ALLES FÜRS PFLEGEEXAMEN IN EINEM PAKET

Pflegeexamen-Komplettpaket

6 PLAN-Lernhilfen plus 4 Bonus-Lernhilfen – 375 Seiten Prüfungsfragen, Probeklausur, Fallbeispiele, Krankheitsbilder, Medikamente und Taschenkarten.

Bestehen ist planbar.

Schriftlich · Mündlich · Praxis · Notfall

10	375	A4
Lernhilfen	Seiten	druckfertig

INHALT

1. Pflegeexamen: 300 Prüfungsfragen
2. Probeklausur Pflegeexamen
3. 92 Fallbeispiele
4. Krankheitsbilder & Pflegeplanung
5. Medikamente kompakt
6. Taschenkarten-Set
7. … plus 4 Bonus-Lernhilfen

⚠ Lernhilfe, mit KI-Unterstützung erstellt und fachlich geprüft. Maßgeblich sind Lehrinhalte, Leitlinien und Standards deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

plan-nrw.de

Inhalt des Komplettpakets

Jede Lernhilfe beginnt mit einem eigenen Deckblatt. Die Seitenzahlen beziehen sich auf dieses Gesamt-PDF. Die Bonus-Lernhilfen gibt es auch einzeln kostenlos in der PLAN-App – hier sind sie der Vollständigkeit halber mit drin.

Pflegeexamen: 300 Prüfungsfragen S. 3
300 Fragen mit Erklärungen

Probeklausur Pflegeexamen S. 67
68 fallbezogene Aufgaben

92 Fallbeispiele S. 91
Entscheidungsfälle mit Auflösung

Krankheitsbilder & Pflegeplanung S. 220
107 Krankheitsbilder

Medikamente kompakt S. 320
43 Wirkstoffe

Taschenkarten-Set S. 336
40 Karten zum Ausschneiden

Prophylaxen-Kompendium (Bonus) S. 347
auch kostenlos in der PLAN-App

Reanimations-Algorithmen (Bonus) S. 365
auch kostenlos in der PLAN-App

Laborwerte kompakt (Bonus) S. 370
auch kostenlos in der PLAN-App

Examens-Spickzettel (Bonus) S. 373
auch kostenlos in der PLAN-App

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

PRÜFUNGSTRAINING · SCHRIFTLICHES EXAMEN

Pflegeexamen: 300 Prüfungsfragen

Multiple-Choice-Fragen aus allen großen Fachbereichen der generalistischen Pflegeausbildung – mit Lösungsschlüssel und verständlichen Erklärungen.

Bestehen ist planbar.

Generalistik | Multiple Choice | Erklärungen | Lösungsschlüssel

300	15	A4
Fragen	Themenbereiche	druckfertig

INHALT

1. Generalistische Ausbildung & Recht
2. Pflegeprozess & Pflegeplanung
3. Prävention & Gesundheitsförderung
4. Mobilität & Bewegung
5. Notfall & Akutsituationen
6. Innere Medizin
7. Chirurgie
8. Pädiatrie
9. Gynäkologie & Geburtshilfe
10. … und 6 weitere Bereiche

⚠ Lernhilfe, mit KI-Unterstützung erstellt und fachlich geprüft. Maßgeblich sind Lehrinhalte, Leitlinien und Standards deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

plan-nrw.de

So nutzt du das Heft

Erst alle Fragen eines Bereichs beantworten, dann im Lösungsteil kontrollieren. Falsche Antworten markieren und nach ein paar Tagen wiederholen.

SCHWIERIGKEIT

● leicht · ●● mittel · ●●● schwer

EHRLICH TESTEN

Lösungen und Erklärungen stehen gesammelt am Ende – kein Spoiler beim Lernen.

THEMENBEREICHE

01 Generalistische Ausbildung & Recht · 20 Fragen
02 Pflegeprozess & Pflegeplanung · 20 Fragen
03 Prävention & Gesundheitsförderung · 20 Fragen
04 Mobilität & Bewegung · 20 Fragen
05 Notfall & Akutsituationen · 20 Fragen
06 Innere Medizin · 20 Fragen
07 Chirurgie · 20 Fragen
08 Pädiatrie · 20 Fragen
09 Gynäkologie & Geburtshilfe · 20 Fragen
10 Psychiatrie · 20 Fragen
11 Psychologie & Kommunikation · 20 Fragen
12 Altenpflege & Geriatrie · 20 Fragen
13 Palliativpflege · 20 Fragen
14 Rehabilitation · 20 Fragen
15 Anatomie: Herz & Kreislauf · 20 Fragen

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

1 Generalistische Ausbildung & Recht

20 Fragen

1 **Aus welchen 3 Teilen besteht die staatliche Abschlussprüfung GPA?** ●●

A Schriftlich und mündlich
B Schriftlich, mündlich, praktisch
C Praktisch und Portfolio
D Nur Portfolio

2 **Welche 6 Schritte hat der Pflegeprozess?** ●

A Anamnese, ärztliche Diagnose und anschließende Therapie
B Aufnehmen, Pflegen und schließlich Entlassen des Patienten
C Beobachten, Handeln und abschließend Dokumentieren
D Informationssammlung, Pflegediagnose, Ziele, Maßnahmen, Durchführung, Evaluation

3 **Was ist Evaluation im Pflegeprozess?** ●●

A Pflegediagnose stellen
B Durchführung der Maßnahmen
C Aufnahme des Patienten
D Überprüfung ob Pflegeziele

4 **Was sind Expertenstandards des DNQP?** ●●

A Wissenschaftlich fundierte Vorgaben für zentrale Pflegethemen (z. B. Dekubitus, Sturz, Schmerz)
B Reine unverbindliche Empfehlungen ohne jede fachliche Grundlage
C Verbindliche Gesetze, die vom Bundestag beschlossen werden
D Interne Regeln, die nur für eine einzelne Station gelten

5 **Wie viele Stunden umfasst die generalistische Pflegeausbildung insgesamt etwa?** ●●

A Rund 500 Stunden, aufgeteilt auf Theorie und Praxis
B Rund 4600 Stunden (etwa 2100 Theorie + 2500 Praxis)
C Rund 100 Stunden im Rahmen eines kurzen Grundkurses
D Deutlich über 20.000 Stunden über die gesamte Ausbildung

6 **Welche Versorgungsbereiche decken die Pflichteinsätze der generalistischen Ausbildung ab?** ●●

A Stationäre Akutpflege, stationäre Langzeitpflege und ambulante Pflege
B Ausschließlich die Versorgung von Patienten auf der Intensivstation
C Ausschließlich verwaltende und organisatorische Tätigkeiten der Einrichtung
D Ausschließlich die Assistenz bei Operationen im OP-Bereich

7 **Welchen Vorteil bietet der generalistische Abschluss im europäischen Kontext?** ●●

A Er gilt ausschließlich innerhalb des Bundeslandes NRW
B Er ist im europäischen Ausland gar nicht anerkannt
C Er ist EU-weit anerkannt und erleichtert das Arbeiten im europäischen Ausland
D Er muss in jedem Bundesland vollständig neu erworben werden

8 **Was ist der Pädiatrie-Pflichteinsatz in der GPA?** ●●

(A) Ein rein optionaler Einsatz ohne festgelegte Mindeststundenzahl

(B) Ein Pflichteinsatz im Umfang von insgesamt 300 Stunden

(C) Ein Wahlpflichteinsatz von 500 Stunden am Ende der Ausbildung

(D) Pflicht: 120h Kinder- und Jugendmedizin

9 **Was bedeutet SMART bei Pflegezielen?** ●●

(A) Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert

(B) Standard, Medizinisch, Ärztlich, Realistisch, Täglich

(C) Sicher, Modern, Akut, Risikoarm, Terminiert

(D) Schnell, Messbar, Akzeptiert, Realistisch, Terminiert

10 **Was ist der Ausbildungsplan des Trägers der praktischen Ausbildung?** ●●

(A) Ein individueller Plan, der die praktischen Einsätze und Lernziele strukturiert

(B) Der Dienstplan der examinierten Pflegekräfte der Einrichtung

(C) Ein reiner Plan zur Verteilung der Urlaubstage im Team

(D) Die wöchentliche Speisekarte der Ausbildungseinrichtung

11 **Welche schulische Zugangsvoraussetzung gilt üblicherweise für die generalistische Pflegeausbildung?** ●●

(A) Ausschließlich das Abitur oder eine gleichwertige allgemeine Hochschulreife

(B) Ein mittlerer Schulabschluss oder ein Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Ausbildung bzw. Pflegeassistenz

(C) Gar kein bestimmter Schulabschluss, da der Zugang zur Ausbildung völlig frei ist

(D) Ein bereits erfolgreich abgeschlossenes Studium in einem medizinischen Fachbereich

12 **Was sind „vorbehaltene Tätigkeiten“ nach dem Pflegeberufegesetz?** ●●●

(A) Tätigkeiten, die nur ausgebildeten Pflegefachpersonen vorbehalten sind (z. B. Erhebung und Steuerung des Pflegeprozesses)

(B) Bestimmte organisatorische Aufgaben im Bereich der Stationsverwaltung und Ablaufplanung

(C) Reine hauswirtschaftliche und Reinigungstätigkeiten im Umfeld der Pflegeeinrichtung

(D) Alltägliche Aufgaben, die grundsätzlich jede beliebige Person ohne Ausbildung übernehmen darf

13 **Was ist der Orientierungseinsatz zu Beginn der Ausbildung?** ●●

(A) Die abschließende praktische und schriftliche Prüfung am Ende der Ausbildung

(B) Ein reiner theoretischer Unterrichtsblock ganz zu Beginn der Ausbildung

(C) Der frei wählbare Vertiefungseinsatz im letzten Ausbildungsdrittel

(D) Der erste Praxiseinsatz beim Träger der praktischen Ausbildung zum Ankommen und Orientieren

14 **Was sind CE 01-11 in der GPA?** ●●

(A) Einzelne schriftliche und mündliche Prüfungen im Verlauf der Ausbildung

(B) Die verschiedenen praktischen Einsätze in Klinik und ambulanter Pflege

(C) Erworbene Zusatzzertifikate für einzelne Fachbereiche der Pflege

(D) Curriculare Einheiten = Lernbereiche der generalistischen Pflegeausbildung

15 **Was ist Salutogenese nach Antonovsky?** ●●●

(A) Beatmungsmethode

(B) Krankheitsentstehung

(C) Was hält Menschen gesund (Gesundheitsentstehung)

(D) Pflegemodell chronisch Kranke

16 **Was unterscheidet Nah- von Fernzielen in der Pflegeplanung?** ●●

(A) Die Nahziele sind für die Pflegeplanung ohne Bedeutung

(B) Zwischen Nah- und Fernzielen besteht kein Unterschied

(C) Nahziele sind kurzfristig erreichbar, Fernziele beschreiben ein längerfristiges Gesamtergebnis

(D) Die Fernziele werden grundsätzlich immer als Erstes erreicht

17 **Was versteht man in der Pflegeplanung unter „Ressourcen“?** ●●

(A) Ausschließlich die verfügbaren finanziellen Mittel des Patienten

(B) Ausschließlich das für die Pflege eingesetzte Personal

(C) Die bestehenden Erkrankungen und Beschwerden des Patienten

(D) Vorhandene Fähigkeiten und Stärken, auf denen die Pflege aufbauen kann

18 **Was gilt für die Ausbildungsvergütung in der generalistischen Pflegeausbildung?** ●

(A) Es wird während der gesamten Ausbildung keinerlei Vergütung gezahlt

(B) Die Auszubildenden müssen für die Ausbildung ein Schulgeld entrichten

(C) Auszubildende haben Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung und zahlen kein Schulgeld

(D) Eine Vergütung wird ausschließlich im dritten Ausbildungsjahr gezahlt

19 **Was ist Kinästhetik-Grundprinzip?** ●●

(A) Nur von Physiotherapeuten anwendbar

(B) Natürliche Bewegungsmuster nutzen

(C) Schnelle Pflege ohne Hilfsmittel

(D) Vollständige Übernahme

20 **Wer ist in der generalistischen Ausbildung der „Träger der praktischen Ausbildung“?** ●●

(A) Die Berufsgenossenschaft als zuständiger Träger der gesetzlichen Unfallversicherung

(B) Das jeweilige Schulministerium des Bundeslandes als oberste zuständige Behörde

(C) Die Einrichtung, die den Ausbildungsvertrag schließt und die praktische Ausbildung verantwortet

(D) Die zuständige Krankenkasse als Kostenträger der monatlichen Ausbildungsvergütung

2 Pflegeprozess & Pflegeplanung

20 Fragen

21 **Was ist Pflegeüberleitung?** ●●

A Fortbildung
B Eine Pflegediagnose
C Übergabe innerhalb Station
D Strukturierte Weitergabe

22 **Was ist Schmerzmanagement nach Expertenstandard?** ●●

A Schmerzmittel nur auf Nachfrage
B Nur nach ärztlicher Anordnung handeln
C Systematische Einschätzung, Therapie und Evaluation des Schmerzes
D Schmerzen selbst beurteilen

23 **Was ist Dekubitus-Kategorie II?** ●●●

A Muskel/Knochen sichtbar
B Blasenbildung oder Erosion
C Vollhautverlust bis Subkutis
D Nicht-wegdrückbare Rötung

24 **Was sind die 4 Hauptbestandteile einer Pflegeplanung?** ●

A Pflegeproblem/Pflegediagnose, Pflegeziel
B Problem, Diagnose, Therapie, Entlassung
C Anamnese, Befund, Plan, Kontrolle
D Aufnahme, Behandlung, Pflege, Entlassung

25 **Was ist der Zweck der Evaluation im Pflegeprozess?** ●●

A Die Vorbereitung der Abrechnung mit dem Kostenträger
B Zu überprüfen, ob die Pflegeziele erreicht wurden, und die Planung ggf. anzupassen
C Die Organisation und Durchführung der Entlassung des Patienten
D Die Erstellung des wöchentlichen Dienstplans des Teams

26 **Was ist das Braden-Assessment?** ●●

A Risikoeinschätzungs-Skala
B Schmerztest
C Ernährungsbewertung
D Sturzrisikotest

27 **In welcher Reihenfolge wird PSA angelegt?** ●●

A Maske → Brille → Kittel → Handschuhe
B Alles gleichzeitig
C Kittel → Maske/Atemschutz → Schutzbrille → Handschuhe
D Handschuhe → Kittel → Maske → Brille

28 **Was ist das Orem-Pflegemodell?** ●●●

A AEDL-Modell
B Maslow-Modell
C Selbstpflegedefizit-Modell
D Salutogenese

29 **Was ist bei der Isolierung eines MRSA-Patienten zu beachten?** ●●●

(A) Der Patient darf grundsätzlich gar nicht besucht werden

(B) Einzelzimmer, Schutzkittel, Handschuhe und FFP2 bei engem Kontakt

(C) Es genügt das alleinige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes

(D) Es genügt das alleinige Tragen von Einmalhandschuhen

30 **Welche Wäsche kommt in den roten Sack?** ●

(A) Gebrauchte Abdecktücher aus dem Operationssaal

(B) Ganz normale, nur leicht verschmutzte Bettwäsche

(C) Grundsätzlich die gesamte Wäsche aller Patienten

(D) Infektionswäsche – direkt verschlossen im Zimmer entsorgen

31 **Aus wie vielen Schritten besteht der Pflegeprozess im gängigen Modell?** ●●

(A) Aus sechs Schritten (von der Informationssammlung bis zur Evaluation)

(B) Aus genau zwei aufeinanderfolgenden Schritten

(C) Aus insgesamt zwölf einzelnen kleinen Schritten

(D) Aus einem einzigen zusammenhängenden Schritt

32 **Was ist die NRS und wie wird sie eingesetzt?** ●

(A) Nationales Sturzregister

(B) Reanimationsschema

(C) Numerische Rating-Skala

(D) Nutritional Risk Screening

33 **Was ist die Visuelle Analogskala (VAS) in der Schmerzerfassung?** ●●

(A) Ein spezielles Blutdruckmessgerät zur Erfassung schmerzbedingter Druckspitzen im Kreislauf

(B) Ein bestimmter Laborwert, der die Stärke eines entzündungsbedingten Schmerzes anzeigt

(C) Eine Skala, auf der der Patient seine Schmerzstärke auf einer Linie zwischen zwei Endpunkten markiert

(D) Ein bildgebendes Verfahren zur genauen Darstellung schmerzender Körperregionen

34 **Was sind potenzielle Pflegeprobleme?** ●●

(A) Medikamentennebenwirkungen

(B) Ärztliche Diagnosen

(C) Risiken/Gefährdungen, die noch nicht eingetreten sind

(D) Bereits eingetretene Probleme

35 **Wann sollten Einmalhandschuhe NICHT getragen werden?** ●

(A) Bei Wundversorgung

(B) Beim normalen Patientenkontakt

(C) Bei Katheteranlage

(D) Bei Blutentnahme

36 **Was ist ein korrektes SMART-Pflegeziel?** ●●

(A) Mobilität verbessern

(B) Patient geht am 3. Tag mit Hilfe 10m

(C) Schmerzen reduzieren

(D) Patient soll sich besser fühlen

37 **Was regelt §23 IfSG für Krankenhäuser?** ●●●

A Ausschließlich die Meldung an das zuständige Gesundheitsamt

B Die Regeln zur Abrechnung erbrachter Krankenhausleistungen

C Surveillance-Pflicht für nosokomiale Infektionen und Antibiotikaresistenzen

D Vorgaben zur personellen Mindestbesetzung der Stationen

38 **Wann müssen Hände gewaschen (nicht desinfiziert) werden?** ●●

A Nach jedem Patientenkontakt

B Immer vor der Desinfektion

C Nur bei sichtbarer Verschmutzung oder Sporenbildnern (z. B. C. difficile)

D Niemals – Desinfektion reicht immer

39 **Was kennzeichnet einen Dekubitus der Kategorie/Grad I?** ●●

A Eine nicht wegdrückbare Rötung bei intakter Haut

B Einen tiefen Krater mit freiliegendem Knochen

C Eine offene Blase mit Hautverlust

D Abgestorbenes, schwarzes Gewebe

40 **In welche drei Dimensionen wird Pflegequalität nach Donabedian eingeteilt?** ●●●

A Preis-, Zeit- und Personalqualität

B Klein-, Mittel- und Großqualität

C Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität

D Anfangs-, Mittel- und Endqualität

3 Prävention & Gesundheitsförderung

20 Fragen

41 **Welches Gesetz regelt die Meldepflicht bei bestimmten Infektionskrankheiten?** ●●

A Das Pflegeberufegesetz
B Das Betäubungsmittelgesetz
C Das Arbeitszeitgesetz
D Das Infektionsschutzgesetz (IfSG)

42 **Was bedeutet Empowerment in der Gesundheitsförderung?** ●

A Die wohlmeinende Bevormundung und Entscheidungsübernahme für den Patienten
B Die reine Weitergabe von Informationen ohne aktive Beteiligung des Patienten
C Befähigung zu mehr Selbstbestimmung und Kontrolle über die eigene Gesundheit
D Die gezielte Gabe von Medikamenten zur Verbesserung der Gesundheit

43 **Was unterscheidet Verhaltens- von Verhältnisprävention?** ●●

A Beide Formen zielen ausschließlich auf die Gabe von Medikamenten
B Die Verhältnisprävention ist grundsätzlich immer freiwillig
C Verhaltensprävention setzt am Individuum an, Verhältnisprävention an den Lebensbedingungen
D Beide Begriffe bezeichnen im Grunde genau dasselbe

44 **Was beschreibt der Begriff „Herdenimmunität“?** ●●

A Immunität, die nur bei Tieren vorkommt
B Lebenslange Immunität nach jeder Infektion
C Schutz Ungeimpfter durch eine hohe Impfquote in der Bevölkerung
D Immunität allein durch gesunde Ernährung

45 **Was ist das Ziel der Tertiärprävention?** ●●

A Krankheiten schon vor ihrer Entstehung vollständig verhindern
B Folgeschäden und Rückfälle einer bestehenden Erkrankung begrenzen (z. B. Reha)
C Bestehende Krankheiten in einem frühen Stadium erkennen
D Gesunde Menschen vorbeugend gegen Erreger impfen

46 **Wie hebt man beim Anheben von Lasten rückenschonend?** ●

A Mit rundem Rücken und gestreckten Beinen
B Ruckartig und möglichst schnell
C Aus den Beinen heben, Rücken gerade, Last nah am Körper
D Grundsätzlich allein und ohne Hilfsmittel

47 **Was unterscheidet Beratung von Anleitung in der Pflege?** ●●

A Die Beratung ist praktisch, die Anleitung dagegen theoretisch

B Beide Begriffe bezeichnen im Grunde genau dasselbe

C Eine Anleitung ist ausschließlich für Angehörige vorgesehen

D Beratung unterstützt Entscheidungsfindung, Anleitung vermittelt konkrete Handlung

48 **Womit prüft man, ob eine Hautrötung ein Dekubitus Kategorie 1 sein könnte?** ●●

A Mit dem Thermometer

B Mit dem Blutdruckmessgerät

C Mit einer Blutentnahme

D Mit dem Fingertest (Wegdrückbarkeit prüfen)

49 **Welche Maßnahme ist am wirksamsten gegen nosokomiale Infektionen?** ●

A Hygienische Händedesinfektion

B Antibiotika-Prophylaxe bei allen Patienten

C Tägliches Wischen der Fußböden

D Mundschutz für Besucher

50 **Wie werden gebrauchte Kanülen korrekt entsorgt?** ●

A Mit wieder aufgesteckter Schutzkappe in den Hausmüll

B In der Kitteltasche zwischensammeln

C Im Ausguss entsorgen

D Ohne Recapping direkt in einen durchstichsicheren Abwurfbehälter

51 **Welche Maßnahme ist bei einem Patienten mit MRSA typisch?** ●●

A Isolierung/Barrierepflege mit Schutzkittel und Handschuhen

B Keine besonderen Maßnahmen nötig

C Den Kontakt zu allen anderen Patienten fördern

D Antibiotika für die gesamte Station

52 **Wer gibt in Deutschland die offiziellen Impfempfehlungen heraus?** ●

A WHO

B STIKO am RKI

C Hausärzteverband

D Pflegekammer

53 **Was ist die erste Maßnahme nach einer Nadelstichverletzung?** ●●

A Blutung fördern, Wunde spülen/desinfizieren und melden

B Die Wunde sofort fest abdrücken und verschließen

C Sofort selbstständig Antibiotika einnehmen

D Die Verletzung ignorieren, wenn sie klein ist

54 **Wodurch beugt man Kontrakturen am wirksamsten vor?** ●●

A Vollständige Ruhigstellung der Gelenke

B Regelmäßige Bewegung und physiologische Lagerung der Gelenke

C Wärmflaschen auf die Gelenke legen

D Kalte Wickel anlegen

55 **Welche Maßnahme zählt zur physikalischen Thromboseprophylaxe?**

A Die strikte Einhaltung durchgehender und dauerhafter Bettruhe

B Frühmobilisation und medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe

C Eine möglichst tiefe Lagerung beider Beine des Patienten

D Das Trinken großer Mengen von koffeinhaltigem Kaffee

56 **Was ist das Ziel der motivierenden Gesprächsführung (Motivational Interviewing)?**

A Den Patienten mit Nachdruck zu einer Entscheidung zu überreden

B Die eigene Veränderungsmotivation des Patienten stärken

C Dem Patienten klare Anweisungen und Vorgaben zu erteilen

D Eine ärztliche Diagnose für den Patienten zu stellen

57 **Was bedeutet Standard- bzw. Basishygiene?**

A Nur bei bekannten Infektionen anzuwenden

B Grundlegende Hygienemaßnahmen bei jedem Patienten unabhängig vom Infektionsstatus

C Nur auf Intensivstationen nötig

D Ausschließlich Händewaschen mit Seife

58 **Welche Maßnahme senkt das Aspirationsrisiko bei der Nahrungsaufnahme?**

A Den Patienten im Liegen füttern

B Aufrechte Sitzposition und angepasste Kostkonsistenz

C Große Bissen schnell anreichen

D Während des Schluckens ablenken

59 **Was ist ein Ziel des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)?**

A Krankenstände durch Druck senken

B Gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen schaffen und Beschäftigte gesund halten

C Gesetzliche Vorgaben nur minimal erfüllen

D Ausschließlich Kosten einsparen

60 **Welche Maßnahme dient der Pneumonieprophylaxe?**

A Flache Rückenlage ohne Bewegung

B Reichlich hustendämpfende Mittel

C Möglichst trockene Raumluft

D Atemübungen, Mobilisation und ggf. atemstimulierende Einreibung

4 Mobilität & Bewegung

20 Fragen

61 **Was gilt für freiheitsentziehende Maßnahmen (z. B. Fixierung) zur Sturzprophylaxe?** ●●●

A Sie gelten als Mittel der ersten Wahl bei jeder Sturzgefahr

B Sie dürfen jederzeit und ohne besonderen Grund angeordnet werden

C Sie sind grundsätzlich völlig frei von Risiken für den Betroffenen

D Sie sind letztes Mittel und bedürfen i. d. R. einer Einwilligung bzw. richterlichen Genehmigung

62 **Was beschreibt die Virchow-Trias?** ●●●

A Drei verschiedene Bereiche des Blutzuckerspiegels

B Die drei Schweregrade eines entstehenden Dekubitus

C Gefäßwandschaden, verlangsamter Blutfluss und erhöhte Gerinnungsneigung

D Drei aufeinanderfolgende Stufen des Bewusstseins

63 **Wann ist eine Wechseldruckmatratze sinnvoll?** ●●●

A Bei stark dekubitusgefährdeten, kaum mobilisierbaren Patienten

B Bei voll mobilen und gesunden, aktiven Personen

C Ausschließlich beim Auftreten von erhöhtem Fieber

D Vorrangig als Maßnahme zur Vorbeugung von Stürzen

64 **Wie beugt man einem Spitzfuß bei bettlägerigen Patienten vor?** ●●

A Durch Lagerung in 90-Grad-Stellung und regelmäßige Bewegung des Sprunggelenks

B Durch dauerhafte Streckung des Fußes

C Durch Hochlagern nur der Zehen

D Durch feste Bandage in Spitzfußstellung

65 **Wann ist ein Patientenlifter indiziert?** ●●

A Bei voll mobilen Patienten, die sich selbstständig bewegen können

B Grundsätzlich nie, da ein Transfer immer manuell erfolgen sollte

C Ausschließlich während der Nacht zur Entlastung des Personals

D Bei schwer immobilen Patienten, die nicht sicher manuell transferiert werden können

66 **Worin unterscheiden sich aktive und passive Bewegungsübungen?** ●

A Aktiv bewegt der Patient selbst, passiv wird er von der Pflegekraft bewegt

B Es gibt keinen Unterschied

C Passiv bedeutet gar keine Bewegung

D Aktiv geht nur mit einer Maschine

67 **Woran erkennt man einen Dekubitus Grad 1?** ●●

A An einer offenen, nässenden Wunde

B An schwarzem, nekrotischem Wundgrund

C An einem tiefen Krater bis zum Knochen

D An einer umschriebenen, nicht wegdrückbaren Rötung intakter Haut

68 **Was ist das wichtigste Prinzip der Kontrakturenprophylaxe?**

A Strikte Bettruhe
B Hochlagerung aller Gelenke
C Fixierung der Gelenke
D Regelmäßige Bewegung und physiologische Lagerung

69 **Wodurch unterscheidet sich ein Rollator von einem Gehbock?**

A Der Rollator hat Räder für flüssiges Gehen, der Gehbock wird angehoben und versetzt
B Beide Gehhilfen sind vollständig identisch und gleich zu bedienen
C Der Gehbock verfügt zusätzlich über einen elektrischen Antrieb
D Der Rollator ist ausschließlich für Kinder gedacht und gebaut

70 **Für welche Patientengruppe ist das Bobath-Konzept vor allem gedacht?**

A Frisch operierte Patienten mit einer Bauchwunde
B Ausschließlich Neugeborene und junge Säuglinge
C Menschen mit zentralen neurologischen Störungen, z. B. nach Schlaganfall
D Patienten mit einer harmlosen fieberhaften Erkältung

71 **Was umfasst die ATL/AEDL 'Sich bewegen'?**

A Positionswechsel, Transfer, Gehen und Bewegungsförderung
B Nur das selbstständige Gehen
C Nur die Nahrungsaufnahme
D Nur die Körperpflege

72 **Was ist das Ziel der Mikrolagerung (Mikrobewegung)?**

A Den Patienten jeweils vollständig auf die andere Seite umzudrehen
B Vor allem die Bettwäsche und die Matratze zu schonen
C Jede Form von Bewegung möglichst vollständig zu vermeiden
D Durch kleine Positionsveränderungen die Druckpunkte regelmäßig leicht zu verändern

73 **Welchen Nutzen hat kinästhetisches Arbeiten für die Pflegekraft?**

A Es ist reine Zeitverschwendung
B Es schont durch ressourcenorientierte Bewegung den eigenen Rücken
C Man muss deutlich mehr heben
D Es ersetzt die Dokumentation

74 **Was kennzeichnet einen individuellen Bewegungsförderungsplan?**

A Ein starres Schema für alle Patienten
B Ausschließlich ärztliche Anordnung ohne Pflege
C Den Verzicht auf Dokumentation
D An Ressourcen, Risiko und Zielen des Patienten ausgerichtete Maßnahmen

75 **Was kennzeichnet aktivierende Körperpflege?**

- A Pflegekraft übernimmt vollständig
- B Pflege nur durch Angehörige
- C Ressourcen des Patienten werden einbezogen
- D Verzicht auf Körperpflege

76 **Was bedeutet ein niedriger Punktwert in der Braden-Skala?**

- A Kein Dekubitusrisiko
- B Ein höheres Dekubitusrisiko
- C Guter Ernährungszustand
- D Ein niedriges Sturzrisiko

77 **Welche Sicherheitsmaßnahme gehört zu jedem Rollstuhl-Transfer?**

- A Die Feststellbremsen bewusst offen und gelöst lassen
- B Die Fußstützen des Rollstuhls unten und ausgeklappt lassen
- C Den Transfer ohne vorherige Ansage an den Patienten beginnen
- D Bremsen feststellen und auf festes Schuhwerk achten

78 **Bei welcher Erkrankung sind Kompressions- bzw. Thrombosestrümpfe mit Vorsicht anzuwenden oder kontraindiziert?**

- A Bei einer leichten Erkältung mit Schnupfen und Husten
- B Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)
- C Bei völlig gesunden Beinen ohne jede Gefäßerkrankung
- D Bei anhaltenden Kopfschmerzen und Migräne des Patienten

79 **Warum ist Frühmobilisation nach Operationen wichtig?**

- A Sie erhöht das Risiko für Komplikationen nach der Operation
- B Sie senkt Thrombose-, Pneumonie- und Dekubitusrisiko und fördert die Genesung
- C Sie dient rein kosmetischen und ästhetischen Zwecken
- D Sie ist nach einer Operation grundsätzlich kontraindiziert

80 **Welche Folge ist typisch für längere Immobilität?**

- A Muskelabbau, Osteoporose und Obstipation
- B Zunahme der Muskelkraft
- C Bessere Gelenkbeweglichkeit
- D Sinkendes Thromboserisiko

5 Notfall & Akutsituationen

20 Fragen

81 **Wie stillt man eine starke äußere Blutung als Erstmaßnahme?** ●●

(A) Direkten Druck auf die Wunde ausüben, Druckverband anlegen, Körperteil hochhalten

(B) Zunächst abwarten und beobachten, ob die Blutung von selbst zum Stillstand kommt

(C) Die Wunde ausgiebig mit Wasser auswaschen und danach offen liegen lassen

(D) Ausschließlich die Wundränder desinfizieren und keinen Druck ausüben

82 **Was wird im ABCDE-Schema unter 'B' beurteilt?** ●

(A) Breathing – die Atmung (Atemfrequenz, SpO2, Auskultation)

(B) Der Blutzuckerspiegel und der allgemeine Stoffwechselzustand des Patienten

(C) Der arterielle Blutdruck und die aktuelle Herzfrequenz

(D) Der Bewusstseinszustand und die Reaktion der Pupillen auf Licht

83 **Wofür steht das FAST-Schema beim Schlaganfallverdacht?** ●●

(A) Fieber, Atemnot, Schmerz, Tremor

(B) Face, Arms, Speech, Time (Gesicht, Arme, Sprache, Zeit)

(C) Fast, Atem, Stabil, Transport

(D) Flüssigkeit, Antibiotika, Sauerstoff, Transport

84 **Wann wird mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen?** ●

(A) Erst wenn der Notarzt eintrifft

(B) Nur bei sichtbarem Herzstillstand im EKG

(C) Wenn die Person nicht reagiert und nicht normal atmet

(D) Erst nach 5 Minuten Wartezeit

85 **Was tut man bei einer bewusstlosen Person, die normal atmet?** ●●

(A) Atemwege freimachen, in stabile Seitenlage bringen, Notruf, Atmung überwachen

(B) Sofort und ohne weitere Prüfung mit der Herzdruckmassage beginnen

(C) Die Person aufsetzen und ihr etwas Wasser zu trinken geben

(D) Sie unbeobachtet und ohne weitere Maßnahmen allein lassen

86 **Nach welchem Prinzip wird das ABCDE-Schema abgearbeitet?** ●●

(A) Nach der persönlichen Sympathie und dem ersten Eindruck des Behandlers

(B) In zufälliger Reihenfolge, je nach gerade verfügbarem Material und Personal

(C) Grundsätzlich mit C beginnen und in jedem Fall zuerst den Kreislauf sichern

(D) 'Treat first what kills first' – feste Reihenfolge A vor B vor C und jeweils sofort behandeln

87 **Wofür steht das 'C' im ABCDE-Schema?**

- A Consciousness
- B Circulation
- C Control
- D Capillary

88 **Wofür steht das 'E' im ABCDE-Schema?**

- A Erhebung des Elektrolythaushalts und Beurteilung des Ernährungszustands
- B Elektrokardiogramm zur fortlaufenden Kontrolle des Herzrhythmus schreiben
- C Exposure/Environment – Entkleiden, Untersuchen, Wärmeerhalt
- D Erhebung der Eigen- und Fremdanamnese gemeinsam mit den Angehörigen

89 **Die MTS-Stufe GRÜN bedeutet ...**

- A 10 min
- B sofort
- C nicht dringend, 120 min
- D normal, 90 min

90 **Was wird im ABCDE-Schema ZUERST beurteilt?**

- A Exposure
- B Breathing
- C Airway
- D Disability

91 **Welche Schockform entsteht durch massiven Flüssigkeits- oder Blutverlust?**

- A Kardiogener Schock
- B Septischer Schock
- C Hypovolämischer Schock
- D Anaphylaktischer Schock

92 **Welcher Herzrhythmus ist bei der Reanimation defibrillierbar (schockbar)?**

- A Die Asystolie, also der vollständige Stillstand des Herzens
- B Kammerflimmern (VF) und pulslose ventrikuläre Tachykardie (pVT)
- C Die pulslose elektrische Aktivität ohne fühlbaren Puls
- D Der geordnete und regelmäßige normale Sinusrhythmus

93 **Was ist beim Einsatz eines AED (automatisierter externer Defibrillator) richtig?**

- A Einschalten und den Sprachanweisungen folgen; während der Analyse den Patienten nicht berühren
- B Ihn bei Ersthelfern und Laien grundsätzlich niemals einsetzen
- C Sofort und ohne vorherige Rhythmusanalyse einen Schock abgeben
- D Ihn ausschließlich bei Kindern und Säuglingen verwenden

94 **Worauf ist bei der Thoraxkompression zu achten?** ●●

A Eine möglichst weiche und nachgebende Unterlage unter dem Brustkorb

B Nur eine flache, oberflächliche Drucktiefe ohne vollständige Kompression

C Harte Unterlage, vollständige Entlastung nach jeder Kompression, Unterbrechungen minimieren

D Ein bewusst langsames und gleichmäßiges Drücken mit langen Pausen

95 **Welche Kompressionsfrequenz empfiehlt der ERC 2025 bei der Reanimation?** ●●

A 100–120/min

B 60–80/min

C 80–100/min

D 140–160/min

96 **Was ist die richtige Erstmaßnahme bei einer kleinflächigen Verbrennung?** ●●

A Die verbrannte Stelle sofort mit Eis oder einem Kühlakku direkt auf der Haut kühlen

B Butter, Speiseöl oder Mehl großzügig auf die verbrannte Hautstelle auftragen

C Mit lauwarmem Wasser kühlen, keine Hausmittel, Wunde locker keimarm bedecken

D Entstehende Brandblasen umgehend öffnen und die abgelöste Haut vorsichtig entfernen

97 **Wie beginnt die Reanimation beim Kind durch geschultes Personal (ERC 2025)?** ●●●

A Sofort mit 30 Herzdruckmassagen beginnen, noch vor jeder Beatmung

B Mit 5 initialen Beatmungen, dann Kompressionen zu Beatmungen im Verhältnis 15:2

C Ausschließlich beatmen und dabei ganz auf Kompressionen verzichten

D Im Verhältnis 30:2 vorgehen, jedoch vollständig ohne Beatmungen

98 **Nach welchem Prinzip wird im MTS die Dringlichkeit festgelegt?** ●●

A höchste zutreffende Stufe anhand von Indikatoren

B nach Alter des Patienten

C Reihenfolge des Eintreffens

D niedrigste zutreffende Stufe

99 **Wie lange sollte die Atem-/Kreislaufkontrolle bei der Reanimationsprüfung maximal dauern?** ●●

A Bis zu 1 Minute

B 30 Sekunden

C So lange wie nötig

D Maximal 10 Sekunden

100 **Welche Nummer ist der europaweite Notruf?** ●

A 110

B 116117

C 19222

D 112

6 Innere Medizin

20 Fragen

101 **Welche BGA-Konstellation spricht für eine metabolische Azidose (z. B. diabetische Ketoazidose)?** ●●●

(A) pH niedrig, HCO3 und Base Excess erniedrigt
(B) pH hoch, HCO3 erhöht
(C) pH hoch, pCO2 niedrig
(D) alle Werte erhöht

102 **Welches Symptom weist auf ein Lungenödem hin?** ●●●

(A) Eine trockene, unauffällige Haut ganz ohne begleitende Beschwerden
(B) Anhaltende, krampfartige Schmerzen im Bereich des Bauchraums
(C) Eine sichtbare Schwellung im Bereich der großen Gelenke
(D) Schwere Atemnot mit brodelnden Rasselgeräuschen, ggf. schaumiger Auswurf

103 **Welcher Normbereich gilt für Bikarbonat (HCO3-) im Blut?** ●●●

(A) 22–26 mmol/l
(B) 2–6 mmol/l
(C) 40–50 mmol/l
(D) 60–70 mmol/l

104 **Welche Folgeerkrankung droht bei langjähriger, unbehandelter arterieller Hypertonie?** ●●

(A) Bessere Nierenfunktion
(B) Gewichtsabnahme
(C) Sehverbesserung
(D) Schlaganfall, Herzinfarkt und Nierenschäden

105 **Was ist das wichtigste Pflegemonitoring bei Herzinsuffizienz?** ●●

(A) Tägliche Gewichtskontrolle
(B) Pupillenkontrolle
(C) Blutzucker
(D) Temperatur

106 **Ab welchen pH-Werten wird es akut lebensbedrohlich?** ●●●

(A) pH unter 7,0 oder über 7,8
(B) Bei den Normalwerten von pH 7,35 und pH 7,45
(C) Bereits bei einem leicht abweichenden pH von 7,30
(D) Bereits bei einem leicht abweichenden pH von 7,50

107 **Was unterscheidet Asthma bronchiale typischerweise von der COPD?** ●●

(A) Es gibt keinen Unterschied
(B) Asthma ist immer irreversibel
(C) Asthma ist meist anfallsartig und weitgehend reversibel
(D) Asthma betrifft nur ältere Raucher

108 **Welcher pH-Bereich des arteriellen Blutes gilt als normal?** ●●

(A) 6,8–7,0
(B) 7,35–7,45
(C) 7,60–7,80
(D) 8,0–8,4

109 **Was ist Dysphagie nach Schlaganfall und welche Gefahr besteht?** ●●

A Hörstörung
B Sehstörung
C Schluckstörung
D Gehstörung

110 **Was ist bei Abnahme und Verarbeitung einer BGA-Probe wichtig?** ●●●

A Möglichst viele Luftblasen in der Spritze belassen
B Die Probe über Stunden bei Zimmerwärme lagern
C Die Probe ganz ohne gerinnungshemmenden Zusatz abnehmen
D Luftblasen entfernen und die Probe rasch analysieren (heparinisierte Spritze)

111 **Worin unterscheiden sich Typ-1- und Typ-2-Diabetes grundsätzlich?** ●●

A Typ 1: absoluter Insulinmangel (Autoimmun); Typ 2: Insulinresistenz mit relativem Mangel
B Beide Diabetesformen sind identisch und unterscheiden sich nicht
C Der Typ 1 betrifft ausschließlich ältere Menschen
D Der Typ 2 erfordert grundsätzlich sofort eine Insulingabe

112 **Wie verändert sich die BGA bei einer respiratorischen Azidose (z. B. schwere COPD, Hypoventilation)?** ●●●

A pH hoch, pCO2 niedrig
B pH niedrig, HCO3 stark erniedrigt
C pH normal, alle Werte normal
D pH niedrig, pCO2 erhöht

113 **Was kennzeichnet die COPD?** ●●

A Eine chronische, nicht vollständig reversible Atemwegsobstruktion
B Eine vorübergehende, voll reversible Verengung
C Eine reine Herzerkrankung
D Eine Nierenentzündung

114 **Welcher Normwert gilt für den arteriellen CO2-Partialdruck (pCO2)?** ●●

A Etwa 5–15 mmHg
B Etwa 80–100 mmHg
C Etwa 120–140 mmHg
D Etwa 35–45 mmHg

115 **Was ist bei Hypoglykämie (BZ < 70 mg/dl, Patient wach) zu tun?** ●●

A Patient schlafen lassen
B Blutabnahme
C Sofort Insulin geben
D 20g schnell resorbierbare KH oral

116 **Was findet man typischerweise bei einer respiratorischen Alkalose (Hyperventilation)?** ●●●

A pH niedrig, pCO2 hoch
B pH hoch, HCO3 stark erhöht
C pH hoch, pCO2 erniedrigt
D alle Werte normal

117 **Welche Symptome sprechen für eine Lungenembolie?** ●●●

A Plötzliche Atemnot, atemabhängiger Brustschmerz und Tachykardie

B Über Stunden langsam zunehmende, dumpfe Schmerzen im Bauchraum

C Ein ausgeprägter, großflächiger Juckreiz der gesamten Haut

D Ausschließlich ein anhaltender, drückender Kopfschmerz

118 **Was ist das Bobath-Konzept in der Schlaganfallpflege?** ●●

A Dekubitusprophylaxe-Konzept

B Medikamentöse Therapie

C Kommunikationshilfe

D Rehabilitationskonzept: betroffene

119 **Warum ist eine ausgeprägte Hyperkaliämie (zu viel Kalium) gefährlich?** ●●●

A Sie verbessert die Herzfunktion

B Sie kann lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen auslösen

C Sie senkt nur harmlos den Blutdruck

D Sie hat keine Bedeutung

120 **Was ist HbA1c und was zeigt er?** ●●

A Durchschnittlicher Blutzuckerwert

B Aktueller Blutzucker

C Insulinspiegel

D Ketonkörper

7 Chirurgie

20 Fragen

121 **Welchen Nutzen hat die postoperative Frühmobilisation?**

(A) Sie erhöht das Risiko für eine Thrombose deutlich

(B) Sie dient rein kosmetischen und ästhetischen Zwecken

(C) Sie senkt Thrombose-, Pneumonie- und Ileusrisiko und fördert die Darmtätigkeit

(D) Sie ist nach einer Operation grundsätzlich untersagt

122 **Wann wird eine perioperative Antibiotikaprophylaxe typischerweise gegeben?**

(A) Kurz vor dem Hautschnitt (innerhalb der definierten Zeit vor OP-Beginn)

(B) Erst etwa zwei Tage nach der Operation als Nachbehandlung

(C) Grundsätzlich nie, da eine Prophylaxe nicht vorgesehen ist

(D) Ausschließlich dann, wenn nach der Operation Fieber auftritt

123 **Welche Zeichen weisen auf eine postoperative Nachblutung hin?**

(A) Ein verlangsamter Puls bei gleichzeitig hohem Blutdruck

(B) Eine trockene, warme Haut bei allgemeinem Wohlbefinden

(C) Tachykardie, Blutdruckabfall, plötzlich stark gefüllte Drainage, blasse kaltschweißige Haut

(D) Ausschließlich ein leichter Juckreiz im Wundbereich

124 **Welche Zeichen können auf eine tiefe Beinvenenthrombose (TVT) nach OP hinweisen?**

(A) Einseitige Schwellung, Spannungsgefühl, Überwärmung und Schmerz der Wade

(B) Beidseits auffällig kalte und blasse Beine ohne Schwellung

(C) Eine trockene, unauffällige Haut ganz ohne Beschwerden

(D) Ein anhaltender Juckreiz im Bereich des betroffenen Arms

125 **Was ist ein Kompartmentsyndrom?**

(A) Eine harmlose, rasch abklingende Schwellung des betroffenen Gewebes

(B) Ein bedrohlicher Druckanstieg in einer Muskelloge, der Durchblutung und Nerven schädigt

(C) Eine oberflächliche Rötung der Haut über der betroffenen Stelle

(D) Ein Verschluss der großen Halsvenen mit Blutrückstau zum Kopf

126 **Was gilt für die Einwilligung (Aufklärung) vor einer Operation?**

(A) Auf eine Einwilligung kann in aller Regel verzichtet werden

(B) Der Patient muss rechtzeitig aufgeklärt werden und informiert einwilligen

(C) Über den Eingriff entscheiden grundsätzlich die Angehörigen

(D) Die Aufklärung erfolgt erst nach dem Ende der Operation

127 **Was sind typische Komplikationen nach Appendektomie?** ●●

A Wundinfektion
B Reine Wundschmerzen
C Nur leichte Übelkeit
D Keine

128 **Wie lange sollen Patienten vor einer geplanten Operation in der Regel nüchtern sein?** ●●

A Klare Flüssigkeiten bis 2 h, feste Nahrung bis 6 h vorher
B Gar nicht nüchtern
C 24 Stunden komplett ohne alles
D Nur 30 Minuten vorher

129 **Worauf achtet die Pflege bei liegender Wunddrainage?** ●●

A Ausschließlich auf die Farbe und Sauberkeit der Bettwäsche des Patienten
B Auf Menge und Aussehen des Sekrets, Sog/Durchgängigkeit und Zeichen einer Nachblutung
C Auf gar nichts, da die Drainage sich vollständig selbst überwacht
D Nur einmal wöchentlich im Rahmen des routinemäßigen Verbandwechsels

130 **Was kennzeichnet eine Redon-Drainage?** ●●

A Eine geschlossene Saugdrainage mit Unterdruck (Sog)
B Eine offene Drainage ohne Sog
C Ein Blasenkatheter
D Eine Magensonde

131 **Wofür steht PONV in der perioperativen Pflege?** ●●

A Ein bestimmter gemessener Wert des arteriellen Blutdrucks
B Postoperative Übelkeit und Erbrechen (postoperative nausea and vomiting)
C Ein spezieller Verbandtyp für frische Operationswunden
D Eine bestimmte Lagerungsform des Patienten nach der Operation

132 **Warum müssen Patienten vor einer Narkose nüchtern sein?** ●●

A Vor allem, damit die geplante Operation insgesamt schneller ablaufen kann
B Hauptsächlich aus organisatorischen und wirtschaftlichen Kostengründen
C Um eine Aspiration (Übertritt von Mageninhalt in die Lunge) bei der Narkoseeinleitung zu vermeiden
D Das Nüchternsein ist aus medizinischer Sicht eigentlich unnötig

133 **Was ist bei der Versorgung eines frisch angelegten Stomas (z. B. Kolostomie) wichtig?** ●●●

A Die umgebende Haut möglichst kräftig und aggressiv reinigen und rubbeln
B Das Stoma vorsichtshalber abbinden, um Ausscheidungen zu verhindern
C Auf jegliche Beobachtung von Durchblutung und Hautzustand verzichten
D Farbe/Durchblutung des Stomas beurteilen, Haut schützen, dichte Versorgung wählen und Betroffene anleiten

134 **Welche Zeichen sprechen für eine Wundinfektion?** ●

A Eine blasse, kühle und trockene Umgebung der Wunde

B Eine auffällig rasche und komplikationslose Heilung

C Rötung, Schwellung, Überwärmung, Schmerz und ggf. eitriges Sekret

D Das vollständige Ausbleiben jeglicher Veränderung

135 **Wann wird eine Wunddrainage in der Regel entfernt?** ●●

A Unmittelbar und grundsätzlich sofort im Anschluss an die Operation

B Wenn die Fördermenge deutlich zurückgegangen ist (nach ärztlicher Anordnung)

C Grundsätzlich immer erst nach mehreren Wochen, unabhängig von der Fördermenge

D Niemals, da eine liegende Wunddrainage dauerhaft im Körper verbleibt

136 **Warum ist die Ein- und Ausfuhrbilanz postoperativ wichtig?** ●●

A Ausschließlich zur zusätzlichen Beschäftigung des Pflegepersonals

B Um Flüssigkeitshaushalt, Urinausscheidung und Drainageverluste zu überwachen

C Die Bilanz ist postoperativ ohne wesentliche Bedeutung

D Sie ist ausschließlich bei Kindern und Säuglingen erforderlich

137 **In welcher Reihenfolge verlaufen die Wundheilungsphasen?** ●●●

A Sie verläuft in einer einzigen, ununterbrochenen Heilungsphase

B Es bildet sich unmittelbar und ohne Zwischenstufen eine fertige Narbe

C Die Reinigungsphase steht ganz am Ende nach der Narbenbildung

D Exsudation/Reinigung, Granulation (Proliferation), Epithelisierung und Reifung (Remodeling)

138 **Welche Maßnahme dient postoperativ der Pneumonieprophylaxe?** ●●

A Möglichst flach liegen bleiben und die eigene Atmung bewusst ruhig und oberflächlich halten

B Das Rauchen zur Beruhigung erlauben und den Patienten möglichst viel allein im Bett ruhen lassen

C Atemübungen (z. B. Atemtrainer), Oberkörper hoch, Mobilisation und ausreichende Schmerztherapie für tiefe Atmung

D Ausschließlich langes und häufiges Schlafen ohne Mobilisation und ohne aktive Atemübungen

139 **Welche Prophylaxen sind postoperativ standardmäßig durchzuführen?** ●●

A Reine Frühmobilisation

B Thrombose-, Pneumonie-, Dekubitus- und Soorprophylaxe

C Antibiotika und Bettruhe

D Nur Schmerztherapie

140 **Was ist der postoperative Harnverhalt?** ●●

A Die Unfähigkeit, die volle Blase spontan zu entleeren

B Ein ungewöhnlich häufiges Wasserlassen in kleinen Mengen

C Eine bakterielle Infektion der Operationswunde

D Ein Verschluss des Darms mit fehlender Passage

8 Pädiatrie

20 Fragen

141 **Wie wird ein leicht bis mäßig dehydriertes Kind bei Durchfall bevorzugt behandelt?** ●●

- A Mit reinem Wasser in großen Mengen
- B Mit Nahrungskarenz über mehrere Tage
- C Mit oraler Rehydratationslösung (ORS)
- D Mit gesüßten Softdrinks

142 **Was sind Impfungen nach STIKO-Empfehlung und warum sind sie relevant?** ●●

- A Empfohlener Kinder-Impfkalender; Impfstatus bei Aufnahme prüfen
- B Impfplan nur für Erwachsene
- C Impfungen nur vor Auslandsreisen
- D Lediglich die Tetanusimpfung

143 **Was ist Kindesmisshandlung und welche Pflichten hat Pflegepersonal?** ●●●

- A Betrifft nur körperliche Gewalt
- B Nicht melden
- C Erst bei sichtbaren Verletzungen
- D Schutzauftrag nach §8a SGB VIII

144 **Was ist typisch für Keuchhusten (Pertussis)?** ●●

- A Anfallsartige, stakkatoartige Hustenattacken, für Säuglinge gefährlich
- B Ein juckender Ausschlag ganz ohne Husten
- C Nur ein leichter Schnupfen
- D Eine reine Magen-Darm-Erkrankung

145 **Was ist Neugeborenen-Gelbsucht (Neonataler Ikterus)?** ●●

- A Eine bakterielle oder virale Infektion des Neugeborenen
- B Physiologisch erhöhter Bilirubinwert (meist Tag 2–7)
- C Eine angeborene, genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung
- D Eine ernsthafte Erkrankung der noch unreifen kindlichen Leber

146 **Was ist Rooming-in und welche Vorteile hat es?** ●●

- A Möglichkeit für Eltern, rund um die Uhr beim Kind zu bleiben
- B Ein hotelähnlicher Service für die begleitenden Eltern
- C Eine Möglichkeit, die ausschließlich auf der Intensivstation gilt
- D Ein Angebot, das ausschließlich den Müttern offensteht

147 **Was versteht man unter dem „Fremdeln“ im Säuglingsalter?** ●●

- A Eine Störung der Sprachentwicklung im Säuglingsalter
- B Eine behandlungsbedürftige Erkrankung des Säuglings
- C Das Reagieren mit Unbehagen auf fremde Personen (etwa ab dem 8. Monat)
- D Ein deutliches Zeichen einer emotionalen Vernachlässigung

148 **Was ist Pseudokrupp und wie wird er behandelt?** ●●

- A Virös bedingter
- B Echte Diphtherie
- C Bronchitis
- D Asthma-Anfall

149 **Was ist eine typische Ursache der Bronchiolitis/obstruktiven Bronchitis bei Säuglingen im Winter?** ●●●

- A Eine Nahrungsmittelallergie
- B Ein Sonnenbrand
- C Eine Verletzung
- D Das RS-Virus (RSV)

150 **Was sind die Pflichteinsatz-Stunden in der Pädiatrie laut GPA?** ●

- A 60h
- B 240h
- C 120h
- D 500h

151 **Was ist Exsikkose beim Kind?** ●●

- A Austrocknung (Dehydratation)
- B Eine hartnäckige Verstopfung mit ausbleibendem Stuhlgang
- C Ein deutliches Übergewicht des Kindes über der Altersnorm
- D Ein fieberhafter Infekt mit erhöhter Körpertemperatur

152 **Wozu dient die Vitamin-D-Prophylaxe im ersten Lebensjahr?** ●●

- A Zur Blutgerinnung
- B Zur Vorbeugung von Infektionen
- C Zur Vorbeugung von Rachitis (Knochenerweichung)
- D Zur Fiebersenkung

153 **Was ist bei Scharlach zu beachten?** ●●

- A Er wird durch Viren verursacht und braucht keine Behandlung
- B Er ist nicht ansteckend
- C Er tritt nur bei Erwachsenen auf
- D Er wird durch Streptokokken verursacht und mit Antibiotika behandelt

154 **Was gehört zur Unfallverhütung bei Kleinkindern?** ●

- A Steckdosen im Kinderzimmer bewusst offen und zugänglich lassen
- B Sicherungen wie Treppengitter und Steckdosensicherungen sowie das Wegräumen von Kleinteilen und Giftstoffen
- C Reinigungs- und Putzmittel in Reichweite der Kinder aufbewahren
- D Kleinkinder in der Nähe von Wasser unbeaufsichtigt spielen lassen

155 **Was sind motorische Entwicklungsmeilensteine im 1. Lebensjahr?** ●●

- A Laufen mit 6 Monaten
- B Kopfkontrolle 3 Mo., Drehen 5-6 Mo.
- C Sprechen mit 6 Monaten
- D Alle Kinder entwickeln sich gleich

156 **Warum ist das Wärmemanagement bei Frühgeborenen besonders wichtig?** ●●

(A) Weil sie schnell auskühlen und die Temperatur schlecht selbst regulieren können
(B) Weil sie überschüssige Wärme produzieren
(C) Weil Kälte ihnen nichts ausmacht
(D) Weil sie keine Temperaturüberwachung brauchen

157 **Was ist bei fiebersenkenden Medikamenten für Kinder wichtig?** ●●●

(A) Sie werden nach Körpergewicht und Alter dosiert (z. B. Paracetamol, Ibuprofen)
(B) Man gibt einfach die Erwachsenendosis
(C) Acetylsalicylsäure (ASS) ist das Mittel der Wahl
(D) Die Dosis spielt keine Rolle

158 **Was ist der APGAR-Score und wann wird er erhoben?** ●●

(A) Ernährungsbewertung
(B) Schmerzskala für Kinder
(C) Entwicklungsskala
(D) Beurteilung des Neugeborenen

159 **Was ist Entwicklungsfördernde Pflege auf der Neonatologie (NIDCAP)?** ●●●

(A) Reiz-reduzierende Entwicklungspflege
(B) Normale Pflege
(C) Ausschließlich Ernährungsaufbau
(D) Reine Inkubatorpflege

160 **Wann wird üblicherweise mit Beikost begonnen?** ●●

(A) Direkt nach der Geburt
(B) Etwa ab dem Beginn des 5. bis 7. Lebensmonats
(C) Erst ab dem 2. Lebensjahr
(D) Gar nicht im ersten Lebensjahr

9 Gynäkologie & Geburtshilfe

20 Fragen

161 **Was ist eine typische Indikation für eine Not-Sectio?**

A Wunsch nach schnellerer Geburt

B Leichte, unregelmäßige Wehen

C Akute Gefährdung des Kindes, z. B. pathologisches CTG mit drohender Hypoxie

D Alleinige Erschöpfung der Mutter

162 **Welche medikamentöse Therapie ist bei GDM Mittel der Wahl, wenn Ernährung nicht ausreicht?**

A Gar keine Therapie

B Cortison

C Orale Antidiabetika (Tabletten)

D Insulin – orale Antidiabetika sind in der Schwangerschaft nicht Mittel der Wahl

163 **Was ist das Ziel einer Tokolyse?**

A Die Wehentätigkeit zu hemmen und die Geburt hinauszuzögern

B Den Blutdruck zu senken

C Die Geburt einzuleiten

D Die Wehen zu verstärken

164 **Warum wird unter der Geburt ein CTG geschrieben?**

A Nur zur Dokumentation

B Um das Gewicht des Kindes zu bestimmen

C Um den Blutdruck der Mutter zu messen

D Um Wehentätigkeit und kindliche Herztöne zu überwachen und eine Sauerstoffunterversorgung früh zu erkennen

165 **Wofür stehen die Kriterien im APGAR-Score?**

A Aussehen, Puls, Größe, Atmung, Reaktion

B Alter, Puls, Gewicht, Atmung, Reflexe

C Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen (Hautfarbe), Reflexe

D Atmung, Position, Gewicht, Alter, Reflexe

166 **Wofür steht die Abkürzung HELLP?**

A Hypertonie, Ejektion, Laktat, Leukozyten, Puls

B Hämolyse, erhöhte Leberwerte (Elevated Liver enzymes), niedrige Thrombozyten (Low Platelets)

C Herz-, Leber- und Lungenproblem

D High Energy Low Level Pressure

167 **Welches ist ein typisches Leitsymptom des HELLP-Syndroms?**

A Schmerzen im linken Bein

B Ohrenschmerzen

C Halsschmerzen

D Rechtsseitiger Oberbauchschmerz (Leberkapselspannung)

168 **Ab wann spricht man von einer Frühgeburt?**

- A Jede Geburt per Sectio
- B Geburt nach der 42. SSW
- C Geburt vor der 40. SSW
- D Geburt vor abgeschlossener 37. SSW (vor 37+0)

169 **Was spricht für eine korrekte Anlegetechnik?**

- A Das Kind saugt nur ganz kurz
- B Die Mutter hat starke Schmerzen
- C Das Kind erfasst nur die Brustwarze
- D Das Kind erfasst Mamille und großen Teil des Warzenhofs, Lippen nach außen gestülpt

170 **Worauf muss das Neugeborene einer Mutter mit GDM nach der Geburt überwacht werden?**

- A Auf Hypoglykämie (Unterzucker)
- B Auf Fieber
- C Sofort auf Übergewicht
- D Auf Bluthochdruck

171 **In welcher Reihenfolge verlaufen die Geburtsphasen?**

- A Nachgeburt – Eröffnung – Austreibung
- B Austreibung – Eröffnung – Nachgeburt
- C Es gibt nur eine einzige Phase
- D Eröffnungsphase – Austreibungsphase – Nachgeburtsphase

172 **Welche sind sichere Zeichen des Geburtsbeginns?**

- A Vermehrter Appetit
- B Sodbrennen und Übelkeit
- C Regelmäßige, zunehmende Wehen, Blasensprung und Zeichnen
- D Nur Rückenschmerzen

173 **Was ist die einzige kausale Therapie des HELLP-Syndroms?**

- A Bettruhe
- B Abwarten bis zum Termin
- C Die Entbindung
- D Antibiotika

174 **Ist Stillen nach einem Kaiserschnitt möglich?**

- A Nein, grundsätzlich nicht
- B Erst nach sechs Wochen
- C Nur mit Medikamenten
- D Ja – möglich, oft aber anfangs erschwert und mit Unterstützung

175 **Warum wird bei drohender Frühgeburt Kortison gegeben?**

- A Zur Lungenreifeinduktion des Kindes (Surfactant-Bildung)
- B Zur Wehenhemmung
- C Gegen Schmerzen
- D Zur Blutdrucksenkung

176 **Welche Hormone steuern die Laktation?**

- A Östrogen und Testosteron
- B Cortisol und Thyroxin
- C Prolaktin (Milchbildung) und Oxytocin (Milchflussreflex)
- D Insulin und Adrenalin

177 **Worauf ist nach einer Sectio pflegerisch besonders zu achten?**

- A Nur auf die Wunde
- B Strikte Bettruhe für zwei Wochen
- C Sofortiges Abstillen
- D Konsequente Thromboseprophylaxe – das Risiko ist nach OP und im Wochenbett erhöht

178 **Wann wird das Screening auf Gestationsdiabetes (oGTT) durchgeführt?**

- A Immer im ersten Trimenon
- B In der 6. SSW
- C In der 24. bis 28. SSW
- D Erst nach der Geburt

179 **Wann wird die U1 durchgeführt?**

- A Direkt nach der Geburt
- B Nach sechs Wochen
- C Am 10. Lebenstag
- D Nur bei Auffälligkeiten

180 **Warum ist der Wärmeerhalt beim Neugeborenen so wichtig?**

- A Nur aus Komfortgründen
- B Das ist nur bei Frühgeborenen relevant
- C Neugeborene kühlen wegen großer Körperoberfläche und unreifer Thermoregulation schnell aus
- D Damit sie besser schlafen

10 Psychiatrie

20 Fragen

181 **Was ist Zwangsstörung (OCD)?** ●●●

A Persönlichkeitsstörung
B Psychose
C Zwangseinweisung
D Wiederkehrende aufdringliche

182 **Was ist De-Eskalation in der Psychiatrie?** ●●

A Fixierung sofort
B Aggression verstärken
C Medikamente zwangsweise
D Systematische Deeskalation

183 **Was besagt das bio-psycho-soziale Modell in der Psychiatrie?** ●

A Ausschließlich biologische Ursachen sind für die Entstehung entscheidend
B Psychische Störungen entstehen durch das Zusammenwirken biologischer, psychischer und sozialer Faktoren
C Ausschließlich die Erlebnisse der Kindheit prägen die Erkrankung
D Soziale Faktoren spielen für die Entstehung keinerlei Rolle

184 **Was ist ein Alkoholentzugsdelir (Delirium tremens)?** ●●●

A Eine lebensbedrohliche Entzugskomplikation mit Verwirrtheit, Zittern, Halluzinationen und vegetativen Symptomen
B Ein vorübergehender, im Grunde harmloser Kater nach Alkoholkonsum
C Eine leichte, rasch abklingende Kopfschmerzphase ohne weitere Folgen
D Ein völlig normaler und ungefährlicher Schlafzustand während des Entzugs

185 **Was bedeutet Einwilligungsfähigkeit im psychiatrischen Kontext?** ●●●

A Sie ist automatisch mit dem Erreichen der Volljährigkeit gegeben
B Die Fähigkeit, Art, Bedeutung und Tragweite einer Maßnahme zu verstehen und frei zu entscheiden
C Sie ist völlig gleichbedeutend mit der Geschäftsfähigkeit
D Sie liegt in der Zustimmung der nächsten Angehörigen

186 **Was ist eine Major Depression und welche Kernsymptome hat sie?** ●●

A Eine normale Traurigkeit als Reaktion auf einen Verlust
B Eine kurze, rasch vorübergehende Stimmungsschwankung
C Ein durch Überlastung entstandenes Burnout-Syndrom
D Depressive Stimmung, Interessenverlust und Antriebsminderung

187 **Welches ist ein Kennzeichen einer Abhängigkeitserkrankung?** ●●

A Gelegentlicher, gut kontrollierter Konsum

B Starkes Verlangen (Craving), Kontrollverlust und Entzugserscheinungen

C Ausschließlich körperliche Beschwerden ohne Verlangen

D Ein einmaliger Konsum

188 **Was ist das maligne neuroleptische Syndrom?** ●●●

A Eine völlig harmlose und vorübergehende Begleiterscheinung der Behandlung

B Eine seltene, lebensbedrohliche Reaktion auf Antipsychotika mit hohem Fieber, Muskelrigidität und Bewusstseinsstörung

C Eine besondere Form einer Angststörung mit ausgeprägter innerer Unruhe

D Eine allergische Reaktion der Haut mit Rötung und Juckreiz

189 **Was ist Milieutherapie in der Psychiatrie?** ●●●

A Therapeutische Gestaltung der gesamten Stationsumgebung

B Eine Form der Umwelttherapie mit Aufenthalten in der Natur

C Eine ausschließlich im Einzelsetting durchgeführte Therapie

D Eine reine Behandlung allein durch die Gabe von Medikamenten

190 **Was sollte man Patienten über die Wirkung von Antidepressiva (z. B. SSRI) erklären?** ●●

A Sie wirken sofort nach der ersten Tablette

B Sie machen grundsätzlich abhängig

C Die stimmungsaufhellende Wirkung setzt oft erst nach 1–3 Wochen ein

D Man kann sie jederzeit abrupt absetzen

191 **Was ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung?** ●●●

A Eine Form der Schizophrenie

B Eine Depression

C Instabile Identität

D Eine Angststörung

192 **Was ist Demenz und wie unterscheidet sie sich von Depression?** ●●●

A Demenz ist heilbar

B Demenz = organischer

C Depression ist schwerer

D Beide gleich

193 **Was ist das Ziel einer Krisenintervention?** ●●

A Die langfristige ambulante Psychotherapie vollständig zu ersetzen

B Kurzfristige Stabilisierung und Entlastung in einer akuten seelischen Ausnahmesituation

C Die sofortige Fixierung und Ruhigstellung des Betroffenen

D Die akute seelische Krise bewusst zu übergehen und abzuwarten

194 **Was gehört zum psychopathologischen Befund (Beobachtung psychischer Symptome)?** ●●●

A Ausschließlich die gemessene Körpertemperatur und die weiteren Vitalzeichen des Patienten

B Systematische Beschreibung von Bewusstsein, Orientierung, Affekt, Antrieb, Denken und Wahrnehmung

C Ausschließlich die im Labor bestimmten Blutwerte und bildgebenden Befunde

D Ausschließlich die vom Arzt gestellte Diagnose ohne jede eigene pflegerische Beobachtung

195 **Was ist bei einer akuten Intoxikation (z. B. Alkohol, Drogen) pflegerisch vorrangig?** ●●

A Vitalzeichen und Bewusstsein überwachen, Aspiration und Atemdepression vorbeugen

B Sofort und vorrangig ein ausführliches Deeskalationsgespräch führen

C Den betroffenen Patienten aktiv zum Aufstehen und Gehen zwingen

D Dem Patienten zur Stärkung zunächst reichlich Nahrung anbieten

196 **Was ist das Konzept der Psychoedukation?** ●●

A Ergotherapie

B Verhaltenstherapie

C Psychiatrie-Studium

D Strukturierte

197 **Was ist therapeutische Kommunikation in der Psychiatrie?** ●●

A Die gezielte Ablenkung des Patienten von seinen Problemen

B Empathische, wertschätzende und nicht-wertende Gesprächsführung

C Klare, direktive Anweisungen und Vorgaben an den Patienten

D Die reine Verabreichung der verordneten Medikamente

198 **Was ist der Unterschied zwischen Psychose und Neurose?** ●●

A Psychose = Realitätsverlust, Neurose = erhaltene Realitätsprüfung

B Beide Begriffe bezeichnen im Grunde denselben Zustand

C Eine Psychose verläuft grundsätzlich harmloser als eine Neurose

D Eine Neurose ist stets die deutlich schwerere Erkrankung

199 **Welchen therapeutischen Zweck hat eine klare Tagesstrukturierung?** ●

A Sie dient ausschließlich der organisatorischen Ordnung der Station

B Sie gibt Orientierung, Sicherheit und Halt und fördert Aktivierung und Selbstständigkeit

C Sie wirkt sich bei einer Depression eher schädlich aus

D Sie kann die Gabe von Medikamenten vollständig ersetzen

200 **Was regelt das PsychKG (in NRW) unter anderem?** ●●●

A Ausschließlich die Höhe und Auszahlung der Vergütung von Pflegekräften

B Voraussetzungen und Verfahren der Unterbringung und Behandlung bei erheblicher Selbst- oder Fremdgefährdung

C Ausschließlich Fragen des Datenschutzes im Bereich der Psychiatrie

D Ausschließlich die Ausbildung und Weiterbildung von Fachärzten

11 Psychologie & Kommunikation

20 Fragen

201 **Was bedeutet Kongruenz (Echtheit) in der Gesprächsführung?** ●●

(A) Das äußere Verhalten stimmt mit dem inneren Erleben überein (Echtheit)

(B) Man verstellt sich im Gespräch bewusst und gezielt

(C) Man äußert grundsätzlich das Gegenteil des Gemeinten

(D) Man schweigt im Gespräch grundsätzlich und dauerhaft

202 **Welche drei Grundhaltungen kennzeichnen die personenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers?** ●●●

(A) Autorität, Distanz, Kontrolle

(B) Belehrung, Wertung, Ratschlag

(C) Empathie, Kongruenz (Echtheit) und bedingungslose Wertschätzung

(D) Schweigen, Ignorieren, Ablenken

203 **Was ist im Umgang mit Menschen mit fortgeschrittener Demenz oft sinnvoll?** ●●

(A) Auf Fakten bestehen und widersprechen

(B) Möglichst schnell und kompliziert sprechen

(C) Ständiges Abfragen von Datum und Ort

(D) Einfache Sprache, Blickkontakt und Gefühle aufgreifen statt zu korrigieren

204 **Wozu dient Biografiearbeit in der Pflege?** ●●

(A) Zur reinen Sammlung von Daten ohne weiteren praktischen Nutzen

(B) Zur Überwachung und Kontrolle des Verhaltens der Patienten

(C) Die Lebensgeschichte zu nutzen, um individuell, sinnstiftend und bedürfnisorientiert zu pflegen

(D) Um vergangene Ereignisse im Leben zu bewerten und zu beurteilen

205 **Was ist bei der Deeskalation aggressiver Situationen hilfreich?** ●●

(A) Die eigene Lautstärke steigern und Drohungen aussprechen

(B) Ruhig bleiben, zuhören, Abstand und Sicherheit wahren und den Menschen ernst nehmen

(C) Den betroffenen Menschen gezielt reizen und provozieren

(D) Ihn umgehend und ohne weitere Deeskalation zu fixieren

206 **Was ist ein Vorurteil bzw. Stereotyp?** ●●

(A) Eine vorgefasste, verallgemeinernde Bewertung ohne ausreichende Prüfung

(B) Eine gesicherte und fachlich belegte medizinische Diagnose

(C) Ein im Pflegeprozess formuliertes konkretes Pflegeziel

(D) Eine objektive, mit Messgeräten erhobene Beobachtung

207 **Was besagt das Axiom 'Man kann nicht nicht kommunizieren' (Watzlawick)?** ●●

A Nur bewusst gesprochene Worte gelten als echte Kommunikation

B Jedes Verhalten hat Mitteilungscharakter – auch Schweigen oder Wegsehen wirkt kommunikativ

C Die Kommunikation ist für das Miteinander im Grunde unwichtig

D Ausschließlich schriftlich Festgehaltenes zählt als Kommunikation

208 **Was ist Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Rosenberg?** ●●

A 4 Schritte: Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte

B Schweigen bei Konflikten

C Konfliktmanagement-Kurs

D Kommunikation ohne Schreien

209 **Was beschreibt der 'erste Eindruck' (Primäreffekt)?** ●●

A Er trifft grundsätzlich immer zu und ist zuverlässig zutreffend

B Er spielt für die weitere Wahrnehmung praktisch keine Rolle

C Frühe Informationen prägen die Wahrnehmung stark und können zu Fehleinschätzungen führen

D Er bildet sich erst nach mehreren Wochen der näheren Bekanntschaft

210 **Was besagt das 4-Ohren-Modell nach Schulz von Thun?** ●●

A 4 Fehler in der Kommunikation

B 4 Phasen der Kommunikation

C Jede Nachricht hat 4 Seiten

D 4 Kommunikationsstile

211 **Was unterscheidet problemorientiertes von emotionsorientiertem Coping?** ●●●

A Problemorientiert verändert die Situation, emotionsorientiert reguliert die eigenen Gefühle

B Beide Bewältigungsformen sind vollständig identisch und unterscheiden sich nicht

C Jede Form der Bewältigung ist grundsätzlich schädlich für den Betroffenen

D Ausschließlich Medikamente können bei der Bewältigung überhaupt helfen

212 **Was bedeutet Empathie in der Pflege?** ●

A Ein Mitgefühl, das die Pflegekraft handlungsunfähig macht

B Die Fähigkeit, sich in die Gefühle und Sichtweise des anderen einzufühlen

C Eine grundsätzliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Patienten

D Das konsequente Durchsetzen der eigenen Meinung

213 **Was kennzeichnet eine offene Frage?** ●

A Sie lädt zum ausführlichen Erzählen ein (z. B. 'Wie geht es Ihnen?')

B Sie kann nur mit Ja oder Nein beantwortet werden

C Sie ist immer suggestiv

D Sie unterbricht das Gespräch

214 **Was beschreibt selektive Wahrnehmung?** ●●

(A) Die Umgebung wird stets vollständig objektiv wahrgenommen

(B) Die menschliche Wahrnehmung verläuft grundsätzlich fehlerfrei

(C) Wir nehmen bevorzugt wahr, was zu unseren Erwartungen und Interessen passt – anderes wird ausgeblendet

(D) Der Mensch nimmt seine Umgebung im Grunde gar nicht wahr

215 **Was gehört zur nonverbalen Kommunikation?** ●

(A) Die Rechtschreibung und die Grammatik des Geschriebenen

(B) Mimik, Gestik, Körperhaltung, Blickkontakt und Tonfall

(C) Ausschließlich der reine inhaltliche Sinn der gesprochenen Worte

(D) Die verwendete E-Mail-Adresse und Telefonnummer

216 **Was bedeutet professionelle Abgrenzung?** ●●

(A) Patienten bewusst grob und abweisend zu behandeln

(B) Sich emotional so abzugrenzen, dass man empathisch bleibt, ohne selbst auszubrennen

(C) Grundsätzlich keinerlei Empathie und Mitgefühl zu zeigen

(D) Möglichst gar nicht mit den Patienten ins Gespräch zu gehen

217 **Wie geht man konstruktiv mit einem Teamkonflikt um?** ●●

(A) Den Konflikt bewusst übergehen und einfach aussitzen

(B) Das Problem sachlich ansprechen, aktiv zuhören und gemeinsam nach Lösungen suchen

(C) Die vermeintlich Schuldigen öffentlich beim Namen nennen

(D) Die Kommunikation mit dem Gegenüber ganz abbrechen

218 **Was ist eine Ich-Botschaft in der Kommunikation?** ●●

(A) Ein deutlicher Vorwurf an den anderen ('Du machst das immer falsch')

(B) Eine klare Anweisung oder ein Befehl an das Gegenüber

(C) Bewusstes Schweigen, um dem anderen keine Angriffsfläche zu bieten

(D) Das Ausdrücken eigener Wahrnehmung und Gefühle ('Ich habe den Eindruck, dass...')

219 **Was meint 'bedingungslose Wertschätzung' (Akzeptanz)?** ●●

(A) Die vorbehaltlose Zustimmung zu jedem gezeigten Verhalten

(B) Die Akzeptanz ausschließlich freundlicher und netter Patienten

(C) Die Bewertung der Person nach der eigenen Sympathie

(D) Den Menschen als Person annehmen, unabhängig von Verhalten oder Meinung

220 **Was bedeutet Adhärenz (Compliance) in der Behandlung?**

(A) Das Ausmaß, in dem das Verhalten mit den gemeinsam vereinbarten Empfehlungen übereinstimmt

(B) Die reine ärztliche Anordnung ohne Beteiligung des Patienten

(C) Die grundsätzliche Ablehnung jeglicher Behandlung durch den Patienten

(D) Eine unerwünschte Nebenwirkung der verordneten Medikamente

12 Altenpflege & Geriatrie

20 Fragen

221 **Wie kann sich eine Depression im Alter von einer Demenz unterscheiden?** ●●●

A Bei der Depression klagen Betroffene oft selbst über die Beschwerden, während sie bei Demenz eher überspielt werden

B Depression und Demenz sind in ihrem Erscheinungsbild vollständig identisch

C Eine Depression tritt im höheren Lebensalter grundsätzlich nicht mehr auf

D Eine Demenz ist bei rechtzeitiger Behandlung in aller Regel vollständig heilbar

222 **Wie geht man mit herausforderndem Verhalten bei Demenz um?** ●●

A Man diskutiert mit der Person und korrigiert sie konsequent

B Man übergeht die Person und ihr Verhalten weitgehend

C Man begegnet ihr mit Strenge und deutlichem Druck

D Man sucht nach Auslösern, bleibt ruhig und wertschätzend und geht auf Bedürfnisse ein

223 **Welche Fraktur ist bei sturzgefährdeten älteren Menschen mit Osteoporose besonders häufig und folgenreich?** ●●

A Eine Zehenfraktur

B Eine Nasenbeinfraktur

C Eine Rippenprellung

D Die hüftnahe (Schenkelhals-)Fraktur

224 **Was ist Validation nach Naomi Feil in der Altenpflege?** ●●

A Schmerzmessung

B Kommunikationsmethode

C Lagerungstechnik

D Wundbehandlung

225 **Wozu dienen Kurzzeit- und Verhinderungspflege?** ●●

A Zur vorübergehenden Entlastung pflegender Angehöriger bzw. zur Überbrückung

B Der dauerhaften Unterbringung im Pflegeheim

C Ausschließlich der medizinischen Rehabilitation

D Der Finanzierung von Umbaumaßnahmen in der Wohnung

226 **Was regelt das Betreuungsrecht und wann greift es?** ●●●

A Rechtliche Betreuung für nicht mehr selbst handlungsfähige Volljährige

B Den Abschluss und die Inhalte eines Heimvertrags

C Die Vormundschaft für noch minderjährige Kinder

D Die Feststellung und Einstufung des Pflegegrades

227 **Was ist Sterbebegleitung und welche Zeichen des Sterbens sind zu beobachten?** ●●

A Aktive Begleitung: Mundpflege

B Arzt anrufen und warten

C Sofort Reanimation

D Nichts tun

228 **Was ist typisch für die Alzheimer-Demenz?** ●●

A Ein plötzlicher Beginn mit Verschlechterung über Nacht

B Ausschließlich körperliche Beschwerden ohne geistige Zeichen

C Ein schleichender Beginn mit fortschreitendem Verlust von Gedächtnis und Orientierung

D Eine bei rechtzeitiger Behandlung vollständige Heilbarkeit

229 **Wozu dient die Braden-Skala?** ●●

A Zur Messung des Blutdrucks

B Zur Bestimmung des Body-Mass-Index

C Zur Einschätzung des Dekubitusrisikos

D Zur Messung der Sehschärfe

230 **Was ist das Wundmanagement bei chronischen Wunden im Alter?** ●●●

A Systematische feuchte Wundversorgung

B Trockene Wundabdeckung mit Mull

C Pflaster draufkleben

D Tägliches Ausspülen mit Alkohol

231 **Was ist das SGB XI und welche Leistungen gibt es?** ●●●

A Arbeitslosenversicherung

B Rentenversicherung

C Krankenversicherung

D Soziale Pflegeversicherung

232 **Was ist der Expertenstandard Sturzprophylaxe?** ●●

A Die Anordnung von durchgehender und strenger Bettruhe

B Die vorbeugende Fixierung der sturzgefährdeten Person

C Risikoeinschätzung und individuelle Sturzpräventionsmaßnahmen

D Das durchgehende Hochstellen der seitlichen Bettgitter

233 **Was versteht man unter Polypharmazie und warum ist sie im Alter riskant?** ●●●

A Die Einnahme ausschließlich eines einzigen Medikaments

B Der vollständige Verzicht auf jegliche Medikamenteneinnahme

C Die gleichzeitige Einnahme vieler Medikamente mit erhöhtem Risiko für Wechsel- und Nebenwirkungen

D Eine besondere, speziell abgestimmte Form der Ernährung

234 **Was ist Biografiearbeit und warum ist sie in der Altenpflege wichtig?** ●●

A Eine möglichst lückenlose pflegerische Verlaufsdokumentation

B Die vollständige medizinische Vorgeschichte des Patienten

C Die Erhebung der Erkrankungen innerhalb der Familie

D Lebensgeschichte, Gewohnheiten und prägende Erlebnisse erfassen

235 **Was ist das Neue Begutachtungsassessment (NBA)?** ●●

A Begutachtungsinstrument
B Ein Pflegeplan
C Eine Pflegediagnose
D Ein Labortest

236 **Was ist bei einem plötzlich verwirrten älteren Menschen zu bedenken?** ●●

A Das ist im Alter normal und erfordert keine weitere Beachtung
B Es könnte ein akutes Delir mit behandelbarer Ursache sein (z. B. Infekt, Exsikkose, Medikamente)
C Es handelt sich grundsätzlich um eine unheilbare Demenz
D Man sollte den Betroffenen einfach in Ruhe weiterschlafen lassen

237 **Was ist bei der Hautpflege alter Menschen zu beachten?** ●

A Die Haut ist dünner und trockener, daher schonende Reinigung und rückfettende Pflege
B Möglichst heiß und lange baden
C Häufiges Waschen mit stark entfettender Seife
D Die Haut braucht keine besondere Pflege

238 **Was ist das Heimgesetz NRW (WTG) und was regelt es?** ●●●

A Wohn- und Teilhabegesetz
B Regelung der Pflegeausbildung
C Krankenhaus-Gesetze
D Ambulante Pflege

239 **Warum sind alte Menschen besonders von einer Exsikkose (Austrocknung) bedroht?** ●●

A Weil sie zu viel trinken
B Weil das Durstempfinden im Alter nachlässt und weniger getrunken wird
C Weil sie mehr Flüssigkeit speichern
D Weil Wasser im Alter schädlich ist

240 **Was ist Kinästhetik und ihre Bedeutung in der Altenpflege?** ●●

A Bewegungslehre
B Ergotherapie
C Physiotherapie
D Sporttherapie

13 Palliativpflege

20 Fragen

241 **Was versteht man unter palliativer Sedierung?** ●●●

A Die gezielte Herbeiführung des Todes

B Den kompletten Verzicht auf jede Medikation

C Das kontrollierte Herabsetzen des Bewusstseins zur Linderung sonst unstillbarer Symptome

D Eine Vollnarkose zur Operation

242 **Was unterscheidet ein stationäres Hospiz von einer Palliativstation?** ●

A Hospiz ist Teil des Krankenhauses

B Palliativstation ist im Krankenhaus, Hospiz ist eigenständig

C Beide sind identisch

D Hospiz nur für Kinder

243 **Was bedeutet eine Therapiezieländerung am Lebensende?** ●●

A Maximaltherapie um jeden Preis

B Wechsel von kurativem zu lindernd-palliativem Ziel

C Therapieabbruch ohne Begleitung

D Aktive Sterbehilfe

244 **Welche Nebenwirkung tritt regelhaft unter Opioiden auf und muss prophylaktisch behandelt werden?** ●●

A Durchfall

B Haarausfall

C Obstipation

D Fieber

245 **Was ermöglicht die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) vielen Menschen?** ●●

A Ausschließlich eine stationäre Behandlung

B Ein Sterben in der vertrauten häuslichen Umgebung

C Einen Verzicht auf jede Symptomkontrolle

D Nur die Versorgung im Krankenhaus

246 **Welche Phasen der Trauer beschrieb Verena Kast?** ●●●

A Zuerst Leugnen, dann Feilschen, danach Handeln und schließlich Vergessen

B Eine einzige, für alle Menschen immer gleich verlaufende Trauerphase

C Nicht-wahrhaben-Wollen, aufbrechende Emotionen, Suchen/Sich-Trennen, neuer Selbst- und Weltbezug

D Ein fester Ablauf aus anfänglichem Schock, Koma und darauf folgender Heilung

247 **Wie definiert die WHO Palliative Care?** ●

A Verbesserung der Lebensqualität bei lebensbedrohlicher Erkrankung

B Heilung der Grunderkrankung

C Ausschließlich Sterbebegleitung

D Beschränkt auf Schmerztherapie

248 **Was ist in der Sterbephase bei der Mundpflege besonders wichtig?**

A Reichliche Flüssigkeitszufuhr erzwingen
B Mundpflege vermeiden
C Feuchthalten der Schleimhäute und Komfort
D Ausschließlich Zähneputzen

249 **Was regelt eine Vorsorgevollmacht?**

A Sie bevollmächtigt eine benannte Vertrauensperson, im Ernstfall für einen zu entscheiden
B Sie legt nur die Bestattungsart fest
C Sie ersetzt das Testament
D Sie ist nur für Ärzte bindend, nicht für Angehörige

250 **Was gehört zur spirituellen Begleitung am Lebensende?**

A Ausschließlich medikamentöse Therapie
B Nur die Regelung finanzieller Fragen
C Das Eingehen auf Sinnfragen, Glauben und persönliche Werte, ggf. mit Seelsorge
D Das Ignorieren religiöser Bedürfnisse

251 **Wie begegnet man terminaler Unruhe (Delir) in der Sterbephase?**

A Den Patienten allein und im Dunkeln lassen
B Reizarme, ruhige Umgebung, Präsenz und ärztlich angeordnete Symptomlinderung
C Ihn grundsätzlich fixieren
D Jede Zuwendung vermeiden

252 **Welche Anzeichen deuten auf die beginnende Finalphase (nahender Tod) hin?**

A Steigender Appetit und mehr Energie
B Anhaltend hoher Blutdruck
C Marmorierte, kühle Haut, veränderte Atmung und zunehmende Schwäche
D Deutliche Gewichtszunahme

253 **Womit lindert man Übelkeit und Erbrechen in der Palliativversorgung?**

A Mit möglichst viel Nahrung auf einmal
B Mit Antiemetika nach ärztlicher Anordnung, angepasst an die Ursache
C Ausschließlich mit strikter Bettruhe
D Durch tagelanges Nüchternlassen

254 **Wie ist die Sorge vor Atemdepression bei korrekt titrierten Opioiden in der Palliativversorgung einzuordnen?**

A Sehr häufig auftretend, weshalb Opioide grundsätzlich gemieden werden
B In praktisch allen Fällen unmittelbar tödlich verlaufend
C Bei sachgerechter Titration selten - Symptomlinderung steht im Vordergrund
D Ausschließlich bei Kindern und Jugendlichen zu beobachten

255 **Was gehört zur würdevollen Versorgung eines Verstorbenen?** ●●

A Waschen, Herrichten und Beachten kultureller bzw. religiöser Wünsche

B Möglichst schnelles Abtransportieren ohne Rücksicht

C Sofortiges Entfernen aller persönlichen Gegenstände

D Verzicht auf jede Körperpflege

256 **Was ist bei der Trauerbegleitung von Angehörigen wichtig?** ●●

A Trauer zulassen und individuell begleiten

B Trauer schnell beenden

C Kontakt vermeiden

D Ausschließlich mit Medikamenten behandeln

257 **Welche Medikamente werden bei neuropathischen Schmerzen häufig ergänzend (als Ko-Analgetika) eingesetzt?** ●●●

A Nur klassische Schmerzmittel wie Paracetamol

B Ausschließlich Opioide

C Bestimmte Antidepressiva und Antikonvulsiva

D Reine Vitaminpräparate

258 **Warum ist es wichtig, Angehörigen Zeit zum Abschied am Verstorbenen zu geben?** ●

A Damit die Formalitäten schneller gehen

B Aus rein rechtlichen Gründen

C Weil ein bewusster Abschied die Trauerverarbeitung unterstützt

D Es ist eigentlich unwichtig

259 **Welches ist ein unsicheres Todeszeichen?** ●●

A Die eingetretene und deutlich ausgeprägte Totenstarre des Körpers

B Die sichtbaren Totenflecken an den tiefliegenden Körperpartien

C Die einsetzenden Fäulnis- und Zersetzungserscheinungen

D Fehlende Atmung und fehlender Puls

260 **Was ist bei kultur- und religionssensibler Sterbebegleitung wichtig?** ●●

A Allen dieselben Rituale vorzugeben

B Individuelle religiöse und kulturelle Bedürfnisse zu erfragen und zu respektieren

C Rituale generell abzulehnen

D Nur die eigene Weltanschauung gelten zu lassen

14 Rehabilitation

20 Fragen

261 **Was ist das zentrale Ziel von Leistungen zur Teilhabe (SGB IX)?** ●●

A Selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

B Klinikaufenthalt verlängern

C Pflegegrad erhöhen

D Medikamente reduzieren

262 **Wofür steht die Phase B im Phasenmodell der neurologischen Reha?** ●●●

A Für die abschließende berufliche Wiedereingliederung

B Für die Frührehabilitation schwer betroffener Patienten

C Für die reine Nachsorge zu Hause

D Für die medikamentöse Akutbehandlung

263 **Was ist ein Grundprinzip des Bobath-Konzepts?** ●●

A Betroffene Seite vernachlässigen

B Strikte Immobilisation

C Training nur der gesunden Seite

D Einbeziehung der betroffenen Körperseite

264 **Was bedeutet Ressourcenorientierung in der rehabilitativen Pflege?** ●

A Defizite betonen

B Vorhandene Fähigkeiten erkennen und fördern

C Alle Tätigkeiten abnehmen

D Den Pflegeaufwand reduzieren

265 **Worauf bezieht sich das ICF-Modell der WHO?** ●●

A Die ärztliche Diagnoseliste

B Der Medikationsplan

C Funktionsfähigkeit, Aktivität und Teilhabe

D Die Behandlungskosten

266 **Was misst der Barthel-Index?** ●●

A Den Blutdruck

B Ausschließlich das Sturzrisiko

C Die Selbstständigkeit bei Alltagsaktivitäten (ADL)

D Die Nahrungsaufnahme in Kalorien

267 **Wofür wird das Konzept der Basalen Stimulation eingesetzt?** ●●

A Förderung von Wahrnehmung und Kommunikation bei beeinträchtigten Menschen

B Eine Behandlung mit gezielt eingesetztem Reizstrom zur Muskelstimulation

C Die reine Gabe von Schmerzmitteln zur Linderung von Beschwerden

D Die fachgerechte Versorgung und Reinigung von Wunden

268 **Wie kommuniziert man am besten mit einem Menschen mit Aphasie?** ●●

A Möglichst schnell und viel auf einmal sprechen

B Alle Sätze für den Patienten zu Ende sprechen

C Geduldig, in kurzen einfachen Sätzen und mit nonverbalen Hilfen

D Kommunikation ganz vermeiden

269 **Was gehört zur Stumpfpflege nach einer Amputation?** ●●

A Den Stumpf möglichst nicht berühren

B Tägliche Hautinspektion, Reinigung und fachgerechtes Wickeln zur Stumpfformung

C Nur einmal wöchentlich kontrollieren

D Sofort dauerhaft die Prothese tragen

270 **In welcher Reihenfolge kleidet man einen Menschen mit Halbseitenlähmung an?** ●●

A Zuerst die gesunde Seite

B Zuerst die betroffene (gelähmte) Seite

C Die Reihenfolge ist egal

D Kleidung immer nur über den Kopf

271 **Was kennzeichnet aktivierend-therapeutische Pflege in der Rehabilitation?** ●●

A Therapeutische Prinzipien in Pflegehandlungen integrieren

B Vollständige Übernahme aller Tätigkeiten

C Reine Beobachtung ohne Eingreifen

D Strikte Bettruhe

272 **Was kennzeichnet das Konzept der Kinästhetik?** ●●

A Vollständiges Abnehmen jeder Bewegung

B Passives Durchbewegen ohne Beteiligung

C Bewegung ausschließlich über Hilfsmittel

D Bewegungsförderung durch angeleitete Eigenbewegung unter Nutzung vorhandener Ressourcen

273 **Was besagt der sozialrechtliche Grundsatz „Reha vor Pflege“?** ●●

A Pflege ist immer günstiger als Rehabilitation

B Reha ist nur für junge Menschen vorgesehen

C Rehabilitation hat Vorrang, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder zu mindern

D Pflegebedürftige haben keinen Reha-Anspruch

274 **Wer gehört typischerweise zum interprofessionellen Reha-Team?** ●

A Ausschließlich Pflegekräfte gemeinsam mit dem Reinigungsdienst

B Ausschließlich die behandelnden Ärzte und die Klinikverwaltung

C Ausschließlich die nahen Angehörigen des Patienten

D Pflege, Ärzte, Physio-/Ergotherapie, Logopädie, Sozialdienst

275 **Was ist ein Hauptziel der geriatrischen Rehabilitation?**

A Die vollständige Heilung sämtlicher bestehender Erkrankungen

B Erhalt von Selbstständigkeit und Vermeidung von Pflegebedürftigkeit

C Die dauerhafte Versorgung des Patienten in der Klinik

D Die gezielte Reduzierung der sozialen Kontakte

276 **Wer trägt in der Regel die Reha nach einem Arbeitsunfall?**

A Die gesetzliche Pflegekasse des betroffenen Patienten

B Das örtlich zuständige Sozialamt der Gemeinde

C Die private Haftpflichtversicherung des Verunfallten

D Die gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)

277 **Was ist eine Anschlussrehabilitation (AHB)?**

A Eine dauerhafte ambulante Versorgung im häuslichen Umfeld

B Ein Kuraufenthalt ganz ohne medizinische Notwendigkeit

C Ein Aufenthalt in einem Hospiz in der letzten Lebensphase

D Reha unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt

278 **Was ist ein zentrales Ziel der Ergotherapie?**

A Ausschließlich das gezielte Training der Muskelkraft

B Ausschließlich das Üben des Sprechens und der Sprache

C Die Handlungsfähigkeit und Selbstständigkeit im Alltag (ADL) wiederherstellen

D Die Verabreichung der ärztlich verordneten Medikamente

279 **Welcher Grundsatz gilt im deutschen Sozialrecht (SGB)?**

A Reha vor Pflege

B Pflege vor Reha

C Reha statt Pflege immer

D Pflege schließt Reha aus

280 **In welcher Reihenfolge zieht man einen Menschen mit Halbseitenlähmung aus?**

A Zuerst die gesunde Seite ausziehen

B Zuerst die betroffene Seite ausziehen

C Immer beide Arme gleichzeitig

D Die Reihenfolge ist unwichtig

15 Anatomie: Herz & Kreislauf

20 Fragen

281 **Was bewirkt eine Aktivierung des Sympathikus?** ●●●

A Pulssenkung und enge Pupillen
B Verstärkte Verdauung
C Pulsanstieg, weite Pupillen, weite Bronchien
D Schlaf und Erholung

282 **Was passiert in der Diastole?** ●

A Auswurf in die Aorta
B Maximale Kontraktion
C Erschlaffung und Füllung der Kammern
D Sprengung der Klappen

283 **Was misst die Pulsoxymetrie?** ●

A Den arteriellen Blutdruck über einen Sensor am Finger
B Den Gehalt an Kohlendioxid in der ausgeatmeten Luft
C Die Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz
D Unmittelbar und direkt die Atemfrequenz des Patienten

284 **Was bedeutet Bradykardie?** ●

A Herzfrequenz unter 60/min
B Herzfrequenz über 100/min
C Unregelmäßiger Puls
D Blutdruckabfall

285 **Wie heißt die Muskelschicht des Herzens?** ●

A Myokard
B Endokard
C Epikard
D Perikard

286 **Warum ist die korrekte Pulskontrolle pflegerisch wichtig?** ●

A Zur Beurteilung von Frequenz, Rhythmus und Kreislaufstabilität
B Zur Berechnung der Medikamentendosis
C Zur Bestimmung des Blutzuckers
D Zur Hautpflege

287 **Welche Klappe trennt die linke Kammer von der Aorta?** ●●

A Pulmonalklappe
B Aortenklappe
C Mitralklappe
D Trikuspidalklappe

288 **Welche Vene führt nährstoffreiches Blut vom Darm zur Leber?** ●●●

A Untere Hohlvene
B Pfortader (V. portae)
C Lebervene
D Milzarterie

289 **Wie berechnet sich das Herzzeitvolumen (HZV)?** ●●●

- A Blutdruck × Puls
- B Herzfrequenz ÷ Schlagvolumen
- C Systole − Diastole
- D Schlagvolumen × Herzfrequenz

290 **Welches Gefäß ist die größte Arterie des Körpers?** ●

- A Aorta
- B Obere Hohlvene
- C Pulmonalvene
- D A. carotis

291 **Wohin pumpt die rechte Herzhälfte das Blut?** ●●

- A In den Körperkreislauf
- B In die Aorta
- C In die Koronararterien
- D In den Lungenkreislauf

292 **Was gilt grundsätzlich für Arterien?** ●

- A Sie führen Blut vom Herzen weg
- B Sie führen immer sauerstoffarmes Blut
- C Sie führen Blut zum Herzen hin
- D Sie führen nur Lymphe

293 **Was ist die Systole?** ●

- A Erschlaffungs- und Füllungsphase
- B Ruhephase des Sinusknotens
- C Klappenschluss der Venen
- D Anspannungs- und Auswurfphase der Kammern

294 **Welche Funktion haben Venenklappen?** ●●

- A Den Rückfluss des Blutes verhindern
- B Blut beschleunigen
- C Sauerstoff binden
- D Den Blutdruck messen

295 **Welche Klappe liegt zwischen rechtem Vorhof und rechter Kammer?** ●●

- A Mitralklappe
- B Trikuspidalklappe
- C Aortenklappe
- D Pulmonalklappe

296 **Wie hoch ist der normale Ruhepuls eines Erwachsenen?** ●

- A 30–50/min
- B 100–140/min
- C 140–180/min
- D 60–100/min

297 **Welche Klappentypen gibt es im Herzen?** ●●

- A Segelklappen und Sehnenfäden
- B Segelklappen (AV) und Taschenklappen
- C Venenklappen und Lymphklappen
- D Ringklappen

298 **Welche Gefäße versorgen den Herzmuskel selbst mit Blut?** ●●

- A Die Lungenvenen
- B Die Hohlvenen
- C Die Koronararterien (Herzkranzgefäße)
- D Die Halsschlagadern

299 **Was bezeichnet der QRS-Komplex im EKG?** ●●●

- A Vorhoferregung
- B Kammerrepolarisation
- C Eine Pause
- D Kammererregung (Depolarisation)

300 **Wie heißen die beiden oberen Herzhöhlen?** ●

- A Ventrikel (Kammern)
- B Klappen
- C Septen
- D Vorhöfe (Atrien)

Lösungsschlüssel & Erklärungen

Richtige Antwort und kurze Begründung zu jeder Frage.

Generalistische Ausbildung & Recht

1	B	Staatliche Abschlussprüfung §§15-25 PflAPrV: 1. Schriftlich (3 Klausuren, 5h gesamt), 2. Mündlich (30-45 Min.), 3. Praktisch (im Vertiefungseinsatz).
2	D	6-stufiger Pflegeprozess: 1.Assessment 2.Pflegediagnose 3.Pflegeziele 4.Maßnahmen planen 5.Durchführen 6.Evaluation.
3	D	Evaluation: systematisch prüfen ob Ziele erreicht. Wenn nein → Ursachen analysieren, Plan ändern. Evaluation ist kontinuierlich.
4	A	Expertenstandards des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) sind wissenschaftlich fundierte, bundesweite Standards zu zentralen Themen wie Dekubitus-, Sturz- und Schmerzmanagement. Sie definieren fachlich anerkannte Qualitätsniveaus.
5	B	Die Ausbildung umfasst insgesamt rund 4600 Stunden: etwa 2100 Stunden theoretischen und praktischen Unterricht an der Pflegeschule sowie etwa 2500 Stunden praktische Ausbildung in den Einsatzbereichen.
6	A	Die Pflichteinsätze umfassen die stationäre Akutpflege (Krankenhaus), die stationäre Langzeitpflege (z. B. Pflegeheim), die ambulante Pflege sowie je einen Einsatz in der pädiatrischen und der psychiatrischen Versorgung – so wird die generalistische Breite abgedeckt.
7	C	Der generalistische Abschluss „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ ist EU-weit anerkannt (automatische Anerkennung nach EU-Berufsanerkennungsrichtlinie). Das erleichtert die Tätigkeit im europäischen Ausland und erhöht die berufliche Mobilität.
8	D	Pflichteinsatz Pädiatrie: 120h in Kinder- und Jugendmedizin. Ebenso Pflicht: 120h Psychiatrie und 500h Vertiefungseinsatz.
9	A	SMART: Spezifisch, Messbar, Attraktiv/Akzeptiert, Realistisch, Terminiert. Schlechtes Ziel: 'Patient soll sich besser fühlen' - nicht messbar!
10	A	Der Träger der praktischen Ausbildung erstellt für jede/n Auszubildende/n einen Ausbildungsplan, der die Reihenfolge der Einsätze, die zu erreichenden Kompetenzen und die Lernziele festlegt und den roten Faden der praktischen Ausbildung bildet.
11	B	Zugang bietet in der Regel ein mittlerer Schulabschluss oder ein Hauptschulabschluss zusammen mit einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung bzw. einer landesrechtlich geregelten Pflege(fach)assistenzausbildung.
12	A	Vorbehaltene Tätigkeiten (§ 4 PflBG) dürfen nur von ausgebildeten Pflegefachpersonen ausgeübt werden – dazu zählen die Erhebung des Pflegebedarfs, die Organisation und Steuerung des Pflegeprozesses sowie die Analyse und Evaluation der Pflegequalität.
13	D	Der Orientierungseinsatz steht am Anfang der Ausbildung und findet beim Träger der praktischen Ausbildung statt. Er dient dem Ankommen, dem Kennenlernen der Einrichtung und der grundlegenden Orientierung im Pflegealltag.
14	D	11 Curriculare Einheiten (CE): strukturieren den Theorieunterricht der GPA. Entwickelt von der Fachkommission nach §53 PflBG. CE 01 = Ausbildungsstart bis CE 11 = Koordination/Steuerung.
15	C	Salutogenese (CE 04): Gegensatz zur Pathogenese. Kohärenzgefühl = Verstehbarkeit + Handhabbarkeit + Bedeutsamkeit. Wichtig für Gesundheitsförderung.
16	C	Nahziele sind kurzfristig und in kleineren Schritten erreichbar, Fernziele (Richtziele) beschreiben das angestrebte längerfristige Gesamtergebnis. Nahziele bauen aufeinander auf und führen zum Fernziel hin.
17	D	Ressourcen sind die vorhandenen Fähigkeiten, Kräfte und Möglichkeiten eines Menschen (z. B. „kann sich mit Hilfsmittel selbst waschen“). Die Pflegeplanung stellt sie den Pflegeproblemen gegenüber und nutzt sie gezielt zur Förderung der Selbstständigkeit.
18	C	Auszubildende erhalten über die gesamte Ausbildung eine angemessene Ausbildungsvergütung. Schulgeld darf nicht erhoben werden – das macht die Ausbildung attraktiv und finanziell tragfähig.

19 **B** Kinaesthetics: Pflegende lernen natürliche Bewegungsmuster nutzen → weniger Kraftaufwand → Eigenaktivität des Patienten fördern. Weniger Rückenschäden beim Personal.

20 **C** Der Träger der praktischen Ausbildung (z. B. Krankenhaus, Pflegeeinrichtung, ambulanter Dienst) schließt den Ausbildungsvertrag, zahlt die Vergütung und verantwortet die praktische Ausbildung – organisiert über Kooperationsverträge mit der Pflegeschule und weiteren Einsatzstellen.

Pflegeprozess & Pflegeplanung

21 **D** Pflegeüberleitung (Entlassungsmanagement): Pflegeprobleme, Ressourcen, Maßnahmen, Hilfsmittelbedarf, Medikamente, soziale Situation weitergeben. Expertenstandard DNQP.

22 **C** Expertenstandard Schmerz (DNQP): 1.NRS-Einschätzung 2.Ziel mit Patient vereinbaren 3.WHO-Stufenschema + Lagerung/Wärme/Ablenkung 4.Evaluation nach 30-60 Min. 5.Patientenedukation.

23 **B** Dekubitus-Kategorien: I = nicht-wegdrückbare Rötung (Haut intakt), II = Blasen/Erosion (Teilverlust Dermis), III = Vollhautverlust bis Subkutis, IV = Muskeln/Knochen/Sehnen betroffen.

24 **A** Pflegeplanung: 1.Pflegeproblem (aktuell/potenziell), 2.Pflegeziel (SMART), 3.Pflegemaßnahmen (wer, was, wann), 4.Evaluation.

25 **B** In der Evaluation wird überprüft, ob die gesetzten Pflegeziele erreicht wurden und ob die Maßnahmen wirksam waren. Je nach Ergebnis wird die Pflegeplanung angepasst, fortgeführt oder beendet – der Pflegeprozess ist ein fortlaufender Regelkreis.

26 **A** Braden-Skala: 6 Faktoren bewertet. Max. 23 Punkte. ≤18 Punkte = Dekubitusrisiko. Je niedrigerer Wert desto höheres Risiko. Einzusetzen bei Aufnahme und bei Veränderungen.

27 **C** PSA anlegen: 1. Kittel (Körper schützen) 2. Maske/Atemschutz 3. Schutzbrille 4. Handschuhe (zuletzt – direkter Kontakt). Ablegen umgekehrt: 1. Handschuhe (kontaminiert!) 2. Kittel 3. Brille 4. Maske → dann Händedesinfektion.

28 **C** Orem: Pflege nur aktiv bei Selbstpflegedefizit. 3 Systeme: voll-kompensierend, teil-kompensierend, unterstützend-edukativ. Ziel: Selbstpflegekompetenz stärken.

29 **B** MRSA-Isolierung: Einzelzimmer (eigenes Bad), Schutzkittel, Handschuhe, FFP2-Maske bei engem Kontakt. Beim Verlassen: PSA im Zimmer ablegen → Händedesinfektion. Besuch möglich (Kittel + Handschuhe). Patienten aufklären und einbeziehen! Screening: Nasen-Rachen-Abstrich.

30 **D** Wäschesortierung: Roter Sack = Infektionswäsche (MRSA, C. diff., Norovirus, stark blutig/kontaminiert) → direkt verschließen, nicht im Zimmer sortieren, Handschuhe + Kittel. Weißer Sack = normale Wäsche. Wäsche NIE ausschütteln → Aerosolbildung → Keimverbreitung!

31 **A** Der Pflegeprozess wird häufig als sechsstufiges Regelkreismodell dargestellt: Informationssammlung, Erkennen von Problemen und Ressourcen, Festlegen der Pflegeziele, Planung der Maßnahmen, Durchführung und Evaluation. Die Schritte bauen aufeinander auf und werden fortlaufend angepasst.

32 **C** NRS: Patient bewertet Schmerz 0-10. Ab NRS ≥4 = Handlungsbedarf. Vor und nach Schmerzmedikation dokumentieren. Alternativen: VAS, BPS/CPOT (nicht-kommunikativ).

33 **C** Bei der Visuellen Analogskala (VAS) markiert der Patient seine Schmerzstärke auf einer Linie zwischen „kein Schmerz“ und „stärkster vorstellbarer Schmerz“. Sie dient – wie die numerische Rating-Skala (NRS) – der standardisierten Selbsteinschätzung und Verlaufskontrolle von Schmerzen.

34 **C** Potenzielle Pflegeprobleme = Risiken: z.B. 'Gefahr eines Dekubitus wegen Immobilität'. Erfordern prophylaktische Maßnahmen.

35 **B** Dauerhaftes Tragen ohne Indikation: falsches Sicherheitsgefühl (Desinfektion wird vergessen), Handschuhe werden zum Übertragungsweg, Hautschäden. Handschuhe ersetzen die Händedesinfektion NICHT – auch nach Handschuhwechsel desinfizieren!

36 **B** SMART: Spezifisch (konkrete Handlung: gehen), Messbar (10m), Attraktiv, Realistisch, Terminiert (3. postop. Tag). Vage Ziele sind nicht auswertbar!

37 **C** §23 IfSG: Krankenhäuser müssen nosokomiale Infektionen und Erreger mit speziellen Resistenzen (MRSA, VRE, ESBL) erfassen und bewerten. Pflicht: Hygienekommission, Krankenhaushygieniker oder -fachkraft, Surveillance-System (z.B. KISS). Ziel: Infektionsraten senken durch systematische Überwachung.

38 **C** C. difficile bildet Sporen, die durch Alkohol nicht abgetötet werden → mechanisches Händewaschen nötig. Ansonsten gilt: Hände waschen macht Schutzflora kaputt und schädigt die Haut. Desinfektion ist effektiver als Waschen!

39 **A** Ein Dekubitus Kategorie I zeigt eine umschriebene, nicht wegdrückbare Rötung bei noch intakter Haut (Fingertest positiv). Er ist ein Warnzeichen und erfordert sofortige konsequente Druckentlastung, um ein Fortschreiten in tiefere Kategorien zu verhindern.

40 **C** Nach Donabedian gliedert sich Qualität in Strukturqualität (Rahmenbedingungen wie Personal und Ausstattung), Prozessqualität (Abläufe und Durchführung der Pflege) und Ergebnisqualität (erreichter Zustand des Patienten). Alle drei zusammen bilden die Pflegequalität ab.

Prävention & Gesundheitsförderung

41 **D** Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) regelt Melde- und Benachrichtigungspflichten, Tätigkeitsverbote und Maßnahmen zum Schutz vor übertragbaren Krankheiten.

42 **C** Empowerment befähigt Menschen, mehr Kontrolle über Entscheidungen und Handlungen zu gewinnen, die ihre Gesundheit beeinflussen.

43 **C** Verhaltensprävention verändert individuelles Verhalten (z.B. Rauchstopp), Verhältnisprävention verändert Umwelt- und Lebensbedingungen (z.B. Rauchverbote, Arbeitsschutz).

44 **C** Bei hoher Durchimpfungsrate kann sich ein Erreger kaum ausbreiten, wodurch auch nicht geimpfte oder immungeschwächte Personen indirekt geschützt werden (Gemeinschaftsschutz).

45 **B** Tertiärprävention setzt bei einer bereits bestehenden Erkrankung an und will Folgeschäden, Komplikationen und Rückfälle verhindern – etwa durch Rehabilitation, Schulungen oder Nachsorge.

46 **C** Rückenschonendes Arbeiten: in die Knie gehen und aus den Beinen heben, den Rücken gerade halten, die Last körpernah führen, Drehbewegungen vermeiden und Hilfsmittel bzw. Kinaesthetics nutzen. Das beugt Muskel-Skelett-Erkrankungen vor.

47 **D** Beratung fördert eine informierte Entscheidung; Anleitung vermittelt eine konkrete praktische Fertigkeit Schritt für Schritt.

48 **D** Beim Fingertest wird die Rötung kurz weggedrückt: Bleibt sie bestehen (nicht wegdrückbar), liegt bereits ein Dekubitus Kategorie 1 vor. Eine wegdrückbare Rötung ist eine reversible Hyperämie.

49 **A** Die hygienische Händedesinfektion ist die einfachste und wirksamste Einzelmaßnahme zur Verhütung von Krankenhausinfektionen und zur Eindämmung multiresistenter Erreger.

50 **D** Gebrauchte Kanülen kommen ohne Zurückstecken der Schutzkappe (kein Recapping!) direkt in einen durchstichsicheren, verschließbaren Abwurfbehälter – das senkt das Risiko von Nadelstichverletzungen.

51 **A** Bei MRSA (methicillinresistenter Staphylococcus aureus) gelten Barrieremaßnahmen: Einzelzimmer bzw. Isolierung, Schutzkittel, Handschuhe, konsequente Händedesinfektion und ggf. Sanierung, um die Übertragung zu verhindern.

52 **B** Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut erstellt die nationalen Impfempfehlungen.

53 **A** Nach einer Nadelstichverletzung: Blutfluss anregen, Wunde mit Wasser/Antiseptikum spülen und desinfizieren, dann D-Arzt bzw. Betriebsarzt aufsuchen und den Unfall dokumentieren/melden (Hepatitis- und HIV-Risiko abklären).

54 **B** Kontrakturprophylaxe beruht auf regelmäßiger aktiver und passiver Bewegung sowie physiologischer Gelenkstellung und Lagerung. Dauerhafte Ruhigstellung führt gerade zur Kontraktur.

55 **B** Zur Basis-/physikalischen Thromboseprophylaxe gehören Frühmobilisation, Bewegungsübungen, Kompression (MTPS) und ausreichende Flüssigkeit; medikamentös ergänzt niedermolekulares Heparin. Bettruhe fördert Thrombosen.

56 **B** Motivational Interviewing stärkt die intrinsische Motivation zur Verhaltensänderung durch empathische, nicht-konfrontative Gesprächsführung.

57 **B** Standardhygiene (Basishygiene) gilt bei allen Patienten unabhängig von einer bekannten Infektion – dazu zählen Händedesinfektion, Schutzhandschuhe und -kleidung nach Bedarf, sichere Entsorgung und Flächendesinfektion.

58 **B** Aufrechte Position (ca. 90°), ruhiges Tempo, kleine Bissen, angepasste Konsistenz (z. B. angedickte Flüssigkeit bei Dysphagie) und Konzentration aufs Schlucken senken das Aspirationsrisiko.

59 **B** BGM zielt darauf, Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich zu gestalten, Belastungen zu reduzieren und Gesundheit sowie Motivation der Beschäftigten langfristig zu erhalten (z. B. Ergonomie, Rückenschule, Pausenkultur).

60 **D** Pneumonieprophylaxe umfasst tiefe Atemübungen, Mobilisation, Oberkörperhochlagerung, Sekretmobilisation und gute Mundpflege. Immobilität und Hustendämpfung erhöhen das Risiko.

Mobilität & Bewegung

61 **D** Fixierungen sind freiheitsentziehend und mit eigenen Risiken verbunden; sie sind nur als letztes Mittel zulässig – grundsätzlich mit Einwilligung bzw. richterlicher Genehmigung. Vorrang haben schonende Alternativen.

62 **C** Die Virchow-Trias nennt die drei Hauptfaktoren der Thromboseentstehung: Gefäßwand- bzw. Endothelschaden, Stase (z. B. durch Immobilität) und Hyperkoagulabilität.

63 **A** Wechseldrucksysteme entlasten durch zyklisch wechselnden Druck und werden bei hohem Dekubitusrisiko eingesetzt – ergänzend, nicht als Ersatz für Bewegungsförderung.

64 **A** Zur Spitzfußprophylaxe wird der Fuß in physiologischer 90-Grad-Stellung gelagert (z. B. Fußstütze) und das Sprunggelenk regelmäßig bewegt.

65 **D** Ein Lifter dient dem sicheren Transfer schwer immobiler Patienten und schützt vor Sturz und Rückenschäden. Anwendung nach Einweisung und mit passendem Gurt.

66 **A** Bei aktiven Übungen bewegt der Patient selbst (fördert Kraft und Beweglichkeit); bei passiven bewegt die Pflegekraft die Gelenke, z. B. zur Kontrakturenprophylaxe bei fehlender Eigenaktivität.

67 **D** Grad 1: intakte Haut mit lokal begrenzter, nicht wegdrückbarer Rötung (Fingertest). Offene oder nekrotische Wunden entsprechen höheren Graden.

68 **D** Bewegung in vollem Bewegungsausmaß und physiologische Gelenkstellung erhalten die Beweglichkeit. Immobilität fördert Kontrakturen.

69 **A** Der Rollator hat Räder (oft mit Bremse und Sitz) für kontinuierliches Gehen; ein Gehbock wird angehoben und versetzt und gibt sehr viel Standstabilität.

70 **C** Das Bobath-Konzept ist ein neurophysiologischer Ansatz zur Förderung von Menschen mit zentralen Bewegungsstörungen (z. B. Hemiplegie nach Schlaganfall).

71 **A** Die ATL/AEDL 'Sich bewegen' umfasst Positionswechsel, Transfer, Gehen und Bewegungsübungen und bildet die Grundlage vieler Prophylaxen.

72 **D** Mikrolagerung verlagert durch kleine Bewegungen regelmäßig die Druckpunkte, ohne den Patienten stark umzulagern – schonend und dekubitusprophylaktisch wirksam.

73 **B** Kinästhetik nutzt die Eigenbewegung des Patienten; die Pflegekraft unterstützt gezielt statt zu heben – das schont den Rücken und fördert die Aktivität des Patienten.

74 **D** Ein Bewegungsförderungsplan wird individuell erstellt (Ressourcen, Risiken, Ziele), regelmäßig evaluiert und dokumentiert – gemäß Expertenstandard Mobilität.

75 **C** Aktivierende Pflege bezieht vorhandene Fähigkeiten ein und fördert Selbstständigkeit statt vollständiger Übernahme.

76 **B** Bei der Braden-Skala gilt: je niedriger der Punktwert, desto höher das Dekubitusrisiko (18 Punkte oder weniger = gefährdet).

77 **D** Vor dem Transfer: Bremsen von Rollstuhl und Bett feststellen, Fußstützen wegklappen, rutschfeste Schuhe, klare Ansage und ggf. Hilfsmittel nutzen – so werden Stürze vermieden.

78 **B** Bei fortgeschrittener pAVK kann Kompression die ohnehin reduzierte arterielle Durchblutung weiter verschlechtern – daher Vorsicht bzw. Kontraindikation und ärztliche Abklärung.

79 **B** Frühmobilisation reduziert typische Immobilitätskomplikationen (Thrombose, Pneumonie, Dekubitus, Obstipation), fördert Kreislauf und Darmtätigkeit und beschleunigt die Genesung.

80 **A** Immobilität führt zu Muskelatrophie, Osteoporose, Kontrakturen und Obstipation sowie erhöhtem Dekubitus-, Thrombose- und Pneumonierisiko.

Notfall & Akutsituationen

81 **A** Starke Blutung: sofort direkten Druck auf die Wunde, Druckverband anlegen, Extremität hochhalten; bei lebensbedrohlicher Extremitätenblutung ggf. Tourniquet. Notruf 112, Schockprophylaxe, Eigenschutz mit Handschuhen.

82 **A** B = Breathing: Atmung beurteilen – Atemfrequenz, Atemtiefe/-muster, SpO2, Auskultation, Thoraxbewegungen; ggf. Sauerstoffgabe.

83 **B** FAST: Face (hängender Mundwinkel), Arms (Armvorhalteversuch), Speech (Sprachstörung), Time (rascher Notruf). Beim Schlaganfall zählt jede Minute ('Time is brain').

84 **C** CPR startet, sobald eine Person nicht ansprechbar ist und nicht normal atmet (Schnappatmung zählt nicht als normal). Vorher Notruf 112 absetzen und – wenn möglich – einen AED holen lassen.

85 **A** Bewusstlos mit normaler Atmung: Atemwege sichern, stabile Seitenlage, Notruf 112, kontinuierliche Überwachung der Atmung – bei Veränderung sofort reagieren.

86 **D** ABCDE wird strikt in der Reihenfolge abgearbeitet: erst lebensbedrohliche Probleme der Atemwege, dann Atmung, Kreislauf usw. – jedes Problem wird sofort behandelt, bevor man weitergeht.

87 **B** C = Circulation: Puls, Blutdruck, Rekapillarisierungszeit, Blutung stillen, Zugang und Volumen.

88 **C** E = Exposure/Environment: den Patienten situationsgerecht entkleiden und vollständig untersuchen, dabei Auskühlung vermeiden (Wärmeerhalt).

89 **D** Grün = normal/Standard, maximal 90 Minuten.

90 **C** A = Airway: zuerst die Atemwege sichern bzw. freimachen (ggf. mit HWS-Schutz).

91 **C** Der hypovolämische Schock entsteht durch Volumenmangel (Blutung, Flüssigkeitsverlust). Weitere Formen: kardiogen, septisch, anaphylaktisch, neurogen.

92 **B** Defibrillierbar sind Kammerflimmern (VF) und pulslose ventrikuläre Tachykardie (pVT). Asystolie und PEA sind nicht schockbar.

93 **A** Der AED wird eingeschaltet, die Elektroden werden aufgeklebt; man folgt den Sprachanweisungen. Während Analyse und Schockabgabe darf niemand den Patienten berühren.

94 **C** Effektive Kompressionen: harte Unterlage, Tiefe 5–6 cm, Frequenz 100–120/min, vollständige Entlastung (Recoil) nach jeder Kompression und minimale Unterbrechungen.

95 **A** 100–120/min, Drucktiefe 5–6 cm, vollständige Entlastung zwischen den Kompressionen.

96 **C** Kleinflächige Verbrennungen mit handwarmem/lauwarmem Wasser kühlen (kein Eis – Erfrierungsgefahr), keine Hausmittel, Blasen nicht öffnen, locker keimarm bedecken. Bei großflächigen Verbrennungen kein ausgedehntes Kühlen (Auskühlung).

97 **B** Beim Kind (durch Fachpersonal): 5 initiale Beatmungen, dann Verhältnis 15:2, Drucktiefe etwa ein Drittel des Brustkorbdurchmessers. Laien dürfen 30:2 anwenden.

98 **A** Über Präsentationsdiagramme wird anhand von Indikatoren (Diskriminatoren) die höchste zutreffende Stufe gewählt.

99 **D** Atmung/Kreislauf werden max. 10 Sekunden geprüft. Bei fehlender normaler Atmung oder Unsicherheit sofort mit der Wiederbelebung beginnen.

100 **D** 112 ist der europaweite Notruf für Rettungsdienst und Feuerwehr. 110 ist die Polizei, 116117 der ärztliche Bereitschaftsdienst.

Innere Medizin

101 **A** Metabolische Azidose: pH und HCO3- (sowie Base Excess) sind erniedrigt. Ursachen: Ketoazidose, Laktatazidose, Nierenversagen, schwere Durchfälle. Kompensation über vertiefte Atmung (Kussmaul).

102 **D** Das Lungenödem zeigt sich durch schwere Dyspnoe, feuchte/brodelnde Rasselgeräusche und ggf. schaumigen Auswurf. Sofortmaßnahmen: Oberkörper hoch, Beine tief, Sauerstoff, Arzt.

103 **A** Bikarbonat liegt normal bei etwa 22–26 mmol/l. Es ist der metabolische Parameter und sinkt z. B. bei metabolischer Azidose.

104 **D** Chronischer Bluthochdruck schädigt Gefäße und Organe: erhöhtes Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz sowie Nieren- und Netzhautschäden. Daher konsequente Therapie und Kontrolle.

105 **A** Tägliche Gewichtskontrolle + Ein-/Ausfuhrbilanz. Gewichtszunahme >1kg/Tag = Warnsignal für Flüssigkeitsretention → Arzt informieren!

106 **A** pH-Werte unter etwa 7,0 oder über 7,8 sind akut lebensbedrohlich (Enzym- und Organfunktion). Der Normbereich ist mit 7,35–7,45 eng.

107 **C** Asthma verläuft typischerweise anfallsartig mit weitgehend reversibler Obstruktion (oft allergisch), während die COPD eine chronische, nur teilreversible Obstruktion ist.

108 **B** Der normale arterielle pH liegt bei 7,35–7,45. Werte unter 7,35 bedeuten Azidose, über 7,45 Alkalose. Der Bereich ist eng reguliert.

109 **C** Dysphagie = Schluckstörung. Stille Aspiration (kein Husten!) besonders gefährlich → Aspirationspneumonie. Logopädie, angepasste Kostform (IDDSI), OK-Hochlagerung beim Essen, kein Strohhalm!

110 **D** BGA-Proben werden in heparinisierten Spritzen abgenommen; Luftblasen verfälschen pO2/pCO2 und müssen entfernt werden. Rasche Analyse (ggf. gekühlt), da der Zellstoffwechsel die Werte verändert.

111 **A** Typ-1-Diabetes beruht auf einem absoluten Insulinmangel durch autoimmune Zerstörung der Betazellen; Typ-2-Diabetes auf Insulinresistenz mit relativem Mangel, oft mit Übergewicht/Lebensstil assoziiert.

112 **D** Bei respiratorischer Azidose staut sich CO2 (Hypoventilation): pCO2 steigt, der pH sinkt. Zur Kompensation steigt später das HCO3- (renale Kompensation).

113 **A** Die COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) ist durch eine chronische, nicht vollständig reversible Atemwegsobstruktion gekennzeichnet – meist raucherassoziiert, mit Husten, Auswurf und Belastungsdyspnoe.

114 **D** Der pCO2 liegt normal bei etwa 35–45 mmHg. Er ist der respiratorische Parameter und steigt z. B. bei Hypoventilation.

115 **D** BZ < 70 mg/dl + Patient wach → 20g KH oral. BZ-Kontrolle nach 15 Min. Bei Bewusstlosigkeit: Glukose 40% i.v. oder Glukagon i.m.

116 **C** Bei Hyperventilation wird zu viel CO2 abgeatmet: pCO2 sinkt, der pH steigt (respiratorische Alkalose). Typisch bei Angst/Panik mit Kribbeln und Pfötchenstellung.

117 **A** Die Lungenembolie zeigt sich oft mit plötzlicher Atemnot, atemabhängigem Brustschmerz, Tachykardie, ggf. Husten/Hämoptyse; Ursache meist eine tiefe Beinvenenthrombose. Notfall – 112.

118 **D** Bobath: betroffene Seite aktivieren statt kompensieren. Patient von betroffener Seite ansprechen, Lagerung auf beiden Seiten, alle Aktivitäten beidseitig. Fördert Neuroplastizität.

119 **B** Kalium ist entscheidend für die Erregbarkeit von Herz und Muskulatur. Eine schwere Hyperkaliämie kann bedrohliche Herzrhythmusstörungen bis zum Kammerflimmern auslösen – Werte engmaschig überwachen.

120 **A** HbA1c = glykiertes Hämoglobin: zeigt Durchschnitts-BZ der letzten 8-12 Wochen. Ziel bei Diabetes meist < 7%. Nicht von Tageszeit abhängig.

Chirurgie

121 **C** Frühmobilisation reduziert Thrombose, Pneumonie, Dekubitus und paralytischen Ileus, fördert Kreislauf und Darmtätigkeit und beschleunigt die Genesung – schmerzadaptiert und sicher durchgeführt.

122 **A** Die perioperative Antibiotikaprophylaxe wird bei entsprechender Indikation rechtzeitig vor dem Hautschnitt gegeben, damit zum Operationszeitpunkt ausreichende Wirkspiegel bestehen.

123 **C** Nachblutung: Tachykardie, Blutdruckabfall, Unruhe, blasse kaltschweißige Haut, rasch zunehmende blutige Drainagemenge oder durchgeblutete Verbände – Zeichen eines beginnenden Volumenmangelschocks. Sofort Arzt informieren.

124 **A** Eine TVT zeigt sich oft einseitig mit Schwellung, Spannungs-/Schweregefühl, Überwärmung, ggf. livider Verfärbung und Schmerz. Es besteht Lungenembolie-Gefahr – ärztlich abklären, die Wade nicht ausstreichen.

125 **B** Beim Kompartmentsyndrom steigt der Druck in einer geschlossenen Muskelloge (z. B. nach Fraktur/OP) so an, dass Durchblutung und Nerven geschädigt werden. Alarmzeichen: starker, lageunabhängiger Schmerz, Blässe, Sensibilitätsstörungen – Notfall.

126 **B** Vor einem Eingriff muss der einwilligungsfähige Patient rechtzeitig ärztlich aufgeklärt werden und einwilligen. Ohne wirksame Einwilligung ist der Eingriff (außer im Notfall) rechtswidrig.

127 **A** Komplikationen nach Appendektomie: Wundinfektion (3-5%), intraabdomineller Abszess (bei Perforation), Darmparalyse/Ileus (Blähbauch, kein Darmgeräusch), Nachblutung. Frühmobilisation reduziert Ileus.

128 **A** Übliche Nüchternheitsgrenzen: klare Flüssigkeiten bis 2 Stunden, leichte/feste Nahrung bis 6 Stunden vor der Narkose – zur Vermeidung einer Aspiration bei der Narkoseeinleitung.

129 **B** Bei Drainagen werden Fördermenge und Sekretbeschaffenheit dokumentiert, Sog und Durchgängigkeit kontrolliert, die Eintrittsstelle beobachtet und Zeichen einer Nachblutung (plötzlich viel frisches Blut) erkannt.

130 **A** Die Redon-Drainage ist eine geschlossene Wunddrainage mit Sog (Unterdruck), die Wundsekret/Blut ableitet und die Wundränder anlegt. Sog und Fördermenge werden überwacht und dokumentiert.

131 **B** PONV = postoperative Übelkeit und Erbrechen, häufig nach Narkosen (Risiko u. a. Frauen, Nichtraucher, Reisekrankheit). Prophylaxe/Therapie mit Antiemetika, Aspiration vermeiden.

132 **C** Nüchternheit reduziert das Risiko, dass bei der Narkoseeinleitung Mageninhalt erbrochen und in die Lunge aspiriert wird (Aspirationspneumonie) – eine potenziell lebensbedrohliche Komplikation.

133 **D** Stomapflege: Vitalität/Farbe (rosig-feucht) beurteilen, Peristomahaut schützen, dicht sitzende Versorgung wählen, Ausscheidung beobachten und die Betroffenen schrittweise zur selbstständigen Versorgung anleiten (Psyche beachten).

134 **C** Klassische Entzündungszeichen: Rötung, Schwellung, Überwärmung, Schmerz und Funktionseinschränkung – bei Wundinfektion oft mit eitrigem Sekret und ggf. Fieber. Arzt informieren.

135 **B** Drainagen werden nach ärztlicher Anordnung gezogen, meist wenn die Sekretförderung deutlich nachgelassen hat. Vorher Menge/Verlauf dokumentieren; das Ziehen erfolgt aseptisch.

136 **B** Die Bilanzierung (Ein-/Ausfuhr inkl. Urin, Drainagen, Erbrochenes) erkennt frühzeitig Flüssigkeitsdefizite, Nachblutungen oder Nierenprobleme und steuert die postoperative Flüssigkeitstherapie.

137 **D** Wundheilung verläuft in Phasen: Exsudations-/Reinigungsphase, Granulations-/Proliferationsphase (Gefäß- und Gewebeneubildung), Epithelisierungs- und schließlich Reifungs-/Remodeling-Phase.

138 **C** Pneumonieprophylaxe: Atemübungen (Atemtrainer/Triflow), Oberkörperhochlagerung, frühe Mobilisation, gute Schmerztherapie (damit tief geatmet werden kann) und Sekretmobilisation.

139 **B** Postoperative Standardprophylaxen: Thrombose (NMH, Kompressionsstrümpfe, Frühmobilisation), Pneumonie (Atemübungen, OK-Hochlagerung), Dekubitus (Umlagerung), Sturz (Klingel griffbereit).

140 **A** Beim Harnverhalt kann die gefüllte Blase nicht spontan entleert werden (z. B. nach Narkose/Regionalanästhesie). Zeichen: Unterbauchschmerz, tastbare Blase, Harndrang ohne Miktion. Ggf. Einmalkatheterisierung.

Pädiatrie

141 **C** Bei leichter bis mäßiger Dehydration durch Durchfall/Erbrechen ist die orale Rehydratation mit einer speziellen Glukose-Elektrolyt-Lösung (ORS) die Therapie der Wahl. Reines Wasser oder zuckerhaltige Getränke gleichen die Elektrolytverluste nicht aus.

142 **A** STIKO (Ständige Impfkommission): Impfkalender für Kinder. Pflegerelevant: Impfstatus bei Aufnahme prüfen, Eltern über Nachholimpfungen informieren, Kontraindikationen beachten (akute Erkrankung, Immundefizienz). Dokumentation im Impfpass.

143 **D** Kindesmisshandlung: körperlich (Hämatome, Knochenbrüche), emotional (Vernachlässigung, psychische Gewalt), sexuell. Schutzauftrag §8a SGB VIII: Hinweise dokumentieren, Kinderarzt einbeziehen, Kinderschutzteam, ggf. Jugendamt. Schweigepflicht kann zurücktreten!

144 **A** Keuchhusten (Pertussis) ist eine bakterielle Erkrankung mit langwierigen, anfallsartigen Hustenattacken, oft mit typischem Einziehen der Luft. Für junge Säuglinge kann er lebensbedrohlich sein (Atemstillstände); Schutz bietet die Impfung, auch der Kontaktpersonen (Kokon-Strategie).

145 **B** Neonataler Ikterus: physiologisch (Tag 2-7), durch Abbau fetaler RBC (höhere Hämoglobin-Konzentration). Pathologisch: innerhalb 24h, >2 Wochen, Reifgeborene >17mg/dl → Phototherapie (Blaulicht 420-490nm). Stillen fördern erhöht Ausscheidung.

146 **A** Rooming-in: Eltern bleiben Tag und Nacht beim Kind. Vorteile: Stärkung Eltern-Kind-Bindung, Stillen fördern, Kind fühlt sich sicher, Eltern lernen Pflege, reduziert Hospitalisierungsangst. Gesetzlich verankert (§ 2 Kinderschutz).

147 **C** Das Fremdeln (etwa ab dem 8. Lebensmonat) ist ein normaler Entwicklungsschritt: Der Säugling unterscheidet vertraute von fremden Personen und reagiert auf Fremde mit Unbehagen. Es zeigt eine gesunde Bindungsentwicklung an.

148 **A** Pseudokrupp (Laryngotracheitis): meist viral (Parainfluenza). Symptome: bellender Husten, Heiserkeit, inspiratorischer Stridor, besonders nachts. Behandlung: kühle feuchte Luft (Fenster auf), Kortison (Dexamethason/Rectodelt), Kind beruhigen, bei schwerem Anfall Klinik.

149 **D** Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist eine häufige Ursache von Bronchiolitis und obstruktiver Bronchitis bei Säuglingen, v. a. in den Wintermonaten. Symptome sind Husten, Atemnot, Giemen und Trinkschwäche; Frühgeborene sind besonders gefährdet.

150 **C** GPA-Pflichteinsatz Pädiatrie: 120h in Kinder- und Jugendmedizin. Ziel: altersspezifische Besonderheiten, Entwicklungsstufen, familienorientierte Pflege.

151 **A** Exsikkose (Dehydratation): häufig bei Kinder durch Erbrechen/Durchfall. Zeichen: trockene Schleimhäute, eingesunkene Fontanelle (Säugling), stehende Hautfalte (>2s), Oligurie, dunkler Urin, Tachykardie, Lethargie. Behandlung: orale/i.v. Rehydratation.

152 **C** Vitamin D fördert die Aufnahme und den Einbau von Kalzium in die Knochen. Die Prophylaxe im ersten Lebensjahr (meist bis zum zweiten erlebten Frühsommer) beugt der Rachitis (gestörte Knochenmineralisierung) vor.

153 **D** Scharlach wird durch A-Streptokokken (Bakterien) verursacht und zeigt sich mit Fieber, Halsschmerzen, Himbeerzunge und feinfleckigem Ausschlag. Er wird mit Antibiotika (z. B. Penicillin) behandelt, um Komplikationen und Folgeerkrankungen vorzubeugen.

154 **B** Kleinkinder sind sehr neugierig und unfallgefährdet. Zur Prävention gehören Treppen- und Herdschutzgitter, Steckdosensicherungen, das sichere Verwahren von Medikamenten, Reinigungsmitteln und Kleinteilen (Verschluckungsgefahr) sowie Aufsicht am und im Wasser.

155 **B** Motorische Meilensteine: 3 Mo. = Kopfkontrolle. 5-6 Mo. = Drehen. 7-8 Mo. = freies Sitzen. 8-10 Mo. = Krabbeln. 10-14 Mo. = Stehen, erste Schritte. Variationsbreite beachten! Alarm: kein Sitzen mit 9 Mo., kein Laufen mit 18 Mo.

156 **A** Frühgeborene haben wenig Unterhautfettgewebe, eine große Körperoberfläche und eine unreife Wärmeregulation – sie kühlen rasch aus. Deshalb sind Inkubator/Wärmebett, angepasste Umgebungstemperatur, Temperaturüberwachung und die Känguru-Methode wichtig.

157 **A** Fiebersenker für Kinder (z. B. Paracetamol, Ibuprofen) werden streng nach Körpergewicht und Alter dosiert. Acetylsalicylsäure (ASS) ist bei Kindern mit fieberhaften Virusinfekten wegen des Risikos eines Reye-Syndroms zu vermeiden.

158 **D** APGAR (nach Virginia Apgar): A=Appearance (Farbe), P=Pulse (HF), G=Grimace (Reflexe), A=Activity (Tonus), R=Respiration (Atmung). Je 0-2 Punkte. 1./5./10. Minute. 7-10=gut, 4-6=mäßig, 0-3=schlecht.

159 **A** NIDCAP (Neonatal Individualized Developmental Care): entwicklungsfördernde Pflege für Frühgeborene. Elemente: Nestlagerung (Grenzen geben), gedimmtes Licht, minimale Stimulation, Clusterpflege (Eingriffe bündeln), Känguru-Methode (Hautkontakt), Eltern als Hauptbezugspersonen.

160 **B** Beikost wird meist zwischen dem Beginn des 5. und 7. Lebensmonats eingeführt, wenn das Kind Reifezeichen zeigt (z. B. Kopfkontrolle, Interesse am Essen). Vorher deckt Milch den Bedarf; zu früher Beginn erhöht Allergie- und Aspirationsrisiken.

Gynäkologie & Geburtshilfe

161 **C** Not-Sectio bei akuter Gefahr für Mutter oder Kind: path. CTG, Nabelschnurvorfall, vorzeitige Plazentalösung, Geburtsstillstand.

162 **D** Reichen Ernährung und Bewegung nicht, wird mit Insulin behandelt; orale Antidiabetika werden in der Schwangerschaft i. d. R. nicht eingesetzt.

163 **A** Die Tokolyse hemmt Wehen und verschafft Zeit, um Lungenreife abzuschließen und ggf. in ein Perinatalzentrum zu verlegen.

164 **D** Das CTG zeichnet Wehen und kindliche Herztöne auf. Herzfrequenzabfälle können auf eine fetale Hypoxie hinweisen.

165 **C** APGAR bewertet Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen und Reflexe (je 0–2 Punkte) bei 1, 5 und 10 Minuten. 7–10 gilt als unauffällig.

166 **B** HELLP = Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets – eine schwere Verlaufsform der Präeklampsie.

167 **D** Der rechtsseitige Oberbauchschmerz entsteht durch Spannung der Leberkapsel – mit Übelkeit, Kopfschmerz und Hypertonie ein Warnzeichen.

168 **D** Frühgeburt = Geburt vor abgeschlossener 37. SSW. Je unreifer, desto höher das Risiko für Atemprobleme und Infektionen.

169 **D** Korrektes Anlegen: Kind erfasst Mamille samt großem Teil des Warzenhofs, Lippen nach außen, Kinn an der Brust – beugt wunden Mamillen vor.

170 **A** Das Kind hat vermehrt Insulin gebildet; nach Wegfall des mütterlichen Zuckerangebots droht eine neonatale Hypoglykämie.

171 **D** Eröffnungsphase (Muttermund bis 10 cm), Austreibungsphase (vollständige Eröffnung bis Geburt des Kindes, Presswehen), Nachgeburtsphase (Geburt der Plazenta).

172 **C** Geburtsbeginn: regelmäßige, zunehmende Wehen, Blasensprung (Fruchtwasserabgang) und Zeichnen (Abgang des blutig-schleimigen Schleimpfropfs).

173 **C** Ursächlich beseitigt wird HELLP nur durch die Entbindung; bis dahin RR-Senkung, Magnesium (Krampfprophylaxe), Kortison (Lungenreife).

174 **D** Stillen ist nach Sectio möglich, durch Wundschmerz und verzögerten Milcheinschuss oft erschwert – aktive Stillberatung und schmerzarme Positionen helfen.

175 **A** Kortison (Betamethason) beschleunigt die kindliche Lungenreife/Surfactant-Bildung und senkt das Risiko eines Atemnotsyndroms.

176 **C** Prolaktin bildet die Milch, Oxytocin löst den Let-down-Reflex aus. Häufiges Anlegen fördert über den Saugreiz beide Hormone.

177 **D** Nach OP und im Wochenbett ist das Thromboserisiko erhöht: LMWH, Kompression, frühe Mobilisation – plus Wochenbett-Kontrollen (Fundus, Lochien).

178 **C** Der oGTT wird in der 24.–28. SSW durchgeführt, da der GDM meist symptomarm verläuft und sonst unentdeckt bliebe.

179 **A** Die U1 erfolgt unmittelbar nach der Geburt (inkl. APGAR). Die U2 folgt am 3.–10. Lebenstag mit dem Neugeborenen-Screening.

180 **C** Wegen relativ großer Körperoberfläche und unreifer Wärmeregulation drohen Auskühlung/Hypothermie – Abtrocknen, Haut-zu-Haut, Mütze beugen vor.

Psychiatrie

181 **D** OCD (ICD-10 F42): Zwangsgedanken = unwillkürliche, ichfremde, belastende Gedanken. Zwangshandlungen = ritualhafte Handlungen zur Angstreduktion (z.B. Händewaschen, Kontrollieren). Behandlung: KVT + ERP (Exposition mit Reaktionsverhinderung) + SSRI.

182 **D** De-Eskalation: 1. Sicherheit (Abstand, Fluchtwege), 2. Ruhige Haltung/Stimme, 3. Empathie zeigen, 4. Bedürfnisse erfragen, 5. Wahlmöglichkeiten anbieten, 6. Unterstützung holen. Fixierung immer letztes Mittel!

183 **B** Das bio-psycho-soziale Modell erklärt psychische Störungen als Ergebnis eines Zusammenspiels aus biologischen (Genetik, Neurotransmitter), psychischen (Denkmuster, Bewältigung) und sozialen Faktoren (Umfeld, Belastung). Es ist Grundlage einer ganzheitlichen, multiprofessionellen Behandlung.

184 **A** Das Delirium tremens ist eine lebensbedrohliche Komplikation des Alkoholentzugs mit Bewusstseins- und Orientierungsstörung, Tremor, Halluzinationen, Unruhe sowie vegetativen Zeichen (Schwitzen, Tachykardie, Blutdruckanstieg). Es erfordert engmaschige Überwachung und Behandlung.

185 **B** Einwilligungsfähigkeit meint, dass die Person Wesen, Bedeutung und Folgen einer Behandlung erfassen und danach frei entscheiden kann. Sie wird situationsbezogen beurteilt und ist unabhängig von der Geschäftsfähigkeit. Fehlt sie, greifen Betreuungsrecht bzw. Unterbringungsregeln.

186 **D** Major Depression (ICD-10 F32): Kernsymptome: depressive Stimmung, Interessenverlust, Antriebsminderung. Zusatzsymptome: Schlafstörung, Konzentrationsstörung, Schuldgefühle, Suizidgedanken, Appetitminderung. Mind. 2 Wochen.

187 **B** Merkmale einer Abhängigkeit sind u. a. starkes Verlangen (Craving), Kontrollverlust über den Konsum, Toleranzentwicklung, Entzugssymptome, Vernachlässigung anderer Interessen und fortgesetzter Konsum trotz schädlicher Folgen.

188 **B** Das maligne neuroleptische Syndrom ist eine seltene, lebensbedrohliche Komplikation einer Antipsychotika-Therapie mit hohem Fieber, ausgeprägter Muskelrigidität, Bewusstseinsstörung und vegetativer Entgleisung. Es ist ein Notfall – das Medikament wird abgesetzt und intensiv behandelt.

189 **A** Milieutherapie: gesamte Stationsumgebung als therapeutisches Instrument. Elemente: klare Tagesstruktur, soziale Regeln, Gruppenangebote (Ergotherapie, Sport, Kochen), therapeutische Gemeinschaft, Patienten übernehmen Verantwortung.

190 **C** Die stimmungsaufhellende Wirkung von Antidepressiva (z. B. SSRI) setzt meist erst nach etwa 1–3 Wochen ein, während Nebenwirkungen früher auftreten können. Wichtig sind Aufklärung, Adhärenzförderung und kein abruptes Absetzen (Absetzsymptome).

191 **C** Borderline (ICD-10 F60.3): instabile Emotionen, Impulsivität, instabile Beziehungen (Idealisierung/Entwertung), Identitätsstörung, Selbstverletzung, Suizidalität, chronische Leere. DBT (Dialektisch-Behaviorale Therapie) als Behandlung.

192 **B** Demenz (ICD-10 F00-F03): organischer, fortschreitender kognitiver Abbau. Depression: affektive Störung, behandelbar. Pseudodemenz: Depression die wie Demenz aussieht → Therapieversuch! Unterscheidung wichtig für Behandlungsplanung.

193 **B** Krisenintervention ist zeitlich begrenzte, unmittelbare Hilfe zur Stabilisierung. Ein bekanntes Schema ist BELLA: Beziehung aufbauen, Erfassen der Situation, Linderung der Symptome, Leute einbeziehen, Ansatz zur Problembewältigung. Ziel ist Entlastung und Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit.

194 **B** Der psychopathologische Befund (z. B. nach AMDP) beschreibt systematisch Bewusstsein, Orientierung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, formales und inhaltliches Denken, Wahrnehmung, Affekt, Antrieb und Ich-Erleben. Pflegende beobachten diese Merkmale kontinuierlich und geben Veränderungen ans Team weiter.

195 **A** Bei Intoxikation steht die vitale Sicherung im Vordergrund: engmaschige Kontrolle von Bewusstsein, Atmung, Kreislauf; Aspirationsschutz (stabile Seitenlage bei Bewusstseinstrübung), Schutz vor Auskühlung und Selbstgefährdung. Psychische Begleitung folgt, wenn der Zustand stabil ist.

196 **D** Psychoedukation: strukturierte Vermittlung von Wissen über die Erkrankung (Was ist Schizophrenie?), Medikamente (Wirkung/NW), Frühwarnsymptome, Rückfallprävention. Fördert Compliance und Selbstmanagement.

197 **B** Therapeutische Kommunikation: aktives Zuhören, Empathie zeigen, offene Fragen stellen, spiegeln, nicht bewerten, Gefühle ansprechen, Schweigen aushalten. Basis jeder psychiatrischen Pflege.

198 **A** Psychose: Realitätsverlust, Halluzinationen, Wahn (z.B. Schizophrenie). Neurose (veraltet): Angststörungen, Zwangsstörungen, Depressionen – Realitätsbezug erhalten. Moderne Psychiatrie nutzt ICD-10/DSM-5.

199 **B** Ein strukturierter Tagesablauf (feste Zeiten für Mahlzeiten, Aktivitäten, Ruhe) gibt Orientierung und Sicherheit, wirkt Antriebslosigkeit und Grübeln entgegen und fördert Selbstständigkeit. Er ist zentraler Bestandteil der Milieutherapie, besonders bei Depression und Psychosen.

200 **B** Das Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) der Länder – in NRW das PsychKG NRW – regelt Hilfen, Schutzmaßnahmen sowie die Voraussetzungen und das gerichtliche Verfahren einer Unterbringung bei erheblicher Eigen- oder Fremdgefährdung. Patientenrechte und Kontrolle durch das Gericht stehen im Vordergrund.

Psychologie & Kommunikation

201 **A** Kongruenz bedeutet Echtheit: Das gezeigte Verhalten stimmt mit dem inneren Erleben überein. Der Gegenüber erlebt die Pflegekraft als authentisch und glaubwürdig.

202 **C** Carl Rogers nennt drei Grundhaltungen: Empathie (einfühlendes Verstehen), Kongruenz (Echtheit) und bedingungslose Wertschätzung (Akzeptanz) – sie schaffen ein hilfreiches Gesprächsklima.

203 **D** Hilfreich sind kurze, einfache Sätze, Blickkontakt, ruhige Zuwendung und das Aufgreifen von Gefühlen. Ständiges Korrigieren/Abfragen kann verunsichern; im fortgeschrittenen Stadium steht die Beziehung vor der Realitätsorientierung.

204 **C** Biografiearbeit nutzt die Lebensgeschichte, um Gewohnheiten, Vorlieben und Bedürfnisse zu verstehen und die Pflege individuell und sinnstiftend zu gestalten – besonders wertvoll bei Menschen mit Demenz.

205 **B** Deeskalation: ruhige Stimme und Körpersprache, aktiv zuhören, Bedürfnisse ernst nehmen, ausreichend Sicherheitsabstand, keine Provokation. Ziel ist, Spannung abzubauen; freiheitsentziehende Maßnahmen sind letztes Mittel.

206 **A** Ein Vorurteil ist eine vorgefasste, oft verallgemeinernde Bewertung ohne ausreichende Prüfung. In der Pflege ist es wichtig, eigene Vorurteile zu erkennen, um Menschen individuell und vorurteilsfrei zu begegnen.

207 **B** Nach Watzlawick hat jedes Verhalten Mitteilungscharakter: Auch Schweigen, Mimik oder Abwenden senden Botschaften. Man kann sich also nicht 'nicht' verhalten und damit nicht 'nicht' kommunizieren.

208 **A** GFK: 1. Beobachtung (ohne Bewertung), 2. Gefühl, 3. Bedürfnis, 4. Bitte (keine Forderung). Unterschied: Beobachtung ≠ Bewertung. Reduziert Konflikte im Team und mit Patienten.

209 **C** Der Primäreffekt beschreibt, dass frühe Eindrücke die weitere Wahrnehmung überproportional prägen. Das kann zu Fehleinschätzungen führen – daher bewusst offen bleiben und Urteile überprüfen.

210 **C** Schulz von Thun: Sachinhalt (Info), Selbstoffenbarung (über Sender), Beziehungsebene (zum Empfänger), Appell (was soll Empfänger tun?). Missverständnisse: Sender und Empfänger sprechen/hören auf verschiedenen Ebenen.

211 **A** Problemorientiertes Coping zielt darauf, die belastende Situation zu verändern (z. B. Lösung suchen). Emotionsorientiertes Coping reguliert die Gefühle (z. B. Entspannung, Umbewertung). Beide können je nach Situation sinnvoll sein.

212 **B** Empathie ist das Einfühlen in Gefühle und Sichtweise des anderen, ohne sich darin zu verlieren. Sie ist Grundlage einer vertrauensvollen Pflegebeziehung – abzugrenzen von handlungslähmendem Mitleid.

213 **A** Offene Fragen (W-Fragen: Wie, Was, Wobei) laden zum Erzählen ein und fördern das Gespräch. Geschlossene Fragen sind nur mit Ja/Nein zu beantworten und dienen der Klärung von Details.

214 **C** Selektive Wahrnehmung bedeutet, dass wir bevorzugt das wahrnehmen, was zu Erwartungen, Interessen oder Vorannahmen passt. Das kann zu einseitigen Einschätzungen führen – wichtig ist bewusste, offene Beobachtung.

215 **B** Zur nonverbalen Kommunikation zählen Mimik, Gestik, Körperhaltung, Blickkontakt, Berührung und der Tonfall (paraverbal). Sie transportiert vor allem Beziehungs- und Gefühlsbotschaften.

216 **B** Professionelle Abgrenzung heißt, mitfühlend zu sein, aber die Belastungen der Patienten nicht dauerhaft zu übernehmen. Sie ist ein wichtiger Schutz vor emotionaler Erschöpfung und Burnout.

217 **B** Konstruktiver Umgang: den Konflikt frühzeitig und sachlich ansprechen, die Perspektive des anderen anhören (aktives Zuhören), auf der Sachebene bleiben und gemeinsam nach Lösungen suchen – bei Bedarf mit Moderation.

218 **D** Ich-Botschaften beschreiben die eigene Wahrnehmung und das eigene Gefühl, ohne den anderen anzuklagen. Sie wirken weniger angreifend als Du-Botschaften (Vorwürfe) und fördern konstruktive Gespräche.

219 **D** Bedingungslose Wertschätzung meint, den Menschen als Person zu achten, unabhängig von seinem Verhalten oder seiner Meinung. Das heißt nicht, jedes Verhalten gutzuheißen – Person und Verhalten werden getrennt.

220 **A** Adhärenz beschreibt, wie sehr das Verhalten (z. B. Medikamenteneinnahme) mit den gemeinsam vereinbarten Empfehlungen übereinstimmt. Gute Adhärenz entsteht durch Information, Beteiligung und eine vertrauensvolle Beziehung.

Altenpflege & Geriatrie

221 **A** Bei einer Altersdepression klagen Betroffene häufig selbst über Gedächtnis- und Antriebsprobleme und wirken traurig oder verzweifelt, während Menschen mit beginnender Demenz Defizite oft bagatellisieren. Die Abgrenzung ist wichtig, da eine Depression gut behandelbar ist (Pseudodemenz).

222 **D** Herausforderndes Verhalten (z. B. Unruhe, Aggression) ist oft Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse, Angst oder Schmerz. Hilfreich sind Ruhe, Wertschätzung, das Suchen nach Auslösern, validierende Kommunikation und das Anpassen der Umgebung – statt Konfrontation oder Zwang.

223 **D** Bei Osteoporose (Knochenschwund) führen schon leichte Stürze häufig zu Frakturen – besonders folgenreich ist die hüftnahe Schenkelhalsfraktur. Sie bedeutet oft Operation, längere Immobilität und Verlust von Selbstständigkeit; Sturz- und Osteoporoseprophylaxe sind daher zentral.

224 **B** Validation: demenzkranker Mensch sagt 'Ich muss nach Hause zu meinen Kindern' → NICHT: 'Ihre Kinder sind erwachsen' → SONDERN: 'Sie vermissen Ihre Kinder sehr.' Gefühle ernst nehmen, nicht in Realität zwingen.

225 **A** Kurzzeitpflege (vorübergehende vollstationäre Pflege, z. B. nach einem Klinikaufenthalt) und Verhinderungspflege (Ersatzpflege bei Ausfall der Pflegeperson) entlasten pflegende Angehörige zeitweise und überbrücken Engpässe. Beide sind Leistungen der Pflegeversicherung (SGB XI).

226 **A** Betreuungsrecht (§§1814ff BGB seit 2023): wenn Volljähriger aufgrund Krankheit/Behinderung Angelegenheiten nicht selbst regeln kann → Betreuungsgericht bestellt Betreuer. Vorrang: Vorsorgevollmacht! Betreuer handelt im Wohl der betreuten Person.

227 **A** Sterbezeichen: Rasselatmung (Sekret), Cheyne-Stokes-Atmung (periodisch), Totenflecken (Livores), kühle/blaue Extremitäten, Bewusstlosigkeit, fehlende Reflexe. Pflegerische Maßnahmen: Mundpflege (wichtigste Maßnahme!), Lagerung, Schmerzkontrolle, Familie informieren und einbeziehen, ruhige Atmosphäre.

228 **C** Die Alzheimer-Demenz ist die häufigste Demenzform. Typisch sind ein schleichender Beginn und ein langsam fortschreitender Verlust von Kurzzeitgedächtnis, Orientierung, Sprache und Alltagskompetenz. Sie ist bislang nicht heilbar, aber begleit- und teils medikamentös behandelbar.

229 **C** Die Braden-Skala ist ein Assessment-Instrument zur Einschätzung des Dekubitusrisikos. Sie bewertet Faktoren wie sensorische Wahrnehmung, Feuchtigkeit, Aktivität, Mobilität, Ernährung sowie Reibung/Scherkräfte. Ein niedriger Punktwert bedeutet ein höheres Risiko.

230 **A** Chronische Wunden im Alter: Dekubitus, Ulcus cruris (venös/arteriell), Diabetisches Fußsyndrom. Wundmanagement: Wunddokumentation (Foto, Maße, Wundtiefe, Exsudat, Infektzeichen), feuchte Wundversorgung (fördert Heilung), Ursachenbehandlung, Wundexpertenberatung (ICW-zertifiziert).

231 **D** SGB XI Leistungen: Pflegegeld (für häusliche Pflege durch Angehörige), Sachleistung (ambulanter Pflegedienst), Kombinationsleistung, vollstationäre Pflege, Kurzzeitpflege (bis 8 Wochen/Jahr), Verhinderungspflege (bis 6 Wochen), Entlastungsbetrag 125€/Monat.

232 **C** Expertenstandard Sturzprophylaxe (DNQP): Risikoeinschätzung bei Aufnahme (z.B. STRATIFY). Maßnahmen: rutschfeste Schuhe, Gehhilfen, Rufanlage in Reichweite, Medikamentenreview (Sedativa!), Umgebung sturzfrei gestalten, Toilettenpläne, Bewegungsförderung. Keine FEM als ersten Schritt!

233 **C** Polypharmazie ist die dauerhafte Einnahme mehrerer (oft fünf oder mehr) Medikamente gleichzeitig. Im Alter steigt dadurch das Risiko für Wechselwirkungen, Nebenwirkungen, Stürze und Verwirrtheit. Eine regelmäßige Überprüfung der Medikation (z. B. anhand der Priscus-Liste) ist wichtig.

234 **D** Biografiearbeit: bei Demenz oft einziger Zugang zum Menschen. Lieblingsspeisen, Musikgeschmack, Berufsbiografie, Rituale kennen → personenzentrierte Pflege. Biografiebogen bei Aufnahme ausfüllen, Angehörige einbeziehen.

235 **A** NBA: bewertet 6 Module: 1.Mobilität, 2.Kognition/Kommunikation, 3.Verhaltensweisen, 4.Selbstversorgung, 5.Krankheitsbewältigung, 6.Alltagsgestaltung. Geistige/psychische Beeinträchtigungen gleichwertig wie körperliche!

236 **B** Eine akute Verwirrtheit (Delir) hat oft eine behandelbare Ursache – z. B. Harnwegsinfekt, Exsikkose, Schmerzen, Medikamente oder Umgebungswechsel. Sie ist ein Warnzeichen: Ursachen werden gesucht und behandelt, die Umgebung wird ruhig und orientierungsfördernd gestaltet.

237 **A** Im Alter wird die Haut dünner, trockener und empfindlicher (weniger Talg, geringere Elastizität). Empfehlenswert sind schonende Reinigung, nicht zu heißes Wasser, milde Waschsubstanzen und rückfettende Pflege, um Hautrisse, Juckreiz und Infektionen zu vermeiden.

238 **A** WTG NRW (Wohn- und Teilhabegesetz): regelt stationäre Pflegeeinrichtungen, Tages-/Kurzzeitpflege, Wohngemeinschaften. Heimaufsicht prüft: Personalschlüssel, Qualitätsstandards, Bewohnerrechte, Hygiene, Sicherheit. Bewohner haben Recht auf: Selbstbestimmung, Privatsphäre, Besuch.

239 **B** Im Alter lässt das Durstempfinden nach, gleichzeitig sinkt der Wassergehalt des Körpers. Dadurch trinken ältere Menschen oft zu wenig und sind exsikkosegefährdet. Trinkpläne, Erinnerungshilfen und Getränke in Reichweite beugen vor.

240 **A** Kinästhetik in der Altenpflege: besonders wichtig bei immobilen, schwer pflegebedürftigen Menschen. Pflegende führen Bewegungen nicht durch sondern begleiten sie. Weniger Rückenschäden beim Personal, mehr Würde für Bewohner, Eigenaktivität auch bei Schwerstpflegebedürftigen fördern.

Palliativpflege

241 **C** Palliative Sedierung senkt kontrolliert und in der niedrigst nötigen Dosis das Bewusstsein, um sonst unerträgliche, therapierefraktäre Symptome (z. B. Atemnot, Unruhe) zu lindern. Sie zielt nicht auf den Tod ab und ist von aktiver Sterbehilfe klar abzugrenzen.

242 **B** Die Palliativstation ist in ein Krankenhaus integriert (Krisenintervention, Symptomkontrolle), das Hospiz ist eine eigenständige Einrichtung für die letzte Lebensphase.

243 **B** Bei infauster Prognose wird das Ziel von Heilung auf Linderung und Lebensqualität umgestellt - kein Behandlungsabbruch, sondern bestmögliche palliative Versorgung.

244 **C** Opioide verursachen fast immer Obstipation. Eine Laxanzien-Prophylaxe gehört daher zur Standardbegleitung der Opioidtherapie.

245 **B** Viele Menschen wünschen sich, zu Hause zu sterben. Ambulante Palliativangebote wie die SAPV ermöglichen durch Symptomkontrolle, Beratung und Rufbereitschaft ein würdevolles Sterben in der vertrauten Umgebung.

246 **C** Verena Kast beschreibt vier Trauerphasen: Nicht-wahrhaben-Wollen, aufbrechende Emotionen, Suchen und Sich-Trennen sowie einen neuen Selbst- und Weltbezug. Trauer verläuft individuell und nicht streng linear.

247 **A** WHO: Palliative Care verbessert die Lebensqualität von Patienten und Angehörigen bei lebensbedrohlicher Erkrankung durch Linderung von Leiden (körperlich, psychosozial, spirituell).

248 **C** In der Sterbephase steht Komfort im Vordergrund: regelmäßiges Befeuchten der Mundschleimhaut lindert Durstgefühl und Mundtrockenheit.

249 **A** Mit einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigt man eine Vertrauensperson, im Fall der eigenen Entscheidungsunfähigkeit Angelegenheiten (z. B. Gesundheit, Aufenthalt, Finanzen) zu regeln – so wird oft eine gerichtliche Betreuung vermieden.

250 **C** Spirituelle Begleitung nimmt Sinn-, Glaubens- und Wertefragen ernst, unabhängig von einer bestimmten Religion. Sie kann Gespräche, Rituale oder die Einbindung von Seelsorge umfassen und ist Teil des ganzheitlichen Palliativansatzes.

251 **B** Bei terminaler Unruhe helfen eine ruhige, reizarme Umgebung, vertraute Bezugspersonen, beruhigende Ansprache und – nach ärztlicher Anordnung – medikamentöse Symptomkontrolle. Behebbare Ursachen wie Harnverhalt oder Schmerz sollten bedacht werden.

252 C Zeichen der Finalphase sind zunehmende Schwäche und Schläfrigkeit, Rückzug, nachlassender Appetit, marmorierte und kühle Extremitäten, veränderte Atmung (z. B. Cheyne-Stokes) sowie Rasselatmung.

253 B Übelkeit und Erbrechen werden ursachenorientiert mit Antiemetika (z. B. Metoclopramid, Haloperidol, Dimenhydrinat) behandelt; ergänzend helfen kleine Portionen, frische Luft, Mundpflege und eine ruhige Umgebung.

254 C Bei sachgerechter, an die Wirkung titrierter Gabe ist eine klinisch relevante Atemdepression selten. Die Linderung von Schmerz und Atemnot hat Vorrang.

255 A Die Versorgung Verstorbener erfolgt würdevoll und ruhig: Der Leichnam wird gewaschen und hergerichtet, Zugänge werden nach Vorgabe entfernt, kulturelle und religiöse Wünsche werden beachtet und den Angehörigen wird Zeit zum Abschied gegeben.

256 A Trauer ist ein individueller Prozess. Begleitung bedeutet Zuhören, Dasein und das Zulassen von Gefühlen ohne Bewertung.

257 C Neuropathische Schmerzen sprechen oft nur begrenzt auf klassische Analgetika an. Als Ko-Analgetika werden u. a. bestimmte Antidepressiva (z. B. Amitriptylin, Duloxetin) und Antikonvulsiva (z. B. Gabapentin, Pregabalin) eingesetzt.

258 C Ein bewusster, würdevoller Abschied am Verstorbenen hilft Angehörigen, den Verlust zu begreifen, und unterstützt eine gesunde Trauerverarbeitung. Pflegende schaffen dafür einen ruhigen, ungestörten Rahmen.

259 D Unsichere Todeszeichen wie Atem- und Pulsstillstand, Blässe, Areflexie oder weite Pupillen können auch bei Bewusstlosigkeit oder Scheintod auftreten. Erst sichere Zeichen (Totenflecke, Totenstarre, Fäulnis) beweisen den Tod.

260 B Kultur- und religionssensible Begleitung erfragt und respektiert individuelle Bedürfnisse (z. B. Rituale, Speisevorschriften, Umgang mit dem Leichnam) und vermeidet pauschale Annahmen. Im Zweifel fragt man Betroffene und Angehörige.

Rehabilitation

261 A Das SGB IX zielt auf Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung.

262 B Im BAR-Phasenmodell steht Phase A für die Akutbehandlung und Phase B für die Frührehabilitation schwer betroffener Patienten; die Phasen C–F folgen mit zunehmender Selbstständigkeit bis zur beruflichen Wiedereingliederung.

263 D Bobath bezieht die betroffene (hemiplegische) Seite aktiv ein, um Wahrnehmung und Bewegung anzubahnen - z.B. Pflege von der betroffenen Seite.

264 B Ressourcenorientierung knüpft an vorhandene Fähigkeiten an und stärkt Eigenaktivität und Selbstwirksamkeit.

265 C Die ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit) betrachtet Körperfunktionen, Aktivität, Teilhabe und Kontextfaktoren - biopsychosozial.

266 C Der Barthel-Index erfasst den Grad der Selbstständigkeit bei Aktivitäten des täglichen Lebens (z. B. Essen, Waschen, Ankleiden, Mobilität) und dient als Verlaufsmaß in der Rehabilitation.

267 A Basale Stimulation (Fröhlich/Bienstein) fördert Wahrnehmung, Bewegung und Kommunikation bei wahrnehmungs- und bewegungsbeeinträchtigten Menschen.

268 C Bei Aphasie (Sprachstörung) helfen ruhiges Tempo, kurze einfache Sätze, Blickkontakt, nonverbale Hilfen (Gestik, Bilder) und Geduld. Bevormunden oder Vorwegnehmen von Sätzen sollte vermieden werden.

269 B Nach einer Amputation gehören tägliche Hautinspektion, sorgfältige Reinigung und fachgerechtes Wickeln (Kompression) zur Ödemreduktion und Formung des Stumpfes zur Vorbereitung der Prothesenversorgung.

270 B Beim Ankleiden wird die betroffene Seite zuerst angezogen, weil sie unbeweglicher ist. Merksatz: „betroffen zuerst an“ – beim Ausziehen umgekehrt die gesunde Seite zuerst.

271 A Aktivierend-therapeutische Pflege integriert therapeutische Konzepte (z.B. Bobath, Kinästhetik) in den pflegerischen Alltag und fördert Reha-Ziele rund um die Uhr.

272 D Kinästhetik unterstützt Menschen dabei, sich mit möglichst wenig Kraftaufwand selbst zu bewegen. Statt zu heben, wird Bewegung angebahnt und begleitet – das schont Patient und Pflegende und fördert die Selbstständigkeit.

273 C Nach dem Grundsatz „Reha vor Pflege“ soll durch rechtzeitige Rehabilitation Pflegebedürftigkeit vermieden, überwunden oder gemindert werden – Reha hat also Vorrang vor reinen Pflegeleistungen.

274 D Interprofessionelle Rehabilitation verbindet u.a. Pflege, Medizin, Physio-, Ergotherapie, Logopädie und Sozialdienst.

275 B Geriatrische Reha will Alltagskompetenz und Selbstständigkeit erhalten bzw. wiederherstellen - Grundsatz 'Reha vor Pflege'.

276 D Für die Rehabilitation nach einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit ist die gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) zuständig und leistet „mit allen geeigneten Mitteln“.

277 D Die AHB schließt sich direkt an eine Akutbehandlung (z.B. OP, Schlaganfall) an, um den Behandlungserfolg zu sichern.

278 C Ergotherapie zielt darauf, die Handlungsfähigkeit und Selbstständigkeit im Alltag wiederherzustellen – z. B. Training von Anziehen, Essen, Feinmotorik sowie Anpassung und Nutzung von Hilfsmitteln.

279 A Der Grundsatz 'Reha vor Pflege' (SGB) bedeutet: Rehabilitationsmaßnahmen sollen Pflegebedürftigkeit vermeiden oder mindern, bevor Pflege greift.

280 A Beim Ausziehen wird die gesunde Seite zuerst befreit, sodass der weniger bewegliche betroffene Arm anschließend leichter aus dem Kleidungsstück geführt werden kann („gesund zuerst aus, betroffen zuerst an“).

Anatomie: Herz & Kreislauf

281 C Der Sympathikus bereitet auf Leistung vor: Herzfrequenz und Blutdruck steigen, Pupillen und Bronchien weiten sich, die Verdauung wird gedrosselt.

282 C In der Diastole erschlaffen die Kammern und füllen sich mit Blut aus den Vorhöfen.

283 C Das Pulsoxymeter misst nichtinvasiv die periphere O_2-Sättigung (SpO_2) und die Pulsfrequenz – z. B. am Finger oder Ohrläppchen.

284 A Bradykardie = Herzfrequenz unter 60/min. Tachykardie = über 100/min.

285 A Das Myokard ist die kräftige Herzmuskelschicht – am dicksten in der linken Kammer.

286 A Die Pulskontrolle gibt Hinweise auf Frequenz, Rhythmus, Füllung und Kreislaufzustand – wichtig zur Früherkennung von Arrhythmien, Schock oder Verschlechterung.

287 B Die Aortenklappe (Taschenklappe) öffnet sich in der Systole, damit Blut in die Aorta ausgeworfen wird.

288 B Die Pfortader (V. portae) sammelt das nährstoffreiche Blut aus dem Darm und leitet es zur Leber, bevor es in den großen Kreislauf gelangt.

289 D HZV = Schlagvolumen × Herzfrequenz. In Ruhe ca. 5 l/min (z. B. 70 ml × 70/min).

290 A Die Aorta ist die größte Arterie – sie entspringt der linken Kammer und versorgt den gesamten Körperkreislauf.

291 D Die rechte Herzhälfte pumpt sauerstoffarmes Blut über die Pulmonalarterie in den Lungenkreislauf zur Sauerstoffaufnahme.

292 A Arterien führen Blut vom Herzen weg, Venen zum Herzen hin. Ausnahme von der O_2-Regel: Die Pulmonalarterie führt sauerstoffarmes Blut.

293 D Systole = Kontraktion der Kammern mit Blutauswurf. Diastole = Erschlaffung und Füllung der Kammern.

294 A Venenklappen verhindern den Rückfluss; zusammen mit der Muskelpumpe fördern sie den venösen Rückstrom zum Herzen entgegen der Schwerkraft.

295 B Rechts liegt die Trikuspidalklappe (3 Segel). Links die Mitral-/Bikuspidalklappe (2 Segel).

296 D Normaler Ruhepuls 60–100/min. Unter 60 = Bradykardie, über 100 = Tachykardie.

297 B Segelklappen (AV-Klappen: Trikuspidal, Mitral) liegen zwischen Vorhof und Kammer; Taschenklappen (Pulmonal, Aorta) an den Kammerausgängen.

298	C	Die Koronararterien versorgen das Myokard. Ein Verschluss führt zur Mangeldurchblutung → Herzinfarkt (Myokardinfarkt).
299	D	Der QRS-Komplex zeigt die Erregungsausbreitung über beide Kammern (Ventrikel).
300	D	Die beiden oberen Höhlen sind die Vorhöfe (Atrien), die unteren die Kammern (Ventrikel).

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

PRÜFUNGSTRAINING · SCHRIFTLICHE PRÜFUNG

Probeklausur Pflegeexamen

8 Fallsituationen und 3 Großfälle mit 68 fallbezogenen Aufgaben – so, wie im Examen gefragt wird: Situation lesen, einschätzen, richtig handeln.

Bestehen ist planbar.

Fallbezogen · Großfälle · Erklärungen · Lösungsschlüssel

68	11	A4
Aufgaben	Fälle	druckfertig

INHALT

1. Teil A: Fallsituationen
2. Teil B: Großfälle
3. Lösungen mit Begründung
4. Auswertung

⚠ Lernhilfe, mit KI-Unterstützung erstellt und fachlich geprüft. Maßgeblich sind Lehrinhalte, Leitlinien und Standards deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

So nutzt du die Probeklausur

Bearbeite die Aufgaben am Stück und ohne Hilfsmittel – wie in der echten Prüfung. Plane etwa zwei Minuten pro Aufgabe ein. Erst danach in den Lösungsteil schauen.

TEIL A

Kurze Fallsituationen aus Krankenhaus, Pflegeheim und ambulanter Pflege – je mehrere Aufgaben zu einem Fall.

TEIL B

Große Fälle, die sich über Aufnahme, Verlauf und Entlassung entwickeln – wie im Examen.

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

A Fallsituationen

Lies jeden Fall genau – die Antworten stecken oft in den Details.

FALL 1 · KRANKENHAUS, INTERNISTISCHE STATION

Herzinsuffizienz, 74-jähriger Mann

Herr K., 74 Jahre, wird mit zunehmender Luftnot und geschwollenen Beinen stationär aufgenommen. Er berichtet, nachts schlecht flach liegen zu können und in den letzten 3 Tagen 2,5 kg zugenommen zu haben. RR 158/94 mmHg, Puls 96/min unregelmäßig, SpO2 90 % bei Raumluft, Atemfrequenz 24/min. Bekannt sind eine chronische Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern.

1 **Welche Beobachtung deutet am deutlichsten auf eine kardiale Dekompensation mit Flüssigkeitseinlagerung hin?** ●●

- A Die Gewichtszunahme von 2,5 kg in 3 Tagen
- B Der unregelmäßige Puls
- C Der erhöhte Blutdruck
- D Das Alter des Patienten

2 **Welche Lagerung entlastet Herrn K. bei akuter Luftnot am wirksamsten?** ●

- A Flache Rückenlage
- B Oberkörperhochlagerung mit hängenden Beinen (Herzbettlagerung)
- C Stabile Seitenlage
- D Kopftieflagerung

3 **Herr K. soll bilanziert werden. Was gehört zwingend zur korrekten Flüssigkeitsbilanzierung?** ●●

- A Nur die Trinkmenge dokumentieren
- B Nur die Urinausscheidung messen
- C Ein- und Ausfuhr vollständig erfassen und gegenüberstellen
- D Einmal täglich den Blutdruck messen

4 **Welche Kombination von Vitalwerten sollte umgehend an den Arzt gemeldet werden?** ●●

- A RR 120/80, Puls 72, SpO2 98 %, AF 14
- B RR 130/85, Puls 80, SpO2 96 %, AF 16
- C RR 125/78, Puls 68, SpO2 97 %, AF 15
- D RR 158/94, Puls 96, SpO2 90 %, AF 24

FALL 2 · KRANKENHAUS, CHIRURGISCHE STATION

Erster postoperativer Tag nach Hüft-TEP, 68-jährige Frau

Frau M., 68 Jahre, ist am Vortag mit einer Hüft-Totalendoprothese versorgt worden. Am ersten postoperativen Tag klagt sie über Schmerzen (NRS 6/10) und möchte lieber im Bett bleiben. Der Verband ist trocken, die Wunddrainage fördert mäßig blutig. RR 110/70, Puls 88, Temperatur 37,8 Grad.

5 **Warum ist die Frühmobilisation trotz der Schmerzen wichtig?**

- A Sie senkt das Risiko für Thrombose, Pneumonie und Dekubitus
- B Sie beschleunigt die Wundheilung direkt
- C Sie ist nur aus Kostengründen vorgeschrieben
- D Sie ersetzt die Schmerztherapie

6 **Was ist vor der geplanten Mobilisation pflegerisch am wichtigsten?**

- A Die Patientin überreden, es einfach zu versuchen
- B Eine bedarfsgerechte Schmerzmedikation nach Anordnung rechtzeitig verabreichen
- C Die Drainage sofort ziehen
- D Die Mobilisation auf den nächsten Tag verschieben

7 **Bei welchem Zeichen besteht der Verdacht auf eine tiefe Beinvenenthrombose?**

- A Beidseitig warme Füße
- B Trockener Wundverband
- C Einseitige Schwellung, Überwärmung und Schmerz der Wade
- D Temperatur von 37,8 Grad

8 **Die Wunddrainage fördert plötzlich stark hellrot und die Patientin wird blass und tachykard. Wie handelst du?**

- A Abwarten und in einer Stunde erneut kontrollieren
- B Die Drainage abklemmen und nichts dokumentieren
- C Der Patientin etwas zu trinken geben
- D Vitalzeichen kontrollieren und umgehend den Arzt informieren

FALL 3 · STATIONÄRE LANGZEITPFLEGE

Verwirrtheit bei 85-jähriger Bewohnerin

Frau S., 85 Jahre, lebt seit zwei Jahren im Pflegeheim und ist normalerweise orientiert und freundlich. Seit gestern ist sie zunehmend verwirrt, zeitlich und örtlich desorientiert, unruhig und sieht Dinge, die nicht da sind. Sie hat seit zwei Tagen wenig getrunken und klagt beim Wasserlassen über Brennen.

9 **Welche Ursache der plötzlichen Verwirrtheit ist bei diesem Verlauf am wahrscheinlichsten?**

- A Ein akutes Delir, möglicherweise durch Harnwegsinfekt und Exsikkose
- B Eine beginnende Demenz
- C Normale Alterserscheinung
- D Eine psychische Erkrankung, die schon lange besteht

10 **Was ist die wichtigste pflegerische Sofortmaßnahme?**

- A Die Bewohnerin fixieren, damit sie sich nicht verletzt
- B Reizarme, sichere Umgebung schaffen, Flüssigkeit anbieten und den Arzt informieren
- C Sie allein lassen, bis sie sich beruhigt
- D Ihr ein Schlafmittel geben

11 **Welche Maßnahme beugt einem erneuten Delir am besten vor?**

- A Möglichst viel Bettruhe
- B Die Bewohnerin täglich testen
- C Ausreichende Flüssigkeitszufuhr, Tag-Nacht-Rhythmus, Brille und Hörgerät, Reorientierung
- D Besuche der Angehörigen verbieten

12 **Warum ist die reduzierte Trinkmenge bei alten Menschen besonders kritisch?**

- A Alte Menschen brauchen kaum Flüssigkeit
- B Trinken spielt im Alter keine Rolle
- C Nur die Nahrungsmenge ist wichtig
- D Das Durstempfinden ist im Alter vermindert, wodurch ein Flüssigkeitsmangel leicht übersehen wird

FALL 4 · KRANKENHAUS, KINDERSTATION

Fieberkrampf-Sorge bei 3-jährigem Kind

Der 3-jährige Tim wird mit hohem Fieber (39,6 Grad) und einem Infekt der oberen Atemwege aufgenommen. Die Mutter ist sehr beunruhigt, weil Tim vor einer Stunde kurz 'komisch gezuckt' habe und danach schläfrig gewesen sei. Tim ist jetzt wach, trinkt aber wenig.

13 **Wie begegnest du der beunruhigten Mutter am besten?**

- A Ruhig zuhören, die Sorge ernst nehmen und über das weitere Vorgehen informieren
- B Ihr sagen, sie solle sich nicht so anstellen
- C Das Thema wechseln
- D Sie aus dem Zimmer schicken

14 **Welche Maßnahme ist bei hohem Fieber pflegerisch sinnvoll?**

- A Das Kind warm einpacken
- B Ausreichend Flüssigkeit anbieten und nach Anordnung fiebersenkende Maßnahmen durchführen
- C Kaltes Wasser über das Kind gießen
- D Nichts tun und abwarten

15 **Was ist bei der Beobachtung eines fieberhaften Kleinkindes besonders zu beachten?**

- A Nur die Körpertemperatur
- B Ausschließlich das Gewicht
- C Bewusstseinslage, Trinkverhalten, Hautkolorit und Atmung im Verlauf
- D Nur die Herzfrequenz

16 **Warum trinkt Tim zu wenig - und warum ist das ein Problem?**

- A Kinder brauchen wenig Flüssigkeit; das ist unkritisch
- B Trinken ist bei Kindern nebensächlich
- C Nur feste Nahrung zählt
- D Fieber und Infekt erhöhen den Bedarf, während krankheitsbedingt weniger getrunken wird - Dehydratationsgefahr

FALL 5 · PSYCHIATRISCHE KLINIK

Antriebslosigkeit bei 22-jährigem Patienten mit Depression

Herr L., 22 Jahre, ist wegen einer schweren depressiven Episode aufgenommen. Er bleibt fast den ganzen Tag im Bett, spricht wenig, vernachlässigt die Körperpflege und äußert, dass 'alles sinnlos' sei. Beim Morgengespräch sagt er leise, er wisse nicht, ob er 'das alles noch durchhalten' könne.

17 **Wie reagierst du auf die Äußerung, er wisse nicht, ob er 'das durchhalten' könne?** ●●●

- A Ihn direkt, ruhig und wertschätzend auf mögliche Suizidgedanken ansprechen
- B Die Aussage ignorieren, um ihn nicht zu beunruhigen
- C Ihm sagen, er solle positiv denken
- D Das Thema wechseln

18 **Wie förderst du die Körperpflege bei ausgeprägter Antriebslosigkeit am besten?** ●●

- A Die Pflege komplett für ihn übernehmen
- B Kleinschrittig anleiten, Aktivitäten anbieten und erreichbare Ziele setzen
- C Ihn zur Pflege zwingen
- D Die Körperpflege ganz weglassen

19 **Welche Haltung ist im Umgang mit depressiven Menschen grundlegend?** ●●

- A Aufmunternde Sprüche wie 'Kopf hoch, wird schon'
- B Distanz halten, um nicht zu belasten
- C Empathisches, geduldiges Dasein ohne Bagatellisieren der Beschwerden
- D Leistung einfordern

20 **Warum ist gerade die Phase beginnender Besserung bei Depression besonders zu beobachten?** ●●●

- A Weil dann keine Gefahr mehr besteht
- B Weil die Behandlung dann endet
- C Weil Beobachtung dann überflüssig wird
- D Weil mit wiederkehrendem Antrieb das Suizidrisiko vorübergehend steigen kann

FALL 6 · KRANKENHAUS, AKUTSITUATION

Akute Verschlechterung, ABCDE-Einschätzung

Du betrittst das Zimmer und findest Frau B., 59 Jahre, deutlich verschlechtert vor: Sie ist nur noch schwer erweckbar, atmet schnell und flach, die Lippen wirken bläulich. Du bist allein im Zimmer.

21 **Was ist dein allererster Schritt?** ●●

- A Ansprechbarkeit prüfen und Hilfe rufen / Notruf absetzen
- B Die Blutdruckmanschette anlegen
- C Erst die Kurve lesen
- D Die Angehörigen anrufen

22 **Nach welchem Schema schätzt du die Situation strukturiert ein?**

- A Von Kopf bis Fuß ohne Reihenfolge
- B ABCDE: Atemweg, Atmung, Kreislauf, neurologischer Status, Umgebung
- C Zuerst die Haut, dann alles Weitere
- D Nur die Sauerstoffsättigung

23 **Die bläulichen Lippen deuten worauf hin?**

- A Auf Fieber
- B Auf Kälte im Zimmer allein
- C Auf eine Zyanose als Zeichen von Sauerstoffmangel
- D Auf eine harmlose Verfärbung

24 **Welche Information ist bei der Übergabe an das eintreffende Team am wichtigsten?**

- A Das Lieblingsessen der Patientin
- B Nur der Name
- C Die Zimmernummer allein
- D Strukturierte Übergabe: Situation, Vitalzeichen, Bewusstsein, bisherige Maßnahmen

FALL 7 · PALLIATIVVERSORGUNG / HOSPIZ

Belastende Atemnot bei palliativer Patientin, 71 Jahre

Frau W., 71 Jahre, befindet sich in der letzten Lebensphase bei fortgeschrittener Tumorerkrankung. Sie leidet unter belastender Atemnot und Angst. Die Angehörigen sind anwesend und wirken hilflos und überfordert.

25 **Was steht in der palliativen Pflege bei belastender Atemnot im Vordergrund?**

- A Linderung der Symptome und des Leidens (Symptomkontrolle, Comfort)
- B Die vollständige Heilung anzustreben
- C Möglichst viele diagnostische Maßnahmen
- D Die Patientin zur Mobilisation drängen

26 **Welche pflegerische Maßnahme kann die Atemnot unmittelbar lindern?**

- A Flachlagerung
- B Oberkörperhochlagerung, ruhige Präsenz, frische Luft / kühler Luftzug
- C Das Fenster schließen und allein lassen
- D Zur Eile drängen

27 **Wie beziehst du die überforderten Angehörigen ein?**

- A Sie aus dem Zimmer bitten
- B Ihnen sagen, sie sollen sich zusammenreißen
- C Sie behutsam informieren, einfache Aufgaben anbieten und ihre Gefühle zulassen
- D Sie ignorieren

28 **Welche Haltung ist in der Sterbebegleitung zentral?**

- A Sachliche Distanz ohne Nähe
- B Die Patientin möglichst wenig stören, also gar nicht ins Zimmer gehen
- C Ausschließlich körperliche Pflege
- D Würde wahren, zuhören, da sein und individuelle Wünsche respektieren

FALL 8 · AMBULANTE PFLEGE, HÄUSLICHES UMFELD

Diabetisches Fußulkus bei 66-jährigem Mann zu Hause

Herr D., 66 Jahre, mit langjährigem Diabetes mellitus Typ 2, wird ambulant versorgt. Beim Hausbesuch entdeckst du an seinem rechten Fuß eine gerötete, druckempfindliche Stelle mit beginnender offener Wunde. Herr D. sagt, er habe davon nichts gespürt. Er lebt allein und kocht selten frisch.

29 **Warum hat Herr D. die Wunde nicht gespürt?**

- A Eine diabetische Polyneuropathie kann das Schmerz- und Druckempfinden herabsetzen
- B Er stellt sich unempfindlich
- C Die Wunde tut grundsätzlich nicht weh
- D Er hat zu dicke Socken getragen

30 **Was ist bei der Wundstelle pflegerisch vorrangig?**

- A Die Stelle fest verbinden und abwarten
- B Druckentlastung, fachgerechte Wundversorgung und ärztliche Abklärung veranlassen
- C Ein Hausmittel auftragen
- D Die Wunde offen lassen und nichts weiter tun

31 **Welche Beratung ist für Herrn D. zur Vorbeugung am wichtigsten?**

- (A) Barfuß laufen zur Abhärtung
- (B) Die Füße möglichst wenig anschauen
- (C) Tägliche Fußinspektion, gut passendes Schuhwerk und regelmäßige Fußpflege
- (D) Enge Schuhe tragen

32 **Herr D. lebt allein und kocht selten frisch. Welcher weitere Aspekt ist relevant?**

- (A) Das ist ohne Bedeutung
- (B) Nur die Wunde zählt
- (C) Er sollte einfach mehr essen
- (D) Ernährungssituation und Blutzuckereinstellung beeinflussen Wundheilung und Verlauf - ggf. weitere Unterstützung organisieren

B1 Großfall

KRANKENHAUS, INTERNISTISCHE STATION

Herr Berger, 78 Jahre - dekompensierte Herzinsuffizienz

Herr Berger, 78 Jahre, wird vom Hausarzt mit zunehmender Luftnot und geschwollenen Beinen eingewiesen. Er lebt allein, seine Frau ist vor einem Jahr verstorben. Bekannt sind eine chronische Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern und ein leichter Diabetes mellitus Typ 2. Bei Aufnahme: RR 165/95 mmHg, Puls 98/min unregelmäßig, SpO2 89 % bei Raumluft, Atemfrequenz 26/min, Temperatur 36,8 Grad. Er kann nur mit erhöhtem Oberkörper atmen.

AUFNAHME

33 **Welches Aufnahmezeichen weist am deutlichsten auf eine akute kardiale Dekompensation mit Sauerstoffmangel hin?**

- A Die SpO2 von 89 % mit erhöhter Atemfrequenz
- B Die Temperatur von 36,8 Grad
- C Der unregelmäßige Puls
- D Das Alter von 78 Jahren

34 **Wie lagerst du Herrn Berger bei der Aufnahme, um seine Atmung zu erleichtern?**

- A Eine flache Rückenlage ganz ohne Erhöhung des Oberkörpers
- B Herzbettlagerung: Oberkörper hoch, Beine tief
- C Die stabile Seitenlage wie bei bewusstlosen Patienten
- D Eine durchgehende Bauchlage zur Entlastung des Rückens

ASSESSMENT

35 **Der Arzt ordnet eine Flüssigkeitsbilanzierung an. Was erfasst du dafür vollständig?**

- A Nur die Trinkmenge
- B Nur die Urinausscheidung
- C Gesamte Ein- und Ausfuhr im Vergleich
- D Nur das Körpergewicht

36 **Warum ist bei Herrn Berger das tägliche Wiegen besonders aussagekräftig?**

- A Weil er im Rahmen der Behandlung gezielt abnehmen soll
- B Weil das Körpergewicht die genaue Medikamentendosis bestimmt
- C Weil sich daran die Einstellung seines Diabetes ablesen lässt
- D Weil eine rasche Gewichtszunahme Flüssigkeitseinlagerung anzeigt

MASSNAHMEN

37 **Herr Berger erhält nach Anordnung ein Diuretikum. Welche Beobachtung ist jetzt besonders wichtig?** ●●●

- A Urinausscheidung, Elektrolyte und Kreislauf
- B Ausschließlich die Farbe und das Aussehen der Haut
- C Ausschließlich die gemessene Körpertemperatur
- D Ausschließlich das täglich erfasste Körpergewicht

38 **Herr Berger möchte trotz Luftnot nachts allein zur Toilette. Wie handelst du sicher?** ●●

- A Ihm das nächtliche Aufstehen zur Toilette streng verbieten
- B Sturzrisiko einschätzen, Hilfe anbieten, Rufanlage in Reichweite legen
- C Ihn ganz ohne weitere Sicherungsmaßnahmen gewähren lassen
- D Ein hochgestelltes Bettgitter allein als ausreichende Maßnahme ansehen

VERSCHLECHTERUNG

39 **In der zweiten Nacht wird Herr Berger plötzlich stark kurzatmig, hustet schaumig-rosa Sekret und hat Todesangst. Was vermutest du?** ●●●

- A Eine Erkältung
- B Normale nächtliche Unruhe
- C Ein akutes Lungenödem
- D Eine Magenverstimmung

40 **Was ist deine erste Maßnahme bei Verdacht auf ein akutes Lungenödem?** ●●●

- A Flach hinlegen und abwarten
- B Ihm etwas zu trinken geben
- C Ihn allein lassen und später kontrollieren
- D Oberkörper hoch, Beine tief, Hilfe rufen und beruhigen

41 **Welche Vitalzeichen-Kombination bestätigt die kritische Verschlechterung am deutlichsten?** ●●

- A SpO2 82 %, AF 34, Puls 118, RR 180/100
- B RR 130/80, Puls 76, SpO2 97 %, AF 15
- C RR 120/75, Puls 70, SpO2 98 %, AF 14
- D SpO2 95 %, AF 18, Puls 82, RR 135/85

STABILISIERUNG

42 **Nach ärztlicher Behandlung stabilisiert sich Herr Berger. Was gehört jetzt zur pflegerischen Überwachung?**

- A Keine weitere Beobachtung nötig
- B Engmaschige Vitalzeichen, Atmung, Bilanz und Bewusstsein
- C Nur einmal täglich Blutdruck
- D Nur das Gewicht am Entlassungstag

ENTLASSUNG

43 **Zur Entlassung berätst du Herrn Berger. Welcher Hinweis ist zur Vermeidung einer erneuten Dekompensation zentral?**

- A Sich möglichst wenig bewegen und körperliche Schonung einhalten
- B Reichlich salzhaltige Speisen zur Kreislaufanregung essen
- C Täglich wiegen und bei rascher Zunahme den Arzt kontaktieren
- D Die verordneten Medikamente bei einsetzender Besserung absetzen

44 **Herr Berger lebt allein und wirkt seit dem Tod seiner Frau niedergeschlagen. Was ist pflegerisch angemessen?**

- A Das ist seine Privatsache und für die Pflege nicht von Bedeutung
- B Ihn dazu auffordern, sich zusammenzureißen und nach vorn zu blicken
- C Ausschließlich die körperlichen Aspekte seiner Erkrankung beachten
- D Die psychosoziale Situation ernst nehmen und Unterstützung (z. B. ambulante Hilfen, Gespräch) anbieten

B2 Großfall

KRANKENHAUS, CHIRURGISCHE STATION NACH OP

Frau Cakir, 24 Jahre - nach Verkehrsunfall und Bein-OP

Frau Cakir, 24 Jahre, wurde nach einem Fahrradunfall mit einem offenen Unterschenkelbruch operiert (Osteosynthese). Sie kommt am OP-Tag auf die Station. Sie hat starke Schmerzen (NRS 7/10), ist blass und ängstlich. Der Wundverband am rechten Unterschenkel ist trocken, eine Redon-Drainage fördert mäßig blutig. RR 105/65, Puls 92, Temperatur 37,2 Grad. Sie fragt immer wieder, ob ihr Bein 'wieder normal' werde.

AUFNAHME

45 **Frau Cakir hat NRS 7/10. Was ist deine vorrangige Maßnahme?**

- A Schmerzmedikation nach Anordnung zeitnah verabreichen und Wirkung kontrollieren
- B Sie freundlich bitten, die Schmerzen noch eine Weile auszuhalten
- C Erst am Abend im Rahmen der Routineversorgung darauf reagieren
- D Sie ausschließlich durch Gespräche vom Schmerz ablenken

46 **Frau Cakir ist blass und tachykard. Welche Ursache musst du postoperativ zuerst ausschließen?**

- A Ein einfaches Hungergefühl aufgrund der längeren Nüchternheit
- B Eine Nachblutung / beginnender Volumenmangel
- C Eine harmlose Langeweile nach dem langen Liegen im Bett
- D Eine zu warm eingestellte Bettdecke mit leichtem Wärmestau

ASSESSMENT

47 **Wie kontrollierst du die Durchblutung, Motorik und Sensibilität (DMS) am operierten Bein?**

- A Gar nicht, da diese Kontrolle ausschließlich der Arzt durchführt
- B Ausschließlich den angelegten Verband von außen ansehen
- C Hautfarbe/Temperatur, Zehenbeweglichkeit und Gefühl regelmäßig prüfen und vergleichen
- D Nur ein einziges Mal am Tag der geplanten Entlassung

48 **Welches Zeichen am operierten Unterschenkel würde dich an ein Kompartmentsyndrom denken lassen?**

- A Ein leichtes Ziehen, das auf die übliche Schmerzmedikation gut anspricht
- B Ein durchgehend trockener und sauber sitzender Wundverband
- C Eine gemessene Körpertemperatur von rund 37,2 Grad
- D Zunehmender, kaum beeinflussbarer Schmerz, praller Unterschenkel, Gefühlsstörung

MASSNAHMEN

49 **Welche Prophylaxen sind bei Frau Cakir postoperativ besonders wichtig?** ●●

- A Thrombose-, Pneumonie- und Dekubitusprophylaxe
- B Ausschließlich die Vorbeugung von Druckgeschwüren (Dekubitus)
- C Gar keine Prophylaxen, da sie noch jung und belastbar ist
- D Ausschließlich die Vorbeugung von Stürzen bei Mobilisation

50 **Bei der ersten Mobilisation wird Frau Cakir schwindelig und blass. Wie reagierst du?** ●●

- A Sie trotz der Beschwerden zum Weitergehen und Durchhalten drängen
- B Mobilisation stoppen, sicher hinsetzen/lagern, Vitalzeichen und Kreislauf kontrollieren
- C Sie zur weiteren Kreislaufanregung kurz allein stehen lassen
- D Zunächst nur das Fenster öffnen und die Entwicklung abwarten

VERSCHLECHTERUNG

51 **Am dritten Tag klagt Frau Cakir über plötzliche Atemnot und stechenden Brustschmerz beim Einatmen. Woran musst du denken?** ●●●

- A Muskelkater
- B Sodbrennen
- C Eine Lungenembolie
- D Aufregung wegen Besuch

52 **Wie verhältst du dich bis zum Eintreffen des Arztes bei Verdacht auf Lungenembolie?** ●●●

- A Die Patientin flach hinlegen und zur Beobachtung allein lassen
- B Sie zur Förderung des Kreislaufs zur Mobilisation auffordern
- C Ihr zur Stärkung zunächst etwas zu essen anbieten
- D Oberkörper hoch, beruhigen, Vitalzeichen/SpO2 überwachen, Sauerstoff nach Anordnung

STABILISIERUNG

53 **Frau Cakir äußert nach dem Zwischenfall große Angst, erneut etwas 'Schlimmes' zu bekommen. Wie begegnest du ihr?** ●●

- A Angst ernst nehmen, altersgerecht informieren und Sicherheit durch Präsenz und Aufklärung geben
- B Ihre geäußerte Angst als deutlich übertrieben abtun
- C Das belastende Thema meiden und bewusst nicht ansprechen
- D Ihr sagen, sie solle einfach nicht so viel darüber nachdenken

REHABILITATION

54 **Frau Cakir sorgt sich um die Zukunft ihres Beins. Welche Haltung ist angemessen?**

- A Ihr eine vollständige Heilung garantieren
- B Ehrlich, aber zuversichtlich informieren und auf das Reha-Team verweisen
- C Sagen, das wisse niemand, und das Thema beenden
- D Ihr raten, sich keine Hoffnung zu machen

55 **Welche Beobachtung an der OP-Wunde würde auf eine Wundinfektion hindeuten?**

- A Ein durchgehend trockener und reizloser Wundverband
- B Ein leichter Juckreiz, der erst nach einigen Tagen auftritt
- C Zunehmende Rötung, Überwärmung, Schwellung, Schmerz und ggf. Fieber
- D Eine blasse, unauffällige Narbe nach mehreren Wochen

ENTLASSUNG

56 **Zur Entlassung: Welcher Hinweis zur Thromboseprophylaxe zu Hause ist wichtig?**

- A Strikte Bettruhe halten, bis die Wunde vollständig verheilt ist
- B Die verordnete Prophylaxe sofort nach der Entlassung beenden
- C Möglichst viel mit hängenden Beinen sitzen und sich schonen
- D In Bewegung bleiben, verordnete Prophylaxe (z. B. Spritzen/Strümpfe) korrekt fortführen

B3 Großfall

AMBULANTE PSYCHIATRISCHE PFLEGE

Herr Novak, 55 Jahre - Depression nach Jobverlust

Herr Novak, 55 Jahre, wird nach einem Klinikaufenthalt wegen einer schweren depressiven Episode ambulant weiterbetreut. Er hat vor einem Jahr seinen Arbeitsplatz verloren, lebt getrennt und hat wenig sozialen Kontakt. Beim ersten Hausbesuch wirkt die Wohnung ungepflegt, er ist unrasiert, spricht leise und verlangsamt. Er sagt, er nehme seine Medikamente 'meistens', und Essen sei ihm 'egal'.

ERSTKONTAKT

57 **Welche Grundhaltung ist beim Erstkontakt mit Herrn Novak am wichtigsten?** ●

- A Empathisch, geduldig und wertschätzend eine Beziehung aufbauen
- B Ihn mit Aufgaben unter Druck setzen
- C Ihm sagen, er solle sich zusammenreißen
- D Distanziert nur die Fakten abfragen

58 **Herr Novak sagt, Essen sei ihm 'egal'. Warum ist das pflegerisch bedeutsam?** ●●

- A Es ist unwichtig, solange er seine Medikamente zuverlässig einnimmt
- B Appetitverlust und Vernachlässigung können Krankheitszeichen sein und die Gesundheit gefährden
- C Ausschließlich sein aktuelles Körpergewicht ist dabei entscheidend
- D Das betrifft allein den behandelnden Arzt und nicht die Pflege

ASSESSMENT

59 **Er berichtet, die Medikamente nur 'meistens' zu nehmen. Wie gehst du damit um?** ●●

- A Ihn wegen der unregelmäßigen Einnahme beschuldigen und ermahnen
- B Ihm die Medikamente ohne sein Wissen heimlich ins Essen geben
- C Nicht-wertend nach Gründen fragen und über die Bedeutung der regelmäßigen Einnahme informieren
- D Die unregelmäßige Einnahme übergehen und nicht ansprechen

60 **Welche Aussage von Herrn Novak erfordert deine höchste Aufmerksamkeit?** ●●●

- A Die Aussage, dass er in letzter Zeit sehr schlecht schlafe
- B Die Aussage, dass er kaum noch Appetit auf Essen habe
- C Die Aussage, dass er sich tagsüber oft müde und erschöpft fühle
- D 'Manchmal denke ich, es wäre besser, nicht mehr da zu sein.'

KRISE

61 **Du sprichst ihn direkt auf Suizidgedanken an. Warum ist dieses offene Nachfragen richtig?** ●●●

A Offenes Ansprechen erhöht das Risiko nicht, sondern entlastet und ermöglicht Hilfe

B Das offene Ansprechen bringt ihn erst auf entsprechende Gedanken

C Ein solches Thema sollte man im Gespräch besser ganz vermeiden

D Über Suizidgedanken darf ausschließlich der Arzt sprechen

62 **Herr Novak bestätigt Suizidgedanken, verneint aber einen konkreten Plan. Was ist jetzt richtig?** ●●●

A Den Hausbesuch wie geplant in Ruhe und ohne weitere Schritte zu Ende bringen

B Situation ernst nehmen, nicht allein lassen bzw. Sicherheit organisieren und umgehend ärztliche/therapeutische Hilfe einbeziehen

C Ihm ein Beruhigungsmittel aus der eigenen Hausapotheke zur Entspannung anbieten

D Das belastende Thema erst beim nächsten vereinbarten Hausbesuch wieder aufgreifen

STABILISIERUNG

63 **In den folgenden Wochen bessert sich Herr Novaks Antrieb, die Stimmung bleibt aber gedrückt. Warum ist gerade jetzt Aufmerksamkeit wichtig?** ●●●

A Weil mit der Besserung nun keinerlei Gefahr mehr besteht

B Weil die pflegerische Betreuung an dieser Stelle regulär endet

C Weil mit zurückkehrendem Antrieb das Suizidrisiko vorübergehend steigen kann

D Weil eine weitere Beobachtung jetzt überflüssig geworden ist

FÖRDERUNG

64 **Wie förderst du Herrn Novaks Selbstversorgung (Körperpflege, Haushalt) am besten?** ●●

A Ihm sämtliche anfallenden Aufgaben vollständig abnehmen

B Ihn nachdrücklich zu allen Tätigkeiten gleichzeitig drängen

C Es ihm ganz allein überlassen, ohne jede Unterstützung

D Kleinschrittig aktivieren, erreichbare Ziele setzen und Erfolge anerkennen

65 **Welche Maßnahme wirkt der sozialen Isolation von Herrn Novak entgegen?** ●●

A Gemeinsam Kontakt- und Tagesstrukturangebote (z. B. Tagesstätte, Gruppen) erarbeiten

B Ihm raten, sich zum Schutz besser weiter zurückzuziehen

C Besuche bei ihm grundsätzlich und möglichst ganz vermeiden

D Ihn ohne Rücksicht zu sozialen Kontakten drängen und zwingen

VERLAUF

66 **Herr Novak fragt, ob er die Medikamente absetzen könne, da es ihm besser gehe. Wie antwortest du?**

- A 'Ja, wenn Sie sich deutlich besser fühlen, können Sie damit aufhören.'
- B 'Das entscheidet der Arzt - Antidepressiva werden nicht eigenmächtig abgesetzt, auch bei Besserung.'
- C 'Nehmen Sie ab jetzt einfach nur noch die halbe Dosis ein.'
- D 'Ob Sie die Medikamente nehmen, ist letztlich Ihre eigene Sache.'

ANGEHÖRIGE

67 **Herrn Novaks erwachsene Tochter meldet sich und möchte helfen, weiß aber nicht wie. Was ist sinnvoll?**

- A Ihr mitteilen, sie solle sich aus der Behandlung heraushalten
- B Ihr auch ohne seine Zustimmung alle Einzelheiten weitergeben
- C Sie - mit Einverständnis von Herrn Novak - einbeziehen und über unterstützenden Umgang informieren
- D Ihr Angebot übergehen und die Tochter nicht weiter einbeziehen

VERLAUF

68 **Woran erkennst du insgesamt, dass die ambulante psychiatrische Pflege bei Herrn Novak wirkt?**

- A Dass er im weiteren Verlauf eher zufällig wieder etwas an Körpergewicht zunimmt
- B Dass er in den Gesprächen insgesamt deutlich weniger mit dir spricht als anfangs
- C Dass seine Wohnung unverändert im gleichen ungepflegten Zustand bleibt
- D Bessere Selbstversorgung, stabilere Einnahmetreue, mehr Kontakte und Tagesstruktur, keine akute Suizidalität

Lösungen & Begründungen

Richtige Antwort und warum – auch die Begründung, warum die anderen Antworten nicht passen.

Fall 1: Herzinsuffizienz, 74-jähriger Mann

1 **A** Eine rasche Gewichtszunahme ist das sensibelste Zeichen einer Flüssigkeitsretention bei Herzinsuffizienz. Tägliches Wiegen unter gleichen Bedingungen gehört deshalb zur Standardüberwachung. Der unregelmäßige Puls passt zum bekannten Vorhofflimmern, erklärt aber nicht die akute Verschlechterung.

2 **B** Die Herzbettlagerung (Oberkörper hoch, Beine tief) verringert den venösen Rückstrom zum Herzen und senkt die Vorlast, was die Atemarbeit erleichtert. Flaches Liegen verstärkt die Luftnot bei Herzinsuffizienz typischerweise.

3 **C** Eine Flüssigkeitsbilanz erfordert die vollständige Erfassung von Einfuhr (Trinken, Infusionen, Sondenkost) und Ausfuhr (Urin, Drainagen, Erbrechen) und deren Gegenüberstellung. Nur so lässt sich eine positive oder negative Bilanz erkennen.

4 **D** Die erste Kombination zeigt eine Sauerstoffsättigung von nur 90 % bei gleichzeitig erhöhter Atemfrequenz und Herzfrequenz - Zeichen einer respiratorischen Belastung bei Dekompensation. Das erfordert ärztliche Rücksprache und ggf. Sauerstoffgabe nach Anordnung.

Fall 2: Erster postoperativer Tag nach Hüft-TEP, 68-jährige Frau

5 **A** Frühmobilisation ist eine zentrale Prophylaxe: Bewegung aktiviert die Muskelpumpe (Thromboseprophylaxe), verbessert die Belüftung der Lunge (Pneumonieprophylaxe) und entlastet gefährdete Hautstellen (Dekubitusprophylaxe). Voraussetzung ist eine ausreichende Schmerztherapie.

6 **B** Schmerz ist das Haupthindernis der Mobilisation. Eine rechtzeitig - also mit Wirkeintritt vor der Mobilisation - verabreichte Schmerzmedikation nach ärztlicher Anordnung ermöglicht ein schmerzarmes Aufstehen und fördert die Kooperation.

7 **C** Eine einseitige Wadenschwellung mit Überwärmung, Spannungsgefühl und Schmerz ist ein Warnzeichen für eine tiefe Beinvenenthrombose und muss ärztlich abgeklärt werden. Die leicht erhöhte Temperatur allein ist postoperativ zunächst unspezifisch.

8 **D** Eine plötzlich starke hellrote Förderung mit Blässe und Tachykardie kann auf eine Nachblutung mit beginnendem Volumenmangel hindeuten. Vitalzeichen erheben und sofortige ärztliche Information sind zwingend - das ist eine potenziell kritische Situation.

Fall 3: Verwirrtheit bei 85-jähriger Bewohnerin

9 **A** Ein plötzlicher Beginn (Stunden bis Tage), fluktuierender Verlauf, Desorientierung und optische Halluzinationen sprechen für ein Delir - im Gegensatz zur schleichend beginnenden Demenz. Häufige Auslöser bei alten Menschen sind Infekte (hier Harnwegsinfekt) und Flüssigkeitsmangel.

10 **B** Beim Delir gilt: Auslöser behandeln lassen (Arzt informieren), Sicherheit und Reorientierung geben, ausreichend Flüssigkeit anbieten. Fixierung und pauschale Sedierung können ein Delir verschlimmern und sind nur letztes Mittel unter strengen Voraussetzungen.

11 **C** Delirprophylaxe bedeutet, die häufigen Auslöser zu vermeiden: genug trinken, Orientierung fördern (Uhr, Kalender, Tageslicht), Seh- und Hörhilfen bereitstellen und vertraute Bezugspersonen einbeziehen. Immobilität und Isolation erhöhen das Risiko.

12 **D** Im Alter nimmt das Durstempfinden physiologisch ab. Ältere Menschen trinken dadurch oft zu wenig, ohne Durst zu verspüren - eine Exsikkose entsteht schleichend und kann Delir, Sturz und Nierenschäden begünstigen. Aktives Anbieten von Getränken ist deshalb zentral.

Fall 4: Fieberkrampf-Sorge bei 3-jährigem Kind

13 **A** Angehörige - besonders Eltern - brauchen Ernstnahme und Information. Aktives Zuhören, Anerkennen der Sorge und transparente Aufklärung über die nächsten Schritte reduzieren Angst und stärken das Vertrauen. Bagatellisieren ist immer falsch.

14 **B** Bei Fieber steigt der Flüssigkeitsbedarf - regelmäßiges Anbieten kleiner Trinkmengen ist wichtig. Fiebersenkende Maßnahmen (Medikamente, ggf. Wadenwickel) erfolgen nach ärztlicher Anordnung. Warmes Einpacken staut die Wärme, abruptes Abkühlen ist schädlich.

15 **C** Bei Kleinkindern verschlechtert sich der Zustand schnell. Neben der Temperatur sind Bewusstsein, Trinkmenge (Dehydratationsgefahr), Hautfarbe und Atemmuster entscheidend, um eine Verschlechterung frühzeitig zu erkennen.

16 **D** Kinder haben im Verhältnis zum Körpergewicht einen hohen Flüssigkeitsbedarf und dehydrieren schneller als Erwachsene. Fieber steigert den Bedarf zusätzlich. Trinkt das Kind gleichzeitig weniger, droht rasch eine Exsikkose - engmaschige Beobachtung und aktives Anbieten sind nötig.

Fall 5: Antriebslosigkeit bei 22-jährigem Patienten mit Depression

17 **A** Anzeichen möglicher Suizidalität müssen direkt und offen angesprochen werden - das offene Fragen erhöht das Risiko nicht, sondern entlastet und ermöglicht Hilfe. Wichtig sind eine ruhige, wertschätzende Haltung und die umgehende Information des Behandlungsteams.

18 **B** Bei depressionsbedingter Antriebsstörung hilft aktivierende Pflege: kleinschrittige Anleitung, konkrete, erreichbare Ziele und Ermutigung ohne Überforderung. Komplette Übernahme fördert Passivität, Zwang schädigt die Beziehung.

19 **C** Depressive Menschen erleben gut gemeinte Aufmunterung oft als Druck und Unverstandensein. Hilfreich sind Empathie, Geduld, verlässliche Präsenz und das Ernstnehmen der Beschwerden - ohne sie kleinzureden.

20 **D** In der Phase beginnender Besserung kann der Antrieb zurückkehren, bevor sich die Stimmung stabilisiert - dadurch kann das Risiko, Suizidgedanken in die Tat umzusetzen, vorübergehend steigen. Diese Phase erfordert besondere Aufmerksamkeit.

Fall 6: Akute Verschlechterung, ABCDE-Einschätzung

21 **A** Bei einer akut kritischen Situation gilt: Bewusstsein prüfen und sofort Hilfe holen, damit weitere Kräfte und Material kommen. Alleiniges Handeln ohne Hilferuf verzögert die Versorgung. Erst danach folgt die strukturierte Einschätzung.

22 **B** Das ABCDE-Schema priorisiert nach Lebensbedrohlichkeit: A (Airway/Atemweg), B (Breathing/Atmung), C (Circulation/Kreislauf), D (Disability/neurologischer Status), E (Exposure/Umgebung). So wird das Gefährlichste zuerst erkannt und behandelt.

23 **C** Bläuliche Lippen und Haut (Zyanose) sind ein Zeichen für eine unzureichende Sauerstoffversorgung des Blutes. Zusammen mit der schnellen, flachen Atmung und der Bewusstseinstrübung ist das ein Alarmzeichen (Problem bei A/B im ABCDE).

24 **D** Eine strukturierte Übergabe (z. B. nach ISBAR: Situation, Hintergrund, Einschätzung, Empfehlung) mit Vitalzeichen, Bewusstseinslage und bereits ergriffenen Maßnahmen ermöglicht dem Team ein schnelles, sicheres Weiterhandeln.

Fall 7: Belastende Atemnot bei palliativer Patientin, 71 Jahre

25 **A** Palliative Pflege zielt auf bestmögliche Lebensqualität und Linderung von belastenden Symptomen, nicht auf Heilung. Bei Atemnot stehen Symptomkontrolle, beruhigende Präsenz, Lagerung und - nach Anordnung - medikamentöse Linderung im Vordergrund.

26 **B** Eine aufrechte Lagerung erleichtert die Atmung, ruhige Anwesenheit reduziert die Angst (die Atemnot verstärkt), und ein kühler Luftzug (z. B. Ventilator, offenes Fenster) wird von vielen Betroffenen als lindernd empfunden.

27 **C** Angehörige sind Teil der palliativen Begleitung. Behutsame Information, das Angebot einfacher Beteiligung (z. B. Hand halten, Mund befeuchten) und Raum für Gefühle geben Halt und Handlungsfähigkeit in einer belastenden Situation.

28 **D** Sterbebegleitung heißt, die Würde des Menschen zu wahren, zuzuhören, präsent zu sein und individuelle Bedürfnisse und Wünsche zu achten. Zugewandte Nähe und aufmerksame Begleitung sind ebenso wichtig wie die körperliche Versorgung.

Fall 8: Diabetisches Fußulkus bei 66-jährigem Mann zu Hause

29 **A** Bei langjährigem Diabetes schädigt eine Polyneuropathie die Nerven, wodurch Schmerz- und Druckempfinden am Fuß abnehmen. Verletzungen und Druckstellen werden dadurch oft zu spät bemerkt - eine Hauptursache des diabetischen Fußsyndroms.

30 **B** Beim diabetischen Fußulkus sind konsequente Druckentlastung, fachgerechte (aseptische) Wundversorgung und die ärztliche Abklärung entscheidend, um eine Ausbreitung und Infektion zu verhindern. Hausmittel sind ungeeignet.

31 **C** Zur Prophylaxe des diabetischen Fußsyndroms gehören tägliche Kontrolle der Füße (auch mit Spiegel/Angehörigen), passendes, druckfreies Schuhwerk und sorgfältige Fußpflege. Barfußlaufen und enge Schuhe erhöhen das Verletzungsrisiko.

32 **D** Eine unausgewogene Ernährung und schlecht eingestellte Blutzuckerwerte verzögern die Wundheilung erheblich. Die soziale Situation (Alleinleben, seltenes frisches Kochen) ist pflegerelevant - hier können z. B. Ernährungsberatung oder weitere Hilfen sinnvoll sein.

Großfall 1: Herr Berger, 78 Jahre - dekompensierte Herzinsuffizienz

33 **A** Eine SpO2 von 89 % zusammen mit einer Atemfrequenz von 26/min zeigt eine respiratorische Belastung durch die Dekompensation. Der unregelmäßige Puls passt zum bekannten Vorhofflimmern, erklärt aber nicht die akute Luftnot.

34 **B** Die Herzbettlagerung senkt durch die tiefe Beinposition den venösen Rückstrom (Vorlast) und entlastet so das Herz. Der erhöhte Oberkörper erleichtert zusätzlich die Atemarbeit.

35 **C** Eine korrekte Bilanz erfasst die vollständige Einfuhr (Trinken, Infusionen) und Ausfuhr (Urin, Drainagen) und stellt sie gegenüber. Das tägliche Wiegen ergänzt die Bilanz, ersetzt sie aber nicht.

36 **D** Eine kurzfristige Gewichtszunahme ist das sensibelste Zeichen einer Flüssigkeitsretention bei Herzinsuffizienz. Gewogen wird unter gleichen Bedingungen (morgens, nüchtern, gleiche Kleidung).

37 **A** Diuretika steigern die Ausscheidung - dabei können Kalium und andere Elektrolyte entgleisen und der Kreislauf kann bei zu starker Entwässerung absacken. Ausscheidung, Elektrolytwerte (nach Anordnung) und Kreislauf sind zu überwachen.

38 **B** Bei Luftnot, Diuretika (Harndrang) und hohem Alter besteht ein deutliches Sturzrisiko. Sturzassessment, angebotene Begleitung und eine erreichbare Rufanlage erhalten Sicherheit und Selbstbestimmung. Bettgitter allein sind keine Sturzprophylaxe und können freiheitsentziehend sein.

39 **C** Schaumig-rosa (blutig tingiertes) Sekret, akute schwere Luftnot und Angst sind Leitzeichen eines akuten Lungenödems - ein Notfall, der sofortiges Handeln und ärztliche Alarmierung erfordert.

40 **D** Sofort Oberkörper hoch/Beine tief zur Vorlastsenkung, umgehend ärztliche Hilfe holen, Sauerstoff nach Anordnung, ruhige Präsenz gegen die Panik. Flachlagerung würde die Situation verschlimmern.

41 **A** Eine SpO2 von 82 % mit stark erhöhter Atem- und Herzfrequenz sowie hypertensiven Werten zeigt die akute respiratorische und kardiale Krise beim Lungenödem - klar behandlungsbedürftig.

42 **B** Nach einer akuten Dekompensation bleibt die Situation instabil. Engmaschige Kontrolle von Vitalzeichen, Atmung, Flüssigkeitsbilanz und Bewusstsein erkennt eine erneute Verschlechterung frühzeitig.

43 **C** Tägliches Wiegen deckt eine erneute Flüssigkeitseinlagerung frühzeitig auf. Bei rascher Zunahme (z. B. 2 kg in wenigen Tagen) soll ärztlicher Rat gesucht werden. Salzreduktion und Therapietreue sind ebenfalls wichtig - Medikamente werden nie eigenmächtig abgesetzt.

44 **D** Soziale Isolation und Trauer beeinflussen Gesundheit, Selbstversorgung und Therapietreue erheblich. Eine ganzheitliche Pflege nimmt die psychosoziale Situation ernst und vermittelt passende Unterstützungsangebote.

Großfall 2: Frau Cakir, 24 Jahre - nach Verkehrsunfall und Bein-OP

45 **A** Ein Schmerz von 7/10 ist behandlungsbedürftig. Die angeordnete Analgesie wird zeitnah gegeben und die Wirkung nach angemessener Zeit erneut mit der Schmerzskala kontrolliert. Gute Schmerzkontrolle ist Voraussetzung für Mobilisation und Genesung.

46 **B** Blässe und erhöhte Herzfrequenz können nach einer OP Zeichen einer Nachblutung mit Volumenmangel sein. Wichtig sind Kontrolle von Verband, Drainagenmenge, Vitalzeichen und ggf. ärztliche Information. Schmerz und Angst können ebenfalls beitragen.

47 **C** Die DMS-Kontrolle (Durchblutung, Motorik, Sensibilität) erkennt Durchblutungsstörungen oder Nervenschäden frühzeitig. Verglichen wird mit dem gesunden Bein; Auffälligkeiten werden dokumentiert und gemeldet.

48 **D** Ein Kompartmentsyndrom zeigt sich durch unverhältnismäßig starken, auf Analgesie kaum ansprechenden Schmerz, prallgespannte Muskellogen, Gefühls- und später Durchblutungsstörungen. Das ist ein Notfall und muss sofort gemeldet werden.

49 **A** Auch junge Patienten sind durch OP und Immobilität gefährdet. Thromboseprophylaxe (Bewegung, ggf. Medikamente/Strümpfe), Pneumonieprophylaxe (Atemübungen) und Dekubitusprophylaxe (Bewegung, Hautpflege) gehören zum Standard.

50 **B** Schwindel und Blässe bei der ersten Mobilisation deuten auf eine orthostatische Kreislaufreaktion. Die Mobilisation wird unterbrochen, die Patientin sicher gelagert und der Kreislauf kontrolliert. Die nächste Mobilisation erfolgt langsamer und begleitet.

51 **C** Plötzliche Atemnot und atemabhängiger Brustschmerz nach einer Bein-OP sind Warnzeichen einer Lungenembolie (verschleppter Thrombus). Das ist ein lebensbedrohlicher Notfall - sofort Vitalzeichen erheben und ärztliche Hilfe alarmieren.

52 **D** Oberkörperhochlagerung erleichtert die Atmung, ruhige Präsenz reduziert Panik, kontinuierliche Überwachung von Vitalzeichen und Sauerstoffsättigung ist entscheidend. Körperliche Belastung wird vermieden. Sauerstoff nur nach Anordnung.

53 **A** Nach einem bedrohlichen Ereignis ist Angst normal. Ernstnehmen, verständlich informieren und verlässliche Präsenz geben Sicherheit. Gerade bei einer jungen Patientin ist die psychische Verarbeitung Teil der Genesung.

54 **B** Falsche Garantien und Entmutigung sind beide unangebracht. Ehrliche, zugleich zuversichtliche Information im Rahmen der eigenen Kompetenz - und der Verweis auf Physiotherapie und ärztliche Einschätzung - geben realistische Perspektive.

55 **C** Klassische Infektzeichen sind Rötung, Überwärmung, Schwellung, zunehmender Schmerz und Funktionseinschränkung, oft mit Fieber. Sie müssen erkannt, dokumentiert und ärztlich abgeklärt werden.

56 **D** Bewegung aktiviert die Muskelpumpe und beugt Thrombosen vor. Die ärztlich verordnete Prophylaxe (medikamentös und/oder Kompression) wird zu Hause konsequent fortgeführt. Langes Sitzen mit hängenden Beinen und einseitige Bettruhe erhöhen das Risiko.

Großfall 3: Herr Novak, 55 Jahre - Depression nach Jobverlust

57 **A** Vertrauen ist die Basis jeder psychiatrischen Pflege. Empathie, Geduld und Wertschätzung ermöglichen eine tragfähige Beziehung. Druck und Bagatellisierung ('zusammenreißen') schaden und verstärken Rückzug und Scham.

58 **B** Appetitverlust, Antriebsstörung und Selbstvernachlässigung sind typische Symptome der Depression. Sie können zu Mangelernährung und körperlicher Verschlechterung führen - die Ernährungssituation ist deshalb pflegerelevant.

59 **C** Non-Adhärenz hat oft Gründe (Nebenwirkungen, Hoffnungslosigkeit, Vergessen). Ein nicht-wertendes Gespräch, Aufklärung über Wirkung und Wichtigkeit sowie praktische Hilfen (z. B. Dosierhilfe) fördern die Einnahmetreue. Heimliche Gabe ist unzulässig.

60 **D** Äußerungen, die auf lebensmüde Gedanken hindeuten, haben höchste Priorität. Sie müssen ernst genommen und aktiv angesprochen werden, um Suizidalität einzuschätzen und Schutz zu organisieren.

61 **A** Ein verbreiteter Irrtum ist, dass Nachfragen Suizidalität auslöse. Das Gegenteil ist der Fall: Direktes, einfühlsames Ansprechen entlastet Betroffene und ist Voraussetzung, um Gefahr einzuschätzen und Hilfe einzuleiten.

62 **B** Auch ohne konkreten Plan ist Suizidalität ernst. Die Pflegekraft sorgt für Sicherheit, lässt die Person nicht ungeschützt allein und bindet umgehend ärztliche bzw. therapeutische Hilfe ein. Eigenmächtige Medikamentengabe ist unzulässig.

63 **C** In der Phase beginnender Besserung kann der Antrieb zurückkehren, bevor sich die Stimmung stabilisiert. Dadurch kann vorübergehend die Gefahr steigen, Suizidgedanken umzusetzen. Diese Phase erfordert besondere Wachsamkeit.

64 **D** Aktivierende Pflege bei Depression bedeutet, in kleinen, machbaren Schritten zu fördern, realistische Ziele zu vereinbaren und Erreichtes wertzuschätzen. Komplette Übernahme fördert Passivität, Überforderung führt zu Misserfolg.

65 **A** Soziale Isolation verstärkt Depression. Gemeinsam - im Tempo des Betroffenen - Kontaktmöglichkeiten und eine Tagesstruktur zu entwickeln, fördert Teilhabe. Zwang ist kontraproduktiv, Rückzug zu bestärken ebenfalls.

66 **B** Antidepressiva werden auch nach Besserung über längere Zeit weitergenommen und nur in ärztlicher Absprache langsam reduziert. Eigenmächtiges Absetzen erhöht das Rückfallrisiko. Die Pflegekraft informiert und verweist an den Arzt.

67 **C** Angehörige sind eine wichtige Ressource. Mit Einverständnis des Betroffenen (Schweigepflicht!) können sie einbezogen und beraten werden, wie sie unterstützend begleiten, ohne zu überfordern. Ohne Zustimmung dürfen keine Details weitergegeben werden.

68 **D** Wirksamkeit zeigt sich an konkreten, beobachtbaren Verbesserungen: Selbstversorgung, Medikamententreue, sozialer Teilhabe, Tagesstruktur und Abwesenheit akuter Suizidalität. Solche Ziele werden gemeinsam überprüft und angepasst.

Auswertung

Richtig beantwortet	_____ von 68
Davon Teil A	_____
Davon Teil B	_____
Themen zum Wiederholen	_____

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

FALLARBEIT · EXAMEN & PRAXIS

92 Fallbeispiele für die Pflege

Klinische Fälle aus 13 Fachgebieten: Situation lesen, an jedem Entscheidungspunkt die beste Handlung wählen – mit ausführlicher Auflösung und Merksatz zu jedem Fall.

Bestehen ist planbar.

Entscheidungen | Priorisierung | Notfall | Merksätze

92	13	A4
Fälle	Fachgebiete	druckfertig

INHALT

1. Innere Medizin
2. Chirurgie
3. Intensivmedizin
4. Pädiatrie
5. Anästhesie
6. Psychiatrie
7. Pflegegrundlagen
8. Neurologie
9. Onkologie
10. … und weitere

⚠ Lernhilfe, mit KI-Unterstützung erstellt und fachlich geprüft. Maßgeblich sind Lehrinhalte, Leitlinien und Standards deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

plan-nrw.de

So arbeitest du mit den Fällen

Jeder Fall hat mehrere Entscheidungspunkte. Wähle jeweils die Handlung, die du als Pflegefachkraft zuerst bzw. am sichersten durchführen würdest. Die Auflösung zeigt, was richtig, vertretbar oder falsch ist – und warum.

BEWERTUNG

RICHTIG beste Wahl
VERTRETBAR möglich, aber nicht optimal
FALSCH gefährlich oder falsch priorisiert

IM UNTERRICHT

Ideal für Lerngruppen und Praxisanleitung: Fall vorlesen, gemeinsam entscheiden, dann auflösen.

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

Innere Medizin

7 Fälle

Fall 1 · Akuter Brustschmerz

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Frau K., 64 J., Diabetikerin: seit 45 min drückender retrosternaler Schmerz, vegetativ (Kaltschweiß, Übelkeit). RR 145/85, Puls 92, SpO_2 96 %.

1 PRIORISIERUNG

Mehrere Maßnahmen sind sinnvoll – womit beginnst du?

A) 12-Kanal-EKG (Ziel < 10 min) + Monitor

B) Sofort O_2 über Maske 10 L geben

C) Erst i.v.-Zugang legen und Troponin abnehmen

2 EKG-BEFUND

EKG: ST-Hebung in II/III/aVF mit reziproker Senkung in I/aVL. Konsequenz?

A) Troponin abwarten, um den Infarkt zu bestätigen

B) Inferiorer STEMI → sofort Reperfusion/Herzkatheter aktivieren

C) Zusätzlich rechtspräkordiale Ableitungen (V4r) ableiten

3 MEDIKATION PRÜFEN

Welcher Punkt ist beim inferioren Infarkt besonders kritisch?

A) Volumengabe grundsätzlich vermeiden

B) Nitrat großzügig geben, senkt ja die Vorlast

C) Nitrate nur vorsichtig/ggf. meiden (mögliche RV-Beteiligung → Vorlastabfall)

4 AKUTE KOMPLIKATION

Bei der Vorbereitung wird die Patientin bewusstlos, am Monitor Kammerflimmern. Reaktion?

A) Erst Puls 10 s tasten und Arzt rufen

B) Sofort Defibrillation + CPR, Notfallteam

C) Amiodaron i.v. zuerst, dann Schock

Fall 2 · Nächtliche Atemnot

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Herr B., 78 J., KHK: nachts schwere Atemnot, Orthopnoe, feuchte RGs beidseits, SpO_2 85 %, RR 195/110, Puls 110.

1 PRIORISIERUNG

Was hat Sofortpriorität?

- A) Zuerst 12-Kanal-EKG, alles andere danach
- B) Sofort hochdosiert i.v.-Furosemid, dann der Rest
- C) Oberkörper hoch / Beine tief, O_2 titrieren, Monitor

2 THERAPIERICHTUNG

RR 195/110 – hypertensives Lungenödem. Was ist führend?

- A) Betablocker i.v. zur Frequenzsenkung
- B) Nitrate (Vor-/Nachlast senken) + Diuretikum, O_2/NIV
- C) Nur hochdosiert Furosemid, keine Nitrate

3 VERSCHLECHTERUNG

Trotz Therapie SpO_2 84 %, zunehmende Erschöpfung, noch ansprechbar. Reaktion?

- A) Weiter nur O_2-Maske, abwarten
- B) Sofort sedieren und intubieren
- C) NIV (CPAP) einleiten, Intensiv informieren

4 ÜBERWACHUNG

Unter NIV bessert es sich. Worauf achtest du besonders?

- A) RR, SpO_2, Atemarbeit, Bilanz/Ausscheidung, Vigilanz, NIV-Toleranz
- B) Nur SpO_2 bis 100 % anstreben

Fall 3 · COPD-Exazerbation

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Frau S., 70 J., schwere COPD: 3 Tage zunehmende Dyspnoe, purulentes Sputum, SpO_2 84 %, leicht somnolent, AF 28.

1 SAUERSTOFFGABE

Wie gibst du Sauerstoff?

- (A) Erst BGA abwarten, bis dahin kein O_2
- (B) Kontrolliert titrieren, Ziel SpO_2 88–92 %, engmaschig
- (C) Reservoirmaske 12–15 L, später runtertitrieren

2 THERAPIE

Was steht therapeutisch im Vordergrund (AO)?

- (A) Sofort NIV für jeden, unabhängig von der BGA
- (B) Kurzwirksame Bronchodilatatoren, systemische Steroide, ggf. Antibiotikum (purulent)
- (C) Sedierung wegen der Unruhe

3 BGA-BEFUND

BGA: pH 7,28, pCO_2 68 mmHg. Was ist indiziert?

- (A) O_2 deutlich erhöhen, um die Sättigung zu pushen
- (B) NIV (respiratorische Azidose), Intensiv informieren
- (C) Weiter nur Inhalation, abwarten

4 ÜBERWACHUNG

Unter NIV bessert sich die BGA. Worauf achtest du?

- (A) SpO_2 auf 100 % anheben
- (B) Vigilanz, AF, SpO_2 (88–92 %), BGA-Verlauf, NIV-Toleranz

Fall 4 · Plötzliche Atemnot postop.

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Herr M., 58 J., 3 Tage nach Knie-TEP: plötzliche Dyspnoe + atemabhängiger Thoraxschmerz, Puls 120, SpO_2 88 %, RR 110/70, einseitig geschwollenes Bein.

1 PRIORISIERUNG

Was hat Vorrang?

A Eigenständig Vollheparinisierung starten

B Erst 12-Kanal-EKG, dann entscheiden

C Monitoring + O_2 titrieren, Patient ruhigstellen, Arzt – V.a. LE

2 DIAGNOSTIK

Aktuell hämodynamisch stabil (RR 110/70). Vorgehen (AO)?

A Erst D-Dimer abwarten, bevor etwas passiert

B CT-Pulmonalisangiografie anstreben; Antikoagulation nach AO

3 AKUTE VERSCHLECHTERUNG

Plötzlich RR 80/50, gestaute Halsvenen, kaltschweißig. Einordnung/Reaktion?

A Großzügig Volumen geben, bis der RR steigt

B Hämodynamisch instabile (Hochrisiko-)LE → Notfallteam, Kreislaufstütze nach AO, Lyse erwägen

C Patienten aufsetzen zur Atemerleichterung

4 ÜBERWACHUNG

Reanimationsbereitschaft. Vorgehen?

A Engmaschig RR/Puls/SpO_2, CPR-Bereitschaft, Lyse/Intensiv nach AO

B Nur die Sättigung überwachen

Fall 5 · Bluterbrechen

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Frau L., 67 J., NSAR + ASS: Hämatemesis (kaffeesatzartig) + Meläna, blass, Puls 112, RR 96/60, unruhig.

1 PRIORISIERUNG

Was hat Vorrang?

- A Kreislauf: 2 großlumige Zugänge, Volumen nach AO, Monitor, Kreuzblut, Arzt
- B Magensonde zum Ausspülen legen
- C Sofort PPI i.v. als Bolus, dann der Rest

2 ZENTRALE MASSNAHME

Stabilisierung läuft. Was ist therapeutisch zentral?

- A Erst beobachten, Endoskopie elektiv am Folgetag
- B Frühe Endoskopie (diagnostisch + therapeutisch), nüchtern, PPI nach AO

3 VERSCHLECHTERUNG

Hb-Abfall, RR 85/55 trotz Volumen, erneute Hämatemesis. Reaktion?

- A Kopftief lagern, um den Kreislauf zu stützen
- B Atemweg schützen (Aspiration!), absaugen, Transfusion nach AO, dringliche Endoskopie/Intensiv
- C Nur weiter Volumen, abwarten

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

- A RR/Puls engmaschig, Bewusstsein, Ausscheidung, Hb-/Gerinnungsverlauf, Rezidivzeichen
- B Einmal RR messen genügt

Fall 6 · Plötzliche Verwirrtheit

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Herr T., 72 J., Insulin + Sulfonylharnstoff: akut verwirrt, zittrig, kaltschweißig. BZ 2,3 mmol/l (41 mg/dl). Noch wach, schluckt sicher.

1 SOFORTMASSNAHME

Wach und schluckfähig – was ist erste Wahl?

- A i.m. Glukagon
- B Orale schnelle KH, 15–20 g (z. B. Traubenzucker/Saft)
- C i.v. Glukose 40 %, obwohl er schlucken kann

2 NACH DER GABE

Wie geht es weiter?

- A Keine Kontrolle, der Patient kann gehen
- B BZ nach 15 min kontrollieren, ggf. wiederholen, dann komplexe KH

3 MEDIKATION BEDENKEN

Welcher Aspekt ist wegen des Sulfonylharnstoffs wichtig?

- A Längere Überwachung (Gefahr protrahierter/rezidivierender Hypoglykämie), Arzt/ggf. stationär
- B Nach Normalisierung sofort entlassen

4 ÜBERWACHUNG / URSACHE

Worauf achtest du?

- A BZ-Verlauf, Bewusstsein, Auslöser (Dosis/Mahlzeit/Niereninsuffizienz), Doku, Arzt
- B Nur einmal nachmessen

Fall 7 · Fieber auf Station

Routine · niedrig | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Frau S., 72 J., fühlt sich seit dem Morgen schlapp und heiß. Du übernimmst die Grundpflege und Beobachtung.

1 SCHICHTBEGINN

Womit beginnst du?

- A Eigenmächtig ein fiebersenkendes Mittel geben
- B Temperatur und weitere Vitalzeichen messen und nach dem Befinden fragen
- C Nur das Fenster öffnen und abwarten

2 BEOBACHTUNG

Temperatur 38,9 °C. Was erfasst du zusätzlich?

- A Bewusstsein, Hautzustand, Trinkmenge und Atmung beobachten und dokumentieren
- B Nur die Temperatur notieren
- C Gar nichts dokumentieren

3 FLÜSSIGKEIT

Die Patientin hat heute kaum getrunken. Was tust du?

- A Den geringen Trinkverlauf ignorieren
- B Getränke anbieten und anreichen, Einfuhr beobachten und melden
- C Sie zum Trinken einer ganzen Kanne drängen

4 MELDUNG

Wie schließt du ab?

- A Befund an die Pflegefachkraft melden und vollständig dokumentieren
- B Erst am Schichtende kurz erwähnen

Chirurgie

7 Fälle

Fall 8 · Akutes Abdomen

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

> Herr R., 24 J.: seit 12 h Bauchschmerz, zunächst periumbilikal, jetzt rechter Unterbauch; Übelkeit, Fieber 38,6 °C, Abwehrspannung, Loslassschmerz.

1 PRIORISIERUNG

Wie gehst du vor?

- A Wärmflasche auf den Bauch zur Schmerzlinderung
- B Abführmittel geben, um den Darm zu entlasten
- C Vitalzeichen, nüchtern lassen, Schmerz/Temperatur erfassen, Arzt informieren

2 ANALGESIE & DIAGNOSTIK

Starke Schmerzen, der Arzt ordnet Diagnostik an. Was ist korrekt?

- A Keine Schmerzmittel, sonst wird die Diagnose verschleiert
- B Analgesie nach AO ist erlaubt und verschleiert die Diagnostik nicht – Labor/Sono/ggf. CT
- C Essen anbieten, damit er zu Kräften kommt

3 VERSCHLECHTERUNG

Plötzlich brettharter Bauch, RR fällt, Puls steigt, hohes Fieber. Reaktion?

- A Schmerzmittel erhöhen und beobachten
- B V.a. Perforation/Peritonitis → sofort Chirurg/OP-Vorbereitung, Volumen, Antibiotika nach AO, Monitoring
- C Erst das CT abwarten, bevor jemand gestört wird

4 ÜBERWACHUNG / OP-VORBEREITUNG

Worauf achtest du?

- A Kreislauf, Bilanz, Temperatur, OP-Vorbereitung (nüchtern, Zugang, Einwilligung), Sepsiszeichen
- B Nur die Temperatur kontrollieren

Fall 9 · Darmverschluss

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Frau D., 71 J., Z.n. Bauch-OPs: zunehmende kolikartige Bauchschmerzen, geblähtes Abdomen, fäkulentes Erbrechen, kein Stuhl/Wind seit 2 Tagen.

1 PRIORISIERUNG

Wie gehst du vor?

- A Abführmittel/Einlauf geben
- B Nüchtern, Magensonde zur Entlastung nach AO, i.v.-Zugang/Volumen, Arzt
- C Reichlich trinken lassen, um den Darm in Gang zu bringen

2 ZENTRALE MASSNAHME

Bildgebung bestätigt mechanischen (Briden-)Ileus. Was ist zentral?

- A Nur Schmerzmittel, abwarten ob es sich löst
- B Magensonden-Entlastung, Bilanz, Elektrolyte ausgleichen, chirurgische Mitbeurteilung

3 VERSCHLECHTERUNG

Plötzlich Dauerschmerz statt Kolik, lokale Abwehr, Fieber, RR fällt. Einordnung?

- A Weiter konservativ abwarten
- B V.a. Strangulation/Ischämie → chirurgischer Notfall, OP-Vorbereitung, Volumen, Antibiotika nach AO

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

- A Nur den Schmerzscore
- B Kreislauf, Bilanz (Sonde/Urin), Elektrolyte, Temperatur, Sepsiszeichen, OP-Vorbereitung

Fall 10 · Plötzlich kaltes Bein

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

> Herr P., 68 J., Vorhofflimmern: plötzlich starker Schmerz im rechten Bein; Bein blass, kalt, kein Fußpuls tastbar, beginnende Gefühlsstörung.

1 PRIORISIERUNG

Wie lagerst und handelst du?

- (A) Bein hochlagern zur Entlastung
- (B) Aktiv mit Wärmflasche erwärmen
- (C) Bein tief lagern, warm halten (nicht aktiv wärmen), Pulsstatus dokumentieren, sofort Gefäßchirurgie/Arzt

2 ZEITKRITISCH

Akuter arterieller Verschluss (embolisch bei VHF). Was ist zeitkritisch (AO)?

- (A) Rasche Revaskularisation (Embolektomie/Lyse); Antikoagulation nach AO; nüchtern (OP)
- (B) Erst abwarten, ob sich die Durchblutung erholt

3 VERSCHLECHTERUNG

Nach Stunden: Schwellung, harte Muskelloge, stärkster Schmerz, Sensomotorik schlechter. Einordnung?

- (A) V.a. Kompartmentsyndrom/fortgeschrittene Ischämie → sofort Chirurg (ggf. Fasziotomie), Monitoring
- (B) Schmerzmittel erhöhen, abwarten

4 ÜBERWACHUNG

Nach Revaskularisation – worauf achtest du?

- (A) Durchblutung/Puls, Sensomotorik, Logenspannung, Nierenwerte/Urin (Reperfusionsschaden), Schmerz
- (B) Nur den Schmerz dokumentieren

Fall 11 · Schmerz im Gips

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Patient, 22 J., nach Unterschenkelfraktur im Gips: zunehmender, unverhältnismäßig starker Schmerz, Schmerz bei passiver Zehenstreckung, pralle Wade, Kribbeln.

1 ERSTES VORGEHEN

Was tust du zuerst?

- A Stärkeres Schmerzmittel geben und abwarten
- B Gips/zirkuläre Verbände sofort spalten, Bein auf Herzhöhe, sofort Arzt
- C Bein hochlagern und kühlen

2 ENTSCHEIDEND

Der Befund spricht für ein drohendes Kompartmentsyndrom. Was ist entscheidend?

- A Erst ein Röntgen abwarten
- B Sofortige chirurgische Beurteilung (Logendruck/Fasziotomie), Durchblutung/Sensomotorik engmaschig

3 VERSCHLECHTERUNG

Trotzdem zunehmender Druck, Sensibilität nimmt ab, Fußpuls jetzt schwächer. Reaktion?

- A Notfall-Fasziotomie veranlassen (Chirurg), Monitoring, Bein auf Herzhöhe
- B Weiter beobachten, der Puls ist ja noch da

4 ÜBERWACHUNG

Nach der Fasziotomie – worauf achtest du?

- A Sensomotorik, Durchblutung, Logenspannung, Nieren-/Urinkontrolle (Rhabdomyolyse), Wunde
- B Nur den Verband kontrollieren

Fall 12 · Postoperative Nachblutung

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Frau H., 60 J., 4 h nach großer Bauch-OP: tachykard (118), RR 95/55, blass, kaltschweißig, Wunddrainage füllt sich rasch mit Blut, unruhig.

1 PRIORISIERUNG

Wie gehst du vor?

- (A) Drainage abklemmen, damit kein Blut mehr verloren geht
- (B) Erst die Schmerzen behandeln, dann weiter
- (C) Kreislauf: Monitor, 2 großlumige Zugänge, Volumen nach AO, Drainagemenge dokumentieren, sofort Chirurg/Arzt

2 DIAGNOSTIK/THERAPIE

Was ist sinnvoll (AO)?

- (A) Labor/Hb, Kreuzblut/Transfusion vorbereiten, Gerinnung prüfen, ggf. operative Revision
- (B) Nur weiter Volumen und beobachten

3 VERSCHLECHTERUNG

Trotz Volumen RR 80/45, Hb fällt, Drainage weiter blutig. Reaktion?

- (A) Weiter nur Kristalloide, abwarten
- (B) Operative Revision anstreben, Transfusion nach AO, Massivtransfusionsbereitschaft, Intensiv

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

- (A) RR/Puls engmaschig, Hb-/Gerinnungsverlauf, Drainagemenge, Bewusstsein, Urin, Wärmeerhalt
- (B) Stündlich RR genügt

Fall 13 · Eingeklemmte Leiste

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

> Herr K., 55 J.: seit 4 h schmerzhafte, nicht reponible Vorwölbung in der Leiste, Übelkeit, Erbrechen; die Schwellung ist prall, gerötet, sehr druckschmerzhaft.

1 PRIORISIERUNG

Wie gehst du vor?

- A Mehrfach kräftig versuchen, die Hernie zurückzudrücken
- B Wärmflasche zur Entspannung auflegen
- C Nüchtern lassen, Vitalzeichen, nicht selbst reponieren, sofort Chirurg/Arzt

2 ZENTRALE MASSNAHME

V.a. Inkarzeration mit drohender Strangulation. Was ist zentral?

- A Abwarten, ob es sich von selbst löst
- B Dringliche operative Versorgung anstreben, nüchtern, Zugang/Volumen, Analgesie nach AO

3 VERSCHLECHTERUNG

Zunehmender Schmerz, Fieber, RR fällt, Abwehrspannung. Einordnung?

- A Noch ein Repositionsversuch
- B V.a. Strangulation/Ileus/Peritonitis → Notfall-OP-Vorbereitung, Volumen, Antibiotika nach AO, Monitoring

4 ÜBERWACHUNG / OP-VORBEREITUNG

Worauf achtest du?

- A Nur den Schmerz dokumentieren
- B Kreislauf, Bilanz, Temperatur, Sepsiszeichen, nüchtern, Zugang, Einwilligung

Fall 14 · Erster Tag nach der OP

Routine · niedrig | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Herr M., 28 J., 1. Tag nach Blinddarm-OP (Appendektomie). Du betreust ihn im Frühdienst und übernimmst Grundpflege und Beobachtung. Er ist wach, klagt aber über Schmerzen.

1 SCHICHTBEGINN

Womit beginnst du sinnvoll deine Betreuung?

- A Ungefragt den Wundverband wechseln
- B Den Patienten sofort zum Aufstehen bewegen
- C Vitalzeichen kontrollieren, nach Befinden und Schmerzen fragen, Verband ansehen

2 SCHMERZ

Herr M. gibt seine Schmerzen mit 6 von 10 an. Wie gehst du vor?

- A Selbst ein Schmerzmittel aus dem Schrank geben
- B Schmerz mit Skala erfassen, an die Pflegefachkraft melden, Gabe nach Anordnung, dokumentieren
- C Abwarten, Schmerzen gehören nach einer OP eben dazu

3 WUNDBEOBACHTUNG

Der Verband ist leicht durchgeblutet. Was tust du?

- A Sofort selbst steril neu verbinden
- B Ausmaß und Farbe beobachten, Stelle markieren, melden und dokumentieren
- C Die Durchblutung ignorieren

4 PROPHYLAXEN

Was ist am 1. Tag nach der OP besonders wichtig?

- A Frühmobilisation nach Anordnung, Thrombose- und Pneumonieprophylaxe, Atemübungen
- B Strikte Bettruhe anordnen, damit die Wunde heilt

Intensivmedizin

7 Fälle

Fall 15 · Septischer Schock

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

> Frau N., 76 J., Dauerkatheter: Fieber 39,4 °C, Schüttelfrost, RR 85/50, Puls 124, verwirrt, Laktat erhöht, warme Peripherie.

1 ERSTE STUNDE

Was tust du im Sepsis-Bündel zuerst?

- (A) Erst fiebersenken (Paracetamol) und beobachten
- (B) Blutkulturen abnehmen, dann zügig Breitband-Antibiotikum nach AO, Volumenbolus, Laktat, Monitoring
- (C) Antibiotikum sofort, Blutkulturen später nachholen

2 VOLUMEN

RR bleibt 85/50 nach erstem Bolus. Vorgehen?

- (A) Sofort Diuretikum, weil wenig Urin kommt
- (B) Weitere balancierte Kristalloid-Boli nach AO, Reevaluation (RR/Laktat/Urin)
- (C) Nur Antibiose, kein weiteres Volumen

3 ESKALATION

Trotz adäquatem Volumen RR 80/45, Laktat steigt. Was ist indiziert?

- (A) Vasopressor (Noradrenalin) nach AO, Intensiv/ZVK, engmaschiges Monitoring
- (B) Weiter literweise Volumen ohne Limit

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

- (A) MAP-Ziel, Laktat-Verlauf, Urinausscheidung, Bewusstsein, Temperatur, Fokuskontrolle (Katheter!)
- (B) Nur die Temperatur

Fall 16 · Beatmungsnotfall

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Beatmeter Intensivpatient: plötzlicher SpO_2-Abfall auf 80 %, Beatmungsdruck-Alarm, zunehmende Zyanose, unruhig.

1 STRUKTURIERT ZUERST

Was tust du?

A) Sedierung erhöhen wegen der Unruhe

B) Sofort den Tubus ziehen

C) 100 % O_2, manuell beatmen (vom Gerät trennen, Beutel), nach DOPES prüfen, Hilfe rufen

2 EINGRENZEN

Manuelles Beatmen schwergängig, einseitig abgeschwächtes Atemgeräusch. Verdacht?

A) Obstruktion vs. Fehllage/einseitige Intubation vs. Pneumothorax → absaugen, Tubuslage prüfen, Arzt

B) Einfach mehr Druck geben

3 VERSCHLECHTERUNG

Gestaute Halsvenen, einseitig fehlendes Atemgeräusch, RR fällt, Trachea verschoben. Einordnung?

A) Weiter beatmen und beobachten

B) V.a. Spannungspneumothorax → sofort Arzt, Entlastungspunktion/Drainage vorbereiten, Monitoring

4 ÜBERWACHUNG

Nach der Entlastung Besserung. Worauf achtest du?

A) Nur SpO_2

B) SpO_2, Beatmungsdrücke, seitengleiches Atemgeräusch, Tubuslage, Drainage/Sog, Kreislauf

Fall 17 · Gefährliches Kalium

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Herr W., 64 J., oligurisches akutes Nierenversagen: Schwäche, Parästhesien; Kalium 6,9 mmol/l; EKG mit hohen spitzen T-Wellen und verbreitertem QRS.

1 PRIORITÄT

Was hat bei EKG-Veränderungen Vorrang?

- A Monitor/EKG, sofort Arzt; Membranstabilisierung mit Kalziumglukonat nach AO
- B Kaliumsenker (Insulin/Glukose) reicht allein, kein Kalzium
- C Erst in Ruhe ein neues Kalium abwarten

2 K^+ SENKEN

Nach Membranstabilisierung – wie wird Kalium gesenkt (AO)?

- A Nur Kationenaustauscher oral, das genügt
- B Insulin + Glukose i.v. (K^+ nach intrazellulär), ggf. Beta-2-Mimetikum; Verlauf (K^+, BZ)

3 DEFINITIV

Anurisch, K^+ bleibt trotz Maßnahmen hoch. Was ist definitiv?

- A Weiter nur Insulin/Glukose wiederholen
- B Dialyse anstreben (definitive Elimination), Intensiv, Monitoring

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

- A Nur einmal K^+ nachbestimmen
- B Kontinuierliches EKG, K^+-/BZ-Verlauf, Diurese/Bilanz, Reanimationsbereitschaft

Fall 18 · Entgleister Zucker

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Frau J., 28 J., Typ-1-Diabetes: Übelkeit/Erbrechen, Bauchschmerz, tiefe Atmung (Kussmaul), exsikkiert; BZ 28 mmol/l, pH 7,12, Ketone positiv, K^+ 3,2 mmol/l.

1 VORRANG

Was hat in der DKA-Therapie Vorrang?

A Natriumbikarbonat zur pH-Korrektur geben

B Großzügige Volumengabe (NaCl) nach AO, Monitoring, Elektrolyte/K^+, Arzt

C Sofort hochdosiert Insulin als Bolus, Volumen später

2 KALIUM BEACHTEN

K^+ ist 3,2 mmol/l. Was ist vor/mit Insulin wichtig?

A Insulin trotzdem sofort hoch, K^+ ignorieren

B Kalium nach AO substituieren; Insulin erst bei adäquatem K^+ starten/begleiten

3 BZ FÄLLT

Unter Therapie sinkt der BZ rasch auf 12 mmol/l, die Azidose ist noch nicht behoben. Vorgehen?

A Insulin sofort stoppen, weil der BZ fast normal ist

B Glukose zur Infusion ergänzen, niedrig dosiertes Insulin weiter bis Azidose/Ketose behoben

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

A Nur BZ alle paar Stunden

B BZ stündlich, K^+/Elektrolyte, BGA/Ketone, Bilanz, Bewusstsein, Herzrhythmus

Fall 19 · Nächtliche Unruhe (Intensiv)

akut | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Herr S., 79 J., 2. Tag nach großer OP auf Intensiv: nachts plötzlich agitiert, desorientiert, zieht an Zugängen, fluktuierende Aufmerksamkeit.

1 ERSTES VORGEHEN

Was tust du zuerst?

A Reversible somatische Ursachen ausschließen (Hypoxie, BZ, Schmerz, Harnverhalt, Medikamente), Monitoring, Arzt

B Ein Benzodiazepin als Schlafmittel geben

C Sofort fixieren und sedieren

2 BASIS DER THERAPIE

Keine akute somatische Ursache gefunden. Was ist die Basis?

A Direkt ein Antipsychotikum als Standard für alle

B Nicht-medikamentös: Reorientierung, Tag-Nacht-Rhythmus, Brille/Hörgerät, Mobilisation, Zugänge sichern, Angehörige

3 EIGENGEFÄHRDUNG

Trotzdem starke Agitation, er reißt am arteriellen Zugang. Vorgehen?

A Niedrig dosiertes Antipsychotikum nach AO, engmaschige Überwachung, weiter nicht-medikamentös

B Hohe Dosis Benzodiazepin zur schnellen Ruhe

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

A Delir-Score (CAM-ICU), Vitalzeichen/QT (bei Antipsychotika), Selbst-/Sturzgefahr, Schlaf, Ursachen reevaluieren

B Nur, ob er ruhig ist

Fall 20 · Reaktion auf Medikament

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Patient erhält ein i.v.-Antibiotikum; innerhalb von Minuten Urtikaria, Atemnot mit Stridor, RR 80/40, Tachykardie, Angst.

1 SOFORT

Was tust du sofort?

- A Erst i.v.-Zugang/Labor sichern, dann Medikamente
- B Auslöser stoppen (Infusion!), Hilfe rufen, Adrenalin i.m. (Oberschenkel) nach AO, O_2, flach mit erhöhten Beinen
- C Zuerst Antihistaminikum + Kortison i.v.

2 WEITER

Nach Adrenalin i.m. – wie weiter?

- A Adrenalin sofort unkontrolliert als i.v.-Bolus nachschieben
- B Volumenbolus (Kristalloid) nach AO, O_2, Monitoring; Adrenalin ggf. wiederholen (alle 5–10 min)

3 ATEMWEG

Zunehmender Stridor / drohende Atemwegsschwellung. Vorgehen?

- A Abwarten, ob das Antihistaminikum wirkt
- B Atemweg sichern (frühe Intubationsbereitschaft/Anästhesie), Adrenalin wiederholen, Intensiv

4 ÜBERWACHUNG

Stabilisierung. Worauf achtest du?

- A Nach Besserung sofort entlassen
- B RR/SpO_2/Atemweg, Reevaluation, längere Überwachung (biphasische Reaktion!), Auslöser dokumentieren

Fall 21 · Grundpflege beim beatmeten Patienten

Routine · mittel | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Herr K. liegt beatmet und bewusstlos auf der Intensivstation. Du unterstützt unter Anleitung bei der Grundpflege.

1 HALTUNG

Wie gehst du den bewusstlosen Patienten an?

- A) Wortlos und ohne Vorstellung pflegen
- B) Trotz Bewusstlosigkeit ansprechen, Würde wahren, vorher Händedesinfektion
- C) Ohne Händedesinfektion und Handschuhe arbeiten

2 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du am Monitor?

- A) Einen Alarm einfach wegdrücken
- B) Nur auf den Patienten schauen, nicht auf den Monitor
- C) Puls, SpO_2 und Blutdruck im Blick behalten und Auffälligkeiten der Fachkraft melden

3 PROPHYLAXE

Welche Pflege ist besonders wichtig?

- A) Mund-, Augen- und Hautpflege sowie Lagerung zur Prophylaxe, nur unter Anleitung
- B) Eigenständig am Beatmungsschlauch hantieren
- C) Nur waschen, alles andere weglassen

4 ABSCHLUSS

Wie schließt du ab?

- A) Nur das Waschen notieren
- B) Alles dokumentieren und im Team kommunizieren

Pädiatrie

7 Fälle

Fall 22 · Krampfanfall bei Fieber

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Leon, 18 Monate, hohes Fieber: zu Hause generalisierter Krampfanfall, jetzt seit 2 min tonisch-klonisch zuckend, die Eltern sind panisch.

1 WÄHREND DES ANFALLS

Was tust du?

(A) Vor Verletzung schützen, Seitenlage wenn möglich, nichts in den Mund, Dauer messen, Atemweg/SpO_2 beobachten, Hilfe

(B) Etwas zwischen die Zähne schieben (Zungenbiss)

(C) Das Kind festhalten und die Zuckungen unterdrücken

2 ANFALLSDAUER

Der Anfall dauert nun > 5 min an. Was ist indiziert (AO)?

(A) Weiter abwarten, hört von selbst auf

(B) Antikonvulsivum nach Notfallschema (z. B. Benzodiazepin, gewichtsadaptiert), Atemweg/SpO_2 überwachen

(C) Sofort Fieber mit kaltem Wasser/Eis senken

3 NACH DEM ANFALL

Der Anfall sistiert, das Kind ist postiktal schläfrig. Vorgehen?

(A) Stabile Seitenlage, Atemweg/SpO_2/Vitalzeichen, Temperatur, ärztliche Abklärung der Ursache, Eltern aufklären

(B) Kind sofort nach Hause, war ja nur Fieber

4 RED FLAGS

Worauf achtest du besonders?

(A) Nur die Temperatur dokumentieren

(B) Bewusstsein/Wiederholung, Nackensteife/Petechien (Meningitis ausschließen!), Atmung, Temperatur, Elternberatung

Fall 23 · Bellender Husten nachts

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Mia, 2 Jahre, nachts: bellender Husten, heisere Stimme, inspiratorischer Stridor in Ruhe, leichte Einziehungen, subfebril, ängstlich.

1 ERSTES VORGEHEN

Was ist sinnvoll?

A Kind flach hinlegen und Racheninspektion mit Spatel

B Ruhe bewahren, Kind aufrecht auf dem Arm der Eltern lassen, nicht aufregen, kühle/feuchte Luft, SpO_2/Atmung beobachten, Arzt

C Sofort unter Zwang mit kaltem Vernebler inhalieren

2 THERAPIE

Stridor in Ruhe – was ist Standard (AO)?

A Fiebersenker reicht aus

B Glukokortikoid (z. B. Dexamethason/Prednisolon) nach AO; bei schwerem Stridor vernebeltes Adrenalin

C Antibiotikum, weil Infektion

3 VERSCHLECHTERUNG

Zunehmender Stridor in Ruhe, stärkere Einziehungen, Blässe, Unruhe. Reaktion?

A Beruhigend einreden und weiter abwarten

B Vernebeltes Adrenalin nach AO, O_2, Kind ruhig lassen, sofort Arzt/Klinik, Monitoring

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

A Nur die Temperatur

B Stridor/Atemarbeit, SpO_2, Bewusstsein/Erschöpfung, nach Adrenalin Nachbeobachtung (Rebound), Eltern einbeziehen

Fall 24 · Atemnot beim Säugling

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Säugling, 4 Monate: seit 2 Tagen Schnupfen, jetzt Trinkschwäche, Tachypnoe, Nasenflügeln, Einziehungen, exspiratorisches Giemen, SpO_2 90 %.

1 ERSTES VORGEHEN

Was ist sinnvoll?

- A Sofort Antibiotikum, weil Infekt
- B Kind flach lagern und ein Beruhigungsmittel geben
- C Oberkörper leicht erhöht, Nase freihalten (absaugen), O_2 titrieren, Trinkmenge/Atmung beobachten, Arzt

2 FLÜSSIGKEIT

Trinkschwäche bei Tachypnoe. Was ist sinnvoll (AO)?

- A Kleine häufige Mahlzeiten / ggf. Sonden- oder i.v.-Flüssigkeit nach AO; Aspirationsrisiko beachten
- B Zwingen, große Mengen auf einmal zu trinken

3 VERSCHLECHTERUNG

Zunehmende Atemnot, SpO_2 86 %, Apnoe-Phasen. Reaktion?

- A O_2 erhöhen/Monitoring, sofort Arzt/Klinik, Apnoe-Überwachung, ggf. Atemunterstützung (High-Flow/CPAP)
- B Inhalieren und abwarten

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

- A Nur SpO_2 bis 100 % anstreben
- B SpO_2, Atemarbeit, Apnoe, Trinkmenge/Ausscheidung, Bewusstsein, Temperatur

Fall 25 · Erbrechen & Durchfall

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Emil, 14 Monate: seit 2 Tagen Erbrechen + wässrige Durchfälle. Trinkt wenig, eingesunkene Augen, trockene Schleimhäute, verlängerte Rekap-Zeit, wenige nasse Windeln, müde.

1 EINSCHÄTZUNG

Erste Maßnahme?

A Durchfall sofort mit Loperamid stoppen

B Hydratationszustand/Vitalzeichen erfassen, orale Rehydratationslösung (ORS) in kleinen Schlucken, Arzt, Bilanz (Windeln/Gewicht)

C Reines Wasser oder Saft/Cola in großen Mengen geben

2 ORS-VORGEHEN

Das Kind erbricht die erste größere Menge. Wie weiter (AO)?

A Aufgeben und nur abwarten

B ORS löffel-/schluckweise sehr häufig (kleine Mengen), Geduld; bei Versagen/Verschlechterung i.v.-Rehydratation

3 VERSCHLECHTERUNG

Zunehmend lethargisch, Rekap > 3 s, Tachykardie, kaum Urin (schwere Dehydratation/ Schock). Reaktion?

A Weiter nur ORS löffelweise

B i.v.-Zugang, Volumenbolus (Kristalloid) nach AO, Monitoring, Klinik/Intensiv, Elektrolyte/BZ

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

A Nur, ob es noch erbricht

B Vitalzeichen, Bewusstsein, Rekap-Zeit, Ausscheidung/Bilanz/Gewicht, Elektrolyte/BZ, Hautturgor

Fall 26 · Fieber mit Hautflecken

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Hanna, 5 Jahre: hohes Fieber, zunehmend schläfrig, Kopfschmerz, Nackensteife; jetzt rasch auftretende, nicht wegdrückbare petechiale Hautflecken, RR niedrig-normal, Rekap verlängert.

1 ERKENNEN

Was ist hier entscheidend?

A Notfall erkennen (V.a. Meningokokken-Sepsis/Meningitis), sofort Arzt/Notfallteam, Monitoring, i.v.-Zugang, isolieren

B Erst beobachten, ob sich die Flecken ausbreiten

C Fiebersenker geben und in 1 h neu beurteilen

2 ZEITKRITISCH

Was ist zeitkritisch (AO)?

A Erst Lumbalpunktion abwarten, vorher keine Antibiose

B Sofortige i.v.-Antibiose (so früh wie möglich) nach AO, Volumen, O_2, Klinik/Intensiv; Umgebungsprophylaxe bedenken

3 VERSCHLECHTERUNG

RR fällt weiter, Marmorierung, zunehmende Eintrübung (septischer Schock). Reaktion?

A Volumenboli nach AO, Vasopressor/Intensiv nach AO, Monitoring, Reanimationsbereitschaft

B Nur Antibiose, kein Volumen

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

A Kreislauf/MAP, Bewusstsein, Ausbreitung der Petechien, Diurese, Temperatur, neurologische Zeichen, Isolation/Schutz

B Nur die Temperatur

Fall 27 · Verschlucktes Kleinteil

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Paul, 1 Jahr, beim Spielen mit Kleinteilen: plötzlich heftiger Husten, dann Würgen, jetzt Atemnot mit Stridor; er hustet noch kräftig, ist aber sichtlich in Not.

1 EINSCHÄTZUNG

Das Kind hustet noch kräftig (effektiver Husten). Was tust du?

A Zum Weiterhusten ermutigen, NICHT auf den Rücken schlagen, beobachten, Hilfe rufen, bereit sein einzugreifen

B Sofort kräftig auf den Rücken schlagen

C Sofort blind mit den Fingern im Mund nach dem Objekt suchen

2 INEFFEKTIVER HUSTEN

Der Husten wird leise, das Kind bekommt kaum noch Luft (ineffektiver Husten), ist aber bei Bewusstsein. Vorgehen (Säugling/Kleinkind)?

A 5 Rückenschläge, dann 5 Thoraxkompressionen (Säugling) im Wechsel; bei größerem Kind ggf. Bauchstöße; Notruf

B Kräftige Bauchstöße (Heimlich) beim Säugling

3 BEWUSSTLOSIGKEIT

Das Kind wird bewusstlos. Reaktion?

A Weiter nur auf den Rücken klopfen

B Reanimation beginnen (Thoraxkompressionen); bei Beatmung Mund auf sichtbaren Fremdkörper prüfen; Notruf/Notfallteam

4 NACH ERFOLG

Der Fremdkörper löst sich / die Atmung kehrt zurück. Worauf achtest du?

A Kind nach Hause schicken, geht ja wieder

B Atmung/SpO_2, Bewusstsein, ärztliche Kontrolle (Restmaterial/Schleimhautschaden, ggf. Bronchoskopie), Eltern

Fall 28 · Fieber beim Kind

Routine · niedrig | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Lena, 4 J., hat 39,2 °C Fieber. Die Eltern sind besorgt am Bett. Du sollst Lena betreuen und beobachten.

1 KONTAKT

Wie gehst du auf Kind und Eltern zu?

- A Das Kind rasch festhalten und schnell durchmessen
- B Die Eltern hinausschicken
- C Ruhig und kindgerecht erklären, die Eltern einbeziehen, dann messen

2 MASSNAHMEN

Wie senkst du das Fieber unterstützend?

- A Warm zudecken, damit es schwitzt
- B Maßnahmen nach Anordnung, ausreichend trinken, Wadenwickel nur bei warmen Beinen
- C Das Kind kalt abduschen

3 BEOBACHTUNG

Worauf achtest du besonders?

- A Nichts weiter beobachten
- B Bewusstsein, Trinkverhalten, Atmung und Hautausschlag beobachten
- C Nur die Temperatur erneut messen

4 ABSCHLUSS

Wie schließt du ab?

- A Nur mündlich der Kollegin sagen
- B Eltern anleiten, Befund melden und dokumentieren

Anästhesie

7 Fälle

Fall 29 · Plötzlicher CO_2-Anstieg intraop.

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Intraoperativ unter Sevofluran: unerklärter $etCO_2$-Anstieg, Tachykardie, Masseterspasmus nach Succinylcholin, beginnender Temperaturanstieg, Azidose.

1 ERKENNEN

Erstes Vorgehen bei Verdacht auf maligne Hyperthermie?

A Erst die Temperatur abwarten, bevor etwas geändert wird

B Trigger sofort stoppen (volatile Anästhetika/Succinylcholin), Hilfe rufen, 100 % O_2 mit hohem Flow, Operateur informieren

C Narkose mit mehr Sevofluran vertiefen

2 SPEZIFISCHE THERAPIE

Was ist die spezifische Therapie (AO)?

A Betablocker gegen die Tachykardie

B Nur kühlen, Dantrolen ist nicht nötig

C Dantrolen schnellstmöglich (gewichtsadaptiert), Team zur Aufbereitung, weiter 100 % O_2/Hyperventilation

3 BEGLEITMASSNAHMEN

Während Dantrolen läuft – welche Begleitmaßnahmen?

A Aktiv kühlen, BGA/Elektrolyte, Hyperkaliämie und Azidose behandeln, Diurese fördern, Monitoring

B Nur die Temperatur senken, Labor ist unwichtig

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du danach?

A $etCO_2$, Temperatur, K^+/BGA, CK/Myoglobin (Rhabdomyolyse), Urin, Kreislauf; Intensivverlegung

B Nach Stabilisierung sofort auf Normalstation

Fall 30 · Stridor nach Extubation

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Direkt nach Extubation (flache Narkose): inspiratorischer Stridor, paradoxe Atembewegungen, rascher SpO_2-Abfall, keine effektive Beatmung möglich.

1 SOFORT

Erstes Vorgehen beim Laryngospasmus?

A Sofort erneut intubieren ohne weitere Maßnahmen

B Patienten zum tiefen Durchatmen auffordern

C 100 % O_2, Esmarch-Handgriff, kräftiger Masken-CPAP, Hilfe rufen, Reize (Sekret/Manipulation) beseitigen

2 PERSISTENZ

Der Spasmus persistiert, SpO_2 fällt weiter. Was ist indiziert (AO)?

A Weiter nur CPAP, abwarten

B Narkose vertiefen (z. B. Propofol) und/oder kleine Dosis Succinylcholin nach AO, weiter 100 % O_2/CPAP

3 NACH DEM DURCHBRECHEN

Der Spasmus löst sich, der Patient wird beatmet. Woran denkst du?

A Nichts weiter, ist ja vorbei

B Oxygenierung sichern und an Negativdruck-Lungenödem denken (nach starkem Sog), Auskultation, Monitoring

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du im Aufwachraum?

A SpO_2, Atemarbeit, Auskultation (Lungenödem?), Wachheit, Sekret, Re-Spasmus-Gefahr

B Nur SpO_2

Fall 31 · Regurgitation bei Einleitung

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Nicht-nüchterner Notfallpatient (Ileus): bei der Einleitung Regurgitation von Mageninhalt, Mageninhalt im Rachen, SpO_2 beginnt zu fallen.

1 SOFORT

Erstes Vorgehen bei beobachteter Regurgitation/Aspiration?

- A Sofort eine aufwändige Zusatzdiagnostik veranlassen
- B Kopftief-/Seitenlage, sofort absaugen, 100 % O_2, Atemweg mit Cuff sichern, Operateur/Hilfe
- C Erst kräftig mit der Maske beatmen, um die Sättigung zu halten

2 NACH ATEMWEGSSICHERUNG

Der Atemweg ist gesichert. Wie weiter (AO)?

- A Routinemäßig sofort Antibiotikum + Kortison für alle
- B Tracheobronchial absaugen, 100 % O_2, ggf. Bronchoskopie nach AO, Beatmung anpassen (PEEP), Monitoring

3 VERSCHLECHTERUNG

SpO_2 bleibt niedrig, steigende Beatmungsdrücke, Giemen. Reaktion?

- A O_2/PEEP optimieren, absaugen, Bronchospasmus nach AO behandeln, Intensiv
- B Beatmungsdruck einfach maximal erhöhen

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

- A Nur SpO_2
- B SpO_2, Beatmungsdrücke, Auskultation, Röntgen-Verlauf, Temperatur/Infektzeichen, Intensivüberwachung

Fall 32 · Symptome nach Regionalanästhesie

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Während/nach Regionalanästhesie mit hoher Lokalanästhetika-Dosis: periorale Taubheit, metallischer Geschmack, Ohrensausen, Unruhe, dann Muskelzuckungen, beginnende Herzrhythmusstörung.

1 ERKENNEN

Erstes Vorgehen bei Verdacht auf Lokalanästhetika-Intoxikation (LAST)?

A Injektion sofort stoppen, Hilfe rufen, 100 % O_2, Monitoring, auf Krampf/Arrhythmie vorbereiten

B Mehr Lokalanästhetikum, um die Wirkung zu sichern

C Erst abwarten, ob sich die Symptome von selbst legen

2 SPEZIFISCHE THERAPIE

Was ist die spezifische Therapie (AO)?

A Nur den Krampf behandeln, Lipid ist nicht nötig

B Lipidemulsion (20 %) als Bolus + Infusion nach Schema, Atemweg/O_2 sichern, Krampf durchbrechen (Benzodiazepin)

3 KREISLAUFSTILLSTAND

Es kommt zum (LAST-bedingten) Kreislaufstillstand. Was ist zu beachten?

A Hochdosiertes Standard-Adrenalin wie üblich

B Reanimation nach ALS, aber prolongiert (gute Prognose!), Lipidemulsion weiter, kleine Adrenalindosen, Amiodaron bei Bedarf

4 ÜBERWACHUNG

Nach ROSC – worauf achtest du?

A Nach Stabilisierung rasch entlassen

B Längere Intensivüberwachung (Rezidivgefahr!), Rhythmus/Kreislauf, Neurostatus, Lipid nach Schema, Auslöser dokumentieren

Fall 33 · Flache Atmung im Aufwachraum

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Im Aufwachraum nach Allgemeinanästhesie: Patient zunehmend somnolent, flache langsame Atmung (AF 6), SpO_2 88 %, enge Pupillen; intraoperativ Opioide.

1 ERSTES VORGEHEN

Erste Maßnahme bei postoperativer Atemdepression?

(A) Stimulieren/ansprechen, Atemweg freimachen, 100 % O_2, zur Atmung auffordern, Monitoring, Hilfe

(B) Patienten schlafen lassen, er ist nur müde

(C) Sofort hochdosiert Naloxon als großer Bolus

2 URSACHE/THERAPIE

Verdacht auf Opioidüberhang. Vorgehen (AO)?

(A) Naloxon titriert (kleine Schritte) nach AO, dabei O_2/Beatmung sichern; an Relaxansüberhang/andere Ursachen denken

(B) Nur O_2 geben, sonst nichts

3 DIFFERENZIAL

Nach Naloxon bessert sich die Atmung nur teilweise; der Patient ist schwach, kann den Kopf nicht halten. Verdacht?

(A) Sicher nur noch müde, abwarten

(B) Relaxansüberhang (Restkurarisierung) → TOF/Relaxometrie, ggf. Antagonisierung nach AO, weiter O_2/Beatmungsbereitschaft

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

(A) Nach kurzer Besserung sofort auf Station verlegen

(B) AF/SpO_2/Vigilanz, Re-Sedierung beachten (Naloxon kürzer wirksam als Opioid!), Muskelkraft/TOF, Schmerz, Kreislauf

Fall 34 · Kreislauf nach Spinalanästhesie

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Kurz nach Spinalanästhesie: RR fällt auf 80/45, Bradykardie 48/min, Übelkeit/Schwindel; die sensible Blockade steigt höher als erwartet.

1 ERSTES VORGEHEN

Erste Maßnahmen bei Hypotonie/Bradykardie nach Spinalanästhesie?

A Patienten aufsetzen, damit ihm nicht schwindelig wird

B Beine hoch / Linksseitenlage (bei Schwangeren!), O_2, Volumen nach AO, Vasopressor (z. B. Akrinor/Ephedrin/Noradrenalin) nach AO, Monitoring

C Erst abwarten, der Druck reguliert sich

2 BRADYKARDIE

Die Bradykardie nimmt zu (40/min) mit Hypotonie. Vorgehen (AO)?

A Atropin nach AO gegen die Bradykardie, Vasopressor/Volumen weiter, O_2, engmaschig Monitoring

B Nur weiter Volumen, Bradykardie ignorieren

3 AUFSTEIGENDE BLOCKADE

Der Patient klagt über Atemnot und Kribbeln in den Händen, die Blockade steigt weiter. Reaktion?

A Beruhigen und weiter beobachten

B Atemweg/O_2 sichern, Beatmungsbereitschaft (Atemmuskulatur!), Kreislauf weiter stützen, Anästhesist/Notfallteam, ggf. Intubation

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du?

A RR/HF, Atmung/SpO_2, Blockadehöhe/Sensomotorik, Bewusstsein, Übelkeit, Rückbildung der Blockade

B Nur den Blutdruck einmal messen

Fall 35 · Vorbereitung zur Narkose

Routine · niedrig | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Frau D., 60 J., soll heute operiert werden. Du bereitest sie für den OP vor.

1 IDENTITÄT

Wie startest du die Vorbereitung?

- A Nur nach dem Namen fragen
- B Identität sichern, Nüchternheit prüfen und kontrollieren, ob Aufklärung/Einwilligung vorliegen
- C Sie ohne Prüfung in den OP fahren

2 CHECKLISTE

Was gehört zur OP-Vorbereitung?

- A Schmuck darf drangelassen werden
- B Allergien nicht erfragen
- C Schmuck, Prothesen und Nagellack entfernen, OP-Hemd, Allergien erfragen

3 ANGST

Frau D. ist sehr ängstlich. Wie reagierst du?

- A Zuwenden, verständlich informieren, beruhigen, Prämedikation nur nach Anordnung
- B Das Thema übergehen
- C Ihr sagen, sie solle sich nicht so anstellen

4 ÜBERGABE

Wie schließt du die Vorbereitung ab?

- A Nur das Wichtigste mündlich nennen
- B Vollständige Übergabe an das OP-Team und sorgfältige Dokumentation

Psychiatrie

7 Fälle

Fall 36 · Hoffnungslosigkeit und Rückzug

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient auf Station wirkt zunehmend zurückgezogen, äußert Hoffnungslosigkeit ('Es hat alles keinen Sinn mehr') und zieht sich von Mitpatienten zurück. Du bist im Gespräch mit ihm.

1 HALTUNG

Wie reagierst du auf die Hoffnungslosigkeit?

A Aufmuntern ('So schlimm ist es doch nicht') und das Thema wechseln

B Ruhig, zugewandt, ernst nehmen, Zeit nehmen, offen und ohne Wertung nachfragen, wie es ihm geht

C Ihn allein lassen, damit er zur Ruhe kommt

2 OFFEN ANSPRECHEN

Wie gehst du mit dem Verdacht auf Suizidalität um?

A Suizidgedanken offen, einfühlsam und direkt ansprechen

B Das Thema meiden, um ihn nicht 'auf Ideen zu bringen'

3 SICHERHEIT

Er bejaht Suizidgedanken. Was ist jetzt wichtig?

A Bei ihm bleiben/Betreuung sicherstellen, Arzt/zuständiges Team umgehend informieren, für eine sichere Umgebung sorgen

B Ihm versprechen, dass es ein Geheimnis bleibt

4 WEITERES VORGEHEN

Wie geht es im Verlauf weiter?

A Nach dem ersten Gespräch wie gewohnt weiterarbeiten

B Engmaschige Betreuung nach Anordnung, sichere Umgebung, im Gespräch bleiben, Dokumentation, ärztliche Einschätzung/Therapieplanung umsetzen

Fall 37 · Angespannter, gereizter Patient

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein akut psychotischer Patient ist zunehmend angespannt, läuft auf und ab, spricht laut, fühlt sich bedroht und reagiert gereizt auf Ansprache. Andere Patienten werden unruhig.

1 ERSTE REAKTION

Wie gehst du auf den erregten Patienten zu?

(A) Ruhig und respektvoll, Distanz wahren, reizarme Umgebung schaffen, ruhige Stimme, Bedürfnisse erfragen (Deeskalation)

(B) Bestimmt und laut Grenzen setzen, ihn zur Ruhe ermahnen

(C) Ihn festhalten, damit er sich beruhigt

2 DEESKALATION

Womit deeskalierst du weiter?

(A) Über seine Wahninhalte diskutieren und sie widerlegen

(B) Zuhören, ernst nehmen, einfache klare Sätze, Wahlmöglichkeiten anbieten, Sicherheit signalisieren, Fluchtweg/ Eigenschutz beachten

3 SICHERHEIT/TEAM

Die Erregung bleibt hoch, eine Gefährdung ist möglich. Vorgehen?

(A) Team hinzuziehen, Eigen- und Fremdschutz sichern, Arzt informieren, Medikation nach AO anbieten, weiter deeskalieren

(B) Allein mit ihm im Raum bleiben und weiter reden

4 LETZTES MITTEL / RECHT

Wenn freiwillige Maßnahmen nicht ausreichen und akute Gefahr besteht – was gilt?

(A) Eigenständig fixieren, ohne weitere Formalitäten

(B) Freiheitsentziehende Maßnahmen nur als letztes Mittel bei akuter Gefahr, ärztliche Anordnung, rechtliche Voraussetzungen (Unterbringungsrecht/PsychKG), engmaschige Überwachung und Dokumentation

Fall 38 · Getriebene, rastlose Patientin

subakut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine Patientin in manischer Episode ist getrieben, redet ununterbrochen, schläft kaum, hat überschießende Pläne, kaum Krankheitseinsicht, gibt viel Geld aus, überschätzt sich und reagiert gereizt auf Grenzen.

1 HALTUNG

Wie begegnest du ihr?

A Mit strengen Verboten und Konfrontation Grenzen setzen

B Ruhig, wertschätzend, klare einfache Struktur, reizarme Umgebung, Beziehung halten, nicht provozieren

C Auf alle Pläne enthusiastisch eingehen und sie bestärken

2 SCHUTZ/STRUKTUR

Worauf achtest du im Alltag?

A Reizarme Umgebung, Tagesstruktur, Schlaf fördern, vor riskanten Folgen schützen (z. B. finanzielle/soziale Selbstgefährdung), Essen/Trinken anbieten

B Ihr volle Freiheit lassen, sie weiß schon, was sie tut

3 KÖRPERLICHES

Sie isst/trinkt kaum und ist ständig in Bewegung. Risiko?

A Auf Erschöpfung, Dehydratation und Mangelernährung achten, Vitalzeichen/Allgemeinzustand beobachten, Grundbedürfnisse anbieten, Arzt informieren

B Nur das Verhalten beobachten, Körperliches ist hier nebensächlich

4 THERAPIE/RECHT

Sie lehnt Medikamente und Klinik ab, gefährdet sich aber. Vorgehen?

A Medikamente heimlich untermischen

B Beziehung/Motivation, Medikation nach AO anbieten; bei akuter Selbst-/Fremdgefährdung ärztliche Einschätzung, ggf. Unterbringungsrecht (PsychKG) als letztes Mittel, Schutz und Dokumentation

Fall 39 · Tremor und Unruhe ohne Alkohol

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient (bekannte Alkoholabhängigkeit), seit etwa 1 Tag ohne Alkohol: Tremor, Schwitzen, Unruhe, Tachykardie, leicht erhöhter Blutdruck, Übelkeit; er ist ängstlich-gereizt.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du die Symptome ein und reagierst zuerst?

(A) Symptome als reine Nervosität abtun

(B) Alkoholentzugssyndrom erkennen, ruhig zuwenden, Vitalzeichen, Schweregrad einschätzen (z. B. Skala), Arzt informieren

(C) Ihm Alkohol geben, damit es ihm besser geht

2 THERAPIE/PROPHYLAXE

Was ist Teil der Behandlung (AO)?

(A) Nur abwarten, das geht von allein vorbei

(B) Medikamentöse Entzugsbehandlung nach Schema (z. B. Benzodiazepine), Thiamin (Vitamin B1) zur Wernicke-Prophylaxe, Flüssigkeit/Elektrolyte, engmaschige Überwachung

3 KOMPLIKATIONEN

Worauf achtest du, um Komplikationen früh zu erkennen?

(A) Nur den Tremor beobachten

(B) Auf Delirzeichen (Desorientierung, Halluzinationen, starke vegetative Entgleisung) und Krampfanfälle achten, Vitalzeichen/Bewusstsein engmaschig, reizarme sichere Umgebung, Sturz-/Eigenschutz

4 ÜBERWACHUNG

Wie gestaltest du die Betreuung?

(A) Nach Symptomlinderung die Überwachung beenden

(B) Engmaschige Überwachung (Skala/Vitalzeichen), ruhige reizarme Umgebung, Orientierung geben, Flüssigkeit/Ernährung, Medikation nach Schema, Dokumentation; bei Verschlechterung Arzt/Intensiv

Fall 40 · Plötzliche Atemnot und Todesangst

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine Patientin bekommt plötzlich Herzrasen, Atemnot, Engegefühl in der Brust, Kribbeln in den Händen, Schwindel und Todesangst ('Ich bekomme keine Luft, ich glaube, ich sterbe'); sie hyperventiliert.

1 ERSTE REAKTION

Wie reagierst du?

A Ruhig und präsent bleiben, beruhigend ansprechen, bei ihr bleiben, Sicherheit vermitteln, langsames Atmen anleiten

B Hektisch viele Geräte anschließen und Aufregung zeigen

C Ihr sagen, sie solle sich zusammenreißen, es sei nichts

2 SOMATIK BEDENKEN

Woran denkst du trotz wahrscheinlicher Panikattacke?

A Bedrohliche körperliche Ursachen im Blick behalten (z. B. Herz/Atmung), Vitalzeichen/SpO_2 prüfen, im Zweifel ärztlich abklären lassen

B Sicher nur psychisch, eine körperliche Abklärung ist überflüssig

3 ATEMFÜHRUNG

Sie hyperventiliert weiter. Wie hilfst du?

A Ruhig langsames Atmen vormachen/anleiten, Aufmerksamkeit lenken, beruhigen, bei ihr bleiben (kein Druck)

B Sie auffordern, kräftig und schnell weiterzuatmen

4 NACHSORGE

Die Attacke klingt ab. Was ist sinnvoll?

A Da bleiben, Erlebtes besprechen/normalisieren, über Panikattacken aufklären, Auslöser/Hilfe thematisieren, Behandlungsteam einbeziehen, dokumentieren

B Sofort allein lassen, ist ja vorbei

Fall 41 · Fieber und Rigor unter Neuroleptika

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient unter Neuroleptika (kürzlich Dosissteigerung) entwickelt hohes Fieber, ausgeprägte Muskelsteifigkeit (Rigor), Bewusstseinstrübung, Schwitzen, Tachykardie und schwankenden Blutdruck.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Verdacht auf malignes neuroleptisches Syndrom (MNS), Notfall: Vitalzeichen, Arzt/Hilfe sofort, Monitoring, an Absetzen des Neuroleptikums denken

(B) Die Neuroleptika-Dosis weiter erhöhen

(C) Fieber als Infekt behandeln und abwarten

2 SOFORTMASSNAHMEN

Was ist jetzt wichtig (AO)?

(A) Nur fiebersenkende Tabletten geben

(B) Auslösendes Neuroleptikum absetzen (nach AO), Vitalfunktionen sichern, kühlen, Flüssigkeit/Elektrolyte, engmaschiges Monitoring, Intensiv vorbereiten

3 KOMPLIKATIONEN

Worauf achtest du wegen drohender Komplikationen?

(A) Komplikationen sind unwahrscheinlich, nur Temperatur messen

(B) Auf Rhabdomyolyse/Nierenversagen (CK, dunkler Urin), Elektrolytentgleisung, Kreislauf-/Atemkomplikationen achten, Bilanz, Labor nach AO

4 ÜBERWACHUNG

Wie geht es weiter?

(A) Intensivüberwachung, Vitalzeichen/Bewusstsein, Temperatur, CK/Niere/Elektrolyte, Flüssigkeit, weitere Therapie nach AO, Dokumentation

(B) Nach erster Fiebersenkung zurück auf Normalstation

Fall 42 · Das erste Gespräch

Routine · niedrig | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Herr A., 35 J., ist zurückgezogen und antriebslos. Du sollst eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen und ihn begleiten.

1 KONTAKT

Wie nimmst du Kontakt auf?

- A) Ihn betont fröhlich aufmuntern und zum Reden drängen
- B) Ruhig und wertschätzend Kontakt anbieten, Zeit geben und zuhören
- C) Ihn einfach in Ruhe lassen und nicht ansprechen

2 BEOBACHTUNG

Worauf achtest du im Verlauf?

- A) Gar nichts beobachten
- B) Stimmung, Antrieb, Tagesstruktur sowie Essen und Trinken beobachten
- C) Nur darauf, ob er am Programm teilnimmt

3 TEAM

Im Gespräch deutet er Hoffnungslosigkeit an. Was tust du?

- A) Ihm versprechen, es für dich zu behalten
- B) Das Thema schnell wechseln
- C) Ihn ernst nehmen, zuhören und die Beobachtung umgehend im Team / an die Fachkraft weitergeben

4 BEGLEITUNG

Wie unterstützt du weiter?

- A) Tagesstruktur fördern, verlässlich da sein und dokumentieren
- B) Ihn sich selbst überlassen

Pflegegrundlagen

8 Fälle

Fall 43 · Wundliegen vorbeugen

Grundlagen · 1. Ausbildungsjahr

Frau Klein (84) ist nach einem Sturz bettlägerig, kann sich kaum selbst bewegen und liegt viel auf dem Rücken. Die Haut am Gesäß ist an einer Stelle gerötet.

1 BEOBACHTEN

Du entdeckst die Rötung am Steiß. Wie prüfst du, ob ein Dekubitus droht?

(A) Fingertest: kurz auf die Rötung drücken – wird sie weiß (wegdrückbar) oder bleibt sie rot? Hautstelle dokumentieren und melden

(B) Die Stelle kräftig massieren, um die Durchblutung anzuregen

(C) Erstmal abwarten, Rötungen verschwinden meist von allein

2 VORBEUGEN

Was ist die wichtigste vorbeugende Maßnahme?

(A) Regelmäßige Druckentlastung: Position nach Plan wechseln, Druckstellen frei lagern, Haut pflegen und trocken halten

(B) Ein dickes Kissen genau punktuell unter die gerötete Stelle legen

3 RESSOURCEN FÖRDERN

Frau Klein kann sich ein wenig mitbewegen. Wie gehst du vor?

(A) Ihr alles abnehmen, sie soll sich gar nicht anstrengen

(B) Eigenbewegung fördern, zu kleinen Lagewechseln anleiten, Bewegung in den Alltag einbauen, Maßnahmen dokumentieren

Fall 44 · Sicher auf den Beinen

Grundlagen | 1. Ausbildungsjahr

Herr Berg (78) ist nach einem Infekt geschwächt, etwas unsicher beim Gehen und möchte nachts allein zur Toilette. Der Boden ist teils mit Kabeln und einem Teppich belegt.

1 EINSCHÄTZEN

Wie schätzt du das Sturzrisiko ein und reagierst?

A Risiko erkennen (Schwäche, Unsicherheit, nächtlicher Toilettengang), Umfeld sichern, Maßnahmen mit ihm besprechen, im Team melden/dokumentieren

B Nichts tun, er ist erwachsen und entscheidet selbst

C Ein Bettgitter hochziehen und ihn nachts 'im Bett halten'

2 UMFELD SICHERN

Was ist eine sinnvolle Maßnahme?

A Den Toilettengang verbieten und einen Dauerkatheter vorschlagen

B Stolperfallen beseitigen (Kabel/Teppich), Nachtlicht, Rufanlage in Reichweite, Gehhilfe bereitstellen, Weg frei halten

3 BEGLEITEN

Nachts klingelt er, um zur Toilette zu gehen. Wie gehst du vor?

A Sagen, er soll schnell allein gehen, du hast keine Zeit

B Zeitnah kommen, beim Aufstehen/Gehen begleiten, Tempo anpassen, festes Schuhwerk/Gehhilfe nutzen, Selbstständigkeit fördern

Fall 45 · Werte deuten und melden

Grundlagen · 1. Ausbildungsjahr

Bei der Routinekontrolle von Frau Sander (70, 2. Tag nach OP) misst du: Temperatur 38,9 °C, Puls 104/min. Sie wirkt matt und klagt über Unwohlsein.

1 BEOBACHTEN

Wie gehst du mit dem auffälligen Wert um?

A Den Wert ignorieren, eine einzelne Messung sagt nichts aus

B Werte vollständig erfassen (Temp, Puls, RR, Atmung, ggf. SpO_2), Allgemeinzustand beobachten, dokumentieren und zeitnah an Pflegefachkraft/Arzt melden

C Eigenmächtig ein fiebersenkendes Medikament aus dem Schrank geben

2 MELDEN

Was gehört zu einer guten Weitergabe?

A Strukturiert melden: wer/was/seit wann, gemessene Werte, Allgemeinzustand, Auffälligkeiten – sachlich und vollständig

B Nur kurz 'der geht's nicht gut' sagen, ohne Werte

3 ÜBERWACHEN

Bis zur ärztlichen Anordnung – wie verhältst du dich?

A Patientin im Blick behalten, Werte nach Vorgabe erneut kontrollieren, auf Verschlechterung achten, für Wohlbefinden sorgen, dokumentieren

B Dich anderem zuwenden und nicht mehr nachschauen

Fall 46 · Ankommen und Vertrauen schaffen

Grundlagen · 1. Ausbildungsjahr

Frau Yilmaz (68) wird zur geplanten OP aufgenommen. Sie wirkt angespannt, spricht leise, hat viele Fragen und schämt sich, dass sie Hilfe braucht.

1 BEGEGNUNG

Wie gestaltest du das Aufnahmegespräch?

A Schnell die Checkliste abarbeiten und Fragen abwürgen, du hast viel zu tun

B Sich vorstellen, freundlich zugewandt sein, Zeit nehmen, aktiv zuhören, in verständlicher Sprache erklären, Fragen ernst nehmen

C Über ihren Kopf hinweg mit den Angehörigen reden statt mit ihr

2 VERSTÄNDNIS SICHERN

Sie versteht einen Fachbegriff nicht. Wie reagierst du?

A In einfacher Sprache erklären, nachfragen ob es verständlich war, bei Sprachbarriere Hilfen anbieten (z. B. Dolmetscher nach Möglichkeit)

B Den Begriff genauso wiederholen, nur lauter

3 WÜRDE

Sie schämt sich, dass sie beim Umziehen Hilfe braucht. Wie gehst du vor?

A Verständnis zeigen, Intimsphäre wahren (Sichtschutz, ruhig erklären), Selbstständigkeit fördern, nur so viel helfen wie nötig

B Es als 'nicht so schlimm' abtun und einfach loslegen

Fall 47 · Körperpflege mit Würde

Grundlagen · 1. Ausbildungsjahr

Du unterstützt Herrn Os (80) bei der morgendlichen Körperpflege. Gesicht und Arme kann er selbst waschen, am Rücken und an den Beinen braucht er Hilfe.

1 HALTUNG

Wie gehst du die Körperpflege an?

(A) Ressourcen nutzen: ihn selbst waschen lassen, was er kann; nur unterstützen, wo nötig; vorher erklären und Einverständnis einholen

(B) Bei offener Tür und ohne Vorankündigung loslegen

(C) Alles komplett übernehmen, das geht schneller

2 INTIMSPHÄRE

Worauf achtest du während der Pflege?

(A) Ihn länger unbedeckt liegen lassen und nebenbei mit Kollegen plaudern

(B) Sichtschutz, nur den Bereich freilegen, der gewaschen wird, angenehme Wassertemperatur, Privatsphäre schützen, Hautzustand beobachten

3 BEOBACHTEN

Beim Waschen fällt dir eine gerötete Hautstelle am Rücken auf. Wie reagierst du?

(A) Hautstelle beobachten/dokumentieren, melden, auf Druckentlastung achten, Pflege schonend fortsetzen

(B) Nichts sagen, das ist sicher nichts

Fall 48 · Atmen nach der OP

Grundlagen | 1. Ausbildungsjahr

Frau Lang (72) liegt nach einer Bauch-OP im Bett. Wegen Schmerzen atmet sie flach, hustet kaum und möchte nur liegen bleiben.

1 RISIKO ERKENNEN

Warum ist das ein Problem und was tust du?

A Ihr eigenmächtig ein Hustenmittel geben, damit Ruhe ist

B Sie liegen und flach atmen lassen, Schonung ist am besten

C Pneumoniegefahr erkennen (flache Atmung, wenig Husten, Immobilität) – Atmung fördern: aufrechte Position, zu tiefem Atmen anregen, Schmerz ansprechen/melden

2 MASSNAHMEN

Welche Maßnahme fördert die Belüftung der Lunge?

A Oberkörper hoch/aufsetzen, tiefe Atemzüge und Abhusten anleiten, Atemübung/Hilfsmittel nach Vorgabe, regelmäßig mobilisieren

B Sie flach hinlegen und die Decke fest bis zum Hals ziehen

3 SCHMERZ & MOBILISATION

Sie traut sich wegen Schmerzen nicht zu husten oder zu bewegen. Wie hilfst du?

A Ihr sagen, sie soll sich zusammenreißen

B Schmerz ernst nehmen und melden (Therapie nach AO), Wunde beim Abhusten stützen lassen, schrittweise mobilisieren, motivieren

Fall 49 · Genug trinken im Alter

Grundlagen · 1. Ausbildungsjahr

Frau Vogt (86) im Pflegeheim wirkt müder als sonst, ihre Lippen sind trocken, die Haut steht in einer Falte kurz 'stehen', und sie hat heute kaum etwas getrunken.

1 BEOBACHTEN

Welche Zeichen deuten auf Flüssigkeitsmangel und wie reagierst du?

(A) Exsikkose-Zeichen erkennen (trockene Schleimhäute, stehende Hautfalte, Müdigkeit, wenig Trinken), Trinken anbieten, Ein-/Ausfuhr im Blick, melden/dokumentieren

(B) Davon ausgehen, dass alte Menschen eben wenig brauchen

(C) Abwarten, vielleicht trinkt sie später von allein

2 TRINKEN FÖRDERN

Wie förderst du, dass sie mehr trinkt?

(A) Sie zwingen, schnell einen Liter auf einmal zu trinken

(B) Lieblingsgetränke in Reichweite, regelmäßig kleine Mengen anbieten und erinnern, beim Trinken helfen, Trinkmenge erfassen

3 MELDEN

Trotz Angebot trinkt sie weiterhin sehr wenig und wird zunehmend matt. Wie gehst du vor?

(A) Es bei dir behalten und nichts melden

(B) An Pflegefachkraft/Arzt melden, Beobachtungen dokumentieren, weiter Trinken anbieten, auf Verschlechterung achten

Fall 50 · Wenn der Appetit fehlt

Grundlagen · 1. Ausbildungsjahr

Herr Frey (79) lässt seit Tagen viel auf dem Teller liegen, hat an Gewicht verloren und sagt, das Essen schmecke ihm nicht und das Kauen falle schwer.

1 BEOBACHTEN

Wie gehst du mit den Hinweisen auf Mangelernährung um?

A Ihn drängen, den Teller schnell leer zu essen

B Den vollen Teller einfach kommentarlos abräumen

C Warnzeichen erkennen (wenig Essen, Gewichtsverlust, Kauprobleme), Essmenge/Gewicht beobachten und dokumentieren, Ursachen ansprechen, melden

2 ANPASSEN

Was hilft konkret bei fehlendem Appetit und Kauproblemen?

A Wünsche/Vorlieben berücksichtigen, Konsistenz anpassen (z. B. weiche Kost), kleine appetitliche Portionen, in Ruhe und aufrecht essen, ggf. Hilfsmittel

B Immer dasselbe in großer Menge servieren

3 MELDEN & BEGLEITEN

Trotzdem isst er weiter wenig und nimmt ab. Wie gehst du vor?

A Es als 'Alter' hinnehmen und nichts weiter tun

B An Pflegefachkraft/Arzt melden, Essprotokoll/Gewicht dokumentieren, weitere Maßnahmen nach Vorgabe, weiter unterstützen

Neurologie

7 Fälle

Fall 51 · Plötzliche Halbseitensymptomatik

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient zeigt plötzlich eine hängende Mundpartie, einseitige Armschwäche und verwaschene Sprache. Symptombeginn vor ca. 40 Minuten.

1 ERKENNEN

Wie reagierst du zuerst?

A Erst abwarten, ob sich die Symptome von selbst bessern

B FAST erkennen (Face/Arm/Speech/Time), sofort Stroke-Unit/Notfall alarmieren, genauen Symptombeginn (Zeitfenster!) feststellen, Vitalzeichen, nüchtern lassen

C Dem Patienten zur Beruhigung etwas zu trinken geben

2 DIAGNOSTIK

Was ist jetzt wichtig (AO)?

A Rasch CT/Bildgebung (Blutung vs. Ischämie), BZ messen, Vitalzeichen/SpO_2, i.v.-Zugang, auf Lyse/Thrombektomie vorbereiten

B Sofort den Blutdruck stark senken

3 SCHLUCKEN & LAGERUNG

Worauf achtest du in der Pflege?

A Flach lagern und normal Essen anbieten

B Nüchtern bis zum Schluck-Screening, Oberkörper ~30°, SpO_2/O_2 nach AO, engmaschiger Neurostatus, Aspirations- und Sturzschutz

4 ÜBERWACHUNG

Worauf achtest du im Verlauf?

A Nur einmal den Blutdruck messen

B Neurostatus, Vitalzeichen/BZ, SpO_2, Schluckfunktion, auf Verschlechterung (Einblutung/Hirndruck) achten, Zeitprotokoll führen

Fall 52 · Anhaltender Krampfanfall

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient krampft generalisiert tonisch-klonisch; der Anfall dauert bereits über 5 Minuten an und sistiert nicht.

1 SOFORTMASSNAHMEN

Erstes Vorgehen beim anhaltenden Krampfanfall?

(A) Patient vor Verletzung schützen, nichts in den Mund, soweit möglich Seitenlage, Atemweg/O_2, Dauer messen, Hilfe rufen

(B) Erst abwarten, Anfälle hören meist von allein auf

(C) Den Patienten festhalten und die Zunge mit einem Spatel sichern

2 THERAPIE

Vorgehen (AO)?

(A) Benzodiazepin nach Notfallschema/AO, BZ messen, i.v.-Zugang, O_2, Monitoring, Reanimationsbereitschaft

(B) Sofort hochdosiert mehrere Medikamente gleichzeitig geben

3 NACH DEM ANFALL

Der Anfall sistiert. Worauf achtest du?

(A) Sofort mobilisieren und Essen anbieten

(B) Atemweg/Atmung/SpO_2 (postiktale/medikamentöse Atemdepression), Seitenlage, BZ/Vitalzeichen, Ursache abklären, auf erneuten Anfall vorbereitet sein

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Vigilanz/Atmung/SpO_2/BZ überwachen, auf erneuten Anfall achten, Auslöser/Antikonvulsiva nach AO, Dokumentation, Sturzschutz

(B) Die Überwachung sofort beenden

Fall 53 · Vernichtungskopfschmerz

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient klagt über einen plötzlichen, noch nie erlebten 'Vernichtungskopfschmerz' (Donnerschlag), dazu Übelkeit, Nackensteife und Lichtscheu.

1 ERKENNEN

Erstes Vorgehen?

(A) An Subarachnoidalblutung denken (Donnerschlagkopfschmerz!), sofort Arzt/Notfall, Vitalzeichen/Bewusstsein, Ruhe und Reizabschirmung

(B) Als gewöhnliche Migräne einordnen, Schmerzmittel geben und abwarten

2 DIAGNOSTIK

Wie weiter (AO)?

(A) Rasche Bildgebung (CT), Vitalzeichen/Neurostatus, Blutdruckmanagement nach AO, reizarme Umgebung, Monitoring

(B) Den Patienten mobilisieren und Pressen/Anstrengung erlauben

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Strenge Ruhe, Reizabschirmung (Licht/Lärm), Oberkörper leicht hoch, Blutdruck-/Neuromonitoring, Stuhlregulierung (Pressen vermeiden), auf Vigilanzabfall achten

(B) Helles Licht und Aktivierung zur Orientierung

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Engmaschig Bewusstsein/Pupillen/Vitalzeichen, auf Nachblutung/Hirndruck/Vasospasmus achten, Bilanz, Intensivüberwachung

(B) Nur den Schmerz dokumentieren

Fall 54 · Eintrübung mit weiter Pupille

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient mit bekannter intrakranieller Raumforderung wird zunehmend somnolent, klagt über Kopfschmerz und Erbrechen; eine Pupille wird weiter, der Blutdruck steigt, der Puls wird langsam.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Zeichen erhöhten Hirndrucks/drohender Einklemmung (Vigilanzabfall, weite Pupille, Cushing-Reflex: RR hoch/Puls langsam) – Notfall, sofort Arzt, Vitalzeichen/Pupillen, Oberkörper ~30° (Kopf gerade)

(B) Als Müdigkeit deuten und schlafen lassen

2 MASSNAHMEN

Was ist wichtig (AO)?

(A) Kopf tief und flach lagern

(B) Oberkörper ~30° hoch, Kopf in Mittelstellung (venösen Abfluss sichern), O_2/Atemweg, hirndrucksteigernde Faktoren meiden, Bildgebung/Intensiv, Medikamente nach AO

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Den Patienten kräftig stimulieren und ohne Schutz absaugen

(B) Engmaschig Bewusstsein (GCS)/Pupillen/Vitalzeichen, hirndrucksteigernde Faktoren minimieren (Pressen, Husten, Schmerz, Abknicken des Halses), reizarm, O_2/Normoventilation nach AO

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Kontinuierlich GCS/Pupillen/Vitalzeichen, auf weitere Verschlechterung/Einklemmung achten, Intensiv, Dokumentation, Arzt sofort bei Veränderung

(B) Nur stündlich den Blutdruck messen

Fall 55 · Zunehmende Muskelschwäche

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Eine Patientin mit Myasthenia gravis ist zunehmend geschwächt, hat Schluckbeschwerden, eine schwache, näselnde Sprache, Doppelbilder und zunehmende Atemnot.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Zur Stärkung erst eine größere Mahlzeit anbieten

B Verdacht auf myasthene Krise (zunehmende Muskel-/Atemschwäche): Atmung/SpO_2/Schlucken beobachten, Arzt sofort, Aspiration vermeiden (nüchtern bei Schluckstörung), Beatmungsbereitschaft

2 ATMUNG ÜBERWACHEN

Worauf liegt der Fokus (AO)?

A Atemfunktion engmaschig (Atemfrequenz, SpO_2, Vitalkapazität), Zeichen der respiratorischen Erschöpfung erkennen, O_2/Beatmungsbereitschaft, Intensiv, Medikation nach AO

B Nur einmal die SpO_2 messen und die Patientin allein lassen

3 PFLEGE

Worauf achtest du noch?

A Aspirationsschutz (Schluckstörung!), Oberkörper hoch, Kräfte schonen (Belastung dosieren), Kommunikation sichern, Medikamente exakt nach AO, auf Verschlechterung achten

B Zur Mobilisation maximal fordern

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Atmung/SpO_2/Vitalkapazität/Schlucken engmaschig, Beatmungsbereitschaft, Medikation nach AO, Intensiv, Dokumentation

B Überwachung reduzieren, sobald es etwas besser wirkt

Fall 56 · Rückenschmerz mit Taubheit

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein Patient mit starken Rückenschmerzen berichtet neu über Taubheit im Reithosenbereich (Damm/Innenseite Oberschenkel), Schwäche in den Beinen und kann seit Stunden kein Wasser mehr lassen.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Als gewöhnliche Rückenschmerzen mit Schonung und Schmerzmittel abtun

B Red Flags für ein Cauda-equina-Syndrom (Reithosenanästhesie, Blasenentleerungsstörung, Beinschwäche) – neurochirurgischer Notfall, sofort Arzt, Neurostatus, nicht abwarten

2 DIAGNOSTIK

Wie weiter (AO)?

A Erst einige Tage konservativ abwarten

B Dringende Bildgebung (MRT), neurologische Befunde dokumentieren (Sensibilität/Kraft/Blase-Mastdarm), Blasenfunktion prüfen (Restharn), rasche neurochirurgische Vorstellung

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Neurostatus engmaschig (Zunahme der Ausfälle?), Blasenfunktion/Restharn beobachten (ggf. Katheter nach AO), Schmerzmanagement, OP-Vorbereitung, Haut-/Dekubitus- und Sturzschutz

B Nur Schmerzmittel geben, die neurologischen Zeichen sind nebensächlich

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Engmaschig Sensibilität/Kraft/Blase-Mastdarm, auf Zunahme achten, OP-Vorbereitung/Dringlichkeit, Dokumentation, Arzt bei Verschlechterung

B Abwarten bis zur Routinevisite

Fall 57 · Sturzgefahr nach Schlaganfall

Routine · mittel | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Herr B., 68 J., nach Schlaganfall halbseitig geschwächt, möchte allein zur Toilette aufstehen. Du bist im Zimmer.

1 SOFORTREAKTION

Wie reagierst du?

A) Ihn allein gehen lassen, er kennt sich ja

B) Ihn vorsichtshalber im Bett festbinden

C) Hilfe anbieten, ihn nicht allein aufstehen lassen, Klingel in Reichweite legen

2 TRANSFER

Wie unterstützt du den Toilettengang?

A) Ihn auf Socken laufen lassen

B) Zu zweit oder mit Hilfsmittel, betroffene Seite sichern, festes Schuhwerk

C) Ihn schnell allein ziehen, geht schon

3 BEOBACHTUNG

Worauf achtest du bei ihm?

A) Nur die Gehstrecke notieren

B) Nichts beobachten

C) Orientierung, Sprache und Schluckvermögen beobachten und Auffälligkeiten melden

4 UMGEBUNG

Wie sicherst du die Umgebung?

A) Nur die Bremsen am Bett prüfen

B) Hindernisse entfernen, Licht an, Klingel erreichbar, dokumentieren

Onkologie

7 Fälle

Fall 58 · Fieber unter Chemotherapie

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient unter Chemotherapie (bekannte Neutropenie) bekommt Fieber 38,8 °C und Schüttelfrost; lokale Entzündungszeichen fehlen weitgehend.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Fieber bei Neutropenie = onkologischer Notfall: sofort Arzt, Vitalzeichen, Blutkulturen vor Antibiose nach AO, auf Sepsis achten

(B) Erst Fieber senken und bis zur nächsten Visite abwarten

2 THERAPIE

Was ist entscheidend (AO)?

(A) Auf das Ergebnis der Blutkultur warten, bevor Antibiotika gegeben werden

(B) Rasche kalkulierte Antibiotikagabe nach AO (zeitnah!), Blutkulturen/Fokussuche vorher nach AO, Volumen/Kreislauf, engmaschiges Monitoring

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Strenge Hygiene/Schutzisolation, Vitalzeichen engmaschig (Sepsiszeichen!), Infektionsquellen meiden, Bilanz, Temperatur, Patienten beobachten

(B) Besuch und gemeinsame Sanitärnutzung wie üblich erlauben

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nach erster Fiebersenkung die Überwachung beenden

(B) Vitalzeichen/Temperatur engmaschig, auf Sepsis/Schock achten, Antibiose/Diagnostik nach AO, Bilanz, Intensiv bei Verschlechterung, Dokumentation

Fall 59 · Entgleisung nach Chemo-Start

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Kurz nach Beginn einer Chemotherapie (großer, rasch wachsender Tumor) wird der Patient zunehmend unwohl; im Labor stark erhöhtes Kalium, Phosphat und Harnsäure, erniedrigtes Kalzium, die Urinausscheidung sinkt.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Als harmlose Begleiterscheinung der Chemo werten und abwarten

B Verdacht auf Tumorlyse-Syndrom (Zellzerfall: Hyperkaliämie/-phosphatämie/-urikämie, Hypokalzämie, Nierengefahr) – Arzt sofort, Monitoring (EKG!), Bilanz, Vitalzeichen

2 THERAPIE

Was ist wichtig (AO)?

A Die Trinkmenge/Infusion reduzieren, um die Niere zu 'schonen'

B Ausreichende Hydrierung nach AO, Elektrolyte engmaschig, Hyperkaliämie behandeln nach AO, EKG-Monitoring, harnsäuresenkende Therapie nach AO, Bilanz/Nierenfunktion

3 PFLEGE

Worauf achtest du besonders?

A EKG/Herzrhythmus (Hyperkaliämie!), Vitalzeichen, Ein-/Ausfuhr und Nierenfunktion, Elektrolytkontrollen nach AO, auf Herzrhythmusstörungen/Tetanie achten

B Nur die Temperatur kontrollieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Engmaschig Elektrolyte/EKG/Nierenwerte/Bilanz, auf Verschlechterung achten, Therapie nach AO, ggf. Intensiv/Dialyse-Bereitschaft, Dokumentation

B Nach erster Besserung die Kontrollen einstellen

Fall 60 · Gestaute Halsvenen, Atemnot

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein Patient mit bekanntem Thoraxtumor entwickelt eine zunehmende Schwellung von Gesicht und Hals, gestaute Halsvenen, Atemnot und ein Druckgefühl im Kopf, verstärkt im Liegen.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Den Patienten flach hinlegen, damit der Kreislauf stabil bleibt

(B) Verdacht auf obere Einflussstauung (Tumor komprimiert die V. cava superior) – Arzt informieren, Oberkörper hochlagern, O_2 nach AO, Atmung/Vitalzeichen, beruhigen

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Zugang/Blutdruckmessung am betroffenen, gestauten Arm anlegen

(B) Oberkörper hoch, O_2 nach AO, Atmung/SpO_2 überwachen, rasche Bildgebung/onkologische Therapieplanung nach AO, ruhige Umgebung, Medikamente nach AO

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Atmung/SpO_2 engmaschig, Oberkörper hoch, auf zunehmende Atemnot/Schwellung achten, Angst reduzieren, Zugänge eher untere Extremität/nach AO, Verlauf dokumentieren

(B) Zur Mobilisation flach lagern und Anstrengung fördern

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nur einmal die SpO_2 messen

(B) Atmung/SpO_2/Schwellung/Bewusstsein überwachen, auf Atemwegsverlegung/Hirndruckzeichen achten, Therapie nach AO, Intensiv bei Verschlechterung, Dokumentation

Fall 61 · Verwirrt und exsikkiert

subakut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine Patientin mit fortgeschrittenem Tumor wird zunehmend müde, verwirrt, klagt über Übelkeit, Verstopfung und starken Durst; sie hat viel Urin ausgeschieden und wirkt exsikkiert. Das Kalzium ist deutlich erhöht.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Die Verwirrtheit allein dem Tumorleiden zuschreiben und abwarten

(B) Verdacht auf maligne Hyperkalzämie (Müdigkeit/Verwirrtheit, Übelkeit, Obstipation, Polyurie/Exsikkose) – Arzt, Vitalzeichen/Bewusstsein, Bilanz, Sturz-/Schutzmaßnahmen

2 THERAPIE

Was ist zentral (AO)?

(A) Die Trinkmenge wegen der Polyurie einschränken

(B) Ausreichende Hydrierung/Volumengabe nach AO (Exsikkose!), Elektrolyte/EKG, kalziumsenkende Therapie nach AO, Bilanz/Nierenfunktion, Bewusstsein

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Bewusstsein/Vitalzeichen/EKG, Ein-/Ausfuhr und Hydratation, Sturz-/Verwirrtheitsschutz, Obstipationsmanagement, Übelkeit behandeln nach AO, Mobilisation dosiert

(B) Die verwirrte Patientin unbeaufsichtigt mobilisieren lassen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Bewusstsein/Vitalzeichen/EKG/Kalzium/Bilanz engmaschig, auf Verschlechterung achten, Therapie nach AO, Dokumentation

(B) Nach leichter Besserung die Kontrollen einstellen

Fall 62 · Brennen an der Infusionsstelle

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Während einer laufenden Chemotherapie über einen peripheren Zugang klagt der Patient über Brennen und Schmerz an der Einstichstelle; dort zeigen sich Schwellung und Rötung, der Rücklauf ist fraglich.

1 SOFORTMASSNAHMEN

Erstes Vorgehen bei Verdacht auf ein Paravasat?

A Die Infusion einfach weiterlaufen lassen, das ist sicher harmlos

B Infusion sofort stoppen (Zugang zunächst belassen), Arzt informieren, Reste/Substanz nach Standard aspirieren, betroffene Stelle markieren, Extremität hochlagern

C Sofort die Kanüle ziehen und kräftig über die Stelle massieren

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO/Standard)?

A Substanzspezifische Maßnahmen nach Standard/AO (z. B. trockene Kälte oder Wärme je nach Substanz, ggf. Antidot), Foto-/Dokumentation, weitere Überwachung

B Pauschal immer warm auflegen, egal welche Substanz

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Die Stelle fest verbinden und nicht mehr ansehen

B Betroffene Stelle/Extremität beobachten und hochlagern, Schmerz behandeln nach AO, Verlauf/Hautbefund dokumentieren, auf Nekrose-/Komplikationszeichen achten, Patienten informieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Keine weitere Kontrolle nötig

B Hautbefund/Schmerz/Funktion im Verlauf kontrollieren, ggf. Fachstelle (z. B. plastische Chirurgie) nach AO, Dokumentation, Patientenedukation

Fall 63 · Plötzliche Schmerzkrise

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein Tumorpatient mit fester Schmerz-Basismedikation hat plötzlich stark zunehmende Schmerzen (NRS 9), ist angespannt und kann kaum sprechen.

1 ERSTES VORGEHEN

Wie reagierst du auf den Durchbruchschmerz?

(A) Schmerz strukturiert erfassen (Stärke/Lokalisation/Auslöser), bei ihm bleiben, schnell wirksame Bedarfsmedikation nach AO geben, beruhigen, Lagerung

(B) Nur mit Atemübungen/Ablenkung arbeiten, keine Medikamente

(C) Auf die nächste planmäßige Gabe der Basismedikation warten

2 NACH DER GABE

Nach der Bedarfsmedikation – wie weiter (AO)?

(A) Sofort eigenständig die Dosis stark erhöhen und wiederholen

(B) Wirkung nach angemessener Zeit reevaluieren (NRS), bei unzureichender Wirkung nach AO nachsteuern, auf Nebenwirkungen (Sedierung/Atemdepression) achten

3 PFLEGE

Worauf achtest du noch?

(A) Vigilanz/Atmung (Opioid-Nebenwirkungen), Obstipations-/Übelkeitsprophylaxe nach AO, Ursache der Schmerzverstärkung bedenken, Dokumentation, Angst ernst nehmen

(B) Nach Linderung sind keine weiteren Beobachtungen nötig

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Schmerz/Atmung/Vigilanz reevaluieren, bei häufigem Durchbruchschmerz die Basismedikation mit dem Arzt überprüfen, Nebenwirkungen managen, Dokumentation

(B) Nur einmal nach dem Schmerz fragen

Fall 64 · Patientin unter Chemotherapie

Routine · mittel | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Frau W., 58 J., erhält eine Chemotherapie und ist dadurch infektanfällig. Du betreust sie und hast selbst einen leichten Schnupfen.

1 INFEKTIONSSCHUTZ

Wie gehst du mit deinem Schnupfen um?

- A Trotzdem ohne Maßnahmen pflegen
- B Maske nur tragen, wenn du daran denkst
- C Vorgesetzte informieren, Schutzmaßnahmen klären, strikte Händehygiene

2 GRUNDPFLEGE

Worauf achtest du in der Pflege besonders?

- A Mundpflege, Hautbeobachtung, Ernährung und Übelkeit beobachten
- B Mundpflege weglassen
- C Nur die Körperpflege durchführen

3 FIEBER

Frau W. bekommt 38,5 °C Fieber. Was bedeutet das?

- A Bei Abwehrschwäche ist Fieber ein Notfall – sofort melden
- B Abwarten und beobachten
- C Erst bei über 39 °C reagieren

4 ABSCHLUSS

Wie schließt du ab?

- A Nur das Fieber notieren
- B Einfühlsam kommunizieren, melden und dokumentieren

Urologie

7 Fälle

Fall 65 · Akuter Hodenschmerz

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein 16-jähriger Patient kommt mit plötzlich einsetzendem, heftigem einseitigem Hodenschmerz, Übelkeit und geschwollenem, hochstehendem Hoden. Beginn vor gut einer Stunde.

1 ERKENNEN

Wie reagierst du zuerst?

A Als harmlose Reizung abtun, kühlen und nach Hause schicken

B Erst etwas zu essen/trinken zur Beruhigung geben

C Verdacht auf Hodentorsion (plötzlicher heftiger Hodenschmerz, Schwellung, Übelkeit) – urologischer Notfall mit engem Zeitfenster, sofort Arzt/Urologie, nüchtern lassen (OP!), Vitalzeichen

2 DIAGNOSTIK

Wie weiter (AO)?

A Nur Schmerzmittel geben und den Verlauf abwarten

B Dringende urologische Abklärung (Doppler-Sonografie), nüchtern lassen, OP-Vorbereitung, Schmerz nach AO, Zeit dokumentieren

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Selbst versuchen, den Hoden 'zurückzudrehen'

B Nüchtern halten, OP-Vorbereitung, Schmerzmanagement nach AO, Patienten/Eltern informieren und beruhigen, Vitalzeichen, Dringlichkeit beachten (Hodenrettung zeitabhängig)

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Vitalzeichen/Schmerz, nüchtern, OP-Vorbereitung zügig, Zeitprotokoll, Patienten begleiten, bei Verschlechterung sofort Arzt

B Die Dringlichkeit unterschätzen und Zeit lassen

Fall 66 · Kein Wasserlassen möglich

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein älterer Patient kann seit vielen Stunden kein Wasser lassen, hat starke Unterbauchschmerzen und einen prall tastbaren, kugeligen Unterbauch; er ist unruhig.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Kräftig auf den Unterbauch drücken, damit es 'läuft'

B Abwarten, das kommt sicher von allein wieder

C Akuten Harnverhalt erkennen (kein Wasserlassen, praller Unterbauch/Blase, Schmerz), Vitalzeichen, Arzt informieren, Entlastung nach AO vorbereiten

2 ENTLASTUNG

Wie wird entlastet (AO)?

A Blasenkatheter nach AO legen (aseptisch), kontrolliert entlasten, Urinmenge erfassen, dokumentieren

B Die volle Blase auf einmal komplett und sehr schnell entleeren

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Ein-/Ausfuhr/Bilanz, Vitalzeichen, auf Entlastungsblutung/Kreislauf achten, Ursache abklären lassen, Patienten beruhigen

B Die abgelassene Urinmenge nicht erfassen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Nach Entlastung nicht weiter beobachten

B Urinfluss/Bilanz, Vitalzeichen, auf erneuten Harnverhalt achten, Ursache (z. B. Prostata) abklären lassen, dokumentieren

Fall 67 · Heftiger Flankenschmerz

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein Patient krümmt sich mit plötzlichen, wellenartigen, sehr starken Flankenschmerzen, die in die Leiste ausstrahlen, dazu Übelkeit und ausgeprägte Bewegungsunruhe.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Eine begleitende Temperaturerhöhung gar nicht beachten

B An eine Nierenkolik (Harnstein) denken, Schmerz erfassen, Vitalzeichen/Temperatur, Arzt informieren, auf Fieber (Urosepsis-Zeichen) achten

C Als Rückenverspannung abtun und abwarten

2 THERAPIE

Wie weiter (AO)?

A Ohne Schmerztherapie einfach abwarten

B Analgesie/Spasmolyse nach AO (Wärme kann lindern), Urin auf Steinabgang sieben nach AO, Flüssigkeit nach AO, Temperatur überwachen

3 WARNZEICHEN

Worauf achtest du besonders?

A Schmerzverlauf, auf Fieber/Schüttelfrost (Urosepsis!) und Harnverhalt achten, Urin beobachten/sieben, Bilanz, bei Fieber sofort melden

B Auftretendes Fieber als 'normal' abtun

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Schmerz/Temperatur/Urin überwachen, auf Urosepsis-/Harnverhaltzeichen achten, Flüssigkeit/Therapie nach AO, dokumentieren

B Nur einmalig den Schmerz erfragen

Fall 68 · Katheter läuft nicht

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Bei einer Patientin mit Dauerkatheter kommt seit Stunden kaum noch Urin; sie klagt über Unterbauchdruck und Unruhe, der Unterbauch ist prall.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Katheterobstruktion vermuten (kein Urinfluss, praller Unterbauch, Druck), System prüfen (Abknickung, Lage, Beutel), Vitalzeichen, Arzt/AO beachten

(B) Abwarten, es läuft sicher gleich wieder

(C) Kräftig am Katheter ziehen

2 PROBLEMLÖSUNG

Wie gehst du vor (AO/Standard)?

(A) Einfache Ursachen beheben (Abknickung lösen, Beutel tiefer, Lage prüfen); bei fortbestehender Obstruktion Anspülen/Wechsel nach AO/Standard, aseptisch

(B) Sofort mit hohem Druck blind spülen, ohne Standard/AO

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Urinfluss/Menge, Unterbauch/Blase, Vitalzeichen, auf erneute Obstruktion achten, Bilanz, aseptisch arbeiten, dokumentieren

(B) Menge und Verlauf nicht dokumentieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nach kurzem Fluss nicht weiter beobachten

(B) Urinfluss/Bilanz, Blase, Vitalzeichen, auf erneute Obstruktion/Harnverhalt achten, dokumentieren

Fall 69 · Blutiger Urin, plötzlich kein Abfluss

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient hat stark blutigen Urin mit Koageln; plötzlich kommt kein Urin mehr, der Unterbauch ist prall und schmerzhaft, der Patient ist unruhig und blass.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Abwarten, der blutige Urin hört sicher von allein auf

(B) Den Kreislauf/die Vitalzeichen nicht beachten

(C) Starke Makrohämaturie mit Blasentamponade vermuten (Koagel verlegen die Blase → Harnverhalt, praller Unterbauch), Vitalzeichen (Blutung/Kreislauf!), sofort Arzt/Urologie

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Spülkatheter/Dauerspülung nach AO, Koagel ausspülen nach AO/Standard, Kreislauf überwachen, Volumen/Transfusion nach AO, Bilanz

(B) Nur Schmerzmittel geben, der Kreislauf ist nebensächlich

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Die Spülung stoppen, obwohl noch Koagel/Blutung da sind

(B) Vitalzeichen/Kreislauf engmaschig (Blutverlust!), Spülung/Abfluss überwachen, Urinfarbe/Koagel beobachten, Bilanz, auf erneute Tamponade achten, beruhigen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nur einmal den Blutdruck messen

(B) Kreislauf/Vitalzeichen, Spülabfluss/Urinfarbe, Bilanz, Hb-Verlauf nach AO, auf Schock/erneute Tamponade achten, Intensiv bei Verschlechterung

Fall 70 · Verwirrt nach Prostata-OP

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Nach einer transurethralen Prostataresektion (TUR-P) mit Spülung wird der Patient zunehmend verwirrt, klagt über Übelkeit und Kopfschmerz; Blutdruck und Puls verändern sich, er wirkt unruhig.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) An ein TUR-Syndrom denken (Aufnahme von Spülflüssigkeit → Verdünnungshyponatriämie: Verwirrtheit, Übelkeit, Kopfschmerz, Kreislaufveränderung) – Arzt sofort, Vitalzeichen/Bewusstsein, OP-/Spülsituation bedenken

(B) Die Verwirrtheit als bloßes 'Aufwachen aus der Narkose' abtun, abwarten

(C) Nur gegen den Kopfschmerz behandeln

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Großzügig zusätzlich freie Flüssigkeit i.v. geben

(B) Arzt/Anästhesie, Vitalzeichen/Neurostatus engmaschig, Elektrolyte (Natrium!) nach AO, Bilanz/Einfuhr beachten, Monitoring, Therapie nach AO

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Bewusstsein/Vitalzeichen/Atmung, Ein-/Ausfuhr genau, auf Verschlechterung (Krampf/Ödeme) achten, Elektrolytkontrollen nach AO, Intensivüberwachung

(B) Nur einmal den Blutdruck messen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nach kurzer Besserung die Kontrollen einstellen

(B) Bewusstsein/Vitalzeichen/Natrium/Bilanz engmaschig, auf Verschlechterung achten, Therapie nach AO, Intensiv, Dokumentation

Fall 71 · Der Blasenkatheter

Routine · niedrig | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Herr T., 70 J., hat einen transurethralen Dauerkatheter. Du übernimmst Pflege und Beobachtung.

1 UMGANG

Worauf achtest du beim Katheter?

- A) Urinmenge und Farbe beobachten, Beutel unter Blasenniveau, geschlossenes System belassen
- B) Den Beutel zur Sicherheit aufs Bett legen
- C) Den Katheter kurz abklemmen

2 HYGIENE

Wie beugst du einer Infektion vor?

- A) Ohne Händedesinfektion arbeiten
- B) Händedesinfektion, sorgfältige Katheter- und Intimpflege, auf Infektzeichen achten
- C) Nur einmal täglich kurz abwischen

3 BILANZ

Es kommt auffällig wenig Urin. Was tust du?

- A) Die geringe Menge ignorieren
- B) Einfach mehr trinken lassen ohne Meldung
- C) Ein- und Ausfuhr bilanzieren, Katheter auf Abknicken prüfen und melden

4 ABSCHLUSS

Wie schließt du ab?

- A) Werte dokumentieren und Auffälligkeiten melden
- B) Nur die Trinkmenge notieren

Gynäkologie

7 Fälle

Fall 72 · Starke Blutung nach der Geburt

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Kurz nach einer vaginalen Geburt blutet die Wöchnerin stark und anhaltend aus der Scheide; die Gebärmutter tastet sich weich und schlecht kontrahiert, sie wird zunehmend blass und unruhig.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Die Blutung als normalen Wochenfluss abtun und abwarten

(B) Postpartale Blutung erkennen (starke anhaltende Blutung, weicher Uterus = Atonie), sofort Hilfe/Arzt/Hebamme, Vitalzeichen (Schock!), Blutung/Vorlagen einschätzen

(C) Den Kreislauf/die Vitalzeichen nicht beachten

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Fundus massieren/reiben (Uterus zur Kontraktion anregen), Blase entleeren lassen, uteruskontrahierende Medikamente nach AO, Zugang/Volumen, Kreislauf überwachen

(B) Die Fundusmassage unterlassen und nur zuschauen

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Vitalzeichen/Kreislauf engmaschig (Blutverlust!), Blutungsstärke/Uterustonus beobachten, Volumen/Transfusion nach AO, Bilanz, beruhigen, Wärme

(B) Den Blutverlust nicht abschätzen/dokumentieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Kreislauf/Vitalzeichen, Blutung/Uterustonus, Bilanz, Hb-Verlauf nach AO, auf Schock achten, Intensiv bei Verschlechterung, Dokumentation

(B) Nur einmal den Blutdruck messen

Fall 73 · Hoher Blutdruck mit Warnzeichen

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Eine Hochschwangere hat stark erhöhten Blutdruck, klagt über starke Kopfschmerzen, Augenflimmern und Oberbauchschmerzen; sie wirkt zunehmend reizbar und überempfindlich gegen Licht und Lärm.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Kopfschmerz und Flimmern als banal abtun und abwarten

B Warnzeichen einer (drohenden) Eklampsie erkennen (Hypertonie + Kopfschmerz/Sehstörung/Oberbauchschmerz = Präeklampsie mit Krampfgefahr), sofort Arzt, reizarme Umgebung, Vitalzeichen

C Für helles Licht und Aktivierung sorgen

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

A Reizarme, ruhige Umgebung, Vitalzeichen/RR engmaschig, Krampfprophylaxe/Medikation (z. B. Magnesium) nach AO, Krampf-/Notfallbereitschaft, CTG/Überwachung nach AO

B Die Patientin allein und unüberwacht lassen

3 KRAMPF

Es kommt zum Krampfanfall. Wie gehst du vor?

A Etwas in den Mund schieben und die Patientin festhalten

B Schützen (nichts in den Mund), Atemweg/O_2, reizarm, Magnesium/Therapie nach AO, Mutter und Kind überwachen, Sturz-/Verletzungsschutz

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A RR/Vitalzeichen/Bewusstsein, Krampfbereitschaft, Magnesium/Therapie nach AO, Mutter und Kind (CTG) überwachen, Dokumentation

B Nach dem Anfall die Überwachung beenden

Fall 74 · Akuter Unterbauchschmerz in der Frühschwangerschaft

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Eine Frau in der Frühschwangerschaft bekommt plötzlich heftige einseitige Unterbauchschmerzen, ist blass, schwindelig, hat einen schnellen Puls und niedrigen Blutdruck; dazu etwas vaginale Blutung.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) An eine (rupturierte) Eileiterschwangerschaft denken (Frühschwangerschaft + akuter einseitiger Unterbauchschmerz + Schockzeichen) – lebensbedrohlich, sofort Arzt/Notfall, Vitalzeichen, Zugang

(B) Als gewöhnliche 'Regelschmerzen' abtun und abwarten

(C) Die Kreislaufzeichen nicht beachten

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Erst etwas zu essen/trinken anbieten

(B) Kreislauf stabilisieren (Zugang, Volumen nach AO), nüchtern lassen (OP!), rasche Diagnostik/OP-Vorbereitung, Vitalzeichen engmaschig, Transfusionsbereitschaft nach AO

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Vitalzeichen/Schockzeichen engmaschig, Blutung beobachten, OP-Vorbereitung, beruhigen, Bilanz, nüchtern halten

(B) Nur Schmerzmittel geben und sonst abwarten

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nur einmal den Blutdruck messen

(B) Kreislauf/Vitalzeichen engmaschig, Blutung, OP-Vorbereitung zügig, Transfusionsbereitschaft nach AO, Intensiv bei Verschlechterung, Dokumentation

Fall 75 · Brustentzündung in der Stillzeit

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine stillende Mutter hat eine schmerzhafte, gerötete, überwärmte Stelle an der Brust, fühlt sich grippig und hat Fieber.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Stillen/Entleeren komplett stoppen und die Brust ruhigstellen

B Mastitis (Brustentzündung) in der Stillzeit erkennen (lokale Rötung/Schmerz/Überwärmung + Fieber), Vitalzeichen, Arzt informieren, weiteres Entleeren/Anlegen unterstützen

C Fieber und Schmerz abwarten

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

A Regelmäßiges Entleeren/Stillen fördern (Milchstau lösen), schonende Maßnahmen (z. B. Wärme vor, Kühlung nach dem Stillen nach Vorgabe), Schmerz-/Fiebermanagement nach AO, Antibiotika nur nach AO

B Eigenmächtig Antibiotika/Medikamente geben

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Zunehmende Schwellung/Eiterhinweise ignorieren

B Brust/Verlauf beobachten (auf Abszess achten), Stillberatung/Unterstützung, Schmerz-/Fiebermanagement nach AO, Flüssigkeit/Ruhe, dokumentieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Nach erster Linderung nicht weiter beobachten

B Temperatur/Schmerz/Brustbefund, auf Besserung oder Abszess achten, Stillunterstützung, Therapie nach AO, dokumentieren

Fall 76 · Starkes Erbrechen in der Schwangerschaft

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine Schwangere im ersten Trimenon erbricht seit Tagen sehr häufig, kann kaum etwas bei sich behalten, hat abgenommen, trockene Schleimhäute und wirkt schwach.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Ausgeprägtes Schwangerschaftserbrechen (Hyperemesis) mit Exsikkose-Zeichen erkennen, Vitalzeichen, Arzt informieren, Flüssigkeits-/Ernährungszustand einschätzen, Bilanz

(B) Als 'normale' Schwangerschaftsübelkeit abtun und abwarten

(C) Die Schwangere zwingen, große Mahlzeiten zu essen

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Eigenmächtig Antiemetika geben

(B) Flüssigkeit/Elektrolyte nach AO (oft i.v.), Antiemetika nach AO, kleine leichte Mahlzeiten/Schlucke anbieten, Bilanz, Ruhe

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Ein-/Ausfuhr/Gewicht, Exsikkose-/Verschlechterungszeichen, Mundpflege, Reize/Gerüche meiden, kleine Mengen, dokumentieren

(B) Bilanz und Gewicht nicht erfassen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nach kurzer Besserung nicht weiter beobachten

(B) Ein-/Ausfuhr/Gewicht, Vitalzeichen, auf zunehmende Exsikkose/Elektrolytentgleisung achten, Therapie nach AO, dokumentieren

Fall 77 · Schwindel in Rückenlage (Schwangerschaft)

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine Hochschwangere wird beim flachen Liegen auf dem Rücken plötzlich blass, schwindelig und übel, der Blutdruck fällt, der Puls steigt.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Die Schwangere weiter flach auf dem Rücken liegen lassen

(B) V.-cava-Kompressionssyndrom erkennen (in Rückenlage drückt die Gebärmutter auf die untere Hohlvene → Blutdruckabfall), sofort die Lagerung ändern: in Linksseitenlage bringen

(C) Sie schnell und ruckartig aufsetzen/aufstehen lassen

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Nichts tun, das wird schon von allein

(B) Linksseitenlage (oder linke Hüfte unterpolstern), Vitalzeichen kontrollieren, beruhigen, O_2 nach AO bei Bedarf, Arzt informieren – meist rasche Besserung

3 PFLEGE & PROPHYLAXE

Worauf achtest du?

(A) Künftig Rückenlage meiden (Seiten-/leichte Kippung), Vitalzeichen/Befinden beobachten, Mutter und Kind im Blick, Schwangere anleiten, dokumentieren

(B) Keine Aufklärung zur Lagerung geben

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Befinden/Vitalzeichen, Mutter und Kind, Lagerung beibehalten/anleiten, bei erneuten Beschwerden Arzt, dokumentieren

(B) Nach Besserung nicht weiter beachten

Fall 78 · Im Wochenbett

Routine · niedrig | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Frau L., 1. Tag nach der Geburt. Du übernimmst Grundpflege und Beobachtung im Wochenbett.

1 SCHICHTBEGINN

Wie beginnst du?

- (A) Befinden und Vitalzeichen erfassen und behutsam nach Blutung und Schmerzen fragen
- (B) Ungefragt die Vorlage kontrollieren
- (C) Intime Themen aus Scham ganz weglassen

2 WOCHENFLUSS

Worauf achtest du beim Wochenfluss (Lochien)?

- (A) Den Wochenfluss nicht beachten
- (B) Nur fragen, ob alles in Ordnung ist
- (C) Menge, Farbe und Geruch beobachten und die Intimhygiene anleiten

3 UNTERSTÜTZUNG

Wie unterstützt du sie weiter?

- (A) Sie ganz sich selbst überlassen
- (B) Bei Mobilisation und Stillen helfen, an Thromboseprophylaxe denken
- (C) Strikte Bettruhe empfehlen

4 ABSCHLUSS

Wie schließt du ab?

- (A) Auffälligkeiten melden und vollständig dokumentieren
- (B) Nur kurz mündlich übergeben

HNO

7 Fälle

Fall 79 · Starkes Nasenbluten

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein Patient hat plötzlich starkes Nasenbluten, das nicht von allein aufhört; er ist unruhig, Blut läuft auch in den Rachen.

1 SOFORTMASSNAHMEN

Wie reagierst du zuerst?

A Aufrecht hinsetzen, Kopf nach vorne neigen, Nasenflügel 10–15 min fest zusammendrücken, Nacken kühlen, beruhigen, Blut ausspucken lassen (nicht schlucken)

B Vitalzeichen/Kreislauf gar nicht beachten

C Den Kopf in den Nacken legen

2 VERLAUF

Die Blutung sistiert nicht. Wie weiter (AO)?

A Arzt/HNO informieren, abschwellende/blutstillende Maßnahmen bzw. Tamponade nach AO, Vitalzeichen, Blutungsstärke, Ursache (Antikoagulation/Hypertonie) bedenken

B Zwischendurch immer wieder loslassen, um nachzuschauen

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Die Blutungsmenge nicht beachten

B Vitalzeichen/Kreislauf beobachten (Blutverlust!), bei Tamponade Pflege/Beobachtung, beruhigen, Blut ausspucken lassen, Ursache abklären lassen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Nach kurzem Stillstand nicht weiter beobachten

B Vitalzeichen/Kreislauf, Blutung, bei Tamponade Beobachtung, Ursache (RR/Gerinnung) abklären lassen, dokumentieren

Fall 80 · Atemnot bei Tracheostoma

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient mit Tracheostoma und Trachealkanüle bekommt zunehmend Atemnot, ist unruhig, die Atmung ist rasselnd und erschwert, die SpO_2 fällt; Verdacht auf eine Sekret-/Borkenverlegung der Kanüle.

1 ERKENNEN

Wie reagierst du zuerst?

(A) Nur über Mund/Nase O_2 geben und das Stoma ignorieren

(B) Atemnot durch verlegte Kanüle erkennen, Hilfe rufen, O_2 anbieten, Oberkörper hoch, absaugen nach Standard, Innenkanüle prüfen/entfernen und reinigen (falls vorhanden) nach Standard

(C) Abwarten, das beruhigt sich sicher wieder

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO/Standard)?

(A) Absaugen nach Standard, Innenkanüle wechseln/reinigen nach Standard, bei fortbestehender Verlegung Arzt/Notfall (ggf. Kanülenwechsel), O_2, SpO_2/Atmung überwachen, Notfallset (Ersatzkanülen) bereit

(B) Tief und unkontrolliert blind absaugen, ohne Standard

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Notfallset/Ersatzkanüle nicht bereithalten

(B) Atmung/SpO_2 engmaschig, Sekret/Borken, Befeuchtung/Inhalation nach AO, Ersatzkanülen/Notfallset griffbereit, beruhigen, dokumentieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nach kurzer Besserung nicht weiter überwachen

(B) Atmung/SpO_2 engmaschig, Sekretmanagement/Befeuchtung nach AO, auf erneute Verlegung achten, Ersatzkanülen bereit, dokumentieren

Fall 81 · Nachblutung nach Mandel-OP

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Einige Stunden nach einer Mandeloperation (Tonsillektomie) beginnt der Patient (z. B. ein Kind) vermehrt zu schlucken, spuckt frisches Blut, wirkt unruhig und blass.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Als 'normal nach der OP' abtun und abwarten

B Den Kreislauf nicht beachten

C Nachblutung nach Tonsillektomie erkennen (häufiges Schlucken, frisches Blut, Blässe) – Notfall, sofort Arzt/HNO, Vitalzeichen, Oberkörper hoch/Kopf zur Seite (Blut ausspucken/abfließen lassen, Aspiration vermeiden), nüchtern lassen (mögliche OP)

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

A Zur Beruhigung etwas zu trinken/essen geben

B Sofort Arzt/HNO, nüchtern lassen, Vitalzeichen/Kreislauf engmaschig, kühlen (Eiskrawatte) nach AO, OP-Vorbereitung, Zugang/Volumen nach AO, Blut ausspucken lassen

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Verschlucktes/erbrochenes Blut nicht beachten

B Vitalzeichen/Kreislauf (Blutverlust – Kinder verschlucken Blut, Menge wird unterschätzt!), Aspirationsschutz (Seitenlage/aufrecht, Blut ausspucken), beruhigen (Kind/Eltern), nüchtern, OP-Vorbereitung

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Nur einmal den Blutdruck messen

B Kreislauf/Vitalzeichen engmaschig, Blutung/Schlucken, Aspirationsschutz, nüchtern, OP-Vorbereitung, Intensiv bei Verschlechterung, dokumentieren

Fall 82 · Atemnot mit Speichelfluss

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient bekommt rasch hohes Fieber, starke Halsschmerzen, eine kloßige Sprache und Speichelfluss (kann kaum schlucken) und sitzt vornübergebeugt, um besser Luft zu bekommen; die Atemnot nimmt zu.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) Verdacht auf Epiglottitis (akute Kehldeckelentzündung: hohes Fieber, kloßige Sprache, Speichelfluss, Atemnot, sitzende vornübergebeugte Haltung) – akuter Atemwegsnotfall, sofort Arzt/Notfall, Ruhe, sitzen lassen, O_2 nach AO, nicht reizen

(B) Mit einem Spatel in den Rachen schauen / eine Racheninspektion erzwingen

(C) Den Patienten flach hinlegen

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Sitzende Position belassen, Ruhe / nicht aufregen (v. a. Kinder), O_2 nach AO, Notfall-/Intubationsbereitschaft (Anästhesie/HNO), nichts in den Mund, Vitalzeichen/SpO_2, nüchtern

(B) Zur Beruhigung etwas zu trinken geben

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Atmung/SpO_2 engmaschig, sitzende Position, ruhige reizarme Umgebung, Notfallteam/Intubationsbereitschaft, nichts in den Mund, beruhigen, dokumentieren

(B) Den Patienten allein lassen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nach kurzer scheinbarer Besserung die Überwachung lockern

(B) Atmung/SpO_2 engmaschig, sitzende Position, Intubations-/Notfallbereitschaft, ruhig, nüchtern, dokumentieren

Fall 83 · Heftiger Drehschwindel-Anfall

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine Patientin mit bekanntem Morbus Menière bekommt einen heftigen Drehschwindelanfall mit Übelkeit und Fallneigung; sie kann kaum sicher stehen.

1 SOFORTMASSNAHMEN

Wie reagierst du zuerst?

(A) Sturzgefahr erkennen, für Sicherheit sorgen (hinsetzen/-legen, nicht allein gehen lassen), reizarme ruhige Umgebung, beruhigen, Vitalzeichen, Arzt/AO

(B) Sie zum Toilettengang allein losschicken

(C) Für helle, unruhige Umgebung sorgen

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Eigenmächtig Medikamente geben

(B) Antiemetika/Antivertiginosa nach AO, Erbrechen managen, ruhige Lagerung, Begleitung, Flüssigkeit nach Verträglichkeit, Vitalzeichen

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Sturzprophylaxe, Begleitung beim Gehen, reizarm, Erbrechen/Übelkeit beobachten, beruhigen, Edukation zu Verhalten im Anfall, dokumentieren

(B) Die Patientin im Anfall unbeaufsichtigt aufstehen lassen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nach leichter Besserung nicht weiter beachten

(B) Befinden/Vitalzeichen, Sturzprophylaxe/Begleitung, Übelkeit, Therapie nach AO, Edukation, dokumentieren

Fall 84 · Plötzliche einseitige Hörminderung

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein Patient berichtet über eine plötzliche einseitige Hörminderung mit 'Wattegefühl' und Ohrgeräusch (Tinnitus), ohne Schmerzen; er ist erschrocken und sorgt sich um sein Gehör.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

(A) An einen Hörsturz denken (plötzliche einseitige Hörminderung, oft Tinnitus, schmerzlos) – als HNO-Eilfall behandeln, zeitnah Arzt/HNO, Ruhe/Stressreduktion, beruhigen

(B) 'Das wird schon wieder' – tagelang abwarten

(C) Eigenmächtig Ohrentropfen/Medikamente geben

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

(A) Am Ohr manipulieren/spülen

(B) Zeitnahe HNO-Abklärung, Medikamente (z. B. Kortison) nur nach AO, Wirkung/Nebenwirkung beobachten, Ruhe/Stressreduktion fördern

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Ruhe/Stressreduktion, bei begleitendem Schwindel Sturzprophylaxe, psychische Unterstützung (Angst ums Gehör), Edukation zu Therapie/Verlauf, dokumentieren

(B) Die Sorge ums Gehör abtun/nicht ernst nehmen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Nach erster Besserung nicht weiter begleiten

(B) Therapie/Wirkung nach AO beobachten, Ruhe, bei Schwindel Sturzprophylaxe, psychische Unterstützung, Edukation, dokumentieren

Fall 85 · Nach der Mandel-OP

Routine · mittel | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Tim, 16 J., einige Stunden nach Mandel-OP (Tonsillektomie). Du betreust ihn auf Station.

1 BEOBACHTUNG

Worauf achtest du als Erstes?

- A Auf Zeichen einer Nachblutung achten (häufiges Schlucken) und Vitalzeichen prüfen
- B Erst einmal abwarten
- C Ihm warmen Tee und Suppe anbieten

2 MASSNAHMEN

Was empfiehlst du ihm?

- A Kräftig Hals freiräuspern
- B Kühle, weiche Kost, kühlen, nicht räuspern, Kopf etwas erhöht
- C Flach hinlegen ohne Erhöhung

3 WARNZEICHEN

Welche Zeichen sprechen für eine Nachblutung?

- A Nur sichtbares Erbrechen von Blut zählt
- B Häufiges Schlucken, Blut im Mund, Blässe und Unruhe sofort melden
- C Solche Zeichen ignorieren

4 ABSCHLUSS

Wie schließt du ab?

- A Nur am Ende kurz erwähnen
- B Beobachtungen melden und dokumentieren

Orthopädie

7 Fälle

Fall 86 · Sturz mit Hüftschmerz im Alter

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine ältere Patientin ist gestürzt und klagt über starke Hüftschmerzen; das betroffene Bein ist verkürzt und nach außen gedreht, sie kann nicht auftreten.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Die Patientin zum Aufstehen/Gehen auffordern

B Verdacht auf hüftgelenknahe Fraktur (Sturz, Schmerz, verkürztes/außenrotiertes Bein) erkennen, Bein ruhigstellen/nicht belasten, Schmerz erfassen, Vitalzeichen, Arzt informieren, DMS (Durchblutung/Motorik/Sensibilität) prüfen

C Den Schmerz nicht weiter beachten

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

A Zur Stärkung etwas zu essen/trinken geben

B Bein schonend lagern/ruhigstellen, Schmerztherapie nach AO, nüchtern lassen (mögliche OP), Diagnostik/OP-Vorbereitung, DMS kontrollieren, Druckstellen beachten

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Die Prophylaxen (Dekubitus/Thrombose/Pneumonie) vernachlässigen

B Schmerz-/Lagerungsmanagement, Prophylaxen (Dekubitus, Thrombose, Pneumonie), auf Verwirrtheit/Delir achten (alter Mensch!), Vitalzeichen, OP-Vorbereitung, beruhigen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Schmerz/DMS/Vitalzeichen, Prophylaxen, auf Delir/Verschlechterung achten, OP-Vorbereitung, dokumentieren

B Nur einmal den Schmerz erfragen

Fall 87 · Atemnot Tage nach Knochenbruch

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient mit Oberschenkelbruch wird 1–2 Tage nach dem Trauma zunehmend kurzatmig und verwirrt; es zeigen sich kleine punktförmige Hauteinblutungen (Petechien), die SpO_2 fällt.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Nur den Frakturschmerz behandeln

B Atemnot und Verwirrtheit als 'Erschöpfung' abtun und abwarten

C An ein Fettembolie-Syndrom denken (1–3 Tage nach Röhrenknochenbruch: Atemnot + Verwirrtheit + Petechien) – Notfall, sofort Arzt, O_2 nach AO, Vitalzeichen/SpO_2, Atmung/Bewusstsein

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

A O_2 nach AO, Vitalzeichen/SpO_2/Bewusstsein engmaschig, Arzt/Intensiv, Bettruhe/schonende Lagerung, Monitoring, Therapie nach AO

B Den Patienten trotz Atemnot kräftig mobilisieren

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Nur einmal die SpO_2 messen

B Atmung/SpO_2/Bewusstsein engmaschig, O_2 nach AO, auf Verschlechterung achten, Intensivüberwachung, Frakturruhigstellung, dokumentieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Nach kurzer Besserung die Überwachung beenden

B Atmung/SpO_2/Bewusstsein/Vitalzeichen engmaschig, O_2/Therapie nach AO, Intensiv, dokumentieren

Fall 88 · Schmerzen und Taubheit unter dem Gips

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein Patient mit frischem Unterschenkelgips klagt über zunehmende, starke Schmerzen, Kribbeln und Taubheit der Zehen; die Zehen wirken blass und kühl, die Schwellung nimmt zu.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Den Schmerz mit Schmerzmittel überdecken und abwarten

B Das Bein tief lagern

C Drohende Durchblutungs-/Nervenstörung unter dem Gips erkennen (zunehmender Schmerz, Kribbeln/Taubheit, blasse/kühle Zehen) – DMS prüfen (Durchblutung/Motorik/Sensibilität), Bein hochlagern, sofort Arzt, Gips nach AO spalten/lockern

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

A Den Gips/Verband noch enger wickeln

B Bein hochlagern, Gips nach AO spalten/aufschneiden/lockern, DMS engmaschig kontrollieren, Arzt, nicht abwarten (drohende Durchblutungsstörung/Kompartment)

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Nur Schmerzmittel geben

B DMS engmaschig (Zehen: Farbe/Wärme/Bewegung/Gefühl), Schwellung/Schmerz beobachten, Hochlagern, bei Verschlechterung sofort Arzt, dokumentieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Nach kurzer Besserung nicht weiter kontrollieren

B DMS/Schwellung/Schmerz engmaschig, hochlagern, bei Verschlechterung sofort Arzt, dokumentieren

Fall 89 · Geschwollene, schmerzhafte Wade

akut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Ein Patient nach längerer Immobilisation/OP klagt über eine einseitig geschwollene, überwärmte, schmerzhafte Wade; die Haut ist gespannt und gerötet.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Die Wade massieren/ausstreichen, um den Schmerz zu lindern

B Verdacht auf tiefe Venenthrombose erkennen (einseitige Schwellung/Überwärmung/Schmerz, Spannung), Bein ruhigstellen, NICHT massieren/kneten, Arzt informieren, Vitalzeichen, auf Lungenembolie-Zeichen achten

C Kräftig mobilisieren – 'laufen ist gut'

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (AO)?

A Arzt/Diagnostik, Antikoagulation nach AO, Bein nach AO lagern, nicht massieren, auf plötzliche Atemnot/ Brustschmerz (Lungenembolie!) achten, Vitalzeichen

B Eigenmächtig Medikamente geben

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Bein beobachten (Umfang/Schmerz), nicht massieren, Therapie nach AO, auf Lungenembolie-Zeichen (Atemnot/ Brustschmerz/Tachykardie) achten und sofort melden, Edukation, dokumentieren

B Plötzliche Atemnot nicht ernst nehmen

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Nach Therapiestart nicht weiter beobachten

B Bein/Umfang/Schmerz, Therapie nach AO, engmaschig auf Lungenembolie-Zeichen achten, Vitalzeichen, Edukation, dokumentieren

Fall 90 · Erste Mobilisation nach Hüft-TEP

subakut | Fortgeschritten | 2. Ausbildungsjahr

Eine Patientin nach Hüft-TEP (künstliches Hüftgelenk) soll erstmals mobilisiert werden; sie möchte sich aus dem Bett drehen und dabei die Beine übereinanderschlagen.

1 LAGERUNG

Wie gehst du die Mobilisation an?

(A) Luxationsprophylaxe beachten (verbotene Bewegungen vermeiden: Beine nicht übereinanderschlagen/überkreuzen, keine starke Beugung über 90°, nicht nach innen drehen), Beine z. B. mit Kissen abspreizen, ruhig erklären

(B) Sie tief in die Hocke / über 90° beugen lassen

(C) Sie die Beine übereinanderschlagen lassen

2 MOBILISATION

Wie weiter (nach Vorgabe)?

(A) Sie ruckartig und ohne Hilfsmittel aufstehen lassen

(B) Nach Vorgabe/Physiotherapie mobilisieren, erlaubte Bewegungen anleiten, Hilfsmittel nutzen, langsam und sicher, Schmerz beachten, DMS/Wunde beobachten

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

(A) Die Prophylaxen vernachlässigen

(B) Luxationsprophylaxe/erlaubte Bewegungen, Thrombose-/Dekubitus-/Pneumonieprophylaxe, Schmerzmanagement, Wunde/DMS beobachten, Edukation, dokumentieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

(A) Erlaubte Bewegungen/Luxationsprophylaxe, Prophylaxen, Schmerz/Wunde/DMS, sichere Mobilisation, Edukation, dokumentieren

(B) Nach erstem Aufstehen nicht weiter anleiten

Fall 91 · Sturz aus Höhe mit Rückenschmerz

akut · hoch | Fortgeschritten | 3. Ausbildungsjahr

Ein Patient ist aus größerer Höhe gestürzt und klagt über starke Rückenschmerzen, Kribbeln in den Beinen und Schwäche; er liegt am Boden.

1 ERKENNEN

Wie ordnest du das ein und reagierst zuerst?

A Den Patienten aufsetzen/hinstellen lassen

B An eine mögliche (instabile) Wirbelsäulenverletzung denken (Sturz aus Höhe + Rückenschmerz + neurologische Zeichen) – Patienten möglichst nicht bewegen/aufsetzen, flach und ruhig liegen lassen, HWS/Achse schützen, sofort Notfall/Arzt, Vitalzeichen, neurologische Zeichen erfassen

C Ihn schnell und unkoordiniert umlagern

2 MASSNAHMEN

Wie weiter (nach Vorgabe)?

A Den Patienten allein und ruckartig umlagern

B Immobilisation/Achse wahren, Bewegungen nur koordiniert (Logroll) im Team nach Vorgabe, neurologische Befunde dokumentieren, Notfallteam, Vitalzeichen, Wärmeerhalt

3 PFLEGE

Worauf achtest du?

A Die neurologischen Zeichen nicht beachten

B Achse/Immobilisation, Neurostatus engmaschig (Sensibilität/Kraft), Vitalzeichen, koordinierte Bewegungen im Team, Druckstellen/Wärme, beruhigen, dokumentieren

4 ÜBERWACHUNG

Weiteres Vorgehen?

A Achse/Immobilisation, Neurostatus/Vitalzeichen engmaschig, koordinierte Bewegungen, Wärmeerhalt, bei Verschlechterung sofort Arzt, dokumentieren

B Nach kurzer Zeit die Achse nicht mehr beachten

Fall 92 · Nach der neuen Hüfte

Routine · mittel | Einsteiger | 1. Ausbildungsjahr

Frau R., 74 J., 1. Tag nach Hüft-TEP (künstliches Hüftgelenk). Du übernimmst Lagerung und Beobachtung.

1 LAGERUNG

Worauf achtest du bei der Lagerung?

- A) Frau R. flach und ohne Hilfsmittel lagern
- B) Abduktionskissen nutzen, keine Beugung über 90°, Beine nicht überkreuzen
- C) Das Bein frei in jede Richtung bewegen lassen

2 PROPHYLAXE

Welche Prophylaxe ist jetzt wichtig?

- A) Thromboseprophylaxe: Bewegung der Füße, Kompressionsstrümpfe und Heparin nach Anordnung
- B) Strikte, völlige Ruhigstellung
- C) Gar keine Prophylaxe

3 MOBILISATION

Wie mobilisierst du sie?

- A) Allein und ohne Hilfsmittel aufstehen lassen
- B) Nach Anordnung, mit Gehhilfe und Anleitung, auf Sturzprophylaxe achten
- C) Vorsichtshalber gar nicht mobilisieren

4 ABSCHLUSS

Wie schließt du ab?

- A) Nur die Mobilisation notieren
- B) Wunde und Durchblutung beobachten, melden und dokumentieren

Auflösungen

Zu jedem Entscheidungspunkt: Bewertung aller Antworten mit Begründung und der Merksatz zum Fall.

Fall 1 · Akuter Brustschmerz

1A	RICHTIG	Richtig – das frühe 12-Kanal-EKG steuert alle weiteren Entscheidungen.
1B	VERTRETBAR	O_2 nur bei SpO_2 < 90 % – hier 96 %. Unnötige Hyperoxie kann schaden; EKG hat Vorrang.
1C	VERTRETBAR	Vertretbar, aber nachrangig: Troponin ist früh oft negativ und darf die Reperfusion nicht verzögern. EKG zuerst.
2A	FALSCH	Bei eindeutiger ST-Hebung kein Warten auf Laborwerte.
2B	RICHTIG	Korrekt – eindeutige ST-Hebung = sofortige Reperfusion.
2C	RICHTIG	Sehr gut mitgedacht – inferiorer Infarkt kann den rechten Ventrikel betreffen.
3A	VERTRETBAR	Nicht pauschal: bei RV-Infarkt mit Hypotonie ist vorsichtige Volumengabe sogar hilfreich.
3B	VERTRETBAR	Riskant beim inferioren/RV-Infarkt – Gefahr schwerer Hypotonie.
3C	RICHTIG	Sehr gut – bei rechtsventrikulärer Beteiligung kann Nitrat den RR einbrechen lassen.
4A	VERTRETBAR	Bei sichtbarem VF + Bewusstlosigkeit nicht zögern.
4B	RICHTIG	Korrekt – bei VF sofort defibrillieren.
4C	VERTRETBAR	Defibrillation hat Vorrang; Amiodaron erst nach dem 3. erfolglosen Schock.

Merke: STEMI: EKG < 10 min steuert alles. Beim inferioren Infarkt an RV-Beteiligung denken (Nitrat-Vorsicht, Volumen kann helfen). Bei VF sofort defibrillieren.

Fall 2 · Nächtliche Atemnot

1A	VERTRETBAR	EKG ist wichtig (Ischämie/Rhythmus), aber Lagerung und O_2 haben Sofortpriorität.
1B	VERTRETBAR	Diuretikum gehört dazu, aber beim hypertensiven Ödem wirken Lagerung/O_2/Nitrate früher.
1C	RICHTIG	Richtig – Lagerung und O_2 wirken sofort, parallel Monitoring.
2A	FALSCH	Im akut dekompensierten Ödem kontraindiziert – verschlechtert die Pumpfunktion.
2B	RICHTIG	Korrekt – beim hypertensiven Ödem sind Nitrate zentral.
2C	VERTRETBAR	Furosemid hilft, aber ohne Nachlastsenkung bleibt der hohe Druck bestehen.
3A	VERTRETBAR	Bei Erschöpfung reicht das oft nicht – NIV erwägen.
3B	VERTRETBAR	Intubation erst, wenn NIV scheitert; Sedierung hier gefährlich.
3C	RICHTIG	Sehr gut – CPAP verbessert Oxygenierung und senkt die Vorlast.
4A	RICHTIG	Sehr gut.
4B	VERTRETBAR	Ziel ist ausreichende, nicht maximale Sättigung; RR/Bilanz fehlen.

Merke: Hypertensives Lungenödem: Lagerung + O_2/NIV (CPAP) + Nitrate/Diuretikum. Betablocker akut kontraindiziert, keine Volumenzufuhr.

Fall 3 · COPD-Exazerbation

1A	FALSCH	Hypoxie nicht unbehandelt lassen – kontrolliert sofort geben.
1B	RICHTIG	Richtig – bei COPD kontrollierte O_2-Gabe.

1C	VERTRETBAR	Initial kontrolliert beginnen – hohe Flüsse riskieren CO_2-Anstieg/Somnolenz.
2A	VERTRETBAR	NIV ist stark bei respiratorischer Azidose – nicht reflexhaft vor Bronchodilatation/BGA.
2B	RICHTIG	Korrekt.
2C	FALSCH	Dämpft den Atemantrieb – gefährlich.
3A	VERTRETBAR	Verstärkt den CO_2-Anstieg.
3B	RICHTIG	Sehr gut – hier ist NIV evidenzbasiert.
3C	VERTRETBAR	Bei pH 7,28 reicht das oft nicht.
4A	VERTRETBAR	Bei COPD riskant – Zielbereich einhalten.
4B	RICHTIG	Sehr gut.

Merke: COPD-Exazerbation: kontrollierte O_2 (88–92 %), Bronchodilatatoren + Steroide (+ AB bei purulent), NIV bei respiratorischer Azidose; keine Sedierung.

Fall 4 · Plötzliche Atemnot postop.

1A	VERTRETBAR	Antikoagulation ist zentral, aber nach ärztlicher Anordnung/Risikoabwägung – nicht eigenmächtig.
1B	VERTRETBAR	EKG ist sinnvoll (Rechtsherzbelastung/DD), aber Monitoring/O_2 und Arztinfo laufen parallel.
1C	RICHTIG	Richtig.
2A	VERTRETBAR	Bei hoher klinischer Wahrscheinlichkeit ist D-Dimer wenig hilfreich – Bildgebung.
2B	RICHTIG	Korrekt beim stabilen Patienten.
3A	VERTRETBAR	Aggressive Volumengabe kann den überlasteten rechten Ventrikel verschlechtern.
3B	RICHTIG	Sehr gut erkannt.
3C	FALSCH	Bei Schock flach/Schocklagerung, nicht aufsetzen.
4A	RICHTIG	Sehr gut.
4B	VERTRETBAR	Der Kreislauf steht im Vordergrund.

Merke: Postop LE: keine Mobilisation, O_2/Monitoring. Stabil → CT-Angio + Antikoagulation; instabil → Hochrisiko-LE (Lyse/Intensiv). Volumen nur vorsichtig (RV!).

Fall 5 · Bluterbrechen

1A	RICHTIG	Richtig – Hämodynamik zuerst.
1B	VERTRETBAR	Nicht primär entscheidend und bei aktiver Hämatemesis ohne Atemwegsschutz riskant.
1C	VERTRETBAR	PPI ist sinnvoll, aber Kreislaufsicherung und Zugänge haben Vorrang.
2A	VERTRETBAR	Bei aktiver Blutung/Instabilität ist die frühe Endoskopie indiziert.
2B	RICHTIG	Korrekt.
3A	VERTRETBAR	Kopftieflage erhöht die Aspirationsgefahr bei Hämatemesis.
3B	RICHTIG	Sehr gut – Aspiration und Schock im Blick.
3C	VERTRETBAR	Allein Volumen reicht bei aktiver Blutung nicht.
4A	RICHTIG	Sehr gut.

4B VERTRETBAR Engmaschig wegen Rezidivblutung.

Merke: Obere GI-Blutung: Kreislauf zuerst (2 Zugänge, Volumen/Transfusion), nüchtern, frühe Endoskopie, Aspirationsschutz; PPI begleitend, nicht statt Kreislauf.

Fall 6 · Plötzliche Verwirrtheit

1A VERTRETBAR Eher wenn keine orale Gabe/kein Zugang möglich; bei Sulfonylharnstoff zudem weniger zuverlässig.

1B RICHTIG Richtig – orale Gabe nach der 15er-Regel.

1C VERTRETBAR Vertretbar bei liegendem Zugang, aber bei sicher schluckfähigem Patienten ist oral erste Wahl.

2A VERTRETBAR Gerade bei Sulfonylharnstoff drohen protrahierte/erneute Hypoglykämien.

2B RICHTIG Korrekt.

3A RICHTIG Sehr gut – Sulfonylharnstoffe wirken lang.

3B VERTRETBAR Zu früh – Rückfallgefahr über Stunden.

4A RICHTIG Sehr gut.

4B VERTRETBAR Verlauf und Ursache sind wichtig.

Merke: Hypoglykämie: wach → orale KH (15er-Regel). Sulfonylharnstoff/lang wirkendes Insulin → längere Überwachung (Rezidiv!). Bewusstlos → nie oral, i.v. Glukose/Glukagon.

Fall 7 · Fieber auf Station

1A FALSCH Keine Medikamentengabe ohne ärztliche Anordnung.

1B RICHTIG Richtig – erst messen und einschätzen.

1C VERTRETBAR Lüften schadet nicht, ersetzt aber keine Einschätzung.

2A RICHTIG Sehr gut – umfassende Beobachtung.

2B VERTRETBAR Zu wenig – der Gesamtzustand zählt.

2C FALSCH Ohne Dokumentation fehlt die Verlaufskontrolle.

3A FALSCH Flüssigkeitsmangel kann rasch gefährlich werden.

3B RICHTIG Richtig – Exsikkosegefahr bei älteren Menschen.

3C VERTRETBAR Zwang vermeiden – lieber regelmäßig kleine Mengen anbieten.

4A RICHTIG Genau richtig.

4B VERTRETBAR Auffälligkeiten gehören zeitnah gemeldet.

Merke: 1. Lernjahr: Vitalzeichen messen, Gesamtzustand beobachten, Flüssigkeit im Blick behalten, zeitnah melden und dokumentieren.

Fall 8 · Akutes Abdomen

1A VERTRETBAR Wärme ist bei akutem Abdomen ungünstig (kann eine Perforation begünstigen) – eher nüchtern/kühlen.

1B FALSCH Laxanzien/Klysmen sind beim akuten Abdomen kontraindiziert – Perforationsgefahr.

1C RICHTIG Richtig – Basismonitoring und nüchtern (mögliche OP).

2A

VERTRETBAR Veraltet – Analgesie darf gegeben werden; nur den Befund vorher dokumentieren.

2B RICHTIG Korrekt – moderne Analgesie verschleiert die Diagnose nicht.

2C FALSCH Nüchtern lassen wegen möglicher OP/Aspiration.

3A VERTRETBAR Analgesie ja, aber die OP-Indikation darf nicht verzögert werden.

3B RICHTIG Sehr gut – septisch-chirurgischer Notfall.

3C VERTRETBAR Bei bretthartem Abdomen + Kreislaufreaktion sofort eskalieren.

4A RICHTIG Sehr gut.

4B VERTRETBAR Kreislauf und Sepsis stehen im Vordergrund.

Merke: Akutes Abdomen: nüchtern, keine Wärme/Laxanzien, Analgesie nach AO erlaubt; bei Perforation/Peritonitis sofortige OP plus Sepsisbündel.

Fall 9 · Darmverschluss

1A FALSCH Beim mechanischen Ileus kontraindiziert (Perforationsgefahr).

1B RICHTIG Richtig – Entlastung plus Flüssigkeits-/Elektrolytausgleich.

1C VERTRETBAR Bei Ileus nüchtern – orale Zufuhr verschlimmert Erbrechen/Aspiration.

2A VERTRETBAR Analgesie ja, aber Entlastung/Bilanz und chirurgische Beurteilung sind nötig.

2B RICHTIG Korrekt.

3A VERTRETBAR Dauerschmerz + Fieber + Kreislauf = Strangulation, sofort eskalieren.

3B RICHTIG Sehr gut – Kolik → Dauerschmerz ist ein Alarmzeichen.

4A VERTRETBAR Kreislauf/Bilanz/Sepsis im Vordergrund.

4B RICHTIG Sehr gut.

Merke: Mechanischer Ileus: nüchtern, Magensonden-Entlastung, Volumen/Elektrolyte, keine Laxanzien/Einläufe; Dauerschmerz + Fieber = Strangulation → OP.

Fall 10 · Plötzlich kaltes Bein

1A VERTRETBAR Bei arterieller Ischämie eher tief lagern – Hochlagern verschlechtert die Perfusion.

1B FALSCH Aktive Wärme steigert den O_2-Bedarf im ischämischen Gewebe – schädlich.

1C RICHTIG Richtig – tief lagern, polstern, Zeit ist Gewebe (6 P).

2A RICHTIG Korrekt – Revaskularisation im Zeitfenster.

2B VERTRETBAR Die Ischämietoleranz ist begrenzt – kein Abwarten.

3A RICHTIG Sehr gut erkannt.

3B VERTRETBAR Harte Loge + Schmerz = Kompartment – sofort eskalieren.

4A RICHTIG Sehr gut – an das Reperfusionssyndrom denken.

4B VERTRETBAR Reperfusion/Kompartment/Niere im Blick behalten.

Merke: Akute Extremitätenischämie (6 P): tief lagern, polstern, NICHT aktiv wärmen, schnelle Revaskularisation; nach Reperfusion auf Kompartment und Niere achten.

Fall 11 · Schmerz im Gips

1A	FALSCH	Der Schmerz ist das Leitsymptom – Analgesie darf das Kompartment nicht verschleiern.
1B	RICHTIG	Richtig – einengende Verbände öffnen, nicht hochlagern (Perfusion!).
1C	VERTRETBAR	Hochlagern senkt den Perfusionsdruck zusätzlich – auf Herzhöhe belassen.
2A	VERTRETBAR	Das Kompartmentsyndrom ist eine klinische Diagnose – nicht auf Bildgebung warten.
2B	RICHTIG	Korrekt – die Fasziotomie ist zeitkritisch.
3A	RICHTIG	Sehr gut – jetzt Notfall.
3B	VERTRETBAR	Pulsverlust ist ein Spätzeichen – nicht darauf warten.
4A	RICHTIG	Sehr gut – an Rhabdomyolyse/Niere denken.
4B	VERTRETBAR	Durchblutung und Niere stehen im Vordergrund.

Merke: Kompartmentsyndrom: klinische Diagnose, einengende Verbände sofort öffnen, Bein auf Herzhöhe (nicht hoch); Pulsverlust ist Spätzeichen; Fasziotomie zeitkritisch; Rhabdomyolyse beachten.

Fall 12 · Postoperative Nachblutung

1A	FALSCH	Abklemmen verschleiert die Blutung und kann zu Verhalt/Tamponade führen – nicht eigenmächtig.
1B	VERTRETBAR	Analgesie ist wichtig, aber Schock/Blutung haben Vorrang.
1C	RICHTIG	Richtig – Schockzeichen + Drainageblut = Nachblutung, Kreislauf zuerst.
2A	RICHTIG	Korrekt.
2B	VERTRETBAR	Volumen ja, aber Transfusionsbereitschaft und ggf. Revision sind nötig.
3A	VERTRETBAR	Bei anhaltender chirurgischer Blutung reicht Volumen nicht.
3B	RICHTIG	Sehr gut – eine chirurgische Blutung muss meist operativ gestillt werden.
4A	RICHTIG	Sehr gut.
4B	VERTRETBAR	Engmaschiger wegen der akuten Blutung.

Merke: Postop Nachblutung: Schock erkennen, Kreislauf zuerst (2 Zugänge, Volumen/Transfusion), Drainage beobachten (nicht eigenmächtig abklemmen), chirurgische Blutung meist operativ stillen.

Fall 13 · Eingeklemmte Leiste

1A	FALSCH	Forcierte Reposition kann ischämischen Darm zurückverlagern (Perforationsgefahr).
1B	VERTRETBAR	Wärme ist bei möglicher Inkarzeration/Ischämie ungünstig; nüchtern + chirurgische Beurteilung.
1C	RICHTIG	Richtig – bei schmerzhafter, irreponibler Hernie keine forcierte Reposition; OP-Bereitschaft.
2A	VERTRETBAR	Bei Inkarzeration mit Ischämiezeichen kein Abwarten.
2B	RICHTIG	Korrekt.
3A	VERTRETBAR	Jetzt erst recht keine Reposition – Not-OP.
3B	RICHTIG	Sehr gut.
4A	VERTRETBAR	Kreislauf und Sepsis stehen im Vordergrund.
4B	RICHTIG	Sehr gut.

Merke: Inkarzerierte Hernie: nicht forciert reponieren, nüchtern, dringliche OP; Strangulation ist ein Notfall mit Ischämie-/Peritonitis-Gefahr.

Fall 14 · Erster Tag nach der OP

1A	FALSCH	Ein Verbandwechsel erfolgt nur nach Anordnung und mit Anleitung – nicht eigenmächtig.
1B	VERTRETBAR	Mobilisation ist wichtig, aber zuerst gehört eine kurze Einschätzung von Zustand und Kreislauf.
1C	RICHTIG	Richtig – erst den aktuellen Zustand erfassen, bevor du handelst.
2A	FALSCH	Keine eigenmächtige Medikamentengabe – immer nur nach ärztlicher Anordnung.
2B	RICHTIG	Genau so – strukturiert erfassen, weitergeben und dokumentieren.
2C	VERTRETBAR	Schmerz muss ernst genommen werden – unbehandelt behindert er Atmung und Mobilisation.
3A	VERTRETBAR	Ein Verbandwechsel erfolgt nach Anordnung und unter Anleitung, nicht spontan allein.
3B	RICHTIG	Sehr gut – beobachten, melden, dokumentieren ist der richtige Weg.
3C	FALSCH	Eine Nachblutung darf nie übersehen werden.
4A	RICHTIG	Richtig – Bewegung und Prophylaxen beugen Komplikationen vor.
4B	VERTRETBAR	Längere Bettruhe fördert Thrombose und Lungenentzündung – dosierte Mobilisation ist besser.

Merke: 1. Lernjahr postoperativ: zuerst beobachten (Vitalzeichen, Schmerz, Wunde), strukturiert melden und dokumentieren, keine eigenmächtige Medikamentengabe, frühe Mobilisation mit Prophylaxen.

Fall 15 · Septischer Schock

1A	VERTRETBAR	Fiebersenkung ist nebensächlich – Kulturen, Antibiose, Volumen haben Priorität.
1B	RICHTIG	Richtig – Kulturen vor AB, frühe Antibiose + Volumen (1-h-Bündel).
1C	VERTRETBAR	Wenn ohne Verzug möglich: Kulturen VOR der ersten Gabe – die Antibiose aber nie lange aufschieben.
2A	FALSCH	Bei Hypovolämie/Schock kontraindiziert – verschlechtert die Perfusion.
2B	RICHTIG	Korrekt – Volumenresuscitation, dann neu bewerten.
2C	VERTRETBAR	Antibiose allein behebt den Volumenmangel nicht.
3A	RICHTIG	Sehr gut – volumenrefraktär = Vasopressor (septischer Schock).
3B	VERTRETBAR	Unbegrenztes Volumen → Ödeme; jetzt Vasopressor.
4A	RICHTIG	Sehr gut – Fokussanierung (DK-Wechsel) nicht vergessen.
4B	VERTRETBAR	MAP/Laktat/Urin/Fokus stehen im Vordergrund.

Merke: Sepsis-1-h-Bündel: Kulturen → frühe Antibiose, Volumen, Laktat. Volumenrefraktär → Vasopressor. Fokussanierung (z. B. DK-Wechsel) nicht vergessen.

Fall 16 · Beatmungsnotfall

1A	FALSCH	Unruhe ist ein Hypoxiezeichen – nicht sedieren, sondern Ursache beheben.
1B	FALSCH	Nicht blind extubieren – erst Ursache abklären.
1C	RICHTIG	Richtig – DOPES (Dislokation, Obstruktion, Pneu, Equipment, Stomach); manuelle Beatmung deckt Geräteursachen auf.
2A	RICHTIG	Korrekt – systematisch abklären.

2B	VERTRETBAR	Hoher Druck bei Pneu ist gefährlich – erst Ursache klären.
3A	VERTRETBAR	Ein Spannungspneu muss sofort entlastet werden.
3B	RICHTIG	Sehr gut – lebensbedrohlich, sofortige Entlastung.
4A	VERTRETBAR	Drücke/Drainage/Kreislauf gehören dazu.
4B	RICHTIG	Sehr gut.

Merke: Beatmungsnotfall: DOPES strukturiert abarbeiten, 100 % O_2 + manuelle Beatmung, nicht blind extubieren/sedieren, Spannungspneu sofort entlasten.

Fall 17 · Gefährliches Kalium

1A	RICHTIG	Richtig – bei EKG-Veränderungen zuerst Kalzium zum Herzschutz.
1B	VERTRETBAR	Insulin/Glukose senkt K^+, schützt das Herz aber nicht sofort – bei EKG-Veränderungen Kalzium voran.
1C	VERTRETBAR	Bei lebensbedrohlichem EKG kein Abwarten – Kalzium gibt Zeit.
2A	VERTRETBAR	Wirkt zu langsam für eine akut bedrohliche Hyperkaliämie.
2B	RICHTIG	Korrekt – verschiebt K^+ rasch; BZ kontrollieren.
3A	VERTRETBAR	Die Verschiebung ist nur temporär – bei Anurie ist Dialyse nötig.
3B	RICHTIG	Sehr gut – bei anurischem ANV ist Dialyse die definitive Therapie.
4A	VERTRETBAR	Engmaschig EKG/K^+ – Arrhythmiegefahr.
4B	RICHTIG	Sehr gut.

Merke: Schwere Hyperkaliämie mit EKG-Veränderungen: 1) Kalzium (Herzschutz), 2) Insulin/Glukose (±Beta-2) zum Verschieben, 3) Dialyse zur Elimination (v. a. anurisch). EKG-Monitoring.

Fall 18 · Entgleister Zucker

1A	VERTRETBAR	Bikarbonat nur in Ausnahmefällen – nicht routinemäßig in der DKA.
1B	RICHTIG	Richtig – der Volumenmangel ist führend, Flüssigkeit zuerst.
1C	VERTRETBAR	Insulin gehört dazu, aber Volumen und K^+-Beachtung zuerst – Insulin nicht vor dem K^+-Check hochfahren.
2A	FALSCH	Gefährliche Hypokaliämie/Arrhythmie.
2B	RICHTIG	Korrekt – Insulin treibt K^+ in die Zelle; bei niedrigem K^+ erst ausgleichen.
3A	VERTRETBAR	Ein Insulinstopp lässt die Ketoazidose persistieren.
3B	RICHTIG	Sehr gut – Insulin nicht stoppen, sondern Glukose zugeben.
4A	VERTRETBAR	K^+/BGA/Bilanz engmaschig – Komplikationsgefahr.
4B	RICHTIG	Sehr gut.

Merke: DKA: 1) Volumen, 2) Kalium beachten (Insulin senkt K^+), 3) niedrig dosiertes Insulin weiter (bei BZ-Abfall Glukose zugeben, nicht stoppen). Bikarbonat nur ausnahmsweise.

Fall 19 · Nächtliche Unruhe (Intensiv)

1A	RICHTIG	Richtig – Delir ist ein Symptom; zuerst reversible Ursachen suchen.
1B		

FALSCH Benzodiazepine können das Delir verschlimmern (außer Entzugsdelir).

1C	VERTRETBAR	Erst Ursache + nicht-medikamentöse Maßnahmen; Fixierung/Sedierung sind nachrangig und riskant.
2A	VERTRETBAR	Medikamente nur bei starker Agitation/Eigengefährdung, nicht als Erstmaßnahme für jeden.
2B	RICHTIG	Korrekt – nicht-medikamentöse Maßnahmen zuerst.
3A	RICHTIG	Sehr gut – gezielt und überwacht.
3B	VERTRETBAR	Benzodiazepine verschlechtern das Delir meist – vermeiden.
4A	RICHTIG	Sehr gut – QT-Kontrolle bei Antipsychotika.
4B	VERTRETBAR	Score/QT/Ursachen gehören dazu.

Merke: ICU-Delir: reversible Ursachen ausschließen, nicht-medikamentöse Maßnahmen zuerst, Benzodiazepine meiden (außer Entzug), Antipsychotika nur gezielt (QT beachten), CAM-ICU.

Fall 20 · Reaktion auf Medikament

1A	VERTRETBAR	Zugang parallel, aber Adrenalin i.m. darf nicht warten.
1B	RICHTIG	Richtig – Adrenalin i.m. ist die wichtigste Sofortmaßnahme.
1C	VERTRETBAR	Wichtig, aber Second-Line – Adrenalin i.m. zuerst (lebensrettend).
2A	VERTRETBAR	i.v.-Adrenalin nur verdünnt/titriert unter Monitoring (Arrhythmiegefahr) – sonst i.m.
2B	RICHTIG	Korrekt.
3A	VERTRETBAR	Bei Atemwegsschwellung kein Abwarten.
3B	RICHTIG	Sehr gut – der Atemweg hat höchste Priorität.
4A	VERTRETBAR	Biphasische Reaktion möglich – ausreichend lange überwachen.
4B	RICHTIG	Sehr gut – an die biphasische Reaktion denken.

Merke: Anaphylaxie: Auslöser stoppen, Adrenalin i.m. zuerst (i.v. nur titriert), Volumen + O_2, früh Atemweg sichern; Antihistaminikum/Kortison Second-Line; biphasische Reaktion → längere Überwachung.

Fall 21 · Grundpflege beim beatmeten Patienten

1A	VERTRETBAR	Auch bewusstlose Patienten ansprechen.
1B	RICHTIG	Richtig – Ansprache und Hygiene gehören dazu.
1C	FALSCH	Hohe Infektionsgefahr auf der Intensivstation.
2A	FALSCH	Alarme müssen abgeklärt werden.
2B	VERTRETBAR	Monitorwerte sind hier zentral.
2C	RICHTIG	Sehr gut – kontinuierliche Beobachtung.
3A	RICHTIG	Richtig – spezielle Prophylaxen beim beatmeten Patienten.
3B	FALSCH	Nur Fachpersonal – Gefahr für den Patienten.
3C	VERTRETBAR	Mund-/Augenpflege sind hier unverzichtbar.
4A	VERTRETBAR	Beobachtungen vollständig dokumentieren.
4B	RICHTIG	Genau richtig.

Merke: 1. Lernjahr Intensiv: Patienten ansprechen, strikte Hygiene, Monitor beobachten, Spezialpflege nur unter Anleitung, Alarme ernst nehmen.

Fall 22 · Krampfanfall bei Fieber

1A	RICHTIG	Richtig – schützen, nichts in den Mund, Dauer messen.
1B	FALSCH	Nichts in den Mund – Verletzungs-/Aspirationsgefahr.
1C	VERTRETBAR	Nicht festhalten/fixieren – nur vor Verletzung schützen.
2A	VERTRETBAR	> 5 min = drohender Status epilepticus – behandeln.
2B	RICHTIG	Korrekt – ab ca. 5 min medikamentös durchbrechen (Status-Gefahr).
2C	VERTRETBAR	Fiebersenkung ist nachrangig; aggressive Kühlung ungünstig – erst Anfall + Atemweg.
3A	RICHTIG	Sehr gut – Ursachensuche + Beobachtung.
3B	VERTRETBAR	Ein (erstmaliger) Fieberkrampf gehört ärztlich abgeklärt.
4A	VERTRETBAR	Meningitis-Zeichen/Wiederholung/Atmung gehören dazu.
4B	RICHTIG	Sehr gut – Meningitis-Zeichen aktiv ausschließen.

Merke: Fieberkrampf: schützen (nichts in den Mund, nicht festhalten), Dauer messen, > 5 min medikamentös durchbrechen, danach Ursache/Red Flags (Meningitis!) abklären.

Fall 23 · Bellender Husten nachts

1A	FALSCH	Racheninspektion/Aufregung kann den Atemweg verschlechtern (cave Epiglottitis) – vermeiden.
1B	RICHTIG	Richtig – Aufregung verschlimmert den Stridor.
1C	VERTRETBAR	Inhalation kann helfen, aber kein Zwang – erst beruhigen.
2A	VERTRETBAR	Behandelt nicht die Atemwegsobstruktion.
2B	RICHTIG	Korrekt – Steroid ist Standard, vernebeltes Adrenalin bei schwerem Stridor.
2C	VERTRETBAR	Pseudokrupp ist meist viral – Antibiotika nicht primär.
3A	VERTRETBAR	Bei zunehmendem Stridor/Einziehungen eskalieren.
3B	RICHTIG	Sehr gut – schwerer Krupp: Adrenalininhalation + Eskalation.
4A	VERTRETBAR	Atemarbeit/SpO_2/Erschöpfung im Vordergrund.
4B	RICHTIG	Sehr gut – nach Adrenalin auf Rebound achten.

Merke: Pseudokrupp: Ruhe/aufrecht bei den Eltern, keine Racheninspektion, Steroid als Standard, vernebeltes Adrenalin bei schwerem Stridor; nach Adrenalin Rebound beachten; leiser Stridor + Erschöpfung = Alarm.

Fall 24 · Atemnot beim Säugling

1A	VERTRETBAR	Bronchiolitis ist meist viral (RSV) – Antibiotika nicht primär.
1B	FALSCH	Sedativa bei Atemnot kontraindiziert (Atemdepression); flach lagern ungünstig.
1C	RICHTIG	Richtig – Atemwege freihalten, O_2 titrieren, Ernährung/Atmung im Blick.
2A	RICHTIG	Korrekt – Flüssigkeit sichern, Aspiration vermeiden.
2B	VERTRETBAR	Bei Tachypnoe Aspirationsgefahr – kleine Mengen/Sonde.

3A	RICHTIG	Sehr gut – Apnoen beim jungen Säugling sind Warnzeichen.
3B	VERTRETBAR	Bei Apnoen/SpO_2-Abfall eskalieren – nicht nur abwarten.
4A	VERTRETBAR	Zielgerechte Sättigung; Apnoe/Trinkmenge gehören dazu.
4B	RICHTIG	Sehr gut.

Merke: Bronchiolitis (RSV): Atemwege freihalten/absaugen, O_2 titrieren, Flüssigkeit sichern (Aspiration vermeiden), keine Sedativa; Apnoen beim jungen Säugling = Warnzeichen; Antibiotika nicht primär.

Fall 25 · Erbrechen & Durchfall

1A	FALSCH	Motilitätshemmer sind bei Kleinkindern/infektiösem Durchfall nicht indiziert.
1B	RICHTIG	Richtig – bei leichter/mittlerer Exsikkose ist ORS erste Wahl.
1C	VERTRETBAR	Cola/Saft (zuckerreich, elektrolytarm) ist ungeeignet – spezielle ORS, kleine Mengen.
2A	VERTRETBAR	Bei fortgesetzten Verlusten droht Verschlechterung – dranbleiben/eskalieren.
2B	RICHTIG	Korrekt – kleine Mengen häufig, bei Versagen i.v.
3A	VERTRETBAR	Bei Schock reicht oral nicht – i.v.
3B	RICHTIG	Sehr gut – schwere Dehydratation/Schock = i.v.-Rehydratation.
4A	VERTRETBAR	Vitalzeichen/Bilanz/Elektrolyte gehören dazu.
4B	RICHTIG	Sehr gut.

Merke: Exsikkose bei Gastroenteritis: Grad einschätzen, ORS (kleine Mengen häufig) bei leicht/mittel, i.v. bei schwerer Dehydratation/Schock; keine Motilitätshemmer, kein Cola/Saft; Bilanz/Gewicht/Elektrolyte.

Fall 26 · Fieber mit Hautflecken

1A	RICHTIG	Richtig – nicht wegdrückbare Petechien + Fieber + Vigilanzminderung = Notfall.
1B	VERTRETBAR	Kein Abwarten – rasch progrediente Petechien sind ein Alarmzeichen.
1C	FALSCH	Bei septischen Petechien kein Abwarten – sofort handeln.
2A	VERTRETBAR	Die LP darf die Antibiose nicht verzögern – bei Sepsiszeichen Antibiose zuerst.
2B	RICHTIG	Korrekt – frühe Antibiose ist lebensentscheidend.
3A	RICHTIG	Sehr gut – septischer Schock, aggressive Stabilisierung.
3B	VERTRETBAR	Im Schock auch Kreislaufstabilisierung nötig.
4A	RICHTIG	Sehr gut – auch an Personalschutz/Umgebungsprophylaxe denken.
4B	VERTRETBAR	Kreislauf/Neuro/Diurese im Vordergrund.

Merke: Meningokokken-Sepsis: nicht wegdrückbare Petechien + Fieber = Notfall; frühe i.v.-Antibiose (nicht durch LP verzögern), Kreislauf stabilisieren, Intensiv; Isolation/Personalschutz + Umgebungsprophylaxe.

Fall 27 · Verschlucktes Kleinteil

1A	RICHTIG	Richtig – bei effektivem Husten nicht eingreifen, nur ermutigen und beobachten.
1B	VERTRETBAR	Solange der Husten effektiv ist, nicht schlagen – zuerst husten lassen.
1C		

FALSCH Blindes Auswischen kann den Fremdkörper tiefer schieben – verboten.

2A RICHTIG Korrekt – bei ineffektivem Husten Rückenschläge + Thoraxkompressionen, Notruf.

2B VERTRETBAR Beim Säugling keine Bauchstöße – Rückenschläge + Thoraxkompressionen.

3A VERTRETBAR Bei Bewusstlosigkeit CPR beginnen.

3B RICHTIG Sehr gut – CPR; nur sichtbaren Fremdkörper entfernen.

4A VERTRETBAR Nach Aspiration ärztliche Kontrolle nötig (Restmaterial/Komplikationen).

4B RICHTIG Sehr gut – immer ärztlich abklären.

Merke: Fremdkörperaspiration: effektiver Husten → ermutigen, nicht eingreifen, nie blind auswischen; ineffektiver Husten beim Säugling → 5 Rückenschläge + 5 Thoraxkompressionen (keine Bauchstöße!); Bewusstlosigkeit → CPR; danach immer ärztliche Kontrolle.

Fall 28 · Fieber beim Kind

1A VERTRETBAR Möglichst ohne Zwang – das erhöht sonst die Angst.

1B FALSCH Bezugspersonen geben dem Kind Sicherheit.

1C RICHTIG Richtig – Vertrauen nimmt dem Kind die Angst.

2A VERTRETBAR Wärmestau vermeiden – eher leicht bekleiden.

2B RICHTIG Sehr gut – Wickel nur bei warmer Peripherie.

2C FALSCH Kälteschock vermeiden – das ist kontraproduktiv.

3A FALSCH Bei Kindern kann sich der Zustand schnell ändern.

3B RICHTIG Richtig – Warnzeichen früh erkennen.

3C VERTRETBAR Zu eng – der Gesamtzustand zählt.

4A VERTRETBAR Dokumentation nicht vergessen.

4B RICHTIG Genau richtig.

Merke: 1. Lernjahr Pädiatrie: kindgerechte Kommunikation, Eltern einbeziehen, schonende Maßnahmen, Warnzeichen beobachten.

Fall 29 · Plötzlicher CO_2-Anstieg intraop.

1A FALSCH Bei etCO_2-Anstieg + Masseterspasmus kein Abwarten – Trigger sofort stoppen.

1B RICHTIG Richtig – Trigger weg, 100 % O_2, Team alarmieren.

1C FALSCH Volatile Anästhetika sind der Trigger – das verschlimmert die Krise.

2A VERTRETBAR Symptomatisch und riskant – die Ursache muss mit Dantrolen behandelt werden.

2B VERTRETBAR Kühlung ist Begleitmaßnahme – ohne Dantrolen bleibt die Krise unbehandelt.

2C RICHTIG Korrekt – Dantrolen ist die kausale Therapie.

3A RICHTIG Sehr gut – Hyperkaliämie, Azidose, Temperatur und Niere im Blick.

3B VERTRETBAR Hyperkaliämie/Azidose/CK sind kritisch – Labor und Behandlung gehören dazu.

4A RICHTIG Sehr gut – Intensivüberwachung, Rhabdomyolyse/Niere beachten.

4B

VERTRETBAR MH erfordert Intensivüberwachung (Rezidiv/Komplikationen).

Merke: Maligne Hyperthermie: Trigger sofort stoppen (volatile/Succinylcholin), 100 % O_2/Hyperventilation, Dantrolen schnellstmöglich, Hyperkaliämie/Azidose/Temperatur behandeln, Rhabdomyolyse/Niere überwachen, Intensiv.

Fall 30 · Stridor nach Extubation

1A	VERTRETBAR	Erst Atemwegsmanöver/CPAP; nicht in flacher Narkose blind intubieren.
1B	FALSCH	Bei Laryngospasmus/flacher Narkose nicht zielführend – aktiv den Atemweg öffnen.
1C	RICHTIG	Richtig – Atemwegsmanöver + CPAP mit 100 % O_2, störende Reize entfernen.
2A	VERTRETBAR	Bei anhaltender Hypoxie nicht nur abwarten.
2B	RICHTIG	Korrekt – Vertiefung bzw. Muskelrelaxans durchbricht den Spasmus.
3A	VERTRETBAR	Komplikation (Negativdruck-Lungenödem) möglich – weiter überwachen.
3B	RICHTIG	Sehr gut – nach Laryngospasmus kann ein Negativdruck-Lungenödem auftreten.
4A	RICHTIG	Sehr gut.
4B	VERTRETBAR	Auskultation/Atemarbeit/Re-Spasmus gehören dazu.

Merke: Laryngospasmus: 100 % O_2, Esmarch + CPAP, Reize entfernen; bei Persistenz Vertiefung/Succinylcholin nach AO; danach an Negativdruck-Lungenödem denken; nicht in flacher Narkose blind intubieren.

Fall 31 · Regurgitation bei Einleitung

1A	FALSCH	Nicht zielführend im Akutmoment – der Atemweg hat Priorität.
1B	RICHTIG	Richtig – Atemweg schützen: absaugen, intubieren/cuffen, O_2.
1C	VERTRETBAR	Maskenbeatmung kann Mageninhalt verteilen/insufflieren – erst absaugen und Atemweg sichern.
2A	VERTRETBAR	Nicht routinemäßig – Antibiotika nur bei Infektzeichen, Steroide werden nicht empfohlen.
2B	RICHTIG	Korrekt – absaugen, oxygenieren, ggf. Bronchoskopie.
3A	RICHTIG	Sehr gut – Aspirationspneumonitis/Bronchospasmus behandeln.
3B	VERTRETBAR	Unkontrolliert hoher Druck riskiert ein Barotrauma.
4A	VERTRETBAR	Drücke/Auskultation/Verlauf gehören dazu.
4B	RICHTIG	Sehr gut.

Merke: Aspiration bei Einleitung: Kopftief/Seitenlage + sofort absaugen, Atemweg mit Cuff sichern (vor Maskenbeatmung), tracheobronchial absaugen, O_2/PEEP, ggf. Bronchoskopie; keine pauschalen Antibiotika/Steroide. Prävention: RSI bei nicht-Nüchternen.

Fall 32 · Symptome nach Regionalanästhesie

1A	RICHTIG	Richtig – Zufuhr stoppen, O_2, Team; LAST früh erkennen.
1B	FALSCH	Erhöht die Toxizität – absolut kontraindiziert.
1C	FALSCH	Bei Prodromi/Zuckungen kein Abwarten – LAST kann rasch in Krampf/Stillstand übergehen.
2A	VERTRETBAR	Die Lipidemulsion ist bei LAST entscheidend.
2B	RICHTIG	Korrekt – Lipidrescue ist die spezifische Therapie.

3A	VERTRETBAR	Bei LAST eher reduzierte Adrenalindosen; Lipidrescue steht im Vordergrund.
3B	RICHTIG	Sehr gut – bei LAST länger reanimieren, Adrenalin niedrig dosieren, Lipid weiter.
4A	VERTRETBAR	Rezidivgefahr – ausreichend lange überwachen.
4B	RICHTIG	Sehr gut – LAST kann rezidivieren, lange überwachen.

Merke: LAST: Zufuhr sofort stoppen, O_2/Atemweg, Krampf durchbrechen, Lipidemulsion 20 % (Lipidrescue) als spezifische Therapie; bei Stillstand prolongierte Reanimation mit reduzierten Adrenalindosen; längere Intensivüberwachung (Rezidiv).

Fall 33 · Flache Atmung im Aufwachraum

1A	RICHTIG	Richtig – stimulieren, Atemweg/O_2, Vitalüberwachung.
1B	FALSCH	Bei AF 6 + SpO_2 88 % keine harmlose Müdigkeit – Atemdepression behandeln.
1C	VERTRETBAR	Naloxon vorsichtig titrieren (Schmerz/Entzug/Lungenödem!) – nicht reflexartig als großer Bolus.
2A	RICHTIG	Korrekt – Naloxon titrieren; differenzialdiagnostisch auch Relaxansüberhang.
2B	VERTRETBAR	O_2 allein behebt die zentrale Atemdepression oft nicht – Ursache angehen.
3A	VERTRETBAR	Muskelschwäche spricht für Relaxansüberhang – nicht ignorieren.
3B	RICHTIG	Sehr gut – an Restrelaxierung denken (TOF), ggf. antagonisieren.
4A	VERTRETBAR	Re-Sedierung möglich – ausreichend lange überwachen.
4B	RICHTIG	Sehr gut – Naloxon wirkt kürzer als das Opioid → Re-Sedierung möglich.

Merke: Postoperative Atemdepression: stimulieren, Atemweg/O_2; Opioidüberhang → Naloxon titriert (kein großer Bolus; Re-Sedierung beachten, da kürzere Wirkdauer); an Relaxansüberhang denken (TOF, Antagonisierung); lange überwachen.

Fall 34 · Kreislauf nach Spinalanästhesie

1A	FALSCH	Aufsetzen lässt Blockade/Hypotonie verschlimmern – flach/Beine hoch.
1B	RICHTIG	Richtig – Lagerung, Volumen, Vasopressor; bei Schwangeren aortocavale Kompression vermeiden.
1C	VERTRETBAR	Bei symptomatischer Hypotonie/Bradykardie nicht abwarten.
2A	RICHTIG	Korrekt – Atropin bei symptomatischer Bradykardie, Kreislauf stützen.
2B	VERTRETBAR	Symptomatische Bradykardie braucht Atropin – nicht nur Volumen.
3A	VERTRETBAR	Aufsteigende Blockade mit Atemnot ist bedrohlich – Atemweg/Beatmung vorbereiten.
3B	RICHTIG	Sehr gut – hohe/totale Spinale kann die Atemmuskulatur lähmen.
4A	RICHTIG	Sehr gut.
4B	VERTRETBAR	HF/Atmung/Blockadehöhe engmaschig.

Merke: Hypotonie/Bradykardie nach Spinalanästhesie: flach/Beine hoch (Schwangere: Linksseitenlage gegen aortocavale Kompression), Volumen + Vasopressor, Atropin bei symptomatischer Bradykardie; bei hoher/totaler Spinale Atemweg/Beatmung sichern.

Fall 35 · Vorbereitung zur Narkose

1A	VERTRETBAR	Identität und Checkliste gehören vollständig geprüft.
1B	RICHTIG	Richtig – Patientensicherheit zuerst.

1C FALSCH Schwerer Sicherheitsfehler.

2A VERTRETBAR Schmuck muss vor der OP entfernt werden.

2B FALSCH Allergien sind sicherheitsrelevant.

2C RICHTIG Sehr gut – vollständige Vorbereitung.

3A RICHTIG Richtig – Sicherheit durch Information und Zuwendung.

3B VERTRETBAR Ängste ernst nehmen ist Teil der Vorbereitung.

3C FALSCH Respektlos und nicht hilfreich.

4A VERTRETBAR Übergabe und Doku müssen vollständig sein.

4B RICHTIG Genau richtig.

Merke: 1. Lernjahr Anästhesie: Identität und Nüchternheit prüfen, Checkliste vollständig, Ängste ernst nehmen, lückenlose Übergabe.

Fall 36 · Hoffnungslosigkeit und Rückzug

1A FALSCH Bagatellisieren/Ablenken signalisiert, dass das Thema unerwünscht ist – ernst nehmen und zuhören.

1B RICHTIG Richtig – ernst nehmen, präsent sein, wertfrei ins Gespräch gehen.

1C FALSCH Bei möglicher Suizidalität nicht allein lassen – Beziehung halten.

2A RICHTIG Korrekt – offenes Ansprechen erhöht das Risiko nicht, sondern entlastet und schafft Klarheit.

2B VERTRETBAR Ein Mythos – offenes Ansprechen bringt niemanden auf Ideen, sondern öffnet das Gespräch.

3A RICHTIG Sehr gut – Sicherheit, nicht allein lassen, Arzt/Team einbeziehen.

3B FALSCH Keine Geheimhaltung bei Suizidalität – Schutz geht vor, das Team muss informiert werden.

4A VERTRETBAR Suizidalität erfordert ein abgestimmtes, engmaschiges Vorgehen – nicht zur Tagesordnung übergehen.

4B RICHTIG Sehr gut – Schutz, Beziehung, ärztliche Einschätzung und Dokumentation.

Merke: Akute Suizidalität: ernst nehmen, präsent bleiben/nicht allein lassen, Suizidgedanken offen und wertfrei ansprechen (erhöht das Risiko nicht), keine Geheimhaltung, sichere Umgebung, Arzt/zuständiges Team umgehend einbeziehen, engmaschige Betreuung und Dokumentation.

Fall 37 · Angespannter, gereizter Patient

1A RICHTIG Richtig – Ruhe, Distanz, reizarm, Deeskalation durch Beziehung.

1B VERTRETBAR Lautes, konfrontatives Auftreten eskaliert oft – deeskalierend bleiben.

1C FALSCH Körperlicher Zwang ist kein Erstmittel – zuerst deeskalieren, Zwang nur als letztes Mittel mit klaren Voraussetzungen.

2A VERTRETBAR Wahn lässt sich nicht 'wegdiskutieren' – nicht bestätigen, aber auch nicht streiten; bei den Gefühlen bleiben.

2B RICHTIG Korrekt – Beziehung, klare einfache Kommunikation, Eigenschutz.

3A RICHTIG Sehr gut – Team, Schutz, Arzt/Medikation nach AO, weiter deeskalieren.

3B VERTRETBAR Bei Gefährdung kein Alleingang – Team und Eigenschutz.

4A VERTRETBAR Zwangsmaßnahmen brauchen ärztliche Anordnung, rechtliche Grundlage, Überwachung und Dokumentation – nie im Alleingang.

4B RICHTIG Sehr gut – Zwang nur als Ultima Ratio mit rechtlicher Grundlage, ärztlicher Anordnung, Überwachung und Doku.

Merke: Psychotische Erregung: ruhig, reizarm, Distanz/Eigenschutz, deeskalierende Kommunikation (zuhören, einfache Sätze, Wahn nicht bestätigen, aber nicht streiten), Team und Arzt einbeziehen, Medikation nach AO anbieten; freiheitsentziehende Maßnahmen nur als Ultima Ratio bei akuter Gefahr mit ärztlicher Anordnung, rechtlicher Grundlage (PsychKG), Überwachung und Dokumentation.

Fall 38 · Getriebene, rastlose Patientin

1A	VERTRETBAR	Strenge Konfrontation führt zu Reibung/Eskalation – ruhig und strukturierend.
1B	RICHTIG	Richtig – Ruhe, Struktur, reizarm, Beziehung statt Machtkampf.
1C	VERTRETBAR	Das befeuert die Manie – freundlich, aber nicht in die Getriebenheit einsteigen.
2A	RICHTIG	Korrekt – Reizreduktion, Schlaf, Schutz vor selbstschädigenden Folgen, Grundbedürfnisse.
2B	VERTRETBAR	Bei fehlender Einsicht und Selbstgefährdung braucht es schützende Struktur.
3A	RICHTIG	Sehr gut – körperliche Erschöpfung/Exsikkose im Blick behalten.
3B	VERTRETBAR	Manie erschöpft auch körperlich – Flüssigkeit/Ernährung/Erschöpfung beachten.
4A	VERTRETBAR	Heimliche Gabe ist unzulässig – transparent vorgehen, bei Gefährdung rechtlich abgesicherte Maßnahmen.
4B	RICHTIG	Sehr gut – erst Motivation/Beziehung, Schutzmaßnahmen nur bei Gefährdung mit ärztlicher/rechtlicher Grundlage.

Merke: Akute Manie: ruhig, wertschätzend, klare Struktur, reizarme Umgebung, Schlaf fördern, Beziehung statt Machtkampf; vor selbstschädigenden Folgen (finanziell/sozial) und körperlicher Erschöpfung/Exsikkose schützen; Medikation nach AO anbieten; keine heimliche Gabe; Schutzmaßnahmen nur bei akuter Gefährdung mit ärztlicher Einschätzung/rechtlicher Grundlage (PsychKG).

Fall 39 · Tremor und Unruhe ohne Alkohol

1A	FALSCH	Alkoholentzug kann lebensbedrohlich werden (Delir/Krampf) – nicht bagatellisieren.
1B	RICHTIG	Richtig – Entzug erkennen, Vitalzeichen, Schweregrad erfassen, Arzt einbeziehen.
1C	FALSCH	Alkohol ist keine pflegerische Maßnahme – strukturierte Entzugsbehandlung nach AO.
2A	VERTRETBAR	Unbehandelt drohen Delir/Krampf – strukturierte Behandlung und Überwachung.
2B	RICHTIG	Korrekt – symptomorientierte Medikation nach Schema, Thiamin, Flüssigkeit, Monitoring.
3A	VERTRETBAR	Delir und Krampfanfall sind die gefährlichen Komplikationen – breiter beobachten.
3B	RICHTIG	Sehr gut – Delir und Entzugskrampf rechtzeitig erkennen, Sicherheit herstellen.
4A	VERTRETBAR	Entzug verläuft über Tage – weiter engmaschig überwachen.
4B	RICHTIG	Sehr gut – strukturierte, sichere, engmaschige Begleitung.

Merke: Alkoholentzugssyndrom: erkennen, Vitalzeichen + Schweregrad (Skala), Arzt einbeziehen; symptomorientierte Medikation nach Schema (z. B. Benzodiazepine), Thiamin (Wernicke-Prophylaxe), Flüssigkeit/Elektrolyte; auf Delir und Entzugskrampf achten; reizarme sichere Umgebung, engmaschige Überwachung über Tage; kein Alkohol als 'Therapie', kein Abwarten.

Fall 40 · Plötzliche Atemnot und Todesangst

1A	RICHTIG	Richtig – Ruhe ausstrahlen, präsent sein, beruhigend führen.
1B	VERTRETBAR	Eigene Hektik überträgt sich – ruhig und strukturiert bleiben.
1C	FALSCH	Abwertung verstärkt die Angst – ernst nehmen und beruhigend begleiten.
2A		

RICHTIG Korrekt – Panikattacke ist eine Ausschlussdiagnose; Somatik nicht übersehen.

2B VERTRETBAR Symptome können auch körperlich bedingt sein – im Zweifel abklären.

3A RICHTIG Sehr gut – ruhige Atemführung und Präsenz, keine Beschämung.

3B VERTRETBAR Schnelles Atmen verstärkt die Hyperventilation – zu langsamem Atmen anleiten.

4A RICHTIG Sehr gut – Nachgespräch, Psychoedukation, Anbindung.

4B VERTRETBAR Ein kurzes Nachgespräch und Sicherheit sind hilfreich.

Merke: Panikattacke: ruhig und präsent bleiben, ernst nehmen, beruhigen, zu langsamem Atmen anleiten; trotzdem bedrohliche körperliche Ursachen prüfen (Ausschlussdiagnose, Vitalzeichen/SpO_2, im Zweifel ärztlich abklären); nach der Attacke kurzes Nachgespräch, Psychoedukation und Anbindung; keine Abwertung, keine eigene Hektik.

Fall 41 · Fieber und Rigor unter Neuroleptika

1A RICHTIG Richtig – MNS ist ein lebensbedrohlicher Notfall: Arzt sofort, Vitalzeichen, Neuroleptikum-Stopp veranlassen.

1B FALSCH Neuroleptika sind der Auslöser – eine Erhöhung verschlimmert das MNS.

1C VERTRETBAR Rigor + Fieber + Bewusstseinstrübung unter Neuroleptika spricht für MNS – nicht nur als Infekt abtun.

2A VERTRETBAR Symptomatische Fiebersenkung allein reicht nicht – Trigger absetzen, supportiv/Intensiv.

2B RICHTIG Korrekt – Trigger absetzen, supportiv stabilisieren, Intensiv.

3A VERTRETBAR MNS kann zu Rhabdomyolyse/Nierenversagen führen – breiter überwachen.

3B RICHTIG Sehr gut – Rhabdomyolyse/Niere, Elektrolyte und Kreislauf im Blick.

4A RICHTIG Sehr gut – Intensivüberwachung und supportive Therapie.

4B VERTRETBAR MNS erfordert intensive Überwachung – nicht zu früh zurückverlegen.

Merke: Malignes neuroleptisches Syndrom: lebensbedrohlicher Notfall (Fieber, Rigor, Bewusstseinstrübung, autonome Entgleisung unter Neuroleptika) – Arzt sofort, auslösendes Neuroleptikum absetzen (nach AO), supportiv stabilisieren (kühlen, Flüssigkeit/Elektrolyte, Vitalfunktionen), auf Rhabdomyolyse/Nierenversagen achten, Intensivüberwachung; die Dosis nie erhöhen, nicht als reinen Infekt verkennen.

Fall 42 · Das erste Gespräch

1A VERTRETBAR Gut gemeint, kann aber Druck erzeugen.

1B RICHTIG Richtig – Beziehung beginnt mit Zuhören.

1C FALSCH Beziehungsangebot ist gerade jetzt wichtig.

2A FALSCH Veränderungen würden übersehen.

2B RICHTIG Sehr gut – wichtige Verlaufsbeobachtung.

2C VERTRETBAR Der Gesamteindruck zählt.

3A FALSCH Solche Hinweise dürfen nie verschwiegen werden.

3B VERTRETBAR Besser ernst nehmen und im Team besprechen.

3C RICHTIG Richtig – Hinweise auf Eigengefährdung immer weitergeben.

4A RICHTIG Genau richtig.

4B VERTRETBAR Verlässliche Begleitung ist wichtig.

Merke: 1. Lernjahr Psychiatrie: wertschätzende Beziehung, zuhören, Stimmung beobachten, Hinweise auf Eigengefährdung immer ans Team weitergeben.

Fall 43 · Wundliegen vorbeugen

1A	RICHTIG	Der Fingertest unterscheidet eine harmlose Rötung von einer beginnenden Druckschädigung (nicht wegdrückbar = Alarm).
1B	FALSCH	Gefährdete, gerötete Haut wird nicht massiert – das schädigt das Gewebe zusätzlich.
1C	VERTRETBAR	Bei bettlägerigen Menschen ist eine Rötung ein Warnzeichen – beobachten und handeln statt abwarten.
2A	RICHTIG	Druckentlastung durch Lagewechsel/Bewegung ist die zentrale Dekubitusprophylaxe.
2B	VERTRETBAR	Punktuelles Unterpolstern (z. B. 'Ring') kann den Druck sogar erhöhen – flächig entlasten und umlagern.
3A	VERTRETBAR	Auch kleine Eigenbewegung ist wertvoll – Ressourcen fördern statt komplett abnehmen.
3B	RICHTIG	

Merke: Dekubitusprophylaxe: gefährdete Haut mit dem Fingertest prüfen (nicht wegdrückbar = Alarm), nicht massieren, konsequent Druck entlasten (Lagewechsel/Bewegung), Haut pflegen und trocken halten, Eigenbewegung fördern und alles dokumentieren.

Fall 44 · Sicher auf den Beinen

1A	RICHTIG	Risikofaktoren erkennen und gezielt vorbeugen ist der richtige Einstieg.
1B	VERTRETBAR	Selbstbestimmung ja – aber Risiken aktiv ansprechen und das Umfeld sichern gehört zur Fürsorge.
1C	FALSCH	Freiheitsentziehende Maßnahmen sind kein Standard-Sturzschutz (rechtlich/ethisch heikel, Verletzungsgefahr) – erst Umfeld und Begleitung.
2A	VERTRETBAR	Das ist unverhältnismäßig – Wege sichern und begleiten statt einschränken.
2B	RICHTIG	Ein sicheres, gut beleuchtetes Umfeld senkt das Sturzrisiko deutlich.
3A	FALSCH	Allein und gehetzt ist die Sturzgefahr am höchsten.
3B	RICHTIG	

Merke: Sturzprophylaxe: Risikofaktoren erkennen (Schwäche, Unsicherheit, nächtliche Wege), Umfeld sichern (Stolperfallen weg, Licht, Rufanlage, Hilfsmittel), zeitnah begleiten und Tempo anpassen, Selbstbestimmung achten – freiheitsentziehende Maßnahmen sind kein Standard-Sturzschutz.

Fall 45 · Werte deuten und melden

1A	FALSCH	Fieber plus erhöhter Puls am OP-Tag ist ein Warnzeichen – nicht ignorieren.
1B	RICHTIG	Auffällige Werte vollständig erfassen, dokumentieren und melden – richtig.
1C	FALSCH	Medikamente gibt man nicht eigenmächtig – erst melden, Gabe nur nach AO.
2A	RICHTIG	Eine klare, strukturierte Übergabe hilft, schnell richtig zu reagieren.
2B	VERTRETBAR	Ohne konkrete Werte kann niemand richtig einschätzen.
3A	RICHTIG	
3B	VERTRETBAR	Bei auffälligen Werten ist Nachkontrolle wichtig.

Merke: Vitalzeichen: auffällige Werte vollständig erfassen (Temp, Puls, RR, Atmung, ggf. SpO_2), keine eigenmächtige Medikamentengabe, strukturiert und mit konkreten Werten melden, dokumentieren und nachkontrollieren.

Fall 46 · Ankommen und Vertrauen schaffen

1A	VERTRETBAR	Auch unter Zeitdruck kurz, aber zugewandt – das nimmt Angst und beugt Missverständnissen vor.
1B	RICHTIG	Eine wertschätzende, verständliche Kommunikation schafft Vertrauen.
1C	FALSCH	Sprich mit der Patientin selbst (Respekt/Autonomie) – Angehörige einbeziehen, aber nicht ersetzen.
2A	RICHTIG	Verständnis sichern statt Fachjargon.
2B	VERTRETBAR	Lauter ist nicht verständlicher – einfache Worte wählen.
3A	RICHTIG	
3B	VERTRETBAR	Gefühle ernst nehmen und Würde aktiv schützen.

Merke: Kommunikation/Aufnahme: sich vorstellen, Zeit nehmen, aktiv zuhören, in einfacher Sprache erklären und Verständnis sichern, mit der Patientin selbst sprechen (Autonomie), Gefühle ernst nehmen, Intimsphäre und Würde schützen, Selbstständigkeit fördern.

Fall 47 · Körperpflege mit Würde

1A	RICHTIG	Aktivierende Pflege fördert Selbstständigkeit und Würde.
1B	FALSCH	Intimsphäre wahren: Tür/Sichtschutz, vorher erklären und um Erlaubnis fragen.
1C	VERTRETBAR	Komplettübernahme baut Selbstständigkeit ab – nur so viel helfen wie nötig.
2A	VERTRETBAR	Das verletzt Würde und Schamgefühl – Privatsphäre konsequent schützen.
2B	RICHTIG	Intimsphäre und Beobachtung gehören zusammen.
3A	RICHTIG	
3B	VERTRETBAR	Hautveränderungen gehören beobachtet, dokumentiert und gemeldet.

Merke: Körperpflege: ressourcenorientiert arbeiten (selbst machen lassen, was geht, nur nötige Hilfe), vorher erklären und Einverständnis einholen, Intimsphäre und Würde schützen (Sichtschutz, nur Nötiges freilegen, angenehme Temperatur), Hautzustand beobachten, dokumentieren und melden.

Fall 48 · Atmen nach der OP

1A	FALSCH	Husten ist hier schützend; Medikamente nur nach AO – nicht eigenmächtig.
1B	VERTRETBAR	Reine Schonung erhöht das Pneumonierisiko – aktivierende Atem- und Bewegungsförderung ist richtig.
1C	RICHTIG	Flache Atmung plus Immobilität begünstigen eine Lungenentzündung – gezielt vorbeugen.
2A	RICHTIG	Aufrechte Position, tiefe Atmung und Mobilisation belüften die Lunge.
2B	VERTRETBAR	Flachlage erschwert die Atmung – Oberkörper hoch.
3A	VERTRETBAR	Schmerz ernst nehmen – sonst bleibt die Atmung flach.
3B	RICHTIG	

Merke: Pneumonieprophylaxe: Risiko erkennen (flache Atmung, wenig Husten, Immobilität), Oberkörper hoch, tiefe Atmung und Abhusten anleiten (Wunde stützen), regelmäßig mobilisieren, Schmerz ernst nehmen und melden (Therapie nach AO) – keine eigenmächtige Medikamentengabe.

Fall 49 · Genug trinken im Alter

1A	RICHTIG	Diese Zeichen sprechen für Flüssigkeitsmangel – gegensteuern und melden.
1B	FALSCH	Auch ältere Menschen brauchen ausreichend Flüssigkeit – das Durstgefühl ist im Alter oft vermindert.
1C	VERTRETBAR	Bei Zeichen von Austrocknung nicht abwarten – aktiv anbieten und beobachten.
2A	VERTRETBAR	Zwang und große Mengen auf einmal sind ungünstig – lieber regelmäßig kleine Mengen.
2B	RICHTIG	Niederschwellige, regelmäßige Trinkangebote helfen am meisten.
3A	VERTRETBAR	Anhaltend wenig Trinken plus Verschlechterung gehört gemeldet.
3B	RICHTIG	

Merke: Flüssigkeitsmangel im Alter: Zeichen erkennen (trockene Schleimhäute, stehende Hautfalte, Müdigkeit/Verwirrtheit, wenig Trinken), regelmäßig kleine Mengen anbieten und erinnern, beim Trinken helfen, Trinkmenge/Ein- und Ausfuhr erfassen, bei anhaltend wenig Trinken oder Verschlechterung melden und dokumentieren.

Fall 50 · Wenn der Appetit fehlt

1A	VERTRETBAR	Druck verstärkt die Ablehnung – Ursachen klären und das Essen anpassen.
1B	FALSCH	Nicht übergehen – wenig Essen und Gewichtsverlust sind ernst zu nehmen und zu melden.
1C	RICHTIG	Mangelernährung früh erkennen und gegensteuern.
2A	RICHTIG	Kost an Bedürfnisse anpassen und eine angenehme Esssituation schaffen.
2B	VERTRETBAR	Große, immer gleiche Portionen schrecken eher ab – lieber klein, abwechslungsreich, passend.
3A	VERTRETBAR	Anhaltender Gewichtsverlust gehört gemeldet und abgeklärt.
3B	RICHTIG	

Merke: Mangelernährung: Warnzeichen erkennen (wenig Essen, Gewichtsverlust, Kauprobleme), Essmenge und Gewicht beobachten/dokumentieren, Ursachen ansprechen, Kost an Bedürfnisse anpassen (Vorlieben, Konsistenz, kleine appetitliche Portionen, angenehme Esssituation), bei anhaltendem Gewichtsverlust melden und abklären lassen.

Fall 51 · Plötzliche Halbseitensymptomatik

1A	FALSCH	Bei akutem Defizit kein Abwarten – jede Minute zählt (Lyse-Fenster).
1B	RICHTIG	Schlaganfall ist 'time is brain': FAST, Zeitfenster, Team, Patient nüchtern.
1C	FALSCH	Bei Schluckstörung/Schlaganfall droht Aspiration – nüchtern lassen.
2A	RICHTIG	BZ messen (Hypoglykämie ahmt Schlaganfall nach!), CT vor Lyse, Vitalwerte.
2B	VERTRETBAR	Beim akuten ischämischen Schlaganfall wird der Blutdruck nicht vorschnell stark gesenkt – nach Schema/AO.
3A	VERTRETBAR	Erst Schluck-Screening; flaches Liegen und orale Gabe sind ungünstig bzw. riskant.
3B	RICHTIG	Schluck-Screening vor erster oraler Gabe, Oberkörper hoch, Neuromonitoring.
4A	VERTRETBAR	Engmaschiges Neuromonitoring ist nötig.
4B	RICHTIG	

Merke: Akuter Schlaganfall: FAST, Symptombeginn/Zeitfenster, sofort Stroke-Unit; BZ messen (Hypoglykämie als Mimic), CT vor Lyse, Blutdruck nach Schema (nicht vorschnell senken), nüchtern bis Schluck-Screening, Oberkörper 30°, engmaschiges Neuromonitoring.

Fall 52 · Anhaltender Krampfanfall

1A	RICHTIG	Schützen, nichts in den Mund, Atemweg/O_2, Dauer messen, Team.
1B	FALSCH	Ab >5 min = Status epilepticus, der durchbrochen werden muss – nicht abwarten.
1C	FALSCH	Nicht festhalten, nichts in den Mund (Verletzungsgefahr) – nur die Umgebung sichern.
2A	RICHTIG	Benzodiazepin als erste Stufe, BZ (Hypoglykämie!) prüfen.
2B	VERTRETBAR	Stufenweise nach Schema; unkontrollierte Mehrfachgabe riskiert Atemdepression.
3A	VERTRETBAR	Postiktal nicht sofort oral/mobilisieren – Vigilanz und Schlucken beachten.
3B	RICHTIG	Nach Benzodiazepin ist Atemdepression möglich – Atemweg sichern.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Re-Anfall und Atemdepression sind möglich – weiter überwachen.

Merke: Status epilepticus (>5 min): schützen, nichts in den Mund, Atemweg/O_2, Dauer messen; Benzodiazepin nach Schema, BZ prüfen; nach Sistieren Atemweg/Atemdepression beachten, Vigilanz/SpO_2/BZ überwachen, auf erneuten Anfall vorbereitet sein.

Fall 53 · Vernichtungskopfschmerz

1A	RICHTIG	Ein Donnerschlagkopfschmerz ist bis zum Beweis des Gegenteils eine SAB.
1B	FALSCH	Plötzlicher Vernichtungskopfschmerz ist keine banale Migräne – sofort abklären.
2A	RICHTIG	CT, Neuromonitoring, Blutdruck nach AO (Nachblutungsrisiko).
2B	VERTRETBAR	Pressen/Anstrengung erhöht das Nachblutungsrisiko – Ruhe.
3A	RICHTIG	Reizabschirmung, auf Nachblutungs-/Hirndruckzeichen achten.
3B	VERTRETBAR	Reize und Anstrengung sind ungünstig – reizarm und ruhig.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Neuromonitoring und Komplikationen im Blick behalten.

Merke: SAB (Donnerschlagkopfschmerz): sofort abklären (CT), nicht als Migräne abtun; strenge Ruhe, Reizabschirmung, Blutdruck nach AO, Pressen vermeiden, engmaschig Bewusstsein/Pupillen, auf Nachblutung/Hirndruck/Vasospasmus achten, Intensiv.

Fall 54 · Eintrübung mit weiter Pupille

1A	RICHTIG	Hirndruckzeichen + Cushing-Reflex = Notfall: Oberkörper hoch, Kopf neutral, Arzt sofort.
1B	FALSCH	Vigilanzabfall plus weite Pupille sind Alarmzeichen – nicht abwarten.
2A	VERTRETBAR	Kopftief-/Flachlage erhöht den Hirndruck – Oberkörper hoch, Kopf gerade.
2B	RICHTIG	Lagerung für venösen Abfluss, Hirndruck senken nach AO, Intensiv.
3A	VERTRETBAR	Starke Reize und unsachgemäßes Absaugen steigern den Hirndruck – schonend, nach AO.
3B	RICHTIG	GCS/Pupillen, hirndrucksteigernde Faktoren vermeiden.
4A	RICHTIG	

4B VERTRETBAR Kontinuierliches Neuromonitoring ist nötig.

Merke: Erhöhter Hirndruck/drohende Einklemmung (Vigilanzabfall, weite Pupille, Cushing-Reflex): Notfall – Oberkörper ~30°, Kopf in Mittelstellung (venöser Abfluss), O_2/Atemweg, hirndrucksteigernde Faktoren (Pressen/Husten/Schmerz/Halsknick) vermeiden, kontinuierlich GCS/Pupillen/Vitalzeichen, Therapie nach AO, Intensiv.

Fall 55 · Zunehmende Muskelschwäche

1A FALSCH Bei Schluckstörung droht Aspiration – nüchtern lassen, Atemweg sichern.

1B RICHTIG Die Atemmuskulatur ist gefährdet: Atmung/Schlucken im Fokus, Arzt sofort.

2A RICHTIG Vitalkapazität/Atemarbeit überwachen, rechtzeitig eskalieren.

2B VERTRETBAR Bei drohender Ateminsuffizienz engmaschig überwachen, nicht allein lassen.

3A RICHTIG Aspirationsschutz, Kräfteschonung, Medikamente nach AO.

3B VERTRETBAR Überlastung verstärkt die Schwäche – dosiert, Kräfte schonen.

4A RICHTIG

4B VERTRETBAR Die Krise kann rasch eskalieren – engmaschig bleiben.

Merke: Myasthene Krise: Atem- und Schluckmuskulatur gefährdet – Atmung/SpO_2/Vitalkapazität engmaschig, respiratorische Erschöpfung früh erkennen, O_2/Beatmungsbereitschaft, Aspirationsschutz (nüchtern bei Schluckstörung), Kräfte schonen, Medikamente exakt nach AO, Intensiv.

Fall 56 · Rückenschmerz mit Taubheit

1A FALSCH Mit diesen Red Flags ist das kein banaler Rückenschmerz – sofortige Abklärung.

1B RICHTIG Reithosenanästhesie plus Blasenstörung = Cauda-Notfall, sofort melden.

2A VERTRETBAR Bei Cauda-Syndrom drohen bleibende Schäden – rasche OP-Abklärung, kein Abwarten.

2B RICHTIG MRT dringlich, Blasenfunktion/Neurostatus dokumentieren; Zeit zählt für die Prognose.

3A RICHTIG Neurostatus, Blasenmanagement, OP-Vorbereitung.

3B VERTRETBAR Die neurologischen Ausfälle sind hier das Entscheidende – engmaschig beobachten.

4A RICHTIG

4B VERTRETBAR Dringlichkeit – nicht auf die Routine warten.

Merke: Cauda-equina-Syndrom (Reithosenanästhesie, Blasenentleerungsstörung, Beinschwäche): neurochirurgischer Notfall – sofort melden, dringend MRT, Neurostatus und Blasenfunktion dokumentieren/managen, rasche OP-Abklärung (Zeit beeinflusst die Prognose); nicht konservativ abwarten.

Fall 57 · Sturzgefahr nach Schlaganfall

1A FALSCH Bei Halbseitenschwäche ist das hochgefährlich.

1B FALSCH Fixierung ist freiheitsentziehend und nur mit Anordnung erlaubt.

1C RICHTIG Richtig – hohes Sturzrisiko.

2A VERTRETBAR Rutschgefahr – festes Schuhwerk ist sicherer.

2B RICHTIG Sehr gut – sicherer Transfer.

2C FALSCH Sturz- und Verletzungsgefahr.

3A	VERTRETBAR	Zu eng gefasst.
3B	FALSCH	Neurologische Verschlechterung würde übersehen.
3C	RICHTIG	Richtig – z. B. Aspirationsgefahr bei Schluckstörung.
4A	VERTRETBAR	Ein Teilaspekt – die Sturzprophylaxe ist umfassender.
4B	RICHTIG	Genau richtig.

Merke: 1. Lernjahr Neurologie: Sturzrisiko erkennen, sicherer Transfer, Schlucken/Orientierung beobachten, keine eigenmächtige Fixierung.

Fall 58 · Fieber unter Chemotherapie

1A	RICHTIG	Febrile Neutropenie ist ein Notfall – keine Zeit verlieren.
1B	FALSCH	Bei Neutropenie kann sich rasch eine Sepsis entwickeln – nicht abwarten.
2A	VERTRETBAR	Antibiose nicht bis zum Kulturergebnis verzögern – kalkuliert nach AO starten.
2B	RICHTIG	Blutkulturen, dann zügig Antibiose; Verzögerung verschlechtert die Prognose.
3A	RICHTIG	Schutzisolation und Sepsismonitoring.
3B	VERTRETBAR	Bei Neutropenie strenge Hygiene/Schutzmaßnahmen – Infektionsrisiko minimieren.
4A	VERTRETBAR	Sepsisgefahr – engmaschig bleiben.
4B	RICHTIG	

Merke: Febrile Neutropenie: onkologischer Notfall – sofort Arzt, Blutkulturen/Fokussuche vor Antibiose, dann zügige kalkulierte Antibiose nach AO (nicht auf das Kulturergebnis warten), Kreislauf-/Sepsismonitoring, strenge Schutzisolation/Hygiene, Intensiv bei Verschlechterung.

Fall 59 · Entgleisung nach Chemo-Start

1A	FALSCH	Die Elektrolytentgleisung (v. a. Hyperkaliämie) ist gefährlich – nicht abwarten.
1B	RICHTIG	Das Tumorlyse-Syndrom ist ein onkologischer Notfall mit Hyperkaliämie- und Nierenrisiko.
2A	VERTRETBAR	Gerade ausreichende Hydrierung schützt die Niere – nicht restriktiv (außer bei Anurie/Überwässerung nach AO).
2B	RICHTIG	Volumen, Elektrolyt-/Hyperkaliämiemanagement, Harnsäure, Niere im Blick.
3A	RICHTIG	Hyperkaliämie = EKG-Monitoring; Niere/Bilanz im Blick.
3B	VERTRETBAR	Beim TLS sind EKG/Elektrolyte/Niere entscheidend, nicht die Temperatur.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Den TLS-Verlauf engmaschig kontrollieren.

Merke: Tumorlyse-Syndrom: Notfall durch Zellzerfall (Hyperkaliämie/-phosphatämie/-urikämie, Hypokalzämie, Nierengefahr) – ausreichende Hydrierung nach AO, EKG-/Elektrolyt-/Nierenmonitoring, Hyperkaliämie und Harnsäure behandeln nach AO, Bilanz, ggf. Intensiv/Dialyse.

Fall 60 · Gestaute Halsvenen, Atemnot

1A	FALSCH	Flachlage verstärkt die Stauung und Atemnot – Oberkörper hochlagern.
1B	RICHTIG	Oberkörper hoch (venöser Rückfluss/Atmung), O_2, Arzt.

2A	VERTRETBAR	Zugänge/Messungen besser nicht am gestauten Bereich – die Stauung nicht verstärken.
2B	RICHTIG	Symptomatisch (Lagerung/O_2) plus rasche ursächliche Therapieplanung.
3A	RICHTIG	Atemwegssicherheit, Lagerung, Angst, Verlauf.
3B	VERTRETBAR	Flachlage/Anstrengung verstärken die Symptomatik – Oberkörper hoch, Ruhe.
4A	VERTRETBAR	Engmaschige Atemüberwachung ist nötig.
4B	RICHTIG	

Merke: Obere Einflussstauung (VCSS): Oberkörper hochlagern (venöser Rückfluss/Atmung), O_2 nach AO, Atmung/SpO_2 engmaschig, Zugänge/Messungen nicht am gestauten Bereich, Angst reduzieren, rasche ursächliche Therapieplanung nach AO; auf Atemwegsverlegung/Hirndruckzeichen achten, Intensiv bei Verschlechterung.

Fall 61 · Verwirrt und exsikkiert

1A	FALSCH	Die Hyperkalzämie ist behandelbar und gefährlich – nicht einfach abwarten.
1B	RICHTIG	Die Symptomtrias passt zur Hyperkalzämie – Arzt, Bilanz, Schutz.
2A	VERTRETBAR	Die Patientin ist exsikkiert – Hydrierung ist die Basistherapie, nicht Flüssigkeitsrestriktion.
2B	RICHTIG	Rehydrierung steht im Vordergrund, dann kalziumsenkende Therapie nach AO.
3A	RICHTIG	Neuro/EKG, Bilanz, Sturzschutz, Symptommanagement.
3B	VERTRETBAR	Bei Verwirrtheit/Schwäche besteht Sturzgefahr – Schutz und Begleitung.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Den Verlauf weiter kontrollieren.

Merke: Maligne Hyperkalzämie (Müdigkeit/Verwirrtheit, Übelkeit, Obstipation, Polyurie/Exsikkose): Arzt, ausreichende Rehydrierung nach AO als Basis, dann kalziumsenkende Therapie nach AO, EKG/Elektrolyte/Bilanz, Bewusstseins- und Sturzschutz, Symptommanagement; keine Flüssigkeitsrestriktion.

Fall 62 · Brennen an der Infusionsstelle

1A	FALSCH	Zytostatika-Paravasate können schwere Gewebeschäden verursachen – sofort stoppen.
1B	RICHTIG	Sofort stoppen, Zugang belassen, aspirieren nach Standard, Arzt, hochlagern.
1C	VERTRETBAR	Erst nach Standard aspirieren; Massieren verteilt die Substanz und schadet.
2A	RICHTIG	Substanzabhängige Maßnahmen nach Standard, Antidot nach AO, dokumentieren.
2B	VERTRETBAR	Kälte/Wärme sind substanzabhängig – nach Standard, nicht pauschal.
3A	VERTRETBAR	Engmaschige Beobachtung ist nötig – Komplikationen früh erkennen.
3B	RICHTIG	Beobachtung/Lagerung, Schmerz, Dokumentation, Aufklärung.
4A	VERTRETBAR	Spätschäden sind möglich – Verlauf beobachten.
4B	RICHTIG	

Merke: Zytostatika-Paravasat: Infusion sofort stoppen (Zugang zunächst belassen, Reste aspirieren nach Standard), Arzt, Extremität hochlagern, substanzspezifische Maßnahmen nach Standard (Kälte/Wärme/Antidot – nicht pauschal), nicht massieren, engmaschige Beobachtung und Dokumentation, bei Bedarf Fachstelle.

Fall 63 · Plötzliche Schmerzkrise

1A	RICHTIG	Erfassen, schnell wirksame Bedarfsmedikation nach AO, Präsenz.
1B	VERTRETBAR	Nicht-medikamentöse Maßnahmen ergänzen, ersetzen aber bei NRS 9 nicht die Bedarfsmedikation nach AO.
1C	FALSCH	Durchbruchschmerz wird mit Bedarfsmedikation behandelt – nicht auf die nächste Basisgabe warten.
2A	VERTRETBAR	Keine eigenmächtige Dosissteigerung – nach AO nachsteuern, Atemdepression vermeiden.
2B	RICHTIG	Wirkung reevaluieren und nach AO anpassen, Nebenwirkungen beobachten.
3A	RICHTIG	Opioid-Nebenwirkungen, Ursache bedenken, Doku, Zuwendung.
3B	VERTRETBAR	Auf Atmung/Sedierung und erneuten Schmerz weiter achten.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Wiederholte Reevaluation ist nötig.

Merke: Durchbruchschmerz/Schmerzkrise: strukturiert erfassen, schnell wirksame Bedarfsmedikation nach AO (nicht auf die nächste Basisgabe warten), Wirkung reevaluieren und nach AO nachsteuern (keine eigenmächtige Dosissteigerung), Opioid-Nebenwirkungen (Sedierung/Atemdepression, Obstipation/Übelkeit) beachten, nicht-medikamentöse Maßnahmen ergänzend, häufigen Durchbruchschmerz → Basistherapie ärztlich überprüfen.

Fall 64 · Patientin unter Chemotherapie

1A	FALSCH	Du könntest die Patientin gefährden.
1B	VERTRETBAR	Schutzmaßnahmen müssen konsequent sein.
1C	RICHTIG	Richtig – Schutz der abwehrgeschwächten Patientin.
2A	RICHTIG	Sehr gut – Schleimhäute und Haut sind gefährdet.
2B	FALSCH	Mukositis-Risiko wird übersehen.
2C	VERTRETBAR	Mund- und Hautbeobachtung sind hier zentral.
3A	RICHTIG	Richtig – neutropenes Fieber ernst nehmen.
3B	FALSCH	Verzögerung kann gefährlich werden.
3C	VERTRETBAR	Bei Immunschwäche zählt schon dieses Fieber.
4A	VERTRETBAR	Meldung und Gesamtdoku gehören dazu.
4B	RICHTIG	Genau richtig.

Merke: 1. Lernjahr Onkologie: konsequenter Infektionsschutz, Mund-/Hautpflege, Fieber bei Abwehrschwäche ist ein Notfall.

Fall 65 · Akuter Hodenschmerz

1A	FALSCH	Ein plötzlicher heftiger Hodenschmerz ist ein Notfall – nicht abwarten.
1B	VERTRETBAR	Bei drohender OP nüchtern lassen – orale Aufnahme verzögert den Eingriff.
1C	RICHTIG	Bei Torsionsverdacht zählt die Zeit (Hodenrettung) – sofort Urologie, nüchtern lassen.
2A	VERTRETBAR	Alleinige Schmerztherapie verschleppt die Diagnose – dringende Abklärung.
2B	RICHTIG	Doppler-Sono, OP-Vorbereitung, nüchtern – das Zeitfenster ist eng.
3A	VERTRETBAR	Eine Reposition ist ärztlich – nicht eigenmächtig manipulieren.
3B		

RICHTIG Nüchtern, OP-Vorbereitung, Schmerz nach AO, Dringlichkeit.

4A RICHTIG

4B VERTRETBAR Die Hodenrettung ist zeitabhängig – zügig handeln.

Merke: Hodentorsion: urologischer Notfall mit engem Zeitfenster – sofort Urologie, nüchtern lassen (OP), dringende Doppler-Sono, Schmerz nach AO, OP-Vorbereitung; nicht abwarten, nicht durch alleinige Schmerzmittelgabe verschleppen, Reposition ist ärztlich.

Fall 66 · Kein Wasserlassen möglich

1A VERTRETBAR Druck auf die volle Blase ist schmerzhaft und schädlich – nicht pressen.

1B FALSCH Die überdehnte Blase muss entlastet werden – nicht abwarten.

1C RICHTIG Praller Unterbauch + kein Wasserlassen = Harnverhalt, Entlastung nach AO.

2A RICHTIG Katheter nach AO, aseptisch, Menge erfassen.

2B VERTRETBAR Schlagartige komplette Entleerung kann Kreislaufprobleme/Entlastungsblutung auslösen – kontrolliert ablassen.

3A RICHTIG Bilanz, Kreislauf/Entlastungsblutung, Ursache.

3B VERTRETBAR Die Menge/Bilanz ist wichtig – dokumentieren.

4A VERTRETBAR Verlauf und mögliche Entlastungsblutung im Blick behalten.

4B RICHTIG

Merke: Akuter Harnverhalt: Blase per Katheter nach AO entlasten (aseptisch), kontrolliert/nicht schlagartig vollständig ablassen, Ein-/Ausfuhr erfassen, Kreislauf/Entlastungsblutung beobachten, Ursache abklären; nicht abwarten, nicht auf den Unterbauch pressen.

Fall 67 · Heftiger Flankenschmerz

1A VERTRETBAR Fieber bei Harnstau kann auf eine gefährliche Urosepsis hinweisen – immer mit prüfen.

1B RICHTIG Wellenartiger Flankenschmerz spricht für eine Kolik – Temperatur/Vitalzeichen mit beachten.

1C FALSCH Die typische Kolik gehört abgeklärt und behandelt – nicht abtun.

2A VERTRETBAR Die Kolik ist sehr schmerzhaft – Analgesie nach AO gehört dazu.

2B RICHTIG Schmerz-/Spasmolyse nach AO, Urin sieben, Temperatur im Blick.

3A RICHTIG Fieber/Schüttelfrost = Alarm (Urosepsis), sofort melden.

3B VERTRETBAR Fieber bei Harnstein/Harnstau ist ein Warnzeichen – nicht ignorieren.

4A RICHTIG

4B VERTRETBAR Verlauf und Warnzeichen weiter beobachten.

Merke: Nierenkolik (Harnstein): Schmerz-/Spasmolyse nach AO (Wärme lindert), Urin beobachten/sieben, Flüssigkeit nach AO; engmaschig auf Fieber/Schüttelfrost (Urosepsis-Gefahr!) und Harnverhalt achten und bei Fieber sofort melden.

Fall 68 · Katheter läuft nicht

1A RICHTIG Erst das System prüfen – häufige Ursachen sind Abknickung/Lage.

1B FALSCH Bei prallem Unterbauch droht eine Blasenüberdehnung – nicht abwarten.

1C

VERTRETBAR Ziehen kann verletzen (Ballon!) – nicht am Katheter zerren.

2A RICHTIG Erst einfache Ursachen, dann Anspülen/Wechsel nach Standard.

2B VERTRETBAR Unkontrolliertes Spülen mit Druck schadet – nach Standard/AO vorgehen.

3A RICHTIG Fluss/Bilanz, Blase, Asepsis, Verlauf.

3B VERTRETBAR Bilanz/Verlauf sind wichtig – dokumentieren.

4A VERTRETBAR Eine erneute Verstopfung im Blick behalten.

4B RICHTIG

Merke: Verstopfter Dauerkatheter: erst einfache Ursachen prüfen (Abknickung, Lage, Beutelhöhe), bei fortbestehender Obstruktion Anspülen/Wechsel nach AO/Standard (aseptisch), nicht am Katheter zerren, Urinfluss/Bilanz und Blase überwachen, auf Harnverhalt achten, dokumentieren.

Fall 69 · Blutiger Urin, plötzlich kein Abfluss

1A FALSCH Tamponade und Blutverlust sind gefährlich – nicht abwarten.

1B VERTRETBAR Bei Blutung droht ein Schock – Kreislauf engmaschig beachten.

1C RICHTIG Koagel-Tamponade + Blässe = Kreislauf im Blick, sofort Urologie.

2A RICHTIG Dauerspülung/Koagelausspülung nach AO, Kreislauf stützen.

2B VERTRETBAR Der Blutverlust ist das Hauptproblem – Kreislauf/Volumen nach AO.

3A VERTRETBAR Vorzeitiger Spülstopp begünstigt eine erneute Tamponade – nach AO weiterführen.

3B RICHTIG Kreislauf, Spülung/Abfluss, Bilanz, erneute Tamponade.

4A VERTRETBAR Bei Blutung engmaschig überwachen.

4B RICHTIG

Merke: Makrohämaturie mit Blasentamponade: Harnverhalt durch Koagel – sofort Urologie, Dauerspülung/Koagelausspülung nach AO (aseptisch), engmaschig Kreislauf/Vitalzeichen wegen Blutverlust, Volumen/Transfusion nach AO, Bilanz, Spülung/Abfluss überwachen; nicht abwarten, den Kreislauf nie aus dem Blick verlieren.

Fall 70 · Verwirrt nach Prostata-OP

1A RICHTIG Verwirrtheit nach TUR-P mit Spülung = an Hyponatriämie/TUR-Syndrom denken.

1B FALSCH Diese Zeichen können ein TUR-Syndrom sein – nicht einfach abwarten.

1C VERTRETBAR Das Grundproblem ist die Elektrolytentgleisung – nicht nur das Symptom behandeln.

2A VERTRETBAR Zusätzliche freie Flüssigkeit verstärkt die Verdünnungshyponatriämie – nicht eigenmächtig.

2B RICHTIG Natrium/Elektrolyte und Bilanz nach AO, engmaschig überwachen.

3A RICHTIG Neuro/Vitalzeichen, genaue Bilanz, Elektrolyte nach AO.

3B VERTRETBAR Engmaschiges Monitoring ist nötig.

4A VERTRETBAR Den Verlauf engmaschig kontrollieren.

4B RICHTIG

Merke: TUR-Syndrom (Verdünnungshyponatriämie durch Spülflüssigkeitsaufnahme bei TUR-P): Verwirrtheit/Übelkeit/Kopfschmerz/Kreislaufveränderung ernst nehmen – sofort Arzt/Anästhesie, Vitalzeichen/Neurostatus engmaschig, Natrium/Elektrolyte und Bilanz nach AO, keine eigenmächtige zusätzliche freie Flüssigkeit, Intensivüberwachung; nicht als bloßes 'Narkose-Nachwirken' abtun.

Fall 71 · Der Blasenkatheter

1A	RICHTIG	Richtig – Rückfluss vermeiden, System geschlossen halten.
1B	FALSCH	Über Blasenniveau droht Rückfluss und Infektion.
1C	FALSCH	Eigenmächtiges Abklemmen kann Harnstau verursachen.
2A	FALSCH	Hauptübertragungsweg für Keime.
2B	RICHTIG	Sehr gut – Hygiene senkt das HWI-Risiko.
2C	VERTRETBAR	Regelmäßige, sorgfältige Pflege ist nötig.
3A	FALSCH	Kann auf Harnstau oder Nierenproblem hinweisen.
3B	VERTRETBAR	Trinken hilft, die geringe Ausfuhr muss aber gemeldet werden.
3C	RICHTIG	Richtig – Ursache suchen und melden.
4A	RICHTIG	Genau richtig.
4B	VERTRETBAR	Ein- und Ausfuhr gehören vollständig erfasst.

Merke: 1. Lernjahr Urologie: geschlossenes System, Beutel unter Blasenniveau, Hygiene, Ein-/Ausfuhr bilanzieren, Infektzeichen melden.

Fall 72 · Starke Blutung nach der Geburt

1A	FALSCH	Starke anhaltende Blutung ist kein normaler Wochenfluss – sofort handeln.
1B	RICHTIG	Weicher Uterus + starke Blutung = Atonie, sofort Hilfe holen.
1C	VERTRETBAR	Bei starker Blutung droht ein Schock – Kreislauf engmaschig beachten.
2A	RICHTIG	Fundusmassage + Blasenentleerung + Uterotonika nach AO.
2B	VERTRETBAR	Bei Atonie hilft die Fundusmassage, den Uterus zu kontrahieren – nicht unterlassen.
3A	RICHTIG	Kreislauf, Blutung/Uterustonus, Volumen nach AO.
3B	VERTRETBAR	Den Blutverlust einschätzen und dokumentieren ist wichtig.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Bei Blutung engmaschig überwachen.

Merke: Postpartale Blutung (häufig Uterusatonie): sofort Hilfe – Fundusmassage, Blase entleeren, uteruskontrahierende Medikamente nach AO, Zugang/Volumen/Transfusion nach AO, engmaschig Kreislauf/Vitalzeichen und Blutungsstärke, Blutverlust einschätzen/dokumentieren; nicht als normalen Wochenfluss verkennen.

Fall 73 · Hoher Blutdruck mit Warnzeichen

1A	FALSCH	Diese Zeichen kündigen einen Krampfanfall an – nicht abwarten.
1B	RICHTIG	Diese Trias bei Hypertonie spricht für Präeklampsie mit Krampfgefahr.
1C	VERTRETBAR	Reize können einen Krampf begünstigen – reizarm und ruhig.

2A	RICHTIG	Reizarm, RR engmaschig, Magnesium nach AO, Krampfbereitschaft.
2B	VERTRETBAR	Bei Krampfgefahr nicht allein lassen – Überwachung und Bereitschaft.
3A	VERTRETBAR	Nichts in den Mund, nicht festhalten – nur die Umgebung sichern.
3B	RICHTIG	Schützen, nichts in den Mund, Atemweg/O_2, Therapie nach AO.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Weiter engmaschig überwachen (erneuter Krampf möglich).

Merke: Präeklampsie/Eklampsie (Hypertonie + Kopfschmerz/Sehstörung/Oberbauchschmerz, Krampfgefahr): sofort Arzt, reizarme ruhige Umgebung, RR/Vitalzeichen engmaschig, Krampfprophylaxe (Magnesium) nach AO, Krampfbereitschaft; bei Krampf schützen (nichts in den Mund), Atemweg/O_2, Mutter und Kind überwachen.

Fall 74 · Akuter Unterbauchschmerz in der Frühschwangerschaft

1A	RICHTIG	Frühschwangerschaft + akuter Schmerz + Schock = an rupturierte EUG denken.
1B	FALSCH	Mit Schockzeichen ist das ein Notfall – nicht als Regelschmerz abtun.
1C	VERTRETBAR	Blässe/Tachykardie/Hypotonie sind Schockzeichen – ernst nehmen.
2A	VERTRETBAR	Bei drohender OP nüchtern lassen – orale Aufnahme verzögert den Eingriff.
2B	RICHTIG	Kreislauf stützen, nüchtern, OP-Vorbereitung.
3A	RICHTIG	Schockzeichen, Blutung, OP-Vorbereitung, nüchtern.
3B	VERTRETBAR	Die Schmerztherapie ersetzt nicht die dringende Abklärung/OP.
4A	VERTRETBAR	Bei Schockgefahr engmaschig überwachen.
4B	RICHTIG	

Merke: Rupturierte Extrauteringravidität (Frühschwangerschaft + akuter einseitiger Unterbauchschmerz + Schock): lebensbedrohlich – sofort Arzt/Notfall, Zugang/Volumen nach AO, nüchtern lassen (OP), OP-Vorbereitung, Transfusionsbereitschaft, engmaschig Kreislauf/Schockzeichen; nicht als Regelschmerz verkennen.

Fall 75 · Brustentzündung in der Stillzeit

1A	FALSCH	Ein Stillstopp begünstigt den Milchstau und verschlimmert die Mastitis – weiter entleeren.
1B	RICHTIG	Lokale Entzündung + Fieber in der Stillzeit = Mastitis; weiter entleeren.
1C	VERTRETBAR	Mastitis sollte früh behandelt werden – nicht abwarten.
2A	RICHTIG	Entleeren, schonende Maßnahmen, Therapie nur nach AO.
2B	VERTRETBAR	Medikamente (auch Antibiotika) nur nach AO – nicht eigenmächtig.
3A	VERTRETBAR	Eine Abszessbildung muss erkannt werden – nicht ignorieren.
3B	RICHTIG	Verlauf (Abszess?), Stillunterstützung, Symptommanagement.
4A	VERTRETBAR	Den Verlauf (Abszess?) im Blick behalten.
4B	RICHTIG	

Merke: Mastitis puerperalis (Rötung/Schmerz/Überwärmung + Fieber in der Stillzeit): weiter regelmäßig entleeren/stillen (Milchstau lösen!), schonende Maßnahmen nach Vorgabe, Schmerz-/Fiebermanagement und Antibiotika nur nach AO, Verlauf beobachten (Abszess?), Stillunterstützung; Stillen nicht abrupt stoppen, keine eigenmächtige Medikamentengabe.

Fall 76 · Starkes Erbrechen in der Schwangerschaft

1A	RICHTIG	Häufiges Erbrechen + Exsikkose-Zeichen = Hyperemesis, einschätzen und melden.
1B	FALSCH	Mit Gewichtsverlust/Exsikkose ist das mehr als normale Übelkeit – nicht abwarten.
1C	VERTRETBAR	Große Mahlzeiten verstärken das Erbrechen – kleine Mengen anbieten.
2A	VERTRETBAR	Medikamente nur nach AO – gerade in der Schwangerschaft nicht eigenmächtig.
2B	RICHTIG	Flüssigkeit/Antiemese nach AO, kleine Mengen, Bilanz.
3A	RICHTIG	Bilanz/Gewicht, Exsikkose-Zeichen, Reize meiden.
3B	VERTRETBAR	Bilanz/Gewicht sind wichtig – erfassen.
4A	VERTRETBAR	Den Flüssigkeits-/Ernährungszustand weiter im Blick behalten.
4B	RICHTIG	

Merke: Hyperemesis gravidarum (häufiges Erbrechen mit Exsikkose): Flüssigkeit/Elektrolyte und Antiemese nach AO (oft i.v.), kleine leichte Mahlzeiten/Schlucke, Reize/Gerüche meiden, Ein-/Ausfuhr und Gewicht erfassen, auf Verschlechterung achten; nicht zum Essen zwingen, keine eigenmächtige Medikamentengabe.

Fall 77 · Schwindel in Rückenlage (Schwangerschaft)

1A	FALSCH	Die Rückenlage ist die Ursache – Lagerung sofort ändern.
1B	RICHTIG	In Rückenlage drückt der Uterus auf die V. cava – sofort Linksseitenlage.
1C	VERTRETBAR	Ruckartiges Aufrichten kann den Kreislauf weiter belasten – kontrolliert in Linksseitenlage.
2A	VERTRETBAR	Bei Blutdruckabfall die Lagerung ändern und überwachen – nicht abwarten.
2B	RICHTIG	Linksseitenlage, Vitalzeichen, meist rasche Besserung.
3A	RICHTIG	Rückenlage meiden, anleiten, Mutter/Kind beobachten.
3B	VERTRETBAR	Die Schwangere sollte die Rückenlage meiden – dazu anleiten.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Lagerung und Befinden weiter im Blick behalten.

Merke: V.-cava-Kompressionssyndrom (Blutdruckabfall der Hochschwangeren in Rückenlage): sofort in Linksseitenlage bringen (oder linke Hüfte unterpolstern), Vitalzeichen kontrollieren, meist rasche Besserung, Arzt informieren; künftig Rückenlage meiden und die Schwangere dazu anleiten.

Fall 78 · Im Wochenbett

1A	RICHTIG	Richtig – einfühlsam und vollständig.
1B	FALSCH	Erst informieren und Einverständnis einholen.
1C	VERTRETBAR	Wichtig zu beobachten – sachlich und respektvoll ansprechen.
2A	FALSCH	Eine verstärkte Blutung würde übersehen.
2B	VERTRETBAR	Beobachtung gehört dazu, nicht nur die Frage.

2C	RICHTIG	Sehr gut – wichtige Verlaufsbeobachtung.
3A	FALSCH	Im Wochenbett ist Begleitung wichtig.
3B	RICHTIG	Richtig – frühe, dosierte Mobilisation.
3C	VERTRETBAR	Längere Bettruhe erhöht das Thromboserisiko.
4A	RICHTIG	Genau richtig.
4B	VERTRETBAR	Dokumentation nicht vergessen.

Merke: 1. Lernjahr Gynäkologie: respektvoll kommunizieren, Wochenfluss beobachten, Mobilisation und Prophylaxe, Blutung sofort melden.

Fall 79 · Starkes Nasenbluten

1A	RICHTIG	Aufrecht, Kopf nach vorne, Nasenflügel komprimieren, kühlen – richtig.
1B	VERTRETBAR	Bei starker Blutung Kreislauf im Blick behalten.
1C	FALSCH	Kopf in den Nacken lässt Blut in den Rachen/Magen laufen (Verschlucken/Übelkeit) – Kopf nach vorne.
2A	RICHTIG	HNO/Tamponade nach AO, Ursache bedenken.
2B	VERTRETBAR	Ständiges Loslassen verhindert die Gerinnung – durchgehend komprimieren.
3A	VERTRETBAR	Blutungsstärke/-menge im Blick behalten.
3B	RICHTIG	Kreislauf, Tamponade-Pflege, Ursache.
4A	VERTRETBAR	Auf erneute Blutung/Kreislauf achten.
4B	RICHTIG	

Merke: Starkes Nasenbluten: aufrecht hinsetzen, Kopf nach vorne, Nasenflügel 10–15 min durchgehend komprimieren, Nacken kühlen, Blut ausspucken lassen (nicht schlucken, Kopf nicht in den Nacken); bei anhaltender Blutung HNO/Tamponade nach AO, Vitalzeichen/Kreislauf beobachten, Ursache (Antikoagulation/Hypertonie) bedenken.

Fall 80 · Atemnot bei Tracheostoma

1A	VERTRETBAR	Bei Tracheostoma muss am Stoma gehandelt werden – Mund-/Nasen-O_2 allein geht am Atemweg vorbei.
1B	RICHTIG	Am Stoma handeln: absaugen, Innenkanüle prüfen – richtig.
1C	FALSCH	Bei Atemnot mit fallender SpO_2 nicht abwarten.
2A	RICHTIG	Absaugen/Innenkanüle, sonst Kanülenwechsel/Arzt, Notfallset bereit.
2B	VERTRETBAR	Unkontrolliertes tiefes Absaugen schädigt die Schleimhaut und verschlimmert die Hypoxie – nach Standard.
3A	VERTRETBAR	Bei Tracheostoma müssen Ersatzkanülen/Notfallset immer griffbereit sein.
3B	RICHTIG	Atmung/SpO_2, Befeuchtung, Notfallset bereit.
4A	VERTRETBAR	Erneute Verlegung im Blick behalten.
4B	RICHTIG	

Merke: Verlegte Trachealkanüle / Atemnot bei Tracheostoma: Notfall – Hilfe rufen, O_2, Oberkörper hoch, am Stoma handeln (absaugen nach Standard, Innenkanüle reinigen/wechseln, ggf. Kanülenwechsel/Arzt), Atmung/SpO_2 engmaschig, Befeuchtung nach AO, Ersatzkanülen/Notfallset immer griffbereit; nicht abwarten, nicht nur über Mund/Nase am Stoma vorbei arbeiten.

Fall 81 · Nachblutung nach Mandel-OP

1A	FALSCH	Frisches Blut/häufiges Schlucken ist eine Nachblutung – nicht abwarten.
1B	VERTRETBAR	Bei Blutung droht ein Schock – Kreislauf beachten.
1C	RICHTIG	Häufiges Schlucken + frisches Blut = Nachblutung, sofort Arzt, nüchtern.
2A	VERTRETBAR	Bei drohender OP und Blutung nüchtern lassen – orale Aufnahme erhöht Aspirations-/OP-Risiko.
2B	RICHTIG	Arzt/HNO, nüchtern, kühlen nach AO, OP-Vorbereitung.
3A	VERTRETBAR	Verschlucktes Blut unterschätzt den Blutverlust – beachten.
3B	RICHTIG	Kreislauf, Aspirationsschutz, nüchtern, OP-Vorbereitung.
4A	VERTRETBAR	Bei Blutung engmaschig überwachen.
4B	RICHTIG	

Merke: Nachblutung nach Tonsillektomie: Notfall – sofort Arzt/HNO, nüchtern lassen (mögliche OP), Oberkörper hoch/Kopf zur Seite und Blut ausspucken lassen (Aspirationsschutz), Vitalzeichen/Kreislauf engmaschig (Kinder verschlucken Blut → Blutverlust wird unterschätzt!), kühlen/OP-Vorbereitung nach AO, beruhigen; nicht als normal abtun, nichts oral geben.

Fall 82 · Atemnot mit Speichelfluss

1A	RICHTIG	Diese Konstellation ist ein Atemwegsnotfall – sitzen lassen, Ruhe, Notfall.
1B	FALSCH	Eine Racheninspektion kann bei Epiglottitis die Atemwege komplett verlegen – unterlassen!
1C	VERTRETBAR	Flachlage verschlimmert die Atemnot – sitzen lassen.
2A	RICHTIG	Sitzen, Ruhe, O_2, Intubationsbereitschaft, nichts in den Mund.
2B	VERTRETBAR	Bei drohender Atemwegsverlegung nichts zu trinken (Aspiration/Reiz) – nüchtern.
3A	RICHTIG	Atmung/SpO_2, sitzen, Ruhe, Bereitschaft.
3B	VERTRETBAR	Bei drohender Atemwegsverlegung nicht allein lassen.
4A	VERTRETBAR	Die Atemwege können rasch komplett verlegen – engmaschig bleiben.
4B	RICHTIG	

Merke: Epiglottitis (akuter Atemwegsnotfall: hohes Fieber, kloßige Sprache, Speichelfluss, sitzende vornübergebeugte Haltung, Atemnot): sitzen lassen, Ruhe/nicht reizen, O_2 nach AO, sofort Notfall/Anästhesie/HNO mit Intubationsbereitschaft, nichts in den Mund und KEINE Racheninspektion (kann die Atemwege komplett verlegen!), engmaschig Atmung/SpO_2, nicht allein lassen; nicht flach hinlegen, nichts zu trinken geben.

Fall 83 · Heftiger Drehschwindel-Anfall

1A	RICHTIG	Sturzprophylaxe steht im Vordergrund – sicher hinsetzen/-legen.
1B	FALSCH	Bei Drehschwindel und Fallneigung droht ein Sturz – nicht allein gehen lassen.
1C	VERTRETBAR	Reize verstärken Schwindel/Übelkeit – reizarm und ruhig.
2A	VERTRETBAR	Medikamente nur nach AO – nicht eigenmächtig.
2B	RICHTIG	Antivertiginosa/Antiemese nach AO, ruhige Lagerung.
3A	RICHTIG	Sturzprophylaxe, Begleitung, reizarm.
3B	VERTRETBAR	Im Anfall nicht unbeaufsichtigt aufstehen lassen – Sturzgefahr.

4A	VERTRETBAR	Sturzrisiko bleibt – weiter begleiten.
4B	RICHTIG	

Merke: Akuter Drehschwindel (z. B. Menière-Anfall): Sturzprophylaxe steht im Vordergrund – sicher hinsetzen/-legen, nicht allein gehen lassen/begleiten, reizarme ruhige Umgebung, Antiemetika/Antivertiginosa nach AO, Erbrechen managen, beruhigen und zu Verhalten im Anfall anleiten; keine eigenmächtige Medikamentengabe.

Fall 84 · Plötzliche einseitige Hörminderung

1A	RICHTIG	Plötzliche einseitige Hörminderung = HNO-Eilfall, zeitnah abklären.
1B	FALSCH	Ein Hörsturz wird zeitnah behandelt – nicht tagelang abwarten.
1C	VERTRETBAR	Medikamente nur nach AO – nicht eigenmächtig.
2A	VERTRETBAR	Manipulation/Spülung ist hier nicht angezeigt – HNO-Abklärung.
2B	RICHTIG	HNO-Abklärung, Kortison nur nach AO, Ruhe.
3A	RICHTIG	Ruhe, Sturzprophylaxe bei Schwindel, psychische Unterstützung.
3B	VERTRETBAR	Die Angst ernst nehmen – psychische Unterstützung gehört dazu.
4A	VERTRETBAR	Verlauf und Befinden weiter im Blick behalten.
4B	RICHTIG	

Merke: Hörsturz (plötzliche einseitige, schmerzlose Hörminderung, oft mit Tinnitus): als HNO-Eilfall zeitnah abklären lassen, Medikamente (z. B. Kortison) nur nach AO mit Wirkungs-/Nebenwirkungskontrolle, Ruhe/Stressreduktion, bei Schwindel Sturzprophylaxe, psychische Unterstützung und Edukation; nicht tagelang abwarten, keine eigenmächtige Gabe/Manipulation am Ohr.

Fall 85 · Nach der Mandel-OP

1A	RICHTIG	Richtig – Nachblutung ist die Hauptgefahr.
1B	VERTRETBAR	Aktive Beobachtung ist besser als reines Abwarten.
1C	FALSCH	Wärme fördert die Blutung – kühle Kost ist richtig.
2A	FALSCH	Das kann die Wunde aufreißen.
2B	RICHTIG	Sehr gut – schont die Wundflächen.
2C	VERTRETBAR	Leicht erhöhter Kopf ist günstiger.
3A	VERTRETBAR	Auch häufiges Schlucken ist ein frühes Zeichen.
3B	RICHTIG	Richtig erkannt.
3C	FALSCH	Eine Nachblutung kann lebensbedrohlich werden.
4A	VERTRETBAR	Zeitnah melden und dokumentieren.
4B	RICHTIG	Genau richtig.

Merke: 1. Lernjahr HNO: nach Tonsillektomie auf Nachblutung achten (häufiges Schlucken!), kühle Kost, sofort melden.

Fall 86 · Sturz mit Hüftschmerz im Alter

1A	FALSCH	Bei Frakturverdacht nicht belasten/mobilisieren – Dislokations- und Schadensgefahr.

1B	RICHTIG	Verkürztes/außenrotiertes Bein nach Sturz spricht für eine hüftnahe Fraktur – ruhigstellen, DMS prüfen.
1C	VERTRETBAR	Schmerz erfassen und behandeln (nach AO) gehört dazu.
2A	VERTRETBAR	Bei möglicher OP nüchtern lassen.
2B	RICHTIG	Ruhigstellen, Schmerz nach AO, nüchtern, OP-Vorbereitung.
3A	VERTRETBAR	Gerade bei Immobilität sind Prophylaxen wichtig.
3B	RICHTIG	Prophylaxen, Delir im Blick, Schmerz/Lagerung.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Verlauf/DMS/Delir weiter beobachten.

Merke: Hüftgelenknahe Fraktur (Schenkelhals) nach Sturz (verkürztes/außenrotiertes Bein): Bein ruhigstellen/nicht belasten, Schmerztherapie nach AO, nüchtern lassen (OP), DMS kontrollieren, OP-Vorbereitung; konsequente Prophylaxen (Dekubitus/Thrombose/Pneumonie) und auf Delir beim alten Menschen achten; nicht zum Aufstehen auffordern, nichts oral geben.

Fall 87 · Atemnot Tage nach Knochenbruch

1A	VERTRETBAR	Das Hauptproblem ist die respiratorische/zerebrale Beteiligung – nicht nur den Schmerz.
1B	FALSCH	Diese Zeichen sind ein Notfall – nicht abwarten.
1C	RICHTIG	Diese Trias nach Röhrenknochenbruch passt zum Fettembolie-Syndrom.
2A	RICHTIG	O_2, engmaschiges Monitoring, Intensiv.
2B	VERTRETBAR	Bei Atemnot/instabiler Lage nicht forcieren – schonen und überwachen.
3A	VERTRETBAR	Engmaschiges Monitoring ist nötig.
3B	RICHTIG	Atmung/SpO_2/Bewusstsein, Intensiv.
4A	VERTRETBAR	Verlauf engmaschig kontrollieren.
4B	RICHTIG	

Merke: Fettembolie-Syndrom (1–3 Tage nach Röhrenknochenbruch: Atemnot + Verwirrtheit + Petechien): Notfall – sofort Arzt, O_2 nach AO, engmaschig Atmung/SpO_2/Bewusstsein, Intensivüberwachung, Therapie nach AO; nicht als Erschöpfung abtun, nicht nur den Schmerz behandeln.

Fall 88 · Schmerzen und Taubheit unter dem Gips

1A	FALSCH	Der zunehmende Schmerz ist ein Warnzeichen – nicht nur überdecken/abwarten.
1B	VERTRETBAR	Tieflagerung verstärkt die Schwellung – hochlagern.
1C	RICHTIG	Diese Zeichen sind Alarm – DMS prüfen, hochlagern, Arzt, Gips nach AO spalten.
2A	VERTRETBAR	Engeres Wickeln verstärkt den Druck – nach AO lockern/spalten.
2B	RICHTIG	Hochlagern, Gips nach AO spalten, DMS engmaschig.
3A	VERTRETBAR	Schmerzmittel überdecken den Warnschmerz – DMS/Ursache angehen.
3B	RICHTIG	DMS engmaschig, Schwellung/Schmerz, hochlagern.
4A	VERTRETBAR	DMS weiter engmaschig prüfen.
4B	RICHTIG	

Merke: Zu enger Gips / drohende Durchblutungs-/Nervenstörung (zunehmender Schmerz, Kribbeln/Taubheit, blasse kühle Zehen): DMS (Durchblutung/Motorik/Sensibilität) engmaschig prüfen, Bein hochlagern, sofort Arzt und Gips nach AO spalten/lockern; nicht abwarten, nicht enger wickeln, nicht tief lagern, den Warnschmerz nicht nur mit Schmerzmitteln überdecken.

Fall 89 · Geschwollene, schmerzhafte Wade

1A	FALSCH	Massieren kann ein Gerinnsel lösen (Emboliegefahr!) – niemals massieren.
1B	RICHTIG	Einseitige geschwollene, warme Wade = TVT-Verdacht: nicht massieren, Arzt.
1C	VERTRETBAR	Bei TVT-Verdacht nicht eigenmächtig forcieren – erst abklären/AO.
2A	RICHTIG	Arzt/Diagnostik, Antikoagulation nach AO, auf LE-Zeichen achten.
2B	VERTRETBAR	Medikamente nur nach AO.
3A	RICHTIG	Nicht massieren, Therapie nach AO, LE-Zeichen melden.
3B	VERTRETBAR	Plötzliche Atemnot/Brustschmerz kann eine Lungenembolie sein – sofort melden!
4A	VERTRETBAR	Weiter auf LE-Zeichen achten.
4B	RICHTIG	

Merke: Tiefe Venenthrombose (einseitig geschwollene, überwärmte, schmerzhafte Wade nach Immobilisation/OP): Bein ruhigstellen, NICHT massieren/kneten (Emboliegefahr!), Arzt/Diagnostik, Antikoagulation und Lagerung nach AO, engmaschig auf Lungenembolie-Zeichen (plötzliche Atemnot/Brustschmerz/Tachykardie) achten und sofort melden, Edukation/Prophylaxe; keine eigenmächtige Medikamentengabe.

Fall 90 · Erste Mobilisation nach Hüft-TEP

1A	RICHTIG	Luxationsprophylaxe: verbotene Bewegungen vermeiden, Beine abspreizen.
1B	VERTRETBAR	Starke Beugung über 90° ist eine verbotene Bewegung – vermeiden.
1C	FALSCH	Überkreuzen/Übereinanderschlagen kann die TEP luxieren – vermeiden.
2A	VERTRETBAR	Ruckartig/ohne Hilfsmittel droht Sturz/Luxation – langsam und sicher.
2B	RICHTIG	Nach Vorgabe/Physio, erlaubte Bewegungen, Hilfsmittel.
3A	VERTRETBAR	Prophylaxen (Thrombose/Dekubitus/Pneumonie) sind wichtig.
3B	RICHTIG	Luxationsprophylaxe + weitere Prophylaxen, Wunde/DMS.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Weiter zu erlaubten Bewegungen anleiten.

Merke: Nach Hüft-TEP – Luxationsprophylaxe: verbotene Bewegungen vermeiden (Beine nicht überkreuzen/übereinanderschlagen, keine Beugung über 90°, kein starkes Innendrehen), Beine abspreizen, nach Vorgabe/Physiotherapie sicher mobilisieren (erlaubte Bewegungen, Hilfsmittel), Schmerz/Wunde/DMS beobachten, Thrombose-/Dekubitus-/Pneumonieprophylaxe, Edukation.

Fall 91 · Sturz aus Höhe mit Rückenschmerz

1A	FALSCH	Aufsetzen/Hinstellen kann bei instabiler Wirbelsäule das Rückenmark schädigen – nicht bewegen.
1B	RICHTIG	Bei diesem Mechanismus an instabile Wirbelsäule denken – nicht bewegen, Achse schützen.
1C	VERTRETBAR	Unkoordiniertes Umlagern gefährdet das Rückenmark – nur koordiniert im Team.
2A		

VERTRETBAR Allein/ruckartig ist gefährlich – nur koordiniert im Team.

2B	RICHTIG	Achse wahren, koordiniert im Team, Neurostatus, Notfallteam.
3A	VERTRETBAR	Die neurologischen Befunde sind hier entscheidend – engmaschig erfassen.
3B	RICHTIG	Achse, Neurostatus, koordiniert, Vitalzeichen.
4A	RICHTIG	
4B	VERTRETBAR	Achse/Immobilisation konsequent wahren.

Merke: Verdacht auf (instabile) Wirbelsäulenverletzung (Sturz aus Höhe + Rückenschmerz + neurologische Zeichen): Patienten nicht aufsetzen/hinstellen, flach und ruhig lagern, Achse/HWS wahren, Bewegungen nur koordiniert im Team (Logroll) nach Vorgabe, sofort Notfall, Neurostatus engmaschig dokumentieren, Vitalzeichen/Wärmeerhalt; keine unkoordinierte oder alleinige Umlagerung.

Fall 92 · Nach der neuen Hüfte

1A	VERTRETBAR	Korrekte Lagerung mit Abduktion ist sicherer.
1B	RICHTIG	Richtig – schützt vor Luxation der Prothese.
1C	FALSCH	Luxationsgefahr durch falsche Bewegung.
2A	RICHTIG	Sehr gut – Thromboserisiko nach OP.
2B	VERTRETBAR	Bewegungslosigkeit erhöht das Thromboserisiko.
2C	FALSCH	Hohes Thromboserisiko wird ignoriert.
3A	FALSCH	Sturz- und Luxationsgefahr.
3B	RICHTIG	Richtig – dosiert und sicher.
3C	VERTRETBAR	Frühe, dosierte Mobilisation ist erwünscht.
4A	VERTRETBAR	Wunde und Beobachtung gehören dazu.
4B	RICHTIG	Genau richtig.

Merke: 1. Lernjahr Orthopädie nach Hüft-TEP: Abduktion, keine Beugung über 90°, Thromboseprophylaxe, sichere Mobilisation.

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

KRANKHEITSLEHRE · PFLEGEPLANUNG · MÜNDLICHE PRÜFU

Krankheitsbilder & Pflegeplanung

107 Krankheitsbilder aus 10 Fachgebieten – Definition, Symptome, Diagnostik, Therapie, fertige Pflegeplanung und Prüfungsfragen. Ideal für die mündliche Prüfung.

Bestehen ist planbar.

ICD-10 · Pflegeplanung · Prüfungsfragen · Mündliche Prüfung

107	10	A4
Krankheitsbilder	Fachgebiete	druckfertig

INHALT

1. Innere Medizin
2. Chirurgie
3. Psychologie für Pflege
4. Gynäkologie
5. Urologie
6. Neurologie
7. HNO
8. Onkologie
9. Pädiatrie
10. … und Orthopädie

⚠ Lernhilfe, mit KI-Unterstützung erstellt und fachlich geprüft. Maßgeblich sind Lehrinhalte, Leitlinien und Standards deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

plan-nrw.de

So lernst du mit dem Heft

Jedes Krankheitsbild folgt demselben Aufbau – genau so, wie in der mündlichen Prüfung gefragt wird: Was ist es? Woran erkenne ich es? Wie wird es behandelt? Was tue ich als Pflegefachkraft?

PFLEGEPLANUNG

Pflegeproblem nach PESR, Ressourcen, Ziel, Maßnahmen und Evaluation – als Vorlage für deine eigene Planung.

PRÜFUNGSFRAGEN

Zu den meisten Krankheitsbildern Kontrollfragen mit Lösung am Ende des Hefts.

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

Innere Medizin

10 Krankheitsbilder

Herzinsuffizienz I50

Unfähigkeit des Herzens, ausreichend Blut/Sauerstoff zu pumpen. Einteilung: Links-, Rechts- oder Globalinsuffizienz. NYHA-Stadien I–IV.

SYMPTOME

- Dyspnoe (Belastung → Ruhe)
- Orthopnoe (flach liegen nicht möglich)
- Ödeme (Knöchel, Unterschenkel)
- Nykturie
- Müdigkeit, Leistungsminderung
- Zyanose
- Gewichtszunahme durch Wassereinlagerung
- Tachykardie

DIAGNOSTIK

- Echo (EF < 40% = systolische HI)
- BNP/NT-proBNP erhöht
- Röntgen Thorax (Kardiomegalie, Lungenödem)
- EKG
- Labor: Kreatinin, Elektrolyte

THERAPIE

- ACE-Hemmer/Sartane
- Betablocker
- Diuretika (Furosemid)
- Aldosteronantagonisten
- Digoxin
- ICD/Resynchronisation

Pflegeproblem	Beeinträchtigte kardiopulmonale Gewebeperfusion r/t verminderter Herzleistung m/d/s Dyspnoe, Zyanose, SpO_2 < 94%
Ressourcen	Kooperativ, Versteht Anweisungen, Angehörige unterstützend
Pflegeziel	Patient atmet in Ruhe ohne Dyspnoe (NRS Atemnot 0-2) innerhalb von 48h
Maßnahmen	• Oberkörperhochlagerung 30-45° kontinuierlich • O_2-Gabe nach Anordnung, SpO_2 ≥ 94% sichern • Vitalzeichen 4-stündlich: RR, HF, AF, SpO_2 • Flüssigkeitsbilanz (Ein-/Ausfuhr täglich) • Tägliche Gewichtskontrolle (gleiche Zeit, Waage) • Ödeme dokumentieren (Umfang messen) • Aktivität schrittweise steigern nach Befinden
Evaluation	Täglich: Dyspnoe-NRS, SpO_2, Gewicht, Ödeme

Pflegeproblem	Überschuss an Körperflüssigkeit r/t Herzpumpversagen m/d/s Ödeme, Gewichtszunahme 3kg/Woche
Ressourcen	Versteht Bedeutung der Trinkmengenbeschränkung
Pflegeziel	Gewichtsreduktion um 0,5-1kg/Tag durch Diurese, Ödeme rückläufig nach 3 Tagen
Maßnahmen	• Trinkmengenbeschränkung nach Anordnung (meist 1,5-2L/Tag) • Diuretika pünktlich verabreichen, Wirkung dokumentieren • Natriumarme Ernährung besprechen • Hautpflege ödematöser Extremitäten (Druckgefahr!) • Hochlagerung der Beine • Patient über Selbstkontrolle schulen (Tagesgewicht)
Evaluation	Täglich Gewicht, Bilanz, Ödemstatus

KONTROLLFRAGEN

1 **Was bedeutet NYHA III bei Herzinsuffizienz?**

- A Keine Symptome
- B Symptome bei leichter Belastung
- C Symptome bei stärkerer Belastung
- D Symptome in Ruhe

2 **Welche Lagerung ist bei akuter kardialer Dyspnoe indiziert?**

- A Flachlagerung
- B Oberkörperhochlagerung 30-45°
- C Bauchlagerung
- D Linksseitenlage

3 **Was ist das wichtigste Pflegemonitoring bei Herzinsuffizienz?**

- A Temperatur
- B Tägliche Gewichtskontrolle + Flüssigkeitsbilanz
- C Pupillenkontrolle
- D Blutzucker

COPD J44

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Nicht vollständig reversible Atemwegsobstruktion durch chronische Bronchitis + Lungenemphysem. Hauptursache: Rauchen. GOLD-Stadien I–IV.

SYMPTOME

- Chronischer Husten (Raucherhusten)
- Auswurf (morgens besonders)
- Belastungsdyspnoe (progredient)
- Giemen/Brummen
- Fassthorax (Emphysem)
- Lippenzyanose
- Uhrglasnägel
- Trommelschlägelfinger

DIAGNOSTIK

- Spirometrie (FEV1/FVC < 0,7)
- Blutgasanalyse (BGA)
- Röntgen/CT Thorax
- 6-Minuten-Gehtest
- COPD-Assessment-Test (CAT)

THERAPIE

- Raucherentwöhnung (!)
- Bronchodilatatoren (LABA, LAMA)
- Inhalatoren-Schulung
- Kortikosteroide inhalativ
- Atemphysiotherapie
- Langzeit-O_2 bei PaO_2 < 55mmHg

Pflegeproblem	Ineffektives Atemmuster r/t bronchialer Obstruktion m/d/s Dyspnoe NRS 6, AF 26/min, SpO_2 88%
Ressourcen	Kann Lippenbremse anwenden, Motiviert zur Mitarbeit
Pflegeziel	SpO_2 ≥ 90% (COPD-Ziel!), Dyspnoe NRS ≤ 3 nach 24h
Maßnahmen	• O_2-Gabe VORSICHTIG: Ziel SpO_2 88-92% (nicht höher! Atemantriebreduktion!) • Kutschersitz anleiten (sitzend, Arme aufgestützt → Atemhilfsmuskulatur) • Lippenbremse üben und anwenden • Bronchodilatator-Inhalation nach Anordnung, Technik kontrollieren • Sekretmobilisation: atemunterstützende Lagerung, PEP-Geräte • Atemgymnastik 3x täglich • Körperliche Schonung, Aktivität nach Befinden
Evaluation	4-stündlich SpO_2, AF, Dyspnoe-NRS

KONTROLLFRAGEN

4 **Warum darf COPD-Patienten NICHT unkontrolliert hochdosiert O_2 gegeben werden?**

- A O_2 ist zu teuer
- B Hypoxischer Atemantrieb: zu viel O_2 → Atemdepression
- C O_2 verschlimmert Bronchitis
- D Keine Kontraindikation

5 **Was ist der Kutschersitz bei Dyspnoe?**

- A Flachlagerung
- B Sitzend, Arme auf Oberschenkeln/Tisch aufgestützt – entlastet Atemhilfsmuskulatur
- C Linksseitenlage
- D Stehend an Wand gelehnt

6 **Was ist die Lippenbremse?**

- A Medikament
- B Atemtechnik: Ausatmung durch halb geöffnete Lippen – erhöht Atemwegsdruck → verhindert Bronchiolenkollaps
- C Eine Lagerungstechnik
- D Ein Absaugverfahren

Diabetes mellitus Typ 2 E11

Chronische Stoffwechselerkrankung mit Insulinresistenz und relativem Insulinmangel. Häufigste Diabetesform (90%). Risikofaktoren: Adipositas, Bewegungsmangel, genetische Disposition.

SYMPTOME

- Polyurie, Polydipsie (bei Entgleisung)
- Müdigkeit, Leistungsminderung
- Wundheilungsstörungen
- Häufige Infektionen
- Sehstörungen (Retinopathie)
- Kribbeln/Taubheit Füße (Neuropathie)
- Oft lange symptomlos!

DIAGNOSTIK

- Nüchtern-BZ ≥ 126 mg/dl
- HbA1c ≥ 6,5%
- OGTT
- Urin: Mikroalbuminurie
- Augenhintergrund, Fußstatus

THERAPIE

- Basistherapie: Ernährung + Bewegung
- Metformin (First-Line)
- SGLT2-Inhibitoren, GLP-1-RA
- Insulin (bei Versagen oraler Antidiabetika)
- HbA1c-Ziel individuell (meist < 7%)

Pflegeproblem	Risiko für Hypoglykämie r/t Insulintherapie und unregelmäßiger Nahrungsaufnahme
Ressourcen	Erkennt Hypoglykämie-Zeichen, Kann BZ selbst messen
Pflegeziel	Keine Hypoglykämie-Episode (BZ > 70 mg/dl) während des stationären Aufenthalts
Maßnahmen	• BZ-Kontrolle nach Anordnung (nüchtern, vor/nach Mahlzeiten) • Mahlzeiten pünktlich, Insulin zeitgerecht verabreichen (6-R-Regel!) • Hypoglykämie-Schema beachten: BZ < 70 → 20g KH oral (Traubenzucker) • BZ < 50 oder bewusstlos → Glukose 40% i.v. nach Anordnung • Notfallset: Glukose immer griffbereit • Schulung: Symptome Hypoglykämie (Zittern, Schwitzen, Herzrasen, Verwirrtheit)
Evaluation	BZ-Profil täglich, Hypoglykämie-Ereignisse dokumentieren

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Gewebeintegrität r/t Wundheilungsstörung bei diabetischer Polyneuropathie m/d/s Ulcus plantare rechts
Ressourcen	Kooperativ, Familie unterstützt Verbandswechsel
Pflegeziel	Wunde zeigt nach 7 Tagen Granulationsgewebe, keine Infektzeichen
Maßnahmen	• Tägliche Wundinspektion und Dokumentation (Foto, Maße, Exsudat, Geruch) • Verbandswechsel nach Wundexpertenstandard (feuchte Wundversorgung) • Druckentlastung: kein Druck auf Ulcus (Spezialschuhe, Bettung) • BZ-Einstellung optimieren (schlechte BZ → schlechte Wundheilung) • Fußpflege täglich: Inspektion alle Zehenzwischenräume • Fußwärme nicht mit Wärmflasche/Heizkissen! (Neuropathie = kein Temperaturempfinden)
Evaluation	Täglich: Wunddokumentation, BZ-Verlauf

KONTROLLFRAGEN

7 **Welche Pflegemaßnahme hat bei Hypoglykämie (BZ < 70 mg/dl, Patient wach) höchste Priorität?**

A) Sofort Insulin geben

B) 20g schnell resorbierbare Kohlenhydrate oral (Traubenzucker, Fruchtsaft)

C) Patient schlafen lassen

D) Blutabnahme

8 **Was ist das Diabetische Fußsyndrom (DFS) und welche Pflegemaßnahme ist FALSCH?**

A) Täglich Füße inspizieren

B) Wärmflasche bei kalten Füßen anwenden

C) Druckentlastung sicherstellen

D) Feuchte Wundversorgung

9 **Was ist HbA1c und was zeigt er?**

A) Aktueller Blutzucker

B) Durchschnittlicher Blutzucker der letzten 2-3 Monate (Langzeitblutzucker)

C) Insulinspiegel

D) Ketonkörper

Schlaganfall (Apoplex) I63/I61

Akute Durchblutungsstörung des Gehirns. Ischämisch (80%: Hirninfarkt) oder hämorrhagisch (20%: Hirnblutung). Time is brain: jede Minute zählt!

SYMPTOME

- Plötzliche Halbseitenlähmung
- Gesichtsfeldausfall
- Sprachstörung (Aphasie, Dysarthrie)
- Schluckstörung (Dysphagie)
- Sehstörungen
- Schwindel, Gangunsicherheit
- Plötzlich stärkste Kopfschmerzen (Hirnblutung)
- Bewusstseinsstörung

DIAGNOSTIK

- FAST-Test (Face, Arms, Speech, Time)
- cCT sofort (Blutung ausschließen)
- MRT
- EKG (Vorhofflimmern?)
- Doppler-Sonographie

THERAPIE

- Lysetherapie (rtPA) bei Ischämie innerhalb 4,5h
- Thrombektomie (mechanisch)
- Stroke Unit Behandlung
- Sekundärprophylaxe: ASS, Antikoagulation bei VHF
- Frührehabilitation!

Pflegeproblem	Beeinträchtigte körperliche Mobilität r/t neurologischem Defizit nach Apoplex m/d/s Hemiparese links, Barthel-Index 35
Ressourcen	Rechte Seite gut beweglich, Motiviert zur Rehabilitation, Tochter unterstützt
Pflegeziel	Patient sitzt nach 3 Tagen mit Unterstützung 30 Min. auf Bettkante, Barthel-Index +10 nach 1 Woche
Maßnahmen	• Bobath-Konzept: betroffene Seite bewusst einbeziehen, Lagerung auf betroffener + gesunder Seite wechselnd • Physiotherapie täglich koordinieren • Transfertraining: immer von der betroffenen Seite ansprechen/aktivieren • Sturzprophylaxe: Bettgitter, Patientenklingel erreichbar • Dekubitusprophylaxe: Umlagerung alle 2h, Druckpunkte prüfen • Kontinenzförderung: regelmäßige Toilettengänge anbieten • Alle Pflegehandlungen langsam, sprachlich begleiten
Evaluation	Täglich Barthel-Index, Mobilisationsprotokoll, Sturzprotokoll

Pflegeproblem	Beeinträchtigte verbale Kommunikation r/t Aphasie nach Apoplex m/d/s Patient versteht Anweisungen, kann nicht sprechen
Ressourcen	Versteht einfache Sätze, Gestik möglich, Schreiben eingeschränkt möglich
Pflegeziel	Patient kommuniziert Grundbedürfnisse (Schmerz, Hunger, Toilette) mit Kommunikationshilfen nach 5 Tagen
Maßnahmen	• Logopädie täglich einbeziehen • Kommunikationsboard/Bildkarten einsetzen • Kurze einfache Sätze, langsam sprechen, nicht schreien • Ja/Nein-Fragen stellen • Geduld: Patient nicht unterbrechen oder Sätze ergänzen • Angehörige in Kommunikationsstrategien schulen • Frustration des Patienten anerkennen und ernst nehmen
Evaluation	Täglich Kommunikationsfortschritt dokumentieren

KONTROLLFRAGEN

10 **Was bedeutet FAST beim Schlaganfall?**

- A) Fast, Accurate, Safe, Treatment
- B) Face (Gesichtslähmung), Arms (Armlähmung), Speech (Sprache), Time (Zeit notieren, Notruf)
- C) First Aid Stroke Treatment
- D) Focused Assessment Stroke Tool

11 **Was ist das Bobath-Konzept in der Schlaganfallpflege?**

- A) Medikamentöse Therapie
- B) Rehabilitationskonzept: betroffene Körperseite bewusst einbeziehen, normale Bewegungsmuster fazilitieren
- C) Ein Lagerungskonzept für Dekubitusprophylaxe
- D) Eine Kommunikationshilfe

12 **Was ist Dysphagie und welche Gefahr besteht?**

- A) Sehstörung
- B) Schluckstörung – Gefahr: stille Aspiration → Aspirationspneumonie
- C) Gehstörung
- D) Hörstörung

Hypertonie I10

Chronisch erhöhter Blutdruck ≥ 140/90 mmHg. Häufigste Herz-Kreislauf-Erkrankung. Meist primär (essentiell, 90%). Stiller Killer – oft jahrelang symptomlos.

SYMPTOME

- Oft symptomlos!
- Kopfschmerzen (okzipital, morgens)
- Schwindel
- Ohrensausen
- Sehstörungen
- Hypertensive Krise: RR > 180/120 + Symptome

DIAGNOSTIK

- Blutdruckmessung (mehrfach, beide Arme)
- 24h-Langzeit-RR
- EKG (LVH)
- Echo
- Labor: Kreatinin, Elektrolyte, Urin

THERAPIE

- Lebensstiländerung: Gewicht, Salz, Alkohol, Bewegung
- ACE-Hemmer/Sartane
- Kalziumantagonisten
- Betablocker
- Diuretika
- Ziel: < 130/80 mmHg

Pflegeproblem	Unzureichendes Selbstmanagement r/t Wissensmangel über Hypertonie m/d/s RR 175/105 trotz Medikation, unregelmäßige Einnahme
Ressourcen	Lernbereit, Möchte RR senken, Ehefrau unterstützt
Pflegeziel	Patient nennt nach 3 Tagen 5 Maßnahmen zur RR-Senkung und nimmt Medikamente regelmäßig
Maßnahmen	• RR-Messung 2x täglich (morgens/abends, protokollieren) • Patientenedukation: Ursachen, Folgen, Therapieziel • Medikamenteneinnahme erklären: warum täglich, nicht absetzen! • Ernährungsberatung: salzarm < 6g/Tag, Alkohol reduzieren • Gewichtskontrolle täglich • Bewegung: 30 Min./Tag moderate Aktivität • Stressreduktion besprechen
Evaluation	Täglich RR-Protokoll, nach 3 Tagen Wissenstest

KONTROLLFRAGEN

13 **Ab welchem Wert spricht man von arterieller Hypertonie?**

(A) 130/80 mmHg
(B) 140/90 mmHg
(C) 160/100 mmHg
(D) 120/80 mmHg

14 **Was ist bei der RR-Messung zu beachten?**

(A) Direkt nach dem Sport messen
(B) 5 Min. Ruhe, sitzen, Arm auf Herzhöhe, beide Arme vergleichen, korrekte Manschettengröße
(C) Immer im Stehen
(D) Nur rechter Arm

15 **Was ist eine hypertensive Krise und wie reagiert die Pflege?**

(A) RR > 140/90
(B) RR > 180/120 mmHg + Symptome (Kopfschmerz, Sehstörung, Brustschmerz) → Notfall! Arzt sofort, Patient beruhigen, RR-Monitoring
(C) Normaler hoher RR
(D) Postoperativer RR-Anstieg

Pneumonie J18

Akute Entzündung des Lungenparenchyms, meist bakteriell (häufig Pneumokokken) oder viral. Ambulant oder nosokomial erworben.

SYMPTOME

- Fieber, Schüttelfrost
- Husten mit Auswurf
- Dyspnoe, Tachypnoe
- Atemabhängige thorakale Schmerzen
- Abgeschlagenheit
- Bei älteren Menschen oft Verwirrtheit

DIAGNOSTIK

- Auskultation (Rasselgeräusche), Klinik
- Röntgen Thorax (Infiltrat)
- Labor (CRP, Leukozyten)
- SpO_2/BGA
- Erregerdiagnostik (Sputum/ Blutkultur)
- CRB-65-Score

THERAPIE

- Antibiotika nach AO (kalkuliert/ gezielt)
- O_2 bei Hypoxie
- Ausreichend Flüssigkeit, Antipyrese
- Sekretmanagement, Atemtherapie/ Mobilisation
- Stationär/Intensiv je nach Schwere

Pflegeproblem	Beeinträchtigter Gasaustausch r/t Lungeninfiltration m/d/s Dyspnoe, Tachypnoe, SpO_2-Abfall
Ressourcen	Patient kooperativ bei Atemübungen, Motiviert zu mobilisieren
Pflegeziel	Patient zeigt innerhalb von 48 h $SpO_2 \geq 94$ % und reduzierte Atemarbeit
Maßnahmen	• O_2 nach AO, SpO_2/Atemfrequenz überwachen • Oberkörperhochlagerung, Atemtherapie anleiten • Sekretmobilisation, abhusten lassen, ausreichend Flüssigkeit • Antibiotika/Antipyrese nach AO • Frühmobilisation und Pneumonieprophylaxe
Evaluation	SpO_2 stabil, Atemarbeit reduziert, Fieber rückläufig.

Chronische Niereninsuffizienz N18

Dauerhafte Abnahme der Nierenfunktion über Monate/Jahre mit Anstieg der Retentionswerte. Stadieneinteilung nach GFR; Endstadium dialysepflichtig.

SYMPTOME

- Lange asymptomatisch
- Müdigkeit, Leistungsminderung
- Ödeme, Bluthochdruck
- Verminderte Urinausscheidung (spät)
- Juckreiz, blass-graue Haut
- Übelkeit/Appetitlosigkeit (Urämie)

DIAGNOSTIK

- Labor (Kreatinin, GFR, Harnstoff, Elektrolyte)
- Urinstatus (Proteinurie)
- Sonografie der Nieren
- Blutdruck
- Verlaufskontrollen

THERAPIE

- Grunderkrankung behandeln (Diabetes/Hypertonie)
- Blutdruck-/Stoffwechseleinstellung
- Flüssigkeits-/Elektrolyt-/ Diätmanagement nach AO
- Renale Medikamentenanpassung
- Nierenersatztherapie (Dialyse) im Endstadium

Pflegeproblem	Flüssigkeitsüberschuss r/t eingeschränkter Nierenfunktion m/d/s Ödemen, Gewichtszunahme, Hypertonie
Ressourcen	Patient hält Vorgaben ein, Angehörige unterstützen
Pflegeziel	Ödeme und Gewicht sind innerhalb der Vorgaben stabil, RR im Zielbereich
Maßnahmen	• Ein-/Ausfuhr und tägliches Gewicht dokumentieren • Trinkmengen-/Diätvorgaben nach AO unterstützen • Blutdruck/Ödeme überwachen • Medikamente (inkl. renaler Dosis) nach AO • Hautpflege, Edukation zu Flüssigkeit/Ernährung
Evaluation	Gewicht/Ödeme stabil, RR im Zielbereich, Vorgaben eingehalten.

Leberzirrhose K74

Irreversibler bindegewebiger Umbau der Leber mit Funktionsverlust, häufig durch Alkohol oder Hepatitis. Folgen: portale Hypertension, Aszites, Ösophagusvarizen, hepatische Enzephalopathie.

SYMPTOME

- Müdigkeit, Leistungsminderung
- Ikterus
- Aszites, Ödeme
- Spider naevi, Palmarerythem, Caput medusae
- Blutungsneigung
- Bewusstseinsveränderungen (Enzephalopathie)

DIAGNOSTIK

- Labor (Leberwerte, Gerinnung, Albumin, Ammoniak)
- Sonografie/ggf. Elastografie
- Gastroskopie (Varizen)
- Aszitespunktion
- Child-Pugh/MELD-Einschätzung

THERAPIE

- Auslöser meiden (Alkoholkarenz), Grunderkrankung behandeln
- Aszites: Diuretika/Punktion, Kochsalzrestriktion nach AO
- Varizenprophylaxe/-behandlung
- Enzephalopathie behandeln (z. B. Laktulose nach AO)
- Ernährung, Infekt-/Blutungsprophylaxe

Pflegeproblem	Gefahr von Blutung und Bewusstseinsstörung r/t Leberzirrhose (Varizen, Enzephalopathie) m/d/s Gerinnungsstörung, Aszites
Ressourcen	Patient kooperativ, Angehörige unterstützen, Alkoholkarenz angestrebt
Pflegeziel	Blutungs- und Enzephalopathiezeichen werden früh erkannt; der Patient bleibt kreislaufstabil und orientiert
Maßnahmen	• Auf Blutungszeichen (Teerstuhl, Bluterbrechen) achten, Vitalzeichen • Bewusstsein/Orientierung beobachten (Enzephalopathie) • Bauchumfang/Gewicht/Bilanz bei Aszites • Medikamente (z. B. Laktulose, Diuretika) nach AO • Ernährung/Alkoholkarenz unterstützen, Edukation
Evaluation	Keine unerkannte Blutung, orientiert, kreislaufstabil, Aszites kontrolliert.

Vorhofflimmern I48

Häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung mit unkoordinierter Vorhofaktivität und unregelmäßigem Puls. Hauptgefahr: Thrombenbildung mit Schlaganfallrisiko.

SYMPTOME

- Unregelmäßiger Puls
- Herzstolpern/Palpitationen
- Leistungsminderung, Dyspnoe
- Schwindel
- Oft auch asymptomatisch
- Ggf. Schlaganfallsymptome als Komplikation

DIAGNOSTIK

- EKG/Langzeit-EKG
- Puls-/Herzfrequenzkontrolle
- Echo (Vorhof, Thromben)
- Labor (Schilddrüse, Elektrolyte)
- Schlaganfall-/Blutungsrisiko (CHA_2DS_2-VASc)

THERAPIE

- Frequenz- oder Rhythmuskontrolle nach AO
- Antikoagulation zur Schlaganfallprophylaxe nach AO
- Ggf. Kardioversion/Ablation
- Auslöser behandeln (Elektrolyte/ Schilddrüse)
- Patientenedukation

Pflegeproblem	Gefahr einer Thromboembolie (Schlaganfall) r/t Vorhofflimmern m/d/s unregelmäßigem Herzrhythmus
Ressourcen	Patient nimmt Medikamente zuverlässig, Versteht die Edukation
Pflegeziel	Der Patient zeigt keine thromboembolischen Komplikationen; die Antikoagulation wird korrekt umgesetzt
Maßnahmen	• Herzrhythmus/Frequenz und Vitalzeichen überwachen • Antikoagulation nach AO, auf Blutungszeichen achten • Auf Schlaganfallzeichen (FAST) achten • Auslöser/Elektrolyte beachten • Edukation zu Adhärenz und Blutungsrisiken
Evaluation	Keine Thromboembolie/Blutungskomplikation, Antikoagulation korrekt, Frequenz im Zielbereich.

Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) E05

Überproduktion von Schilddrüsenhormonen mit gesteigertem Stoffwechsel, häufig Morbus Basedow oder Schilddrüsenautonomie. Gefährliche Maximalform: thyreotoxische Krise.

SYMPTOME

- Tachykardie, Herzklopfen
- Gewichtsverlust trotz Appetit
- Innere Unruhe, Nervosität, Tremor
- Wärmeintoleranz, Schwitzen
- Schlafstörungen
- Ggf. Exophthalmus (Basedow)

DIAGNOSTIK

- Labor (TSH erniedrigt, fT3/fT4 erhöht)
- Sonografie/Szintigrafie der Schilddrüse
- Antikörper (Basedow)
- Puls/Blutdruck
- EKG

THERAPIE

- Thyreostatika nach AO
- Symptomatisch Betablocker nach AO
- Definitiv: Radiojodtherapie oder Operation
- Bei thyreotoxischer Krise intensivmedizinische Behandlung
- Patientenedukation

Pflegeproblem	Aktivitätsintoleranz und Unruhe r/t gesteigertem Stoffwechsel m/d/s Tachykardie, Nervosität, Gewichtsverlust
Ressourcen	Patient kooperativ, Angehörige unterstützen
Pflegeziel	Der Patient ist ruhiger, Puls im Zielbereich, Gewicht stabilisiert sich
Maßnahmen	• Puls/Blutdruck/Temperatur überwachen • Reizarme, kühle Umgebung, Ruhe und Schlaf fördern • Ausreichende Kalorien-/Flüssigkeitszufuhr, Gewicht dokumentieren • Medikamente (Thyreostatika/Betablocker) nach AO • Auf thyreotoxische Krise achten, Edukation
Evaluation	Puls im Zielbereich, ruhiger, Gewicht stabil, keine Krisenzeichen.

Chirurgie

10 Krankheitsbilder

Postoperative Pflege Z48

Pflegerische Versorgung nach operativen Eingriffen. Ziel: Komplikationen verhindern, Erholung fördern, Selbstständigkeit wiederherstellen. ABCDE-Schema im AWR.

SYMPTOME

- Schmerzen (NRS beachten!)
- Übelkeit/Erbrechen (PONV)
- Hypothermie
- Nachblutung
- Wundinfektion (ab Tag 3-5)
- Thrombose (ab Tag 1)
- Pneumonie (ab Tag 2-3)

DIAGNOSTIK

- Vitalzeichen-Monitoring
- Wundinspektion
- Drainageoutput
- Labor (BB, CRP, Gerinnung)
- Schmerzassessment NRS

THERAPIE

- Schmerztherapie nach WHO-Schema
- Frühmobilisation!
- Thromboseprophylaxe
- Wundversorgung
- Ernährungsmanagement

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t operativem Gewebetrauma m/d/s NRS 7/10, Patient schont sich, vermeidet Bewegung
Ressourcen	Kooperativ, Kann NRS-Skala anwenden, Versteht Bedeutung von Mobilisation trotz Schmerz
Pflegeziel	Schmerzreduktion auf NRS ≤ 3 in Ruhe und NRS ≤ 5 bei Bewegung innerhalb von 2h nach Schmerzmedikation
Maßnahmen	• Schmerzerfassung NRS alle 4h + bei Bedarf • Analgetika nach Anordnung pünktlich (nicht erst bei NRS 8!) • Wirkung nach 30-60 Min. kontrollieren, dokumentieren • Lagerung: schmerzarme Position, Kissen zur Abstützung • Nicht-pharmakologisch: Kühlung, Ablenkung, Entspannung • Patienten zur Beurteilung von Schmerz vor Mobilisation einbeziehen • Arzt informieren bei NRS > 6 trotz Analgetikum
Evaluation	NRS 30-60 Min. nach Medikation, täglich Schmerztagebuch

Pflegeproblem	Risiko einer Wundinfektion r/t operativem Eingriff und Immunsuppression
Ressourcen	Versteht Hygienemaßnahmen, Kooperiert bei Verbandswechsel
Pflegeziel	Keine Infektzeichen (Rötung, Schwellung, Eiter, Fieber > 38°C) bis zur Entlassung
Maßnahmen	• Verbandswechsel nach Standard, aseptisch • Wunddokumentation: Größe, Rand, Exsudat, Geruch, Temperatur • Vitalzeichen 2x täglich: Temperatur als Infektmarker • Labor: CRP, Leukozyten beachten • Drainagen: Menge, Farbe, Konsistenz täglich • Händehygiene bei jedem Wundkontakt • Patient: Wundzeichen erkennen, Selbstbeobachtung
Evaluation	Täglich Wundinspektion, Temperatur, Labor

KONTROLLFRAGEN

16 **Welche Prophylaxen sind postoperativ standardmäßig durchzuführen?**

(A) Nur Schmerztherapie

(B) Thromboseprophylaxe + Pneumonieprophylaxe + Dekubitusprophylaxe + Sturzprophylaxe

(C) Nur Antibiotika

(D) Nur Mobilisation

17 **Wann soll eine postoperative Frühmobilisation begonnen werden?**

(A) Erst nach 3 Tagen

(B) So früh wie möglich, meist am OP-Tag oder Tag 1 – nach Stabilität und ärztlicher Freigabe

(C) Erst wenn Schmerzen weg

(D) Erst nach Entfernung der Drainagen

18 **Wann sollte der Arzt bei Wundinspektion sofort informiert werden?**

(A) Bei jedem Verbandswechsel

(B) Bei Zeichen einer Wundinfektion: Rötung, Wärme, Schwellung, Eiter, Fieber, zunehmender Schmerz

(C) Bei normalem Wundsekretverlauf

(D) Bei trockener Wunde

Hüft-TEP / Knie-TEP Z96.6

Totalendoprothese der Hüfte (Hüft-TEP) oder des Knies (Knie-TEP). Häufigste elektive Orthopädie-Operation. Ziel: Schmerzfreiheit und Beweglichkeit wiederherstellen.

SYMPTOME

- Postoperativ: Schmerzen, Schwellung
- Bewegungseinschränkung
- Luxationsgefahr (Hüft-TEP!)
- Thrombosegefahr

DIAGNOSTIK

- Röntgen postoperativ
- Laborkontrollen
- Doppler bei TVT-Verdacht

THERAPIE

- Frühfunktionelle Behandlung
- Physiotherapie ab Tag 1
- Analgesie (PDA, Regionalanästhesie)
- Thromboseprophylaxe (NMH + Strümpfe)

Pflegeproblem	Risiko der Hüft-TEP-Luxation r/t postoperativer Instabilität m/d/s Erstmobilisation Tag 1
Ressourcen	Versteht Luxationsprophylaxe, Kooperativ
Pflegeziel	Keine Luxation während des stationären Aufenthalts, Patient kennt Verbotspositionen nach Entlassung
Maßnahmen	• Verbotspositionen einhalten: kein Beugen > 90°, kein Überkreuzen der Beine, kein Drehen des Fußes nach innen • Lagerungskeil zwischen die Beine (Abduktionskeil) • Transfer immer auf operierte Seite, Anleitung bei jedem Transfer • Toilettenerhöhung, erhöhte Sitzmöbel (Beugewinkel < 90°) • Patient und Angehörige in Verbotspositionen schulen • Physio: Gangschulung mit Gehstützen
Evaluation	Täglich Transfer kontrollieren, Patientenwissen überprüfen

KONTROLLFRAGEN

19 Welche Lagerung ist nach Hüft-TEP zwingend einzuhalten?

A) Beine überkreuzen erlaubt

B) Abduktionskeil zwischen die Beine, kein Beugen > 90°, keine Innenrotation

C) Bauchlagerung

D) Beine eng zusammenhalten

20 Warum ist Thromboseprophylaxe nach Knie-/Hüft-TEP besonders wichtig?

A) Standard bei jedem OP

B) Hohe TVT-Rate (bis 40% ohne Prophylaxe) durch Blutstase und Gefäßverletzung

C) Nur bei übergewichtigen Patienten

D) Nur bei älteren Patienten

21 Was ist bei der Mobilisation nach Knie-TEP zu beachten?

A) Erst nach 1 Woche mobilisieren

B) Frühmobilisation ab Tag 1 mit Physio, Vollbelastung sofort erlaubt je nach Fixation

C) Bettruhe 3 Wochen

D) Nur passive Bewegung

Appendizitis K35

Entzündung des Wurmfortsatzes (Appendix vermiformis). Häufigste chirurgische Notfallerkrankung. Therapie: Appendektomie (laparoskopisch oder offen). Komplikation: Perforation!

SYMPTOME

- Schmerz: periumbilikal → rechter Unterbauch
- McBurney-Punkt druckschmerzhaft
- Loslassschmerz (Blumberg-Zeichen)
- Übelkeit, Erbrechen
- Fieber 37,5-38,5°C
- Abwehrspannung bei Perforation

DIAGNOSTIK

- Klinische Untersuchung (Alvarado-Score)
- Labor: Leukozyten, CRP
- Sonographie
- CT bei Unklarheit

THERAPIE

- Appendektomie laparoskopisch (Standard)
- Antibiose perioperativ
- Bei Perforation: Drainage, Lavage

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t entzündlichem Prozess/OP m/d/s NRS 8, Schonhaltung
Ressourcen	Jung, sonst gesund, Kooperativ
Pflegeziel	NRS ≤ 3 in Ruhe nach 2h, NRS ≤ 5 bei Bewegung
Maßnahmen	• Analgetika nach Anordnung (kein Wärmepflaster auf Bauch!) • Schonlagerung: Knie leicht angewinkelt (Bauchdecke entspannt) • NRS alle 4h erheben • Kühlung auf Wunde wenn hilfreich • Bei Übelkeit: Antiemetikum nach Anordnung, Lagerung • Frühmobilisation nach OP trotz Schmerz anstreben
Evaluation	NRS 30-60 Min. nach Analgetikum

KONTROLLFRAGEN

22 **Was ist der McBurney-Punkt?**

- A Ein Herzpunkt
- B Druckschmerzpunkt bei Appendizitis: Mitte zwischen Nabel und rechtem Darmbeinstachel
- C Nierendruckpunkt
- D Gallenblasenpunkt

23 **Warum ist Wärme bei Appendizitisverdacht kontraindiziert?**

- A Kein Grund
- B Wärme fördert Entzündung und Perforation – absolut verboten!
- C Wärme ist erlaubt
- D Nur Kühlung verboten

24 **Was sind typische postoperative Komplikationen nach Appendektomie?**

- A Keine Komplikationen
- B Wundinfektion, Nachblutung, Darmparalyse (Ileus), Abszess bei Perforation
- C Nur Schmerzen
- D Nur Übelkeit

Cholezystitis / Gallensteine (Cholelithiasis) K80

Gallensteine mit möglicher Entzündung der Gallenblase. Häufige Ursache akuter rechtsseitiger Oberbauchschmerzen; Therapie oft operativ (Cholezystektomie).

SYMPTOME

- Kolikartige Schmerzen im rechten Oberbauch
- Ausstrahlung in Rücken/rechte Schulter
- Übelkeit/Erbrechen
- Fieber bei Entzündung
- Druckschmerz, positives Murphy-Zeichen
- Ggf. Ikterus bei Steinabgang

DIAGNOSTIK

- Sonografie Oberbauch (Steine, Wandverdickung)
- Labor (Entzündungs-/Cholestasewerte)
- Klinik (Murphy-Zeichen)
- Ggf. weitere Bildgebung
- Vitalzeichen

THERAPIE

- Nüchtern, Analgesie/Spasmolyse nach AO
- Antibiotika bei Entzündung nach AO
- Cholezystektomie (meist laparoskopisch)
- Perioperative Pflege
- Bei Gallengangsteinen endoskopische Entfernung

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t Gallenkolik/Gallenblasenentzündung m/d/s rechtsseitigem Oberbauchschmerz, Abwehrspannung
Ressourcen	Patient kooperativ, Frühzeitige Vorstellung
Pflegeziel	Der Patient ist innerhalb weniger Stunden schmerzarm (NRS ≤ 3) und kreislaufstabil
Maßnahmen	• Analgesie/Spasmolyse nach AO, Wirkung kontrollieren • Nüchtern lassen, Vitalzeichen überwachen • Übelkeit/Erbrechen behandeln, Bilanz • Perioperative Vorbereitung bei OP-Indikation • Auf Ikterus/Komplikationen achten
Evaluation	Schmerz reduziert, kreislaufstabil, keine Komplikationszeichen.

Ileus (Darmverschluss) K56

Störung der Darmpassage – mechanisch (z. B. Verwachsungen, Tumor) oder paralytisch (z. B. postoperativ, Peritonitis). Notfall mit Gefahr von Darmischämie/Sepsis.

SYMPTOME

- Zunehmende Bauchschmerzen, geblähtes Abdomen
- Erbrechen (ggf. Miserere bei tiefem Ileus)
- Stuhl-/Windverhalt
- Hochgestellte/klingende oder fehlende Darmgeräusche
- Übelkeit
- Zeichen der Exsikkose/Schock

DIAGNOSTIK

- Auskultation/Palpation des Abdomens
- Röntgen-Abdomen/CT (Spiegel, Dilatation)
- Labor (Entzündung, Laktat, Elektrolyte)
- Vitalzeichen, Bilanz
- Ursachensuche (OP-Anamnese, Tumor)

THERAPIE

- Nüchtern, Magensonde zur Entlastung nach AO
- Volumen-/Elektrolytausgleich i.v.
- Mechanischer Ileus: meist operativ
- Paralytischer Ileus: Ursache behandeln, Motilität fördern
- Engmaschiges Monitoring

Pflegeproblem	Gefahr von Volumenmangel und Komplikationen r/t gestörter Darmpassage m/d/s Erbrechen, geblähtem Abdomen, Stuhlverhalt
Ressourcen	Stationäre Versorgung, Patient kooperativ
Pflegeziel	Der Patient bleibt kreislaufstabil und ausreichend hydriert; Komplikationen werden früh erkannt
Maßnahmen	• Nüchtern lassen, Magensonde nach AO pflegen, Ablauf dokumentieren • i.v.-Volumen/Elektrolyte nach AO, Bilanz • Vitalzeichen, Bauchbefund und Darmgeräusche engmaschig • Schmerzmanagement nach AO • Auf Peritonitis-/Schockzeichen achten, OP-Vorbereitung
Evaluation	Kreislaufstabil, ausreichend hydriert, keine Komplikationszeichen, Passage wiederhergestellt.

Leistenhernie K40

Vorwölbung von Bauchinhalt durch eine Schwachstelle in der Leistenregion. Gefahr der Einklemmung (Inkarzeration) mit Durchblutungsstörung; Therapie operativ.

SYMPTOME

- Vorwölbung/Schwellung in der Leiste
- Ziehen/Schmerz, v. a. bei Belastung
- Reponierbar (unkompliziert)
- Bei Inkarzeration: starke Schmerzen, nicht reponierbar, Übelkeit
- Ggf. Ileuszeichen bei Einklemmung

DIAGNOSTIK

- Klinische Untersuchung (Reponierbarkeit)
- Sonografie bei Unklarheit
- Bei Verdacht auf Inkarzeration rasche Abklärung
- Vitalzeichen

THERAPIE

- Elektive Operation (Netzverfahren)
- Bei Inkarzeration: Notfall-OP
- Perioperative Pflege
- Postoperativ Schonung, schweres Heben vermeiden
- Analgesie nach AO

Pflegeproblem	Gefahr einer Inkarzeration r/t Leistenhernie m/d/s nicht reponibler, schmerzhafter Vorwölbung
Ressourcen	Patient kooperativ, Versteht Warnzeichen
Pflegeziel	Eine Einklemmung wird früh erkannt; postoperativ ist der Patient schmerzarm und komplikationsfrei
Maßnahmen	• Auf Inkarzerationszeichen achten (starker Schmerz, nicht reponibel, Übelkeit) • Perioperative Vorbereitung/Nachsorge, Wundkontrolle • Schmerzmanagement nach AO • Beratung zu Heben/Pressen und Obstipationsprophylaxe • Vitalzeichen überwachen
Evaluation	Keine unerkannte Inkarzeration, postoperativ schmerzarm, Wunde reizlos.

Stomaversorgung (Kolo-/Ileostomie) Z93

Operativ angelegte künstliche Darmöffnung (Stoma) zur Stuhlableitung. Pflegerischer Schwerpunkt: Versorgung, Hautschutz und Anleitung zur Selbstständigkeit.

SYMPTOME

- Stoma (rosig, feucht, leicht erhaben)
- Stuhlausscheidung über das Stoma
- Mögliche peristomale Hautreizung
- Komplikationen: Retraktion, Prolaps, Stenose, Parastomalhernie
- Psychische Belastung/ Akzeptanzprobleme

DIAGNOSTIK

- Inspektion von Stoma und peristomaler Haut
- Beurteilung von Durchblutung/ Vitalität des Stomas
- Ausscheidungskontrolle (Menge/ Konsistenz)
- Bei Komplikationen ärztliche/ Stomatherapeuten-Vorstellung

THERAPIE

- Sachgerechte Versorgung (passende Basisplatte/Beutel)
- Peristomaler Hautschutz
- Bei Komplikationen Anpassung/ ärztliche Behandlung
- Ernährungsberatung
- Einbindung der Stomatherapie

Pflegeproblem	Gefahr einer Hautschädigung r/t Stuhlkontakt bei Stoma m/d/s peristomaler Hautrötung/Reizung
Ressourcen	Patient lernbereit, Stomatherapie verfügbar, Angehörige unterstützen
Pflegeziel	Die peristomale Haut bleibt intakt; der Patient versorgt sein Stoma zunehmend selbstständig
Maßnahmen	• Versorgungssystem sachgerecht und dicht anpassen, Leckagen vermeiden • Peristomalen Hautschutz anwenden, Haut regelmäßig beurteilen • Ausscheidung dokumentieren, Komplikationen früh erkennen • Patienten Schritt für Schritt zur Selbstversorgung anleiten • Psychische Unterstützung, Stomatherapie/Ernährungsberatung einbeziehen
Evaluation	Peristomale Haut intakt, dichte Versorgung, zunehmende Selbstständigkeit.

Thoraxdrainage-Pflege Z48.0

Drainage des Pleuraraums zur Ableitung von Luft (Pneumothorax) oder Flüssigkeit (Erguss/Blut). Pflegerischer Schwerpunkt: sichere Handhabung des Drainagesystems und Überwachung.

SYMPTOME

- Liegende Thoraxdrainage mit Drainagesystem
- Atemabhängige Schwankung/Sog (je nach System)
- Mögliche Luftleckage (Blubbern)
- Atemnot/Schmerz bei Komplikationen
- Sekret-/Luftförderung

DIAGNOSTIK

- Atmung/SpO_2 und Vitalzeichen überwachen
- Drainagesystem prüfen (Sog, Wasserschloss, Fördermenge)
- Röntgen Thorax zur Lagekontrolle
- Auf Komplikationen (Dislokation, Verstopfung, Hautemphysem) achten

THERAPIE

- Korrekte Position des Drainagesystems (unter Thoraxniveau, kein Abknicken)
- Sog nach AO einstellen
- Fördermenge/Luftleck dokumentieren
- Schmerzmanagement, Atemtherapie/Mobilisation
- Entfernung nach AO bei Besserung

Pflegeproblem	Gefahr einer respiratorischen Komplikation r/t liegender Thoraxdrainage m/d/s Pneumothorax/Erguss, Dislokationsrisiko
Ressourcen	Patient kooperativ, Funktionierendes Drainagesystem
Pflegeziel	Die Drainage funktioniert sicher; der Patient bleibt respiratorisch stabil ($SpO_2 \geq 94$ %)
Maßnahmen	• Drainagesystem korrekt führen und regelmäßig kontrollieren (Sog/Wasserschloss/Förderung/Leck) • Atmung/SpO_2/Vitalzeichen überwachen, Eintrittsstelle beobachten • Schmerzmanagement, Atemtherapie und Mobilisation • Lage-/Verbandkontrolle, Komplikationen früh erkennen • Bei Diskonnektion/Dislokation nach Standard handeln und Arzt informieren
Evaluation	Drainage funktioniert sicher, SpO_2 stabil, keine Komplikation.

Postoperative Wundinfektion (SSI) T81.4

Infektion im Operationsgebiet nach einem Eingriff (Surgical Site Infection), oberflächlich oder tief. Wichtig: Früherkennung, Hygiene und Wundmanagement.

SYMPTOME

- Rötung, Schwellung, Überwärmung der Wunde
- Schmerzzunahme
- Eitrige Sekretion/Wunddehiszenz
- Fieber
- Verzögerte Wundheilung

DIAGNOSTIK

- Wundinspektion (Lokalzeichen)
- Temperatur/Entzündungswerte
- Wundabstrich nach AO
- Beurteilung von Sekret/Wundheilung
- Ggf. Bildgebung bei tiefer Infektion

THERAPIE

- Wundmanagement nach AO (Reinigung, ggf. Eröffnung/Drainage)
- Antibiotika bei Indikation nach AO
- Aseptischer Verbandwechsel
- Schmerzmanagement
- Ernährung/Allgemeinzustand optimieren

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Hautintegrität/Infektion r/t postoperativer Wundinfektion m/d/s Rötung, Sekretion, verzögerter Heilung
Ressourcen	Patient kooperativ, Gute Wundheilungsvoraussetzungen
Pflegeziel	Die Wundinfektion ist rückläufig (abnehmende Lokalzeichen), keine Ausbreitung
Maßnahmen	• Wunde regelmäßig beurteilen und dokumentieren • Aseptischer Verbandwechsel, konsequente Händehygiene • Temperatur/Entzündungszeichen überwachen • Wundmanagement und Antibiotika nach AO • Ernährung/Mobilisation fördern, Edukation, Hygienemaßnahmen
Evaluation	Lokalzeichen rückläufig, kein Fieber, fortschreitende Wundheilung.

Divertikulitis K57

Entzündung von Ausstülpungen der Darmwand (Divertikel), meist im Sigma. Verlauf von leicht bis kompliziert (Abszess, Perforation).

SYMPTOME

- Schmerzen im linken Unterbauch
- Fieber
- Stuhlunregelmäßigkeiten (Obstipation/Diarrhö)
- Übelkeit
- Druckschmerz/Abwehrspannung links
- Bei Komplikation: Peritonitiszeichen

DIAGNOSTIK

- Klinik (Druckschmerz links)
- Labor (Entzündungswerte)
- CT-Abdomen (Schweregrad/ Komplikationen)
- Vitalzeichen
- Koloskopie erst nach Abklingen der Akutphase

THERAPIE

- Leichte Form: Ernährung/ Schonung, ggf. ambulant
- Antibiotika nach AO bei Indikation
- Bei Komplikation (Abszess/ Perforation): stationär/operativ
- Analgesie nach AO
- Ernährungsberatung (ballaststoffreich nach Akutphase)

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t Divertikelentzündung m/d/s linksseitigem Unterbauchschmerz, Druckschmerz, Fieber
Ressourcen	Patient kooperativ, Frühzeitige Vorstellung
Pflegeziel	Der Patient ist schmerzarm (NRS ≤ 3) und fieberfrei; Komplikationen werden früh erkannt
Maßnahmen	• Schmerz-/Temperatur-/Vitalzeichenüberwachung • Ernährung nach AO anpassen, Bilanz • Antibiotika/Analgesie nach AO • Auf Peritonitis-/Komplikationszeichen achten • Ernährungsberatung (ballaststoffreich nach Akutphase)
Evaluation	Schmerz reduziert, fieberfrei, keine Komplikationszeichen.

Psychologie für Pflege

10 Krankheitsbilder

Kommunikationsmodelle –

Theoretische Modelle zur Erklärung von Kommunikationsprozessen. In der Pflege grundlegend für therapeutische Kommunikation, Patientenedukation und Teamarbeit.

SYMPTOME

- Kommunikationsprobleme
- Missverständnisse
- Konflikte im Team
- Non-Compliance des Patienten

DIAGNOSTIK

- Gesprächsanalyse
- Selbstreflexion
- Supervision

THERAPIE

- Aktives Zuhören
- Gewaltfreie Kommunikation (GFK)
- Ich-Botschaften
- Feedback-Kultur

Pflegeproblem	Beeinträchtigte verbale Kommunikation r/t sprachlicher Barriere/Aphasie m/d/s Patient kann Bedürfnisse nicht äußern
Ressourcen	Gestik vorhanden, Familie als Dolmetscher, Bildkarten verfügbar
Pflegeziel	Patient kommuniziert 3 Grundbedürfnisse (Schmerz, Hunger, Toilette) mit Hilfsmitteln nach 48h
Maßnahmen	• Kommunikationsboard einsetzen (Bilder/Symbole) • Ja/Nein-Fragen stellen • Einfache kurze Sätze, langsam sprechen • Geduld: Patient nicht unterbrechen • Logopädie einbeziehen • Nonverbale Kommunikation bewusst einsetzen (Mimik, Gestik) • Angehörige als Kommunikationshelfer schulen
Evaluation	Täglich Kommunikationserfolge dokumentieren

KONTROLLFRAGEN

25 **Was besagt das 4-Ohren-Modell nach Schulz von Thun?**

(A) 4 Kommunikationsstile

(B) Jede Nachricht hat 4 Seiten: Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehung, Appell

(C) 4 Phasen der Kommunikation

(D) 4 Fehler in der Kommunikation

26 **Was ist aktives Zuhören in der Pflege?**

(A) Einfach schweigen

(B) Verbales + nonverbales Signalisieren von Aufmerksamkeit: Blickkontakt, Nicken, Paraphrasieren, offene Fragen, keine Ratschläge

(C) Nur nicken

(D) Patient ausreden lassen ohne Reaktion

27 **Was ist Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Rosenberg?**

A) Kommunikation ohne Schreien

B) 4-Schritte-Modell: Beobachtung - Gefühl - Bedürfnis - Bitte

C) Ein Konfliktmanagement-Kurs

D) Schweigen bei Konflikten

Stressbewältigung & Burnout Z73

Pflegeberufe haben hohes Burnout-Risiko. Burnout = emotionale Erschöpfung + Depersonalisation + reduzierte Leistungsfähigkeit. Prävention ist Kernaufgabe des Selbstmanagements.

SYMPTOME

- Emotionale Erschöpfung
- Zynismus, Distanzierung
- Leistungsabfall
- Schlafstörungen
- Psychosomatische Beschwerden
- Innere Kündigung

DIAGNOSTIK

- Maslach Burnout Inventory (MBI)
- Selbstreflexion
- Supervision
- Betriebsärztliche Beratung

THERAPIE

- Ressourcenaktivierung
- Work-Life-Balance
- Supervision
- Psychotherapie
- Stressmanagement-Techniken

Pflegeproblem	Risiko Burnout r/t chronischer Arbeitsbelastung und unzureichender Erholung m/d/s MBI-Score erhöht
Ressourcen	Hohe Berufsmotivation, Kollegiales Team, Sport als Ausgleich
Pflegeziel	Mitarbeiter benennt 3 persönliche Stressbewältigungsstrategien und nutzt sie regelmäßig
Maßnahmen	• Supervision regelmäßig anbieten • Dienstplanung: ausreichend Erholungszeiten • Ressourcen stärken: was gibt Energie? • Grenzen setzen: Nein sagen lernen • Progressive Muskelrelaxation (PMR) anleiten • Kollegiale Fallberatung etablieren
Evaluation	Nach 4 Wochen: MBI-Score, subjektives Wohlbefinden

KONTROLLFRAGEN

28 **Was sind die 3 Kernkomponenten des Burnout-Syndroms nach Maslach?**

A) Müdigkeit, Kopfschmerz, Rücken

B) Emotionale Erschöpfung + Depersonalisation + reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit

C) Stress, Konflikte, Überstunden

D) Depression, Angst, Panik

29 **Was ist Progressive Muskelrelaxation (PMR) nach Jacobson?**

A) Eine Sportart

B) Stressbewältigungstechnik: bewusstes An- und Entspannen von Muskelgruppen → körperliche Entspannung → mentale Entspannung

C) Eine Massagetechnik

D) Ein Atemübungskonzept

30 **Was versteht man unter 'Selbstfürsorge' in der Pflege?**

A Eigene Interessen über Patienten stellen

B Bewusster Umgang mit den eigenen Ressourcen um langfristig gesund und arbeitsfähig zu bleiben

C Nur Urlaub nehmen

D Sich nicht um Arbeit kümmern

Motivationstheorien –

Theorien zur Erklärung menschlichen Verhaltens und Antriebe. In der Pflege relevant für Patientenedukation, Compliance-Förderung und Teamführung.

SYMPTOME
- Mangelnde Compliance
- Non-Adhärenz
- Motivationsprobleme im Team

DIAGNOSTIK
- Motivationsanalyse
- Gespräch
- Zielvereinbarung

THERAPIE
- Motivierende Gesprächsführung
- Ressourcenorientierung
- Zielvereinbarung

KONTROLLFRAGEN

31 **Was beschreibt Maslows Bedürfnispyramide?**

A 5 Kommunikationsstufen

B Hierarchie menschlicher Bedürfnisse: Physiologisch → Sicherheit → Soziales → Anerkennung → Selbstverwirklichung

C 5 Stressstufen

D 5 Lerntypen

32 **Was ist motivierende Gesprächsführung (Motivational Interviewing)?**

A Überredung des Patienten

B Patientenzentrierte Technik: Autonomie stärken, Ambivalenz erkunden, eigene Motivation aktivieren – nicht sagen was Patient tun soll

C Direktive Beratung

D Informationsvermittlung

33 **Was ist das Transtheoretische Modell (TTM) der Verhaltensänderung?**

A Ein Kommunikationsmodell

B 5 Stadien der Verhaltensänderung: Absichtslosigkeit → Absichtsbildung → Vorbereitung → Handlung → Aufrechterhaltung

C Ein Stressmodell

D Ein Lernmodell

Professionelle Nähe und Distanz –

Balance zwischen empathischer Zuwendung und professioneller Abgrenzung in der Pflegebeziehung. Zu viel Distanz wirkt kalt, zu viel Nähe überfordert und verwischt die Rollen.

SYMPTOME

- Übermäßige emotionale Verstrickung oder Gleichgültigkeit
- Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen
- Gefühl der Überforderung/ Ausbrennen
- Bevorzugung/Abneigung einzelner Patienten
- Rollenunklarheit

DIAGNOSTIK

- Selbstreflexion eigener Gefühle/ Reaktionen
- Kollegiale Beratung/Supervision
- Beobachtung von Beziehungsdynamiken
- Feedback im Team

THERAPIE

- Bewusste Rollenklärung und Grenzen
- Empathie mit professioneller Abgrenzung verbinden
- Supervision/Intervision nutzen
- Selbstfürsorge
- Klare, wertschätzende Kommunikation

Pflegeproblem	Gefahr emotionaler Überlastung r/t mangelnder Nähe-Distanz-Balance m/d/s Überforderungsgefühl, unklaren Grenzen
Ressourcen	Team/Supervision verfügbar, Bereitschaft zur Selbstreflexion
Pflegeziel	Die Pflegekraft gestaltet die Beziehung empathisch und zugleich professionell abgegrenzt
Maßnahmen	• Rollen und Grenzen bewusst klären und kommunizieren • Eigene Gefühle reflektieren, Supervision/Intervision nutzen • Empathie mit Abgrenzung verbinden • Selbstfürsorge praktizieren • Beziehungsdynamiken im Team besprechen
Evaluation	Beziehung tragfähig, Grenzen gewahrt, keine Überlastung.

Umgang mit Sterben, Tod und Trauer –

Begleitung sterbender Menschen und ihrer Angehörigen sowie der Umgang mit Trauer. Erfordert Haltung, kommunikative Kompetenz und Selbstfürsorge.

SYMPTOME

- Sterbephasen (nach Kübler-Ross: Nicht-wahrhaben, Zorn, Verhandeln, Depression, Akzeptanz)
- Angst, Schmerz, Rückzug
- Belastung der Angehörigen
- Trauerreaktionen
- Eigene Betroffenheit der Pflegenden

DIAGNOSTIK

- Bedürfnisse und Wünsche des Sterbenden erfassen
- Belastung der Angehörigen einschätzen
- Symptome/Leiden beobachten
- Patientenverfügung/Wünsche beachten

THERAPIE

- Palliative Begleitung, Symptomlinderung nach AO
- Würde, Ruhe und Präsenz ermöglichen
- Angehörige einbeziehen und begleiten
- Spirituelle/seelsorgerische Unterstützung anbieten
- Abschied ermöglichen

Pflegeproblem	Bedürfnis nach würdevoller Begleitung r/t Sterbeprozess m/d/s Angst, Schmerz, Belastung von Patient und Angehörigen
Ressourcen	Angehörige anwesend, Palliativteam/Seelsorge verfügbar, Wünsche/Verfügung bekannt
Pflegeziel	Der sterbende Mensch wird würdevoll und möglichst beschwerdearm begleitet; Angehörige fühlen sich unterstützt
Maßnahmen	• Präsenz, Zuwendung, Zuhören • Schmerz-/Symptomkontrolle nach AO • Würde und Wünsche respektieren, Ruhe ermöglichen • Angehörige einbeziehen und begleiten, Abschied ermöglichen • Seelsorge/Palliativteam einbinden, Selbstfürsorge
Evaluation	Beschwerden gelindert, Würde gewahrt, Angehörige begleitet.

Umgang mit Angst beim Patienten –

Angst ist eine häufige Reaktion auf Krankheit, Eingriffe und Klinikaufenthalt. Pflegerischer Umgang zielt auf Sicherheit, Information und emotionale Entlastung.

SYMPTOME

- Unruhe, Anspannung, Nervosität
- Vegetative Zeichen (Herzrasen, Schwitzen, Zittern)
- Vermeidung, Rückzug oder Klammern
- Fragen/Rückversicherung, Schlafstörungen
- Konzentrations-/ Kooperationsprobleme

DIAGNOSTIK

- Angst und Auslöser erfragen/ beobachten
- Vegetative Zeichen wahrnehmen
- Informationsbedarf einschätzen
- Vorerfahrungen/ Bewältigungsmuster erfragen

THERAPIE

- Sichere, ruhige Atmosphäre, Präsenz
- Verständliche Information und Aufklärung
- Beteiligung und Kontrolle ermöglichen
- Beruhigungs-/ Entspannungstechniken
- Bei Bedarf ärztliche/ psychologische Unterstützung

Pflegeproblem	Angst r/t Krankheit/Eingriff/Klinikaufenthalt m/d/s Unruhe, vegetativen Zeichen, Rückversicherungsbedarf
Ressourcen	Patient äußert sich, Angehörige unterstützen, Bewältigungserfahrungen vorhanden
Pflegeziel	Der Patient fühlt sich sicherer und ist merklich entlastet (ruhiger, kooperativer)
Maßnahmen	• Ruhige, sichere Atmosphäre und Präsenz • Verständlich informieren und aufklären • Mitbestimmung/Kontrolle ermöglichen • Entspannungs-/Ablenkungsangebote • Bei starker Angst ärztliche/psychologische Unterstützung
Evaluation	Angst reduziert, ruhiger, kooperativer.

Validierender Umgang bei Demenz –

Kommunikationshaltung, die die Gefühle und die subjektive Wirklichkeit demenziell erkrankter Menschen wertschätzt, statt sie zu korrigieren (Validation).

SYMPTOME

- Desorientierung, Zeit-/ Ortsverwirrung
- Wiederholtes Fragen, Hinlauftendenz
- Unruhe, Angst, Aggression bei Korrektur
- Rückzug
- Herausforderndes Verhalten

DIAGNOSTIK

- Bedürfnisse hinter dem Verhalten erkennen
- Auslöser von Unruhe/Aggression beobachten
- Biografie und Gewohnheiten einbeziehen
- Kommunikationsfähigkeiten einschätzen

THERAPIE

- Validation: Gefühle bestätigen, nicht die Realität korrigieren
- Einfache, ruhige Kommunikation, Blickkontakt
- Biografiearbeit, vertraute Routinen
- Reizarme, sichere Umgebung
- Herausforderndes Verhalten verstehen statt sanktionieren

Pflegeproblem	Herausforderndes Verhalten/Unruhe r/t Demenz und Desorientierung m/d/s Angst, Aggression bei Korrektur
Ressourcen	Biografie bekannt, Angehörige unterstützen, Vertraute Routinen
Pflegeziel	Der Mensch mit Demenz fühlt sich verstanden und sicher; Unruhe/Aggression nehmen ab
Maßnahmen	• Validierend kommunizieren (Gefühle bestätigen, nicht korrigieren) • Einfache, ruhige Sprache, Blickkontakt, Zeit • Biografie/Routinen einbeziehen, Orientierungshilfen • Auslöser meiden, reizarme sichere Umgebung • Geduld und Wertschätzung, Angehörige einbeziehen
Evaluation	Weniger Unruhe/Aggression, fühlt sich sicherer und verstanden.

Deeskalation und Umgang mit Aggression –

Strategien zur Verhinderung und Entschärfung aggressiver oder gewaltträchtiger Situationen durch Kommunikation, Haltung und Eigenschutz.

SYMPTOME

- Zunehmende Anspannung, lautere Stimme
- Drohgebärden, motorische Unruhe
- Gereiztheit, Provokation
- Eingeengtes Denken
- Vorboten von Gewalt

DIAGNOSTIK

- Frühwarnzeichen wahrnehmen
- Auslöser/Bedürfnisse erkennen
- Eigene Sicherheit/Fluchtweg einschätzen
- Situationsdynamik beobachten

THERAPIE

- Ruhig bleiben, Distanz wahren, reizarm
- Aktiv zuhören, ernst nehmen, Optionen anbieten
- Klare, einfache Kommunikation, nicht provozieren
- Eigenschutz/Team, Hilfe holen
- Nachbesprechung/Reflexion

Pflegeproblem	Gefahr von Gewalt/Eskalation r/t Aggression m/d/s zunehmender Anspannung, Drohgebärden
Ressourcen	Team verfügbar, Deeskalationskompetenz, Erkennbare Auslöser
Pflegeziel	Die Situation wird deeskaliert; Patient und Mitarbeitende bleiben unversehrt
Maßnahmen	• Frühwarnzeichen erkennen und früh deeskalieren • Ruhe, Distanz, Eigenschutz, reizarme Umgebung • Aktiv zuhören, ernst nehmen, Optionen anbieten • Bei Gefährdung Team/Hilfe holen • Nachbesprechung und Reflexion der Auslöser
Evaluation	Situation entschärft, niemand verletzt, Auslöser reflektiert.

Kultursensible Kommunikation –

Pflege, die kulturelle, religiöse und sprachliche Hintergründe achtet und Missverständnisse vermeidet (transkulturelle Kompetenz).

SYMPTOME

- Sprachbarrieren, Missverständnisse
- Unterschiedliche Krankheits-/Schmerzkonzepte
- Religiöse/kulturelle Bedürfnisse (Ernährung, Rituale, Geschlecht)
- Unsicherheit/Rückzug
- Konflikte durch unterschiedliche Erwartungen

DIAGNOSTIK

- Sprach-/Verständigungsbedarf erfassen
- Kulturelle/religiöse Bedürfnisse erfragen
- Eigene Vorurteile reflektieren
- Ressourcen (Dolmetscher, Angehörige) klären

THERAPIE

- Respektvolle, offene Haltung, nachfragen statt annehmen
- Dolmetscher/Übersetzungshilfen nutzen
- Bedürfnisse (Ernährung, Rituale, Schamgefühl) berücksichtigen
- Einfache Sprache, nonverbale Kommunikation
- Individuell statt stereotyp

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Kommunikation r/t Sprach-/Kulturunterschieden m/d/s Missverständnissen, Unsicherheit
Ressourcen	Dolmetscher/Angehörige verfügbar, Patient kooperativ, Offenheit im Team
Pflegeziel	Die Verständigung gelingt; kulturelle/religiöse Bedürfnisse werden berücksichtigt
Maßnahmen	• Verständigung sichern (Dolmetscher, einfache Sprache, Hilfsmittel) • Kulturelle/religiöse Bedürfnisse erfragen und respektieren • Schamgefühl/Präferenzen beachten • Offen, individuell und ohne Stereotype handeln • Angehörige einbeziehen
Evaluation	Verständigung gelungen, Bedürfnisse berücksichtigt, weniger Konflikte.

Umgang mit depressiven Patienten –

Pflegerischer Umgang mit Menschen mit depressiver Symptomatik: Beziehung, Struktur, behutsame Aktivierung und Beobachtung – ohne Überforderung oder Bagatellisierung.

SYMPTOME

- Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit
- Interessenverlust, Rückzug
- Schlaf-/Appetitstörungen
- Negatives Denken, Hoffnungslosigkeit
- Verlangsamung, ggf. Suizidgedanken

DIAGNOSTIK

- Stimmung, Antrieb, Rückzug beobachten
- Auf Hoffnungslosigkeit/Suizidalität achten (offen ansprechen)
- Schlaf/Appetit/Tagesstruktur erfassen
- Ressourcen und Belastungen erfragen

THERAPIE

- Tragfähige, wertschätzende Beziehung
- Realistische Tagesstruktur, kleine erreichbare Ziele
- Behutsame Aktivierung ohne Überforderung
- Medikamentöse/ psychotherapeutische Behandlung nach AO
- Bei Suizidalität Schutz und ärztliche Einbindung

Pflegeproblem	Antriebslosigkeit und sozialer Rückzug r/t depressiver Symptomatik m/d/s Interessenverlust, Hoffnungslosigkeit
Ressourcen	Patient lässt Kontakt zu, Angehörige unterstützen, Behandlung läuft
Pflegeziel	Der Patient nimmt zunehmend an Struktur/Aktivitäten teil; Suizidalität wird sicher erfasst
Maßnahmen	• Wertschätzende, geduldige Beziehung, ernst nehmen • Tagesstruktur und kleine erreichbare Ziele unterstützen • Behutsam aktivieren, Erfolge würdigen • Schlaf/Ernährung/Körperpflege fördern • Auf Suizidalität achten, offen ansprechen, Arzt/Team einbeziehen
Evaluation	Mehr Teilnahme/Antrieb, Suizidalität erfasst und adressiert.

Gynäkologie

17 Krankheitsbilder

Mammakarzinom C50

Häufigste Krebserkrankung der Frau (30% aller Karzinome). Invasives duktales oder lobuläres Karzinom. Risikofaktoren: BRCA1/2, Alter, Hormone, Adipositas. 5-Jahres-Überleben Stad. I: >95%.

SYMPTOME

- Schmerzlose Verhärtung der Brust
- Hautveränderungen (Orangenhaut, Einziehungen)
- Brustwarzeneinziehung oder -ausfluss
- Axilläre Lymphknotenschwellung
- Asymmetrie der Brust
- Hautrötung/Überwärmung (inflammatorisch)

DIAGNOSTIK

- Mammographie (Screening ab 50)
- Sonographie
- MRT Mamma
- Stanzbiopsie (Histologie)
- Sentinel-Lymphknoten-Biopsie
- Staging: CT, Knochenszintigraphie

THERAPIE

- Operation: BET (brusterhaltend) oder Mastektomie
- Sentinel-LK-Biopsie / Axilladissektion
- Strahlentherapie nach BET
- Chemotherapie (neo-/adjuvant)
- Antihormontherapie (Tamoxifen, Aromatasehemmer)
- Herceptin bei HER2-positiv

Pflegeproblem	Beeinträchtigtes Körperbild r/t Mastektomie/Narbe m/d/s Patientin betrachtet Wunde nicht, äußert Scham
Ressourcen	Vertrauensvolle Beziehung zur Pflegekraft, Unterstützender Partner, Offenheit für Gespräche
Pflegeziel	Patientin betrachtet Wundbereich und benennt 2 positive Aspekte ihres Körpers bis zur Entlassung
Maßnahmen	• Einfühlsame Wundpflege: Patientin einbeziehen, nicht drängen • Aktives Zuhören: Gefühle ernst nehmen, nicht bagatellisieren • Informationen über Brustprothesen, Rekonstruktion anbieten • Kontakt zu Selbsthilfegruppe (z.B. Frauenselbsthilfe nach Krebs) • Sexualberatung bei Bedarf ansprechen • Psychoonkologischen Dienst einbeziehen
Evaluation	Täglich Gesprächsbereitschaft beobachten, Körperbildwahrnehmung erfragen

Pflegeproblem	Risiko Lymphödem r/t Axilladissektion m/d/s Einschränkung Lymphabfluss rechter Arm
Ressourcen	Versteht Prophylaxemaßnahmen, Kooperativ
Pflegeziel	Patientin benennt Lymphödem-Prophylaxemaßnahmen korrekt vor Entlassung
Maßnahmen	• Keine Blutdruck-Messungen, Injektionen, Blutabnahmen am betroffenen Arm • Armlymphödem-Prophylaxe schulen: kein enger Schmuck, keine Hitze • Manuelle Lymphdrainage nach Anordnung • Kompressionshandschuh/-ärmel anpassen • Auf Infektionszeichen achten (Rötung, Schwellung, Wärme) • Arm bei Ruhe hochlagern
Evaluation	Armumfang täglich messen, Ödem dokumentieren

KONTROLLFRAGEN

34 **Was bedeutet BET in der Mammakarzinom-Therapie?**

- A Beidseitige Entfernung der Tumore
- B Brusterhaltende Therapie: Tumorektomie + Strahlentherapie statt Mastektomie
- C Eine Chemotherapie-Art
- D Biologische Ersatztherapie

35 **Was ist beim Lymphödem-Risiko nach Axilladissektion zu beachten?**

- A Kein Problem
- B Kein RR-Messen, keine Injektionen, keine Blutabnahmen am betroffenen Arm – Infektionsschutz!
- C Nur keine heißen Bäder
- D Nur Armhochlagerung

36 **Was ist der Sentinel-Lymphknoten?**

- A Der größte Lymphknoten
- B Der erste drainierende Lymphknoten = Wächterlymphknoten: Befall → höheres Metastasierungsrisiko
- C Ein gesunder Lymphknoten
- D Der entfernteste Lymphknoten

Präeklampsie / Eklampsie O14

Hypertensive Schwangerschaftserkrankung ab 20. SSW. Präeklampsie: RR ≥140/90 + Proteinurie. Schwere Form: HELLP-Syndrom. Eklampsie: zerebrale Krampfanfälle. Lebensbedrohlich für Mutter und Kind.

SYMPTOME

- RR ≥ 140/90 mmHg nach 20. SSW
- Proteinurie > 0,3g/24h
- Ödeme (Gesicht, Hände)
- Kopfschmerzen
- Sehstörungen, Flimmern
- Oberbauchschmerzen (HELLP)
- Übelkeit, Erbrechen
- Hyperreflexie

DIAGNOSTIK

- RR-Messung (mehrfach)
- Proteinurie (Streifentest, 24h-Urin)
- Labor: Thrombozyten, Transaminasen, LDH, Harnsäure
- CTG, Doppler-Sonographie
- Augenhintergrund

THERAPIE

- Stationäre Überwachung
- Antihypertensiva: Methyldopa, Nifedipin, Labetalol
- Magnesium i.v. (Eklampsie-Prophylaxe!)
- Bei Eklampsie: Diazepam, Sicherung Atemweg
- Entbindung = einzige Heilung
- Frühgeburt einkalkulieren

Pflegeproblem	Risiko mütterlicher Verletzung r/t möglichem Eklampsie-Anfall m/d/s RR 160/100, Hyperreflexie
Ressourcen	Hospitalisiert, CTG-Monitoring vorhanden, Kooperative Patientin
Pflegeziel	Patientin erleidet keinen Krampfanfall durch konsequente Prophylaxe und Überwachung
Maßnahmen	• RR alle 15-30 Min. messen und dokumentieren • Magnesium i.v. nach Anordnung: Laufrate kontrollieren • Patellarsehnenreflex stündlich prüfen (Mg-Toxizität!) • Atemfrequenz überwachen (> 12/Min.!) • Antidot Calciumgluconat griffbereit halten • Reizarme Umgebung: Licht dimmen, Ruhe • Sturzprophylaxe: Bettgitter hochstellen • Krampfbereitschaft: Beißkeil, Sauger, O_2 bereit
Evaluation	Kontinuierliches Monitoring, sofort Arzt bei RR > 160/110 oder Reflexveränderungen

KONTROLLFRAGEN

37 **Was ist das HELLP-Syndrom?**

A) Ein Herzfehler
B) Schwere Präeklampsie: Hämolyse + Elevated Liver enzymes + Low Platelets – lebensbedrohlich!
C) Eine Allergie
D) Ein Atemwegsproblem

38 **Warum wird Magnesiumsulfat bei Eklampsie eingesetzt?**

A) Als Diuretikum
B) Krampfprophylaxe und -therapie: Mg hemmt neuromuskuläre Übertragung – Antidot: Calciumgluconat!
C) Als Blutdruckmittel
D) Als Tokolytikum

39 **Wann spricht man von Eklampsie?**

A) Bei hohem Blutdruck allein
B) Bei Krampfanfall im Rahmen einer Präeklampsie – medizinischer Notfall!
C) Bei Ödemen
D) Bei Proteinurie

Endometriose N80

Vorkommen von gebärmutterschleimhaut-ähnlichem Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle. Häufige Ursache chronischer Unterbauchschmerzen und von Unfruchtbarkeit.

SYMPTOME

- Zyklusabhängige, oft starke Unterbauchschmerzen
- Dysmenorrhö (schmerzhafte Regel)
- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
- Zyklusstörungen
- Unerfüllter Kinderwunsch
- Müdigkeit

DIAGNOSTIK

- Anamnese (zyklusabhängiger Schmerz)
- Gynäkologische Untersuchung
- Sonografie
- Laparoskopie (Sicherung)
- Schmerzverlauf/Zyklusbezug

THERAPIE

- Schmerztherapie nach AO
- Hormontherapie nach AO
- Operative Entfernung der Herde (Laparoskopie)
- Kinderwunschbehandlung bei Bedarf
- Begleitung/Beratung

Pflegeproblem	Chronischer Schmerz r/t Endometriose m/d/s zyklusabhängigem Unterbauchschmerz, Dysmenorrhö
Ressourcen	Patientin kooperativ, Behandlung läuft
Pflegeziel	Die Patientin ist schmerzgelindert (NRS ≤ 3) und kann mit der Erkrankung umgehen
Maßnahmen	• Schmerzmanagement nach AO, Wirkung/Zyklusbezug dokumentieren • Wärme/Entspannung anbieten • Perioperative Pflege bei Eingriff • Psychische Unterstützung (Schmerz, Kinderwunsch) • Edukation zu Hormon-/Schmerztherapie
Evaluation	Schmerz gelindert, Patientin informiert und entlastet.

Uterus myomatosus (Myome) D25

Gutartige Muskelknoten der Gebärmutter (Myome). Häufig; können Blutungsstörungen, Druckgefühl und Schmerzen verursachen.

SYMPTOME

- Verstärkte/verlängerte Regelblutung
- Unterbauchschmerzen/ Druckgefühl
- Blutungsanämie möglich
- Harndrang/Obstipation bei Druck
- Oft auch beschwerdefrei

DIAGNOSTIK

- Gynäkologische Untersuchung
- Sonografie
- Labor (Anämie bei starker Blutung)
- Ggf. Hysteroskopie
- Verlaufskontrolle

THERAPIE

- Beobachtung bei Beschwerdefreiheit
- Hormon-/Blutungstherapie nach AO
- Operative Entfernung (Myomenukleation) oder Hysterektomie
- Behandlung der Anämie
- Beratung

Pflegeproblem	Gefahr einer Anämie r/t verstärkter Blutung bei Uterus myomatosus m/d/s Hypermenorrhö, Müdigkeit
Ressourcen	Patientin kooperativ, Behandlung verfügbar
Pflegeziel	Die Blutung ist kontrolliert; eine Anämie wird erkannt und behandelt
Maßnahmen	• Blutungsstärke und Anämiezeichen beobachten • Labor/Eisentherapie nach AO unterstützen • Schmerzmanagement nach AO • Perioperative Pflege bei OP • Edukation zu Therapieoptionen
Evaluation	Blutung kontrolliert, keine/behandelte Anämie, Patientin informiert.

Ovarialkarzinom C56

Bösartiger Tumor der Eierstöcke, oft spät symptomatisch und daher häufig erst in fortgeschrittenem Stadium diagnostiziert.

SYMPTOME

- Lange unspezifisch/symptomarm
- Zunehmender Bauchumfang/ Aszites
- Druck-/Völlegefühl, Verdauungsbeschwerden
- Unterbauchschmerzen
- Gewichtsverlust, Leistungsminderung

DIAGNOSTIK

- Gynäkologische Untersuchung
- Sonografie/CT
- Tumormarker (z. B. CA-125) nach AO
- Histologie (operativ)
- Staging

THERAPIE

- Operative Tumorentfernung
- Chemotherapie nach AO
- Symptom-/Aszitesmanagement
- Supportive/palliative Therapie bei Bedarf
- Psychoonkologische Begleitung

Pflegeproblem	Belastung durch Symptome und Diagnose r/t Ovarialkarzinom m/d/s Aszites, Schmerzen, Sorge
Ressourcen	Angehörige unterstützen, Psychoonkologie verfügbar
Pflegeziel	Die Patientin ist symptomkontrolliert und fühlt sich in der Krankheitsbewältigung unterstützt
Maßnahmen	• Perioperative/onkologische Pflege, Symptomkontrolle • Aszites/Bauchumfang/Ernährung/Bilanz beobachten • Chemotherapie-Nebenwirkungen nach AO managen • Schmerztherapie nach AO • Psychoonkologische Begleitung, Angehörige einbeziehen
Evaluation	Symptome kontrolliert, Patientin unterstützt und informiert.

Zervixkarzinom (Gebärmutterhalskrebs) C53

Bösartiger Tumor des Gebärmutterhalses, meist durch HPV-Infektion bedingt. Früherkennung (Vorsorge) und HPV-Impfung sind wichtig.

SYMPTOME

- Frühstadium oft symptomlos
- Kontaktblutungen (z. B. nach Verkehr)
- Zwischen-/Postmenopausenblutungen
- Ausfluss
- Fortgeschritten: Schmerzen, Beschwerden

DIAGNOSTIK

- Vorsorge: Zytologie (Pap), HPV-Test
- Kolposkopie, Biopsie
- Bildgebung zum Staging
- Gynäkologische Untersuchung

THERAPIE

- Operative Therapie (je nach Stadium)
- Strahlen-/Chemotherapie nach AO
- Nachsorge
- Prävention: HPV-Impfung, Vorsorge
- Psychoonkologische Begleitung

Pflegeproblem	Belastung und Symptome r/t Zervixkarzinom und Therapie m/d/s Blutungen, Sorge, Therapienebenwirkungen
Ressourcen	Patientin kooperativ, Psychoonkologie/Angehörige
Pflegeziel	Die Patientin ist symptomkontrolliert und in der Bewältigung unterstützt
Maßnahmen	• Perioperative/onkologische Pflege • Therapienebenwirkungen nach AO managen • Schmerz-/Symptomkontrolle, Intimsphäre wahren • Psychische Unterstützung • Edukation zu Vorsorge/HPV-Impfung
Evaluation	Symptome kontrolliert, Patientin informiert und unterstützt.

Extrauteringravidität (Eileiterschwangerschaft) OOO

Einnistung der befruchteten Eizelle außerhalb der Gebärmutterhöhle, meist im Eileiter. Notfall bei Ruptur mit Blutungsgefahr.

SYMPTOME

- Einseitige Unterbauchschmerzen
- Ausbleiben der Regel/positiver Schwangerschaftstest
- Schmierblutung
- Bei Ruptur: akute starke Schmerzen, Kreislaufschock
- Schulterschmerz bei Blutung ins Abdomen

DIAGNOSTIK

- Schwangerschaftstest/β-HCG-Verlauf
- Vaginale Sonografie
- Klinik (Schmerz, Kreislauf)
- Vitalzeichen
- Bei Rupturverdacht rasche Abklärung

THERAPIE

- Engmaschige Kontrolle/medikamentös bei frühem, stabilem Befund nach AO
- Operative Versorgung (oft laparoskopisch)
- Bei Ruptur: Notfall-OP, Volumen/Kreislauf
- Schmerztherapie
- Psychische Begleitung

Pflegeproblem	Gefahr eines hämorrhagischen Schocks r/t möglicher Tubarruptur m/d/s einseitigem Schmerz, Blutungsrisiko
Ressourcen	Frühzeitige Vorstellung, Stationäre Versorgung
Pflegeziel	Eine Ruptur/Blutung wird früh erkannt; die Patientin bleibt kreislaufstabil
Maßnahmen	• Vitalzeichen/Schmerz engmaschig, auf Schockzeichen achten • Bei Ruptur OP-Vorbereitung, i.v.-Volumen nach AO • Schmerzmanagement nach AO • Blutung beobachten, Bilanz • Psychische Begleitung
Evaluation	Kreislaufstabil, Komplikation früh erkannt, Patientin begleitet.

Adnexitis (Eileiter-/Eierstockentzündung) N70

Entzündung der Adnexe (Eileiter/Eierstöcke), meist als aufsteigende Infektion. Kann zu Komplikationen (Abszess, Unfruchtbarkeit) führen.

SYMPTOME

- Unterbauchschmerzen (oft beidseitig)
- Fieber
- Ausfluss
- Schmerzen beim Verkehr
- Allgemeines Krankheitsgefühl
- Druck-/Portioschiebeschmerz

DIAGNOSTIK

- Gynäkologische Untersuchung
- Labor (Entzündungswerte)
- Abstrich/Erregernachweis
- Sonografie (Abszess?)
- Vitalzeichen

THERAPIE

- Antibiotika nach AO
- Schmerz-/Antipyrese nach AO
- Schonung
- Bei Abszess ggf. operative Therapie
- Partnerbehandlung/Beratung

Pflegeproblem	Akuter Schmerz und Infektion r/t Adnexitis m/d/s Unterbauchschmerz, Fieber
Ressourcen	Patientin kooperativ, Frühzeitige Behandlung
Pflegeziel	Die Patientin ist schmerzarm (NRS ≤ 3) und fieberfrei; Komplikationen werden früh erkannt
Maßnahmen	• Schmerz-/Temperaturüberwachung • Antibiotika/Analgesie nach AO • Schonung, Wärme anbieten • Auf Abszess-/Peritonitiszeichen achten • Edukation zu Therapietreue/Prävention
Evaluation	Schmerz reduziert, fieberfrei, keine Komplikationen.

Descensus genitalis (Beckenbodensenkung) N81

Senkung von Gebärmutter und/oder Scheidenwänden durch Beckenbodenschwäche, teils bis zum Vorfall (Prolaps). Häufig nach Geburten und im Alter.

SYMPTOME

- Fremdkörper-/Druckgefühl nach unten
- Sicht-/tastbarer Vorfall
- Harninkontinenz oder Entleerungsstörung
- Stuhlentleerungsstörung
- Rückenschmerz/Ziehen im Unterbauch

DIAGNOSTIK

- Gynäkologische Untersuchung
- Beurteilung des Senkungsgrades
- Miktions-/Kontinenzanamnese
- Ggf. Restharnbestimmung
- Verlaufsbeurteilung

THERAPIE

- Beckenbodentraining/ Physiotherapie
- Pessartherapie nach AO
- Operative Korrektur bei Bedarf
- Hormonelle Lokaltherapie nach AO
- Beratung (Heben/Gewicht)

Pflegeproblem	Beeinträchtigtes Wohlbefinden/Kontinenz r/t Beckenbodensenkung m/d/s Druckgefühl, Inkontinenz
Ressourcen	Patientin motiviert, Physiotherapie verfügbar
Pflegeziel	Die Patientin ist beschwerdegelindert und beherrscht Beckenbodenübungen/Maßnahmen
Maßnahmen	• Beckenbodentraining anleiten • Pessarpflege unterstützen, Haut kontrollieren • Kontinenz-/Miktionsbeobachtung, Hautschutz • Perioperative Pflege bei OP • Edukation: Heben/Pressen meiden, Obstipationsprophylaxe
Evaluation	Beschwerden gelindert, Übungen/Maßnahmen umgesetzt.

Wochenbett (Puerperium) O90

Zeitraum nach der Geburt (ca. 6–8 Wochen) mit Rückbildung der Geburtsveränderungen. Pflegerischer Fokus: Rückbildung, Wochenfluss, Stillen und Komplikationsprävention.

SYMPTOME

- Uterusrückbildung (Involution)
- Wochenfluss (Lochien)
- Brustveränderungen/ Milcheinschuss
- Erschöpfung, emotionale Labilität
- Risiken: Blutung, Infektion, Thrombose, postpartale Depression

DIAGNOSTIK

- Fundusstand/Uterusrückbildung beurteilen
- Lochien (Menge/Geruch/Farbe) beobachten
- Vitalzeichen, Blutungskontrolle
- Brust/Stillen, Ausscheidung
- Stimmung/psychisches Befinden

THERAPIE

- Rückbildung fördern (Mobilisation, Rückbildungsgymnastik)
- Stillberatung/Brustpflege
- Schmerz-/Wundmanagement (Damm/Sectio) nach AO
- Thrombose-/Infektionsprophylaxe
- Bei Komplikationen ärztliche Behandlung

Pflegeproblem	Gefahr von postpartaler Blutung/Infektion r/t Wochenbett m/d/s Uterusrückbildung, Wochenfluss, Wundheilung
Ressourcen	Mutter motiviert, Unterstützung durch Partner/Familie
Pflegeziel	Die Rückbildung verläuft komplikationslos; Blutungs-/Infektionszeichen werden früh erkannt
Maßnahmen	• Fundusstand und Lochien regelmäßig beobachten und dokumentieren • Vitalzeichen, auf Infektions-/Thrombosezeichen achten • Stillberatung, Brust-/Dammpflege, Hygiene • Mobilisation und Thromboseprophylaxe • Auf psychisches Befinden achten, Anleitung/Edukation
Evaluation	Rückbildung regelrecht, keine Blutung/Infektion, Mutter angeleitet.

Spontangeburt (physiologische Geburt) O80

Regelrechte vaginale Geburt aus Schädellage am Termin (37+0 bis 41+6 SSW) ohne operative Eingriffe. Verläuft in Phasen: Eröffnungsphase, Austreibungsphase und Nachgeburtsphase.

SYMPTOME

- Regelmäßige, zunehmende Wehen
- Zeichnen (blutig-schleimiger Schleimpfropf)
- Blasensprung (Fruchtwasserabgang)
- Muttermunderöffnung 0 bis 10 cm
- Presswehen in der Austreibungsphase

DIAGNOSTIK

- CTG (Wehentätigkeit + kindliche Herztöne)
- Vaginale Untersuchung (Muttermundweite, Höhenstand)
- Leopold-Handgriffe (Lage des Kindes)
- Vitalzeichen und Temperatur der Mutter
- Fruchtwasser beurteilen (klar/grün = Mekonium)

THERAPIE

- Geburtsbegleitung durch Hebamme/Arzt
- Wehenmanagement und Positionswechsel
- Schmerzlinderung (Atmung, Bewegung, ggf. PDA)
- Dammschutz in der Austreibungsphase
- Abnabeln und frühes Bonding (Haut-zu-Haut)

Pflegeproblem	Schmerz und Erschöpfung unter der Geburt r/t Wehentätigkeit m/d/s Schmerzäußerung, Anspannung, Unruhe
Ressourcen	Gebärende ist motiviert, Begleitperson anwesend, Hebamme betreut kontinuierlich
Pflegeziel	Die Gebärende bewältigt die Geburt möglichst schmerzarm, sicher und selbstbestimmt
Maßnahmen	• Atem- und Entspannungstechniken anleiten • Positionswechsel und Bewegung ermöglichen • Kontinuierliche CTG- und Vitalzeichenüberwachung • Emotionale Begleitung und Information • Blasenentleerung fördern
Evaluation	Geburt komplikationslos, Gebärende fühlt sich sicher begleitet, Kind wohlauf.

KONTROLLFRAGEN

40 **In welcher Reihenfolge verlaufen die Geburtsphasen?**

A) Austreibung – Eröffnung – Nachgeburt
B) Eröffnungsphase – Austreibungsphase – Nachgeburtsphase
C) Nachgeburt – Eröffnung – Austreibung
D) Es gibt nur eine Phase

41 **Welches sind sichere Zeichen des Geburtsbeginns?**

A) Nur Rückenschmerzen
B) Regelmäßige, zunehmende Wehen, Blasensprung und Zeichnen
C) Übelkeit
D) Sodbrennen

42 **Warum wird unter der Geburt ein CTG geschrieben?**

A) Nur zur Dokumentation
B) Um Wehentätigkeit und kindliche Herztöne zu überwachen und eine Sauerstoffunterversorgung früh zu erkennen
C) Um den Blutdruck zu messen
D) Um das Gewicht zu bestimmen

Sectio caesarea (Kaiserschnitt) O82

Operative Entbindung durch Bauchschnitt. Primäre Sectio = geplant, sekundäre/Not-Sectio = während der Geburt bei akuter Gefahr. Häufigste geburtshilfliche Operation.

SYMPTOME

- Indikation z. B. Querlage oder Missverhältnis
- Pathologisches CTG (fetale Hypoxie)
- Placenta praevia
- Schwere Präeklampsie/HELLP
- Geburtsstillstand

DIAGNOSTIK

- CTG und Vitalzeichen
- Labor (Blutbild, Gerinnung, Blutgruppe/Kreuzblut)
- OP-Vorbereitung und Aufklärung
- Sonographie (Lage, Plazentasitz)

THERAPIE

- Sectio in Spinal-/Periduralanästhesie oder Vollnarkose
- Postoperative Überwachung
- Schmerztherapie nach Stufenschema
- Thromboseprophylaxe (erhöhtes Risiko)

Pflegeproblem	Postoperative Schmerzen und Thrombosegefahr r/t abdominaler Operation und eingeschränkter Mobilität m/d/s Wundschmerz, Bewegungseinschränkung
Ressourcen	Mutter motiviert zu Mobilisation, Analgesie angeordnet, Unterstützung durch Personal/Familie
Pflegeziel	Die Wöchnerin ist ausreichend schmerzarm, wird frühzeitig mobilisiert und entwickelt keine Thrombose
Maßnahmen	• Schmerztherapie nach Plan und vor Mobilisation/Stillen • Thromboseprophylaxe: LMWH, Kompressionsstrümpfe, frühe Mobilisation • Wunde und Verband regelmäßig kontrollieren • Fundusstand und Lochien überwachen • Beim Stillen und Bonding aktiv unterstützen
Evaluation	Schmerzarm, frühzeitig mobilisiert, keine Thrombose-/Wundkomplikation, Stillbeginn gelungen.

KONTROLLFRAGEN

43 **Was ist eine typische Indikation für eine Not-Sectio?**

(A) Wunsch nach schneller Geburt

(B) Akute Gefährdung des Kindes, z. B. pathologisches CTG mit drohender Hypoxie

(C) Leichte Wehen

(D) Erschöpfung der Mutter allein

44 **Worauf ist nach einer Sectio pflegerisch besonders zu achten?**

(A) Nur auf die Wunde

(B) Konsequente Thromboseprophylaxe – das Thromboserisiko ist nach OP und in Wochenbett deutlich erhöht

(C) Bettruhe für 2 Wochen

(D) Kein Stillen

45 **Ist Stillen nach einem Kaiserschnitt möglich?**

(A) Nein, grundsätzlich nicht

(B) Ja – es ist möglich, oft aber anfangs erschwert und braucht aktive Unterstützung

(C) Nur mit Medikamenten

(D) Nur nach 6 Wochen

Neugeborenenversorgung (Erstversorgung, APGAR) Z38

Erstversorgung und Überwachung des Neugeborenen nach der Geburt: postnatale Adaptation, Wärmeerhalt, APGAR-Beurteilung, Prophylaxen sowie U1/U2 und Neugeborenen-Screening.

SYMPTOME

- Postnatale Adaptation (erster Atemzug, Kreislaufumstellung)
- APGAR bei 1/5/10 Minuten
- Physiologische Neugeborenengelbsucht möglich
- Wärmeempfindlichkeit (Hypothermiegefahr)

DIAGNOSTIK

- APGAR-Score (Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen, Reflexe) bei 1/5/10 min
- U1 direkt nach Geburt, U2 am 3.–10. Lebenstag
- Neugeborenen-Screening (Fersenblut)
- Pulsoxymetrie-Screening
- Gewicht, Länge, Kopfumfang

THERAPIE

- Wärmeerhalt (Haut-zu-Haut, Wärmelampe, Mütze)
- Abtrocknen, ggf. Absaugen
- Vitamin-K-Prophylaxe
- Augenprophylaxe nach Bedarf
- Frühes Anlegen und Bonding

Pflegeproblem	Gefahr der Hypothermie und gestörten Adaptation r/t unreifer Thermoregulation m/d/s großer Körperoberfläche und Nässe nach Geburt
Ressourcen	Mutter für Haut-zu-Haut bereit, Wärmelampe/Erstversorgungsplatz vorhanden
Pflegeziel	Das Neugeborene hält eine stabile Körpertemperatur und adaptiert komplikationslos
Maßnahmen	• Sofort abtrocknen und Wärme erhalten (Haut-zu-Haut, Wärmelampe, Mütze) • APGAR und Vitalzeichen erheben • Atmung, Hautfarbe und Temperatur überwachen • Bonding und erstes Anlegen fördern • Prophylaxen und Screening durchführen
Evaluation	Temperatur stabil, Adaptation regelrecht, APGAR gut, Bonding gelungen.

KONTROLLFRAGEN

46 **Wofür stehen die Buchstaben im APGAR-Score?**

A) Alter, Puls, Gewicht, Atmung, Reflexe

B) Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen (Hautfarbe), Reflexe

C) Aussehen, Puls, Größe, Atmung, Reaktion

D) Atmung, Position, Gewicht, Alter, Reflexe

47 **Warum ist der Wärmeerhalt beim Neugeborenen so wichtig?**

A) Aus Komfortgründen

B) Neugeborene kühlen wegen großer Körperoberfläche und unreifer Thermoregulation schnell aus (Hypothermiegefahr)

C) Damit sie schlafen

D) Nur bei Frühgeborenen relevant

48 **Wann wird die U1 durchgeführt?**

A) Am 10. Lebenstag

B) Direkt nach der Geburt

C) Nach 6 Wochen

D) Erst bei Auffälligkeiten

Stillen und Laktation Z39.1

Ernährung des Säuglings mit Muttermilch. Die Laktation wird durch Prolaktin (Milchbildung) und Oxytocin (Milchflussreflex) gesteuert. Milchreifung von Kolostrum über Übergangs- zu reifer Milch.

SYMPTOME

- Milcheinschuss um den 2.–4. Tag
- Let-down-Reflex (Milchspendereflex)
- Mögliche wunde Mamillen
- Möglicher Milchstau
- Mögliche Mastitis (Brustentzündung)

DIAGNOSTIK

- Anlege- und Stillposition beurteilen
- Trinkverhalten und Gewichtsverlauf des Kindes
- Brust auf Rötung/Stau/Überwärmung prüfen
- Ausscheidung des Kindes (nasse Windeln)

THERAPIE

- Korrekte Anlegetechnik anleiten
- Häufiges Anlegen nach Bedarf
- Verschiedene Stillpositionen zeigen
- Milchstau: entleeren, wärmen vor/kühlen nach dem Stillen
- Mastitis: weiterstillen/entleeren, ggf. Antibiose

Pflegeproblem	Stillschwierigkeiten und wunde Mamillen r/t fehlerhafter Anlegetechnik m/d/s Schmerz beim Anlegen, Unsicherheit der Mutter
Ressourcen	Mutter motiviert zu stillen, Stillberatung verfügbar, Kind trinkt grundsätzlich
Pflegeziel	Die Mutter legt schmerzfrei korrekt an und stillt sicher und selbstständig
Maßnahmen	• Anlegetechnik anleiten (Kind erfasst Warzenhof, nicht nur Mamille) • Verschiedene Stillpositionen zeigen • Mamillenpflege beraten • Zu häufigem Anlegen ermutigen • Milchstau/Mastitis vorbeugen und Zeichen erklären
Evaluation	Anlegen schmerzfrei, Mamillen intakt, Mutter stillt sicher, Kind nimmt zu.

KONTROLLFRAGEN

49 **Welche Hormone steuern die Laktation?**

A) Insulin und Adrenalin
B) Prolaktin (Milchbildung) und Oxytocin (Milchflussreflex)
C) Östrogen und Testosteron
D) Cortisol und Thyroxin

50 **Wie geht man bei einer beginnenden Mastitis in der Regel vor?**

A) Sofort abstillen
B) In der Regel weiterstillen/entleeren, kühlen und schonen – bei Bedarf Antibiose
C) Nur kühlen und nicht mehr anlegen
D) Nichts tun

51 **Was ist ein Zeichen für eine korrekte Anlegetechnik?**

A) Das Kind erfasst nur die Brustwarze
B) Das Kind erfasst Mamille und großen Teil des Warzenhofs, Lippen sind nach außen gestülpt
C) Die Mutter hat starke Schmerzen
D) Das Kind saugt nur kurz an

Gestationsdiabetes (GDM) O24.4

Erstmals in der Schwangerschaft auftretende Glukosetoleranzstörung. Häufigste Schwangerschaftskomplikation. Risiken: kindliche Makrosomie, Geburtskomplikationen, neonatale Hypoglykämie, späteres Diabetesrisiko der Mutter.

SYMPTOME

- Meist symptomarm – Screening entscheidend
- Mögliche Makrosomie (großes Kind)
- Mögliches Polyhydramnion (viel Fruchtwasser)
- Nach Geburt: Hypoglykämiegefahr des Kindes

DIAGNOSTIK

- Oraler Glukosetoleranztest (oGTT) in der 24.–28. SSW
- Blutzucker-Tagesprofil
- HbA1c ergänzend
- Sonographie (kindliches Wachstum, Fruchtwassermenge)

THERAPIE

- Basis: Ernährungsumstellung und Bewegung
- Blutzucker-Selbstkontrolle
- Bei unzureichender Einstellung: Insulin (keine oralen Antidiabetika in der Schwangerschaft)
- Engmaschige Betreuung

Pflegeproblem	Erhöhtes Blutzuckerniveau r/t Gestationsdiabetes m/d/s pathologischem oGTT
Ressourcen	Schwangere motiviert, Ernährungsberatung verfügbar, BZ-Messgerät vorhanden
Pflegeziel	Die Blutzuckerwerte liegen im Zielbereich, die Schwangerschaft verläuft komplikationslos
Maßnahmen	• Blutzucker-Selbstmessung anleiten und dokumentieren lassen • Ernährungsumstellung und Bewegung unterstützen • Ggf. Insulingabe schulen und überwachen • Auf Zielwerte und Warnzeichen achten • Nach Geburt: Neugeborenes auf Hypoglykämie kontrollieren
Evaluation	BZ-Werte im Zielbereich, keine Komplikationen, Kind ohne Hypoglykämie.

KONTROLLFRAGEN

52 **Wann wird das Screening auf Gestationsdiabetes (oGTT) durchgeführt?**

- A) In der 6. SSW
- B) In der 24. bis 28. SSW
- C) Erst nach der Geburt
- D) Im ersten Trimenon immer

53 **Welche medikamentöse Therapie ist bei GDM zulässig, wenn Ernährung nicht ausreicht?**

- A) Orale Antidiabetika (Tabletten)
- B) Insulin – orale Antidiabetika sind in der Schwangerschaft nicht Mittel der Wahl
- C) Gar keine
- D) Cortison

54 **Worauf muss das Neugeborene einer Mutter mit GDM nach der Geburt überwacht werden?**

- A) Auf Fieber
- B) Auf Hypoglykämie (Unterzucker)
- C) Auf Bluthochdruck
- D) Auf Übergewicht sofort

HELLP-Syndrom O14.2

Schwere Verlaufsform der Präeklampsie. HELLP steht für Hemolysis (Hämolyse), Elevated Liver enzymes (erhöhte Leberwerte) und Low Platelets (Thrombozytopenie). Lebensbedrohlich für Mutter und Kind.

SYMPTOME

- Rechtsseitiger Oberbauchschmerz (Leberkapselspannung)
- Übelkeit und Erbrechen
- Kopfschmerzen, Sehstörungen
- Hypertonie und Ödeme
- Gefahr von Eklampsie, Leberruptur, Gerinnungsstörung (DIC)

DIAGNOSTIK

- Labor: Hämolysezeichen (LDH erhöht), Transaminasen erhöht, Thrombozyten erniedrigt
- Blutdruckmessung
- Proteinurie (Urin)
- Gerinnungsstatus
- CTG (kindliches Befinden)

THERAPIE

- Einzige kausale Therapie: Entbindung
- Blutdrucksenkung
- Magnesium zur Krampfprophylaxe
- Kortison zur Lungenreife des Kindes
- Intensivüberwachung

Pflegeproblem	Lebensbedrohliche Komplikationsgefahr (Eklampsie, Leberruptur) r/t HELLP-Syndrom m/d/s Oberbauchschmerz, Hypertonie, pathologischem Labor
Ressourcen	Klinik/Personal vorbereitet, Intensiv-/OP-Bereitschaft vorhanden
Pflegeziel	Komplikationen werden früh erkannt, Mutter und Kind bleiben stabil bis zur Entbindung
Maßnahmen	• Engmaschige Überwachung von RR, Neurologie, Reflexen und Oberbauchschmerz • Reizarme Umgebung zur Eklampsie-Prophylaxe • Magnesiumtherapie überwachen (Reflexe, Atemfrequenz, Urinausscheidung) • Ein-/Ausfuhr bilanzieren, Labor kontrollieren • Notfall- und OP-Bereitschaft sicherstellen
Evaluation	Keine Eklampsie/Blutung, Werte stabilisiert, rechtzeitige Entbindung.

KONTROLLFRAGEN

55 **Wofür steht die Abkürzung HELLP?**

(A) High Energy Low Level Pressure

(B) Hämolyse, erhöhte Leberwerte (Elevated Liver enzymes), erniedrigte Thrombozyten (Low Platelets)

(C) Herz-, Leber- und Lungen-Problem

(D) Hypertonie, Ejektion, Laktat, Leukozyten, Puls

56 **Welches ist ein typisches Leitsymptom des HELLP-Syndroms?**

(A) Schmerzen im linken Bein

(B) Rechtsseitiger Oberbauchschmerz (Leberkapselspannung)

(C) Halsschmerzen

(D) Ohrenschmerzen

57 **Was ist die einzige kausale Therapie des HELLP-Syndroms?**

(A) Bettruhe

(B) Die Entbindung

(C) Antibiotika

(D) Abwarten bis zum Termin

Frühgeburt / vorzeitige Wehen O60

Geburt vor abgeschlossener 37. Schwangerschaftswoche (37+0 SSW). Vorzeitige Wehen sind muttermundwirksame Wehen vor diesem Zeitpunkt. Häufigste Ursache perinataler Morbidität und Mortalität.

SYMPTOME

- Vorzeitige, regelmäßige Wehen
- Vorzeitiger Blasensprung
- Muttermundverkürzung und -eröffnung
- Ggf. vaginale Blutung
- Druckgefühl nach unten

DIAGNOSTIK

- CTG (Wehentätigkeit)
- Vaginale Untersuchung und Zervixlängenmessung (Sonographie)
- Fibronektin-Test
- Infektionsparameter (Labor, Abstrich)
- Fruchtwasser-/Blasensprungnachweis

THERAPIE

- Tokolyse (Wehenhemmung, z. B. Atosiban/Fenoterol)
- Lungenreifeinduktion mit Kortison (Betamethason)
- Magnesium zur Neuroprotektion des Kindes
- Antibiotika bei Infektion
- Verlegung in ein Perinatalzentrum

Pflegeproblem	Gefahr der Frühgeburt r/t vorzeitiger Wehentätigkeit m/d/s regelmäßiger Wehen, Zervixverkürzung
Ressourcen	Schwangere kooperativ, Tokolyse verfügbar, Perinatalzentrum erreichbar
Pflegeziel	Die Schwangerschaft wird möglichst prolongiert, die Lungenreife des Kindes abgeschlossen
Maßnahmen	• CTG- und Wehenüberwachung • Tokolyse nach Anordnung, Nebenwirkungen kontrollieren • Lungenreifegabe sicherstellen • Körperliche Schonung ermöglichen, Infektzeichen beobachten • Psychische Begleitung, Verlegung/Frühgeborenenversorgung vorbereiten
Evaluation	Wehen sistieren/reduziert, Lungenreife abgeschlossen, Kind bestmöglich versorgt.

KONTROLLFRAGEN

58 **Ab wann spricht man von einer Frühgeburt?**

A) Geburt vor der 40. SSW
B) Geburt vor abgeschlossener 37. SSW (vor 37+0)
C) Geburt nach der 42. SSW
D) Jede Geburt per Sectio

59 **Warum wird bei drohender Frühgeburt Kortison gegeben?**

A) Zur Wehenhemmung
B) Zur Lungenreifeinduktion des Kindes (Surfactant-Bildung)
C) Gegen Schmerzen
D) Zur Blutdrucksenkung

60 **Was ist das Ziel einer Tokolyse?**

A) Die Wehen zu verstärken
B) Die Wehentätigkeit zu hemmen und die Geburt hinauszuzögern
C) Den Blutdruck zu senken
D) Die Geburt einzuleiten

Urologie

10 Krankheitsbilder

Harnwegsinfekt (HWI) N39.0

Häufigste bakterielle Infektion. Unkompliziert: Zystitis (Blase). Kompliziert: Pyelonephritis (Niere), katheterassoziiert (CAUTI). Häufigster Erreger: E. coli (80%). Frauen 10× häufiger betroffen.

SYMPTOME

- Dysurie (Brennen beim Wasserlassen)
- Pollakisurie (häufiger Harndrang)
- Hämaturie
- Übelriechender/trüber Urin
- Unterbauchschmerzen/-druck
- Bei Pyelonephritis: Fieber, Flanken-/Klopfschmerz
- Verwirrtheit (bei alten Menschen oft einziges Zeichen!)

DIAGNOSTIK

- Urinstreifentest (Nitrit, Leukozyten)
- Urinstatus + Kultur (Mittelstrahlurin!)
- Blutbild, CRP
- Sonographie Nieren bei Pyelonephritis
- Blutkultur bei Sepsisverdacht

THERAPIE

- Unkompliziert: Nitrofurantoin, Fosfomycin, Trimethoprim
- Pyelonephritis: Fluorochinolone, Cephalosporine i.v.
- Katheter-HWI: Antibiose + Katheterwechsel
- Viel trinken (2-3L/Tag)
- Wärme (Wärmflasche Unterbauch)

Pflegeproblem	Risiko katheterassoziierter Harnwegsinfektion r/t liegendem DK m/d/s Immunsuppression
Ressourcen	Kooperativer Patient, Pflegepersonal geschult
Pflegeziel	Patient entwickelt keine Katheterinfektion (kein Fieber, kein Urin-Befund) über Liegedauer
Maßnahmen	• Tägliche Indikationsprüfung: DK wirklich nötig? → frühzeitig entfernen! • Sterile Anlage, geschlossenes System immer erhalten • Intimhygiene 2x täglich mit Wasser (kein Desinfektionsmittel!) • Beutel immer unter Blasenniveau, niemals auf Boden • Kein Abklemmen des Katheters • Auf Katheterstau/Knick achten • Flüssigkeitszufuhr 1,5-2L/Tag sichern • Täglich: Urin beurteilen (Trübung, Geruch, Farbe)
Evaluation	Täglich Urinbeschaffenheit, Temperatur, Befinden

KONTROLLFRAGEN

61 **Wie nimmt man einen Mittelstrahl-Urin korrekt ab?**

(A) Einfach laufen lassen

(B) Ersten Harnstrahl verwerfen, Mittelstrahl in steriles Gefäß auffangen, letzten Strahl verwerfen

(C) Katheter nötig

(D) Alles auffangen

62 **Warum ist die tägliche Indikationsprüfung des Dauerkatheters so wichtig?**

(A) Nur zur Dokumentation

(B) Jeder Kathetertag erhöht CAUTI-Risiko um 3-7% – frühzeitiger Entfernung = wichtigste Prophylaxe!

(C) Wegen Kosten

(D) Nur bei Frauen

63 **Welches Zeichen eines HWI ist bei alten Menschen oft das einzige Symptom?**

A Brennen beim Wasserlassen

B Verwirrtheit/Delir – klassische Symptome können fehlen!

C Fieber

D Hämaturie

Benignes Prostataadenom (BPH) N40

Gutartige Vergrößerung der Prostata. Betrifft 50% der Männer >50J, 90% der >80-Jährigen. Führt zu Blasenausflussobstruktion mit LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms). Kein Krebsrisiko per se.

SYMPTOME

- Abschwächung des Harnstrahls
- Harnstottern (intermittierender Strahl)
- Restharngefühl
- Nykturie (nächtliches Wasserlassen)
- Pollakisurie
- Harndrang
- Harnverhalt (akut)

DIAGNOSTIK

- IPSS-Score (International Prostate Symptom Score)
- PSA-Wert
- Sonographie (Prostatavolumen, Restharn)
- Urodynamik
- Uroflowmetrie
- Rektale Untersuchung

THERAPIE

- Medikamentös: Alpha-1-Blocker (Tamsulosin), 5-Alpha-Reduktasehemmer
- Operative Entfernung: TURP (transurethrale Resektion)
- Laser-Verfahren
- Notfall Harnverhalt: transurethraler Katheter

Pflegeproblem	Akuter Harnverhalt r/t BPH m/d/s Restharn 600ml, starker Harndrang, Unterbauchschmerzen
Ressourcen	Kooperativer Patient, Schmerzmittel vorhanden
Pflegeziel	Blasenentlastung durch Katheteranlage innerhalb 30 Min., Schmerzfreiheit
Maßnahmen	• Transurethralen Katheter nach ärztl. Anordnung anlegen (aseptisch!) • Urin langsam ablassen: nicht mehr als 500ml auf einmal (Hypotension, Hämaturie vermeiden) • Urinmenge, -farbe, -geruch dokumentieren • Schmerzerfassung (NRS) vor und nach Katheteranlage • Wärme auf Unterbauch (prä-/periinterventionell) • Aufklärung über TURP wenn geplant • Sturzprophylaxe: Drang → Stürze bei Eile
Evaluation	Restharnkontrolle nach Miktion (Sonographie), Schmerz-NRS

KONTROLLFRAGEN

64 **Was ist TURP?**

A Eine Medikamentengruppe

B Transurethrale Resektion der Prostata: endoskopische Abtragung des Prostatagewebes über die Harnröhre

C Eine Prostata-Biopsie

D Ein Bluttest

65 **Warum darf man bei akutem Harnverhalt nicht sofort die gesamte Urinmenge ablassen?**

A Kein Grund

B Dekompressionsbedingte Hämaturie und Blutdruckabfall (Dekompressionsschock) möglich – max. 500ml auf einmal!

C Wegen Infektionsrisiko

D Nur bei Frauen relevant

66 **Was ist der IPSS?**

A Ein Bluttest

B International Prostate Symptom Score: Fragebogen zur Einschätzung des Schweregrades der Miktionsbeschwerden

C Ein Ultraschallwert

D Ein Krebsmarker

Urolithiasis / Nierenkolik (Harnsteine) N20

Steine in Niere/Harnleiter, die bei Abgang heftige kolikartige Schmerzen verursachen können. Gefahr von Harnstau und Infektion.

SYMPTOME

- Heftige, kolikartige Flankenschmerzen
- Ausstrahlung in Unterbauch/Leiste
- Übelkeit/Erbrechen
- Hämaturie (Blut im Urin)
- Harndrang, Unruhe
- Bei Infekt/Stau: Fieber

DIAGNOSTIK

- Klinik (Kolik), Urinstatus (Hämaturie)
- Sonografie/CT
- Labor (Entzündung, Nierenwerte)
- Vitalzeichen
- Auf Harnstau/Infekt achten

THERAPIE

- Analgesie/Spasmolyse nach AO
- Ausreichend Flüssigkeit, Bewegung
- Steinabgang fördern; ggf. Steinzertrümmerung (ESWL)/ endoskopische Entfernung
- Bei Harnstau/Infekt rasche Entlastung nach AO
- Metaphylaxe/Beratung

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t Nierenkolik m/d/s heftigem Flankenschmerz, Übelkeit
Ressourcen	Patient kooperativ, Behandlung verfügbar
Pflegeziel	Der Patient ist rasch schmerzgelindert (NRS ≤ 3); Komplikationen werden früh erkannt
Maßnahmen	• Analgesie/Spasmolyse nach AO, Wirkung kontrollieren • Flüssigkeit fördern, Urin beobachten/sieben, Bilanz • Auf Fieber/Harnstau achten • Bewegung unterstützen • Edukation zu Trinkmenge/Steinprophylaxe
Evaluation	Schmerz gelindert, kein Harnstau/Infekt, Steinabgang/Behandlung erfolgt.

Prostatakarzinom C61

Häufigster bösartiger Tumor des Mannes, oft langsam wachsend. Früh meist symptomlos; Vorsorge und individuelle Therapieentscheidung sind zentral.

SYMPTOME

- Frühstadium meist symptomlos
- Miktionsbeschwerden (spät)
- Hämaturie/Hämatospermie (selten)
- Bei Metastasen: Knochenschmerzen
- Leistungsminderung

DIAGNOSTIK

- Tastuntersuchung (DRU), PSA-Wert nach AO
- Biopsie (Sicherung)
- Bildgebung/Staging
- Verlaufskontrolle

THERAPIE

- Aktive Überwachung bei Niedrigrisiko
- Operation (Prostatektomie) oder Strahlentherapie
- Hormon-/Systemtherapie nach AO
- Symptom-/Schmerzkontrolle
- Psychoonkologische Begleitung

Pflegeproblem	Belastung und mögliche Inkontinenz r/t Prostatakarzinom/Therapie m/d/s Miktionsbeschwerden, Sorge
Ressourcen	Patient kooperativ, Angehörige/Psychoonkologie
Pflegeziel	Der Patient ist symptomkontrolliert und in Bewältigung/Kontinenz unterstützt
Maßnahmen	• Perioperative/onkologische Pflege • Kontinenz-/Beckenbodentraining, Katheterpflege • Therapienebenwirkungen nach AO managen • Schmerz-/Symptomkontrolle • Psychische Unterstützung, Edukation
Evaluation	Symptome kontrolliert, Kontinenz verbessert, Patient unterstützt.

Harninkontinenz N39.3

Unwillkürlicher Harnverlust verschiedener Formen (z. B. Belastungs-, Drang-, Misch-, Überlaufinkontinenz). Häufig, mit hoher Belastung der Lebensqualität.

SYMPTOME

- Unwillkürlicher Urinverlust (bei Belastung/Drang)
- Häufiger/imperativer Harndrang
- Nächtliches Wasserlassen
- Hautprobleme im Intimbereich
- Sozialer Rückzug/Scham

DIAGNOSTIK

- Miktions-/Inkontinenztagebuch
- Anamnese (Form/Auslöser)
- Restharnbestimmung
- Urinstatus (Infekt ausschließen)
- Ärztliche Abklärung

THERAPIE

- Form-spezifisch: Beckenbodentraining, Blasentraining
- Medikamente nach AO
- Hilfsmittelversorgung
- Operative Optionen bei Bedarf
- Gewichts-/Lebensstilberatung

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Ausscheidung und Hautgefahr r/t Harninkontinenz m/d/s unwillkürlichem Urinverlust
Ressourcen	Patient/in motiviert, Hilfsmittel verfügbar
Pflegeziel	Die Kontinenzsituation verbessert sich; die Haut bleibt intakt und die Würde gewahrt
Maßnahmen	• Form/Auslöser erfassen, Toilettentraining/-rhythmus • Beckenboden-/Blasentraining anleiten • Hautschutz, geeignete Hilfsmittel • Intimsphäre/Würde wahren • Edukation, Flüssigkeits-/Toilettenmanagement
Evaluation	Weniger Urinverlust, Haut intakt, Lebensqualität verbessert.

Harnblasenkarzinom C67

Bösartiger Tumor der Harnblase, Risikofaktor v. a. Rauchen. Leitsymptom ist oft die schmerzlose Hämaturie.

SYMPTOME

- Schmerzlose Hämaturie (Blut im Urin)
- Häufiger Harndrang
- Schmerzen/Brennen beim Wasserlassen (später)
- Bei Fortschreiten: Beschwerden/ Stau
- Leistungsminderung

DIAGNOSTIK

- Urinstatus/-zytologie
- Zystoskopie (Sicherung)
- Bildgebung/Staging
- Labor
- Verlaufskontrolle

THERAPIE

- Transurethrale Resektion (TUR-B)
- Lokale Instillationstherapie nach AO
- Bei Fortschreiten: radikale Therapie/Zystektomie (ggf. Harnableitung)
- Chemo-/Systemtherapie nach AO
- Nachsorge

Pflegeproblem	Belastung und Ausscheidungsveränderung r/t Blasenkarzinom/Therapie m/d/s Hämaturie, ggf. Harnableitung
Ressourcen	Patient kooperativ, Angehörige/Stomatherapie
Pflegeziel	Der Patient ist symptomkontrolliert und versorgt seine Ausscheidung/Harnableitung zunehmend selbstständig
Maßnahmen	• Perioperative/onkologische Pflege, Spülung/Katheter nach AO • Urin/Hämaturie beobachten, Bilanz • Bei Harnableitung Versorgung/Anleitung, Hautschutz • Therapienebenwirkungen nach AO managen • Psychische Unterstützung, Edukation (Rauchstopp)
Evaluation	Symptome kontrolliert, Versorgung sicher, zunehmende Selbstständigkeit.

Akuter Harnverhalt R33

Plötzliche Unfähigkeit, die volle Blase zu entleeren – ein schmerzhafter Notfall, häufig bei BPH, postoperativ oder medikamentös bedingt.

SYMPTOME

- Starker Harndrang ohne Entleerung
- Schmerzen/Druck im Unterbauch
- Tastbare, prall gefüllte Blase
- Unruhe
- Überlaufinkontinenz (tröpfelnd) möglich

DIAGNOSTIK

- Klinik (prall gefüllte Blase)
- Sonografie/Restharnbestimmung
- Ursachensuche (BPH, Medikamente, postoperativ)
- Vitalzeichen

THERAPIE

- Sofortige Entlastung durch Katheterisierung nach AO (langsam ablassen)
- Ursache behandeln (z. B. BPH, Medikamente)
- Schmerztherapie
- Bilanz/Beobachtung nach Entlastung
- Beratung

Pflegeproblem	Akuter Schmerz und Harnverhalt r/t Blasenentleerungsstörung m/d/s prall gefüllter Blase, Unterbauchschmerz
Ressourcen	Stationäre Versorgung, Patient kooperativ
Pflegeziel	Die Blase wird sicher entlastet; der Patient ist schmerzfrei und kreislaufstabil
Maßnahmen	• Katheterisierung nach AO, Urin langsam ablassen, Menge dokumentieren • Schmerz-/Vitalzeichenüberwachung • Nach Entlastung Bilanz und Kreislauf beobachten • Katheterpflege/Hygiene • Ursache klären, Edukation
Evaluation	Blase entlastet, schmerzfrei, kreislaufstabil.

Pyelonephritis (Nierenbeckenentzündung) N10

Bakterielle Entzündung von Nierenbecken und Nierengewebe, meist aufsteigend. Fieberhafte, ernste Form des Harnwegsinfekts.

SYMPTOME

- Hohes Fieber, Schüttelfrost
- Flankenschmerz/Klopfschmerz der Nierenlager
- Dysurie/Pollakisurie
- Übelkeit/Erbrechen
- Allgemeines Krankheitsgefühl

DIAGNOSTIK

- Urinstatus/-kultur
- Labor (Entzündungswerte)
- Sonografie (Stau/Abszess)
- Vitalzeichen
- Auf Komplikationen (Urosepsis) achten

THERAPIE

- Antibiotika nach AO
- Ausreichend Flüssigkeit
- Antipyrese/Analgesie nach AO
- Bei Harnstau Entlastung nach AO
- Stationär bei schwerem Verlauf

Pflegeproblem	Erhöhte Körpertemperatur und Infektion r/t Pyelonephritis m/d/s Fieber, Flankenschmerz
Ressourcen	Patient kooperativ, Frühzeitige Behandlung
Pflegeziel	Der Patient ist innerhalb weniger Tage fieberfrei und schmerzgelindert; eine Urosepsis wird früh erkannt
Maßnahmen	• Temperatur-/Vitalzeichen-/Schmerzüberwachung • Antibiotika zeitgerecht nach AO • Flüssigkeit fördern, Bilanz, Urin beobachten • Auf Urosepsiszeichen achten • Edukation zu Therapietreue/Prävention
Evaluation	Fieber rückläufig, schmerzgelindert, keine Urosepsis.

Hodentorsion N44

Verdrehung des Hodens mit Unterbrechung der Durchblutung – ein urologischer Notfall. Ohne rasche Behandlung droht der Verlust des Hodens.

SYMPTOME

- Plötzlicher, heftiger Hodenschmerz
- Schwellung/Rötung des Hodens
- Übelkeit/Erbrechen
- Hochstand/Querlage des Hodens
- Schmerz oft ohne Linderung bei Anheben

DIAGNOSTIK

- Klinik (akuter Hodenschmerz)
- Dopplersonografie (Durchblutung)
- Rasche urologische Abklärung
- Vitalzeichen
- Zeit ist entscheidend!

THERAPIE

- Sofortige operative Freilegung/ Detorsion (Notfall!)
- Schmerztherapie nach AO
- Nüchtern, OP-Vorbereitung
- Rasche Klinik-/Facharztvorstellung
- Beobachtung

Pflegeproblem	Akuter Schmerz und Organgefahr r/t Hodentorsion m/d/s heftigem Hodenschmerz, Durchblutungsstörung
Ressourcen	Rasche Versorgung möglich, Patient kooperativ
Pflegeziel	Die Durchblutung wird rasch wiederhergestellt; der Patient ist schmerzgelindert
Maßnahmen	• Als Notfall behandeln: sofortige OP-Vorbereitung, nüchtern • Schmerzmanagement nach AO, Vitalzeichen • Patienten beruhigen, Dringlichkeit kommunizieren • Postoperative Pflege • Psychische Unterstützung/Edukation
Evaluation	Rasch operiert, Hoden erhalten, schmerzgelindert.

Transurethraler Dauerkatheter (DK) – Pflege Z46.6

Liegender Blasenkatheter zur Harnableitung. Pflegerischer Schwerpunkt: Hygiene, Infektionsprävention (CAUTI) und sichere Handhabung; die Indikation ist regelmäßig zu prüfen.

SYMPTOME

- Liegender transurethraler Katheter mit Ableitungssystem
- Risiko: katheterassoziierter Harnwegsinfekt (CAUTI)
- Mögliche Probleme: Verstopfung, Leckage, Diskonnektion
- Blasenkrämpfe/Druckgefühl
- Hautreizung/Verletzung im Genitalbereich

DIAGNOSTIK

- Urin (Menge/Farbe/Beimengungen) beobachten, Bilanz
- Auf Infektzeichen achten (trüber/ riechender Urin, Fieber)
- Durchgängigkeit/Lage des Systems prüfen
- Indikation regelmäßig überprüfen

THERAPIE

- Aseptische Anlage und geschlossenes System
- Katheter nur so lange wie nötig (Indikation prüfen)
- Bei Infekt/Komplikation Behandlung nach AO
- Ausreichend Flüssigkeit
- Frühzeitige Entfernung anstreben

Pflegeproblem	Infektionsgefahr r/t liegendem Blasenkatheter m/d/s Fremdkörper in den Harnwegen, CAUTI-Risiko
Ressourcen	Patient kooperativ, Funktionierendes System
Pflegeziel	Der Patient entwickelt keinen katheterassoziierten Harnwegsinfekt; die Ableitung funktioniert sicher
Maßnahmen	• Geschlossenes System, Beutel unter Blasenniveau, kein Abknicken • Tägliche Katheter-/Meatuspflege, konsequente Händehygiene • Urin/Bilanz beobachten, auf Infektzeichen achten • Ausreichend Flüssigkeit fördern • Indikation täglich prüfen, frühe Entfernung anstreben
Evaluation	Kein CAUTI, Ableitung sicher, Katheter so kurz wie möglich.

Neurologie

10 Krankheitsbilder

Schlaganfall (Apoplex) I63 / I61

Plötzliche fokale Hirnschädigung durch Ischämie (85%, I63) oder Blutung (15%, I61). Time is Brain: jede Minute = 1,9 Mio. Neuronenverluste. Thrombolyse-Fenster: 4,5h (ischämisch).

SYMPTOME

- Plötzliche einseitige Lähmung (Hemiparese/-plegie)
- Gesichtslähmung (faziale Parese)
- Sprach-/Sprechstörung (Aphasie/ Dysarthrie)
- Schluckstörung (Dysphagie)
- Sehstörungen (Hemianopsie)
- Schwindel, Gangstörung
- Starke Kopfschmerzen (bei Blutung)
- Bewusstlosigkeit

DIAGNOSTIK

- FAST-Test (Prehospital)
- CT Schädel sofort (Blutung ausschließen!)
- MRT Schädel (diffusionsgewichtet)
- CT-/MR-Angiographie
- EKG (Vorhofflimmern?)
- Labor: Gerinnung, BZ

THERAPIE

- Stroke Unit!
- Ischämisch: Lyse rtPA i.v. (bis 4,5h) oder Thrombektomie (bis 24h)
- Blutung: neurochirurgisch ggf.
- Sekundärprophylaxe: ASS, Antikoagulation
- Frührehabilitation: Physio, Ergo, Logo ab Tag 1
- Dysphagie-Screening vor erstem Schluck!

Pflegeproblem	Risiko Aspiration r/t Schluckstörung (Dysphagie) nach Schlaganfall m/d/s positives Dysphagie-Screening
Ressourcen	Patient kooperiert trotz Aphasie, Logopädie verfügbar
Pflegeziel	Patient aspiriert nicht – sichere Nahrungsaufnahme durch angepasste Konsistenz nach logopädischer Freigabe
Maßnahmen	• Vor ERSTEM Schluck: standardisiertes Dysphagie-Screening (z.B. 3-Unzen-Wassertest) • Bis Screening-Ergebnis: NICHTS per oral, Mund feucht halten • Nach Logo-Freigabe: angepasste Kost (Andickungsmittel, weiche Kost) • Beim Essen: aufrechte Position 90°, betroffene Seite unterstützen • Essen nie überstürzen, genug Zeit lassen • Absauggerät bereithalten • Nach Essen 30 Min. aufrecht bleiben • Angehörige in sicheres Füttern schulen
Evaluation	Täglich Schluckfähigkeit beobachten, Aspirationszeichen (Husten, Stimmveränderung)

Pflegeproblem	Beeinträchtigte körperliche Mobilität r/t Hemiparese links m/d/s Patient kann linken Arm/Bein nicht heben
Ressourcen	Hohe Motivation, Vorhandenes Pflegebett mit Hilfsmitteln
Pflegeziel	Patient dreht sich mit geringer Hilfe auf betroffene Seite nach 3 Tagen Frührehabilitation
Maßnahmen	• Bobath-Lagerung: betroffene Seite einbeziehen, nicht kompensieren • Stundenlageplan: alle 2h Umlagerung • Patient von betroffener Seite ansprechen (Förderung Aufmerksamkeit zur Seite) • Frührehabilitation: Physiotherapie ab Tag 1 nach Anordnung • Transfertraining (Bett → Stuhl) mit PT • Hilfsmittel: Rollator, Handschiene nach Ergotherapie • Antispastik-Lagerung beachten (Armschiene)
Evaluation	Täglich Motorik, Tonus, Lagerungstoleranz

KONTROLLFRAGEN

67 **Was bedeutet FAST beim Schlaganfall?**

A) Ein Medikament

B) F=Face, A=Arms, S=Speech, T=Time – Schlaganfall-Schnelltest, sofort 112!

C) Ein Bildgebungsverfahren

D) Eine Lagerungstechnik

68 **Warum muss vor dem ersten Schluck ein Dysphagie-Screening erfolgen?**

A) Nur Routine

B) Stille Aspiration möglich: Patient schluckt und hustet nicht – Pneumonie- und Asphyxie-Risiko!

C) Nur bei Bewusstlosen

D) Nur bei Beatmeten

69 **Was ist das Bobath-Konzept bei der Schlaganfallpflege?**

A) Bettruhe

B) Betroffene Körperseite aktiv einbeziehen, nicht kompensieren – fördert Neuroplastizität und verhindert Vernachlässigung

C) Nur für Physiotherapeuten

D) Schmerztherapiekonzept

Epilepsie G40

Chronische Erkrankung mit rezidivierenden epileptischen Anfällen durch unkontrollierte synchrone Entladungen von Neuronenverbänden. Prävalenz: 0,5-1%. Fokal oder generalisiert. Status epilepticus: Anfall > 5 Min. = Notfall.

SYMPTOME

- Tonisch-klonischer Anfall (grand mal)
- Absence (kurze Bewusstseinsunterbrechung)
- Aura (subjektive Vorboten)
- Myoklonien
- Postiktale Phase: Verwirrtheit, Erschöpfung
- Status epilepticus: Anfall > 5 Min.

DIAGNOSTIK

- EEG (interiktal/iktal)
- MRT Schädel
- Labor: BZ, Elektrolyte, Antiepileptika-Spiegel
- Provokationsfaktoren erfragen

THERAPIE

- Antiepileptika: Valproat, Lamotrigin, Levetiracetam, Carbamazepin
- Status epilepticus: Lorazepam i.v. → Phenytoin → Narkose
- Anfallsauslöser vermeiden (Schlafentzug, Alkohol, Flackerlicht)
- Führerschein: 12 Monate anfallsfrei

Pflegeproblem	Risiko sturzbedingte Verletzung r/t unkontrollierten Krampfanfällen m/d/s Epilepsie, letzter Anfall vor 3 Tagen
Ressourcen	Versteht Sicherheitsmaßnahmen, Kooperativ
Pflegeziel	Patient verletzt sich bei möglichem Anfall nicht durch konsequente Sturzprophylaxe
Maßnahmen	• Bettgitter tagsüber nur nach Risiko-Assessment – nicht pauschal! • Scharfe Gegenstände aus Griffweite entfernen • Bett auf niedrigste Position • Bei Anfall: NIEMALS festhalten, Atemweg freihalten, Zeit stoppen • Kein Beißkeil! (Verletzungsgefahr, Aspiration) • Patienten NICHT alleine lassen während Anfall • Nach Anfall: stabile Seitenlage, Sauerstoff, Vitalzeichen • Anfall dokumentieren: Beginn, Dauer, Verlauf, postiktale Phase
Evaluation	Bei jedem Anfall: Dauer, Art, Verlauf dokumentieren

KONTROLLFRAGEN

70 **Was tut man NICHT bei einem epileptischen Anfall?**

A) Atemweg freihalten

B) Beißkeil einlegen und festhalten – beides falsch und gefährlich!

C) Zeit stoppen

D) Verletzungsschutz sichern

71 **Ab wann gilt ein epileptischer Anfall als Status epilepticus?**

A) Ab 1 Min.

B) Ab 5 Min. – medizinischer Notfall, sofortige Therapie!

C) Ab 30 Min.

D) Nur bei mehreren Anfällen

72 **Was bedeutet 'postiktale Phase'?**

A) Die Aura vor dem Anfall

B) Erschöpfungs-/Verwirrtheitszustand nach dem Anfall – kann Minuten bis Stunden dauern

C) Der Anfall selbst

D) Ein EEG-Befund

Morbus Parkinson G20

Chronisch-neurodegenerative Erkrankung mit Dopaminmangel. Leitsymptome: Rigor, Tremor, Brady-/Akinese, posturale Instabilität.

SYMPTOME

- Ruhetremor
- Rigor (Muskelsteifigkeit)
- Bradykinese/Akinese (verlangsamte Bewegung)
- Posturale Instabilität, kleinschrittiger Gang
- Maskengesicht, leise Sprache, Mikrografie

DIAGNOSTIK

- Klinische Diagnose (Kardinalsymptome)
- Anamnese, neurologische Untersuchung
- L-Dopa-Test
- Bildgebung zum Ausschluss
- Verlaufsbeurteilung

THERAPIE

- Medikamentös (L-Dopa, Dopaminagonisten) nach AO – pünktliche Gabe!
- Physio-/Ergo-/Logopädie
- Sturzprophylaxe, Hilfsmittel
- Ggf. tiefe Hirnstimulation
- Ernährung, Obstipationsprophylaxe

Pflegeproblem	Sturzgefahr und beeinträchtigte Mobilität r/t Parkinson m/d/s Rigor, Bradykinese, posturaler Instabilität
Ressourcen	Motiviert, Angehörige unterstützen, Physiotherapie verfügbar
Pflegeziel	Der Patient bleibt sturzfrei und so mobil/selbstständig wie möglich
Maßnahmen	• Medikamente exakt pünktlich nach AO, On-/Off-Phasen beobachten • Sturzprophylaxe, sichere Mobilisation, Hilfsmittel • Zeit lassen, Selbstständigkeit fördern • Schluckstörung/Aspiration beachten, Ernährung anpassen • Obstipations-/Dekubitusprophylaxe, Physiotherapie einbinden
Evaluation	Sturzfrei, Mobilität/Selbstständigkeit erhalten, Medikamentenwirkung stabil.

Multiple Sklerose G35

Chronisch-entzündliche, demyelinisierende Erkrankung des ZNS mit schubförmigem oder progredientem Verlauf und vielfältigen neurologischen Ausfällen.

SYMPTOME

- Sehstörungen (z. B. Optikusneuritis)
- Sensibilitätsstörungen, Missempfindungen
- Paresen, Spastik
- Gangunsicherheit, Koordinationsstörungen
- Fatigue, Blasenstörungen

DIAGNOSTIK

- MRT (Entzündungsherde)
- Liquordiagnostik
- Evozierte Potenziale
- Neurologische Untersuchung
- Verlauf (Schübe)

THERAPIE

- Schubtherapie (Kortison) nach AO
- Verlaufsmodifizierende Immuntherapie nach AO
- Symptomatische Therapie (Spastik, Blase, Fatigue)
- Physio-/Ergotherapie
- Rehabilitation

Pflegeproblem	Fatigue und beeinträchtigte Mobilität r/t Multipler Sklerose m/d/s Erschöpfung, Paresen/Spastik
Ressourcen	Patient kennt seine Erkrankung, Therapie läuft, Angehörige unterstützen
Pflegeziel	Der Patient teilt seine Energie ein und bleibt im Rahmen seiner Möglichkeiten mobil/selbstständig
Maßnahmen	• Fatigue-Management, Aktivitäten und Pausen planen • Mobilität/Spastik unterstützen (Lagerung, Hilfsmittel, Sturzprophylaxe) • Blasen-/Darmmanagement, Hautschutz • Schubtherapie nach AO begleiten • Ressourcen fördern, psychische Unterstützung
Evaluation	Energie besser eingeteilt, Mobilität erhalten, Komplikationen vermieden.

Migräne G43

Anfallsartige, oft einseitige Kopfschmerzen, häufig mit Übelkeit und Licht-/Lärmempfindlichkeit, teils mit Aura. Chronisch-rezidivierend.

SYMPTOME

- Pulsierender, oft einseitiger Kopfschmerz
- Übelkeit/Erbrechen
- Licht-/Lärm-/Geruchsempfindlichkeit
- Verstärkung bei Bewegung
- Ggf. Aura (z. B. Sehstörungen) vor dem Schmerz

DIAGNOSTIK

- Klinische Diagnose, Anamnese (Trigger, Verlauf)
- Kopfschmerztagebuch
- Ausschluss anderer Ursachen (Red Flags)
- Neurologische Untersuchung

THERAPIE

- Akut: Analgetika/Triptane nach AO, früh einnehmen
- Reizabschirmung, Ruhe
- Antiemetika nach AO
- Prophylaxe bei häufigen Attacken nach AO
- Triggervermeidung, Lebensstil

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t Migräneattacke m/d/s pulsierendem Kopfschmerz, Übelkeit, Reizempfindlichkeit
Ressourcen	Patient kennt Auslöser, Medikamente verfügbar
Pflegeziel	Der Patient ist während der Attacke deutlich schmerzgelindert (NRS ≤ 3)
Maßnahmen	• Reizarme, abgedunkelte, ruhige Umgebung schaffen • Medikamente früh nach AO geben, Wirkung kontrollieren • Übelkeit/Erbrechen behandeln, Flüssigkeit anbieten • Kopfschmerztagebuch/Triggervermeidung unterstützen • Edukation zu früher Einnahme und Auslösern
Evaluation	Schmerz gelindert, Übelkeit kontrolliert, Trigger reflektiert.

Demenz (Alzheimer-Typ) G30

Fortschreitender Verlust kognitiver Fähigkeiten (v. a. Gedächtnis), häufigste Form ist Alzheimer. Beeinträchtigt Alltag und Selbstständigkeit zunehmend.

SYMPTOME

- Gedächtnisstörungen (v. a. Kurzzeitgedächtnis)
- Orientierungsstörungen (Zeit/Ort)
- Wortfindungs-/Sprachstörungen
- Beeinträchtigte Alltagskompetenz
- Verhaltensänderungen, Unruhe, Tag-Nacht-Umkehr

DIAGNOSTIK

- Kognitive Tests (z. B. MMST/ Uhrentest)
- Anamnese (Eigen-/ Fremdanamnese)
- Bildgebung, Labor (Ausschluss)
- Verlaufsbeurteilung

THERAPIE

- Antidementiva nach AO
- Nicht-medikamentöse Förderung (Aktivierung, Biografiearbeit)
- Strukturierter, sicherer Alltag
- Behandlung von Begleitsymptomen
- Angehörigenberatung/-entlastung

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Orientierung und Selbstständigkeit r/t Demenz m/d/s Gedächtnis-/ Orientierungsstörungen, Unruhe
Ressourcen	Biografie bekannt, Angehörige unterstützen, Erhaltene Ressourcen
Pflegeziel	Der Mensch mit Demenz ist sicher, orientiert sich im Rahmen seiner Möglichkeiten und behält Selbstständigkeit/Würde
Maßnahmen	• Klare Tagesstruktur, Orientierungshilfen, vertraute Routinen • Validierender, ruhiger Umgang, einfache Kommunikation • Sicherheit gewährleisten (Sturz-/Hinlaufprophylaxe), reizarm • Ressourcen/Selbstständigkeit fördern, Biografiearbeit • Ernährung/Flüssigkeit sichern, Angehörige beraten/entlasten
Evaluation	Sicher, im Rahmen orientiert, Selbstständigkeit/Würde gewahrt.

Bakterielle Meningitis G00

Bakterielle Entzündung der Hirnhäute, ein lebensbedrohlicher Notfall. Schnelle Diagnose und Antibiotikatherapie sind entscheidend.

SYMPTOME

- Hohes Fieber
- Starke Kopfschmerzen
- Meningismus (Nackensteife)
- Licht-/Geräuschempfindlichkeit, Übelkeit
- Bewusstseinstrübung, ggf. Petechien (Meningokokken)

DIAGNOSTIK

- Klinik (Meningismus, Brudzinski/ Kernig)
- Liquorpunktion nach AO
- Labor/Blutkultur
- Bildgebung bei Indikation
- Vitalzeichen/Bewusstsein

THERAPIE

- Sofortige Antibiotikatherapie nach AO (nicht verzögern!)
- Ggf. Kortison nach AO
- Intensivüberwachung, Kreislauf-/ Atemstabilisierung
- Isolation (je nach Erreger)
- Symptomatische Therapie

Pflegeproblem	Gefahr der Verschlechterung r/t bakterieller Meningitis m/d/s Fieber, Meningismus, Bewusstseinstrübung
Ressourcen	Stationäre/intensive Versorgung, Frühzeitige Therapie
Pflegeziel	Eine Verschlechterung wird früh erkannt; der Patient bleibt kreislauf- und neurologisch stabil
Maßnahmen	• Vitalzeichen/Bewusstsein engmaschig überwachen • Antibiotika/Medikamente zeitgerecht nach AO • Reizarme, abgedunkelte Umgebung, Schmerz-/Fiebermanagement • Isolation nach Standard, konsequente Hygiene • Auf Petechien/Komplikationen achten, Intensiv
Evaluation	Früh erkannt, stabil, Therapie zeitgerecht, keine Übertragung.

Guillain-Barré-Syndrom G61

Akute, meist postinfektiöse Entzündung peripherer Nerven mit aufsteigenden, symmetrischen Lähmungen. Gefahr der Atemlähmung.

SYMPTOME

- Aufsteigende, symmetrische Muskelschwäche (von den Beinen)
- Reflexverlust
- Sensibilitätsstörungen/ Missempfindungen
- Gangunsicherheit
- Bei Progredienz: Atem-/ Schluckstörung, autonome Störungen

DIAGNOSTIK

- Klinik (aufsteigende Paresen, Areflexie)
- Liquor (Eiweißerhöhung)
- Elektroneurografie
- Atemfunktion überwachen
- Verlaufsbeobachtung

THERAPIE

- Immuntherapie (z. B. Immunglobuline/Plasmapherese) nach AO
- Engmaschige Überwachung der Atmung (Intensiv!)
- Thrombose-/Pneumonie-/ Dekubitusprophylaxe
- Physiotherapie
- Schmerz-/Symptomtherapie

Pflegeproblem	Gefahr der respiratorischen Insuffizienz r/t aufsteigender Lähmung bei GBS m/d/s zunehmender Muskelschwäche
Ressourcen	Intensive Überwachung möglich, Therapie läuft
Pflegeziel	Eine respiratorische Verschlechterung wird früh erkannt; der Patient bleibt ausreichend ventiliert
Maßnahmen	• Atmung/Vitalkapazität engmaschig überwachen, Beatmungsbereitschaft • Schluckstörung/Aspiration beachten • Thrombose-/Pneumonie-/Dekubitus-/Kontrakturprophylaxe • Immuntherapie nach AO begleiten, Physiotherapie • Psychische Unterstützung, Kommunikation sichern
Evaluation	Atmung früh überwacht, ausreichend ventiliert, keine Prophylaxe-Komplikation.

Polyneuropathie G62

Erkrankung mehrerer peripherer Nerven, häufig durch Diabetes oder Alkohol. Typisch: distal-symmetrische Sensibilitätsstörungen und Missempfindungen.

SYMPTOME

- Kribbeln, Brennen, Taubheit (v. a. Füße, 'Socken'-Muster)
- Sensibilitätsstörungen, vermindertes Schmerzempfinden
- Muskelschwäche (fortgeschritten)
- Gang-/Standunsicherheit
- Erhöhte Verletzungs-/Wundgefahr (z. B. Fußulkus)

DIAGNOSTIK

- Anamnese (Diabetes, Alkohol), Neurologie
- Sensibilitäts-/Reflexprüfung
- Elektroneurografie
- Labor (Ursachensuche)
- Fußinspektion

THERAPIE

- Grunderkrankung behandeln (BZ-Einstellung, Alkoholkarenz)
- Schmerztherapie nach AO
- Fußpflege/Verletzungsschutz
- Physiotherapie
- Vitaminsubstitution nach AO bei Mangel

Pflegeproblem	Verletzungs-/Sturzgefahr r/t verminderter Sensibilität bei Polyneuropathie m/d/s Taubheit, Gangunsicherheit
Ressourcen	Patient lernbereit, Grunderkrankung behandelbar
Pflegeziel	Der Patient bleibt sturz- und verletzungsfrei; die Füße bleiben intakt
Maßnahmen	• Füße/Haut täglich inspizieren, Druck/Verletzungen vermeiden • Sturzprophylaxe, sichere Mobilisation • Schmerz-/Missempfindungen nach AO managen • Geeignetes Schuhwerk/Fußpflege, Vorsicht mit Wärmequellen • Grunderkrankung (BZ/Alkohol) unterstützen, Edukation
Evaluation	Sturz-/verletzungsfrei, Füße intakt, Beschwerden gelindert.

Fazialisparese G51

Lähmung des Gesichtsnervs (N. facialis), meist einseitig und idiopathisch (Bell-Parese). Halbseitige Gesichtslähmung; wichtig ist der Schutz des Auges.

SYMPTOME

- Einseitig hängender Mundwinkel
- Unvollständiger Lidschluss (betroffenes Auge)
- Fehlende Stirnrunzelung (periphere Parese)
- Verwaschene Sprache, Speichelfluss
- Geschmacks-/Hörveränderungen möglich

DIAGNOSTIK

- Klinik (einseitige mimische Schwäche, Stirn betroffen?)
- Abgrenzung zentral/peripher
- Neurologische Untersuchung
- Ggf. weitere Abklärung (Ursachen)

THERAPIE

- Ggf. Kortison nach AO (früh)
- Augenschutz (Tränenersatz, Uhrglasverband) zwingend
- Mimische Übungen/ Physiotherapie/Logopädie
- Ursachenbehandlung
- Verlaufskontrolle

Pflegeproblem	Gefahr einer Hornhautschädigung r/t unvollständigem Lidschluss bei Fazialisparese m/d/s fehlendem Lidschluss, trockenem Auge
Ressourcen	Patient kooperativ, Therapie früh begonnen
Pflegeziel	Das betroffene Auge bleibt geschützt und reizfrei (keine Hornhautschädigung)
Maßnahmen	• Augenschutz konsequent (Tränenersatz, ggf. Uhrglasverband), Augenkontrolle • Bei Mahlzeiten Aspiration/Speichelfluss beachten, Mundpflege • Mimische Übungen/Physio-/Logopädie unterstützen • Medikamente (z. B. Kortison) nach AO • Psychische Unterstützung, Edukation
Evaluation	Auge geschützt und reizfrei, keine Hornhautschädigung, Therapie umgesetzt.

HNO

10 Krankheitsbilder

Tracheotomie-Pflege Z93.0

Tracheotomie = operativer Zugang zur Trachea. Temporär (PDT: perkutane Dilatationstracheotomie bei Langzeitbeatmung) oder dauerhaft (Laryngektomie). Sichert Atemweg, erleichtert Weaning. Tracheostomaversorgung ist Kernkompetenz der Intensivpflege und HNO.

SYMPTOME

- Atemnot bei Verlegung der Kanüle
- Sekretansammlung
- Hautreizung um Stoma
- Granulationen
- Kanülenobstruktion

DIAGNOSTIK

- Klinische Beurteilung (Atemgeräusche, Sekret)
- Laryngoskopie bei Komplikationen
- Bronchoskopie bei Verdacht Sekretpfropf

THERAPIE

- Regelmäßige Kanülenpflege
- Absaugung (steril/aseptisch nach Standard)
- Innenkanüle wechseln
- Feuchtigkeitserhalt (HME-Filter, Befeuchtung)
- Stöma-Hautpflege
- Sprechen: Sprechkanüle, Passy-Muir-Ventil

Pflegeproblem	Ineffektive Atemwegsclearance r/t Tracheotomie und eingeschränktem Hustenmechanismus m/d/s zähes Sekret, Absaugbedarf
Ressourcen	Patient kann bei Absaugung mitarbeiten, Absaugeinheit vorhanden
Pflegeziel	Atemwege bleiben frei, $SpO_2 \geq 94\%$, Absaugintervall > 2h ohne Atemnot
Maßnahmen	• Absaugung: NUR bei Bedarf (nicht nach Schema!), sterile Technik • Vor Absaugen: präoxygenieren (FiO_2 erhöhen, bei Beatmung) • Einführtiefe: max. 0,5cm über Kanülenspitze – nicht tiefer! • Sog max. 150-200 cmH_2O, max. 15 Sek. pro Absaugvorgang • Innenkanüle alle 8h wechseln/reinigen • HME-Filter 24h-Wechsel (Befeuchtung, Bakterienfilter) • Ausreichend Flüssigkeit sichern (Sekretverflüssigung) • Raumluftbefeuchtung • Stöma täglich reinigen: sterile NaCl-Kompressen
Evaluation	Atemgeräusche, SpO_2, Sekretmenge/-beschaffenheit, Hautbefund

KONTROLLFRAGEN

73 **Was ist der Unterschied zwischen PDT und chirurgischer Tracheotomie?**

(A) Kein Unterschied

(B) PDT = perkutane Dilatation am Patientenbett (Intensiv, Notfall), chirurgische = OP-Saal, präziser bei Adipositas/Kurzalshals

(C) PDT ist dauerhafter

(D) PDT ist nur für Kinder

74 **Warum wird bei der Tracheostomaabsaugung präoxygeniert?**

A Nur bei Beatmeten nötig

B Absaugung unterbricht Ventilation/Oxygenierung → SpO_2-Abfall → vorherige O_2-Erhöhung verhindert Hypoxie

C Nur wegen Keimfreiheit

D Keine Begründung

75 **Was ist ein HME-Filter bei Tracheotomie?**

A Ein Absaugkatheter

B Heat and Moisture Exchanger: Wärme-Feuchtigkeits-Austauscher + Bakterienfilter – ersetzt Nasenrachen-Funktion

C Ein Sprechventil

D Eine Kanülenart

Otitis media (Mittelohrentzündung) H66

Häufigste bakterielle Infektion im Kindesalter (70% aller Kinder bis 3J. mindestens einmal). Akut: meist viral/bakteriell (Pneumokokken, H. influenzae). Chronisch: Gefahr Komplikationen. Wichtig für GPA-Pädiatrie-Einsatz.

SYMPTOME

- Starke Ohrenschmerzen (Otalgie)
- Fieber
- Hörverlust (Schallleitungsschwerhörigkeit)
- Reizbarkeit (Säuglinge)
- Ohrziehen (Kinder)
- Druckgefühl im Ohr
- Eitrige Sekretion bei Perforation (dann Schmerzlinderung!)

DIAGNOSTIK

- Otoskopie: gerötet, vorgewölbt, Lichtreflex fehlt
- Tympanometrie
- Audiometrie bei chronischer Form
- Abstrich bei Sekretion

THERAPIE

- Schmerztherapie: Ibuprofen, Paracetamol
- Abschwellende Nasentropfen
- Abwartend bei unkomplizierter akuter Otitis (7 Tage)
- Antibiotika: Amoxicillin bei Komplikationen/Risikogruppen
- Parazentese (Einschnitt Trommelfell) bei starken Schmerzen
- Paukenröhrchen bei rezidivierender Otitis

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t Mittelohrentzündung m/d/s Kind weint, NRS-Kinderskala 7, Ohrziehen
Ressourcen	Eltern kooperativ, Kind ablenkbar
Pflegeziel	Schmerz auf NRS-Kinderskala ≤ 3 innerhalb von 1h nach Analgesie
Maßnahmen	• Analgetikum nach Anordnung: Ibuprofen (bevorzugt, auch antiinflammatorisch) oder Paracetamol gewichtsadaptiert • Wärme auf Ohr (Kirschkernsäckchen, wenn kein Abszess!) • Abschwellende Nasentropfen nach Anordnung • Ablenkung: Spielzeug, Eltern einbeziehen • Keine Wattepfropfen ins Ohr! • Lagerung: betroffene Seite oben → erleichtert Drainage • Fiebersenkung nach Anordnung
Evaluation	NRS-Kinderskala 30 Min. nach Analgesie

KONTROLLFRAGEN

76 **Warum sind Kinder häufiger von Otitis media betroffen als Erwachsene?**

A) Kindliche Immunschwäche allein

B) Eustachische Röhre kürzer, horizontaler und weicher – schlechtere Belüftung + leichterer Keimaufstieg aus dem Nasopharynx

C) Nur wegen Infektionen

D) Kein Unterschied

77 **Was bedeutet es, wenn bei Otitis media plötzlich Eiter aus dem Ohr fließt?**

A) Verschlimmerung

B) Trommelfellperforation → Druckentlastung → Schmerzlinderung! Oft positive Wendung.

C) Sofortiger Notfall

D) Kein Zeichen

78 **Was ist ein Paukenröhrchen?**

A) Ein Hörgerät

B) Kleines Titanröhrchen im Trommelfell: belüftet Mittelohr, lässt Sekret abfließen – bei rezidivierender Otitis

C) Ein Antibiotikum

D) Ein Diagnoseinstrument

Tonsillitis (Angina tonsillaris) J03

Akute Entzündung der Gaumenmandeln, meist bakteriell (Streptokokken) oder viral. Häufig mit Halsschmerzen und Fieber.

SYMPTOME

- Halsschmerzen, Schluckbeschwerden
- Gerötete, geschwollene Mandeln (ggf. Beläge)
- Fieber
- Geschwollene Halslymphknoten
- Kopf-/Gliederschmerzen
- Mundgeruch

DIAGNOSTIK

- Racheninspektion
- Anamnese, Temperatur
- Ggf. Streptokokken-Schnelltest
- Auf Komplikationen achten (Abszess)
- Labor bei Bedarf

THERAPIE

- Analgesie/Antipyrese nach AO
- Antibiotika bei bakterieller Genese nach AO
- Ausreichend Flüssigkeit, Schonung
- Bei rezidivierender Tonsillitis ggf. Tonsillektomie
- Lokale Maßnahmen

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t Tonsillitis m/d/s Halsschmerz, Schluckbeschwerden, Fieber
Ressourcen	Patient kooperativ, Behandlung verfügbar
Pflegeziel	Der Patient ist schmerzgelindert (NRS ≤ 3), fieberfrei und nimmt ausreichend Flüssigkeit
Maßnahmen	• Schmerz-/Fiebermanagement nach AO • Weiche Kost, ausreichend (kühle) Flüssigkeit • Auf Schluck-/Atembeschwerden und Abszesszeichen achten • Mundpflege • Edukation (Therapietreue, Ansteckung)
Evaluation	Schmerz gelindert, fieberfrei, ausreichende Flüssigkeitsaufnahme.

Sinusitis (Rhinosinusitis) J32

Entzündung der Nasennebenhöhlen, oft nach Erkältung. Akut oder chronisch; meist viral, teils bakteriell.

SYMPTOME

- Druck-/Kopfschmerz (verstärkt beim Bücken)
- Behinderte Nasenatmung
- Eitriges Nasensekret
- Riechminderung
- Druckschmerz über den Nebenhöhlen
- Ggf. Fieber

DIAGNOSTIK

- Klinik (Druckschmerz, Sekret)
- Anamnese
- Ggf. Endoskopie/Bildgebung
- Auf Komplikationen achten
- Temperatur

THERAPIE

- Abschwellende Maßnahmen (Nasenspray/Spülung) nach AO
- Analgesie nach AO
- Antibiotika nur bei bakterieller/komplizierter Genese nach AO
- Ausreichend Flüssigkeit, Inhalation
- Bei chronischem Verlauf HNO

Pflegeproblem	Schmerz und behinderte Nasenatmung r/t Sinusitis m/d/s Gesichtsdruck, Sekretstau
Ressourcen	Patient kooperativ, Behandlung verfügbar
Pflegeziel	Der Patient ist schmerzgelindert und atmet freier durch die Nase
Maßnahmen	• Abschwellende Maßnahmen/Nasenpflege nach AO • Inhalation/Befeuchtung, ausreichend Flüssigkeit • Schmerz-/Fiebermanagement nach AO • Oberkörper hoch, Ruhe • Edukation zu Anwendung/Warnzeichen
Evaluation	Schmerz gelindert, Nasenatmung verbessert, kein Komplikationshinweis.

Epistaxis (Nasenbluten) R04.0

Blutung aus der Nase, meist aus dem vorderen Nasenseptum (Locus Kiesselbachi). Meist harmlos, selten bedrohlich (z. B. bei Antikoagulation/Hypertonie).

SYMPTOME

- Blutung aus der Nase (ein-/beidseitig)
- Blutfluss in den Rachen möglich
- Bei starker Blutung: Kreislaufzeichen
- Angst/Unruhe
- Ggf. Hinweise auf Ursache (Hypertonie, Antikoagulation)

DIAGNOSTIK

- Blutungsquelle/-stärke beurteilen
- Vitalzeichen (RR, Puls)
- Anamnese (Antikoagulation, Hypertonie, Trauma)
- Auf Kreislaufrelevanz achten

THERAPIE

- Oberkörper aufrecht, Kopf nach vorne, Nasenflügel komprimieren
- Kühlung (Nacken), ggf. abschwellende/blutstillende Maßnahmen nach AO
- Bei starker Blutung Tamponade/HNO nach AO
- Ursache behandeln (RR, Gerinnung)
- Beruhigung

Pflegeproblem	Gefahr von Blutverlust und Angst r/t Epistaxis m/d/s Nasenblutung, Unruhe
Ressourcen	Patient kooperativ, Sofortmaßnahmen möglich
Pflegeziel	Die Blutung steht; der Patient ist kreislaufstabil und beruhigt
Maßnahmen	• Sofortmaßnahmen (aufrecht, Kopf nach vorne, Nasenflügel komprimieren, Nacken kühlen) • Beruhigen, Blut ausspucken lassen • Vitalzeichen/Blutungsstärke überwachen • Bei Tamponade Pflege/Beobachtung • Ursachen (RR/Gerinnung) beachten, Edukation
Evaluation	Blutung gestillt, kreislaufstabil, beruhigt.

Hörsturz H91.2

Plötzliche, meist einseitige Innenohr-Schwerhörigkeit ohne erkennbare äußere Ursache. Wird als HNO-Eilfall behandelt.

SYMPTOME

- Plötzliche einseitige Hörminderung
- Ohrdruck/'Wattegefühl'
- Häufig Tinnitus
- Ggf. leichter Schwindel
- Keine Schmerzen

DIAGNOSTIK

- HNO-Untersuchung, Hörtests (Audiometrie)
- Otoskopie (Ausschluss anderer Ursachen)
- Anamnese
- Verlaufskontrolle

THERAPIE

- Glukokortikoide nach AO (oft hochdosiert/lokal)
- Ggf. durchblutungsfördernde Maßnahmen nach AO
- Ruhe, Stressreduktion
- HNO-Verlaufskontrolle
- Aufklärung

Pflegeproblem	Belastung durch akute Hörminderung r/t Hörsturz m/d/s einseitiger Hörminderung, Tinnitus, Sorge
Ressourcen	Patient kooperativ, Frühzeitige Behandlung
Pflegeziel	Der Patient erhält zeitgerecht die Therapie und ist im Umgang mit der Situation unterstützt
Maßnahmen	• Medikamente nach AO geben, Wirkung/Nebenwirkung beobachten • Ruhe/Stressreduktion fördern • Bei Schwindel Sturzprophylaxe • Psychische Unterstützung • Edukation zu Therapie/Verlauf
Evaluation	Therapie zeitgerecht, Patient unterstützt, Verlauf beobachtet.

Morbus Menière (Drehschwindel) H81.0

Innenohrerkrankung mit anfallsartigem Drehschwindel, Hörminderung und Tinnitus, bedingt durch Endolymphschwankungen.

SYMPTOME

- Anfallsartiger heftiger Drehschwindel (Minuten bis Stunden)
- Übelkeit/Erbrechen
- Einseitige Hörminderung
- Tinnitus
- Druckgefühl im Ohr, Fallneigung

DIAGNOSTIK

- HNO-Untersuchung, Hörtests
- Gleichgewichtsdiagnostik
- Anamnese (Anfallsmuster)
- Ausschluss anderer Ursachen

THERAPIE

- Im Anfall: Ruhe, Antiemetika/Antivertiginosa nach AO
- Sturzschutz
- Langfristig: medikamentös/diätetisch nach AO
- HNO-Betreuung
- Aufklärung/Schulung

Pflegeproblem	Sturzgefahr r/t anfallsartigem Drehschwindel bei Morbus Menière m/d/s Schwindel, Übelkeit, Fallneigung
Ressourcen	Patient kooperativ, Begleitung verfügbar
Pflegeziel	Der Patient bleibt im Anfall sturzfrei und ist symptomgelindert
Maßnahmen	• Sturzprophylaxe, reizarme Umgebung, ruhige Lagerung, beruhigen • Antiemetika/Antivertiginosa nach AO, Erbrechen managen • Begleitung beim Gehen • Flüssigkeit/Ernährung anpassen • Edukation zu Verhalten im Anfall
Evaluation	Sturzfrei, Schwindel/Übelkeit gelindert.

Larynxkarzinom (Kehlkopfkarzinom) C32

Bösartiger Tumor des Kehlkopfs, Hauptrisikofaktoren Rauchen und Alkohol. Häufig anhaltende Heiserkeit als Frühzeichen.

SYMPTOME

- Anhaltende Heiserkeit
- Fremdkörpergefühl/Räusperzwang
- Schluckbeschwerden
- Husten, ggf. blutiger Auswurf
- Bei Fortschreiten: Atemnot, Halslymphknoten

DIAGNOSTIK

- HNO-Untersuchung, Laryngoskopie
- Biopsie (Sicherung)
- Bildgebung/Staging
- Anamnese (Rauchen/Alkohol)

THERAPIE

- Operative Therapie (Teil-/Laryngektomie)
- Strahlen-/Chemotherapie nach AO
- Bei Laryngektomie: Tracheostoma, Stimmrehabilitation
- Nachsorge
- Rauch-/Alkoholkarenz

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Kommunikation und Atemwegssicherheit r/t Larynxkarzinom/Laryngektomie m/d/s Stimmverlust, Tracheostoma
Ressourcen	Patient lernbereit, Logopädie/Stomatherapie verfügbar, Angehörige unterstützen
Pflegeziel	Der Atemweg ist sicher; der Patient kann sich verständigen und versorgt sein Tracheostoma zunehmend selbstständig
Maßnahmen	• Tracheostoma sicher versorgen/absaugen, Atmung/Sekret beobachten • Kommunikationshilfen bereitstellen (Schreibtafel, später Stimmrehabilitation) • Therapienebenwirkungen nach AO managen, Ernährung/Schlucken • Perioperative/onkologische Pflege • Psychische Unterstützung, Logopädie, Rauch-/Alkoholkarenz
Evaluation	Atemweg sicher, Verständigung möglich, zunehmende Selbstversorgung.

Peritonsillarabszess J36

Eiteransammlung neben der Gaumenmandel, meist als Komplikation einer Tonsillitis. Kann die Atmung gefährden – ein HNO-Notfall.

SYMPTOME

- Zunehmende, oft einseitige Halsschmerzen
- Hohes Fieber
- Kloßige Sprache
- Kieferklemme (Mundöffnung erschwert)
- Schluckunfähigkeit/Speichelfluss, einseitige Schwellung

DIAGNOSTIK

- Racheninspektion (einseitige Vorwölbung, Uvula-Verdrängung)
- Klinik, Temperatur
- HNO-Vorstellung
- Auf Atemwegsgefährdung achten

THERAPIE

- Abszessentlastung (Punktion/ Inzision) nach AO
- Antibiotika nach AO
- Analgesie/Antipyrese nach AO
- Flüssigkeit (oft i.v.)
- Auf Atemweg achten, ggf. stationär

Pflegeproblem	Akuter Schmerz und Atemwegsgefährdung r/t Peritonsillarabszess m/d/s einseitiger Schwellung, Schluckunfähigkeit
Ressourcen	Stationäre Versorgung, Frühzeitige Behandlung
Pflegeziel	Der Atemweg bleibt frei; der Patient ist schmerzgelindert und kann schlucken
Maßnahmen	• Atmung/Schlucken engmaschig beobachten (Atemwegsgefährdung) • Schmerz-/Fiebermanagement nach AO • Flüssigkeit (oft i.v.) sichern, Bilanz • Nach Abszessentlastung beobachten, Mundpflege • Beruhigen, Edukation
Evaluation	Atemweg frei, Schmerz gelindert, Schlucken möglich.

Otitis externa H60

Entzündung des äußeren Gehörgangs ('Bade-Otitis'), oft bakteriell oder durch Feuchtigkeit. Schmerzhaft, mit Juckreiz und Schwellung.

SYMPTOME

- Ohrenschmerzen (verstärkt bei Zug an der Ohrmuschel)
- Juckreiz im Gehörgang
- Schwellung/Rötung, Sekretion
- Hörminderung bei Schwellung
- Druckgefühl

DIAGNOSTIK

- Otoskopie (geröteter, geschwollener Gehörgang)
- Klinik (Tragus-/Zugschmerz)
- Ggf. Abstrich
- Anamnese (Wasser, Manipulation)

THERAPIE

- Reinigung des Gehörgangs (HNO) nach AO
- Lokale (antibiotisch/antiseptische) Ohrentropfen nach AO
- Analgesie nach AO
- Gehörgang trocken halten
- Manipulation/Wattestäbchen meiden

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t Entzündung des äußeren Gehörgangs m/d/s Ohrenschmerz, Schwellung, Juckreiz
Ressourcen	Patient kooperativ, Behandlung verfügbar
Pflegeziel	Der Patient ist schmerzgelindert; die Entzündung klingt ab
Maßnahmen	• Ohrentropfen/Lokaltherapie nach AO korrekt anwenden/anleiten • Schmerzmanagement nach AO • Gehörgang trocken halten, vor Wasser schützen • Manipulation vermeiden, Edukation • Auf Besserung/Komplikation achten
Evaluation	Schmerz gelindert, Entzündung rückläufig.

Onkologie

10 Krankheitsbilder

Onkologische Pflegegrundlagen C00-C97

Onkologische Pflege umfasst alle pflegerischen Maßnahmen bei Krebserkrankungen: Prävention, Therapiebegleitung (OP, Chemo, Bestrahlung, Immuntherapie), Symptommanagement und Palliativpflege. Besondere Anforderungen an Kommunikation und Psychoonkologie.

SYMPTOME

- B-Symptome: Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust
- Fatigue (tumorbedingte Erschöpfung)
- Schmerzen (akut/chronisch)
- Nausea/Emesis (CINV)
- Mukositis (Schleimhautentzündung)
- Neutropenie (Infektionsgefahr)
- Thrombozytopenie (Blutungsrisiko)
- Alopecie (Haarausfall)

DIAGNOSTIK

- Staging: TNM-Klassifikation
- PET-CT, CT, MRT
- Tumormarker
- Biopsie
- Labor: Blutbild, Leber/Niere vor Chemo

THERAPIE

- Chirurgie
- Chemotherapie (Zytostatika)
- Strahlentherapie
- Immuntherapie (Checkpoint-Inhibitoren)
- Targeted Therapy (Tyrosinkinasehemmer)
- Palliativtherapie

Pflegeproblem	Übelkeit und Erbrechen r/t Chemotherapie (CINV) m/d/s Patient erbricht 5x täglich, Nahrungsablehnung
Ressourcen	Antiemetika vorhanden, Familie unterstützend, Motivation trotz Erschöpfung
Pflegeziel	CINV auf max. 2 Erbrechen/Tag reduziert, ausreichende Flüssigkeitszufuhr gesichert nach 48h
Maßnahmen	• Antiemetika nach Schema: prophylaktisch VOR Chemo-Gabe! • 5-HT3-Antagonisten (Ondansetron) + Dexamethason + NK1-Antagonisten (Aprepitant) je nach Emetogenität • Kalte/kühle Speisen bevorzugen (weniger Geruch) • Kleine, häufige Mahlzeiten (5-6/Tag statt 3 große) • Stark riechende Speisen vermeiden • Frische Luft, Fenster öffnen • Ingwer-Tee, Pfefferminze • Flüssigkeitsbilanz führen, bei > 1L Defizit: i.v.-Hydration • Mundpflege nach Erbrechen (Mundspülung)
Evaluation	Emesis-Tagebuch: Häufigkeit, Schwere (NCI-Skala)

Pflegeproblem	Risiko Infektion r/t Neutropenie durch Chemotherapie m/d/s Leukozyten 0,8 G/L, Fieber 38,5°C
Ressourcen	Patient kennt Infektionszeichen, Isolierungsmöglichkeit vorhanden
Pflegeziel	Keine lebensbedrohliche Infektion durch konsequente Schutzmaßnahmen; bei febriler Neutropenie: Antibiose innerhalb 1h
Maßnahmen	• Febrile Neutropenie = Notfall: Fieber ≥ 38,3°C bei Neutrophilen < 500/µl → sofort Arzt! • Blutkultur (2 Paare) VOR Antibiose (nicht verzögern!) • Breitband-Antibiose innerhalb 1h nach Anordnung • Umkehrisolation (protektive Isolation): Besucher mit MNS • Händehygiene: strikt WHO 5 Momente • Keine frischen Blumen/Topfpflanzen im Zimmer (Schimmel!) • Keine Rohkost, kein Rohmilchkäse (Low-Microbial-Diät nach Standard) • Täglich: Mundpflege Chlorhexidin, Körperpflege • GCSF nach Anordnung (Wachstumsfaktor für Neutrophile)
Evaluation	4-stündlich Temperatur, täglich Leukozyten/Neutrophile

KONTROLLFRAGEN

79 **Was bedeutet febrile Neutropenie?**

A) Normaler Verlauf der Chemotherapie

B) Fieber ≥ 38,3°C bei Neutrophilen < 500/µl – onkologischer Notfall, Antibiose innerhalb 1h!

C) Leichte Nebenwirkung

D) Nur bei Kindern

80 **Was ist CINV?**

A) Eine Krebsart

B) Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting – häufigste und gefürchtetste Nebenwirkung der Chemo

C) Ein Schmerzmittel

D) Eine Pflegediagnose

81 **Was ist Fatigue bei Krebspatienten?**

A) Normale Müdigkeit

B) Tumorbedingte Erschöpfung: multidimensional (körperlich, emotional, kognitiv), durch Schlaf nicht gebessert – häufig unterschätzt!

C) Ein Schmerzsyndrom

D) Eine Nebenwirkung nur der Bestrahlung

Palliativpflege Z51.5

Palliativpflege = aktive Gesamtbehandlung von Patienten mit unheilbarer, fortgeschrittener Erkrankung. Ziel: Lebensqualität, nicht Lebenszeit. WHO-Definition: weder Lebensverkürzung noch -verlängerung. Umfasst Schmerztherapie, Symptomkontrolle, psychosoziale/spirituelle Unterstützung.

SYMPTOME

- Schmerzen (häufig unzureichend behandelt)
- Dyspnoe
- Übelkeit
- Obstipation (durch Opioide)
- Mundtrockenheit
- Angst, Depression
- Delir (terminal)
- Rasselatmung (Sterbephase)

DIAGNOSTIK

- ECOG/KPS (Performance Status)
- ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale)
- Schmerzassessment: NRS, BPI
- Spirituelle Bedürfnisse: SPIR-Interview

THERAPIE

- Analgesie WHO-Stufenschema
- Opioide: Morphin, Oxycodon, Fentanyl transdermal
- Symptomkontrolle: Antiemetika, Laxanzien obligat zu Opioiden!
- Psychosoziale Unterstützung
- Seelsorge
- Angehörigenbegleitung

Pflegeproblem	Chronischer Schmerz r/t Tumorprogress m/d/s NRS 7 in Ruhe, Patient schläft nicht
Ressourcen	Offen für Opioidtherapie, Angehörige unterstützen Pflege
Pflegeziel	Dauerschmerz NRS ≤ 3, Nachtschlaf ≥ 5h nach Opioideinstellung innerhalb 48h
Maßnahmen	• Schmerzassessment: NRS, Lokalisation, Qualität, Verstärker/Linderung • Retardiertes Opioid nach Anordnung zur festen Zeit (nicht nach Bedarf!) • Schnellwirkendes Opioid als Reserve bei Durchbruchschmerz bereithalten • Laxans immer gleichzeitig zu Opioid verordnen lassen (keine Obstipation!) • Schmerztagebuch führen (Patient einbeziehen) • Komplementäre Maßnahmen: Lagerung, Wärme/Kälte, TENS, Entspannung • Nichts erzwingen: Patient darf Therapie ablehnen • Angehörige in Schmerzbeobachtung schulen
Evaluation	NRS 4-stündlich, Schlafqualität täglich, Nebenwirkungen (Obstipation, Übelkeit, Sedierung)

KONTROLLFRAGEN

82 **Was ist das WHO-Stufenschema der Schmerztherapie?**

A) Ein Pflegemodell

B) 3 Stufen: Nicht-Opioid → schwaches Opioid → starkes Opioid – immer Basisanalgesie, nicht nach Bedarf!

C) Nur für Krebsschmerzen

D) Ein Notfallschema

83 **Warum muss zu jedem Opioid ein Laxans verordnet werden?**

A) Nur bei alten Patienten

B) Opioide hemmen Darmmotilität (μ-Rezeptoren im Darm) – Obstipation tritt bei fast 100% auf und bessert sich NICHT durch Toleranz!

C) Nur bei hoher Dosis

D) Kein zwingender Grund

84 **Was ist Rasselatmung in der Sterbephase?**

A) Atemnot des Patienten

B) Geräuschvolle Atmung durch Sekretan sammlung im Rachen – Patient leidet meist nicht, aber Angehörige sehr!

C) Ein Notfall

D) Aspirationspneumonie

Bronchialkarzinom (Lungenkarzinom) C34

Bösartiger Lungentumor, Hauptrisikofaktor Rauchen. Oft spät symptomatisch; eingeteilt in klein- und nicht-kleinzellige Form.

SYMPTOME

- Anhaltender Husten/ Hustenveränderung
- Bluthaltiger Auswurf (Hämoptyse)
- Dyspnoe, thorakale Schmerzen
- Gewichtsverlust, Abgeschlagenheit
- Rezidivierende Atemwegsinfekte

DIAGNOSTIK

- Röntgen/CT-Thorax
- Bronchoskopie + Biopsie
- Labor, Staging
- Anamnese (Rauchen)
- Lungenfunktion

THERAPIE

- Operation (je nach Stadium)
- Strahlen-/Chemo-/zielgerichtete/ Immuntherapie nach AO
- Symptom-/Schmerzkontrolle, O_2 bei Bedarf
- Supportive/palliative Therapie
- Rauchstopp, psychoonkologische Begleitung

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Atmung und Belastung r/t Bronchialkarzinom/Therapie m/d/s Dyspnoe, Husten, Sorge
Ressourcen	Angehörige unterstützen, Psychoonkologie verfügbar
Pflegeziel	Der Patient ist atem- und symptomkontrolliert und in der Krankheitsbewältigung unterstützt
Maßnahmen	• Atmung/SpO_2 überwachen, O_2 nach AO, atemerleichternde Lagerung • Therapienebenwirkungen nach AO managen • Schmerz-/Symptomkontrolle, Ernährung • Psychoonkologische Begleitung, Angehörige einbeziehen • Atemtherapie/Mobilisation, Edukation (Rauchstopp)
Evaluation	Atmung/Symptome kontrolliert, Patient unterstützt.

Kolorektales Karzinom (Darmkrebs) C18

Bösartiger Tumor von Dick- oder Enddarm, häufig. Früherkennung (Vorsorge-Koloskopie) verbessert die Prognose deutlich.

SYMPTOME

- Veränderte Stuhlgewohnheiten
- Blut im Stuhl
- Leistungsminderung, Gewichtsverlust
- Anämie (okkulte Blutung)
- Bauchschmerzen, ggf. Ileuszeichen

DIAGNOSTIK

- Koloskopie + Biopsie
- Stuhltest (okkultes Blut)
- Bildgebung/Staging
- Labor (Anämie, Tumormarker nach AO)

THERAPIE

- Operative Tumorentfernung (ggf. Stoma)
- Chemo-/Strahlentherapie nach AO
- Symptom-/Schmerzkontrolle
- Nachsorge
- Psychoonkologische Begleitung

Pflegeproblem	Belastung und Ausscheidungsveränderung r/t kolorektalem Karzinom/Therapie m/d/s Stuhlveränderung, ggf. Stoma, Sorge
Ressourcen	Patient kooperativ, Stomatherapie/Angehörige
Pflegeziel	Der Patient ist symptomkontrolliert und versorgt seine Ausscheidung/ein Stoma zunehmend selbstständig
Maßnahmen	• Perioperative/onkologische Pflege; bei Stoma Versorgung/Anleitung, Hautschutz • Ausscheidung/Blutung beobachten, Ernährung, Bilanz • Therapienebenwirkungen nach AO managen • Schmerz-/Symptomkontrolle • Psychische Unterstützung, Edukation (Vorsorge)
Evaluation	Symptome kontrolliert, Versorgung sicher, zunehmende Selbstständigkeit.

Leukämie C95

Bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems mit unkontrollierter Vermehrung unreifer weißer Blutzellen. Akut oder chronisch.

SYMPTOME

- Müdigkeit, Blässe (Anämie)
- Infektneigung (Mangel funktionsfähiger Leukozyten)
- Blutungsneigung (Thrombozytopenie)
- Fieber, Nachtschweiß
- Lymphknoten-/Milzschwellung, Knochenschmerzen

DIAGNOSTIK

- Blutbild (Zytopenien/Blasten)
- Knochenmarkpunktion
- Weiterführende Diagnostik/ Typisierung
- Verlaufskontrollen

THERAPIE

- Chemotherapie nach AO
- Ggf. Stammzelltransplantation
- Supportiv: Transfusionen, Infektprophylaxe/-therapie nach AO
- Symptomkontrolle
- Psychoonkologische Begleitung

Pflegeproblem	Infektionsgefahr r/t therapiebedingter Immunsuppression bei Leukämie m/d/s Neutropenie, Fieberneigung
Ressourcen	Patient kooperativ, Angehörige unterstützen
Pflegeziel	Der Patient entwickelt keine unbehandelte Infektion; Komplikationen werden früh erkannt
Maßnahmen	• Strenge Infektionsprophylaxe, Hygiene/ggf. Umkehrisolation • Temperatur überwachen, Fieber als Notfall behandeln (febrile Neutropenie) • Auf Blutungs-/Anämiezeichen achten, Transfusionen nach AO begleiten • Chemotherapie-Nebenwirkungen managen, Mund-/Hautpflege • Psychische Unterstützung, Edukation
Evaluation	Keine unbehandelte Infektion, Komplikationen früh erkannt.

Malignes Lymphom (Hodgkin/Non-Hodgkin) C85

Bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems mit Lymphknotenvergrößerung. Unterschieden werden Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphome.

SYMPTOME

- Schmerzlose Lymphknotenschwellung
- B-Symptomatik: Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust
- Müdigkeit, Leistungsminderung
- Juckreiz
- Infektneigung möglich

DIAGNOSTIK

- Lymphknotenbiopsie
- Bildgebung/Staging
- Labor, Knochenmarkdiagnostik
- Verlaufskontrolle

THERAPIE

- Chemotherapie nach AO
- Strahlentherapie nach AO
- Ggf. Immun-/zielgerichtete Therapie
- Supportive Therapie
- Psychoonkologische Begleitung

Pflegeproblem	Belastung durch Erkrankung und Therapie r/t malignem Lymphom m/d/s B-Symptomatik, Therapienebenwirkungen
Ressourcen	Patient kooperativ, Angehörige/Psychoonkologie
Pflegeziel	Der Patient ist symptom- und nebenwirkungskontrolliert und in der Bewältigung unterstützt
Maßnahmen	• Therapienebenwirkungen nach AO managen (Übelkeit, Schleimhäute, Fatigue) • Infektionsprophylaxe, Temperatur überwachen • B-Symptomatik beobachten, Ernährung/Flüssigkeit • Schmerz-/Symptomkontrolle • Psychische Unterstützung, Edukation
Evaluation	Symptome/Nebenwirkungen kontrolliert, Patient unterstützt.

Chemotherapie – Nebenwirkungsmanagement Z51.1

Pflegerische Begleitung der zytostatischen Therapie mit Fokus auf Erkennung und Management typischer Nebenwirkungen sowie sicheren Umgang.

SYMPTOME

- Übelkeit/Erbrechen
- Knochenmarkdepression (Anämie, Infekt-, Blutungsneigung)
- Mukositis (Mundschleimhautentzündung)
- Haarausfall, Fatigue
- Haut-/Schleimhaut- und Magen-Darm-Probleme

DIAGNOSTIK

- Blutbild/Laborkontrollen nach AO
- Auf Fieber/Infektzeichen achten (febrile Neutropenie!)
- Mundschleimhaut/Haut beurteilen
- Übelkeit/Ernährung/Gewicht erfassen

THERAPIE

- Antiemese nach AO
- Infektprophylaxe/-therapie, Transfusionen nach AO
- Mundpflege/Mukositis-Prophylaxe
- Hautschutz, Ernährungsunterstützung
- Sicherer Umgang mit Zytostatika (Schutz, Extravasation vermeiden)

Pflegeproblem	Gefahr von Komplikationen r/t Chemotherapie-Nebenwirkungen m/d/s Übelkeit, Knochenmarkdepression, Mukositis
Ressourcen	Patient kooperativ, Behandlung strukturiert
Pflegeziel	Nebenwirkungen sind gelindert; Komplikationen (Infekt/Blutung) werden früh erkannt
Maßnahmen	• Antiemese nach AO, Übelkeit/Ernährung managen • Blutbild beachten, Infektionsprophylaxe, Fieber als Notfall behandeln • Mundpflege (Mukositisprophylaxe), Hautschutz • Fatigue-Management • Sicherer Umgang/Applikation, Extravasation beobachten, Edukation
Evaluation	Nebenwirkungen gelindert, Komplikationen früh erkannt, Therapie sicher.

Tumorschmerz (WHO-Stufenschema) R52

Schmerz bei Tumorerkrankungen, häufig chronisch. Behandlung nach WHO-Stufenschema; Ziel ist eine möglichst weitgehende Schmerzfreiheit.

SYMPTOME

- Anhaltender/wiederkehrender Schmerz
- Durchbruchschmerzen
- Beeinträchtigung von Schlaf/Alltag/Stimmung
- Bewegungs-/belastungsabhängiger Schmerz
- Begleitend Angst/Erschöpfung

DIAGNOSTIK

- Systematische Schmerzerfassung (Skala, Lokalisation, Charakter)
- Schmerzverlauf/-tagebuch
- Wirkung/Nebenwirkung der Therapie beurteilen
- Auf Durchbruchschmerz achten

THERAPIE

- WHO-Stufenschema (Nicht-Opioide → schwache → starke Opioide) nach AO
- Feste Basismedikation + Bedarfsmedikation (Durchbruchschmerz)
- Begleitmedikation (Koanalgetika) nach AO
- Nicht-medikamentös (Lagerung, Wärme/Kälte, Entspannung)
- Nebenwirkungsmanagement (z. B. Obstipationsprophylaxe bei Opioiden)

Pflegeproblem	Chronischer Schmerz r/t Tumorerkrankung m/d/s anhaltendem Schmerz, Durchbruchschmerzen
Ressourcen	Patient kooperativ, Schmerztherapie etabliert
Pflegeziel	Der Patient ist weitgehend schmerzgelindert (NRS ≤ 3) und kann am Alltag teilnehmen
Maßnahmen	• Schmerz regelmäßig erfassen (Skala) und dokumentieren • Basis-/Bedarfsmedikation nach AO, Wirkung kontrollieren • Opioid-Nebenwirkungen managen (Obstipationsprophylaxe, Übelkeit) • Nicht-medikamentöse Maßnahmen anbieten • Edukation und psychische Unterstützung
Evaluation	Schmerz weitgehend gelindert, Teilhabe verbessert, Nebenwirkungen beherrscht.

Febrile Neutropenie D70

Fieber bei stark verminderten neutrophilen Granulozyten (meist nach Chemotherapie) – ein onkologischer Notfall mit hoher Infektions-/Sepsisgefahr.

SYMPTOME

- Fieber bei bekannter/erwarteter Neutropenie
- Schüttelfrost, Krankheitsgefühl
- Oft wenig lokale Entzündungszeichen (durch Zellmangel)
- Mögliche rasche Verschlechterung (Sepsis)
- Kreislaufzeichen bei Sepsis

DIAGNOSTIK

- Temperatur + Blutbild (Neutropenie)
- Blutkulturen/Fokussuche nach AO
- Vitalzeichen, Sepsiszeichen
- Rasche ärztliche Einschätzung

THERAPIE

- Sofortige (kalkulierte) Antibiotikatherapie nach AO – nicht verzögern!
- Blutkulturen vor Antibiose nach AO
- Kreislaufüberwachung/-stabilisierung
- Strenge Infektionsprophylaxe/ Isolation
- Intensiv bei Sepsis

Pflegeproblem	Hohe Infektions-/Sepsisgefahr r/t febriler Neutropenie m/d/s Fieber bei Neutropenie
Ressourcen	Stationäre/rasche Versorgung, Frühzeitige Behandlung
Pflegeziel	Die Infektion wird zeitgerecht behandelt; der Patient bleibt kreislaufstabil (keine unerkannte Sepsis)
Maßnahmen	• Fieber als Notfall behandeln, sofort Arzt, Antibiose zeitgerecht nach AO • Blutkulturen/Diagnostik nach AO unterstützen • Vitalzeichen engmaschig, auf Sepsiszeichen achten • Strenge Hygiene/Schutzisolation • Edukation (Fieber sofort melden)
Evaluation	Antibiose zeitgerecht, kreislaufstabil, keine unerkannte Sepsis.

Portkatheter (Port) – Pflege Z45.2

Dauerhaft implantierter venöser Zugang (Portkammer unter der Haut) für Chemotherapie, Infusionen und Blutentnahmen. Pflegerischer Fokus: aseptische Handhabung und Komplikationsprävention.

SYMPTOME

- Implantierte Portkammer (meist subklavikulär tastbar)
- Nutzung nur mit Spezialnadel (Huber-Nadel)
- Risiken: Infektion, Thrombose, Diskonnektion, Paravasat
- Mögliche lokale Rötung/ Schwellung bei Komplikation
- Funktionsstörung (kein Rückfluss)

DIAGNOSTIK

- Punktionsstelle auf Infektion/ Entzündung beurteilen
- Durchgängigkeit/Rückfluss prüfen
- Auf Paravasat/Schwellung achten
- Hygiene-/Lagekontrolle

THERAPIE

- Aseptische Punktion mit Huber-Nadel, sterile Technik
- Spülung/Blockung nach Standard/ AO
- Bei Infektion/Komplikation Behandlung nach AO
- Korrekte Fixierung/Verband
- Nur geschultes Personal

Pflegeproblem	Infektions-/Komplikationsgefahr r/t implantiertem Portkatheter m/d/s zentralvenösem Zugang, Punktionen
Ressourcen	Geschultes Personal, Patient kooperativ
Pflegeziel	Der Port bleibt infektfrei und funktionsfähig; Komplikationen werden früh erkannt
Maßnahmen	• Streng aseptisch arbeiten, nur Huber-Nadel verwenden • Punktionsstelle auf Infektzeichen beobachten, steriler Verband • Durchgängigkeit prüfen, Spülung/Blockung nach Standard/AO • Auf Paravasat/Thrombose achten • Patientenedukation, Dokumentation
Evaluation	Port infektfrei und funktionsfähig, keine Komplikation.

Pädiatrie

10 Krankheitsbilder

Pseudokrupp (Laryngitis subglottica) J05.0

Virale Entzündung im subglottischen Larynxbereich mit Schleimhautschwellung. Typisch nachts bei Kleinkindern (6 Mon.–3 J.), meist selbstlimitierend.

SYMPTOME

- Bellender Husten
- Heiserkeit
- Inspiratorischer Stridor
- Einziehungen/Atemnot bei Schwere
- Meist nur subfebril
- Verschlechterung nachts und bei Aufregung

DIAGNOSTIK

- Klinische Diagnose (Anamnese, Auskultation)
- Schweregrad: Stridor in Ruhe? Einziehungen?
- SpO_2
- Keine routinemäßige Racheninspektion (cave Epiglottitis)

THERAPIE

- Ruhe, Kind aufrecht bei der Bezugsperson
- Kühle, feuchte Luft
- Glukokortikoid (z. B. Dexamethason/Prednisolon)
- Bei schwerem Stridor: vernebeltes Adrenalin
- O_2 bei Hypoxie
- Stationär bei Stridor in Ruhe/ Erschöpfung

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Atmung r/t subglottischer Schleimhautschwellung m/d/s inspiratorischem Stridor, Einziehungen, Unruhe
Ressourcen	Eltern anwesend und beruhigend, Kind auf dem Arm der Eltern ruhig, Kooperative Familie
Pflegeziel	Kind atmet innerhalb von 2 h ruhiger, kein Stridor in Ruhe, $SpO_2 \geq 94$ %
Maßnahmen	• Kind aufrecht bei der Bezugsperson belassen, nicht aufregen • Kühle, feuchte Luft anbieten • Steroid und ggf. vernebeltes Adrenalin nach AO • SpO_2/Atemarbeit engmaschig, nach Adrenalin Rebound beobachten • Keine Racheninspektion ohne ärztliche Indikation
Evaluation	Stridor und Einziehungen rückläufig, SpO_2 stabil, Kind ruhig.

Bronchiolitis (RSV) J21.0

Meist durch RSV ausgelöste Entzündung der kleinen Atemwege bei Säuglingen (< 1–2 J.) mit obstruktiver Atemnot. Häufigste untere Atemwegsinfektion im 1. Lebensjahr.

SYMPTOME

- Vorausgehender Schnupfen
- Tachypnoe, Nasenflügeln
- Einziehungen
- Exspiratorisches Giemen/ feinblasige RGs
- Trinkschwäche
- Apnoen bei jungen Säuglingen

DIAGNOSTIK

- Klinische Diagnose
- SpO_2 und Atemfrequenz
- RSV-Schnelltest (optional)
- Beobachtung von Trinkverhalten/ Hydratation
- Röntgen nur bei Komplikationsverdacht

THERAPIE

- Atemwege freihalten (Nase absaugen)
- O_2 titriert (Zielsättigung)
- Flüssigkeitszufuhr sichern (kleine Mengen/Sonde/i.v.)
- Ggf. High-Flow/CPAP
- Monitoring (Apnoe!)
- Antibiotika nur bei bakterieller Superinfektion

Pflegeproblem	Ineffektive Atemwegsclearance r/t Sekretobstruktion der kleinen Atemwege m/d/s Giemen, Einziehungen, SpO_2-Abfall
Ressourcen	Eltern unterstützen die Pflege, Kind trinkt in kleinen Mengen, Zu Beginn stabiler Allgemeinzustand
Pflegeziel	Säugling zeigt innerhalb von 24 h freie Atemwege, SpO_2 im Zielbereich, keine Apnoen
Maßnahmen	• Nase regelmäßig absaugen/freihalten • Oberkörper leicht erhöht lagern • O_2 nach AO titrieren, SpO_2 kontinuierlich • Apnoe-Monitoring beim jungen Säugling • Trinkmenge sichern (kleine Mengen/Sonde nach AO), Aspiration vermeiden
Evaluation	Atemarbeit reduziert, SpO_2 stabil, keine Apnoen, ausreichende Trinkmenge.

Asthma bronchiale (im Kindesalter) J45

Chronisch-entzündliche Atemwegserkrankung mit variabler, reversibler Obstruktion und bronchialer Hyperreagibilität; anfallsartige Atemnot.

SYMPTOME

- Anfallsartige Atemnot
- Exspiratorisches Giemen, verlängertes Exspirium
- Trockener Husten (oft nachts)
- Engegefühl in der Brust
- Bei schwerem Anfall: Sprechdyspnoe, Einziehungen, Tachykardie

DIAGNOSTIK

- Anamnese (Trigger, Atopie)
- Auskultation (Giemen)
- Peak-Flow/Spirometrie (ältere Kinder)
- SpO_2
- Reversibilität nach Bronchodilatator

THERAPIE

- Anfall: inhalative kurzwirksame Beta-2-Mimetika (SABA)
- Systemische Steroide bei mittlerem/schwerem Anfall
- O_2 bei Hypoxie
- Dauertherapie: inhalative Steroide (ICS)
- Trigger meiden, Schulung

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Atmung r/t bronchialer Obstruktion m/d/s Giemen, verlängertem Exspirium, Dyspnoe
Ressourcen	Kind kennt seine Inhalation, Eltern unterstützend, Bekannte Trigger
Pflegeziel	Kind atmet innerhalb von 1 h ruhiger, Giemen rückläufig, $SpO_2 \geq 94$ %
Maßnahmen	• Atemerleichternde Lagerung (Kutschersitz), Ruhe • Inhalative Bronchodilatatoren nach AO mit Spacer • SpO_2/Atemfrequenz/Atemarbeit engmaschig • Steroide nach AO bei mittlerem/schwerem Anfall • Kind und Eltern anleiten, Trigger meiden
Evaluation	Dyspnoe und Giemen rückläufig, SpO_2 stabil, Kind ruhig.

Akute Gastroenteritis mit Exsikkose A09

Meist virale (z. B. Rota-/Norovirus) Entzündung des Magen-Darm-Trakts mit Erbrechen/Durchfall. Bei Kleinkindern besteht rasche Dehydratationsgefahr.

SYMPTOME

- Erbrechen, wässrige Durchfälle
- Bauchschmerzen
- Eingesunkene Augen, trockene Schleimhäute
- Verlängerte Rekap-Zeit, reduzierter Hautturgor
- Verminderte Urinausscheidung
- Lethargie bei Schwere

DIAGNOSTIK

- Klinische Einschätzung des Dehydratationsgrades
- Gewichtsverlauf
- Vitalzeichen, Rekap-Zeit
- Bei Schwere: Elektrolyte, BZ
- Stuhldiagnostik nur bei Indikation

THERAPIE

- Orale Rehydratationslösung (ORS) in kleinen Mengen
- Bei schwerer Dehydratation/ Schock: i.v.-Rehydratation
- Frühe Wiederernährung
- Keine Motilitätshemmer bei Kleinkindern
- Hygiene/Isolation (Übertragung)

Pflegeproblem	Flüssigkeitsdefizit r/t Erbrechen und Durchfall m/d/s trockenen Schleimhäuten, verlängerter Rekap-Zeit, verminderter Urinausscheidung
Ressourcen	Kind nimmt kleine Mengen ORS an, Eltern beteiligen sich an der Pflege, Frühzeitige Vorstellung
Pflegeziel	Kind ist innerhalb von 24 h ausreichend hydriert (feuchte Schleimhäute, Rekap < 2 s, ausreichende Urinmenge)
Maßnahmen	• ORS in kleinen Mengen sehr häufig anbieten • Ein-/Ausfuhr und Gewicht dokumentieren • Vitalzeichen/Rekap-Zeit/Bewusstsein überwachen • Bei Versagen/Schockzeichen i.v.-Rehydratation nach AO • Hygiene/Isolation, Hautschutz im Windelbereich
Evaluation	Hydratationszeichen verbessert, Trink- und Urinmenge ausreichend, Gewicht stabilisiert.

Fieberkrampf R56.0

Mit Fieber assoziierter zerebraler Krampfanfall bei Kindern (meist 6 Mon.–5 J.) ohne ZNS-Infektion. Einfacher (kurz, generalisiert) vs. komplizierter Fieberkrampf.

SYMPTOME

- Generalisierter tonisch-klonischer Anfall im Fieber
- Bewusstseinsverlust
- Postiktale Schläfrigkeit
- Meist < 5 min (einfacher Fieberkrampf)
- Komplizierter: > 15 min, fokal oder wiederholt

DIAGNOSTIK

- Klinische Diagnose + Anamnese
- Meningitis/Enzephalitis ausschließen (Nackensteife, Petechien, Vigilanz!)
- Temperatur und Fokussuche
- Bei kompliziertem Krampf weiterführende Abklärung
- BZ bei Bewusstseinsstörung

THERAPIE

- Schützen, nichts in den Mund, Dauer messen
- Bei > 5 min: Benzodiazepin nach Notfallschema
- Fokus des Fiebers behandeln
- Aufklärung der Eltern (gute Prognose beim einfachen Fieberkrampf)

Pflegeproblem	Verletzungsgefahr r/t generalisiertem Krampfanfall m/d/s unkontrollierten Bewegungen und Bewusstseinsverlust
Ressourcen	Eltern anwesend, Rasche Reaktion des Teams, Kind zwischen den Anfällen stabil
Pflegeziel	Kind erleidet während und nach dem Anfall keine Verletzung; der Atemweg bleibt frei
Maßnahmen	• Umgebung sichern, vor Verletzung schützen, nichts in den Mund • Seitenlage, Atemweg/SpO_2 beobachten, Anfallsdauer messen • Bei > 5 min Medikation nach Notfallschema/AO • Postiktal Seitenlage und Vitalzeichen, Meningitis-Zeichen beobachten • Eltern beruhigen und über den Fieberkrampf aufklären
Evaluation	Keine Verletzung, Atemweg frei, Anfall sistiert, Eltern informiert.

Otitis media acuta H66.0

Akute Mittelohrentzündung (viral/bakteriell), häufig bei Kleinkindern nach Atemwegsinfekt. Meist selbstlimitierend.

SYMPTOME

- Ohrenschmerzen (Säuglinge: Greifen ans Ohr, Schreien)
- Fieber
- Hörminderung
- Unruhe/Schlafstörung
- Ggf. Ohrenfluss bei Trommelfellperforation

DIAGNOSTIK

- Otoskopie (gerötetes/vorgewölbtes Trommelfell)
- Anamnese
- Temperatur
- Hörprüfung bei Rezidiven

THERAPIE

- Analgesie/Antipyrese (Ibuprofen/Paracetamol)
- Abschwellende Maßnahmen
- Antibiotikum nach Indikation (Alter/Schwere)
- Abwartendes Offenhalten möglich
- HNO-Vorstellung bei Rezidiven

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t Mittelohrentzündung m/d/s Greifen ans Ohr, Schreien, Unruhe
Ressourcen	Eltern unterstützend, Kind nimmt Medikamente an
Pflegeziel	Kind ist innerhalb von 24 h schmerzarm (altersgerechte Einschätzung) und schläft ruhiger
Maßnahmen	• Analgesie/Antipyrese nach AO geben und Wirkung kontrollieren • Kopf leicht erhöht lagern, Wärme anbieten • Ohr auf Sekretaustritt beobachten • Eltern zur Medikamentengabe und zu Warnzeichen anleiten • Ausreichend Flüssigkeit anbieten
Evaluation	Schmerz reduziert, Kind ruhiger, kein Hinweis auf Komplikation.

Pertussis (Keuchhusten) A37

Hochansteckende bakterielle Atemwegsinfektion (Bordetella pertussis) mit stakkatoartigen Hustenanfällen. Für junge Säuglinge gefährlich (Apnoen).

SYMPTOME

- Stakkatoartige Hustenanfälle mit inspiratorischem Ziehen
- Hustenattacken bis zum Erbrechen
- Zyanose/Apnoen (Säuglinge!)
- Wochenlang anhaltender Husten
- Anfangs erkältungsähnlich

DIAGNOSTIK

- Klinik + Anamnese (Impfstatus, Kontakt)
- Erregernachweis (PCR/Abstrich)
- Beobachtung der Hustenanfälle/ Apnoen
- SpO_2

THERAPIE

- Antibiotikum (Makrolid), v. a. früh/ zum Schutz
- Stationär bei jungen Säuglingen (Apnoe-Monitoring)
- O_2/Atemunterstützung bei Bedarf
- Isolation (hochansteckend)
- Impfung/Umgebungsprophylaxe

Pflegeproblem	Ineffektive Atmung r/t paroxysmalen Hustenanfällen m/d/s Apnoen, Zyanose, Erschöpfung
Ressourcen	Eltern anwesend, Stationäre Überwachung möglich
Pflegeziel	Säugling zeigt während der Überwachung keine unbehandelten Apnoen, SpO_2 im Zielbereich
Maßnahmen	• Kontinuierliches Apnoe-/SpO_2-Monitoring • Hustenanfälle begleiten, beruhigen, O_2 nach AO • Kleine, häufige Mahlzeiten wegen Erbrechen • Isolation und konsequente Hygiene • Antibiotikum nach AO, Eltern zu Impfung/Prophylaxe beraten
Evaluation	Apnoen erkannt und behandelt, SpO_2 stabil, ausreichende Nahrungsaufnahme.

Pneumonie im Kindesalter J18

Akute Entzündung des Lungenparenchyms (viral/bakteriell) mit Husten, Fieber und Atemnot; bei Kindern häufige stationäre Ursache.

SYMPTOME

- Fieber, Husten
- Tachypnoe, Nasenflügeln, Einziehungen
- Knisterrasseln/abgeschwächtes Atemgeräusch
- Trinkschwäche, Abgeschlagenheit
- Ggf. Bauch-/Flankenschmerz

DIAGNOSTIK

- Klinik + Auskultation
- SpO_2, Atemfrequenz
- Röntgen Thorax bei Indikation
- Entzündungswerte bei Bedarf
- Erregerdiagnostik nach Indikation

THERAPIE

- O_2 bei Hypoxie
- Antibiotikum bei bakterieller Genese nach AO
- Antipyrese, ausreichende Flüssigkeit
- Sekretmanagement/Lagerung
- Stationär bei Atemnot/ Trinkschwäche

Pflegeproblem	Beeinträchtigter Gasaustausch r/t Lungenparenchymentzündung m/d/s Tachypnoe, Einziehungen, SpO_2-Abfall
Ressourcen	Eltern unterstützend, Kind kooperiert bei Inhalation
Pflegeziel	Kind zeigt innerhalb von 48 h $SpO_2 \geq 94$ % und eine reduzierte Atemarbeit
Maßnahmen	• O_2 nach AO, SpO_2 kontinuierlich • Oberkörper erhöht, Sekretmanagement • Antipyrese und ausreichende Flüssigkeit nach AO • Atemfrequenz/Atemarbeit dokumentieren • Antibiotikum nach AO, Eltern einbeziehen
Evaluation	SpO_2 stabil, Atemarbeit reduziert, Fieber rückläufig.

Harnwegsinfekt / Pyelonephritis (Kind) N10

Bakterielle Harnwegsinfektion; bei Kindern auch fieberhaft als Pyelonephritis. Bei Säuglingen oft unspezifisch (Fieber, Trinkschwäche).

SYMPTOME

- Fieber (oft einziges Zeichen beim Säugling)
- Dysurie/Pollakisurie (ältere Kinder)
- Bauch-/Flankenschmerz
- Übelriechender Urin
- Trinkschwäche/Gedeihstörung
- Reizbarkeit

DIAGNOSTIK

- Urinstatus/-kultur (sachgerechte Gewinnung!)
- Entzündungswerte
- Sonografie der Harnwege
- Temperatur
- Bei Rezidiven weiterführende Abklärung

THERAPIE

- Antibiotikum nach AO/ Antibiogramm
- Ausreichende Flüssigkeit
- Antipyrese/Analgesie
- Bei fieberhafter Pyelonephritis ggf. stationär
- Abklärung anatomischer Ursachen (Reflux)

Pflegeproblem	Erhöhte Körpertemperatur r/t Harnwegsinfektion m/d/s Fieber, Reizbarkeit, Trinkschwäche
Ressourcen	Eltern unterstützend, Kind trinkt mit Anleitung
Pflegeziel	Kind ist innerhalb von 48 h fieberfrei und trinkt ausreichend
Maßnahmen	• Temperatur überwachen, Antipyrese nach AO • Sachgerechte Uringewinnung, Ein-/Ausfuhr • Trinkmenge fördern und dokumentieren • Antibiotikum nach AO, Wirkung beobachten • Intimhygiene anleiten, Eltern zur Prophylaxe beraten
Evaluation	Fieber rückläufig, ausreichende Trink-/Urinmenge, Wohlbefinden gebessert.

Invagination (Darmeinstülpung) K56.1

Einstülpung eines Darmabschnitts in den folgenden, v. a. bei Säuglingen/Kleinkindern. Akuter Notfall mit Ileus-/ Ischämiegefahr.

SYMPTOME

- Plötzliche kolikartige Bauchschmerzen (anfallsweise Schreien, Anziehen der Beine)
- Schmerzfreie Intervalle
- Erbrechen
- Himbeergeleeartiger (blutig-schleimiger) Stuhl
- Tastbare walzenförmige Resistenz
- Zunehmende Apathie

DIAGNOSTIK

- Klinik + Anamnese
- Abdomen-Sonografie (Kokarde/ Target-Zeichen)
- Vitalzeichen
- Ausschluss Ileus/Peritonitis

THERAPIE

- Nüchtern, i.v.-Zugang/Volumen
- Sonografisch gesteuerte hydrostatische/pneumatische Reposition
- Bei Versagen/Peritonitis operative Versorgung
- Monitoring, Analgesie nach AO

Pflegeproblem	Akuter Schmerz und Komplikationsgefahr r/t Darmeinstülpung m/d/s anfallsartigem Schreien, Erbrechen, blutigem Stuhl
Ressourcen	Eltern anwesend, Frühzeitige Vorstellung, Stationäre Versorgung
Pflegeziel	Kind ist nüchtern und kreislaufstabil; eine drohende Verschlechterung wird früh erkannt
Maßnahmen	• Nüchtern lassen, i.v.-Zugang/Volumen nach AO • Vitalzeichen, Schmerz und Bauchbefund engmaschig • Stuhl und Erbrechen beobachten/dokumentieren • Repositions-/OP-Vorbereitung nach AO • Eltern begleiten und aufklären
Evaluation	Kreislaufstabil, Schmerz kontrolliert, Reposition/OP erfolgreich, keine Peritonitiszeichen.

Orthopädie

10 Krankheitsbilder

Schenkelhalsfraktur (proximale Femurfraktur) S72.0

Bruch des proximalen Oberschenkels, häufig bei älteren Menschen nach Sturz (Osteoporose). Hohe Bedeutung wegen Immobilität und Komplikationen.

SYMPTOME

- Schmerzhafte Bewegungseinschränkung der Hüfte
- Bein verkürzt und außenrotiert
- Belastungsunfähigkeit
- Schwellung/Hämatom
- Sturzanamnese

DIAGNOSTIK

- Röntgen Hüfte/Becken
- Klinische Untersuchung
- Labor/EKG (OP-Vorbereitung)
- Begleitverletzungen ausschließen

THERAPIE

- Meist operativ (Osteosynthese oder Endoprothese)
- Frühmobilisation
- Analgesie
- Thrombose-/Pneumonie-/Dekubitusprophylaxe
- Osteoporose-Abklärung

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Mobilität r/t proximaler Femurfraktur und postoperativem Zustand m/d/s Schmerz, Belastungseinschränkung
Ressourcen	Motiviert mitzuarbeiten, Angehörige unterstützen, Vor Sturz selbstständig mobil
Pflegeziel	Patient mobilisiert in den ersten postoperativen Tagen nach AO schmerzarm (NRS ≤ 3) mit Hilfsmittel
Maßnahmen	• Schmerzmanagement nach AO, vor Mobilisation analgetisch abdecken • Frühmobilisation nach ärztlicher Freigabe, Physiotherapie einbeziehen • Thrombose-, Pneumonie- und Dekubitusprophylaxe konsequent • Durchblutung/Sensomotorik/Wundkontrolle dokumentieren • Sturzprophylaxe, Hilfsmittel bereitstellen
Evaluation	Schmerzarme Mobilisation gelingt, keine prophylaxeassoziierten Komplikationen.

Distale Radiusfraktur S52.5

Häufigste Fraktur des Erwachsenen, meist Sturz auf die ausgestreckte Hand. Versorgung konservativ (Gips) oder operativ (Platte).

SYMPTOME

- Schmerz/Schwellung am Handgelenk
- Fehlstellung (z. B. Gabel-/Bajonettstellung)
- Bewegungs-/Belastungseinschränkung
- Hämatom
- Ggf. Sensibilitätsstörung (N. medianus)

DIAGNOSTIK

- Röntgen Handgelenk in 2 Ebenen
- Durchblutung/Motorik/Sensibilität (DMS) prüfen
- Klinische Untersuchung

THERAPIE

- Reposition + Gips (konservativ) oder Osteosynthese
- Analgesie
- Hochlagerung, Schwellungskontrolle
- Frühfunktionelle Übungsbehandlung
- Gips-/Verbandkontrolle

Pflegeproblem	Gefahr peripherer neurovaskulärer Beeinträchtigung r/t Fraktur und Gipsverband m/d/s Schwellung, möglicher Einengung
Ressourcen	Patient kooperativ, Versteht die Anleitung
Pflegeziel	Durchblutung, Motorik und Sensibilität der Hand bleiben während des Aufenthalts intakt
Maßnahmen	• Hand konsequent hochlagern, Schwellung beobachten • DMS-Kontrolle regelmäßig dokumentieren • Gips/Verband auf Einengung prüfen, bei Zeichen sofort Arzt • Schmerzmanagement nach AO • Zu Fingerbewegungen und Selbstpflege anleiten
Evaluation	DMS intakt, keine Einengungszeichen, Schwellung rückläufig.

Koxarthrose (Hüftarthrose) M16

Degenerativer Verschleiß des Hüftgelenks mit Knorpelabbau, Schmerz und Bewegungseinschränkung. Endstadium: Hüft-Endoprothese (TEP).

SYMPTOME

- Belastungs-/Anlaufschmerz in Hüfte/Leiste
- Bewegungseinschränkung (v. a. Innenrotation)
- Hinken
- Schmerzausstrahlung bis ins Knie
- Zunehmende Verkürzung der Gehstrecke

DIAGNOSTIK

- Röntgen Hüfte (Gelenkspaltverschmälerung, Osteophyten)
- Klinische Funktionsprüfung
- Anamnese, Schmerzverlauf

THERAPIE

- Konservativ: Bewegung, Physiotherapie, Gewichtsreduktion, Analgesie
- Gelenkerhaltende Maßnahmen
- Hüft-Endoprothese (TEP) im Endstadium
- Postoperativ Mobilisation + Prophylaxen

Pflegeproblem	Chronischer Schmerz und beeinträchtigte Mobilität r/t Hüftarthrose (bzw. postoperativ nach TEP) m/d/s Belastungsschmerz, Bewegungseinschränkung
Ressourcen	Motiviert, Angehörige unterstützen, Versteht Bewegungsregeln
Pflegeziel	Patient bewegt sich schmerzarm (NRS ≤ 3) und hält nach TEP die Luxationsprophylaxe ein
Maßnahmen	• Schmerzmanagement nach AO, vor Mobilisation abdecken • Nach TEP Luxationsprophylaxe anleiten und überwachen • Frühmobilisation/Physiotherapie, Hilfsmittel schulen • Thrombose-/Pneumonie-/Dekubitusprophylaxe • Selbstständigkeit im Alltag fördern
Evaluation	Schmerzarme Mobilisation, Bewegungsregeln eingehalten, keine Komplikationen.

Gonarthrose (Kniearthrose) M17

Degenerativer Verschleiß des Kniegelenks mit Schmerz, Schwellung und Funktionsverlust. Endstadium: Knie-Endoprothese.

SYMPTOME

- Belastungs-/Anlaufschmerz im Knie
- Schwellung, Krepitation
- Bewegungseinschränkung
- Achsfehlstellung (O-/X-Bein)
- Verkürzung der Gehstrecke

DIAGNOSTIK

- Röntgen Knie (Gelenkspalt, Osteophyten)
- Klinische Funktionsprüfung
- Ggf. MRT bei Begleitschäden

THERAPIE

- Konservativ: Physiotherapie, Gewichtsreduktion, Analgesie
- Knie-Endoprothese im Endstadium
- Postoperativ: Mobilisation, Beweglichkeit (CPM-Schiene nach AO)
- Prophylaxen

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Mobilität r/t Kniearthrose (bzw. postoperativ nach Knie-TEP) m/d/s Schmerz, Schwellung, Bewegungseinschränkung
Ressourcen	Motiviert mitzuarbeiten, Physiotherapie verfügbar
Pflegeziel	Patient erreicht nach AO eine schmerzarme Mobilisation und zunehmende Kniebeweglichkeit
Maßnahmen	• Schmerz-/Schwellungsmanagement (Kühlung nach AO) • Frühmobilisation und Beweglichkeitsübungen nach AO • Thrombose-/Pneumonie-/Dekubitusprophylaxe • DMS- und Wundkontrolle dokumentieren • Gehschulung, Hilfsmittel bereitstellen
Evaluation	Zunehmende Beweglichkeit, schmerzarme Mobilisation, keine Komplikationen.

Lumbaler Bandscheibenvorfall M51.1

Verlagerung von Bandscheibengewebe mit möglicher Nervenwurzelkompression, meist lumbal (L4/5, L5/S1). Schmerz mit Ausstrahlung ins Bein.

SYMPTOME

- Rückenschmerz mit Ausstrahlung ins Bein (Ischialgie)
- Sensibilitätsstörungen/Kribbeln im Dermatom
- Kraftminderung
- Schmerzverstärkung bei Husten/Pressen
- Red Flags: Blasen-/Mastdarmstörung, Reithosenanästhesie

DIAGNOSTIK

- Neurologische Untersuchung (Kraft, Reflexe, Sensibilität)
- MRT der LWS
- Anamnese (Red Flags!)

THERAPIE

- Meist konservativ: Analgesie, Bewegung, Physiotherapie
- Entlastende Lagerung (z. B. Stufenbett)
- Operative Versorgung bei Lähmung/Kaudasyndrom (Notfall!)
- Rückenschule

Pflegeproblem	Akuter Schmerz und Gefahr neurologischer Ausfälle r/t Nervenwurzelkompression m/d/s ausstrahlendem Schmerz, Sensibilitätsstörung
Ressourcen	Patient kooperativ, Versteht rückenschonendes Verhalten
Pflegeziel	Patient ist schmerzarm (NRS ≤ 3); neue neurologische Ausfälle werden früh erkannt
Maßnahmen	• Schmerzmanagement nach AO, entlastende Lagerung (z. B. Stufenbett) • Neurologische Kontrolle (Kraft/Sensibilität, Blase/Mastdarm) dokumentieren • Mobilisation nach AO, rückengerechtes Verhalten anleiten • Bei Red Flags (Reithosenanästhesie/Blasenstörung) sofort Arzt • Sturz-/Dekubitusprophylaxe bei Immobilität
Evaluation	Schmerz reduziert, keine neuen Ausfälle, Mobilisation gelingt.

Osteoporose M81

Systemische Skeletterkrankung mit verminderter Knochendichte und erhöhter Frakturgefahr (typisch: Wirbelkörper, Hüfte, Radius). Häufig postmenopausal/altersbedingt.

SYMPTOME

- Oft lange asymptomatisch
- Frakturen bei geringem Trauma
- Rückenschmerzen, Größenabnahme
- Rundrücken (Hyperkyphose)
- Bewegungsangst/Immobilität

DIAGNOSTIK

- Knochendichtemessung (DXA, T-Wert)
- Röntgen (Wirbelkörperfrakturen)
- Labor (Kalzium, Vitamin D)
- Sturz-/Frakturrisiko erfassen

THERAPIE

- Kalzium + Vitamin D
- Antiresorptiva/Osteoanabolika nach AO
- Bewegung/Krafttraining
- Sturzprophylaxe
- Ernährungsberatung, Nikotin-/Alkoholkarenz

Pflegeproblem	Gefahr von Stürzen und Frakturen r/t verminderter Knochendichte m/d/s Frakturanamnese, Bewegungsunsicherheit
Ressourcen	Motiviert, Angehörige unterstützen, Selbstständig mobil
Pflegeziel	Patient erleidet während des Aufenthalts keinen Sturz/keine Fraktur und kennt Prophylaxemaßnahmen
Maßnahmen	• Sturzrisiko erfassen, Umgebung sichern, Hilfsmittel bereitstellen • Bewegung/Krafttraining nach AO fördern • Medikamente (Kalzium/Vitamin D, Antiresorptiva) nach AO und Beratung • Schmerzmanagement bei Frakturen • Ernährungs-/Lebensstilberatung
Evaluation	Kein Sturz/keine Fraktur, Patient kennt und nutzt Prophylaxemaßnahmen.

Schulterluxation S43.0

Auskugelung des Schultergelenks (meist vordere Luxation), oft traumatisch. Gefahr von Gefäß-/Nervenschäden (N. axillaris).

SYMPTOME

- Starke Schmerzen, federnde Fixation
- Sichtbare Konturveränderung (leere Pfanne)
- Bewegungsunfähigkeit
- Ggf. Sensibilitätsstörung über dem Deltoid (N. axillaris)
- Schonhaltung

DIAGNOSTIK

- Röntgen vor und nach Reposition
- DMS prüfen (v. a. N. axillaris)
- Klinische Untersuchung

THERAPIE

- Rasche Reposition (ärztlich) + Analgesie/Sedierung
- Ruhigstellung (z. B. Gilchrist) nach AO
- Frühfunktionelle Nachbehandlung
- Bei Rezidiven operative Stabilisierung

Pflegeproblem	Akuter Schmerz und Gefahr neurovaskulärer Schädigung r/t Schulterluxation m/d/s federnder Fixation, möglicher Sensibilitätsstörung
Ressourcen	Patient kooperativ, Versteht die Anleitung
Pflegeziel	Patient ist schmerzarm; DMS bleibt intakt; die Ruhigstellung wird korrekt eingehalten
Maßnahmen	• DMS (insbesondere N. axillaris) vor/nach Reposition prüfen • Schmerzmanagement nach AO • Korrekte Ruhigstellung (z. B. Gilchrist) anleiten/kontrollieren • Bewegungsübungen nach AO • Hautpflege unter dem Verband
Evaluation	Schmerz reduziert, DMS intakt, Ruhigstellung korrekt.

Sprunggelenksfraktur (OSG) S82.6

Bruch im Bereich des oberen Sprunggelenks (Außen-/Innenknöchel), oft durch Umknicktrauma. Versorgung konservativ oder operativ.

SYMPTOME

- Schmerz/Schwellung am Knöchel
- Belastungsunfähigkeit
- Fehlstellung/Hämatom
- Bewegungsschmerz
- Druckschmerz über den Malleolen

DIAGNOSTIK

- Röntgen OSG in 2 Ebenen
- DMS prüfen
- Weichteil-/Hautbeurteilung (Spannungsblasen)

THERAPIE

- Konservativ (Gips/Orthese) oder Osteosynthese
- Hochlagerung, Schwellungs-/Weichteilmanagement
- Thromboseprophylaxe bei Immobilisation
- Teilbelastung nach AO
- Physiotherapie

Pflegeproblem	Gefahr peripherer neurovaskulärer Beeinträchtigung und Thrombose r/t Fraktur, Schwellung und Immobilisation m/d/s Schwellung, eingeschränkter Belastung
Ressourcen	Patient kooperativ, Versteht die Teilbelastung
Pflegeziel	DMS bleibt intakt, keine Thrombosezeichen, die Teilbelastung wird korrekt eingehalten
Maßnahmen	• Bein hochlagern, Schwellung/Weichteile (Spannungsblasen) beobachten • DMS-Kontrolle und Gips/Orthese auf Einengung prüfen • Thromboseprophylaxe nach AO • Mobilisation und Teilbelastung anleiten • Schmerzmanagement nach AO
Evaluation	DMS intakt, keine Thrombosezeichen, korrekte Teilbelastung.

Achillessehnenruptur S86.0

Riss der Achillessehne, oft bei sportlicher Belastung. Typisch: plötzlicher peitschenartiger Schmerz, eingeschränkte Plantarflexion.

SYMPTOME

- Plötzlicher peitschenartiger Schmerz an der Ferse
- Hörbares Schnalzen
- Kraftverlust beim Abstoßen, Zehenstand nicht möglich
- Tastbare Delle über der Sehne
- Positiver Thompson-Test (keine Plantarflexion bei Wadenkompression)

DIAGNOSTIK

- Klinik + Thompson-Test
- Sonografie/MRT
- Tastbefund (Delle)

THERAPIE

- Konservativ (Spezialschuh/Orthese in Spitzfußstellung) oder operativ
- Ruhigstellung, schrittweise Belastung nach AO
- Thromboseprophylaxe
- Physiotherapie
- Belastungsaufbau

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Mobilität und Thrombosegefahr r/t Achillessehnenruptur und Ruhigstellung m/d/s Belastungsunfähigkeit, Immobilisation
Ressourcen	Patient motiviert, Versteht die Belastungsregeln
Pflegeziel	Patient hält Ruhigstellung und Belastungsstufen ein; keine Thrombosezeichen
Maßnahmen	• Korrekte Ruhigstellung (Spitzfußstellung) kontrollieren • Thromboseprophylaxe nach AO • DMS-/Schwellungskontrolle dokumentieren • Mobilisation und Belastungsaufbau nach AO anleiten • Schmerzmanagement nach AO
Evaluation	Ruhigstellung/Belastung korrekt, keine Thrombosezeichen, zunehmende Mobilität.

Vordere Kreuzbandruptur S83.5

Riss des vorderen Kreuzbandes (VKB), meist Sportverletzung mit Distorsionstrauma. Führt zu Instabilität des Kniegelenks.

SYMPTOME

- Akutes Knietrauma mit Schmerz
- Hörbares Knacken
- Schwellung/Gelenkerguss (Hämarthros)
- Instabilitätsgefühl (Giving-way)
- Bewegungseinschränkung

DIAGNOSTIK

- Klinische Tests (Lachman-/Schubladentest)
- MRT des Knies
- Gelenkpunktion bei Erguss (Hämarthros)

THERAPIE

- Akut: PECH-Schema (Pause, Eis, Compression, Hochlagern)
- Konservativ (Muskelaufbau) oder operativ (Kreuzbandplastik)
- Postoperativ: Mobilisation, Beweglichkeit, Belastung nach AO
- Thromboseprophylaxe
- Physiotherapie

Pflegeproblem	Akuter Schmerz/Schwellung und beeinträchtigte Mobilität r/t Kreuzbandruptur (bzw. postoperativ) m/d/s Gelenkerguss, Instabilität
Ressourcen	Patient motiviert, Physiotherapie verfügbar
Pflegeziel	Schwellung und Schmerz sind rückläufig; Patient hält Belastungs-/Bewegungsvorgaben ein
Maßnahmen	• Akut PECH-Schema, Schwellung/Erguss beobachten • Schmerzmanagement nach AO • Postoperativ Mobilisation/Beweglichkeit, Orthese nach AO • Thromboseprophylaxe, DMS-Kontrolle • Belastungsaufbau/Physiotherapie anleiten
Evaluation	Schwellung/Schmerz rückläufig, Vorgaben eingehalten, zunehmende Stabilität.

Lösungen der Kontrollfragen

Herzinsuffizienz

1 B NYHA III = Symptome (Dyspnoe, Erschöpfung) bereits bei leichter körperlicher Belastung wie Treppensteigen. NYHA I = keine Symptome, NYHA IV = Ruhedyspnoe.

2 B Oberkörperhochlagerung 30-45°: senkt venösen Rückstrom → entlastet das Herz, verbessert Atemmechanik. Bei Schock: flach lagern!

3 B Tägliche Gewichtskontrolle (gleiche Zeit, leichte Kleidung) + Ein-/Ausfuhrbilanz: Gewichtszunahme >1kg/Tag = Warnsignal für Flüssigkeitsretention → Arzt informieren!

COPD

4 B COPD-Patienten mit chronischer Hyperkapnie haben einen hypoxischen Atemantrieb. Zu viel O_2 (SpO_2 > 92%) → Atemdepression → CO_2-Narkose. Ziel-SpO_2: 88-92%!

5 B Kutschersitz: Patient sitzt, lehnt sich nach vorne, stützt Arme auf Oberschenkeln oder Tisch. Fixiert Schultergürtel → Atemhilfsmuskulatur (Mm. scaleni, sternocleidomastoideus) kann effizienter arbeiten.

6 B Lippenbremse: durch locker aufeinanderliegende Lippen langsam ausatmen. Erzeugt leichten Gegendruck → verhindert Bronchiolenkollaps beim Emphysem → effektivere Entleerung der Lungen.

Diabetes mellitus Typ 2

7 B BZ < 70 mg/dl + Patient wach → 20g KH oral (4 Traubenzuckertäfelchen, 200ml Fruchtsaft). BZ-Kontrolle nach 15 Min. Bei Bewusstlosigkeit: Glukose 40% i.v. oder Glukagon i.m.

8 B Wärmflasche ist KONTRAINDIZIERT! Diabetische Neuropathie → kein Temperaturempfinden → Verbrennungsgefahr! Korrekte Fußpflege: tägliche Inspektion, keine Hitze, professionelle Fußpflege, Druckentlastung.

9 B HbA1c = glykiertes Hämoglobin: zeigt den durchschnittlichen BZ der letzten 8-12 Wochen. Ziel bei Diabetes meist < 7% (53 mmol/mol). Vorteil: nicht von Tageszeit/Mahlzeiten abhängig.

Schlaganfall (Apoplex)

10 B FAST = schnelle Schlaganfallerkennung: F=Face (hängt eine Gesichtshälfte?), A=Arms (kann Patient beide Arme heben?), S=Speech (ist Sprache undeutlich/fehlt?), T=Time (Uhrzeit notieren, sofort 112!).

11 B Bobath: betroffene Seite aktivieren, nicht kompensatorisch mit gesunder Seite arbeiten. Patient von betroffener Seite ansprechen, Lagerung auf beiden Seiten, alle Aktivitäten beidseitig durchführen. Fördert Neuroplastizität.

12 B Dysphagie = Schluckstörung, häufig nach Schlaganfall. Stille Aspiration (kein Husten!) besonders gefährlich → Aspirationspneumonie. Logopädie-Schluckdiagnostik, angepasste Kostform (IDDSI), Oberkörperhochlagerung beim Essen, niemals mit Strohhalm!

Hypertonie

13 B Hypertonie: ≥ 140/90 mmHg (gemessen mehrfach in Ruhe). Optimaler RR: < 120/80. Hochnormaler RR: 130-139/85-89. Hypertensive Krise: > 180/120 mmHg mit Symptomen → Notfall!

14 B Korrekte RR-Messung: 5 Min. Ruhe, sitzen, Arm auf Herzhöhe, keine Kleidung am Oberarm, korrekte Manschettengröße (zu klein → falscher Wert!), beide Arme vergleichen (Differenz > 10 mmHg = abklären).

15 B Hypertensive Krise: RR > 180/120 + Endorganschäden (Herz, Hirn, Niere) → Hypertensiver Notfall! Maßnahmen: Arzt sofort, Patient beruhigen (Stress erhöht RR), flache Lagerung, RR-Monitoring alle 5 Min., i.v.-Antihypertensiva nach Anordnung.

Postoperative Pflege

16 B Postoperative Standardprophylaxen: Thrombose (NMH, Kompressionsstrümpfe, Frühmobilisation), Pneumonie (Atemübungen, OK-Hochlagerung, Mobilisation), Dekubitus (Umlagerung, Druckmessung), Sturz (Bettgitter, Klingel griffbereit).

17 B Frühmobilisation = so früh wie möglich! Vorteile: reduziert Pneumonie, Thrombose, Dekubitus, Muskelschwund, Delir. Beginn: nach Stabilisierung (Kreislauf stabil, Schmerz tolerierbar). Stufenweise: Sitzen → Stehen → Gehen.

18 B Sofortige Arzt-Information bei: Rötung + Wärme + Schwellung (Infektzeichen), eitriges Sekret, Fieber > 38°C, Wunddehiszenz (Wunde öffnet sich), plötzliche starke Schmerzsteigerung, Nachblutung.

Hüft-TEP / Knie-TEP

19 B Hüft-TEP Luxationsprophylaxe: Abduktionskeil zwischen Beine, Hüfte nicht > 90° beugen (erhöhte Sitzgelegenheiten!), keine Innenrotation, keine Adduktion (Beine nicht überkreuzen). Diese Regeln gelten 3-6 Monate!

20 B TEP-Operationen haben ohne Prophylaxe TVT-Rate bis 40%! Ursachen: Blutstase (Immobilität), Gefäßverletzung (OP), Hyperkoagulabilität. Maßnahmen: NMH (z.B. Enoxaparin 4-6 Wo.), Kompressionsstrümpfe, Frühmobilisation.

21 B Knie-TEP: Frühmobilisation ab Tag 1 (oft noch am OP-Tag!). Ziel: rasche Beugung (Tag 1: 60°, Tag 5: 90°). Motorschiene (CPM) möglich. Physio täglich. Thromboseprophylaxe bis 5-6 Wochen. Vollbelastung meist sofort erlaubt.

Appendizitis

22 B McBurney-Punkt: Druckschmerz im rechten Unterbauch, Mitte zwischen Nabel (Umbilikus) und rechtem Spina iliaca anterior superior. Typisch für Appendizitis. Blumberg-Zeichen = Loslassschmerz kontralateral = Peritonitis-Zeichen!

23 B KEINE Wärme bei Appendizitisverdacht! Wärme → Vasodilatation → Entzündungsförderung → erhöhtes Perforationsrisiko. Auch keine Laxanzien, keine Analgetika vor Diagnose (verdecken Befund – umstritten). Kühlung und Nahrungskarenz stattdessen.

24 B Postoperative Komplikationen: Wundinfektion (3-5%), intraabdomineller Abszess (bei perforierter Appendizitis), Darmparalyse/Ileus (Blähbauch, kein Darmgeräusch), Nachblutung, Narbenhernie (selten). Frühmobilisation und Kostaufbau reduzieren Ileus-Risiko.

Kommunikationsmodelle

25 B Schulz von Thun: jede Nachricht enthält 4 Ebenen: 1. Sachinhalt (was ist die Info?), 2. Selbstoffenbarung (was sage ich über mich?), 3. Beziehungsebene (was halte ich vom Empfänger?), 4. Appell (was soll der Empfänger tun?). Missverständnisse entstehen durch unterschiedliche Sender-/Empfänger-Ohren.

26 B Aktives Zuhören: Blickkontakt, zugewandte Körperhaltung, Nicken, Paraphrasieren ('Sie meinen also...'), Verbalisieren von Gefühlen ('Das klingt belastend'), offene Fragen ('Wie fühlen Sie sich dabei?'), keine vorschnellen Ratschläge. Zeigt echtes Interesse.

27 B GFK (Marshall Rosenberg): 1. Beobachtung (ohne Bewertung: 'Wenn ich sehe dass...'), 2. Gefühl ('fühle ich mich...'), 3. Bedürfnis ('weil ich brauche...'), 4. Bitte ('bitte ich Sie...'. Unterschied: Beobachtung ≠ Bewertung, Bitte ≠ Forderung. Reduziert Konflikte.

Stressbewältigung & Burnout

28 B Burnout-Trias nach Maslach: 1. Emotionale Erschöpfung ('ausgebrannt sein'), 2. Depersonalisation (Distanzierung, Zynismus gegenüber Patienten/Kollegen), 3. Reduzierte Leistungsfähigkeit (Gefühl nichts mehr zu schaffen). Messung: Maslach Burnout Inventory (MBI).

29 B PMR: Muskelgruppen nacheinander 5-10s anspannen → loslassen → Unterschied wahrnehmen. Beginnt bei Händen → Arme → Gesicht → Nacken → Rücken → Bauch → Beine. Führt zu tiefer Entspannung. Evidenzbasiert bei Stress, Angst, Schlafstörungen. Einfach erlernbar!

30 B Selbstfürsorge = Voraussetzung für gute Pflege! Erschöpfte Pflegekräfte machen mehr Fehler und können nicht empathisch sein. Maßnahmen: ausreichend Schlaf, Sport, soziale Kontakte, Hobbys, Supervision, Grenzen setzen, professionelle Hilfe rechtzeitig suchen.

Motivationstheorien

31 B Maslow (1943): 5 Hierarchiestufen: 1. Physiologisch (Essen, Trinken, Schlafen), 2. Sicherheit (Schutz, Stabilität), 3. Soziale Bedürfnisse (Zugehörigkeit, Liebe), 4. Anerkennung (Wertschätzung, Status), 5. Selbstverwirklichung. Erst wenn untere Ebene erfüllt, strebt Mensch nach oben. Pflegerelevant: Grundbedürfnisse zuerst!

32 B Motivational Interviewing (Miller & Rollnick): Patient soll eigene Motivation entwickeln, nicht durch Druck. Prinzipien: Empathie, Diskrepanz entwickeln (zwischen Ist und Ziel), Widerstand vermeiden, Selbstwirksamkeit stärken. Vorteil: höhere Nachhaltigkeit als direktive Beratung.

33 B TTM (Prochaska & DiClemente): 1. Absichtslosigkeit (kein Problembewusstsein), 2. Absichtsbildung (denkt darüber nach), 3. Vorbereitung (plant Änderung), 4. Handlung (ändert Verhalten), 5. Aufrechterhaltung (stabil > 6 Mo.). Pflege: Interventionen stadiengerecht anpassen!

Mammakarzinom

34 B BET = Brusterhaltende Therapie: Tumor wird mit Sicherheitsabstand entfernt (Lumpektomie/Segmentresektion) + obligate postoperative Bestrahlung der gesamten Brust. Gleichwertig zur Mastektomie bei geeigneten Tumoren (Größe, Lokalisation).

35 B Nach Axilladissektion: betroffener Arm absolut schonen vor Traumen. KEIN Blutdruck messen, keine venösen/arteriellen Punktionen, keine i.m.-Injektionen. Kein enger Schmuck. Keine Hitze (Sauna, Sonnenbrand). Sofort bei Rötung/Schwellung/Wärme: Arzt informieren (Erysipel-Risiko!).

36 B Sentinel-LK = Wächterlymphknoten: erster Lymphknoten in der Abflussbahn des Tumors. Wird intraoperativ markiert (radioaktiv/Farbstoff) und entfernt. Histologisch untersucht: kein Befall → keine Axilladissektion nötig → weniger Lymphödem-Risiko!

Präeklampsie / Eklampsie

37 B HELLP = H(emolysis) + E(levated) L(iver enzymes) + L(ow) P(latelets). Schwere Komplikation der Präeklampsie. Symptome: Oberbauchschmerzen, Übelkeit, Thrombozytopenie → Blutungsrisiko, Hämolyse, Leberruptur möglich. Sofortige Entbindung oft nötig!

38 B Magnesiumsulfat: Standard-Antikonvulsivum bei Eklampsie und schwerer Präeklampsie. Überdosierung → Mg-Toxizität: erst Reflexverlust (PSR fehlt!), dann Atemdepression, dann Herzstillstand. Monitoring: PSR, Atemfrequenz, Diurese. Antidot: Calciumgluconat 10% i.v.!

39 B Eklampsie = tonisch-klonischer Krampfanfall bei Präeklampsie ohne andere Ursache. Häufig mit Bewusstlosigkeit. Notfallmaßnahmen: Seitenlage, Atemweg sichern, O_2, Diazepam i.v., Magnesium i.v., sofortige Entbindung vorbereiten.

Spontangeburt (physiologische Geburt)

40 B Eröffnungsphase (Muttermund öffnet sich bis 10 cm), Austreibungsphase (vollständige Eröffnung bis Geburt des Kindes, Presswehen), Nachgeburtsphase (Geburt der Plazenta). Danach folgt die Postplazentarphase (frühes Wochenbett).

41 B Geburtsbeginn zeigt sich durch regelmäßige, an Stärke und Frequenz zunehmende Wehen, den Blasensprung (Fruchtwasserabgang) und das Zeichnen (Abgang des blutig-schleimigen Schleimpfropfs).

42 B Das CTG (Kardiotokografie) zeichnet gleichzeitig die Wehen und die kindlichen Herztöne auf. Abfälle der Herzfrequenz können auf eine fetale Hypoxie (Sauerstoffmangel) hinweisen und erfordern rasches Handeln.

Sectio caesarea (Kaiserschnitt)

43 B Eine sekundäre/Not-Sectio wird bei akuter Gefahr für Mutter oder Kind durchgeführt, z. B. pathologisches CTG (fetale Hypoxie), Nabelschnurvorfall, vorzeitige Plazentalösung oder Geburtsstillstand.

44 B Nach der Operation und im Wochenbett ist das Thromboserisiko erhöht. Wichtig sind LMWH, Kompressionsstrümpfe und vor allem die frühe Mobilisation. Zusätzlich gelten die Wochenbett-Kontrollen (Fundus, Lochien).

45 B Stillen ist nach einer Sectio möglich. Durch Wundschmerz, verzögerten Milcheinschuss und eingeschränkte Mobilität ist der Start oft erschwert – hier hilft aktive Stillberatung, schmerzarme Positionen und frühes Anlegen.

Neugeborenenversorgung (Erstversorgung, APGAR)

46 B APGAR bewertet Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen (Hautfarbe) und Reflexe – je 0 bis 2 Punkte, erhoben bei 1, 5 und 10 Minuten. Ein Wert von 7 bis 10 gilt als unauffällig.

47 B Neugeborene verlieren wegen ihrer relativ großen Körperoberfläche und der unreifen Wärmeregulation rasch Wärme. Abtrocknen, Haut-zu-Haut-Kontakt und Mütze beugen einer gefährlichen Auskühlung vor.

48 B Die U1 erfolgt unmittelbar nach der Geburt (Erstuntersuchung inkl. APGAR). Die U2 folgt am 3. bis 10. Lebenstag, ergänzt durch das Neugeborenen-Screening aus Fersenblut.

Stillen und Laktation

49 B Prolaktin sorgt für die Milchbildung, Oxytocin löst den Milchspende-/Let-down-Reflex aus. Häufiges Anlegen fördert über den Saugreiz beide Hormone und damit die Milchmenge.

50 B Bei Mastitis wird meist weiter gestillt bzw. entleert (Milchstau lösen!), zusätzlich Kühlung nach dem Stillen, Schonung und ausreichend Flüssigkeit. Bei ausbleibender Besserung oder Fieber ggf. Antibiotikum – Abstillen ist selten nötig.

51 B Beim korrekten Anlegen erfasst das Kind die Mamille samt großem Teil des Warzenhofs, die Lippen sind nach außen gestülpt, Kinn berührt die Brust. Das beugt wunden Mamillen vor und sichert effektives Trinken.

Gestationsdiabetes (GDM)

52 B Der orale Glukosetoleranztest (oGTT) wird als Screening in der 24. bis 28. Schwangerschaftswoche durchgeführt, da der GDM meist symptomarm verläuft und sonst unentdeckt bliebe.

53 B Reichen Ernährung und Bewegung nicht aus, wird mit Insulin behandelt. Orale Antidiabetika werden in der Schwangerschaft in der Regel nicht eingesetzt. Basis bleibt immer die Ernährungsumstellung.

54 B Das Kind hat sich intrauterin an hohe Zuckerwerte angepasst und produziert vermehrt Insulin. Nach der Geburt fällt das mütterliche Zuckerangebot weg – es droht eine neonatale Hypoglykämie, die überwacht werden muss.

HELLP-Syndrom

55 B HELLP = Hemolysis (Hämolyse), Elevated Liver enzymes (erhöhte Leberwerte) und Low Platelets (niedrige Thrombozyten). Es ist eine schwere Verlaufsform der Präeklampsie.

56 B Der rechtsseitige Oberbauchschmerz entsteht durch die Spannung der Leberkapsel und ist ein Warnzeichen. Zusammen mit Übelkeit, Kopfschmerz und Hypertonie muss an ein HELLP-Syndrom gedacht werden.

57 B Ursächlich beseitigt wird das HELLP-Syndrom nur durch die Entbindung. Bis dahin werden Blutdruck gesenkt, Magnesium zur Krampfprophylaxe und Kortison zur Lungenreife gegeben und Mutter und Kind intensiv überwacht.

Frühgeburt / vorzeitige Wehen

58 B Eine Frühgeburt ist die Geburt vor abgeschlossener 37. Schwangerschaftswoche. Je unreifer das Kind, desto höher das Risiko für Atemprobleme, Infektionen und weitere Komplikationen.

59 B Kortison (z. B. Betamethason) beschleunigt die kindliche Lungenreife und die Surfactant-Bildung. Das senkt das Risiko für ein Atemnotsyndrom des Frühgeborenen deutlich.

60 B Die Tokolyse hemmt die Wehen und zögert die Geburt hinaus. Das gewonnene Zeitfenster wird genutzt, um die Lungenreifeinduktion abzuschließen und ggf. in ein Perinatalzentrum zu verlegen.

Harnwegsinfekt (HWI)

61 B Mittelstrahlurin: 1. Genitale reinigen (Frau: von vorne nach hinten), 2. Ersten Harnstrahl verwerfen (spült Harnröhre), 3. Mittelstrahl in steriles Gefäß, 4. Letzten Strahl verwerfen. Innerhalb 2h ins Labor oder kühlen. Kontamination durch falschen Einfangen verfälscht Ergebnis!

62 B CAUTI (Catheter-Associated Urinary Tract Infection): häufigste nosokomiale Infektion. Risiko steigt täglich. Jeder Tag ohne Indikation = vermeidbares Infektionsrisiko. Täglich fragen: Braucht der Patient den Katheter wirklich noch? Wenn nein: sofort entfernen! → wichtigste Prophylaxe.

63 B Bei alten Menschen: typische Symptome (Dysurie, Pollakisurie) oft nicht vorhanden! Häufig nur: Verwirrtheit, Delir, Stürze, Inappetenz, allgemeine Verschlechterung. Bei plötzlicher Verwirrtheit älterer Patienten immer HWI ausschließen (Urinstreifentest)!

Benignes Prostataadenom (BPH)

64 B TURP = Transurethrale Resektion der Prostata: Goldstandard bei BPH. Endoskopisch (kein Hautschnitt!): Resektoskop über Harnröhre → elektrische Schlinge trägt Prostatagewebe ab. Postoperativ: DK + Blasenspülung (Hämatocolpos). Cave: Ejakulationsprobleme (retrograde Ejakulation) häufig!

65 B Akuter Harnverhalt: Blase unter hohem Druck (bis 1000ml+). Sofortiger kompletter Ablauf → Druckabfall → Schleimhautgefäße rupturieren → Hämaturie (ex vacuo) + Vagotonie/Hypotonie möglich. Daher: max. 500ml ablassen, dann kurz abklemmen, weiter ablassen – langsam!

66 B IPSS (International Prostate Symptom Score): 7 Fragen zu Miktionssymptomen (Harnstrahl, Harndrang, Restharnfühl etc.) + 1 Frage Lebensqualität. 0-7 = leicht, 8-19 = mäßig, 20-35 = schwer. Wichtig für Therapieentscheidung und Verlaufskontrolle.

Schlaganfall (Apoplex)

67 B FAST = Schlaganfall-Schnelltest: F(ace) = Gesicht hängt? A(rms) = Arm sinkt ab bei Vorhalteversuch? S(peech) = Sprache verwaschen/fehlt? T(ime) = Uhrzeit notieren, SOFORT 112! Je schneller Stroke Unit, desto besser. Time is Brain!

68 B Nach Schlaganfall: Schluckreflexstörung häufig (50-60%). Gefährlich: stille Aspiration = Patient aspiriert ohne zu husten oder zu würgen! → Aspirationspneumonie → häufige Todesursache. Daher: KEIN Schluck (auch kein Wasser, Medikamente!) vor validiertem Dysphagie-Screening.

69 B Bobath: Pflege bezieht betroffene (paretische) Seite aktiv ein. Patient wird von betroffener Seite angesprochen, Pflege erfolgt von dieser Seite. Gegenteil: kompensieren mit gesunder Seite → verhindert Rehabilitation. Bobath fördert Neuroplastizität (Gehirn lernt neu). Lagerung: betroffenen Arm/Bein stützen, Spastik vermeiden.

Epilepsie

70 B Bei Anfall NICHT: festhalten (Frakturrisiko!), Beißkeil einlegen (Verletzung von Zähnen, Mund, Finger der Pflegekraft, Aspirationsgefahr!), in den Mund fassen. TUN: Zeit stoppen, Verletzungsschutz (Polster), stabile Seitenlage nach Anfall, O_2, ärztl. Information wenn > 5 Min. (Status epilepticus!).

71 B Status epilepticus: Anfall > 5 Min. ODER 2+ Anfälle ohne vollständige Erholung dazwischen. Notfall! Schädigung: je länger, desto mehr Neuronen. Therapie: Lorazepam i.v. 0,1mg/kg → 2. Stufe: Phenytoin/Valproat i.v. → bei Therapieversagen: Narkose (Propofol/Midazolam/Thiopental).

72 B Postiktale Phase: nach epileptischem Anfall. Patient: verwirrt, desorientiert, erschöpft, ggf. Aphasie (Todd-Parese). Kann Minuten bis Stunden dauern. Wichtig: Patient nicht alleine lassen, orientieren, sichern. Nicht mit Schlaganfall verwechseln! (Differenzierung: Vorgeschichte, Anfallsverlauf, EEG, CCT)

Tracheotomie-Pflege

73 B PDT (perkutane Dilatationstracheotomie): Bronchoskopisch kontrolliert, am Intensivbett möglich, schnell. Geeignet für unkomplizierte Anatomie. Chirurgische Tracheotomie: OP-Saal, bei erschwerter Anatomie (Adipositas, kurzer Hals, Struma), Kindertracheotomie, elektive Dauerlösungen (Laryngektomie). PDT heute häufiger auf ICU.

74 B Absaugung = Unterbrechung der Beatmung + Sog entzieht auch Alveolarluft → SpO_2 fällt. Präoxygenierung: FiO_2 für 1-2 Min. auf 100% erhöhen (beatmet) oder 2-3 tiefe Atemzüge ermöglichen (spontan). Maximal 15 Sek. absaugen, dann erneut beatmen/oxygenieren, DANN ggf. 2. Absaugvorgang.

75 B HME (Heat and Moisture Exchanger): kleines Gerät auf Tracheostoma/Kanüle. Speichert Wärme und Feuchtigkeit der Ausatemluft → gibt sie bei Einatmung zurück. Ersetzt Klimatisierungsfunktion der Nase. Verhindert Schleimhautaustrocknung und Sekreteindickung. Gleichzeitig Bakterienfilter. Wechsel alle 24h.

Otitis media (Mittelohrentzündung)

76 B Ohrtrompete (Tuba Eustachii) bei Kindern: kürzer (Erwachsene: 3,5cm, Kinder: 1,8cm), horizontaler (Erwachsene: 45°, Kinder: 10°), weicher (kollabiert leichter). → Schlechte Belüftung des Mittelohrs + leichter Keimaufstieg aus Rachen. Adenoide (Rachenmandeln) behindern zusätzlich.

77 B Trommelfellperforation bei Otitis media: Der Eiter entweicht nach außen → Druckentlastung im Mittelohr → oft deutliche Schmerzlinderung! Nicht dramatisch wirken: Eltern beruhigen, Abstrich abnehmen, Ohr trocken halten (kein Wasser!), Antibiose prüfen. Trommelfell heilt meist spontan zu.

78 B Paukenröhrchen (Tympanostomieröhrchen): chirurgisch ins Trommelfell eingesetzt (in Kurznarkose beim Kind). Belüftet das Mittelohr dauerhaft, lässt Sekret abfließen. Indikation: ≥3 Otitis-Episoden in 6 Monaten ODER Hörverlust durch Paukenerguss > 3 Monate. Fällt nach 6-18 Monaten meist selbst heraus.

Onkologische Pflegegrundlagen

79 B Febrile Neutropenie: onkologischer Notfall! Infektionen können ohne Neutrophile (die Abwehrzellen fehlen) rasend schnell zur Sepsis führen. Mortalität ohne schnelle Therapie hoch. Maßnahmen: 2x Blutkultur → sofort Breitband-Antibiose innerhalb 1h (nicht warten auf Kulturergebnis!). Häufige Erreger: E. coli, Klebsiella, Pseudomonas.

80 B CINV = durch Chemotherapie ausgelöste Übelkeit und Erbrechen. Akut (0-24h), verzögert (24-120h), antizipatorisch (Pawlow-Reflex). Prophylaxe nach Emetogenität: hoch emetogen (Cisplatin): 5-HT3-Antagonist + Dexamethason + Aprepitant + ggf. Olanzapin. Antiemetika VOR Chemo geben!

81 B Tumor-Fatigue: häufigste Nebenwirkung bei Krebs (>80%). Unterschied zu normaler Müdigkeit: durch Schlaf NICHT gebessert, beeinflusst alle Lebensbereiche. Ursachen: Tumor, Therapie, Anämie, Schmerz, Depression. Therapie: Aktivitätsmanagement (nicht schonen, sondern angepasste Bewegung!), Behandlung Anämie, kognitive Verhaltenstherapie.

Palliativpflege

82 B WHO-Stufenschema: Stufe 1 = Nicht-Opioide (NSAR, Paracetamol, ±Adjuvanzien). Stufe 2 = schwache Opioide (Tramadol, Tilidin). Stufe 3 = starke Opioide (Morphin, Oxycodon, Fentanyl). Prinzip: oral, regelmäßig (nach Uhr!), individuell, mit Begleitmedikation (Antiemetikum, Laxans). Koanalgetika: Antidepressiva, Antikonvulsiva bei Neuropathie.

83 B Opioide binden an μ-Opioid-Rezeptoren im Darm → Hemmung der Peristaltik → Obstipation bei nahezu allen Patienten. Im Gegensatz zu Übelkeit (bessert sich) und Sedierung (bessert sich) entwickelt sich KEINE Toleranz gegen Obstipation! Daher: Laxans von Anfang an, z.B. Macrogol, Natriumpicosulfat. Nie vergessen!

84 B Rasselatmung (death rattle): Sekret sammelt sich im Rachen/Rachen bei abgeschwächtem oder fehlendem Schluckreflex in der Sterbephase. Geräuschvoll, aber: Patient nimmt es meist nicht wahr (Bewusstsein stark reduziert). Maßnahmen: Seitenlage, Absaugen NUR wenn Patient leidet, Mundpflege, vor allem: Angehörige aufklären und begleiten – für sie ist es belastend.

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

PHARMAKOLOGIE FÜR DIE PFLEGE

Medikamente kompakt

43 wichtige Wirkstoffe aus Pflegealltag, Notfall, Anästhesie und Intensivmedizin – Wirkung, Nebenwirkungen, Kontraindikationen und vor allem: worauf du als Pflegekraft achten musst.

Bestehen ist planbar.

Wirkung · Nebenwirkungen · Kontraindikationen · Pflege

43	9	A4
Wirkstoffe	Gruppen	druckfertig

INHALT

1. Anästhesie
2. Intensivmedizin
3. Notfall
4. Pflegealltag
5. Herz & Kreislauf
6. Antikoagulation
7. Schmerz
8. Neurologie & Psychiatrie
9. Diabetes

⚠ Lernhilfe, mit KI-Unterstützung erstellt und fachlich geprüft. Dosierungen nur als Orientierung – verbindlich sind ärztliche Anordnung, Fachinformation und Klinikstandard.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

plan-nrw.de

So ist jede Karte aufgebaut

Name und Wirkstoffgruppe, Indikation bzw. Dosis, Wirkung, Nebenwirkungen (NW), Kontraindikationen (KI) und der wichtigste Pflegehinweis. Der Pflegehinweis ist das, was in Praxis und Prüfung zählt.

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

Anästhesie

7 Wirkstoffe

Propofol Hypnotikum

Dosis (Orientierung)	1-2,5 mg/kg i.v. Einleitung; 4-12 mg/kg/h TIVA
Wirkung	Bewusstseinsverlust, Sedierung, leichte Analgesie, antiemetisch
Nebenwirkungen	Blutdruckabfall, Atemdepression, Injektionsschmerz, Lipidinfusion
Kontraindikationen	Sojaallergie, Eiweißallergie, Propofol-Infusions-Syndrom bei >48h
Pflege	Blutdruck überwachen, Apnoe-Bereitschaft, nicht >48h auf ICU, Emulsion kühl lagern

Remifentanil Opioid (ultrakurz)

Dosis (Orientierung)	0,05-2 µg/kg/min i.v. (TIVA)
Wirkung	Starke Analgesie, Atemdepression, Bradykardie, Hustendämpfung
Nebenwirkungen	Atemdepression, Bradykardie, Rigidität (hohe Dosen), Hyperalgesie nach Absetzen
Kontraindikationen	Relative KI: Spontanatmung ohne Monitoring
Pflege	NUR unter Beatmung! Sofort antagonisieren mit Naloxon bei Überdosierung, nie als Bolus

Fentanyl Opioid

Dosis (Orientierung)	1-3 µg/kg i.v.; Pflaster 12-200 µg/h
Wirkung	Starke Analgesie, Sedierung, Hustendämpfung
Nebenwirkungen	Atemdepression, Übelkeit, Obstipation, Suchtpotenzial
Kontraindikationen	MAO-Hemmer (Kombination!), schwere Ateminsuffizienz
Pflege	Naloxon bereithalten, Atemfrequenz überwachen, Pflaster: Hautreaktion prüfen

Midazolam Benzodiazepin

Dosis (Orientierung)	0,03-0,3 mg/kg/h i.v. Sedierung; 1-2,5 mg Anxiolyse
Wirkung	Anxiolyse, Sedierung, Amnesie, Muskelrelaxation, antikonvulsiv
Nebenwirkungen	Atemdepression, Blutdruckabfall, paradoxe Reaktionen (Kinder/ Ältere), Abhängigkeit
Kontraindikationen	Myasthenia gravis, schwere Leberinsuffizienz
Pflege	Antagonist: Flumazenil! Atemüberwachung, bei Agitation paradoxe Reaktion bedenken

Rocuronium Nicht-depolarisierendes Muskelrelaxans

Dosis (Orientierung)	0,6 mg/kg Intubation; 0,1-0,2 mg/kg Erhalt
Wirkung	Neuromuskuläre Blockade → Muskellähmung, Intubationsbedingungen
Nebenwirkungen	Keine Sedierung! Analgesie! Anaphylaxie möglich
Kontraindikationen	Myasthenia gravis (relativ)
Pflege	KEIN Analgetikum! Patient wach aber gelähmt ohne Sedierung → immer Sedierung begleitend! Antagonist: Sugammadex

Succinylcholin Depolarisierendes Muskelrelaxans

Dosis (Orientierung)	1-1,5 mg/kg i.v. RSI
Wirkung	Schnelle vollständige Muskelrelaxation (60s), kurze Wirkdauer 10-15 Min.
Nebenwirkungen	Faszikulationen, Hyperkaliämie, Bradykardie, MH-Trigger!, Histaminfreisetzung
Kontraindikationen	Verbrennungen, Querschnitt, MH-Disposition, Hyperkaliämie, Pseudocholinesterasemangel
Pflege	MH-Notfallset bereit! Dantrolen griffbereit! Nur RSI-Indikation

Ketamin (S-Ketamin) Dissoziatives Anästhetikum

Dosis (Orientierung)	1-2 mg/kg i.v. Anästhesie; 0,1-0,5 mg/kg Analgesie
Wirkung	Dissoziation, Analgesie, Bronchodilatation, Kreislaufstimulation, erhält Schutzreflexe
Nebenwirkungen	Halluzinationen, Alpträume, Tachykardie, RR-Anstieg, Hypersalivation
Kontraindikationen	Hypertensive Krise, erhöhter Hirndruck (relativ), Psychosen
Pflege	Kombination mit Midazolam (Halluzinationen!), Licht dimmen, ruhige Umgebung, Absaugbereitschaft (Hypersalivation)

Intensivmedizin

6 Wirkstoffe

Noradrenalin Vasopressor (α_1-Agonist)

Dosis (Orientierung)	0,01-1,0 µg/kg/min i.v. Perfusor
Wirkung	Vasokonstriktion → MAP↑, wenig Herzfrequenzeffekt
Nebenwirkungen	Periphere Ischämie, Tachykardie, Hypertonie bei Überdosierung
Kontraindikationen	Hypovolämie ohne Volumenersatz (relativ)
Pflege	Nur ZVK oder sichere Kanüle! Backup-Perfusor! NIE unterbrechen! 4-Augen-Prinzip bei Zubereitung

Adrenalin Katecholamin (α+β-Agonist)

Dosis (Orientierung)	0,01-1 µg/kg/min Perfusor; 1mg i.v. Reanimation
Wirkung	Herzfrequenz↑, Kontraktilität↑, Vasokonstriktion, Bronchodilatation
Nebenwirkungen	Tachykardie, Arrhythmien, Hypertonie, Myokardischämie
Kontraindikationen	Relative KI: schwere KHK, Tachyarrhythmien
Pflege	Bei Anaphylaxie: 0,5mg i.m.! Bei Reanimation: 1mg i.v. alle 3-5 Min.

Dobutamin Positiv-inotrop (β_1-Agonist)

Dosis (Orientierung)	2-20 µg/kg/min i.v. Perfusor
Wirkung	Herzfrequenz↑, Kontraktilität↑ (inotrop), Vasodilatation (β_2)
Nebenwirkungen	Tachykardie, Arrhythmien, RR-Abfall möglich
Kontraindikationen	Obstruktive Kardiomyopathie, schwere Aortenklappenstenose
Pflege	Häufig kombiniert mit Noradrenalin, HF-Monitoring, EKG

Heparin (unfraktioniert) Antikoagulans

Dosis (Orientierung)	Initial 5000 IE i.v.; Erhalt nach aPTT (Ziel 60-80s)
Wirkung	Hemmung der Gerinnungskaskade (IIa, Xa), schnell wirksam, kurze HWZ
Nebenwirkungen	Blutungen, HIT (Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II!), Hyperkaliämie
Kontraindikationen	Aktive Blutung, HIT Vorgeschichte, schwere Thrombozytopenie
Pflege	Thrombozyten täglich! HIT-Verdacht: Heparin sofort stoppen, Alternativantikoagulation. Antagonist: Protamin

Propofol (ICU-Sedierung) Hypnotikum/Sedativum

Dosis (Orientierung)	0,3-4 mg/kg/h Sedierung ICU
Wirkung	Sedierung, Anxiolyse, antiemetisch
Nebenwirkungen	Propofol-Infusions-Syndrom (>48h, >4mg/kg/h): Azidose, Rhabdomyolyse, Herzversagen!
Kontraindikationen	>48h Dauerinfusion auf ICU vermeiden, Triglyzeride überwachen
Pflege	Triglyzeride kontrollieren, max. 4mg/kg/h, RASS-Score dokumentieren, Analgesie zuerst (PADIS)!

Dexmedetomidin α_2-Agonist/Sedativum

Dosis (Orientierung)	0,2-1,4 µg/kg/h i.v.
Wirkung	Sedierung ohne Atemdepression, analgetisch, anxiolytisch, sympatholytisch
Nebenwirkungen	Bradykardie, Hypotonie, Mundtrockenheit
Kontraindikationen	AV-Block Grad II/III, schwere Herzinsuffizienz
Pflege	Patient erweckbar! Weniger Delir als Benzodiazepine. HF und RR überwachen

Notfall

6 Wirkstoffe

Adrenalin (Reanimation) Katecholamin

Dosis (Orientierung)	1mg i.v./i.o. alle 3-5 Min. (ERC-Leitlinie)
Wirkung	Koronarperfusion↑, zerebrale Perfusion↑, Vasokonstriktion
Nebenwirkungen	Tachykardie, Arrhythmien, Hypertonie nach ROSC
Kontraindikationen	Keine absoluten KI bei Reanimation
Pflege	Während CPR! Nach ROSC: RR, HF, Temperatur überwachen, Zieltemperaturmanagement

Amiodaron Antiarrhythmikum (Klasse III)

Dosis (Orientierung)	300mg i.v. Bolus VF/pVT; 150mg bei Wiederholung
Wirkung	Verlängert Repolarisation, antiarrhythmisch bei VF/pVT nach 3. Defibrillation
Nebenwirkungen	Hypotonie, Bradykardie, Phlebitis, Schilddrüsenprobleme (Langzeit)
Kontraindikationen	Jodallergie (Kurzzeit relativ), Sinusbradykardie
Pflege	Nur über ZVK langfristig, Lichtschutz, Schilddrüsenwerte Langzeit kontrollieren

Atropin Anticholinergikum

Dosis (Orientierung)	0,5-1mg i.v. Bradykardie; max. 3mg
Wirkung	Herzfrequenz↑ (vagolytisch), Bronchodilatation, Speichelsekretion↓
Nebenwirkungen	Tachykardie, Mundtrockenheit, Harnverhalt, Mydriasis, Hyperthermie
Kontraindikationen	Glaukom (relativ), Prostatahyperplasie
Pflege	Bei Asystolie nicht mehr 1. Wahl! EKG-Monitoring, Harnblase kontrollieren

Naloxon Opioid-Antagonist

Dosis (Orientierung)	0,4-2mg i.v./i.m./nasal; titrieren 0,04mg Schritte
Wirkung	Kompetitive Verdrängung der Opioide vom Rezeptor → Aufhebung Atemdepression
Nebenwirkungen	Akutes Entzugssyndrom, Tachykardie, Hypertonie, Lungenödem
Kontraindikationen	Keine absoluten KI bei Atemdepression
Pflege	Kurze HWZ (30-90 Min.)! Opioid wirkt länger → Rebound-Atemdepression! Engmaschiges Monitoring, ggf. wiederholen

Dantrolen Muskelrelaxans (Spezifisch MH)

Dosis (Orientierung)	2,5 mg/kg i.v. Bolus, bis 10mg/kg
Wirkung	Hemmung der Kalziumfreisetzung aus sarkoplasmatischem Retikulum → MH-Therapie
Nebenwirkungen	Muskelschwäche, Phlebitis, Übelkeit
Kontraindikationen	Keine bei MH-Notfall
Pflege	MH-Notfall: sofort Trigger stoppen, 100% O_2, Dantrolen, aktive Kühlung. Immer vorrätig im OP!

Glukose 40-50% Antihypoglykämikum

Dosis (Orientierung)	20-40ml G40% i.v. bei Hypoglykämie
Wirkung	Sofortiger BZ-Anstieg
Nebenwirkungen	Venenwandreizung (hyperosmolar!), Hyperglykämie bei Überdosierung
Kontraindikationen	Hyperglykämie
Pflege	Nur über guten Venenzugang! BZ-Kontrolle nach 15 Min., Ursache der Hypoglykämie klären

Pflegealltag

6 Wirkstoffe

Metformin Antidiabetikum (Biguanid)

Dosis (Orientierung)	500-2000mg/Tag oral
Wirkung	Glukoseproduktion Leber↓, Insulinsensitivität↑, kein Hypoglykämierisiko als Monotherapie
Nebenwirkungen	Gastrointestinal (Übelkeit, Durchfall), Laktatazidose (selten, bei Niereninsuffizienz!)
Kontraindikationen	GFR <30, Kontrastmittelgabe (48h pausieren), Alkohol, Operationen
Pflege	Vor KM-Gabe und OP pausieren! Nierenfunction kontrollieren, mit Mahlzeit einnehmen

Insulin (Humaninsulin) Antidiabetikum

Dosis (Orientierung)	Individuell; s.c. oder i.v. (nur Normalinsulin i.v.!)
Wirkung	BZ-Senkung durch Glukoseaufnahme in Zellen
Nebenwirkungen	Hypoglykämie!, Lipodystrophie (Injektionsstellen wechseln!), Hypokaliämie
Kontraindikationen	Hypoglykämie
Pflege	BZ-Kontrolle! Injektionsstellen rotieren! Bei i.v.: NUR Normalinsulin. Hypoglykämie-Notfall: Glukose 40%

ASS (Acetylsalicylsäure) Thrombozytenaggregationshemmer/Analgetikum

Dosis (Orientierung)	100mg/Tag Aggregationshemmung; 500-1000mg Analgesie
Wirkung	Irreversible COX-1-Hemmung → Thrombozytenaggregation↓, Analgesie, antipyretisch
Nebenwirkungen	Magenblutung, Ulkus, Bronchospasmus (ASS-Intoleranz), Blutungszeit↑
Kontraindikationen	<12 Jahre (Reye-Syndrom!), Blutungsneigung, Magenulkus aktiv
Pflege	Magenblutungszeichen beachten, vor Operationen pausieren (5-7 Tage), Kinder NIEMALS!

Pantoprazol Protonenpumpenhemmer (PPI)

Dosis (Orientierung)	20-40mg/Tag oral; 40mg i.v.
Wirkung	Irreversible Hemmung H^+/K^+-ATPase → Magensäureproduktion↓
Nebenwirkungen	Kopfschmerzen, Durchfall, Magnesiummangel (Langzeit), C.-difficile-Risiko↑
Kontraindikationen	Kombination mit Nelfinavir/Atazanavir
Pflege	30 Min. vor dem Essen einnehmen, Magnesium langfristig kontrollieren, nicht unnötig langfristig geben

Metamizol Analgetikum/Antipyretikum

Dosis (Orientierung)	500-1000mg oral/i.v.; max. 4g/Tag
Wirkung	Analgesie, Antipyrese, Spasmolytisch (Koliken!)
Nebenwirkungen	Agranulozytose (selten, lebensbedrohlich!), Hypotonie bei schneller i.v. Gabe, Thrombozytopenie
Kontraindikationen	Blutbildstörungen, G6PD-Mangel, letztes Trimenon
Pflege	Blutbild bei Langzeittherapie! I.v. NUR langsam! Bei Fieber, Schmerzen, Gallenkolik. In einigen Ländern verboten!

Morphin Opioid-Analgetikum

Dosis (Orientierung)	2-10mg s.c./i.v.; PCA möglich
Wirkung	Starke Analgesie, Sedierung, Euphorie, Hustendämpfung, Ödemreduktion (Herzinsuffizienz)
Nebenwirkungen	Atemdepression!, Übelkeit, Obstipation, Abhängigkeit, Harnverhalt
Kontraindikationen	Atemdepression, Ileus, Alkohol/Benzodiazepin-Kombination (Vorsicht!)
Pflege	Naloxon bereithalten! Atemfrequenz/SpO_2, Laxanzien prophylaktisch! Obstipation ist häufigste NW

Herz & Kreislauf

5 Wirkstoffe

Metoprolol (Beloc) Beta-Blocker

Indikation	Hypertonie, Herzinsuffizienz, Angina, Arrhythmien
Wirkung	HF ↓, RR ↓, Herzarbeit ↓
Nebenwirkungen	Bradykardie, Hypotonie, Müdigkeit, Bronchospasmus
Kontraindikationen	Bradykardie, AV-Block, Asthma
Pflege	Puls vor Gabe messen (NV: >60/min). Bei Bradykardie Arzt!

Ramipril (Delix) ACE-Hemmer

Indikation	Hypertonie, Herzinsuffizienz, nach MI
Wirkung	Vasodilatation, Nachlastsenkung, Nierenprotektion
Nebenwirkungen	Trockener Husten, Hypotonie, Hyperkaliämie, Angioödem
Kontraindikationen	Schwangerschaft, Angioödem in Anamnese
Pflege	1. Dosis abends (Hypotonie!). Trockener Husten → ggf. ARB

Furosemid (Lasix) Schleifendiuretikum

Indikation	Herzinsuffizienz, Ödeme, Hypertonie
Wirkung	Hemmung Na-K-2Cl-Cotransporter (Henle-Schleife)
Nebenwirkungen	Hypokaliämie, Dehydration, Hypotonie, Ototoxizität
Kontraindikationen	Anurie, Hypokaliämie
Pflege	MORGENS geben! Elektrolyte kontrollieren (Kaliummangel). Ein-/Ausfuhr!

Amlodipin (Norvasc) Kalziumantagonist

Indikation	Hypertonie, Angina pectoris
Wirkung	Vasodilatation, RR ↓
Nebenwirkungen	Knöchelödeme, Flush, Kopfschmerzen
Kontraindikationen	Schwere Hypotonie
Pflege	Knöchelödeme häufig (nicht mit Herzinsuffizienz verwechseln!)

Nitroglycerin (Nitrolingual) Nitrat

Indikation	Angina pectoris, ACS
Wirkung	Vasodilatation (Vorlastsenkung)
Nebenwirkungen	Starke Kopfschmerzen, Hypotonie, Flush
Kontraindikationen	Hypotonie, Rechtsherzinfarkt, PDE-5-Hemmer (Sildenafil!)
Pflege	NUR bei RR >90 mmHg! Sitzend geben. Kopfschmerzen normal.

Antikoagulation

3 Wirkstoffe

Phenprocoumon (Marcumar) Vitamin-K-Antagonist

Indikation	VHF, mech. Herzklappe, TVT/LE
Wirkung	Hemmung Faktoren II, VII, IX, X
Nebenwirkungen	Blutungen, Hautnekrose (selten)
Kontraindikationen	Schwangerschaft, schwere Lebererkrankung
Pflege	INR-Kontrolle regelmäßig (Ziel 2,0–3,5). Lebensmittel-WW (Brokkoli, Spinat)! Antidot: Vitamin K, PPSB

Rivaroxaban (Xarelto) DOAK (Faktor-Xa-Hemmer)

Indikation	VHF, TVT/LE
Wirkung	Direkte Hemmung Faktor Xa
Nebenwirkungen	Blutungen, Übelkeit
Kontraindikationen	Schwere Niereninsuffizienz (GFR<15), Schwangerschaft
Pflege	Kein INR-Monitoring. Einnahme zu Mahlzeiten (15/20 mg). Antidot: Andexanet alfa

Enoxaparin (Clexane) NMH

Indikation	Thromboseprophylaxe und -therapie
Wirkung	Anti-Xa-Wirkung
Nebenwirkungen	Blutung, HIT (selten), Hämatome
Kontraindikationen	HIT in Anamnese, schwere Niereninsuffizienz
Pflege	s.c. in Bauchfalte, Nadel senkrecht, nicht reiben. Kein PTT-Monitoring nötig.

Schmerz

3 Wirkstoffe

Paracetamol (Ben-u-ron) Nicht-Opioid-Analgetikum

Indikation	Leichte bis mittlere Schmerzen, Fieber
Wirkung	Zentrale Wirkung, antipyretisch
Nebenwirkungen	Hepatotoxizität bei Überdosierung
Kontraindikationen	Leberinsuffizienz, Alkoholismus
Pflege	Maximaldosis 4 g/Tag! Bei Lebererkrankungen kontraindiziert.

Ibuprofen (Ibuflam) NSAR

Indikation	Schmerzen, Entzündungen, Fieber
Wirkung	COX-1/2-Hemmer
Nebenwirkungen	Magenulkus, Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz ↑
Kontraindikationen	Ulkus, schwere Nieren-/Herzinsuffizienz, SS (3. Trimenon)
Pflege	Immer mit Mahlzeit! Bei Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, Ulkus vermeiden.

Metamizol (Novalgin) Nicht-Opioid-Analgetikum

Indikation	Starke Schmerzen, Koliken, Fieber
Wirkung	Analgetisch, spasmolytisch, antipyretisch
Nebenwirkungen	Agranulozytose, Hypotonie (i.v.), Allergien
Kontraindikationen	Agranulozytose in Anamnese
Pflege	i.v.: LANGSAM! (Hypotonie bei Schnellgabe). Agranulozytose möglich → Blutbild!

Neurologie & Psychiatrie

4 Wirkstoffe

L-Dopa/Carbidopa (Madopar) Antiparkinsonmittel

Indikation	Morbus Parkinson
Wirkung	Dopaminvorstufe passiert Blut-Hirn-Schranke
Nebenwirkungen	Dyskinesien, Übelkeit, Psychose, Impulskontrollstörungen
Kontraindikationen	Engwinkelglaukom, Psychosen
Pflege	PÜNKTLICH geben! Off-Phasen vermeiden. 30 min vor Mahlzeit (Eiweiß hemmt Resorption). Nicht abrupt absetzen!

Levetiracetam (Keppra) Antiepileptikum

Indikation	Epilepsie
Wirkung	Hemmung synaptischer Vesikelfreisetzung (SV2A)
Nebenwirkungen	Verhaltensänderungen, Aggression, Schwindel
Kontraindikationen	Schwere Niereninsuffizienz (Dosisanpassung)
Pflege	Stimmungsschwankungen möglich (informieren). Nicht abrupt absetzen!

Sertralin (Zoloft) SSRI

Indikation	Depression, Angststörungen
Wirkung	Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
Nebenwirkungen	Übelkeit, Schlafstörungen, sexuelle Dysfunktion, Serotoninsyndrom
Kontraindikationen	MAO-Hemmer-Kombination, Schwangerschaft
Pflege	Wirkung nach 2–4 Wochen (Compliance!). Suizidalität zu Beginn beobachten! Nicht abrupt absetzen. CAVE: Tramadol-Kombination (Serotoninsyndrom)!

Lorazepam (Tavor) Benzodiazepin

Indikation	Angststörungen, Epilepsieanfall, Prämedikation
Wirkung	GABA-A-Rezeptor-Agonist
Nebenwirkungen	Sedierung, Atemdepression, Abhängigkeit, Paradoxreaktionen bei Alten
Kontraindikationen	Schwere Atemdepression, Myasthenia gravis
Pflege	Atemdepression! Nicht mit Opioiden kombinieren ohne Überwachung. Kurzzeitig! Antidot: Flumazenil (Anexate)

Diabetes

3 Wirkstoffe

Metformin (Glucophage) Biguanid

Indikation	Diabetes Typ 2 (Mittel der 1. Wahl)
Wirkung	Hepatische Glukoneogenese ↓, Insulinsensitivität ↑
Nebenwirkungen	Übelkeit, Diarrhö, Laktatazidose (selten)
Kontraindikationen	GFR <30, Kontrastmittelgabe, schwere Herzinsuffizienz
Pflege	Vor Kontrastmittel 48h absetzen! Vor OP absetzen. Bei Niereninsuffizienz: Laktatazidose!

Insulin glargin (Lantus) Basalinsulin (Langzeit)

Indikation	Diabetes Typ 1 und 2
Wirkung	24h gleichmäßige Wirkung, kein Peak
Nebenwirkungen	Hypoglykämie, Lipodystrophie, Gewichtszunahme
Kontraindikationen	Hypoglykämie
Pflege	Einmal täglich zur gleichen Zeit. Rotationsprinzip! Kühl lagern (2–8°C; angebrochen: bis 4 Wo. Raumtemperatur). Hypoglykämiegefahr!

Insulin aspart (NovoRapid) Kurzzeit-Analoginsulin

Indikation	Mahlzeiteninsulin, Korrektur-Bolus
Wirkung	Wirkbeginn 10–20 min, Dauer 3–5h
Nebenwirkungen	Hypoglykämie, Lipodystrophie
Kontraindikationen	Hypoglykämie
Pflege	Direkt vor oder nach dem Essen. Mahlzeit muss danach kommen! BZ-Kontrolle 2h postprandial.

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

KITTELTASCHEN-WISSEN · ZUM AUSSCHNEIDEN

Taschenkarten-Set

40 Karten mit dem wichtigsten Praxis- und Prüfungswissen – ausdrucken, ausschneiden, laminieren und in die Kitteltasche stecken.

Bestehen ist planbar.

Hygiene · Prophylaxen · Notfall · Scores · Intensiv · Recht

40	2	A4
Karten	pro Zeile	druckfertig

⚠ Lernhilfe, mit KI-Unterstützung erstellt und fachlich geprüft. Maßgeblich sind Lehrinhalte, Leitlinien und Standards deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

Inhalt

Tipp: Auf festeres Papier (160 g/m²) drucken und laminieren – dann halten die Karten die ganze Ausbildung.

01 Hygienische Händedesinfektion
02 Handschuhe – Wann ja/nein?
03 Dekubitusprophylaxe
04 Sturzprophylaxe
05 Thromboseprophylaxe
06 Pneumonieprophylaxe
07 Wundversorgung Kurzref.
08 Notfallmedikamente
09 BLS – Basic Life Support
10 ATL-Pflegeplanung Kurzref.
11 Isolationsmaßnahmen
12 Vitalzeichen Normalwerte
13 Kinästhetik Grundprinzipien
14 Innere Medizin Kurzref.
15 Schmerzerfassung
16 ABCDE-Schema Notfall
17 Glasgow Coma Scale (GCS)
18 SBAR-Übergabe
19 Sepsis-Erkennung (qSOFA)
20 Anaphylaxie Notfall
21 Hypoglykämie & Hyperglykämie
22 EKG-Grundlagen
23 Blasenkatheter-Pflege
24 Magensonde (NGS)
25 NEWS2-Score
26 Delir-Erkennung (CAM-ICU)
27 Fixierung/FEM – Rechtliches
28 Drainagen-Pflege
29 Bluttransfusion
30 Kinderreanimation (PBLS)
31 WHO-Schmerztherapie
32 Beatmung Grundlagen
33 Flüssigkeitsbilanz
34 Nach einem Sturz
35 Tracheostoma Pflege
36 Schutzausrüstung PSA
37 SAMPLE-Anamnese Notfall
38 Intensiv-Medikamente
39 Manchester Triage (MTS)
40 Pädiatrie Notfälle

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

01 Hygienische Händedesinfektion

5 WHO-MOMENTE
- 1. Vor Patientenkontakt
- 2. Vor aseptischen Tätigkeiten
- 3. Nach Körperflüssigkeiten
- 4. Nach Patientenkontakt
- 5. Nach Patientenumgebung

TECHNIK
- 3–5 ml · 30 Sekunden (EN 1500)
- 6 Schritte: Flächen · Rücken · Finger · Außen · Daumen · Kuppen
- Nicht abwischen – trocknen lassen!

MERKE!
- C. difficile → Waschen statt Alkohol!
- Handschuhe ersetzen HD NICHT

02 Handschuhe – Wann ja/nein?

JA BEI:
- Blut · Körperflüssigkeiten · Schleimhäute
- Wundversorgung · Katheter · Zugänge
- Isolationspatienten · Desinfektionsmittel

NEIN BEI:
- Blutdruck messen · Begrüßung
- Medikamente richten (ohne Kontamin.)
- Dauerhaftem Tragen ohne Grund!

MERKE!
- Nach jedem Wechsel: Hände desinfizieren!
- Handschuhe ≠ Ersatz für Händedesinfektion

03 Dekubitusprophylaxe

RISIKO-ASSESSMENT
- Braden-Skala (6–23 Punkte)
- ≤18 = erhöhtes Risiko
- ≤9 = sehr hohes Risiko

MASSNAHMEN
- Umlagerung 2–4h (Risikopatient)
- Druckentlastende Hilfsmittel (W/H-Matratze)
- Hautinspektion bei jeder Pflege
- Mikrolagerung (30°) · KEINE Ringkissen!

STADIEN
- Kategorie 1: Rötung · 2: Blase/Abtragung
- Kategorie 3: Vollhautverlust · 4: Knochen sichtbar

04 Sturzprophylaxe

RISIKOFAKTOREN
- Sturzanamnese · Gangschwäche · Orthostase
- Polypharmazie · Sehstörung · Kognition
- Nykturie · Schmerz · Hilfsmittel

MASSNAHMEN
- Bewegungsmelder · rutschfeste Schuhe
- Nachts: Licht an · Bett niedrig
- Hüftprotektoren · Mobilitätstraining
- Toilettenstuhl bereitstellen

DOKUMENTATION
- Sturzprotokoll nach jedem Sturz
- Maßnahmenplan schriftlich festhalten

05 Thromboseprophylaxe

RISIKO-ASSESSMENT
- Caprini-Score (chir.) / Padua (intern.)
- Immobilität · OP · Thrombose-Vorgeschichte
- Adipositas · Malignome · Pille/HRT

MASSNAHMEN
- Frühmobilisation (1. postop. Tag!)
- Thrombosestrümpfe ATS Kl. I/II
- Heparin s.c. nach ärztl. AO
- Ausreichend trinken: ≥1,5–2 l/Tag
- Wadenpumpe aktivieren · Fußgymnastik

TVT-ZEICHEN
- Homans-Zeichen · Wadendruckschmerz
- Schwellung · Überwärmung · Rötung → Arzt!

06 Pneumonieprophylaxe

RISIKOFAKTOREN
- Immobilität · Schluckstörung · Bewusstlosigkeit
- Beatmung (VAP!) · COPD · Rauchen
- Flachlagerung · Sekretretention

MASSNAHMEN
- Oberkörper 30–45° hochlagern
- Atemübungen (10×/h) · Atemtraining
- Sekretmobilisation · Inhalation
- Ausreichend trinken · Mundpflege
- Frühmobilisation · Beatmungsentwöhnung

VAP-BÜNDEL
- Cuff-Druck 20–30 cmH_2O
- Mundhygiene Chlorhexidin
- Tägliche Extubationsprüfung

07 Wundversorgung Kurzref.

WUNDBEURTEILUNG
- Größe (L×B×T in cm)
- Wundgrund: Granulation🔴 Fibrin🟡 Nekrose⚫
- Exsudat: serös · hämorrhagisch · purulent⚠️
- Wundrand: scharf · mazeriert · unterminiert

NERDS (LOKAL)
- Non-healing · Exudate↑ · Red tissue
- Debris · Smell → ≥3: Abstrich!

WUNDAUFLAGEN
- Foam: stark exsudierend
- Hydrokolloid: wenig Exsudat
- Alginat: Hohlräume · stark blutend
- Silber-Auflage: Infektion/NERDS≥3

08 Notfallmedikamente

REANIMATION ACLS
- Adrenalin 1mg i.v. alle 3–5 Min.
- Amiodaron 300mg i.v. (1. Dosis)
- Amiodaron 150mg i.v. (2. Dosis)
- Atropin 0,5mg i.v. (Bradykardie)

ANALGESIE/SEDIERUNG
- Morphin 2–5mg i.v. titrieren
- Midazolam 1–2mg i.v. (Anxiolyse)
- Propofol 1–2,5mg/kg i.v. (Einleitung)

MERKE!
- 6R-Regel vor jeder Gabe!
- Richtiges Medikament · Dosis · Patient
- Zeit · Applikation · Dokumentation

09 BLS – Basic Life Support

ABLAUF
- 1. Sicher? Ansprechen + Schulter schütteln
- 2. Keine Reaktion → Hilfe rufen!
- 3. Atemwege frei? Kopf überstrecken
- 4. Atemkontrolle max. 10 Sek.
- 5. Keine Atmung → 112 + Defi holen!

CPR
- 30 Kompressionen : 2 Beatmungen
- Frequenz: 100–120/Min.
- Tiefe: 5–6 cm · Vollständige Entlastung
- Druckpunkt: Sternummitte · Handballen

DEFIBRILLATION
- So früh wie möglich!
- EIN Schock → sofort CPR weiter
- AED: Anweisungen befolgen

10 ATL-Pflegeplanung Kurzref.

10 ATLS (JUCHLI)
- 1. Kommunizieren · 2. Sich bewegen
- 3. Vitale Fkt. · 4. Körperpflege
- 5. Essen & Trinken · 6. Ausscheiden
- 7. Schlafen · 8. Beschäftigen
- 9. Sinn finden · 10. Soziale Sicherung

PFLEGEPLAN-SCHEMA
- P: Problem (individuell formulieren)
- Ä: Ätiologie (Ursache)
- S: Symptom
- Z: Pflegeziel (SMART!)
- M: Maßnahmen (konkret, messbar)
- E: Evaluation (Datum festlegen)

MERKE!
- Ressourcen immer dokumentieren!
- Patient einbeziehen → aktivierende Pflege

11 Isolationsmaßnahmen

MRSA
- Einzelzimmer · Kittel · Handschuhe · FFP2
- Screening: Nasen-Rachen-Abstrich
- Sanierung: Mupirocin + Ganzkörperwäsche

C. DIFFICILE / NOROVIRUS
- Einzelzimmer · Kittel · Handschuhe
- WASCHEN statt Alkohol (Sporen!)
- Sporozide Flächendesinfektion

TBC
- Einzelzimmer mit Unterdruck!
- FFP3-Maske (kein MNS!)
- Meldepflicht §6 IfSG

PSA REIHENFOLGE
- An: Kittel→Maske→Brille→Handschuhe
- Ab: Handschuhe→Kittel→Brille→Maske→HD

12 Vitalzeichen Normalwerte

NORMALWERTE ERWACHSENER
- RR: 120/80 mmHg (optimal)
- Puls: 60–100/Min. (regelmäßig)
- AF: 12–18/Min.
- SpO_2: ≥95% (COPD: ≥88%)
- Temp: 36,5–37,4°C (rektal +0,5°C)
- BZ: 70–100 mg/dl (nüchtern)

KRITISCHE WERTE → ARZT!
- RR syst. <90 oder >180 mmHg
- Puls <40 oder >150/Min.
- SpO_2 <90% trotz O_2
- Temp >40°C oder <35°C

SCHMERZ-NRS
- 0=kein · 1–3=leicht · 4–6=mittel
- 7–10=stark → Analgesie dokumentieren

13 Kinästhetik Grundprinzipien

6 KONZEPTE
- 1. Interaktion · 2. Funktionale Anatomie
- 3. Menschliche Bewegung
- 4. Anstrengung · 5. Menschliche Funktion
- 6. Umgebung

TRANSFERS – GRUNDREGELN
- Eigenbewegung des Pat. nutzen!
- Körper nah am Pat. halten
- Aus eigener Körpermitte bewegen
- Kein Heben – Schieben und Gleiten
- Bett in Arbeitshöhe (Nabelhöhe)

SELBSTSCHUTZ
- Rücken gerade halten · Knie beugen
- Gewicht auf Vorderfuß verlagern
- Hilfsmittel nutzen (Gleitmatte, Lifter)

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

14 Innere Medizin Kurzref.

HERZINSUFFIZIENZ NYHA
- I: Keine Beschwerden bei Belastung
- II: Leichte Beschwerden (Treppensteigen)
- III: Beschwerden bei leichter Belastung
- IV: Beschwerden in Ruhe

ACS – LEITSYMPTOME
- Vernichtungsschmerz · Ausstrahlung (Arm/Kiefer)
- Kaltschweißigkeit · Übelkeit
- Atemnot · SOFORT EKG + Arzt!

DIABETES NOTFÄLLE
- Hypo (<70 mg/dl): Traubenzucker · bewusstlos → Glukagon
- Hyper (>300+Keton): Insulin + Flüssigkeit → Arzt!

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

15 Schmerzerfassung

SKALEN
- NRS 0–10 (Numeric Rating Scale)
- VAS: Visuelle Analogskala
- BESD: Demenzkranke (Beobachtung)
- KUSS: Kinder (0–5 Punkte)
- BPS: Beatmete/Sedierte (3–12 Punkte)

OPQRST-ANALYSE
- O: Onset (wann begonnen?)
- P: Provocation (was verstärkt/lindert?)
- Q: Quality (wie? stechend/drückend?)
- R: Radiation (Ausstrahlung?)
- S: Severity (Stärke 0–10)
- T: Time (wie lange?)

MERKE!
- Schmerz ist immer subjektiv!
- Vor VW: Analgesie prüfen (30 Min. vorher)

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

16 ABCDE-Schema Notfall

A – AIRWAY (ATEMWEG)
- Atemweg frei? → Kopf überstrecken / Jaw-thrust
- Fremdkörper? → entfernen
- Obstruktion? → Guedel-/Wendl-Tubus

B – BREATHING (ATMUNG)
- SpO_2, Atemfrequenz, Atemtiefe
- O_2-Gabe: Ziel SpO_2 ≥94% (COPD: 88-92%)
- Beutel-Maske-Beatmung wenn nötig

C – CIRCULATION (KREISLAUF)
- RR, HF, Rekapillarisierung (< 2s)
- 2 großlumige Zugänge, Volumen
- Blutungsquelle komprimieren

D + E
- D: GCS, Pupillen (Größe/Reaktion/Seitengleich)
- E: Entkleiden, Temp, Verletzungen
- SAMPLE-Anamnese starten

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

17 Glasgow Coma Scale (GCS)

AUGEN ÖFFNEN (1–4)
- 4 = Spontan
- 3 = auf Ansprache
- 2 = auf Schmerzreiz
- 1 = kein Öffnen

VERBAL (1–5)
- 5 = orientiert
- 4 = verwirrt
- 3 = unzusammenhängende Worte
- 2 = unverständliche Laute
- 1 = keine Reaktion

MOTORIK (1–6)
- 6 = befolgt Aufforderungen
- 5 = gezielte Schmerzabwehr
- 4 = ungezielte Abwehr
- 3 = Beugesynergismen
- 2 = Strecksynergismen
- 1 = keine Reaktion
- ⚠️ GCS ≤ 8 = Intubation!

18 SBAR-Übergabe

S – SITUATION
- Wer bin ich? Welche Station?
- Patient: Name, Zimmer, Diagnose
- Aktuelles Problem in 1 Satz

B – BACKGROUND
- Relevante Vorerkrankungen
- Aktuelle Medikamente
- Letzte Vitalzeichen, BZ, Labor

A – ASSESSMENT
- Meine Einschätzung: Was glaube ich?
- Dringlichkeit einschätzen
- „Ich mache mir Sorgen weil..."

R – RECOMMENDATION
- Was brauche ich von Ihnen?
- Konkrete Bitte: Visitenkommen? Anordnung? Rückruf?
- Zeitrahmen nennen

19 Sepsis-Erkennung (qSOFA)

QSOFA – JE 1 PUNKT
- RR systolisch ≤ 100 mmHg
- Atemfrequenz ≥ 22/min
- Bewusstseinsveränderung (GCS < 15)
- ⚠️ qSOFA ≥ 2 → Sepsisverdacht!

SOFORTMASSNAHMEN (1H-BUNDLE)
- Blutkultur (2 Paare) VOR Antibiose!
- Laktat-Messung (> 2 = kritisch)
- Breitband-Antibiotikum i.v.
- 500ml Kristalloid-Bolus (bei Hypotonie)
- Arzt sofort informieren!

SIRS-KRITERIEN
- Temp > 38°C oder < 36°C
- HF > 90/min
- AF > 20/min oder pCO_2 < 32
- Leuko > 12.000 oder < 4.000

20 Anaphylaxie Notfall

SCHWEREGRADE (I–IV)
- I: Haut (Urtikaria, Flush, Juckreiz)
- II: Haut + Kreislauf/Abdomen
- III: Bronchospasmus, Schock
- IV: Herz-Kreislauf-Stillstand

SOFORTMASSNAHMEN
- Auslöser SOFORT stoppen!
- Adrenalin 0,5mg i.m. Oberschenkel (immer!)
- O_2 10-15 l/min
- Venenzugang, 500-1000ml Kristalloid
- Flachlagerung + Beine hoch (Schock)

FOLGEMEDIKATION
- H1: Dimetinden (Fenistil) i.v.
- H2-Blocker optional nach Klinikstandard
- Kortison: Prednisolon 250-1000mg i.v.
- Bei Bronchospasmus: Salbutamol inhalativ
- Notarzt rufen!

21 Hypoglykämie & Hyperglykämie

HYPOGLYKÄMIE (BZ < 70 MG/DL)

- Wach: 20g KH oral (4x Traubenzucker)
- Bewusstlos: Glukose 40% i.v. 20-40ml
- Oder: Glukagon 1mg i.m./s.c.
- BZ-Kontrolle nach 15 Min.
- Ursache klären!

HYPERGLYKÄMIE (BZ > 300 + KETON)

- DKA: Kussmaul-Atmung, Acetongeruch
- Flüssigkeit 0,9% NaCl (Arzt-AO)
- Insulin i.v. nach Anordnung
- Elektrolyte: K+ engmaschig!
- Arzt sofort informieren

NORMWERTE

- Nüchtern: 70-100 mg/dl
- 2h postprandial: < 140 mg/dl
- HbA1c-Ziel: < 7%
- ⚠️ < 50 mg/dl = Notfall!

22 EKG-Grundlagen

NORMALER SINUSRHYTHMUS

- HF 60-100/min, regelmäßig
- P-Welle vor jedem QRS
- PQ-Zeit: 120-200ms
- QRS-Breite: < 120ms
- QT-Zeit: < 440ms (Männer)

ALARMZEICHEN – SOFORT ARZT!

- VF/VT: Defibrillation!
- Asystolie: CPR sofort
- STEMI: ST-Hebung ≥ 2mm
- AV-Block III°: kein P→QRS
- Schrittmacher-Versagen

HÄUFIGE ARRHYTHMIEN

- VHF: unregelmäßig, kein P
- VES: breiter QRS, kompensatorische Pause
- LBBB/RBBB: QRS > 120ms
- WPW: kurzes PQ, Delta-Welle
- Torsade de pointes: Drehbewegung

23 Blasenkatheter-Pflege

KATHETERANLAGE – ASEPTISCH!

- Sterile Handschuhe + Kittel
- Desinfektion Meatus 3x (außen→innen)
- Charrière: Frauen 12-14 Ch, Männer 14-18 Ch
- Blockung: 5-10ml steriles Aqua dest.
- Fixierung: Schenkel innen (Frauen), Bauch (Männer)

CAUTI-PROPHYLAXE

- Tägliche Indikationsprüfung! (= wichtigste Maßnahme!)
- Geschlossenes System IMMER erhalten
- Beutel IMMER unter Blasenniveau
- Intimhygiene 2x täglich (Wasser, kein Desinfektionsmittel)
- Kein Abklemmen!

WARNSYMPTOME

- Trüber/übelriechender Urin
- Fieber + Flanken-/Bauchschmerz
- Blut im Urin → Arzt
- Beutel voll oder kein Urin (Stau?)
- Urinmenge < 0,5ml/kg/h

24 Magensonde (NGS)

ANLAGE

- Größe: Erwachsene 12-16 Ch
- Länge messen: Nase-Ohr-Nabel (ca. 50-60cm)
- Kopf leicht vorbeugen beim Einführen
- Lagekontrolle: Aspiration (pH ≤ 5.5) + Röntgen!
- Fixierung: Nasenpflaster, täglich wechseln

ERNÄHRUNGSMANAGEMENT

- 30-45° Oberkörperhochlagerung IMMER
- Sondenkost-Temperatur: Zimmertemperatur
- Spülung: 20-50ml Wasser vor/nach Gabe
- Restvolumen-Check alle 4h (> 200ml = Arzt!)
- Schlauch alle 24h wechseln

MEDIKAMENTENGABE

- Nur flüssige/lösliche Medikamente!
- Tabletten mörsern + auflösen (Rückfrage Apotheke)
- Interaktionen beachten (pH-abhängig)
- Spülung VOR und NACH Medikament
- Retard-Tabletten NIEMALS mörsern!

25 NEWS2-Score

PARAMETER (JE 0-3 PUNKTE)

- Atemfrequenz: 12-20 = 0, < 8 = 3
- SpO_2 (Skala 1): ≥ 96 = 0, ≤ 91 = 3
- SpO_2 (Skala 2, COPD): 88-92 = 0
- Systol. RR: 111-219 = 0, ≤ 90 = 3
- Puls: 51-90 = 0, ≤ 40 = 3
- Temperatur: 36.1-38.0 = 0
- Bewusstsein: alert = 0, CVPU = 3

AUSWERTUNG + REAKTION

- 0 = niedrig, min. 12h-Monitoring
- 1-4 = gering, mind. 4-6h
- 5-6 = mittel → Arzt sofort, mind. 1h
- ≥ 7 = HOCH → Notfallteam!
- Neu: O_2-Gabe = automatisch +2 Punkte

26 Delir-Erkennung (CAM-ICU)

CAM-ICU – 4 KRITERIEN

- 1. Akuter Beginn/Fluktuierender Verlauf
- 2. Unaufmerksamkeit (Buchstaben-Test: SAVEAHAART)
- 3. Desorganisiertes Denken
- 4. Veränderte Bewusstseinslage (RASS ≠ 0)
- ⚠️ Delir = Kriterien 1+2 + (3 ODER 4)!

NICHT-PHARMAKOLOGISCHE THERAPIE

- Tag-Nacht-Rhythmus (Licht, Uhren, Kalender)
- Frühmobilisation täglich
- Orientierungshilfen: Brille, Hörgerät!
- Schlaf fördern: Lärm/Licht reduzieren
- Familie einbeziehen, vertraute Stimmen

RASS-SKALA

- +4 Streitlustig, +3 Sehr agitiert
- 0 = Alert/wach (Ziel)
- −1 Schläfrig, −2 Leichte Sedierung
- −3 Moderate, −4 Tiefe Sedierung
- −5 Nicht erweckbar

27 Fixierung/FEM – Rechtliches

GRUNDSATZ

- FEM = Letztes Mittel!
- Erst: alle Alternativen ausschöpfen
- Sensormatten, Hüftprotektoren, Bettrandschutz
- Stuhlalarm, Betreuung intensivieren
- Pflegebett absenken

RECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN

- Richterliche Genehmigung (§1906 BGB) ODER
- Betreuungsrechtliche Einwilligung
- Notfall: ohne Genehmigung max. bis Richterentscheid
- Dokumentation: Grund, Zeit, Art, Kontrollen
- 1:1-Betreuung Pflicht!

ÜBERWACHUNG BEI FIXIERUNG

- Vitalzeichen alle 30 Min.
- Durchblutung, Atmung prüfen
- Toilettengang anbieten!
- Ablösen sobald möglich
- Nachgespräch führen
- PsychKG NRW beachten

28 Drainagen-Pflege

ALLGEMEINE REGELN

- Immer geschlossenes System!
- Niemals höher als Ableitstelle platzieren
- Drainagevolumen täglich dokumentieren
- Farbe, Konsistenz, Geruch beurteilen
- Eintrittsstelle täglich inspizieren

THORAXDRAINAGE

- Drainageflasche: 2/3 Wasser (Wasserventil!)
- Luft/Blut in Kammer = Komplikation → Arzt!
- Patient: keine tiefen Atemzüge vermeiden
- Klemmen NUR auf ärztliche Anordnung
- Milkingsysteme nach Standard

ABDOMINALDRAINAGE (JP, REDON)

- Redon: Unterdruck täglich prüfen
- JP-Drain: Kammer komprimieren nach Entleerung
- Auslitern, Dokumentation, Kultur bei Infektion
- Zug-Test täglich (zieht → fest verankert)
- Entfernung nach ärztl. AO: Asepsis!

29 Bluttransfusion

VOR DER TRANSFUSION
- Aufklärung + Einwilligung (schriftlich)!
- Blutgruppe + Kreuzprobe liegt vor?
- Produktidentifikation: Konserve ≠ Patient → STOPP
- Bettseitige Kontrolle: 2-Personen-Prinzip
- Venenzugang 16-18 G, nur NaCl 0,9%

WÄHREND DER TRANSFUSION
- Erste 15 Min.: langsam! (ca. 20-30 Tr./min)
- Patient nicht allein lassen!
- Vitalzeichen: vorher, nach 15 Min., nach Abschluss
- EK: max. 4h, TK: max. 30 Min., FFP: max. 6h

TRANSFUSIONSREAKTION → STOPP!
- Sofort stoppen, Zugang OFFEN halten
- Arzt sofort!
- Fieber, Schüttelfrost, Juckreiz, RR-Abfall
- Blut + Konserve aufbewahren
- Transfusionsreaktion meldepflichtig

30 Kinderreanimation (PBLS)

WICHTIGSTE UNTERSCHIEDE (VS. BLS)
- ZUERST 5 initiale Beatmungen!
- Dann: 15:2 (nicht 30:2!)
- Drucktiefe: 1/3 Thoraxtiefe (4-5cm)
- Säugling: 2 Finger, Kind: 1-2 Handballen
- Frequenz: 100-120/min (wie Erwachsene)

BESONDERHEITEN
- Kopf neutral (Säugling) / leicht überstreckt
- Mund-zu-Mund-Nase (Säugling!)
- AED: ab 1. Lebensjahr, Kinderpads ≤ 25kg
- Adrenalin: 0,01mg/kg i.v. (= 0,1ml/kg 1:10.000)
- IO-Nadel wenn kein i.v.-Zugang in 2 Versuchen

ATEMWEGE KIND
- Säugling atmet nasal → Nase freihalten!
- Pseudokrupp: kühle Luft + Kortison
- Epiglottitis: Kind ruhig halten, kein Spatel!
- Fremdkörper: Rückenschläge + Heimlich ab 1J.

31 WHO-Schmerztherapie

STUFE 1: NICHT-OPIOIDE
- Paracetamol 500-1000mg alle 4-6h (max. 4g/d)
- Ibuprofen 400-800mg alle 6-8h (mit Mahlzeit!)
- Metamizol 500-1000mg alle 6h (langsam i.v.!)
- Diclofenac 50-100mg alle 8-12h
- ± Adjuvanzien (Antikonvulsiva, Antidepressiva)

STUFE 2: SCHWACHE OPIOIDE
- Tramadol 50-100mg alle 6-8h
- Tilidin/Naloxon 50/4-100/8mg
- Cave: Übelkeit, Schwindel!
- Immer mit Laxans!
- Kombination mit Stufe-1 möglich

STUFE 3: STARKE OPIOIDE
- Morphin retardiert alle 8-12h
- Oxycodon alle 12h, Fentanyl-Pflaster 72h
- IMMER Laxans von Anfang an (Macrogol)!
- Antiemetikum für die ersten Tage
- NRS-Kontrolle vor/nach Gabe dokumentieren

32 Beatmung Grundlagen

STARTPARAMETER (ERWACHSENER)
- Tidalvolumen: 6-8ml/kg Idealgewicht
- Frequenz: 12-16/min
- PEEP: 5-8 cmH_2O (Standard)
- FiO_2: Start 1,0 → titrieren auf SpO_2 ≥94%
- Plateaudruck: < 30 cmH_2O (Lungenprotektion)

ALARME → URSACHEN
- Hoher Druck: Husten, Sekret, Tubusabknick, PNX
- Niedriges TV: Leck, Cuff-Druckverlust
- Apnoe: Tubusverlegung/-dislokation → sofort!
- Niedrige SpO_2: Tubuslage, Absaugen, FiO_2 ↑
- Kapno ↑: Hypoventilation, ↓: Fehlage/PE

VAP-PROPHYLAXE (BUNDLE)
- OK 30-45° hochlagern IMMER
- Cuff-Druck 20-30 cmH_2O halten
- Mundpflege Chlorhexidin 2x täglich
- Subglottische Absaugung (falls Tubus)
- Tägliche Extubationsprüfung!

33 Flüssigkeitsbilanz

EINFUHR DOKUMENTIEREN
- Trinkmenge (Becher abmessen!)
- Infusionen + Medikamente i.v.
- Enterale/parenterale Ernährung
- Blutprodukte, Spülungen
- Ziel: exakte ml-Angaben

AUSFUHR DOKUMENTIEREN
- Urin (Dauerkatheter: exakt; ohne: schätzen)
- Erbrechen, Drainagen, Wundexsudat
- Stuhl (schätzen: gering/mittel/viel)
- Perspiratio: ca. 500-700ml/24h (unsichtbar)
- Fieber: +200ml/°C über 37°C

AUSWERTUNG
- Ausgeglichene Bilanz = Einfuhr ≈ Ausfuhr
- + Bilanz: Ödemgefahr, Herzinsuffizienz
- − Bilanz: Dehydration, Nierenversagen
- Tägliche Gewichtskontrolle! (1kg ≈ 1L)
- > +1kg/Tag → Arzt informieren

34 Nach einem Sturz

SOFORTMASSNAHMEN
- Patient NICHT sofort aufheben!
- Ersteinschätzung: Bewusstsein, Atmung, Puls
- Verletzungen prüfen: Kopf, Hüfte, Handgelenk
- Bei Verdacht Fraktur: ruhig lagern, Notarzt
- Vitalzeichen, Schmerz-NRS, Pupillen

DOKUMENTATION (SOFORT!)
- Zeitpunkt, Ort, Sturzhergangsbeschreibung
- Wer war dabei? Zeugen?
- Vorgefundene Situation
- Durchgeführte Maßnahmen
- Arztinfo + Angehörigeninfo

NACHBEARBEITUNG
- Sturzprotokoll ausfüllen
- CIRS-Meldung erwägen
- Sturzrisiko neu bewerten (Morse/STRATIFY)
- Maßnahmenplan anpassen
- Patientengespräch + Edukation

35 Tracheostoma Pflege

ABSAUGUNG (NUR BEI BEDARF!)
- Präoxygenieren: FiO_2 ↑ für 2 Min.
- Steriler Katheter: max. Kanülendurchmesser
- Einführtiefe: max. 0,5cm über Kanülenspitze
- Sog: max. 150-200 cmH_2O
- Max. 15 Sekunden pro Absaugvorgang!

INNENKANÜLE & HME-FILTER
- Innenkanüle alle 8h reinigen/wechseln
- HME-Filter alle 24h wechseln (Befeuchtung!)
- Stoma täglich mit NaCl-Kompressen reinigen
- Cuff-Druck: 20-25 cmH_2O (Manometer!)
- Sprechventil: nur bei bewusstem, stabilen Pat.

NOTFALL – KANÜLE VERLEGT/HERAUSGEFALLEN
- Ruhe! Sauerstoff sofort anlegen
- Absaugen versuchen
- Kanüle wechseln (immer bereit haben!)
- Notfallset am Bett: Kanülen (gleiche + eine Nr. kleiner)
- Notarzt wenn keine Ventilation möglich

36 Schutzausrüstung PSA

ANLEGEN (IN DIESER REIHENFOLGE)
- 1. Kittel (hinten binden)
- 2. Maske/FFP2 (Nasenbügel anformen!)
- 3. Schutzbrille
- 4. Handschuhe (über Kittelärmel ziehen)
- Vor Anlegen: Händedesinfektion!

ABLEGEN (IN DIESER REIHENFOLGE)
- 1. Handschuhe (nach innen stülpen)
- 2. Kittel (nach innen rollen)
- 3. Schutzbrille (an Bügeln absetzen)
- 4. Maske (Bänder lösen, nicht vorne anfassen)
- Nach jedem Schritt: Händedesinfektion!

MASKEN-ÜBERSICHT
- MNS/OP-Maske: Tröpfcheninfektionen
- FFP2: MRSA, COVID, Influenza
- FFP3: Offene TBC, SARS
- Wechsel: MNS nach 3-4h, FFP2 nach 8h
- Feuchte Masken SOFORT wechseln!

37 SAMPLE-Anamnese Notfall

S – SYMPTOME
- Hauptbeschwerde in eigenen Worten
- Lokalisation, Charakter, Intensität (NRS)
- Beginn, Verlauf, auslösende Faktoren
- Begleitsymptome

A – ALLERGIEN / M – MEDIKAMENTE
- A: Allergien auf Medikamente, Latex, Lebensmittel
- M: Aktuelle Dauermedikation (auch freiverkäuflich!)
- Letzte Einnahme, Dosierung
- Blutgerinnungshemmer besonders wichtig!

P – PROBLEME / L – LETZTE MAHLZEIT / E – EREIGNIS
- P: Bekannte Erkrankungen, Operationen, Krankenhausaufenthalte
- L: Letzte Nahrungsaufnahme (Narkose-relevant!)
- E: Was ist passiert? Hergang, Unfallmechanismus
- Immer bei Trauma: ATLS-Schema

38 Intensiv-Medikamente

VASOPRESSOREN/KATECHOLAMINE
- Noradrenalin: 0,01-1,0 µg/kg/min (First-Line Sepsis)
- Adrenalin: 0,01-0,5 µg/kg/min
- Dobutamin: 2-20 µg/kg/min (Kardiogen. Schock)
- Vasopressin: 0,03-0,04 E/min (Add-on)
- NIEMALS unterbrechen → Backup-Perfusor!

SEDIERUNG/ANALGESIE (PADIS)
- Analgesie ZUERST! (Pain before sedation)
- Propofol: 0,3-4 mg/kg/h (max. 48h!)
- Midazolam: 0,03-0,2 mg/kg/h
- Dexmedetomidin: 0,2-1,4 µg/kg/h (kooperativ!)
- Ziel: RASS -1 bis 0 (leicht sediert)

HÄUFIGE I.V.-PERFUSOREN
- Heparin: nach aPTT 60-80s
- Insulin: BZ-Protokoll, Ziel 140-180 mg/dl
- Furosemid: 5-40mg/h (Diurese-Protokoll)
- Amiodaron: 900mg/24h Erhalt nach Bolus
- Kalium: max. 20 mmol/h über ZVK!

39 Manchester Triage (MTS)

5 DRINGLICHKEITSSTUFEN
- Rot · sofort · 0 min
- Orange · sehr dringend · 10 min
- Gelb · dringend · 30 min
- Grün · normal · 90 min
- Blau · nicht dringend · 120 min

PRINZIP
- Präsentationsdiagramme + Indikatoren
- Höchste zutreffende Stufe zählt
- Legt Wartezeit fest, nicht Reihenfolge

ROT – BEISPIELE
- Kreislaufstillstand · Schock
- Verlegte Atemwege
- Nicht ansprechbar / schwerste Atemnot

MERKE
- 0–10–30–90–120 min (Rot→Blau)
- Ersteinschätzung, keine Diagnose

40 Pädiatrie Notfälle

ATEMNOT BEIM KIND
- Pseudokrupp: Ruhe, Steroid, schwerer Stridor → Adrenalin-Inhalation
- Bronchiolitis (RSV): absaugen, O_2 titrieren, Apnoen beachten
- Asthma: SABA inhalativ + ggf. Steroid

FIEBERKRAMPF
- Schützen, nichts in den Mund
- Dauer messen, > 5 min durchbrechen
- Meningitis ausschließen (Petechien/Nackensteife)

EXSIKKOSE (GASTROENTERITIS)
- ORS in kleinen Mengen häufig
- i.v. bei Schock
- keine Motilitätshemmer

FREMDKÖRPERASPIRATION
- Effektiver Husten → ermutigen
- Säugling: 5 Rückenschläge + 5 Thoraxkompressionen
- Nie blind auswischen; bewusstlos → CPR

WARNZEICHEN
- Leiser werdender Stridor + Erschöpfung
- Apnoen beim Säugling
- Nicht wegdrückbare Petechien = Notfall

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf
plan-nrw.de

KOMPENDIUM · PRÜFUNGSWISSEN

Prophylaxen-Kompendium

Alle examensrelevanten Prophylaxen mit Risikofaktoren, Assessment-Skalen, Maßnahmen und Expertenstandards – übersichtlich zum Lernen und Nachschlagen.

Bestehen ist planbar.

Expertenstandards | Assessment-Skalen | Hygiene | Examen

16	DNQP	A4
Themen	Standards	druckfertig

⚠ Lernhilfe für Ausbildung und Prüfung. Es gelten die Standards und Verfahrensanweisungen deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

plan-nrw.de

Inhalt

Jedes Thema auf einer eigenen Seite – ideal zum Ausdrucken und Abheften.

01 Dekubitusprophylaxe
02 Sturzprophylaxe
03 Thromboseprophylaxe
04 Pneumonieprophylaxe
05 Aspirationsprophylaxe
06 Kontrakturprophylaxe
07 Intertrigoprophylaxe
08 Obstipationsprophylaxe
09 Dehydrationsprophylaxe
10 Mangelernährungsprophylaxe
11 Infektionsprophylaxe / Hygiene
12 Stomatitisprophylaxe
13 Parotitisprophylaxe
14 Hygienische Händedesinfektion
15 Handschuhe – Wann ja, wann nein?
16 Allgemeine Krankenhaushygiene

1 Dekubitusprophylaxe

Maßnahmen zur Verhütung von Druckgeschwüren durch Druckentlastung, Hautpflege und Mobilisation.

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität / Bettlägerigkeit
- Mangelernährung & Dehydration
- Inkontinenz / Feuchtigkeit
- Sensibilitätsstörungen
- Durchblutungsstörungen
- Hohes Alter

ASSESSMENT-SKALA

Braden-Skala

≤18 Punkte = Risiko · ≤12 = hohes Risiko · ≤9 = sehr hohes Risiko

- Sensorisches Empfindungsvermögen
- Feuchtigkeit
- Aktivität
- Mobilität
- Ernährung
- Reibung & Scherkräfte

KATEGORIEN / STADIEN

- Kat. I: Nicht wegdrückbare Rötung, Haut intakt
- Kat. II: Teilverlust der Haut (Blase/Abschürfung)
- Kat. III: Vollständiger Hautverlust, Subkutis sichtbar
- Kat. IV: Vollständiger Gewebeverlust, Knochen/ Sehnen sichtbar

MASSNAHMEN

- Lagerungswechsel alle 2 Stunden (oder individueller Plan)
- Antidekubitusmatratze / Wechseldruckmatratze
- Druckentlastung: Fersen, Steißbein, Schulterblätter
- Hautbeobachtung bei jeder Pflege (Rötung = Kategorie I)
- Hautpflege: pH-neutral, keine Massage bei Rötung
- Flüssigkeit mind. 1,5–2 l/Tag
- Proteinreiche Ernährung
- Inkontinenzversorgung optimieren
- Dokumentation nach Kategorien I–IV (EPUAP)

Standard / Grundlage: DNQP Expertenstandard Dekubitusprophylaxe (2017)

2 Sturzprophylaxe

Maßnahmen zur Verhinderung von Stürzen, besonders bei älteren und kognitiv eingeschränkten Patienten.

RISIKOFAKTOREN

- Gangstörungen, Gangunsicherheit
- Schwindel, orthostatische Hypotonie
- Seheinschränkungen
- Kognitive Beeinträchtigung / Demenz
- Polymedikation (Sedativa, Diuretika, Antihypertensiva)
- Frühere Stürze
- Inkontinenz (Dranggefühl)
- Unbekannte Umgebung

ASSESSMENT-SKALA

Morse-Sturzskala

0–24 = kein Risiko · 25–44 = mittleres Risiko · ≥45 = hohes Risiko

- Sturzvorgeschichte
- Sekundärdiagnose
- Gehhilfe
- IV-Zugang
- Gang
- Geistiger Zustand

MASSNAHMEN

- Rufanlage in Reichweite, Funktion erklären
- Bett auf niedrigste Position
- Orientierungslicht nachts
- Rutschfeste Schuhe / Socken
- Haltegriffe im Bad und WC
- Gehhilfen griffbereit
- Medikamente prüfen (Sedativa reduzieren?)
- Regelmäßiges Toilettenanbieten
- Sturzprotokoll nach Sturzereignis

Standard / Grundlage: DNQP Expertenstandard Sturzprophylaxe (2013/2019)

3 Thromboseprophylaxe

Vorbeugung tiefer Venenthrombosen durch physikalische und medikamentöse Maßnahmen.

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität / Bettruhe
- Postoperativer Zustand
- Übergewicht (BMI >30)
- Dehydration
- Herzinsuffizienz
- Malignom
- Frühere TVT / LE
- Hormontherapie

WARNZEICHEN

- Wadenschmerz
- Schwellung
- Überwärmung
- Rötung
- Homans-Zeichen

MASSNAHMEN

- Frühmobilisation so früh wie möglich
- Kompressionsstrümpfe (ATS Kl. I/II) korrekt anlegen
- Intermittierende pneumatische Kompression (IPK)
- Beinübungen im Bett (Pumpen, Kreisen)
- Ausreichend Flüssigkeit
- NMH s.c. nach Anordnung (Clexane, Fragmin)
- Bei oraler Antikoagulation: INR / Anti-Xa überwachen

NOTFALLMASSNAHMEN

Lungenembolie: Dyspnoe + Tachykardie + Thoraxschmerz → SOFORT Arzt!

Standard / Grundlage: S3-Leitlinie Prophylaxe der venösen Thromboembolie (AWMF)

4 Pneumonieprophylaxe

Vorbeugung einer Lungenentzündung durch Sekretmobilisation, Atemübungen und Frühmobilisation.

RISIKOFAKTOREN

- Bettlägerigkeit
- Beatmung / Intubation
- Schluckstörungen
- Rauchen
- COPD, Asthma
- Immunsuppression
- Hohes Alter
- Schmerzen (verhindert tiefes Atmen)

MASSNAHMEN

- Atemgymnastik: tiefes Ein-/Ausatmen, Lippenbremse
- Atemstimulierende Einreibung (ASE) nach Bienstein
- Inzentiv-Spirometer (Flutter, Triflow)
- Sekretmobilisation: Abklopfen, Vibrationsmassage
- Oberkörperhochlagerung 30° (besonders bei Beatmung)
- Frühmobilisation: Sitzen → Stehen → Gehen
- Ausreichend Flüssigkeit (Sekret verflüssigen)
- Mundpflege (Keimreduktion)
- Schmerzmanagement

ATEMSTIMULIERENDE EINREIBUNG (ASE)

ASE: Kreisende Bewegungen am Rücken im Atemrhythmus des Patienten, 5–10 Min., fördert reflektorisch die Atemtiefe

5 Aspirationsprophylaxe

Verhütung des Eindringens von Speichel, Nahrung oder Mageninhalt in die Atemwege.

RISIKOFAKTOREN

- Schluckstörungen (Dysphagie)
- Bewusstseinsstörungen
- PEG / nasogastrale Sonde
- Erbrechen / Reflux
- Neurologische Erkrankungen
- Demenz
- Sedierung

MASSNAHMEN

- Oberkörper beim Essen 30–90° hochlagern
- Position 30 min nach Essen beibehalten
- Schlucktestung vor erster Mahlzeit
- Angedickte Kost / Flüssigkeiten
- Kein Strohhalm bei Schluckstörung
- Kleine Bissen, langsames Essen
- Absauggerät bereithalten
- Logopädie einbeziehen

6 Kontrakturprophylaxe

Verhütung von Gelenkversteifungen durch regelmäßige Bewegung und korrekte Lagerung.

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität / Lähmungen
- Spastik (z.B. nach Schlaganfall)
- Schmerzen (Schonhaltung)
- Bewusstlosigkeit
- Frakturen / Verbände

MASSNAHMEN

- Passive Bewegungsübungen aller Gelenke (2× täglich)
- Korrekte Lagerung in Funktionsstellung
- Keine Spitzfußlage: Antispitzfußschiene / Fußstütze
- Handrolle bei Faustbildungstendenz
- Frühmobilisation
- Physiotherapie einbeziehen
- Schmerzen behandeln

LAGERUNGSTECHNIKEN

- Funktionsstellung: Gelenke in physiologischer Mittelstellung lagern
- Lagerung regelmäßig wechseln (Rücken-, Seiten-, 30°-Lagerung)
- Bei Hemiplegie: Lagerung nach Bobath-Konzept, betroffene Seite einbeziehen
- Füße: Fußsohle abgestützt, Bettdecke nicht auf die Zehen drücken lassen
- Lagerungshilfsmittel gezielt einsetzen, keine starren Dauerlagerungen

Standard / Grundlage: Kein eigener DNQP-Expertenstandard – Orientierung an Physiotherapie- und Bobath-Konzept

7 Intertrigoprophylaxe

Verhütung von Hautreizungen in Hautfalten durch Feuchtigkeit, Reibung und Wärme.

RISIKOFAKTOREN

- Übergewicht
- Diabetes
- Schwitzen
- Inkontinenz
- Immobilität

MASSNAHMEN

- Hautfalten täglich inspizieren (Achseln, Leisten, Bauch, Brust)
- Sorgfältig trocknen (Föhn auf niedrigster Stufe)
- Zinksalbe oder Cavilon-Spray
- Baumwolltücher zwischen Hautfalten
- Atmungsaktive Kleidung
- Bei Candidose: Nystatin-Puder

8 Obstipationsprophylaxe

Verhütung von Verstopfung durch Flüssigkeit, ballaststoffreiche Kost und Bewegung.

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität
- Geringe Flüssigkeitszufuhr
- Ballaststoffarme Ernährung
- Opioide / Anticholinergika
- Schilddrüsenunterfunktion
- Demenz

MASSNAHMEN

- Flüssigkeit mind. 1,5–2 l/Tag
- Ballaststoffreiche Kost: Vollkorn, Obst, Gemüse
- Körperliche Aktivität
- Bauchmassage im Uhrzeigersinn
- Warmes Getränk morgens (Gastrokolischer Reflex)
- Stuhlprotokoll führen
- Laxanzien nach AO: Macrogol, Lactulose, Bisacodyl
- Bei Opioidtherapie: prophylaktisch Laxans!

9 Dehydrationsprophylaxe

Verhütung von Flüssigkeitsmangel durch ausreichende Zufuhr und frühzeitige Erkennung.

RISIKOFAKTOREN

- Hohes Alter (Durstgefühl ↓)
- Demenz
- Schluckstörungen
- Fieber / Erbrechen / Durchfall
- Diuretika
- Hitze

WARNZEICHEN

- Trockene Schleimhäute
- Stehende Hautfalten
- Konzentrierter Urin (dunkelgelb)
- Tachykardie
- Hypotonie
- Verwirrtheit

MASSNAHMEN

- Trinkprotokoll führen (Ziel 1,5–2 l/Tag)
- Getränke in Reichweite stellen
- Alle 2h Trinken anbieten
- Lieblingsgetränke erfragen
- Ein-/Ausfuhr bilanzieren bei Risiko
- Suppe, Joghurt, Obst als Flüssigkeitsquellen
- Bei Dysphagie: angedickte Flüssigkeiten

10 Mangelernährungsprophylaxe

Verhütung von Unterernährung durch Ernährungsassessment und gezielte Maßnahmen.

ASSESSMENT-SKALA

MNA (Mini Nutritional Assessment)

≥24 = gut · 17–23,5 = Risiko · <17 = Mangelernährung

MASSNAHMEN

- Gewicht wöchentlich kontrollieren
- Ernährungsprotokoll führen
- Appetitfördernde Maßnahmen: Lieblingsessen, Atmosphäre
- Kleine häufige Mahlzeiten
- Hochkalorische Trinknahrung (Fresubin, Ensure)
- Essen assistieren bei Bedarf
- Mundpflege (Schmerzen beim Essen?)
- Ernährungsberatung
- PEG bei dauerhafter oraler Unfähigkeit

11 Infektionsprophylaxe / Hygiene

Verhütung nosokomialer Infektionen durch konsequente Hygienemaßnahmen.

MASSNAHMEN

- Händehygiene: 5 Momente der WHO
- Hygienische HD: 30 Sekunden · Chirurgische HD: 3 Minuten
- Schutzausrüstung situationsgerecht: Handschuhe, Kittel, Maske
- Aseptisches Arbeiten bei Wundversorgung, Katheter, Infusionen
- Katheter: täglich Notwendigkeit prüfen (CAUTI-Prävention)
- Isolationsmaßnahmen bei MRSA, VRE, ESBL
- Reinigungs- und Desinfektionsplan einhalten

5 MOMENTE DER HÄNDEHYGIENE

- 1. Vor Patientenkontakt
- 2. Vor aseptischen Tätigkeiten
- 3. Nach Kontakt mit infektiösem Material
- 4. Nach Patientenkontakt
- 5. Nach Kontakt mit Patientenumgebung

12 Stomatitisprophylaxe

Verhütung von Mundschleimhautentzündungen, besonders bei Chemo, Immunsuppression und Beatmung.

MASSNAHMEN

- Mundpflege 4–6× täglich (weiche Zahnbürste)
- Schleimhäute feucht halten (Mundspray, Glycerin)
- Keine alkoholhaltigen Mundspülungen
- Kamillentee / Salbeitee zum Spülen
- Bei Chemotherapie: Mundschleimhaut kühlen (Eiswürfel)
- Bei Soor: Nystatin-Suspension
- Lippen mit Fettsalbe pflegen
- Prothesen nachts herausnehmen und reinigen

13 Parotitisprophylaxe

Verhütung der Ohrspeicheldrüsenentzündung durch ausreichende Speichelproduktion und Mundpflege.

RISIKOFAKTOREN

- Dehydration
- Mundatmung
- NPO (Nahrungskarenz)
- Immunsuppression
- Anticholinergika

MASSNAHMEN

- Ausreichend Flüssigkeit
- Regelmäßige Mundpflege
- Kaugummi kauen (Speichelfluss ↑)
- Saure Drops (Speichelproduktion ↑)
- Mundatmung vermeiden: Nasenpflege
- Ohrspeicheldrüse beobachten (Schwellung, Schmerz)

14 Hygienische Händedesinfektion

Die hygienische Händedesinfektion ist die wichtigste Einzelmaßnahme zur Verhütung nosokomialer Infektionen. Sie reduziert die transiente Keimflora auf ein sicheres Niveau (WHO, KRINKO 2016).

INDIKATIONEN

- 1. Vor Patientenkontakt
- 2. Vor aseptischen Tätigkeiten (Wundversorgung, Katheter, Infusion)
- 3. Nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material (Blut, Körperflüssigkeiten)
- 4. Nach Patientenkontakt
- 5. Nach Kontakt mit Patientenumgebung (Klingel, Bettgitter, Nachttisch)

DURCHFÜHRUNG

- Mindestens 3–5 ml alkoholisches Händedesinfektionsmittel entnehmen
- Einreiben mindestens 30 Sekunden (EN 1500)
- Schritt 1: Handfläche auf Handfläche reiben
- Schritt 2: Rechte Handfläche über linken Handrücken, wechseln
- Schritt 3: Handfläche auf Handfläche mit verschränkten Fingern
- Schritt 4: Außenseite der Finger durch Einschlagen
- Schritt 5: Daumen eingeschlossen in anderer Hand, wechseln
- Schritt 6: Fingerkuppen kreisend in Handfläche, wechseln
- Hände trocknen lassen – NICHT abwischen!

MASSNAHMEN

Creme

- Hände waschen NUR wenn sichtbar verschmutzt oder nach C.-difficile-Kontakt (Sporenbildner – Alkohol unwirksam!)
- Vor Desinfektion: Hände TROCKEN (feuchte Hände reduzieren Wirksamkeit)
- Handschuhe ersetzen Händedesinfektion NICHT
- Kein Schmuck, keine Uhren, keine langen Fingernägel, kein Nagellack
- Hautschutz: vor Dienst → Schutzpräparat · während Dienst → Pflegecreme · nach Dienst → rückfettende

HÄUFIGE FEHLER

- Zu wenig Desinfektionsmittel aufgetragen (verdampft zu schnell)
- Fingerkuppen und Daumen vergessen – häufigste Fehlerzone!
- Handschuhe abziehen ohne anschließende Desinfektion
- Hautschutz vernachlässigt → Hautschäden → Keimreservoir

Standard / Grundlage: WHO-Leitlinie Händehygiene 2009 · KRINKO-Empfehlung Händehygiene 2016 · EN 1500

15 Handschuhe – Wann ja, wann nein?

Handschuhe schützen Patient und Pflegende. Falscher Einsatz macht Handschuhe selbst zum Übertragungsweg. Sie ersetzen die Händedesinfektion NICHT.

MASSNAHMEN

HANDSCHUHE: WANN JA

HANDSCHUHE: WANN NEIN

- Nach jedem Handschuhwechsel: Händedesinfektion!
- Handschuhe direkt nach Gebrauch entsorgen – nicht in Taschen tragen
- Handschuhgröße wählen: zu eng → reißen · zu weit → rutschen
- Latexallergie: Nitril-Handschuhe verwenden
- Kontakt mit Blut, Körperflüssigkeiten, Sekreten, Exkreten
- Kontakt mit Schleimhäuten oder nicht-intakter Haut
- Legen / Pflege von Gefäßzugängen, Kathetern, Drainagen
- Wundversorgung
- Kontakt mit kontaminierten Materialien (Verbände, Wäsche)
- Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Schutzhandschuhe)
- Isolationspflichtige Patienten (MRSA, VRE, Noro etc.)
- Normaler Patientenkontakt ohne Körperflüssigkeitskontakt (Begrüßung, Blutdruck messen)
- Medikamente richten ohne Kontaminationsrisiko
- Dauerhaftes Tragen ohne Indikation → Übertragungsweg + falsche Sicherheit

WARUM NICHT DAUERHAFT TRAGEN

- Handschuhe haben mikro-poröse Defekte – kein 100% Schutz
- Beim Aus-/Anziehen leichte Kontamination der Hände möglich
- Falsches Sicherheitsgefühl: Desinfektion wird vergessen
- Erhöhtes Übertragungsrisiko bei Wechsel ohne Händedesinfektion

HANDSCHUHTYPEN

- Untersuchungshandschuhe (Nitril/Latex): nicht-steril, allgemeiner Schutz
- Sterile OP-Handschuhe: aseptische Eingriffe, sterile Katheterisierung
- Haushaltshandschuhe: Reinigung und Flächendesinfektion
- Chemikalienschutzhandschuhe: Desinfektionsmittelkonzentrate

Standard / Grundlage: TRBA 250 (Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen) · KRINKO 2016

16 Allgemeine Krankenhaushygiene

Krankenhaushygiene umfasst alle Maßnahmen zur Verhütung nosokomialer Infektionen. Ca. 400.000–600.000 nosokomiale Infektionen jährlich in Deutschland, ca. 10.000–15.000 Todesfälle.

RISIKOFAKTOREN

- Liegekatheter (CAUTI-Risiko: täglich Notwendigkeit prüfen!)
- Gefäßzugänge (ZVK-assoziierte Sepsis)
- Beatmung (VAP)
- Postoperative Wundinfektionen
- Immunsupprimierte Patienten

MASSNAHMEN

Schlussdesinfektion

- Flächendesinfektion: täglich patientennahe Flächen (Bettgitter, Nachttisch, Klingel), nach Entlassung
- Wischdesinfektion: von rein nach unrein · von oben nach unten · Einwirkzeit beachten
- Abfall: Gruppe A (Hausmüll) · Gruppe B (infektiös) · Gruppe C (Zytostatika) · Sharpsafe für Nadeln
- Kanülen NIEMALS recappen – Nadelstichverletzungsgefahr!
- Infektionswäsche: roter Sack, direkt verschließen, nicht ausschütteln
- PSA anlegen: Kittel → Maske → Brille → Handschuhe
- PSA ablegen: Handschuhe → Kittel → Brille → Maske → Händedesinfektion

ISOLATIONSMASSNAHMEN

- MRSA: Einzelzimmer, Kittel + Handschuhe + FFP2
- VRE: Einzelzimmer, Kittel + Handschuhe
- Norovirus/C. difficile: Einzelzimmer, Händewaschen (kein Alkohol!), Kittel + Handschuhe
- Tröpfchen (Influenza, COVID): chirurgischer MNS oder FFP2
- Aerogen (TBC): Einzelzimmer mit Unterdruck, FFP3

MELDEPFLICHT

NRW

- Nosokomiale MRSA/VRE/ESBL-Infektionen: Meldepflicht §6/§7 IfSG
- Ausbrüche (≥2 Erkrankungen, epidemiolog. Zusammenhang): sofortige Meldung ans Gesundheitsamt
- Krankenhäuser: Surveillance-Pflicht nach §23 IfSG
- Schulungspflicht: mind. 1× jährlich

Standard / Grundlage: Infektionsschutzgesetz (IfSG) §23, §36 · KRINKO-Empfehlungen · Hygieneverordnung

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**

NOTFALL-POSTER · ZUM AUSDRUCKEN

Reanimation & Notfallalgorithmen

4 Algorithmen im Überblick – Erwachsene, Kinder, Fremdkörper und erweiterte Maßnahmen. A4-Poster zum Ausdrucken, Laminieren und Lernen.

Bestehen ist planbar.

BLS Erwachsene | PBLS Kinder | Fremdkörper | ALS Klinik

4	A4	ERC
Algorithmen	druckfertig	Leitlinien-basiert

INHALT

1. BLS – Basic Life Support
2. PBLS – Kinder & Säuglinge
3. Fremdkörperverlegung
4. ALS – Advanced Life Support

⚠ Nur zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken. Ersetzt kein zertifiziertes BLS-/ALS-Training, keine innerklinischen Standards und keine ärztliche Anordnung. Maßgeblich sind die jeweils aktuellen ERC-Leitlinien und dein Klinikstandard.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

plan-nrw.de

1 BLS – Basic Life Support

Erwachsene · Ersthelfer außerhalb und innerhalb der Klinik

Patient reagiert nicht?
Laut ansprechen, an den Schultern rütteln

↓

Laut um Hilfe rufen

↓

Atemwege freimachen & Atmung prüfen
Kopf überstrecken, Kinn anheben · sehen, hören, fühlen – max. 10 Sek.

↓

Keine normale Atmung oder Schnappatmung
= Kreislaufstillstand

↓

Notruf 112 · AED holen lassen
Handy auf Lautsprecher, Patienten nicht verlassen

↓

30 Thoraxkompressionen
Mitte des Brustkorbs · 5–6 cm tief · 100–120/Min. · vollständig entlasten

↓

2 Beatmungen
Wenn geschult – sonst durchgehend drücken

↓

Zyklus 30 : 2 fortsetzen
Bis AED bereit, Rettungsdienst übernimmt oder Patient normal atmet

↓

AED anschließen, sobald verfügbar
Sprachanweisungen folgen · Unterbrechungen kurz halten

Merke: Alle 2 Minuten Drücker wechseln, wenn ein zweiter Helfer da ist – die Qualität der Kompressionen lässt schnell nach.

2 PBLS – Paediatric Basic Life Support

Säuglinge und Kinder bis zur Pubertät

Kind reagiert nicht?
Ansprechen, sanft berühren – Säugling nicht schütteln

↓

Um Hilfe rufen

↓

Atemwege öffnen & Atmung prüfen
Säugling: Kopf neutral · Kind: Kopf leicht überstrecken · max. 10 Sek.

↓

Keine normale Atmung

↓

5 initiale Beatmungen
Säugling: Mund-zu-Mund-und-Nase · Kind: Mund-zu-Mund

↓

Lebenszeichen prüfen
Kein sicheres Lebenszeichen → sofort Kompressionen

↓

15 Kompressionen : 2 Beatmungen
1/3 der Brustkorbtiefe (Säugling ca. 4 cm, Kind ca. 5 cm) · 100–120/Min.

↓

Notruf 112
Zweiter Helfer sofort · allein: über Lautsprecher, sonst nach 1 Minute CPR

↓

15 : 2 fortsetzen
Bis Rettungsdienst übernimmt oder das Kind normal atmet

Merke: Säugling = zwei Finger oder zwei Daumen mit umgreifenden Händen · Kind = ein oder zwei Handballen.

3 Fremdkörperverlegung der Atemwege

Erwachsene und Kinder · Besonderheiten beim Säugling

Plötzliches Husten, Würgen, Atemnot?
Oft beim Essen · Patient greift sich an den Hals

Husten wirksam

Kann husten, sprechen, atmen

↓

Zum Husten ermutigen
Nichts weiter tun, engmaschig beobachten

↓

Verschlechterung?
→ wie bei unwirksamem Husten

Husten unwirksam

Kein Laut, keine Atmung

↓

5 Rückenschläge
Zwischen die Schulterblätter, Oberkörper nach vorn gebeugt

↓

5 Oberbauchkompressionen
Heimlich-Manöver · Säugling: 5 Thoraxkompressionen!

↓

Im Wechsel 5 : 5
Bis Fremdkörper gelöst ist

Wird bewusstlos?
Sofort Notruf 112 und mit CPR beginnen (BLS bzw. PBLS)

Nach Oberbauchkompressionen immer ärztlich abklären lassen – innere Verletzungen sind möglich.

4 ALS – Advanced Life Support

Klinischer Ablauf mit Defibrillator und Medikamenten

Kreislaufstillstand · Reanimationsteam rufen
CPR 30 : 2 · Defibrillator/Monitor anschließen

↓

Rhythmus beurteilen

Schockbar (VF / pulslose VT)

1 Schock

↓

Sofort CPR für 2 Min.
Danach Rhythmus erneut prüfen

↓

Nach dem 3. Schock
Adrenalin 1 mg i.v./i.o. + Amiodaron 300 mg

↓

Weiter
Adrenalin alle 3–5 Min. · Amiodaron 150 mg nach dem 5. Schock

Nicht schockbar (Asystolie / PEA)

Sofort CPR für 2 Min.

↓

Adrenalin 1 mg i.v./i.o.
So früh wie möglich

↓

Rhythmus alle 2 Min. prüfen

↓

Adrenalin alle 3–5 Min.

WÄHREND DER CPR

- Hochwertige Kompressionen, Pausen < 5 Sek.
- Sauerstoff, Atemwegssicherung, Kapnografie
- Gefäßzugang i.v. oder i.o.

REVERSIBLE URSACHEN

- **4 H:** Hypoxie · Hypovolämie · Hypo-/Hyperkaliämie (metabolisch) · Hypo-/Hyperthermie
- **HITS:** Herzbeuteltamponade · Intoxikation · Thrombose (Lunge/Herz) · Spannungspneumothorax

Nach ROSC: ABCDE-Schema · SpO_2 94–98 % · 12-Kanal-EKG · Ursache behandeln · Fieber vermeiden.

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**

GRATIS-LERNHILFE · NACHSCHLAGEN

Laborwerte kompakt

Die wichtigsten Laborwerte mit Normbereich und was erhöhte oder erniedrigte Werte bedeuten – mit Fokus auf das, was für die Pflege wichtig ist.

Bestehen ist planbar.

Blutbild · Elektrolyte · Niere · Gerinnung · Leber · BGA

7	35+	A4
Themenblöcke	Laborwerte	druckfertig

INHALT

1. Blutbild
2. Elektrolyte
3. Niere & Stoffwechsel
4. Entzündung & Notfall
5. Gerinnung
6. Leber & Pankreas
7. Blutgasanalyse (arteriell)

⚠ Referenzbereiche unterscheiden sich je nach Labor, Methode und Alter. Maßgeblich sind immer die Normwerte auf dem Befund deines Labors.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

plan-nrw.de

Laborwerte auf einen Blick

Normbereiche für Erwachsene · ↑ = erhöht · ↓ = erniedrigt

Wert	Normbereich	↑ erhöht bei	↓ erniedrigt bei
BLUTBILD			
Hämoglobin (Hb)	♀ 12–16 · ♂ 13,5–17,5 g/dl	Polyglobulie, Dehydratation	Anämie, Blutung
Hämatokrit (Hk)	♀ 37–47 · ♂ 40–52 %	Dehydratation	Anämie, Überwässerung
Erythrozyten	♀ 4,0–5,2 · ♂ 4,5–5,9 /pl	Polyglobulie	Anämie
Leukozyten	4–10 /nl	Infektion, Entzündung, Kortison	Chemotherapie, Knochenmarkschaden
Thrombozyten	150–400 /nl	Entzündung, nach Blutung	Blutungsgefahr, HIT, Sepsis
ELEKTROLYTE			
Natrium	135–145 mmol/l	Dehydratation	Verwirrtheit, Krampfanfälle
Kalium	3,5–5,0 mmol/l	Herzrhythmusstörungen! Niereninsuffizienz	Rhythmusstörungen, Muskelschwäche, Diuretika
Calcium	2,2–2,6 mmol/l	Hyperparathyreoidismus, Tumor	Tetanie, Kribbeln
Magnesium	0,7–1,1 mmol/l	Niereninsuffizienz	Krämpfe, Rhythmusstörungen
NIERE & STOFFWECHSEL			
Kreatinin	♀ 0,5–0,9 · ♂ 0,7–1,2 mg/dl	Niereninsuffizienz	geringe Muskelmasse
Harnstoff	17–43 mg/dl	Niereninsuffizienz, Dehydratation, GI-Blutung	Leberinsuffizienz
eGFR	> 90 ml/min	–	Nierenfunktion ↓ – Dosis anpassen!
Blutzucker nüchtern	70–100 mg/dl	Diabetes, Stress, Kortison	Hypoglykämie < 70 → Traubenzucker
HbA1c	< 5,7 %	Diabetes (≥ 6,5 %)	–
ENTZÜNDUNG & NOTFALL			
CRP	< 5 mg/l	Infektion, Entzündung	–
Procalcitonin (PCT)	< 0,5 ng/ml	bakterielle Infektion, Sepsis	–
Laktat	0,5–2,2 mmol/l	Schock, Sepsis, Minderperfusion	–
Troponin T (hs)	< 14 ng/l	Herzinfarkt, Myokardschaden	–
NT-proBNP	< 125 pg/ml	Herzinsuffizienz	–
GERINNUNG			
Quick	70–120 %	–	Marcumar, Leberschaden, Vit.-K-Mangel
INR	0,85–1,15	Marcumar (Ziel meist 2–3)	–
aPTT	25–38 s	Heparin, Gerinnungsstörung	–
D-Dimere	< 0,5 mg/l	Thrombose, Lungenembolie, nach OP	–
LEBER & PANKREAS			

GOT (AST)	**♀ < 35 · ♂ < 50 U/l**	Leber-, Herz-, Muskelschaden	–
GPT (ALT)	**♀ < 35 · ♂ < 50 U/l**	Leberschaden	–
γ-GT	**♀ < 40 · ♂ < 60 U/l**	Alkohol, Gallenstau	–
Bilirubin gesamt	**< 1,2 mg/dl**	Ikterus, Gallenstau, Hämolyse	–
Lipase	**< 60 U/l**	Pankreatitis	–
Albumin	**35–52 g/l**	–	Mangelernährung, Leberschaden, Ödeme
BLUTGASANALYSE (ARTERIELL)			
pH	**7,35–7,45**	Alkalose	Azidose
pO_2	**75–100 mmHg**	O_2-Gabe	Hypoxämie
pCO_2	**35–45 mmHg**	Hypoventilation (resp. Azidose)	Hyperventilation
HCO_3^-	**22–26 mmol/l**	metabolische Alkalose	metabolische Azidose
BE	**–2 bis +2 mmol/l**	metabolische Alkalose	metabolische Azidose

Für die Pflege besonders wichtig: Kalium (Rhythmusstörungen!), Blutzucker (Hypoglykämie), Thrombozyten und Gerinnung (Blutungsgefahr, Injektionen), Kreatinin/eGFR (Medikamentendosis) und Laktat (Schock). Auffällige Werte immer an den Arzt weitergeben.

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**

LERNHILFE · FÜR DIE LETZTEN TAGE VOR DER PRÜFUNG

Examens-Spickzettel

Alle Kernzahlen, Scores und Merksätze für das Pflegeexamen auf einen Blick – kompakt zum Ausdrucken und Wiederholen.

Bestehen ist planbar.

Vitalwerte · Scores · Perfusor · Hygiene · Recht NRW · Abkürzungen

6	60+	A4
Themenblöcke	Kernfakten	druckfertig

INHALT

1. Vitalwerte Normbereiche
2. Wichtige Scores
3. Perfusor & Dosierung
4. Hygiene-Kernfakten
5. Ausbildung & Recht NRW
6. Wichtige Abkürzungen

⚠ Lernhilfe für Ausbildung und Prüfung. Werte können je nach Lehrbuch, Leitlinie und Klinikstandard leicht abweichen – im Zweifel gilt der Standard deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

plan-nrw.de

Kernzahlen auf einen Blick

Ausdrucken, an die Wand hängen, jeden Tag einmal lesen.

1 VITALWERTE NORMBEREICHE

Blutdruck (Erw.)	120/80 mmHg · normal bis 139/89
Puls (Erw.)	60–100/Min.
Atemfrequenz (Erw.)	12–20/Min.
Temperatur	36,0–37,4 °C
SpO_2	≥ 95 % · COPD-Ziel 88–92 %
Blutzucker nüchtern	70–100 mg/dl (3,9–5,6 mmol/l)
Puls Neugeborenes	120–160/Min.
AF Neugeborenes	30–60/Min.

2 WICHTIGE SCORES

Braden-Skala	6–23 P. · ≤ 18 = Dekubitusrisiko
Barthel-Index	0–100 · 100 = selbstständig
Glasgow Coma Scale	3–15 · ≤ 8 = Atemwegssicherung erwägen
NRS Schmerz	0–10 · ab 4 behandlungsbedürftig
qSOFA	≥ 2 von 3: AF ≥ 22 · RR syst. ≤ 100 · Bewusstsein verändert
NEWS2	0–20 · ≥ 5 dringend · ≥ 7 Notfallteam
MNA	≥ 24 gut · 17–23,5 Risiko · < 17 Mangelernährung
CAM-ICU	Akuter Beginn + Unaufmerksamkeit + (Denken oder Bewusstsein)

3 PERFUSOR & DOSIERUNG

Grundformel	ml/h = (µg/kg/min × kg × 60) ÷ (µg/ml)
Tropfen (20 Tr./ml)	Tropfen/Min. = ml/h ÷ 3
Noradrenalin	z. B. 5 mg auf 50 ml = 100 µg/ml
Insulin	z. B. 50 IE auf 50 ml = 1 IE/ml
Merke	Konzentrationen immer nach Klinikstandard!

4 HYGIENE-KERNFAKTEN

Hyg. Händedesinfektion	3–5 ml · mind. 30 Sek. (EN 1500)
Chirurg. Händedesinfektion	1,5–3 Min. nach Herstellerangabe
5 WHO-Momente	Vor Patient · vor aseptisch · nach Körperflüssigkeit · nach Patient · nach Umgebung
C. difficile / Noro	Zusätzlich Hände waschen – Sporen!
PSA anlegen	Kittel → Maske → Brille → Handschuhe
PSA ablegen	Handschuhe → Kittel → Brille → Maske → Händedesinfektion

5 AUSBILDUNG & RECHT NRW

Pflegefachfrau/-mann	3 Jahre Vollzeit · Teilzeit bis 5 Jahre · Verkürzung um bis zu 1 Jahr möglich
Staatliche Prüfung	3 schriftliche Klausuren · mündlich (30–45 Min.) · praktisch
Pflegefachassistenz NRW	1 Jahr · 700 h Theorie + 950 h Praxis
Ausländische Abschlüsse	Kenntnisprüfung oder Anpassungslehrgang
Zuständig in NRW	Bezirksregierung

6 WICHTIGE ABKÜRZUNGEN

ATL / AEDL	(Aktivitäten und existenzielle Erfahrungen der) Aktivitäten des Lebens
PESR	Problem – Einflussfaktoren – Symptome – Ressourcen
SMART	Spezifisch · Messbar · Attraktiv · Realistisch · Terminiert
SBAR	Situation · Background · Assessment · Recommendation
DNQP	Dt. Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege
ROSC	Return of Spontaneous Circulation
MH	Maligne Hyperthermie
HIT	Heparin-induzierte Thrombozytopenie

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**